Trastornos de personalidad severos

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

Trastornos de personalidad severos: estrategias psicoterapéuticas Otto Kernberg Yale University Press New Haven y Londres

La gratitud por permiso para reimprimir material se expresa en los Agradecimientos. Publicado con asistencia del Fondo Memorial Louis Stern. Copyright €> 1984 por Yale University, © 1986 por Otto F. Kernberg Todos los derechos reservados. Este libro puede no ser reproducido, en su totalidad o en parte, en cualquier forma (más allá de esa copia permitida por las Secciones 107 y 108 de la Ley de Derecho de Autor de la U.S. y, excepto por los revisores de la prensa pública), sin el permiso por escrito de los editores. Diseñado por James J. Johnson y se encuentra en Palatino Roman. Impreso en los Estados Unidos de América El documento en este libro cumple con las directrices de permanencia y durabilidad de la Comisión de Directrices de producción para la longevidad del Consejo sobre los recursos de la biblioteca. Biblioteca del Congreso Catalogación en datos de publicación Kernberg, Otto F., 1928- Trastornos de personalidad severos. Bibliografía: p. Incluye índice. yo. Personalidad, trastornos de. 2. Trastorno de la personalidad límite. 3. Narcisismo. I. Título. [DNLM: i. Narcisismo. 2. Trastornos de personalidad: diagnóstico. 3. Trastornos de personalidad personal. 4. Métodos de psicoterapia. WM 1901 (395) RC554.K47 1984 6i6.85'8 84-40197 ISBN 978-0-300-05349-4 ISBN 0-300-05349-5 (PBK.) Un registro de catálogo para este libro está disponible en la Biblioteca Británica. 20 19 18 17 16 15

A la memoria de mis padres Leo y Sonia Kernberg y a la memoria de mi maestro y amigo, el Dr. Carlos Whiting D'Andurain

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

Contenidos Prefacio Agradecimientos Parte One Consideraciones de diagnóstico 1 Diagnóstico estructural 2 La entrevista estructural 3 Diagnóstico diferencial en la adolescencia 4 Trastornos de personalidad en la vejez 5 Problemas en la clasificación de los trastornos de la personalidad Parte dos Tratamiento de las personalidades de la frontera 6 Psicoterapia expresiva 7 Gestión de la transferencia en psicoterapia expresiva 8 Psicoterapia expresiva con adolescentes 9 Psicoterapia de apoyo 10 Indicaciones y contraindicaciones para modalidades de tratamiento de base psicoanalítica Parte Tres Personalidades narcisistas: Teoría clínica y tratamiento 11 Contemporáneo Enfoques psicoanalíticos para el narcisismo 12 Estrategias técnicas en el tratamiento de las personalidades narcisistas 13 Análisis de caracteres 14 Self, Ego, afecta y impulsan la parte cuatro regresiones severas: diagnóstico y tratamiento 15 estancamientos en el tratamiento 16 Diagnóstico y manejo clínico de pacientes con Suicide potencial IX XI 3 27 52 68 77 97 112 131 147 165 179 197 21o 227 241 254 VII

VIII CONTRA 17 CONTRATÁTRAFANZA, Regresión de la transferencia y la incapacidad de depender de 18 aspectos clínicos de la patología de su superygo grave 19 Regresión paranoica y narcisismo maligno Parte Five Five Hospital Tratamiento 20 Filosofías contrastantes del tratamiento hospitalario para la psicopatología severa 21 el Modelo comunitario terapéutico del tratamiento hospitalario para la psicopatología severa 22 Tratamiento hospitalario a largo plazo de la frontera grave y la patología narcisista Referencias de las referencias de las tiendas de las tiendas 264 275 290 315 330 343 359 375 330 343 359 375

Prefacio Mis objetivos en este libro son twofold. La primera es presentar extensiones de los hallazgos y formulaciones contenidas en mi trabajo anterior, con énfasis especial en los aspectos de diagnóstico y tratamiento de los casos graves de patología fronteriza y narcisista. El segundo es explorar otros desarrollos deónales con respecto a estos temas en el campo de la psiquiatura clínica y el psicoanálisis y revisarlos de manera crítica a la luz de mi pensamiento actual. Una preocupación importante que se refleja en todo el libro es el deseo de hacer que mis formulaciones teóricas sean clínicamente relevantes y, en particular, para proporcionar al clínico herramientas técnicas para diagnosticar y tratar el caso difícil. Con este fin, comience por intentar reducir la confusión en un área más difícil al describir un modo específico de diagnóstico diferencial y una técnica para realizar lo que llamo una entrevista de diagnóstico estructural. También establece enlaces entre esa técnica y los criterios para el pronóstico y el tipo de tratamiento más apropiado para cada caso. Luego, detalla las estrategias de tratamiento para los pacientes con límites, dando atención particial a los casos más severos. En esta sección del libro, incluyo un examen sistemático de la psicopoterapia expresiva y de apoyo, ambos derivados de un marco psicoanalítico. En varios capítulos sobre el tratamiento de la patología narcisista, me concentro en los desarrollos en la técnica que he encontrado útiles para tratar las resistencias severas y la generalización de los personajes. Otro área de tratamiento problemática es la gestión del paciente no respondible o difícil: cómo hacer frente a los estancamientos en el tratamiento, cómo manejar a los pacientes que amenazan persistentemente el suicidio, cómo diferenciarse tratables de pacientes antisociales no tratables, cómo responder a los pacientes con paranoico Regresiones en la transferencia de que IX.

x parece verge en el psicótico. Estas son algunas de las preguntas tratadas en la parte cuatro. Finalmente, ofrezco un modelo de tratamiento hospitalario, basado en, pero algunos de los diferentes modelos de tratamiento de la comunidad terapéutica anteriores para los pacientes que requieren hospitalización extendida. Este libro, entonces, es en gran parte clínico. Mi objetivo es proporcionar al psico-terapeuta y psicoanalista con un amplio armamento de técnicas psicoterapéuticas específicas. Al mismo tiempo, dentro del contexto de los datos clínicos relevantes, explico mis contribuciones teóricas anteriores con respecto a la psicopatología de la debilidad e identidad de la psicopatología de la debilidad e identidad con nuevas hipótesis relacionadas con la patología severa de su superyo. Este volumen, por lo tanto, contiene los últimos desarrollos en la psicología del ego y la teoría de las relaciones de objetos.

Prefacio

Agradecimientos TS Las elaboraciones teóricas a las que se hace referencia en el prefacio dependen en gran medida del trabajo del difunto Edith Jacobson. Sus formulaciones y la exploración creativa de Margaret Mah-Ler de estas formulaciones a los estudios del desarrollo infantil continúan inspirando mi pensamiento. Un pequeño grupo de distinguidos psicoanalistas y amigos cercanos ha continuado brindándome un desafío crítico, aunque de apoyo, de apoyo, que he encontrado invaluable. Deseo agradecer especialmente a Doctor Ernst Ticho, con quien he trabajado de manera colaborativa ahora durante 22 años, y los médicos Martin Bergmann, Harold Blum, Arnold Cooper, William Grossman, Donald Kaplan, Paulina Kernberg, y Robert Michels, todos los cuales no solo han dado generosamente su tiempo, sino que también se han sentido libres de estar en desacuerdo con bruscamente y señalar problemas en mis formulaciones. También agradezco a los médicos, William Frosch y Richard Munich por su crítica revisión de mi pensamiento con respecto al tratamiento hospitalario y la comunidad teráutica, y los médicos Ann Appelbaum y Arthur Carr por su paciencia interminable con mis solicitudes de su ayuda para formular mis ideas más precisamente Finalmente, agradezco a Dr. Malcolm Pines por su alquiler de mi crítica de la comunidad terapéutica y el Dr. Rob- Ert Wallerstein por su crítica reflexiva de mis puntos de vista con respecto a la psicoterapia suplica. Los doctores Stephen Bauer, Arthur Carr, Harold Koenigsberg, John Oldham, Lawrence Rockland, Jessie Schomer y Michael Selzer, en la División de Hospital de Nueva York, en la División de New York, en la División de Westchester del Hospital de Nueva York, contribuyeron al desarrollo de la Metodologías de diagnóstico clínico involucradas en el diagnóstico diferencial de la organización de personalidad límite. Más recientemente, ellos y los médicos Ann Appelbaum, John Clarkin, Gretchen Haas, Paulina Kern-Berg y Andrew Lotterman han contribuido a la definición operativa.

XII Agradecimientos de las diferencias entre las modalidades expresivas y de apoyo del tratamiento como parte de un proyecto de investigación de psicoterapia en curso sobre las condiciones de la línea de fronteras. A todos ellos expreso mi gratitud. Como antes, necesito absolver a todos estos amigos, maestros y colegas de cualquier responsabilidad por mis formulaciones. Estoy profundamente agradecido con la Sra. Shirley Grunenthal, señorita Louise Taitt, y la Sra. Jane Carr por su patitud interminable en escribir, revisar, leer, leer y organizar las versiones aparentemente interminables de la manubrutión. En particular, la Sra. Jane Carr, que se unió a nuestro personal recientemente, ha mostrado una aptitud notable para llevar a cabo estas tareas. La señorita Lil- Lian Wahowow, bibliotecaria en la División de Westchester de Nueva York Hospital, y su personal, la Sra. Marilyn Bottjer y la Sra. Marcia Miller, me proporcionaron una ayuda invaluable en la investigación bibliográfica. Finalmente, la señorita Anna-Mae Artim, mi asistente administrativo, ha logrado una vez más lo imposible. Ella ha coordinado el trabajo editorial y la preparación del manuscrito; Ella ha anticipado de manera imperiosa y prevenida problemas importantes posibles; Y, en su forma alegre pero implacable, ha logrado cumplir con los plazos y, de alguna manera, asegure la finalización de este libro. Trabajando, por primera vez, con la ayuda de mi editor en los años de cambio, la Sra. Natalie Altman, y el editor de Yale University Press, la Sra. Gladys Topkis, me encontré en la posición altamente privilegiada de ser observado y controlado a cada paso en mis esfuerzos por expresar. Mis pensamientos claramente y en inglés aceptable. En el proceso, a menudo vino a sospechar que sabían mucho más sobre el psicoanálisis, la psiquiatura y la psicoterapia que yo. No puedo decir lo extremadamente agradecido que estoy a ambos. A continuación se reconoce el permiso para reimprimir el material en los siguientes capítulos. Capítulo I: Adaptado de "El diagnóstico estructural de la Organización de la Persona Bordelina / 'en Trastornos de la

Personalidad Bordelina, Ed. P. Hartocollis, 1977, págs. 87-122. Publicado con permiso de Universidades internacionales Press, Inc. Capítulo 2: Adaptado de la" entrevista estructural ", clínicas psiquiátricas de América del Norte, 4: l, 169-95,1981; con permiso. Capítulo 3: Adaptado de" El diagnóstico de condiciones fronterizas en la adolescencia ", psiquiatría adolescente, 6 (1978): 298-319. Copyright © University of Chicago. Publicado con permiso de la Prueba de la Universidad de Chicago. Capítulo 4: Adaptado de" El destino de los trastornos de la personalidad en la vejez ", en la perspectiva de la investigación psicodinámica sobre el desarrollo, psicópata

Agradecimientos XIII OGY, y tratamiento en la vida posterior, ed. N. E. Miller y G. D. Cohen (en prensa). Publicado con permiso de Universidades internacionales Press, Inc. Capítulo 6: Adaptado de 'El tratamiento psicoterapéutico de las personalidades de la línea fronteriza /' en la actualización de la psiquiatría: Volumen I, ed. L. GrindPoon. Washington, D.C.: American Psychiatric Association Press, Inc.,
1982. Copyright 1982 American Psychiatric Association. Utilizado con permiso. Capítulo 7: Adaptado de "enfoques contrastantes a la psiquiatría de las condiciones fronterizas / 'en nuevas perspectivas sobre la psicoterapia del límite de los adultos, ed. J. F. Masterson, 1978, pp. 77-104. Publicado con permiso de Brunner / Mazel. Capítulo 8: Adaptado de" psicoterapia psicoanalítica con adolescentes de línea fronteriza /' psiquiatría adolescente, 7 (1979): 294-321. Copyright 1979 por la Universidad de Chicago. Publicado con permiso de la Universidad de Chicago Press. Capítulo 9: Adaptado de la "psicoterapia de apoyo con las condiciones fronterizas / 'en problemas críticos en la psiquiatría, Ed. J. O. Cavenar y H. K. Brodie, 1982, pp. 180-202. Publicado con permiso de J. B. Labios. Pincott Company. Capítulo 12: Adaptado de" Un enfoque de psicología y relaciones de objetos de ego a la personalidad narcisista /' en la actualización de la psiquiatría: Volumen I, ed. L. GrindPoon. Washington, D.C.: American Psychiatric Association
Press, Inc., 1982. Copyright 1982 American Psychiatric Association. Utilizado con permiso. Chapter 13: Adapted from "Object Relations Theory and Character Analysis," Journal of the American Psychoanalytic Association, in press. Pub) con permiso de la revista de la American Psychoanalytic Association. Capítulo 14: Adaptado de "Self, Ego, afecto y unidades / 'Diario de la American Psychoanalytic Association, 30 (1982): 893-917. Publicado con permiso de la revista de la American Psychoanalytic Association. Capítulo 15: Adaptado de" Cambio estructural y sus impedimentos, "en

trastornos de la personalidad limítrofe, ed. P. Hartocollis, 1977, pp. 275-306. PUSEADO CON PERMANO DE UNIVERSIDADES INTERNACIONALES Press, Inc. Capítulo 16: Adaptado de" Diagnóstico y Clínico Gestión del posibilidad de sui- cida en pacientes con límites, "en el paciente límite: conceptos emergentes, diagnóstico, psicodinámica y tratamiento, ed. James Grotstein, Marion Solomon, y Joan Langs, en prensa. Publicado con permiso de Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Capítulo 20: Adaptado de" Tratamiento del Hospital psiquiátrico en los Estados Unidos ", Nordisk Psykiatrist TidssSkrift, 35, No. 4 (1981): 293-298. Publicado con permiso de Nordisk Psykiatrist Tidssskrift.

XIV ADGRADECIMIENTOS CAPÍTULO 21: Adaptado de "Ventajas y pasivos de los modelos de la comunidad terapéutica / 'en el individuo y el grupo, ed. M. Pines y L. Rafaelson, vol. I, 1982, pp. 543-565. Publicado con Permiso de prensa de plenum. Capítulo 22: Adaptado de" Algunos problemas en la teoría del tratamiento del hospital /' tidssskrift para Den Norske LoeGeForening, 14 (1981): 837-843. Pub) con permiso.

Parte uno: Consideraciones de diagnóstico

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

CAPÍTULO I: Diagnóstico estructural Uno de los problemas que plagan el campo de la psiquiatría ha sido el de diagnóstico diferencial, especialmente cuando existe la posibilidad de que exista la posibilidad de la patología de la característica fronteriza. Las condiciones de la frontera deben diferenciarse de, por un lado, las neurosis y la patología de los personajes neuróticos y, por otro lado, las psicosis, particularmente la esquizofrenia y los principales trastornos afectivos. Tanto el enfoque descriptivo del diagnóstico, que se centra en los síntomas y en el comportamiento observable, y el enfoque genético, que enfocan el trastorno mental en los familiares biológicos del paciente, son valiosos, especialmente con los principales trastornos afectivos y la esquizofrenia, pero, Ya sea que se utilice individualmente o juntos, ninguno ha resultado suficientemente preciso cuando se aplica a los trastornos de la personalidad. Creo que una comprensión de las características estructurales intrapsíquicas de los pacientes con organización de personalidad límite, junto con los criterios derivados del diagnóstico descriptivo, puede resultar en una gran mejora en la precisión de diagnóstico. Si bien un diagnóstico estructural es más difícil de llevar a cabo, requiere más práctica y experiencia del médico, y presenta cierta dificultades metodológicas, tiene ventajas definitivas, particularmente con pacientes que no caen fácilmente en una de las categorías principales de enfermedad neurótica o psicótica. Un enfoque descriptivo con los pacientes límite puede ser engañoso. Por ejemplo, varios autores (GRINKER et al., 1968; Gunderson y Kolb, 1978) han descrito un efecto intenso, en particular la ira y / o la depresión, como característica de los pacientes con límites. Sin embargo, los pacientes con personalidades esquizoides típicas y una organización de personalidad límite no pueden presentar la ira o la depresión en absoluto. Lo mismo ocurre con algunas personalidades narcisistas que tienen un límite típico subyacente 3

4 Consideraciones de diagnóstico Organización de la personalidad. El comportamiento impulsivo también se ha descrito como una característica común de los pacientes con límites, pero muchos pacientes histéricos típicos con una estructura neurótica también muestran un comportamiento impulsivo. Clínicamente, por lo tanto, solo un enfoque descriptivo cae corto con algunos casos límite. Estas limitaciones también se aplican a los esfuerzos para llegar a una di-agnosis utilizando un enfoque puramente genético. El estudio de las posibles relaciones georticas de los trastornos graves de la personalidad a la especificación esquizofrénica y los trastornos afectivos importantes aún se encuentra en una etapa temprana, y puede ser que los hallazgos importantes nos esperan en esta área. En la actualidad, sin embargo, la historia genética generalmente tiene muy poco que contribuir al problema clínico de diferenciar la sintomatología neurótica, fronteriza y psicótica. Es posible que un enfoque estructural se conecte a comprender la relación de predisposición genética a la sintomatología abierta. Un enfoque estructural puede tener la ventaja adicional de aportar a un enfoque más agudo la relación entre los diversos síntomas de los trastornos límite, en particular las constelaciones de los rasgos de la característica patológica, por lo que típicamente se encuentra en este grupo. Como he señalado en un trabajo anterior (1975, 1976), las características estructurales de la organización de Personalidad del límite tienen importantes implicaciones pronósticas y terapéuticas. La calidad de las relaciones de objetos y el grado de integración de suminO son importantes criterios pronósticos para la psicoterapia intensiva de los pacientes con límites. La naturaleza de las transferencias primitivas que estos pacientes se desarrollan en la psicoterapia psicoanalítica y la técnica para tratar con ellos, se derivan directamente de las características estructurales de sus relaciones de objetos internalizados. En un estudio más temprano (Kernberg et al., 1972), encontramos que los pacientes no psicóticos con

debilidad del ego se replicaban bien a las modalidades expresivas de la psicoterapia, pero mal al psicoanálisis no nodificado y a la psicoterapia de apoyo. En resumen, la adición del enfoque estructural enriquece el diagnóstico psiquiátrico, en particular de los casos que se resisten a la clasificación fácil y contribuciones también para determinar el pronóstico y el tratamiento. Estructuras mentales y organización de personalidad El concepto psicoanalítico de la estructura mental formulada por primera vez formulada por Freud en 1923 se ha referido a la división postulada de la psique en el Ego, el superego y la identificación. Dentro de la psicología del ego psicoanalítico, el análisis estructural se ha referido a la vista (Hartmann et al., 1946; Rapaport y Gill, 1959) que el ego puede ser conceptualizado como (i) cambiando lentamente "estructuras" o configuraciones, que determinan la canalización de los procesos menores, (2) los procesos mentales, o "funciones", y (3) "umbrales" de la activación de estas funciones y configuraciones. Las estructuras, según este concepto, son configuraciones relativamente estables.

Diagnóstico estructural 5 de procesos mentales; Superego, EGO y ID son estructuras que integran dinamicalmente las subestructuras, como las con- las conversaciones cognitivas y defensivas del ego. Más recientemente, he usado el término anal-ysis estructural para describir la relación entre los derivados estructurales de las relaciones de objetos internalizados (Kernberg, 1976) y los diversos niveles de organización del funcionamiento mental. En mi opinión, las relaciones de objetos internalizados constituyen subestructuras del ego, subestructuras que se encuentran, a su vez, organizadas jerárquicamente (ver Capítulo 14). Finalmente, en el pensamiento psicoanalítico reciente, el análisis estructural también se refiere al análisis de la organización permanente del contenido de conflictos no conscientes, en particular al complejo de Edipo como una característica organizativa de la mente que tiene una historia de desarrollo, se organiza dinamic-aliy en La sensación de que es más que la suma de sus partes e incorpora experiencias tempranas y organizaciones de accionamiento específicas de fase en una nueva organización (Panel, 1977). Esta última concepción de las estructuras mentales se relaciona con el enfoque de las relaciones con los objetos con respecto a la estructuralización de las relaciones de objetos internalizados: los contenidos menores predominantes, como el complejo de Edipo, reflejan una organización de relaciones de objetos internalizados. Tanto los puntos de vista recientes implican secuencias motivacionales organizadas jerárquicamente en contraste con el desarrollo puramente lineal y una secuencia de organizaciones jerárquicas discontinuas en lugar de una simple genética (en un sentido psicoanalítico). He aplicado todos estos conceptos estructurales al análisis de las estructuras intrapsíquicas predominantes y los conflictos instintivos de los pacientes de línea fronteriza. Propongo la existencia de tres organizaciones estructurales amplias correspondientes a la organización neurótica, límite y personalidad psicótica. En cada

caso, la organización estructural realiza la función de estabilizar el aparato mental, mediando entre los factores etiológicos y las manifestaciones de la enfermedad conductual directas. Independientemente de los factores genéticos, constitucionales, bioquímicos, familiares, psicodinámicos, bioquímicos, psicodinámicos, o psicosociales que contribuyen a la etiología de la enfermedad, los efectos de todos estos factores se reflejan finalmente en la estructura psíquica del individuo, que luego se convierte en el subyacente Matriz de los cuales se desarrollan los síntomas de la halvanal. Estos tipos de organización neuróticos, fronterizos y psicóticos se reflejan en las características primordiales del paciente, en particular con la reiteración a (i) su grado de integración de identidad, (2) los tipos de operaciones defensivas que emplea habitualmente, y (3) su capacidad para las pruebas de realidad. Propongo que la estructura de la personalidad neurótica, en contraste con la frontera y las estructuras psicóticas, implica una identidad integrada. La estructura de la personalidad neurótica presenta una organización defensiva centrada en la representación y otras operaciones defensivas avanzadas o de alto nivel. En contraste, se encuentran las estructuras de la frontera y las estructuras psicóticas en pacientes que muestran un predominio de las operaciones defensivas primitivas centradas en el mecanismo.

6 consideraciones de diagnóstico nismo de división. La realización de la realidad se mantiene en la organización neurótica y fronteriza, pero se ve severamente deteriorada en la organización psicótica. Estos criterios estructurales pueden complementar las descripciones de comportamiento ordinarias o fenomológicas de los pacientes y afilar la precisión del diagnóstico diferente de enfermedad mental, especialmente en los casos que son difíciles de clasificar. Los criterios estructurales adicionales útiles en diferenciación de la organización de la personalidad límite de las neurosis incluyen la presencia o ausencia de manifestaciones no específicas de la debilidad de los ego, la falta de tolerancia a la ansiedad, el control de impulso y la capacidad de sublimación; y, con el propósito de diagnóstico diferencial de la esquizofrenia, la presencia o ausencia en la situación clínica del pensamiento primario. Debido a que las manifestaciones no específicas de la debilidad del ego son clínicamente menos esenciales en la diferenciación de las condiciones fronterizas y neuróticas, y debido a que las pruebas psicológicas en lugar de las entrevistas clínicas pueden ser las más útiles en la diferenciación de la fronteriza y el funcionamiento cognitivo psicótico, no estoy examinando estos Criterios en detalle aquí. El grado y la calidad de la integración de SupereOgo son características estructurales adicionales que diferencian a la organización neurótica y fronteriza de diferencia. La entrevista estructural como método de diagnóstico, la entrevista psiquiátrica tradicional se modeló después de la entrevista medical general, adaptada en gran medida por Pacientes psicóticos y orgánicos (Gill et al., 1954). Bajo la influencia de la teoría y la práctica psicoanalíticas, el énfasis se desplazó gradualmente a la interacción del entrevistador del paciente. Una secuencia más o menos estándar de preguntas se reemplazó por una evaluación más flexible de los problemas predominantes, enfocados en la comprensión del paciente de sus conflictos y vincular el estudio de la personalidad del paciente a la de su comportamiento

actual en la entrevista. El estudio de caso de Karl Menninning Ger (1952) es un buen ejemplo de este enfoque. Whitehorn (1944), Powdermaker (1948), Fromm-Reichmann (1950), y, en particular, Sullivan (1954), son en gran parte responsables de una entrevista psiquiátrica modificada que se concentra en la interacción del paciente-terapeuta como Una fuente importante de información. Gill et al. (1954) diseñó un nuevo modelo de entrevista psiquiátrica que destaca una amplia tasación del paciente y un refuerzo de su deseo de ayuda. La naturaleza del DISPONIBLE, la motivación y la capacidad de la psicoterapia se pueden evaluar en la interacción actual con el entrevistador. Este enfoque para enterrar establece un vínculo inmediato entre la psicopla: la psicopla del paciente. Para una revisión de la literatura sobre características descriptivas y estructurales de la personalidad de la línea de borrar, ver Kernberg, 1975.

Diagnóstico estructural 7 Tofología y indicación para el tratamiento psicoterapéutico. También se focan a las resistencias que probablemente se convertirán en temas importantes en las primeras etapas del tratamiento. Debido a que los elementos de apoyo inherentes a este enfoque tienden a resaltar los activos del paciente, sin embargo, puede perderse ciertos aspectos de la psicopatología del paciente. Deutsch (1949) abogó por un método psicoanalítico de entrevistas que revelarían las conexiones inconscientes entre los problemas actuales y el pasado del paciente. De un fondo teórico diferente, Rogers (1951) propuso un estilo de entrevista que alienta al paciente a explorar sus experiencias emocionales y las conexiones entre ellas. Estos enfoques no estructurados tienen la desventaja de minimizar los datos objetivos y no explorar la psicopatología del paciente y los establecimientos de manera sistemática. Mackinnon y Michels (1971) describen una evaluación psicoanalítica que destaca la interacción del entrevistador de pacientes. Manifestaciones clínicas de los patrones de caracteres El paciente demuestra en la entrevista se utilizan con fines de diagnóstico. Este enfoque produce información descriptiva sofisticada dentro de un marco psicoanalítico. Las entrevistas clínicas que he descrito se han convertido en herramientas cruciales para evaluar las características descriptivas y dinámicas, pero no, en mi opinión, en mi opinión, lo que permite provocar los criterios estructurales que diferencian la organización de personalidad límite. BELLAK et al. (1973) desarrolló una entrevista clínica estructurada en un intento por lograr un diagnóstico diferencial entre los sujetos normales, los pacientes neuróticos y los esquizofrénicos sobre la base de un modelo estructural de funcionamiento del ego. Aunque su estudio no buscó diferenciar a los pacientes con límites, estos autores encontraron diferentes diferencias entre los tres grupos en escalas de calificación que evaluaron las estructuras y las funciones del ego. Su estudio ilustra la utilidad de un enfoque estructural para el diagnóstico diferencial. En

colaboración con S. BAUER, R. Blumenthal, A. Carr, E. Gold-Stein, H. Hunt, L. Pessar, y M. Piedra, he desarrollado lo que ha sugerido la Blu-Menthal (comunicación personal) llamando a un intervista estructural a Resalte las características estructurales de los tres tipos principales de organización de personalidad. Esta entrevista se centra en los síntomas, conflictos o dificultades que presenta el paciente, y las formas particulares en las que los refleja en la interacción aquí y ahora con el entrevistador. Suponemos que el enfoque del entrevistador en los principales conclícitos del paciente creará suficiente tensión para que surjan la organización defensiva y "estructural" del paciente ". Al resaltar estas operaciones defensivas en la entrevista, obtenemos datos que nos permiten clasificarlo en una de las tres estructuras de personalidad sobre la base del grado de integración de identidad (la integración de las representaciones de sí mismo y objetos), el tipo de operaciones defensivas predominan

8 Consideraciones de diagnóstico Natación y la capacidad de las pruebas de realidad. Para activar y diaginar estas características estructurales, hemos desarrollado una entrevista que combina el examen tradicional de estado mental con una entrevista orientada psychocalíticamente enfocada en la interacción del paciente-terapeuta y sobre la aclaración, la confrontación y la interpretación de la Conflictos de identidad, mecanismos defensivos y distorsión de la realidad que el paciente revela en esta interacción, especialmente como estos elementos de transformencia identificables expresos. Antes de describir la entrevista real, algunas definiciones pueden ser útiles. La aclaración se refiere a la exploración, con el paciente, de todos los elementos en la información que ha proporcionado que son vagos, poco claros, de poca, contradictorios o incompletos. La aclaración es la primera etapa cognitiva en la que lo que dice el paciente se discute de una manera no cuesta para aprovechar todas sus implicaciones y descubrir el alcance de su comprensión o confusión con respecto a lo que aún no está claro. Claro de aplicación tiene como objetivo evocar material consciente y preconsciente sin desafiar al paciente. Al final, es el propio paciente quien aclara su comportamiento y experiencia intrapsíquica para nosotros, lo que nos lleva a los límites actuales de su conciencia consciente y preconsciente. Confrontación, el segundo paso en la entrevista. Proceso, presenta al paciente con áreas de información que parecen contradictorias o incongruentes. La confrontación significa señalar al paciente aquellos aspectos de la interacción que parecen indicar la presencia de funcionamiento conflictivo y, por implicación, la presencia de operaciones defensivas, un auto contradictorio y representaciones de objetos, y la conciencia de la realidad disminuyó. Primero, la atención del paciente se siente atraída a algo en la interacción de la cual ha sido inconsciente o ha tomado como natural y que el entrevista percibe como inapropiado, contradictorio a otros aspectos de la información, o confuso. La confrontación requiere

unir un material confuso y preconsciente que el paciente presentó o experimentó por separado. El entrevistador también plantea la cuestión de la posible importancia de este comportamiento para el funcionamiento actual del paciente. Por lo tanto, la capacidad del paciente para ver las cosas de manera diferente sin una mayor regresión, las relaciones internas entre las diversas cuestiones reunidas y, en particular, se expresan la integración del concepto de sí mismo y otros. El aumento o disminución de la conciencia de la realidad reflejada en la respuesta del paciente a la confrontación y su empatía continua con el entrevistador como un reflejo de la conciencia social y las pruebas de realidad también se destacan. Finalmente, el entrevistador relaciona aspectos de la interacción aquí y ahora a problemas similares en otras áreas y, por lo tanto, se convierte en una conexión entre los problemas descriptivos y las quejas y las características de personal estructural. La confrontación, definida, se requiere tacto y paciencia; está

Diagnóstico estructural 9 No es una forma agresiva de entrometerse en la mente del paciente o en un movimiento para polarizar la relación con él. La interpretación, en contraste con la confrontación, vincula a un material consciente y preestablecido con funciones inconscientes supuestas o hipótesis, en las motivaciones, en el presente, y ahora. Explora los orígenes conflictivos de la disociación de los estados del Ego (representaciones de sí mismo dividido y objetos), la naturaleza y los motivos para las operaciones defensivas activadas, y el abandono defensivo de las pruebas de realidad. En otras palabras, la interpretación se enfoca en las ansiedades subyacentes y los conflictos activados. La confrontación reúne y reorganiza lo que se ha observado; La interpretación agrega una dimensión hipótesis de causalidad y profundidad al material. El entrevistador conecta así las funciones actuales de un comportamiento específico con las ansiedades, motivos y conflictos subyacentes del paciente, que aclara las dificultades generales más allá de la interacción actual. Por ejemplo, señalando a un paciente que su comportamiento parece ser la sospecha de Manifest y explorar su conciencia de este patrón es una confrontación; Sugiriendo que la sospecheza o el miedo del paciente se debe a su atribución al entrevistador, algo "malo" de que está tratando de deshacerse de sí mismo (de lo que el paciente no ha sido consciente antes) es una interpretación. La transferencia significa la presencia en la interacción diagnóstica del comportamiento apropiado. Eso refleja la recreación inconsciente de las relaciones patógenas y conflictivas con otros significativos en el pasado del paciente. Las reacciones de transferencia proporcionan el contexto para las interpretaciones que vinculan la perturbación aquí y ahora con el paciente, y luego la experiencia. Señalando a la El paciente que está actuando de manera de control y sospechoso hacia el diagnóstico es una confrontación. Señalando que puede estar viendo al entrevistador como control, estricto, duro y sospechoso, y por lo tanto puede sentir que tiene que estar en guardia

debido a su propia lucha con tal TENDENCIAS DIVERSAS DIVERSAS: es una interpretación. Señalando que el paciente está luchando con el entrevistador, que representa a un "enemigo" interno que tiene tales características porque experimentó una interacción similar en el pasado con una figura parental, es una interpretación de la transferencia. En resumen, la aclaración es un medio cognitivo indiferente para explorar los límites de la conciencia del paciente de ciertos materiales. La confrona intenta que el paciente sea consciente de los aspectos potencialmente conflictivos e incongruentes de ese material. La interpretación trata de resolver la naturaleza conflictiva del material asumiendo motivos y defensas inconscientes subyacentes que hacen que el contradictorio previamente aparezca lógico. La interpretación de la transferencia aplica todas estas modalidades precedentes de la técnica a la interacción actual entre el paciente y el diagnóstico.

10 consideraciones de diagnóstico porque se centran en la confrontación y la interpretación de las defensas, en los conflictos de identidad, en las pruebas de realidad o las distorsiones en las relaciones de objetos interconalizados, y en conflictos afectivos y cognitivos, entrevistas estructurales sujetos al paciente a una cierta cantidad. De estrés. En lugar de poner al paciente a gusto y reducir su "defensividad" al tolerarlo o pasarlo por alto, el entrevistador trata de resaltar la Patholery en la organización de funciones del Ego del paciente para obtener información sobre la organización estructural de la enfermedad. Sin embargo, el enfoque que estoy describiendo es de ninguna manera una entrevista tradicional de "estrés", que intenta inducir conflictos artificiales o ansiosidad en el paciente. Por el contrario, la aclaración de la realidad requerida en mucha confianza inicial requiere tacto y refleja el respeto y la preocupación por la realidad emocional del paciente, un compromiso honesto en contraste con lo que a veces puede ser una tolerancia indiferente o "superior" de lo inapropiado. La técnica de entrevista estructural se describe en el Capítulo 2; Las características clínicas de la organización de la personalidad límite que surgen durante la entrevista estructural se resumen a continuación. Las características estructurales de los síntomas descriptivos de la organización de la personalidad límite como la evidencia "presuntiva", los síntomas de los pacientes y los rasgos patológicos de los personajes no son criterios estructurales, pero dirigen la atención del médico a los criterios estructurales de la Organización de la Personalidad Bordelina. De manera similar, la presencia de síntomas "presuntivo" de una naturaleza psicótica que no parece justificar o corresponder a un diagnóstico de corte claro de un trastorno afectivo importante (enfermedad mancha-depresiva), esquizofrenia o un cerebro orgánico agudo o crónico El síndrome debe sugerirle al médico que explore los criterios estructurales para la organización de la personalidad límite. Los síntomas descriptivos de los pacientes con límites son

similares a los síntomas de presentación de las neurosis sintomáticos ordinarios y la patología del carácter, pero la combinación de ciertas características es peculiar de los casos de borde. Los seguidores de los síntomas son particularmente importantes (ver Kernberg, 1975). 1. Ansiedad. Los pacientes límite tienden a presentar ansiedad crónica, difusa y libre flotante. 2. Neurosis simptomática. Muchos pacientes presentan varios síntomas neuróticos, pero aquí estoy considerando solo a aquellos pacientes que tienden a presentar dos o más de los siguientes: a. Múltiples fobias, especialmente aquellas que imponen severas restricciones en la vida diaria del paciente. b. Síntomas obsesivos-compulsivos que han adquirido segundo.

La sintonía de Ary Ego y, por lo tanto, una calidad de pensamiento y acción "sobrevalorado". c. Múltiples síntomas de conversión elaborados o extraños, especialmente si son crónicos. d. Reacciones disociativas, especialmente "estados crepusculares" histéricos, y las fugas, y la amnesia acompañada de alteraciones de la conciencia. e. Hipocondría. f. Tendencias paranoicas e hipocondríacas con cualquier otra neurosis sintonómica (una combinación típica que indica un diagnóstico presupuesto de la organización de la personalidad límite). 3. Tendencias sexuales perversas polimorfas. Me refiero aquí a los pacientes que presentan una desviación sexual manifiesta en la que coexisten varias tendencias perversas. Cuanto más caóticos y múltiples, las fantasías y las acciones perversas y las más inestables, las relaciones de objetos relacionadas con estas interacciones, cuanto más se debe considerar la presencia de organización de personalidad borregal. Las extrañas formas de perversión, especialmente aquellas que manifiestan la agresión primitiva o el reemplazo primitivo de los objetivos genitales de los eliminatorios (micción, defecación), también son indicativos de una organización de personalidad límite subyacente. 4. Estructuras de personalidad prepsicóticas "clásicas". Estos incluyen: a. La personalidad paranoica (tendencias paranoicas de tal intensidad que determinan el diagnóstico descriptivo principal). b. La personalidad esquizoide. c. La personalidad hipomanínea y la organización de la personalidad de la ciclotima con sólidas tendencias hipomanísticas. 5. Impulso neurosis y adicciones. Me refiero aquí a esas formas de patología de carácter de derrota en la que la erupción repetitiva crónica de un impulso gratifica las necesidades instintivas de una manera que se diferencia egoístónico de los episodios "impulsos por impulsos", pero es egonntónico. Y en realidad altamente placentero durante el episodio, yo mismo. El alcoholismo, la adicción a las drogas, ciertas formas de obesidad psicógena y la kleptomanía son ejemplos típicos. 6. Trastornos de caracteres "de nivel inferior".

Aquí se incluye una patología severa de caracteres típicamente representada por el carácter caótico e impulsado, en contraste con los tipos de formación de reacción clásicos de la estructura de caracteres y los caracteres más suaves de "rasgo de evitación". Desde un punto de vista clínico, la personalidad histérica típica no tiene estructuras fronterizas; Lo mismo ocurre con la mayoría de las personalidades obsesivas-compulsivas y las estructuras de "personalidad afesiva" (laughlin, 1967) o personalidades masoquistas mejor integradas. En contraste, muchos diagnósticos perfectuosos infantiles 11

12 Consideraciones de diagnóstico Las sonalidades y las personalidades narcisistas típicas presentan una organización fronteriza subyacente; Las personalidades "como si" también pertenecen a este último grupo. Todas las estructuras de personalidad antisocial claras que he examinado han presentado una organización típica de la personalidad límite. Todos estos síntomas, así como los rasgos de carácter patológicos dominantes pueden ser provocados por la investigación inicial de los síntomas que llevan al paciente al tratamiento. La investigación abarca las características de la vida interpersonal y social del paciente con respecto a su trabajo y su familia; Sus relaciones sexuales y matrimoniales; Sus interacciones con parientes cercanos, amigos, conocidos; y sus interacciones en las áreas de recreación, cultura, política, religión y otros intereses de la comunidad interpersonal. Con todos los pacientes en los que se evaluará el diagnóstico de la organización de la personalidad de la línea fronteriza, una historia integral de la sintomatología y las peculiaridades de las interacciones interpersonales es, por lo tanto, la información inicial importante. Falta de una identidad integrada: el síndrome de la difusión de identidad clínicamente, la difusión de identidad está representada por un concepto mal integrado del yo y de otros significativos. Se refleja en la experiencia subjetiva de los vacíos crónicos, las auto-percepciones contradictorias, el comportamiento contradictorio que no se puede integrar de una manera emocionalmente significativa, y las percepciones poco profundas, planas y empobrecidas de los demás. Diagnósticamente, la difusión de identidad aparece en la incapacidad del paciente para transmitir interacciones significativas con otras personas a un entrevistador, quienes, por lo tanto, no pueden empatizarse emocionalmente con la concepción del paciente de sí mismo y a los demás en tales interacciones. Teóricamente, las siguientes suposiciones subyacen a esta falta de integración de uno mismo y del concepto de otros significativos (Kernberg, 1975): (i) en la organización de

personalidad limítrofe, existe suficiente diferente de las representaciones de autosiciones de las representaciones de objetos para permitir la Mantenimiento de los límites del ego (es decir, de la delimitación afilada entre el yo y los demás). En las estructuras psicóticas, por el contraste, se presenta una refutación regresiva o falta de diferenciación entre las representaciones de sí mismo y objetos. (2) en contraste con las estructuras neuróticas, donde todas las imágenes de auto (tanto "buenas" como "malas") se han integrado en un yo integral, y donde las imágenes "buenas" y "malas" de otros pueden integrarse en conceptos integrales de otros, en la organización de la personalidad límite, tal La integración falla, y las representaciones de sí mismas y objetos reinan representaciones múltiples, contradictorias, afectivas y cognitivas afectivas de sí mismo y otras. (3) Esta falta de integración de aspectos "buenos" y "malos" de la realidad de sí mismo y otros se presumiblemente se debe a la predominio de SE-

Diagnóstico estructural 13 Vere Agresión temprana activada en estos pacientes: la disociación de las representaciones de "buena" y "mala", y las representaciones de objetos en efecto protegen el amor y la bondad de la contaminación al anular el odio y la maldad. En la entrevista estructural, la difusión de identidad se refleja en un historial de comportamiento groseramente contradictorio, o en una alternancia entre los estados emofionales que implican un comportamiento y percepción tan groseramente contradictorios y la percepción del yo que el entrevistador le resulta muy difícil ver el paciente como un ser humano "entero". Mientras que en la patología neurótica severa, el comportamiento interpersonal contradictorio puede reflejar la visión patológica pero integrada del paciente y los demás, en la organización de la personalidad límite, es la visión interna de sí mismo y de otros que no están integrados. Por ejemplo, un paciente neurótico con una estructura predominantemente histérica de personalidad, dijo en la entrevista que quería ayuda para sus dificultades sexuales, pero fue muy reacio a discutirlas. Confrontado con esta contradicción, explicó que ella sintió que los entrevistadores masculinos disfrutarían del efecto humillante que tendría en una mujer para hablar de sus dificultades sexuales, para que pudieran emocionarse sexualmente mientras disfrutaba de la depreciación de ella como sensualmente inferior. Este concepto de hombres y de la naturaleza humillante de las experiencias sexuales y su revelación fue parte de un concepto integrado, aunque patológico de sí misma y otras. En contraste, un paciente con la estructura de carácter infantil predominante y la organización de la personalidad límite explicó lo disgustada que estaba con los hombres que solo estaban usando a las mujeres como objetos sexuales, cómo tuvo que escapar de los avances sexuales de un jefe anterior, y cómo evitó los contactos sociales. Debido a los enfoques sexuales depredadores de los hombres. Pero ella también dijo que había trabajado durante algún tiempo como "conejito" en un club de Playboy, y se sorprendió

mucho cuando el entrevistador la confrontó con la contradicción entre sus afirmaciones y su elección del empleo. La difusión de identidad también se refleja en las descripciones de los períodos significativos en la vida del paciente que no permiten que el entrevistador "los ponga juntos". Para obtener una imagen clara de ellos. La descripción de la importancia de los demás es frecuentemente contradictoria que suenan más como las caricaturas que las personas reales. Una mujer que vivió en un menaje y Trois no podía describir las características del hombre y la mujer con la que vivía o las relaciones sexuales y humanas entre ellos y, particularmente, con ella. Otro paciente límite con la estructura de la personalidad masoquista describió a su madre en varias ocasiones en la entrevista, como cálida, atractiva, sensible y alerta a las necesidades del paciente; y como frío, indiferente, insensible, autoconsalentado, y retirado. Los esfuerzos para aclarar estas aparentes contradicciones se llevaron primero a un aumento de la ansiedad por parte del paciente. Más tarde ella sintió que estaba siendo atacada por la inter-

14 Consideraciones de diagnóstico Viewer, siendo criticado por tener imágenes contradictorias de su madre y, implícitamente, para albergar "malos" sentimientos hacia ella. La interpretación de la proyección de sus propios sentimientos de culpa al entrevistador redujo su ansiedad, pero dejó al paciente con la dolorosa experiencia de una percepción caótica de su madre. Un paciente puede, por supuesto, describir a alguien que es verdaderamente caótico, de modo que uno tiene que distinguir una descripción caótica de otra persona de una cuenta precisa de alguien que, de hecho, crónicamente contradictorio. Esto, en la práctica, es más fácil de lo que parece parecer. La entrevista estructural a menudo nos permite explorar las perpetuos del entrevistador y la dificultad del paciente para empatizar los esfuerzos del entrevistador para reunir lo que percibe como las percepciones del paciente de él. En resumen, la entrevista estructural constituye una situación experimental en la que se puede explorar y probar y analizar una situación experimental en la que se puede explorar y probar y analizar una situación experimental de la integración del yo y la percepción de los objetos. Una identidad sólida del ego refleja una estructura de personalidad neurótica en un paciente con pruebas de realidad intactas. Una identidad anormal y patológicamente integrada puede aparecer en algunos sistemas delirantes crónicos en pacientes manídicos y esquizofrénicos. Estructuralmente hablando, tanto la integración como la congruencia con la realidad que diferencian a la organización neurótica de la organización de personalidad psicótica. Un problema estructural íntimamente relacionado tiene que ver con la calidad de las relaciones de objeto: la estabilidad y la profundidad de las relaciones del paciente con otros significativos, lo que se manifestó por el calor, la dedicación, la preocupación y la tacto. Otros aspectos cualitativos son la empatía, la comprensión y la capacidad de mantener una relación cuando se invade por conflicto o frustración. La calidad de las relaciones con los objetos depende en gran medida de la integración de la identidad, que

incluye no solo el grado de integración, sino también la continuidad temporal del concepto del paciente y de los otros. Normalmente, nos experimentamos constantemente a lo largo del tiempo en circunstancias variables y con diferentes personas, y experimentamos conflictos cuando surgen contradicciones en nuestro autoconcepto. Lo mismo se aplica a nuestra experiencia de los demás. Pero en la organización de la personalidad límite, esta continuidad temporal se pierde; Tales pacientes tienen poca capacidad para una evaluación realista de los demás. Las filtraciones a largo plazo de los Pacientes fronterizos con otros se caracterizan por una percepción cada vez más distorsionada de ellos. Él no logra lograr empatía real; Sus relaciones con los demás son caóticas o poco profundas; y las relaciones íntimas generalmente están contaminadas por su condensación típica de conflictos genitales y pregénicos. La calidad de las relaciones con los objetos del paciente puede ser evidente en esta interacción con el entrevistador. Aunque es una breve, tales industrias diagnósticas a menudo permiten la diferenciación de la acumulación graduada de la personalidad neurótica de una relación personal de un tipo apropiado de la personalidad de Bordelline, de manera persistente, vacía, distorsionada o bloqueada.

Diagnóstico estructural 15 Relación. En el caso de la organización de personalidad psicótica, donde se pierde las pruebas de realidad, puede surgir distorsiones de la relación de diagnóstico al paciente. Es la combinación de dicha distorsión dentro de una acción en la que se mantiene las pruebas de la realidad que es tan característica de la organización de la personalidad límite. El cambio frecuente de enfoque de la presencia de interacción del paciente y el entrevistador a las dificultades del paciente en las interacciones con otros significativos proporciona material adicional para la evaluación de la calidad de sus relaciones de objeto. Mecanismos de defensa primitivos Una diferencia adicional entre la estructura de la personalidad neurótica, por un lado, y la frontera y las estructuras psicóticas, por la otra, es la naturaleza de la organización defensiva. En la neurótica, como se mencionó anteriormente, esto se centra en la represión y otras operaciones defensivas de alto nivel. La frontera y las estructuras psicóticas, en contraste, se caracterizan por un predominio de las operaciones defensivas primitivas, especialmente el mecanismo de división. La represión y los mecanismos de alto nivel relacionados relacionados a medida que la formación de reacción, el aislamiento, la deshacimiento, la intelectualización y la racionalización protegen al ego de los conflictos intrapsíquicos por el rechazo de un derivado de accionamiento o su representación ideational, o ambos, de la Con- ego escaso. La división y otros mecanismos relacionados protegen al ego de los conflictos por medio de la disociación o manteniendo activamente las experiencias contradictorias de los demás y los demás. Cuando predominan tales mecanismos, los estados contradictorios de ego se activan alternativamente. Mientras estos estados de ego contradictorios puedan mantenerse separados entre sí, se evita o se controla la ansiedad relacionada con estos conflictos. El mecanismo de disociación primitiva o división y los mecanismos asociados de la idealización primitiva, los tipos primitivos de proyección (particularmente la

identificación proyectiva), la negación, la omnipotencia y la devaluación pueden ser provocados en la interacción clínica del paciente y Diagnóstico. Estas defensas protegen el paciente límite de los conflictos intrapsíquicos, pero al costo de debilitar su funcionamiento del ego, lo que reduce su efectividad y flexibilidad adaptativa en la entrevista y en su vida en general. Estas mismas operaciones defensivas primitivas, cuando se encuentran en la organización psicótica, protegen al paciente de una mayor desintegración de los límites entre el yo y el objeto. El hecho de que se puedan observar las mismas operaciones defensivas en los pacientes con límites y psicóticos y, sin embargo, se han demostrado clínicamente las diferentes funciones. La interpretación de la división y otros mecanismos relacionados con la organización de personalización límite integra el ego y mejora el funcionamiento inmediato del paciente. Este aumento inmediato (si solo solo transitorio) en la adaptación social y en las pruebas de realidad se puede utilizar con fines de diagnóstico. En contrasta, interpretación de estas defensas al paciente psicótico en la DI-

16 Consideraciones de diagnóstico La entrevista agnóstica produce una mayor regresión en su funcionamiento. Por lo tanto, si el paciente mejora inmediatamente o se deteriora bajo el efecto de dicha interpretación, contribuye de manera crucial a la diferenciación diagnóstica de la organización fronteriza y psicótica. La división. Probablemente la manifestación más clara de la división es la división de los objetos externos en "todo bien" y "todo malo /" con la posibilidad concomitante de cambios completos y abruptos de un objeto de un compartimento extremo a la otra, es decir, reverses repentinos y completos de todos Sentimientos y conceptualizaciones sobre una persona en particular. La oscilación extrema de la petición entre los conceptos contradictorios es otra manifestación del mecanismo de división. En la entrevista de diagnóstico, el Sud-den se desplaza en la percepción del entrevistador o en la percepción del paciente de sí mismo. O una separación completa de las reacciones contradictorias al mismo tema puede reflejar mecanismos de división en la interacción aquí y ahora. Un aumento en la ansiedad del paciente cuando los aspectos contradictorios de su autoimagen o sus representaciones de objetos también indican el mecanismo. De división. Los intentos de aclarar, contrarrestar e interpretar tales aspectos contradictorios de las representaciones de sí mismo y objetos, activan el mecanismo de división en la interacción aquí y ahora y refleja sus funciones con respecto a las pruebas de realidad (aumento o disminución) y la rigidez de Los rasgos de carácter que "fijan" se dividen en problemas estables. Idealización primitiva. Este mecanismo complica la tendencia a ver objetos externos, ya sea totalmente bueno o totalmente malo al aumentar la calidad de la "bondad" o "maldad" de manera totalmente buena o patológicamente. La idealización primitiva crea imágenes poco realistas, todas bien y poderosas; Esto puede reflejarse en la interacción con el diagnóstico al tratarlo como una figura ideal, omnipotente o piadosa en la que el paciente depende de manera poco

realista. El entrevistador o alguna otra persona idealizada puede verse como un aliado potencial contra objetos igualmente poderosos (y igualmente irrealistas) "todo malo". Formas tempranas de proyección, especialmente identificación proyectiva. En contraste con los niveles más altos de proyección caracterizada por el atributo del paciente con el otro impulso que se ha reprimido en sí mismo, las formas primitivas de proyección, en particular la identificación proyectiva, se caracterizan por (i) la tendencia a continuar experimentando el impulso que es simultáneo. Siendo proyectados en la otra persona, (2) temor a la otra persona bajo la influencia de ese impulso proyectado, y (3) la necesidad de controlar a la otra persona bajo la influencia de este mecanismo. Por lo tanto, la identificación proyectiva implica aspectos intrapsíquicos, así como los aspectos internos de comportamiento de las interacciones del paciente, y esto puede reflejarse

Diagnóstico estructural 17 dramáticamente en la entrevista de diagnóstico. El paciente puede acusar al IN-TERVIEWER de una cierta reacción a él, una reacción que el paciente realmente está intentando inducir en el entrevistador por su propio comportamiento. Por ejemplo, un paciente acusó al entrevistador de ser sádico mientras él mismo trataba al entrevistador de una manera fría, controladora, despectiva y sospechosa. La interpretación de esta operación defensiva en el presente y ahora a menudo permite dramáticamente la diferenciación de una personalidad paranoica (una típica constelación de la personalidad límite) de la esquizofrenia paranoide. Negación. La negación en los pacientes con límites normalmente se ejemplifica por parte negativa de dos áreas de conciencia emocionalmente independientes; Podríamos decir que la negación aquí simplemente refuerza la división. El paciente es consciente de que sus percepciones, pensamientos y sentimientos sobre sí mismo u otras personas, en un momento u otra, son completamente opuestas a las que ha tenido en otras ocasiones, pero su memoria no tiene relevancia emocional y no puede influir en la forma en que se siente ahora. La negación puede ser manifestada como una completa falta de preocupación, ansiedad o reacción emocional sobre una necesidad, conflicto o peligro inmediato, grave, urgente en la vida del paciente, de modo que el paciente transmite con calma su conciencia cognitiva de la situación mientras niega sus implicaciones emocionales.. O todo un área de la conciencia subjetiva del paciente puede ser excluida de su experiencia subjetiva, lo que lo protege de un área de conflicto potencial. El esfuerzo empático del diagnóstico para evaluar las circunstancias del paciente y las reacciones del paciente a ellas a la luz de las reacciones humanas normales, uno esperaría de-Diez le brinda al paciente un fuerte contraste entre este EF-Fort empático y su propia actitud aparentemente indiferente o acumulada acerca de él mismo o otros importantes. La negación también puede ser evidente en la discusión del paciente de su

vida actual y en la contradicción entre su situación de vida y su reacción a ella en la entrevista de diagnóstico. Omnipotencia y devaluación. Tanto la omnipotencia como la devaluación son derivados de las operaciones de división que afectan a las representaciones de sí mismo y objetos y, por lo general, están representadas por la activación de los estados del EGO que reflejan un yo muy inflado y se refiere a las representaciones de degradaje emocionalmente inflado. De los demás. Personalidades narcisistas, un subgrupo especial de organización de personalidad límite, presente estas operaciones defensivas con bastante fuerza. La omnipotencia y la devaluación pueden manifestarse en las descripciones de los pacientes de otros distintos y sus interacciones con ellos y en su comportamiento durante la entrevista diagnóstica. A este respecto, el diagnóstico debe estar especialmente alerta a las pequeñas o sutiles indicaciones de comportamiento patológico se pueden obtener en los contactos diagnósticos tempranos con el paciente. Teniendo en cuenta que un paciente generalmente intenta presentarse en su mejor momento en una

18 Consideraciones de diagnóstico NUEVA SITUACIÓN (y que, si no lo hace, la patología de caracteres serias puede estar indicada), se debe concluir que tanto los comportamientos inapropiados, cuando están presentes, y las desviaciones sutiles de un comportamiento "perfectamente normal" requieren sondeo en entrevistas de diagnóstico. Realidad Prueba de organización de personalidad neurótica y fronteriza presente el mantenimiento de las pruebas de realidad, en contraste con las estructuras de la personalidad psicótica. Por lo tanto, si bien el síndrome de difusión de identidad y la predominio de las operaciones defensivas primitivas permiten la diferencia estructural de la frontera de las condiciones neuróticas, las pruebas de realidad permiten la diferenciación de la organización de la personalidad límite de los principales síndromes psicóticos. Las pruebas de realidad se definen por la capacidad de diferenciarlo de acuerdo con la norma, intrapsíquica de los orígenes externos de las percepciones y los estímulos, y la capacidad de evaluar de manera realista la propia afección, comportamiento y el contenido de pensamiento en términos de normas sociales ordinarias. Clínicamente, las pruebas de realidad son reconocidas por (i) la ausencia de alucinas y delirios; (2) la ausencia de afecto extremadamente inapropiado o extraño, contenido de pensamiento o comportamiento; y (3) la capacidad de empatizar y aclarar las observaciones de otras personas de lo que les parecen aspectos inapropiados o desconcertantes de los efectos, el comportamiento o el contenido del paciente en el contexto de las interacciones sociales ordinarias. Las pruebas de realización deben diferenciarse de las alteraciones en la experiencia subjetiva de la realidad, que pueden estar presentes en algún momento de cualquier paciente con angustia psicológica, y de la alteración de la relación con la residencia que está presente en toda la patología del carácter, así como en más regresión, Condiciones psicóticas. Por sí mismo, es de valor diagnóstico solo en formas muy extremas (FROSCH, 1964). ¿Cómo se refleja la

realización de la realidad en la entrevista de diagnóstico estructural? 1. Las pruebas de la realidad se pueden considerar presente cuando la información del paciente indica que no ha sufrido y no ha sufrido de alucinaciones o delirios, o si ha tenido alucinaciones o desliciones en el pasado, que ahora tiene la capacidad de evaluarlos completamente., Incluida la capacidad de expresar la preocupación apropiada o el desconcierto sobre tales fenómenos. 2. En pacientes que no hayan tenido alucinaciones o delirios, las pruebas de realidad pueden ser evaluadas por el enfoque del entrevistador en el que se puede observar considerablemente en lo que nunca se puede observar, el contenido del pensamiento o el comportamiento. La realización de la realidad se refleja en la capacidad del paciente para empatizar con la percepción del entrevistador de estas características y, de manera más sutil, en su capacidad para empatizar con la percepción del entrevistador de la interpretación con el paciente en general. La entrevista estructural, como he señalado, por lo tanto, constituye una oportunidad ideal para la realización de la realidad.

Diagnóstico estructural 19 ING y así para la diferenciación de la frontera de la organización psicótica. 3. Por razones mencionadas anteriormente, las pruebas de realidad también pueden evaluarse interpretando las operaciones defensivas primitivas en la interacción del entrevistador del paciente. Una mejora en el funcionamiento inmediato del paciente como consecuencia de dicha interpretación refleja el mantenimiento de las pruebas de realidad, mientras que un deterioro inmediato de la función del paciente como consecuencia de tal intervención indica la pérdida de las pruebas de la realidad. La Tabla I resume la diferenciación de la organización de la personalidad en términos de los tres criterios estructurales de integración de identidad, operaciones defensivas y pruebas de realidad. Manifestaciones no específicas de la debilidad del ego Las manifestaciones "no específicas" de la debilidad del ego incluyen la ausencia de tolerancia a la ansiedad, de control de impulso y de canales desarrollados de sublimación. Estos se diferencian de los aspectos "específicos" de la debilidad del ego: las consecuencias del debilitamiento del ego de la predominio de los mecanismos defensivos primitivos. La tolerancia a la ansiedad se refiere al grado en que el paciente puede tolerar una carga de tensión mayor que lo que experimenta habitualmente sin desarrollar síntomas incrementados o comportamiento recesivo genoralmente regresivo; El control de impulso se refiere al grado en que el paciente puede experimentar impulsos instintivos o emociones fuertes sin tener que actuar sobre ellos inmediatamente contra su mejor juicio e interés; La efectividad sublimatoria se refiere al grado en que el paciente puede invernarse en valores más allá de su autoconservación inmediata o personal, especialmente en el grado en que puede desarrollar recursos creativos en algún área más allá de su fondo natural, educación o capacitación. Estas características, aunque reflejan las condiciones estructurales, se manifiestan en el comportamiento directo, que pueden ser provocadas en el curso de la

historia del paciente. Las manifestaciones no específicas de la debilidad del ego diferencian a la organización de la personalidad límite y las psicosis de las estructuras de la personalidad neurótica, pero tienen una función diferenciadora menos precisa y clara entre la frontera y las estructuras neuróticas que las verdaderas para la integración de la identidad y los niveles de defensiva. Organización. Muchas personalidades narcisistas, por ejemplo, presentan menos indicaciones de síntomas inespecíficos de la debilidad del ego que uno podría esperar. Falta de integración de SuperOgo A relativamente bien integrada, aunque el superyo excesivamente grave, el suministro, los tipos neuróticos de organización de la personalidad. Límite y

Tabla 1. Diferenciación de la organización de personalidad Criterios estructurales Bordelítico neurótico Las representaciones psicóticas y las representaciones de objetos están claramente delimitados. Difusión de identidad: aspectos contradictorios de sí mismo y otros están mal integrados y se han mantenido separados. Identidad de identidad integrada: auto representan: integración, las imágenes contradictorias y las representaciones de objetos están mal delimitadas, o bien, hay identidad delirante. Las edades de sí mismo y otras están integradas en concepciones preiefensivas. Operaciones defensivas La represión y los productos de alto nivel: formación de reacción, aislamiento, deshacimiento, prisionero, responsabilidad. Las defensas protegen al paciente del conflicto intrapsíquico. La interpretación mejora la funcionalización. Principalmente divisiones y defensas de bajo nivel: idealización primitiva, identificación proyectiva, denegación, omnipotencia, deservaluación. Las defensas protegen al paciente de la incendio y la fusión de sí mismo / objeto. La interpretación conduce a la regresión. Se conserva la capacidad para probar la realidad: la diferencia de auto de la fiebre, intrapsy chic a partir de orígenes externos de percepciones y estímulos. Las alteraciones ocurren en relación con la resistencia y en los sentimientos de la realidad. Se pierde la capacidad para probar la resistencia. La capacidad existe para evaluarlo y otros de manera realista y en profundidad. La realidad de prueba

Diagnóstico estructural 21 Las organizaciones psicóticas reflejan deficiencias en la integración de SupereOgo y se caracterizan por precursores de superyo no integrados, particularmente representaciones de objetos sádicos e objetos idealizados primitivos. La integración de SupereOgo se puede evaluar al estudiar el grado en que el paciente identifica con los valores éticos y tiene la culpa normal como un regulador importante. Regulación de la autoestima por sentimientos de culpabilidad excesivamente graves o cambios de humor depresivos representa una integración patológica de sumino (típica de la organización neurótica) en contraste con las funciones autocríticas moduladas, específicamente enfocadas, específicas del individuo normal en términos de valores éticos.. El grado en que la persona puede regular su funcionamiento de acuerdo con los principios éticos; abstenerse de la explotación, manipulación o maltrato de otros; y mantener la honestidad y la integridad moral en ausencia de control externo indica la integración de SupereOgo. Este criterio es de diagnóstico menos confiable que los que se describen anteriormente. Incluso los pacientes que emplean defensas predominantemente primitivas pueden dar evidencia de la integración de su superyó, aunque puede ser sádica en la nación, y hay pacientes con una organización de personalidad límite que mantienen una integración de superego relativamente buena a pesar de la patología severa en el área de la integración de la identidad, Relaciones con objetos, e organización defensiva. Además, la información sobre la integración de SUPEROGO puede ser provocada de manera más efectiva de la historia del paciente y de la observación a largo plazo que en la entrevista de diagnóstico. Sin embargo, la utilidad pronóstica del grado de integración de Superego lo convierte en un criterio estructural enorboso importante para la indicación o contraindición de la psicoterapia intensiva a largo plazo. De hecho, la calidad de las relaciones de objetos y la calidad del funcionamiento del superego son probablemente los dos criterios pronósticos más

importantes que se derivan de un análisis estructural. Características genéticas-dinámicas de los conflictos instintivos Aunque los conflictos instintivos de la organización de la personalidad límite de la característica se manifiestan en los compromisos terapéuticos a largo plazo con los pacientes con límites, son relativamente difíciles de discernir en entrevistas diagnósticas y se describen aquí en el interés de la integridad. La organización de personalidad límite presenta una condena patológica de los esfuerzos instintivos genitales y pregénicos, con un predominio de agresión pregenital (Kernberg, 1975). Este supuesto exige la condensación extraña o inadecuada de los impulsos sexuales, dependientes y agresivos encontrados clínicamente en la organización límite (y también psicótica). Lo que aparece como una persistencia caótica de unidades primitivas y temores, la panexualidad del caso límite, representa una combinación de diversas soluciones patológicas de estos conflictos. También debe destacarse aquí que la discrepancia entre el desarrollo histórico real del paciente y su experiencia interna y fijada.

22 Las consideraciones de diagnóstico de esto son enormes. Lo que nos enteramos en la exploración psicoanalítica de estos casos no es lo que sucedió en la realidad externa, sino la forma en que el paciente experimentó sus importantes relaciones de objetos en el pasado. De la misma manera, no podemos tomar el historial inicial del paciente a valor nominal: cuanto más grave sea la patología del personaje, menos confiable la historia inicial. En los trastornos de la personalidad narcisista de Seane y en la personalidad de la personalidad limítrofe en general, la historia inicial del desarrollo temprano es de manera frecuente vacía o caótica o engañosa. Solo después de años de tratamiento, es posible reconstruir una secuencia genética interna (en el sentido de los orígenes intrapsíquicos) y relacionarlo de alguna manera a las experiencias pasadas reales del paciente. Las características del conflicto instintivo enumeradas a continuación se derivan de la literatura, resumidas en otros lugares (Kernberg, 1975), y de mi propia experiencia con psicoterapia psicoanalítica intensiva y psicalia de pacientes con límites. La primera es una agresividad excesiva de los conflictos edípicos, de modo que la imagen del rival de edificación edípica generalmente adquiere características aterradoras, abrumadoramente peligrosas y destructivas; La ansiedad de castración y la envidia del pene parecen extremadamente exageradas y abrumadoras; y la producción de Superego contra las relaciones sexualizadas adquieren una calidad salvaje, primitiva, manifestada en tendencias masoquistas graves o proyecciones paranoicas de precursores de superyo. En segundo lugar, las idealizaciones del objeto de amor heterosexual en la relación preventiva prevaltiva y del objeto de amor homosexual en la relación edípica negativa se exageran y tienen marcadas funciones defensivas contra la rabia primitiva. Por lo tanto, existe una idealización poco realista de y el anhelo de tales objetos de amor y la posibilidad de una rápida interrupción de la idealización, con una reversión de la relación positiva a la negativa (o negativa a positiva) en un cambio rápido y total de la

relación del objeto. Como consecuencia, las idealizaciones aparecen exclamatorias y frágiles, con la complicación adicional en el caso de la patología de caracteres narcisistas de la fácil devaluación de los objetos idealizados y el retiro total. Tercero, la naturaleza poco realista del rival de edificación amenazante y la idealizada, deseada revela, en un análisis genético cuidadoso, la existencia de imágenes condensadas padre-madre de un tipo irreal, que refleja la condensación de aspectos parciales de las relaciones con ambos padres. Si bien se mantienen las diferencias sexuales en las relaciones con los objetos, la relación fanfasied con cada uno de estos objetos es poco realista y primitiva y refleja la condensación de las relaciones idealizadas o amenazadoras que se derivan de los desarrollos preeedipales y edípicos y un cambio rápido de ambos Relaciones bidales y agresivas de un objeto parental a la otra. Cada relación particular con un objeto de los padres resulta que refleja un historial de desarrollo más complejo que generalmente el caso de los pacientes neuróticos, excepto por los más severos neuróticos, en los que la transferencia-

Diagnóstico estructural 23 Los desarrollos de ENCE están más estrechamente relacionados con los eventos realistas del pasado. Cuarto, los luchos genitales de los pacientes con conflictos previos predominantes de predefinidos sirven importantes funciones pregénicas. El pene, por ejemplo, puede adquirir características de la alimentación, la retención o la madre que ataca (básicamente la función de alimentación de su seno), y la vagina puede adquirir funciones de la boca hambrienta, alimentación o agresiva; Los desarrollos similares se producen con respecto a las funciones anal y urinarias. Aunque muchos pacientes neuróticos y pacientes con una patología menos grave de caracteres también presentan estas características, su existencia en combinación con la excesiva agresividad de todas las funciones libidales pregenitales es la típica de los pacientes con la organización de personalidad límite. El quinto lugar, los pacientes con límites, generalmente muestran lo que podría describirse como una edipalización prematura de sus conflictos y relaciones preeedipales, una progresión defensiva en su desarrollo instintivo que se refleja clínicamente en la previsión temprana de la transferencia. Este fenómeno de transferencia a menudo resulta ser espurio porque eventualmente lleva de nuevo a la patología preeedipal severa y caótica; Sin embargo, al mismo tiempo es significativo en lo que indica la organización defensiva de los conjuntos de edificación edificada que eventualmente, a veces, después de años de tratamiento, predominan en la transferencia. En este sentido, nuestro conocimiento en desarrollo sobre la conciencia genital temprana en ambos sexos y la diferencia en las relaciones madre infantil dependiendo del sexo infantil (dinero y EHRHARDT, 1972; Galenson y Roiphe, 1977; Kleeman, 1977; Stoller, 1977) puede proporcionar información sobre el comportamiento para bebés temprano que se relaciona con los procesos intrapsy-chices por los cuales se produce un escape de los conflictos preeedipales a la oedición de las relaciones de objetos. En ambos sexos, el

desplazamiento de las necesidades de dependencia frustrada de la madre a padre los colores es la relación previo positivo de la niña y la relación edípica negativa del niño. El desplazamiento de conflictos orales-agresivos de la madre a padre aumenta la ansiedad de castración y la rivalidad previa en los niños y la envidia del pene y las distorsiones de caracteres relacionados en las niñas. En las niñas, la agresión pregenital severa hacia la madre refuerza las tendencias masoquistas en su relación con los hombres, las prohibiciones severas de superoplo contra la genitalidad en general, y la relación edípica negativa a la madre como una idealización defensiva y la formación de reacción contra la agresión. La proyección de conflictos primitivos en torno a la agresión en la relación sexual entre los padres aumenta la impresión y las versiones aterradoras de la escena primordial, que pueden extenderse al odio de todo el amor mutuo ofrecido por otros. Más generalmente, el desplazamiento defensivo de los impulsos y los conflictos de una parrilla a la otra a la otra fomenta el desarrollo de combinaciones fantásticas y fantásticas de imágenes parentales bisexuales condensadas bajo la influencia de un impulso proyectado en particular.

24 Consideraciones de diagnóstico Todas estas características de los conflictos instintivos de los pacientes con organización de personalidad de bordesal pueden reflejarse en la síntal-Matología inicial y en su comportamiento, fantasías y relaciones interpersonales de su comportamiento sexual. Pero, como se mencionó anteriormente, no se prestan a menudo a un análisis en profundidad durante las primeras entrevistas de diagnóstico. Conclusión Varias cuestiones requieren una investigación más clínica y experimental. Estos se relacionan con el diagnóstico estructural de la organización de la personalidad límite en momentos de regresión temporal, como los breves epiálidos psicóticos que los pacientes con límite tienen bajo la influencia de la crisis emorfia grave, el alcohol o las drogas. La experiencia clínica preliminar sugiere que la entrevista de diagnóstico estructural aquí propuesta aún puede diferenciar la organización de la personalidad límite en estas condiciones, en efecto, en efecto, reduciendo temporalmente la pérdida de las pruebas de la realidad en estos pacientes. Sin embargo, la exploración adicional será necesaria para confirmar esto. Las características decriptivas de tales episodios psicóticos breves y el hecho de que están incorporados en una estructura de personalidad típica de la organización de personalidad límite constituyen los criterios de diagnóstico positivos en este momento. Otro problema es presentado por reacciones psicóticas bajo la influencia de los fármacos psicotomiméticos, que a menudo, durante su etapa aguda, plantean la cuestión del diagnóstico diferencial entre episodios psicóticos agudos en la organización de la personalidad límite y las reacciones esquizotríficas agudas (Trastorno esquizofreniforme en la Asociación Psiquiátrica Americana, 1980 [DSM-III]). Una vez más, la evidencia preliminar parece indicar que la pérdida de la realización de la realidad en la psicosis inducida por fármacos en la organización de la personalidad limítrofe puede mejorar de manera transitorial la evaluación diana de manera estructural propuesta, en contraste

con el aumento temporal de la recuperación cuando se interpretan las defensas primitivas. En el caso de las reacciones esquizofrénicas. Esto es, sin embargo, solo una impresión preliminar. Un problema importante es el de las características estructurales de los pacientes con enfermedades esquizofrénicas crónicas durante los períodos de remisión. Mis colegas y yo hemos observado varios tipos de organización de personalidad en tales pacientes. Algunos pacientes esquizofrénicos crónicos parecen "juntar" y presentar una organización neurótica de personalidad durante los períodos de latencia; otros sellan y presentan una organización de personalidad límite; Aún otros pacientes esquizofrénicos crónicos presentan una regresión psicótica típica cuando se examinan con el enfoque estructural durante los períodos de remisión clínica, lo que indica así la permanencia o la persistencia de una estructura psicócialmente psicótica. Por lo tanto, la estructura de personalidad subyacente de los pacientes esquizofrénicos crónicos durante la remisión puede no ser uniforme, y puede ser posible diferenciar, con criterios estructurales, crónico

Diagnóstico estructural 25 organizaciones psicóticas de personalidad propias de pacientes con un nivel de nivel superior. Si es así, esto puede tener implicaciones pronósticas y terapéuticas en términos de las condiciones previas y características de los turnos en la organización de personalidad predominantes que observamos en algunos pacientes esquimánicos durante la remisión. Los criterios estructurales propuestos, en particular la de las pruebas de la realidad, pueden considerarse como herramientas de diagnóstico extremadamente útiles que se utilizarán en la conclusión con una evaluación de los síntomas descriptivos de las diversas condiciones psicóticas. El enfoque de diagnóstico estructural puede enriquecer significativamente la nitidez, la precisión y la precisión de nuestros diagnósticos diferenciales y agregar elementos importantes a las consideraciones pronósticas y terapéuticas de cada caso individual. No obstante, algunos casos probablemente continúen desafiando nuestra capacidad de diagnóstico diferencial, al menos cuando se intenta en un período de tiempo relativamente breve. El enfoque estructural del diagnóstico diferencial de la organización de la personalidad límite de límites subraya la importancia de diagnosticar al paciente como un individuo total y de evaluar su vida interna de las relaciones de objetos en términos de su concepto de sí mismo y de otros significativos. Para- cebédicamente, este enfoque dinámico basado en la teoría de las relaciones de objetos, que parece ser contraria a una forma más descriptiva de diagnóstico basada en los síntomas y el comportamiento, enriquece el diagnóstico descriptivo. Desde el punto de vista de la metodología de investigación, es más fácil y aparentemente, más "objetivo" descompone el comportamiento humano en grupos de manifestaciones conductuales que para estudiar al individuo humano en su totalidad. Sin embargo, a pesar de las dificultades metodológicas implicadas por un estudio de este tipo de la totalidad del individuo, a largo plazo puede proporcionar una base más firme para la investigación

sobre la organización de la personalidad y el cambio de personalidad. El diagnóstico de la organización de la personalidad límite afecta tanto el pronóstico como el tratamiento. Donde el diagnóstico estructural determina la presencia de la organización de la personalidad límite en lugar de la neurosis sintomática ordinaria y la patología del carácter, indica limitaciones a la posibilidad de un tratamiento psicoanalítico; sugiere que la psicoterapia psicoanalítica expresiva intensiva a largo plazo en lugar de un tratamiento supciente sería más apropiado; Señala la necesidad de evaluar completamente si y cómo estructurar la vida externa del paciente, mientras que tal psicoterapia intensiva ingrese; Significa que, en condiciones de crisis aguda, se indica la intervención de crisis. En última instancia, la Decisión deberá hacerse en última instancia en qué enfoque de tratamiento para adoptar la psicoterapia externa o de apoyo. Para aquellos casos en que la psicoterapia expresiva está contraindicada y se eligió un enfoque de apoyo, la posibilidad puede tener que aceptarse que un paciente puede necesitar apoyo durante muchos años o quizás de la vida. En mi opinión, este diagnóstico tiene un mejor pronóstico para muchos pacientes hoy en día de lo que tenía solo 20 o 30 años. En el caso de los pacientes.

26 Consideraciones de diagnóstico con enfermedades esquizofrénicas crónicas, el diagnóstico de la organización de personalización límite (en contraste con la estructura psicótica) durante los períodos de reusión indica la posibilidad de la psicoterapia psicoanalítica y, implícitamente, la posibilidad de Mejorando fundamentalmente la estructura de la personalidad y, por lo tanto, otorgando a la protección adicional del paciente contra la desglose psicótica.

Capítulo 2: La entrevista estructural Mi objetivo principal en este capítulo es ilustrar la utilidad clínica de entrevistas estructurales, particularmente en el diagnóstico diferencial de las condiciones fronterizas. Las descripciones clínicas detalladas de diferentes patrones que emergen durante las entrevistas estructurales también deben ilustrar los límites de la utilidad de la entrevista estructural. Para decirlo brevemente, más emerge un síndrome psicótico u orgánico claro, cuanto más se asemeja a la entrevista estructural el examen tradicional de estado mental. Pero para los pacientes dentro del fronterizo o el espectro neurótico de la pizamatología, las ventajas de la entrevista estructural se hacen evidentes rápidamente. La entrevista estructural no solo afecta el diagnóstico diferencial, sino que también revela información con importantes implicaciones pronósticas y terapéuticas. Nos cuenta sobre la motivación del paciente, su capacidad de introspección y su colaboración en el tratamiento psicotericídico, y su potencial para actuar y para la descompensación psicótica. Una pregunta importante es si se debe tomar una historia psiquiátrica estándar antes de una entrevista estructural, que, bajo estas condiciones, luego reemplaza el examen tradicional de estado mental; O si tanto la historia de la historia estándar como el examen tradicional de estado mental deben ser reemplazados por una entrevista estructural, lo que puede terminar con la historia selectiva: toma la luz de los hallazgos de la entrevista en sí. Las ventajas de comenzar con la historia clásica de la historia son que este método cumple con mayor facilidad a la capacitación de los residentes psiquiátricos en la historia y el examen de los residentes médicos, permite que el psiquiatra diagnostica una psicopatología psicótica y orgánica obvia (donde la entrevista estructural es mucho menos importante.), Y, debido a que este enfoque es más tradicional, disminuye la ansiedad inicial para los 27

28 Consideraciones de diagnóstico Paciente ajustando las expectativas ordinarias de la interacción del paciente / médico. Para comenzar a tomar un historial, también evita las consecuencias de un brote prematuro grave de las defensas primitivas (con la activación de los desarrollos inadagóricamente negativos o de oposición, particularmente en el caso de pacientes paranoicos). Las desventajas de comenzar con una entrevista estructural de la historia tradicional, que permite que las operaciones defensivas predominantes del paciente sean subterráneas, y, especialmente, con las estructuras de la personalidad fronteriza y neurótica, facilita que el paciente "adapte" protectoramente a la entrevista, que Disminuye la ansiedad mientras considera áreas de conflictos actuales y desarrollos de transferencia temprana. Al sopesar estas ventajas y desventajas, creo que, menos tiempo, el entrevistador tiene para una evaluación completa del paciente, y la menor experiencia que el entrevistador ha tenido en entrevistas estructurales, mayor es la ventaja al comenzar con una historia estándar y luego cambiarse a la entrevista estructural. En contraste, más tiempo disponible, más experimentó el entrevistador, y cuanto más se centra la di-agnosis diferencial en los límites entre neuróticos y límite, y entre la frontera y la estructura psicótica, más útil es comenzar con una entrevista estructural, con la comprensión de la información histórica requerida en Los casos individuales se ajustarán naturalmente a las fases avanzadas de la entrevista estructural. El entrevistador comienza pidiéndole al paciente que presente un breve resumen de sus razones para llegar al tratamiento, sus expectativas de tratamiento y la naturaleza de sus síntomas, problemas o dificultades predominantes. Si bien el patrón de búsqueda que sigue las preguntas de apertura inicial puede variar en diferentes enfoques a la entrevista estructural (Stone, 1980; Selzer, 1981), mi preferencia es seguir la investigación inicial con una búsqueda sistemática, examinando el ciclo de "SÍNTOMAS DE ANTLANO" de la psicopatología clave indicado en

el perímetro del círculo en la figura i. La encuesta completada, el entrevistador se enfoca en los síntomas significativos que surgieron en su curso, explorándolos a medida que aparecen en la interacción aquí y ahora de la entrevista, seguidos de la clarinicatura, la confrontación y la interpretación tentativa, con una atentida atentida. Dado a las reacciones del paciente a estas intervenciones. La capacidad del paciente para empatizar con la consulta del entrevistador, para aclarar aún más las Islas con respecto a su identidad del ego, las relaciones de objetos, las pruebas de realidad y las configuraciones de impulsos de defensa, otorgan una indicación de su capacidad de introspección. El diagnóstico estructural depende en gran medida de cómo el paciente maneja aclaraciones, confrontaciones e interpretaciones. Si, por ejemplo, la encuesta inicial ha revelado alguna evidencia de difusión y defectos de identidad en las pruebas de realidad, el entrevistador primero atenta a amplificar la expresión de estas características en el presente y-

29 Figura 1. Ciclismo de síntomas de anclaje. Ahora interacción de la entrevista. Luego, se enfrenta al paciente llamando la atención a las discrepancias en lo que el paciente ha dicho o a otras incongruencias que indican la posible naturaleza defensiva de su comportamiento. Además, el entrevistador interpreta tentativamente la posible importancia de las discrepancias, que desafía aún más al paciente a expresar su comportamiento y motivaciones. Se le pregunta al paciente cómo ve a estas inconsistencias, cómo se siente acerca de ellos y qué otra información podría aclarar lo que ha estado ocurriendo. La entrevista estructural

30 Consideraciones de diagnóstico Las respuestas del paciente son de importancia primordial para diferenciar estructuras neuróticas, fronterizas y psicóticas. Dada su capacitación intacta para las pruebas de realidad, los pacientes límite revelan una reorganización y mejora a menudo sorprendentes en el funcionamiento con estas aclaraciones, confrontaciones e interpretaciones. Son capaces de empatizar con las "confusiones" del entrevistador para aclarar y corregir sus percepciones y utilizar estas correcciones constructivamente en fases posteriores de la vista. Además, los pacientes fronterizos demuestran cierta capacidad para la invisión y la percepción de la base de las incongruencias. Como se señaló anteriormente, los pacientes con estructuras psicóticas carecen de esta capacidad para empatizar con criterios sociales ordinarios de la realidad, y, por lo tanto, los intentos de aclarar pueden revelar más distorsiones en las pruebas de realidad. Los pacientes neuróticos, a diferencia de los casos límite, emergen con un concepto integrado de ellos, lo que, a su vez, tiende a aumentar la empatía del entrevistador con diversos aspectos de sus conflictos y la realidad y con sus conceptos integrados de otros significativos. Este último da la realidad interpersonal y la historia pasada de estos pacientes una fuerte presencia. Mientras que los pacientes con límites pueden aumentar su comportamiento realista durante la entrevista, simultáneamente hacen que el vacío, el caos y la confusión en su situación de vida y las relaciones de objetos. Con los pacientes que están inarticulados y se comunican mal, la información de fuentes distintas de la entrevista debe ser llevada a soportar el proceso de diagnóstico. Las inferencias sobre los síntomas de anclaje se pueden hacer de dicha información. Luego, se puede intentar el enfoque en los síntomas en el presente y ahora y la aclaración, la confrontación y la interpretación. Esta investigación más detallada puede llevarse a cabo para el severo de los síntomas de anclaje de presentación hasta que el entrevistador se sienta cómodo con el diagnóstico

estructural. La entrevista de diagnóstico estructural, luego, combina un enfoque psicoanítico en la interacción del entrevistador de pacientes con una técnica psicoanalítica para interpretar problemas conflictivos y operaciones defensivas en esta interacción para resaltar simultáneamente los síntomas de anclaje clásico de Psicopatología descriptiva y la estructura de personalidad subyacente. Una característica significativa del modelo propuesto para entrevistar estructural es su naturaleza cíclica. El concepto de los síntomas de anclaje como logrado en el perímetro de un círculo lo hace posible para el entrevistador, ya que procede de un síntoma cardinal a otro, para regresar incluso al punto de partida y reiniciar un nuevo ciclo de consulta, en un contraste agudo con un "Árbol de decisión" Modelo de investigación, que tiene un patrón fijo de progresión. "Reciclaje" a lo largo de los síntomas de anclaje permite que el entrevistador regrese con la frecuencia que sea necesario para los mismos problemas en diferentes contextos, lo que se involucre los hallazgos preliminares en las etapas posteriores del intervista. Como se verá, no se pretende que la simpatización de anclajes

La entrevista estructural 31 Toms se exploran invariablemente sistemáticamente, uno por uno. Dependiendo de los hallazgos tempranos, se recomiendan diferentes enfoques a este ciclo de investigación. La fase inicial de la entrevista estructural es útil comenzar la entrevista con varias preguntas (directas o indígenas) presentadas en secuencia, lo que proporciona tanto una idea clara de lo que espera del paciente y varias formas posibles para que él se adhiera. Además, la misma capacidad del paciente para comprender una serie de preguntas y recordarlas pruebas su funcionamiento en varios síntomas clave de anclaje. Una consulta inicial típica podría ser de la siguiente manera: "Estoy interesado en escuchar lo que le trajo aquí, cuál es la naturaleza de sus dificultades o problemas, lo que espera del tratamiento y dónde está ahora en este sentido". Si la entrevista ocurre en el contexto de una consulta hospitalaria o una configuración de investigación, o si el entrevistador tiene información previa sobre el paciente de otras fuentes, podría agregar un comentario ex plonatorio, como: "He tenido la oportunidad de escuchar algo sobre sus dificultades, pero estoy muy interesado en aprender de saber de Directamente cómo ves todo esto", o "me gustaría decirle que al, aunque tendré la oportunidad de conocer sus dificultades de los miembros del personal [o la persona que lo remitió por una consulta, etc.] en este punto, no tengo información sobre usted". Esta apertura permite al paciente hablar sobre sus síntomas y las razones principales de su llegada al tratamiento, así como para ampliar la naturaleza de otras dificultades. Permite al entrevistador evaluar en directamente la conciencia del paciente de su enfermedad y de la necesidad de tratamiento y la naturaleza realista o poco realista de sus expectativas del tratamiento y las reacciones a las recomendaciones de tratamiento ya sugeridas. En respuesta a estas preguntas, los pacientes sin psicopatología psicótica o ornica pueden hablar libremente sobre los síntomas y dificultades neuróticos en los aspectos psicológicos de su vida social que apuntan a los

rasgos de carácter patológico; Por lo tanto, indirectamente, dan el primer signo de buenas pruebas de realidad. La capacidad de recordar estas preguntas, para responder a ellos de una manera cohesiva y bien integrada, también indica un sensorio transparente, una buena memoria y probablemente una intelidad normal o incluso alta. Representa, por lo tanto, un primer "ciclismo" automático a lo largo de todo el perímetro de los síntomas de anclaje. En contraste, los pacientes con alteraciones en el sensorio (disminución de la atentización, orientación, conciencia, comprensión o juicio) pueden tener dificultades para responder a tales preguntas, y lo mismo es cierto para los pacientes con memoria o déficit intelectual (particularmente, una capacidad limitada para la abstracción), que es, pacientes con síndromes cerebrales orgánicos agudos o crónicos.

32 Consideraciones de diagnóstico Los pacientes también pueden ser excesivamente concretos, vagos, confusos o evicantes en sus respuestas a estas preguntas. Luego, el entrevistador puede aclarar plenamente la discrepancia entre las preguntas y las respuestas. Es útil investigar si el paciente siente que ha respondido plenamente a lo que se le preguntó o cree que las preguntas no han sido claras, o tal vez son abrumadoras. Si el paciente ahora reconoce las dificultades para seguir o comprender al entrevistador, las preguntas deben repetirse, redactarse de manera un tanto de manera diferente, y el entrevistador debería explorar si el paciente todavía tiene dificultades en la parte inferior. Si este es el caso, debería explorar la siguiente cuál es la naturaleza de la dificultad. De esta manera, a menudo "ingresando" el ciclo de diagnóstico a través de la evaluación de los síntomas, la entrevista ahora puede liderar rápidamente a la aclaración, la confrontación y la interpretación de la dificultad, lo que permite al entrevistador diferenciar la confusión derivada de la ansiedad inflable y de la psicótica. Malinterpretación de la situación total, el negativismo y la alteración del sensorio, o las graves déficits de memoria o de la intelidad. El paciente puede responder de manera que tengan poco o ninguna relación aparente a la pregunta inicial. Un paciente esquizofrénico severamente desorganizado, uno con un síndrome hipomaníaco o con una patitud de carácter grave, puede hacer uso de la investigación inicial para expresar, por ejemplo, evasividad paranoica u perfeccionismo obsesivo al aclarar a cada uno del entrevistador Las declaraciones. Un paciente masoquista puede comenzar a llorar como si se le presentara una tarea excesivamente onerosa. Todas estas respuestas pueden explorarse con tacto, aclarando las preguntas una vez más, al tiempo que, al momento de obtener más información sobre la naturaleza de la dificultad que evocó las preguntas. De esta manera, las manifestaciones tempranas de la pérdida de la realización de la realización de la realización, los síntomas psicóticos y los síntomas orgánicos agudos o

crónicos pueden ser provocados, junto con los desarrollos de transferencias prematuras, la característica de los pacientes con patología severa. Si un paciente primero responde adecuadamente a las preguntas iniciales, pero luego se pierde en detalles al intentar aclararlos más, el entrevista debe explorar nuevamente para varios complejos de síntomas. Dentro del ámbito de los síntomas neuróticos, ¿el paciente se pierde en detalles debido a las tendencias obsesivas? ¿Es vago y cauteloso al expresar tendencias para no? Dentro del ámbito de la pérdida de la pérdida de las pruebas de la realidad y los síntomas psicóticos, ¿es el paciente evasivo debido a las dellas paranoicas subyacentes u otras interpretaciones psicóticas de la presenta interacción? ¿Se pierde en detalle debido a problemas en sus funciones cognitivas, ya sea debido a la alteración en el sensorio o debido a la pérdida crónica de la memoria y la inteligencia? Una vez más, la clarificación táctil, la exploración con el paciente de su dificultad para responder (confrontación), y la exploración tentativa de las razones de la dificultad de la comunicación (interpretación) puede enfocar la atención en uno u otro de los principales anclajes

La entrevista estructural 33 síntomas y proporciona pistas tempranas a las características descriptivas y estructurales del paciente. Si el paciente puede entender y responder de manera completa y clara a las preguntas iniciales, y al mismo tiempo presentar una imagen coherente de los principales síntomas que lo llevó a consultar y de otros problemas y dificultades, el entrevistador puede luego aumentar las preguntas subsidiarias derivadas de la información que ya se presenta. Por ejemplo, puede preguntar sobre aspectos más precisos de los síntomas, la fecha aproximada de su apariencia y su desarrollo, y síntomas relacionados adicionales; Esto puede completar la información sobre los síntomas neuróticos y, al mismo tiempo, indica indirectamente que el paciente tiene un sensorio normal, no hay déficits de memoria importantes, y al menos un nivel normal de funcionamiento de la inteligencia. Sin embargo, si en el curso de la descripción del paciente de sus dificultades, se refiere específicamente a la concentración, la memoria y sus funciones cognitivas en general, el entrevistador ahora tendría una buena razón para centrarse más sobre los síntomas de los síndromes cerebrales orgánicos agudos y crónicos, pero con un La comprensión preliminar de que se mantiene las pruebas de realidad (y el paciente, por lo tanto, incluso si está ornico, no está demente). Cuando las respuestas del paciente no conducen en una dirección "orgánica", sino que transmiten información que indique un excelente nivel de funcionamiento en términos de sensorio, memoria e inteligencia, se puede asumir que se ha obtenido la información más importante sobre los síntomas neuróticos. El enfoque de la entrevista ahora puede cambiar a lo largo del perímetro a la investigación de los rasgos de carácter patológicos (ver Figura I). La investigación de los rasgos patológicos de carácter, fundamental en la evaluación no solo del tipo de carácter de carácter o patología de la personalidad, sino también su severidad (y, por la misma ficha, la presencia o ausencia de la organización de personalidad abordores, con su síntoma de

anclaje clave de difusión de identidad), Es un enfoque crucial de la entrevista estructural. La primera pregunta, una vez que se ha alcanzado este punto de consulta, puede ser formulado de la siguiente manera: "Me lo han contado sobre sus dificultades, y ahora me gustaría escuchar más sobre usted como persona. ¿Podría describirlo, su personalidad, lo que cree que es importante para mí saber para que ¿Puedo obtener un verdadero sentimiento para ti como persona?" Esta pregunta representa un nuevo desafío, un nivel más profundo de investigación que, bajo circunstancias óptimas, puede llevar a un paciente a un estado de ánimo auto-reflexivo. Luego, puede describir los sentimientos sobre sí mismo, las áreas importantes de su vida (estudios o trabajos, familias, vida social, sexo, intereses culturales y políticos, tiempo libre), y en particular, sus relaciones clave con otros significativos. Si el paciente puede presentar espontáneamente dicha información sobre sí mismo, por lo que proporciona una indicación de las buenas pruebas de realidad. Los pacientes psicóticos con capacidad para mantener una cierta apariencia de una relación apropiada con la realidad pueden haber llegado a este punto en el inter-

34 Consideraciones de diagnóstico Ver sin mostrar importantes perturbaciones. Sin embargo, para que respondan a una pregunta tan abierta, sin embargo, es virtualmente imposible, ya que esto requiere la capacidad de mantener la empatía con los aspectos ordinarios de la realidad social (como el interés del entrevistador en la personalidad del paciente). La capacidad de un paciente para explorar su personalidad en profundidad ahora puede indicar que probablemente ha mantenido las pruebas de realidad. Por lo tanto, el intercambiador puede desechar la enfermedad psicótica (además de los síndromes cerebrales agudos y orgánicos desechados previamente) del espectro de posibilidades de diagnóstico. A veces, un paciente tiene una gran dificultad para hablar de sí mismo de manera tan no estructurada debido a los factores culturales y de la personalidad. Luego, el entrevistador le puede sugerir que el paciente describe sus relaciones con las personas que son más importantes para él y cuentan sobre su vida, estudios o trabajo, familia, vida sexual, relaciones sociales, cómo pasa su tiempo libre. Los pacientes con patología severa de caracteres, especialmente aquellos con rasgos graves represivos o paranoicos, pueden resultar difícil proporcionar incluso esta información más concreta, circunscrita. El incumplimiento de esta pregunta más directa sería una primera indicación de la patología grave del carácter. El entrevistador investigará entonces la difusión de identidad (para el diagnóstico diferencial de la organización de la personalidad límite) e incluso reevaluará las pruebas de realidad. El procedimiento en este caso sería para que el diagnóstico señale al paciente que parece tener dificultades para hablar de sí mismo como persona. El entrevistador puede entonces preguntar hasta qué punto el paciente cree que esta dificultad se debe a las circunstancias de la propia reserva, las aprensiones sobre ser entrevistadas en general, o temores específicos sobre el entrevistador o la situación de diagnóstico (por lo tanto, sondeo posible. Características paranoicas), o si la dificultad refleja un problema general

que el paciente tiene para aclarar a sí mismo quién es él o cuáles son sus relaciones con el mundo circundante y otros (qué sondas para posibles características esquizoides). Como respuesta a este sondeo, los pacientes con organización de personalidad limítrofe pueden presentar operaciones defensivas primitivas, como la identificación proyectiva, la división, la disección primitiva de aspectos contradictorios de la experiencia, denegación, la grandilidad, la fragmentación de los efectos, Omnipotencia, o devaluación. La entrevista se ha centrado ahora en un segmento específico de la perimetración de los síntomas de anclaje, a saber, que se extiende de rasgos de carácter patológico a través de la difusión de identidad a las pruebas de realidad. Describí en el Capítulo I cómo reconocer clínicamente el mantenimiento de las pruebas de realidad. Si el afecto, el comportamiento o el contenido del paciente en las etapas tempranas de la entrevista es claramente inapropiado, lo que indica la posibilidad de una enfermedad orgánica o psicótica importante, la existencia de halluinceros o delirios puede explorarse más directamente. (Este aspecto de la entrevista se discute más completamente a continuación). Si, sin embargo, no hay evidencia bruta

La entrevista estructural 35 de la psicosis se ha obtenido en la entrevista y la información del paciente ha dado que el entrevistador no se ha dado a la razón para pensar que ha tenido alucinaciones o delirios en el pasado o, si los ha tenido, que todavía están con él, el entrevistador ahora puede enfocarse bruscamente en Lo que parece más inapropiado, extraño o extraño en el afecto del paciente, el contenido del pensamiento o el comportamiento. Como se mencionó anteriormente, alentando al paciente a hablar de sí mismo de manera libremente, particularmente los pacientes con organización de personalidad limítrofe o síndromes psicóticos que se han convertido hasta ahora sin ser detectados, pueden activar las operaciones defensivas primitivas y las características interpersonales de estas defensas que se manifiestan en el paciente inmediato / Interacción del entrevistador. El diagnóstico puede al principio experimentar esta distorsión como un sentido de estrés o tensión; Su sentido interno de libertad en interactuar con el paciente disminuye. Eventualmente, puede encontrar que se ha activado y superpuesto a una relación específica, regresiva de un objeto regresivo, orientado a la entrevista correspondiente. Si, en este punto, el entrevistador, centrado en el afecto del paciente, el contenido del pensamiento y el comportamiento, comparte con el paciente lo que le parece más inusual en cualquiera de estos aspectos y le pregunta al paciente si puede explicar el sentido del entrevistador de que la presentación del paciente tiene un extraño o desconcertante. Aspecto, la respuesta del paciente puede arrojar luz sobre sus pruebas de realidad. Las pruebas de realidad se reflejan en la capacidad del paciente para empatizar la percepción del entrevistador de estas características de la interacción y, de manera más sutil, en su capacidad para empatizar con la percepción del entrevistador del paciente en un sentido más amplio. Por ejemplo, el entrevistador puede decir: "Como le pedí que me dijeras más sobre ti mismo, primero parecía desconcertado y luego comenzó a hablar sobre la forma en que tu esposo te

trata. Un poco más tarde, cuando te pregunté si tuviste algún problema al relacionarte con su esposo en tales circunstancias y por qué estabas mencionando esto Ejemplo particular, respondió contándome sobre otros aspectos de la habilidad de su marido. Es como si, cuando te pedí que hablaras de ti mismo, parecías estar obligado a hablar sobre cómo eres tratado con tu esposo. Encuentro este desconcertante. ¿Puedes ver que tengo dificultades? ¿Con tu atencion?" El paciente puede entender lo que rompe al entrevistador y explicar, por ejemplo, que ella se siente tan abrumada por su esposo que es como si no tuviera derecho a examinar cómo se siente sobre ella (así, lo que indica las pruebas de la realidad en esta situación). O puede decir, en un tono temeroso y sospechoso, que ella está tratando de señalar que su esposo la está tratando mal y pregunte si el entrevistador está insinuando que estas dificultades son todo su culpa (por lo que aumentan las dudas sobre sus pruebas de realidad, además de señalar Tendencias paranoicas). Si este último sea el caso, el entrevistador ahora puede preguntar al paciente por qué le pregunte si podría estar haciendo cualquier contribución a la dificultad.

36 Consideraciones de diagnóstico Las fulturas con su esposo sugirieron la insinuación de que las dificultades eran de su culpa. Por lo tanto, sigue la técnica de llevar a cabo ciclos de aclaración, confrontación e interpretación en torno a un área de discusión en la interacción que puede proporcionar más información sobre la personalidad del paciente, al mismo tiempo aclarando la capacidad del paciente para probar la realidad. Es importante primero aclarar si el paciente tiene una estructura psicótica, es decir, ausencia de pruebas de realidad (que, por definición, indicaría que el paciente no es un paciente limítrofe), antes de indecorar la difusión de identidad. La sensación de identidad del paciente, diferencia de la patología del carácter del límite (caracterizado por la difusión de identidad) de la patología del carácter de la línea de la línea de la línea (donde la integración de identidad está intacta). Si, en el curso de la exploración de las características de la personalidad del paciente o los rasgos de carácter patológicos, la cuestión de la pérdida de las pruebas de la realidad nunca surge (o se responde rápidamente satisfactoriamente en el sentido de que se mantiene la realización de la realidad), la entrevista luego ingresa a la fase media, en la que la evaluación de la difusión de identidad (y, por lo tanto, el diagnóstico diferencial de la organización de la personalidad límite) se convierte en el principal objetivo. Pero si, al evaluar la personalidad del paciente, emerge claramente que se pierde las pruebas de realidad, la entrevista se centra entonces en la naturaleza de la psicosis del paciente. Ahora, debería quedar claro que, aunque la entrevista comienza de manera estándar en todos los casos, la naturaleza de las preguntas, la interacción y toda la calidad de la entrevista variará considerablemente de acuerdo con la naturaleza de la psicopatología del paciente. En entrevistado estructural, este es un efecto deseable, una consecuencia de la conexión sistemática del entrevistador de la información del paciente con la naturaleza de la interacción paciente / diagnosticaria. La fase media de la organización

neurótica de la personalidad neurótica de entrevistas, los pacientes con neurosis sintomáticos y pafestología de caracteres de noborderina son aquellos que pueden responder en la fase inicial de la entrevista estructural con un resumen pertinente de lo que los trajo al tratamiento, cuáles son sus principales dificultades, lo que esperan de Tratamiento, y dónde están en este punto. Estos también son pacientes que no dan evidencia de comportamiento extraño, extraño o absurdo, afecta o pensamientos. Su capacidad para probar la realidad permite al entrevistador descartar la posibilidad de la enfermedad psicótica, y presentan un sensualismo obviamente normal, la memoria normal y al menos la inteligencia normal, así que sorprenando un síndrome de cerebro orgánico. Estos pacientes son capaces, cuando los in-

La entrevista estructural 37 Terviewer solicita más información, para ampliar sus síntomas o dificultades de presentación de manera significativa. Claramente, entienden no solo el contenido manifiesto de las preguntas del entrevistador, sino las sustas implicaciones de estas preguntas. Tal entrevista puede parecerse a un observador externo notablemente similar a una entrevista psiquiátrica tradicional o estándar. Ahora, el área principal de enfoque del intercambiador a lo largo del perímetro del círculo de los síntomas de anclaje es el área de rasgos de carácter patológico. Las preguntas ahora deben centrarse en las dificultades del paciente en las relaciones interpersonales, al ajustar al medio ambiente, así como sobre sus necesidades psicológicas percibidas internamente. Sea cualquiera de las señales que se proporcionó el paciente antes sobre las dificultades en cualquiera de estas áreas, ahora debería explorarse, y esta exploración debe seguirse con una pregunta más general, como: "Ahora me gustaría aprender más sobre usted como persona, la forma en que se percibe, la forma en que cree que otras personas lo perciben, lo que sea Piensas que podría ayudarme a formar una imagen de usted en profundidad dentro de este tiempo limitado". Esta pregunta sondas para obtener más información sobre los problemas caracterológicos y conduce a un diagnóstico más específico con respecto al tipo predominante de rasgos de carácter patológico, la constelación patológica dominante. Al mismo tiempo, la pregunta también hace posible una evaluación de la difusión de identidad. Si el paciente ahora transmite la información que el entrevistador no puede armar en su mente, en particular los datos contradictorios que no se ajustan a la imagen interna del paciente que el entrevistador está construyendo, se determina un sondeo tacto de tales contradicciones posibles o aparentes. El objetivo del entrevistador es evaluar la medida en que estén presentes las autoridades contrajecidas (una indicación de la difusión de identidad) o la medida en que el paciente presenta una concepción sólida y bien integrada de sí mismo. Con bastante

frecuencia hay áreas periféricas de auto experiencia que son contradictorias a un área central y bien integrada de la autoevaluación subjetiva, las áreas periféricas que el paciente mismo experimenta como ego-alienígena o ego-distónico, que no se ajusta a su Imagen integrada de sí mismo. Estas áreas aisladas pueden ser una fuente importante de conflictos intrapsíquicos o dificultades interpersonales, pero no deben equipararse con la difusión de identidad. En otras palabras, no esperamos la armonía total en pacientes neuróticos, pero debe haber una integración subjeciente central del auto concepto sobre la base de la cual el entrevistador puede construir una imagen mental del paciente. La siguiente pregunta trata de otros significativos en la vida del paciente. Una vez que el entrevistador ha respondido tentativamente en su propia mente, la pregunta con respecto a la integración del auto concepto, puede explorar la integración del paciente de los conceptos de otros significativos. Pacientes con organización de personalidad limítrofe y la sincronización correspondiente.

38 Consideraciones de diagnóstico Drome de difusión de identidad típicamente presentan una incapacidad para integrar las representaciones de otros significativos en profundidad. Estos pacientes tienen más problemas para presentar una imagen dotada de la vida de las personas que son importantes para ellos que las personas que solo saben de manera casual. Una pregunta principal aquí podría ser: "Me gustaría pedirle que me digas algo sobre las personas que ahora son más importantes en tu vida. ¿Podría decirme algo sobre ellos para que, dado nuestro tiempo limitado aquí, podría formar una clara impresión de ellos?" Ahora, el alcance de la integración de las representaciones de objetos frente a la falta de integración puede ser explorada y, en este contexto, el grado de patología de la vida interpersonal del paciente. Tanto la integración de la identidad como la difusión (una criterio estructural transversal) y la naturaleza de las relaciones con objetos del paciente (un criterio longitudinal, histórico-estructural) pueden aclararse en el proceso. Nuevamente, cada vez que surjan contradicciones internas en la narrativa del paciente, el entrevistador puede aclarar estos primero, luego confrontar tácticamente al paciente con estas contradicciones aparentes o potenciales y evaluar la capacidad del paciente para reflexionar sobre las observaciones del entrevistador. El In-Terviewer puede estudiar así la capacidad de la introspección del paciente.
Finalmente, si surgen problemas conflictivos obvios en la exploración de tales áreas contradictorias, dentro del concepto de autocompletar o el concepto de otras posibles, la aclaración y la confrontación pueden ser seguidas por una interpretación tentativa, en el presente, y ahora solo, de potencialmente dinámico o Implicaciones conflictivas de estos temas. Si bien esta parte de la entrevista con un paciente neurótico típico está procediendo, el entrevistador debe centrarse en los efectos que la exploración está teniendo en la interacción real entre él y el paciente. La exploración de áreas de confusión, contradicciones internas y los conflictos potenciales pueden aumentar la

ansiedad del paciente, así como la movilización de sus operaciones defensivas predominantes. Característicamente, en el paciente neurótico, estas defensas serán bastante discretas, de modo que, en la práctica, es de diez muy difíciles de diagnosticar la existencia de represión, desplazamiento, racionalización o intelectualización en la evaluación de la época del paciente. Teracción con el entrevistador. Solo las formaciones de reacción y los rasgos de carácter inhibitorios que asumen las funciones defensivas inmediatamente y los rasgos de carácter patio-lógica en general (que, por supuesto, siempre asumen funciones defensivas), se pueden detectar temprano en la interacción con pacientes neuróticos. Las defensas de alto nivel pueden inferirse indirectamente del contenido de lo que se está discutiendo, pero rara vez se muestran directamente en las primeras entrevistas. Como se señaló, con la organización de la personalidad límite, la exploración de la difusión de identidad (a lo largo de las líneas de disociación del auto concepto y de los conceptos de otros significativos), generalmente activa las operaciones defensivas primitivas que surgen en la interacción con el diagnóstico en lugar de simplemente en el contenido de Comunicaciones verbales. La

La entrevista estructural 39 más La interacción inmediata entre el paciente y el diagnóstico se produce, se transforma, alterados o distorsionados por dichos procesos defensivos, más probabilidades son las opetas de defensa primitivas tailandesas. Por lo tanto, se confirma un criterio estructural significativo para el diagnóstico de la organización de la personalidad de la línea fronteriza. En el caso de los pacientes que no muestran indicios de difusión de identidad o operaciones defensivas primitivas, las áreas dominantes de conflicto, inhibiciones emocionales o desarrollo sintomático pueden explorarse hasta el punto en que se alcanza los límites de la conciencia consciente o preconsciente del paciente, en otras palabras., A los límites de sus barreras represivas. En estos casos, el diagnóstico puede formular hídricos dinámicos con respecto a los conflictos intrapsíquicos inconscientes. A menudo, aquellos se fortalecen por la continuidad natural entre las ex perdencias actuales del paciente y su recuerdo de experiencias pasadas, pero tales hipótesis dinámicas deben seguir siendo altamente especulativas. El paciente más saludable, más fácil será para el diagnóstico en las entrevistas tempranas para la hipótesis de las conexiones entre el pasado consciente y el presente, pero, paradójicamente, cuanto más difícil sea para que el paciente se vincule presente y pasado porque estos enlaces son reprimidos. Con la organización de la personalidad neurótica, la inspección cuidadosa de los síntomas de presentación, la personalidad general y los aspectos interaccionales en la entrevista que enriquecen o complementan otra información, prácticamente coincide con una historia sistemática. En estos casos, la información recopilada por entrevistas estructurales suele ser mucho más completa, más rica y más inmediatamente relevante para las consideraciones de tratamiento que el enfoque estándar. La información relevante sobre el pasado del paciente se deduce naturalmente de la investigación de su personalidad actual. En todos los casos con estructura de personalidad neurótica, después de completar la

información con respecto a la enfermedad actual, es útil obtener un breve sudor del pasado. En el contexto de dicha recopilación de datos, a menudo es posible vincular los hallazgos con respecto a la personalidad del paciente tentativamente con la información con respecto a su pasado, un vínculo previsto para no probar higes dinámicos, sino a probar los límites del entendimiento espontáneo y la integración de la integración de los pacientes del paciente. Su pasado y presente. Organización de la personalidad límite. Ya he enfatizado la medida en que los pacientes con organización de personalidad límite generalmente contaminan la información sobre el pasado con las dificultades actuales de la personalidad. Dicha contaminación es aún más extrema en el caso de una enfermedad psicótica funcional. Una exploración cuidadosa de la vida actual del paciente del límite, con especial énfasis en el síndrome de la difusión de identidad, y, en este contexto, la naturaleza de sus relaciones de objeto, generalmente demuestra una rica fuente de datos para aclarar la

40 Consideraciones de diagnóstico Tipo y severidad de su personaje Patología. Esta información debe complementarse con una investigación exhaustiva de los síntomas neu-roticos actualmente manifiestos. En estos casos, es preferible explorar el pasado solo en general y no intentar aclarar, confrontar o interpretar la caracterización del paciente de sus experiencias pasadas; Más bien, la información sobre el pasado debe estar registrada como se presenta. Los pacientes con organización de personalidad limítrofes generalmente presentan difusión de identidad, pero las personalidades narcisistas presentan una complicación importante a este respecto. La personalidad narcisista generalmente tiene un concepto de autocompleto integrado, pero el concepto es patológico y grandioso. Sin embargo, la personalidad narcisista presenta claramente la falta de integración del concepto de otros significativos, facilitando así el diagnóstico de difusión de identidad y un predominio de las operaciones defensivas primitivas, particularmente la omnipotencia y la devaluación. Las características estructurales de la personalidad narcisista tienden a emerger más lentamente en entrevistas estructurales que las de la patología fronteriza no narcisista. Por lo general, está en la fase media de la entrevista, con un paciente que presenta claramente las buenas pruebas de realidad y no hay evidencia inicial de la falta de integración del auto concepto, que surge gradualmente una extraña superficialidad o indisponibilidad de las descripciones en profundidad de otros distintos., Junto con una expresión sutil pero generalizada de autoadegranización y, a menudo, una attitud desencadente sutil o sutil o no sutil hacia el entrevistador. A veces, en las personalidades narcisistas de mejor funcionamiento, el diagnóstico surge primero en las descripciones de estas pacientes de sus relaciones con otros en lugar de en las interacciones con el crimensionador propio. En contraste, en la patología fronteriza no narcisista, la información inicial con respecto a los motivos de los pacientes para la consulta y las expectativas del tratamiento puede

generar inmediatamente un revoltijo aparentemente inconsciente y caótico de la información sobre ellos mismos, sus expectativas poco realistas de tratamiento, y extrañas o ideas, comportamiento o afectación inapropiados en relación con el diagnóstico, que requieren evaluación de sus pruebas de realidad. Por ejemplo, un paciente puede comenzar a llorar al presentar sus razones de consulta, y cuando el diagnóstico explora con ella lo que la hace llorar (en particular la posibilidad de una depresión aguda o grave), la respuesta inmediata puede ser que ella llora porque ella sabe que nadie le prestará atención a lo que Ella dice, y todos, y, por lo tanto, también este psiquiatra, estará de acuerdo con su madre, con quien tiene conflictos severos. En contraste, el llanto como manifestación de la labilidad emocional en una estructura de personalidad esencialmente neurótica (por ejemplo, en una personalidad histérica) puede desaparecer fácilmente bajo la exención. El paciente reconocerá su rápido cambio de estados de ánimo y la naturaleza inapropiada de ese afecto, y mantendrá una empatía espontánea e inmediata con la realidad de la presente interacción social.

La entrevista estructural 41 Siempre que la interacción emocional inmediata de la sesión se intensifique profundamente en la fase temprana de entrevistas estructurales (por la expresión de comportamiento, afecto o pensamientos que afectan fuertemente esa interacción), se indica una exploración, después de completar la exención. De las respuestas del paciente a la investigación inicial, de estos maniquíes en el aquí y ahora. Se debe tomar una decisión delicada ahora: cuando la gravedad de las perturbaciones interpersonales del paciente en la interacción impidimenta aumenta la cuestión de la mente del entrevistador de si se está manteniendo las pruebas de realidad, se garantiza una exploración inmediata de estos trastornos. En estas circunstancias, la aclaración y la confrontación en el presente, y ahora de estos imprevistas interactivos pueden aclarar la existencia de las pruebas de realidad y asegurar al intercambiador de que no está en presencia de una estructura psicótica. Luego, puede regresar a la exploración de la patología del personaje del paciente en términos de otros aspectos de la vida del paciente y al mismo tiempo se centran en las operaciones defensivas primitivas manifestadas en la entrevista. Pero donde las pruebas de realidad no están en cuestión, puede haber una aventura en la siguiente investigación con un segundo conjunto de preguntas que investigan la vida y las relaciones actuales del paciente con otros. El propósito aquí es buscar la confirmación de las indicaciones de la difusión de identidad en la información del paciente sobre él y su vida social. Solo más tarde, el entrevistador regresará a las manifestaciones de las operaciones productivas primitivas y las relaciones de objetos patológicos en el aquí, y- ahora. Aquí la pregunta clave es: "Lo que me has dicho sobre tu vida me hace pensar en algo que he observado aquí, en esta hora, y me recuerdo de estas dificultades que mencionaste. Podría ser que (tal y ese comportamiento aquí) es un reflejo, en tu relación conmigo, de lo que has dicho. ¿Te las preocupa con otras personas? Para ponerlo de manera un tanto diferente, desde el

. . . .

punto de vista de la estrategia de explorar varios síntomas de anclaje, si un paciente con indicaciones obvias de la patología de caracteres revela tales perturbaciones en el efecto, el contenido del pensamiento o el comportamiento de que su realización de pruebas se cuestiona, una exploración de estos problemas lleva Precedencia sobre la exploración adicional de sus rasgos de carácter patológico fuera de la situación de diagnóstico actual. Sin embargo, si, sin embargo, se asegura las pruebas de realidad, es una ventaja en la obtención de más información sobre los rasgos de carácter patológicos y al reunir más pruebas sobre las dificultades en la vida del paciente fuera de esta situación de concreto. El objetivo es recopilar información sobre la difusión de identidad y las operaciones de defensa primitivas en un área relativamente "neutral" primero, y solo entonces para vincular esta información con la exención de las implicaciones emocionales de estos festivos de maniad de características en la hora. El tema de la difusión de identidad puede generalmente se puede aclarar completamente, y, en cierta medida, las operaciones defensivas primitivas también diagnostican. A veces, sin embargo, en pacientes cuyas pruebas de la realidad al principio parecen apuntar

42 Consideraciones de diagnóstico Se proponan, otras pruebas se acumula gradualmente con respecto a su falta de tacto, inadecuada inadecuada, inmadurez general y arbitrariedad del juicio, y similares, que pueden requerir una segunda exploración de pruebas de realización. El entrevistador debe evaluar la medida en que estos pacientes puedan mantener la empatía con los criterios sociales de la realidad al aumentar las cuestiones con respecto a sus descripciones de las relaciones con otras personas y explorar la naturaleza socialmente inapropiada de algunos de los comportamientos que pueden describir en una cuestión de -Facción de manera. En el paciente típico de la frontera, los síntomas neuróticos tienden a fusionarse con dificultades difusas, generalizadas y caóticas, lo que refleja un mal funcionamiento de personalidad grave. Cuando hay falta de integración de identidad, a menudo es difícil o imposible obtener una visión integral de la vida del paciente. De la misma manera, las historias pasadas de tales pacientes generalmente no son confiables, altamente distorsionadas a la luz de la psicopatología actual. En otras palabras, el rango de la patología del personaje, menos confiable, y menos inmediatamente relevante, es la historia pasada. Aquí, por lo tanto, en contraste con los pacientes con estructura de personalidad neurótica, es difícil o imposible vincular los conflictos de corriente predominantes con un material psicodinámicamente significativo pasados, y el intento de hacerlo es, por lo tanto, es un procedimiento altamente cuestionable. Sin embargo, paradójicamente, los conflictos intrapsíquicos mutuamente desactivados pueden hacer su aparición con bastante rapidez en el contenido manifiesto de las comunicaciones del paciente límite. Por lo tanto, los conflictos clave pueden estar disponibles más directamente en las entrevistas iniciales con los pacientes con límites que con los pacientes neuróticos, mientras que los enlaces dinámicos a su pasado permanecen ocultas. De la misma manera, la investigación de la personalidad actual de los pacientes

con la organización de la personalidad neurótica, naturalmente, conduce a la información sobre su pasado. En contraste, la información inicial sobre el pasado obtenida de pacientes con organización de personalidad límite a menudo no es más que una expansión retrospectiva de los conflictos actuales con otros significativos. En pacientes con organización de personalidad limítrofe, particularmente aquellas con estructura de personalidad narcisista (ya sea que su funcionamiento manifiesto sea o no ", es extremadamente importante evaluar el comportamiento antisocial. Las características antisociales, junto con la calidad de las relaciones de objetos, son variables pronósticos cruciales para la psicoterapia intensiva con las personalidades límite y siempre deben ser investigadas antes de que se realice el tratamiento. Especialmente en pacientes con personalidad narcisista, es útil explorar con tacto si el paciente ha tenido dificultades con la ley y en qué medida los comportamientos antisociales como el robo, el levantamiento de talleres, la mentira crónica y el comportamiento cruel intensamente son significativos. Tecedientes. En la práctica, esta investigación debe integrarse con la información relevante que presenta el paciente en otras áreas. Cuando se hacen tales preguntas directa y naturalmente en el contexto de la información relacionada del paciente, las respuestas a menudo son sorprendentemente directas y abiertas.

La entrevista estructural 43 (naturalmente, el paciente que admite libremente la mentira o "narradora" solo está dando una advertencia de que pronto se sienta tentado a hacer lo mismo con el terapeuta). Organización psicótica de la personalidad La presencia o ausencia de difusión de identidad diferencia a la limitación de Patología de personajes de noborderina en entrevistas estructurales. La presencia o ausencia de pruebas de realidad diferencia a la organización de personalización de la PERSONALIZADA fronteriza de las estructuras psicóticas. Aquí me refiero a los pacientes con enfermedad psicótica "funcional" en contraste con los desarrollos psicóticos secundarios a un síndrome cerebral orgánico agudo o crónico. Este grupo incluye todo el espectro de enfermedades esquizofrénicas, trastornos afectivos importantes y psicosis paranoicos que no encajan en los otros dos síndromes psicóticos principales. Todos estos pacientes presentan la pérdida de las pruebas de realidad. En un caso típico de una enfermedad psicótica, la respuesta del paciente a la investigación inicial ya puede indicar la ausencia de pruebas de realidad y, más allá de eso, una incapacidad para responder de manera inteligible a las preguntas del entrevistador de que todo el espectro de enfermedad psicótica funcional, aguda y el síndrome de cerebro orgánico, tiene que ser evaluado. En el caso extremo de un paciente que no responde a la investigación inicial, el entrevistador debe intentar explorar primero con él si ha escuchado la pregunta y la ha entendido. Si el paciente ha podido entrar en la habitación y, obviamente, es consciente y alerta al entorno inmediato, es probable que dicho mutismo total indique una enfermedad psicótica funcional en lugar de un síndrome de cerebro orgánico. Nevado, es útil para el entrevistador proceder a lo largo de todo el penetrador del ciclo de los síntomas de anclaje. Explore el sensorium, luego la memoria e inteligencia, antes de reciclar para enfocarse aún más en las pruebas de realización y los principales síntomas psicóticos en el comportamiento, afectan, el contenido y la

organización del pensamiento y las alucinaciones. El enfoque en el sensorio puede llevarse a cabo primero, probando la atención del paciente: "Le hice algunas preguntas, y no se ha replantado; ¿Fuiste lo que pudiste escuchar y entender lo que le pregunté?" Si el paciente sigue siendo insensible, es útil averiguar si puede indicar que él oye, entiende, y está de acuerdo o está en desacuerdo con varias preguntas formuladas por la cabeza con la cabeza o por cualquier otra señal. Desean las circunstancias extremas, es importante aclarar si se entiende y está tratando de comunicarse, aunque puede que no pueda hablar. La falta de respuesta a este comportamiento de sondeo generalmente indica el negacionalismo como parte de un síndrome catatónico o una enfermedad esquizofrénica en el retardo psicomotor general o grave en grados extremos de enfermedades depresivas.

44 Consideraciones de diagnóstico Ness. A veces, en el paciente totalmente insontable, las pruebas directas de las características catatónicas, en particular el negativismo, pueden provocar el comportamiento directamente opuesto a las instrucciones proporcionadas, Flexibilitas Cerea y / o postura o comportamiento estereotipado que apunta a la enfermedad esquizofrénica. En otros casos, solo una exploración completa de la historia de la presente enfermedad, obtenida de otras fuentes, proporcionará información más definida. Los pacientes orgánicos cuyo grado de conciencia es suficiente para estar alerta a su entorno, generalmente pueden responder a preguntas simples que completarían la exploración del sensorio, como la orientación, la conciencia, la comprensión y el juicio del paciente de la situación inmediata. (Debido a que estas áreas están bien cubiertas de guías al examen de estado mental estándar, no les estoy ilustrando con preguntas más concretas). Si, en el curso de la investigación inicial, resulta que el sensorium del paciente es claro, se puede explorar si la falta de respuesta o la La respuesta confusa al conjunto inicial de preguntas se debió a la pérdida de la memoria o la falta de inteligencia, es decir, una incapacidad para comprender claramente lo que se solicitó o conservar las preguntas lo suficiente con la previsión de una respuesta. Nuevamente, sin entrar en un análisis detallado de la pérdida de funciones cognitivas que caracterizarían un símbolo cerebral orgánico, quiero enfatizar el punto general de que, cuando un paciente demuestra la incapacidad grave para responder al conjunto inicial de preguntas, los síntomas de análisis que reflejan Las anomalías en el sensorio, la memoria y la inteligencia deben explorarse antes de regresar al examen de los principales síntomas de anclaje de la psicosis funcional. Si es evidente que el paciente muestra una perturbación severa en el comportamiento verbal o no verbal, pero no hay alteración del sensorio, la memoria o la información, entonces el entrevistador debe regresar al conjunto inicial de preguntas sobre lo que trae al paciente

al tratamiento, la naturaleza de sus dificultades, Lo que él espera del tratamiento, y dónde está ahora. Si la respuesta a este segundo ciclo de investigación sigue siendo inapropiada, confundida o confusa, o acompañada por el efecto o el comportamiento que parece inapropiado, el entrevistador ahora debería centrarse en tal contenido de pensamiento patológico, afectar y comportarse, compartir tactantemente sus observaciones con el paciente, y Explore en detalle la medida en que el paciente pueda empatizar con la experiencia del diagnóstico de las respuestas del paciente como extraño o desconcertante. Si está claro que se ha perdido las pruebas de realidad con respecto a cualquier aspecto del comportamiento, el pensamiento o el efecto del paciente durante la entrevista, se debe considerar la diagnóstico de una psicosis funcional, y el diagnóstico puede luego cambiar a un enfoque diferente a las manifestaciones perturbadas del paciente por Intentando explorar con él significados posibles de estas manifestaciones en términos de la experiencia subjetiva actual del paciente. En otras palabras, una vez que la pérdida de las pruebas de la realidad ha sido

La entrevista estructural 45 se confirma, existe una ventaja en abandonar temporalmente un enfoque de confronte y en la búsqueda de la experiencia interna del paciente correspondiente a sus manifestaciones de comportamiento. La exploración adicional de las experiencias subjetivas del paciente puede llevar a una comprensión de las conexiones entre su efecto, el pensamiento y el comportamiento y abra el camino a un diagnóstico diferente. Es el paciente que sufre de una enfermedad esquizofrénica (con desorganización de estos vínculos) o una enfermedad afectiva (en la que una organización interna vincula un efecto, comportamiento y pensamiento inapropiado para que se mantenga un grado de armonía interna entre estas funciones psíquicas. Organización patológica de ellos)? La evaluación de las experiencias alucinantes puede ahora enriquecer el diagnóstico de la pérdida de las pruebas de realidad formuladas anteriormente sobre la base de los procesos interacionales. La confirmación de las alucinaciones indica, por definición, pérdida de pruebas de realidad. De manera similar, el diagnóstico de delirios también confirma la pérdida de las pruebas de la realidad y generalmente proporciona más pistas sobre la naturaleza de la enfermedad psicótica. Un principio general de entrevistas estructurales con los pacientes psicóticos es que, una vez que aclara y la confrontación táctil confirman la pérdida de las pruebas de realidad, los procesos de pensamiento del paciente, la distorsión de la realidad y la experiencia interna ya no están desafiados. Por el contrario, ahora se debe hacer un esfuerzo para empatizar al máximo con la realidad interna del paciente para profundizar la comprensión del proceso psicótico. De la misma manera, en las fases del medio y terminación de la entrevista estructural de los pacientes psicóticos, el diagnóstico puede ajustar implícitamente sus intervenciones a las distorsiones graves en la interacción con el paciente, lo que ayuda al paciente a lograr un no amenazante o Ansiedad-Reducción de la fase de terminación de la entrevista. En el caso de algunos pacientes

psicóticos, con quienes la comunicación inicial es mucho más apropiada y más libre, donde solo la exploración de lo que inicialmente apareció como una patología grave de caracteres lidera al entrevistador para evaluar las pruebas de la realidad y, finalmente, a la decisión de que se pierde las pruebas de la realidad, el La entrevista puede parecer mucho más similar a la del paciente típico del límite. De hecho, los pacientes con verdaderas hallas y delirios a veces presentan inicialmente sus delirios o alucinaciones como ideas o ilusiones respectivamente, sobrevaloradas (incluso obsesivas) (incluso obsesivas) (o pseudohallucinaciones). En estas condiciones, puede ser útil explorar en qué medida el paciente está tratando de mantener una evaluación "razonable" o "normal" de su pensamiento o percepciones sensoriales porque teme que de lo contrario podría ser considerado "loco". Por ejemplo, una pregunta ilustrativa podría ser: "Me lo has dicho a veces que sientes que eres Jesucristo, pero eso, por supuesto, eres consciente de que realmente no eres Jesucristo. ¿Podría ser eso, en el fondo, estás realmente convencido de que eres Jesucristo pero teme que esta convicción sea interpretada? ¿Como 'loco' por mí o por otros?" En otra

46 Consideraciones de diagnóstico Palabras, cuando los fenómenos delirantes o alucinatorios están potencialmente presentes, las pruebas de realidad deben incluir una confrontación no solo con la realidad externa, sino también con la realidad psicótica, de una manera no amenazadora. Cuando la exploración de comportamiento inapropiado, afectará o el contenido del pensamiento no aclara el tema de las pruebas de realidad y cuando no hay una indicación clara de alucinaciones o delirios, se puede utilizar una técnica de entrevistas más compleja y más compleja, es decir, la interpretación en el presente y- Ahora de las operaciones defensivas primitivas del paciente. Como lo he sugerido (ver CHAP, I), la interpretación de las operaciones defensivas primitivas en el presente y ahora tiende a aumentar las pruebas de realidad en pacientes con la organización de la personalidad límite, pero para disminuirlo en pacientes psicóticos. Por ejemplo, una intervención típica que interpreta una identificación proyectiva podría ser: "Me doy cuenta de que has estado hablando de una manera muy cautelosa y temerosa conmigo, como si tuvieras miedo de algún peligro conectado conmigo. También noté que has estado frunciendo el ceño en algunos de Mis preguntas (por ejemplo, ...). ¿Podría ser que tenga miedo de que pueda pensar mal de usted o atacarlo de alguna manera porque tiene miedo de algunas tendencias similares en usted mismo, como sentirse crítico o enojado hacia mí?" La interpretación de las operaciones defensivas primitivas es difícil. El diagnóstico debe desarrollar una hipótesis sobre la naturaleza de las relaciones de objetos primitivos, fantásticos, disociados activados. También debe desarrollar una hipótesis sobre la función defensiva de esa operación defensiva primitiva. Luego debe compartir su hipótesis con el paciente. A veces puede haber cambios dramáticos hacia la mejora o empeoramiento en la interacción inmediata después de una hipótesis de tales interpretación. En otras ocasiones, la respuesta es incierta. Los pacientes con enfermedades psicóticas parecientes que han conservado la conciencia suficiente sobre

la realización para ocultar sus pensamientos o temores reales pueden simplemente mostrar una mayor evaabilidad después de tales intervenciones de sondeo. Algunos de los desafíos más difíciles de las entrevistas estructurales (así como a todos los aputadores de diagnóstico) son presentados por pacientes paranoicos en los que se desenfoca el diagnóstico diferencial entre la personalidad paranoica y la psicosis paranoica. Se pueden requerir entrevistas de diagnóstico repetidas para llegar a una conclusión más definitiva. En el caso de los pacientes con enfermedad psicótica activa, particularmente la esquizofrenia y la enfermedad maníaca y depresiva, el principal énfasis de la entrevista estructural debe ser de la naturaleza de los síntomas que presentan, con el objetivo de diferenciar las psicosis principales, así como subtipos dentro de ellos. En estos casos y en pacientes con síndrome de cerebro orgánico y pérdida de la realización de la realidad, la investigación sistemática de la historia de la presente enfermedad, así como de la historia pasada, generalmente requiere información de otras fuentes y no forma parte de la propia interferencia estructural.

La entrevista estructural 47 síndromes cerebrales orgánicos agudos y crónicos como se mencionó anteriormente, la incapacidad de un paciente para responder adecuadamente al conjunto inicial de preguntas puede indicar una alteración del sensorio (típico de un síndrome cerebral orgánico agudo) o un grave déficit de memoria y Inteligencia (típica de un síndrome cerebral orgánico crónico). Cuando el paciente aparece, pero no responde a la investigación inicial o, aunque responde, revela una desorganización grave en su respuesta, una reacción mínima o inadecuada, o una actitud general de confusión o perplejidad, ciclismo de los problemas de presentación a la Se indica la evaluación del sensorio, la memoria y la inteligencia. La evaluación del sensorio, incluida la atención espontánea e inducida del paciente, su orientación, el grado de conciencia, su comprensión y juicio, puede aclarar si un estado confusivo existe característico de un síndrome cerebral orgánico agudo o si este estado confusional representa una psicosis funcional aguda, esquizofrenia particularmente aguda (un trastorno esquizofreniforme en DSM-III). La evaluación táctil de la conciencia del paciente de sus dificultades para agarrar las preguntas del entrevistador o la situación total de la entrevista puede producir gradualmente la evidencia de desorientación, disminuir la conciencia y dificultad difusa para comprender los conceptos, todos los cuales son tipificados de un agudo. Síndrome de cerebro orgánico. En contraste, las respuestas altamente idiosincrásicas en las que coexisten la perplejidad y la confusión con las formulaciones extrañas pero organizadas son más características de la esquizofrenia. Una serie de preguntas directas que tienen que ver con aclarar y enfrentar las dificultades Las experiencias de pacientes para comunicar y explorar su disminución a la introspección pueden contribuir al diagnóstico diferencial de los estados confusionales orgánicos y esquizofrénicos. Con pacientes cuya dificultad para agarrar y responder a la investigación inicial parece reflexionar sobre principalmente un déficit en la memoria y la comprensión intelectual,

una ventilación abierta de tales dificultades puede facilitar una evaluación sistemática de las funciones de memoria e inteligencia (en particular la abstracción). Por ejemplo, el entrevistador puede comentar: "Tengo la impresión de su reacción que está luchando con problemas para concentrarse o en la memoria. ¿Puedo hacerle algunas preguntas para aclarar si, de hecho, tiene algunas dificultades con su memoria?" Esta consulta puede iniciar la transición hacia una evaluación sistemática más estándar de la memoria y la inteligencia. Si y cuando se han confirmado los déficits en la memoria y la inteligencia, el entrevistador puede explorar tentativamente con el paciente el efecto al que es consciente o preocupado por sus dificultades para responder o formular su pensamiento claramente, y cuán molesta esto es para él. Si el paciente no puede comprender sus dificultades obvias o las niega con vehemencia, la confrontación táctil puede probar las discrepansiones entre lo que observa el diagnóstico y la reacción del paciente.

48 consideraciones de diagnóstico Si tal confrontación aumenta la negación, se puede asumir la pérdida de la realización de las pruebas de la realidad, que se pueden asumir, y el entrevistador puede, según seguro un diagnóstico tentativo de demencia (es decir, un síndrome cerebral orgánico crónico con Pérdida secundaria de las pruebas de realidad). En un caso menos severo de síndrome cerebral orgánico crónico, el paciente puede presentar cierta conciencia de sus dificultades y reconocerlos. Sin embargo, puede haber una falta de ansiedad o depresión adecuada sobre esta pérdida, que también puede indicar cambios de personalidad y pérdida de las pruebas de realidad acorde con la demencia. En estas condiciones, antes de explorar las discrepancias entre la memoria y los déficits intelectuales del paciente, por un lado, y su estado afecto, por el otro, es útil explorar si ha experimentado dificultades similares en relación con los estudios, el trabajo, otras personas y su vida social en general. Por lo tanto, la investigación de los síntomas del síndrome cerebral orgánico crónico se expande por lo tanto a través de "reciclaje" a través de la evaluación de los síntomas neuróticos y rasgos de carácter patológico en la vida social del paciente. De esta manera, la entrevista estructural puede contribuir al diagnóstico diferente de los estados confusionales (orgánicos versus esquizofrénicos) y a la evaluación de la gravedad del deterioro de la personalidad y la pérdida de la realización de la realización en el síndrome cerebral orgánico crónico, es decir, el evaluación de la demencia. En general, cuando el entrevistador ve que el paciente está teniendo dificultades severas que respondan a la investigación inicial o parece muy ansioso, deprimido o confundido, debe compartir sus impresiones con el paciente. Además, debería preguntar si estas impresiones corresponden a los sentimientos del paciente sobre sí mismo y si parte de su aprensión o temor puede relacionarse con la entrevista en sí. De hecho, este enfoque a la expresión del miedo intenso y la aprensión debe ser impregnada a los pacientes a lo largo de todo el espectro

de la psicopatología. Los casos psicóticos y orgánicos y pacientes con rasgos de personalidad paranoica severa y grados graves de inhibición social (timidez, timidez y similares) pueden parecer intensamente ansiosos en la entrevista, especialmente en la fase temprana. Por otro lado, la investigación inicial, con sus propiedades de estructuración, puede tener un efecto de tranquilización o tranquilización en pacientes no psicosóticos no psicosicos al modificar sus fantasías poco realistas sobre la entrevista en sí. Por lo tanto, la persistencia de la ansiedad intensa después de la investigación inicial generalmente indica una psicopatología severa de algún tipo. La fase de terminación de la entrevista estructural que ha completado la exploración de los síntomas neuróticos y los rasgos de carácter patológica, las operaciones defensivas predominantes y la difusión de identidad, las pruebas de realidad y los principales síntomas de anclaje psicótico u orgánico, el entrevistador ahora debería reconocer a la paciente que

La entrevista estructural 49 ha completado su tarea. Luego, debe invitar al paciente a proporcionarle información sobre temas adicionales que los pacientes contienen importantes o piensan que el entrevistador debe saber. Una pregunta muy útil (sugerida por Robert Michels en una comunicación personal, 1981) es "¿Qué crees que debería haberte pedido y aún no lo hagas?" Esta investigación a veces puede llevar a una nueva información significativa o a reflexiones adicionales sobre las áreas ya exploradas. También proporciona una oportunidad para que el paciente exprese ansiedades activadas durante la entrevista, que ahora se puede explorar más y reducidas al traer consideraciones de la realidad. Es importante dejar suficiente tiempo al final, no solo para el paciente para aumentar las preguntas, sino también para que el entrevistador les responda y para lidiar con la ansiedad inesperada y otras complicaciones. El entrevistador puede decidir que se justifiquen más entrevistas antes de que se pueda llegar a un diagnóstico de definición, o tal vez que ambos participantes necesiten más tiempo para pensar antes de discutir las recomendaciones de tratamiento, o quizás que se pueda completar una disposición de tratamiento ahora. En cualquier caso, el proceso de toma de decisiones debe ser compartido con el paciente. El entrevistador puede decirle al paciente que ha aprendido lo suficiente sobre él para hacer una recomendación o siente que le gustaría continuar el proceso de diagnóstico; En cualquier caso, el entrevistador puede desear obtener información pertinente de otras fuentes. La terminación de la entrevista estructural es una oportunidad crucial para evaluar la motivación del paciente para la continuación del proceso de diagnóstico y / o tratamiento, la gestión de peligros agudos que se les diagnostican y requieren medidas urgentes (por ejemplo, riesgo de suicidio agudo en severamente deprimido Los pacientes), y la medida en que el paciente puede tolerar y responder positivamente a las declaraciones con respecto a sus problemas según lo percibido por el entrevistador.

Cada consulta debe llevar consigo la posibilidad de que el diagnóstico lo extienda con una serie de entrevistas adicionales si es necesario. El supuesto mágico del paciente de que todas las conclusiones de diagnóstico se pueden hacer en una o dos entrevistas deben explorarse de manera realista si es necesario. La mayoría de los pacientes suelen ser apreciativos cuando un psiquiatra reconoce honestamente que, aunque ha aprendido mucho, aún no sabe lo suficiente como para decidir qué, si las necesidades de tratamiento son, si las hay. Algunas consideraciones adicionales en la actitud de la actitud del entrevistador, la entrevista estructural requiere tiempo, incluido el tiempo para experimentar y pensar mientras la entrevista continúa. Por lo tanto, recomiendo que al menos una hora y media se reserven para una entrevista inicial. En nuestro proyecto de investigación de diagnóstico fronterizo (Kernberg et al., 1981), después de mucho experimentamiento, nos establecimos en dos períodos de 45 minutos, separados por un 10-

50 consideraciones de diagnóstico a -5 minutos de intermisión. En mi práctica privada, a menudo reservo las dos últimas horas de tratamiento del día para la entrevista inicial de un nuevo paciente. El diagnóstico debe ser cómodo, relativamente "en su mejor momento" en el sentido de no ser perturbado por consideraciones extrañas, y puede permanecer emocionalmente alerta y receptiva, pero en gran medida en el fondo, mientras que toda su atención se centra en el paciente. A pesar de (o debido a) su actitud discreta, el entrevistador puede aparecer inicialmente como una persona "ideal" al paciente; Puede provocar fuertes tendencias hacia la idealización o la dependencia en pacientes con una capacidad de confianza básica, independientemente de las ansiedades y dificultades que los llevaron al tratamiento. En pacientes con alteraciones severas en sus relaciones de objeto, una incapacidad para la confianza básica, las disposiciones paranoicas o la intensidad de envidia inconscidental, la calma, la receptividad y la "sin problemas" del diagnóstico pueden evocar sospechas, resentimiento, miedo, o derogación. En cualquier caso, se establece rápidamente una doble relación entre el paciente y el entrevistador: una realista, socialmente apropiada de pacientes y terapeutas, y una subyacente, más o menos sutil que refleja las disposiciones de transferencia predominantes del paciente y la posibilidad del diagnóstico correspondiente correspondiente. Disposiciones. El último active conjuntamente una relación de objetos conflictiva, "fantástica" (en el sentido de una fantasía y su naturaleza poco realista). La expresión temprana de las disfunciones afectivas, agresivas y efectativas eróticas, agresivas y / o dependientes, crea que la parte del paciente crea no solo una conciencia cognitiva de ellos en el diagnóstico, sino también las disposiciones afecativas concordantes o complementarias en él. (Ritero, 1968). El diagnóstico se enfrenta a la tarea de simultáneamente (a) explorando la subjetiva, el mundo interior, (b) del paciente, observando el comportamiento e

interacciones del paciente con él, y (c) utilizando sus propias reacciones afectivas al paciente para aclarar la naturaleza del subyacente. Relación de objetos activados. Esta relación de objeto subyacente es el material básico que debe permitir que el entrevistador formule las interpretaciones provisionales en el presente y ahora de las operaciones defensivas del paciente, si tales operaciones se vuelven evidentes, dominantes y requieren exploración. Desde una perspectiva diferente, el diagnóstico también se acumula en su propia mente un modelo de la imagen del paciente de sí mismo, su autoridad. Al mismo tiempo, explora la medida en que las comunicaciones del paciente realmente se prestan para construir un modelo de este tipo. El diagnóstico también intenta construir un modelo en su mente de los otros significativos con los que el paciente está interactuando en su vida y aumenta la misma pregunta: si es posible obtener una representación integrada de ellos. Aquí, por supuesto, el diagnóstico está evaluando la integración de identidad versus la difusión de identidad. Desde una perspectiva aún diferente, el diagnóstico está evaluando

La entrevista estructural 51 lo que parece ser más inapropiado en el afecto del paciente, el contenido del pensamiento o el comportamiento, preparándose para explorar sus percepciones con el paciente de una manera honesta pero táctil, evaluando, en este contexto, la capacidad del paciente para empatizar con el diagnóstico. Experiencia, que reflexionará, en un nivel, la capacidad de la introspección o la percepción del paciente y, a un nivel diferente, la capacidad de las pruebas de realidad del paciente. Para llevar a cabo todas estas tareas es difícil; Requiere el conocimiento y la experiencia con el examen de estado mental estándar, la experiencia psicoterica en el trabajo de manera interpretativa con los desarrollos de transferencia y la experiencia clínica con un amplio espectro de pacientes psiquiátricos. Sin embargo, es una técnica que se puede impartir y adquirir por residentes psiquiátricos de tercer año dotados y se desarrolló en la experiencia y la práctica personales. La entrevista estructural representa lo que podría llamarse una "segunda generación" de la "intercambio dinámica" anterior ", que reflejaba el impacto de un marco psicoanalítico de referencia sobre la entrevista de diagnóstico en la psiquiatría descriptiva.1 i. Para las implicaciones de investigación de entrevistas de diagnóstico, consulte Carr et al. (1979), Bauer et al. (1980), y Kernberg et al. (1981).

CAPÍTULO 3: Diagnóstico diferencial en la adolescencia Las consideraciones de diagnóstico generales en la "literatura más antigua en las perturbaciones de identidad en la adolescencia, las crisis de identidad y la difusión de identidad no se diferenciaron claramente. Por lo tanto, todavía se puede encontrar la pregunta planteada si todos los adolescentes podrían presentar cierto grado de difusión de identidad y, por lo tanto, ser indistinguibles de la organización de personalidad límite posterior. Creo que uno puede diferenciar la patología del carácter fronterizo y de la línea de noborderina, utilizando el enfoque estructural del diagnóstico. Las características descriptivas y psicodinámicas de la patología severa de caracteres y las condiciones de borregal en la adolescencia han sido revisadas por Geleerd (1958), Masterson (1967, 1972), Paz (1976), Michael Stone (1980), y Paulina Kernberg (1982). Al aplicar los criterios estructurales a la evaluación inicial de los pacientes con adolescentes, el médico se enfrenta a varias características de complicación. Primero, la severidad relativa de los efectos desorganizados de los neuros de neuros sintomáticos en la adolescencia, generalmente ansiedad y depresión graves, puede afectar el funcionamiento general del adolescente en el hogar, en la escuela, y con sus compañeros en la medida en que puede parecerse a la desglose social severa. Típico de las condiciones fronterizas. La segunda es la tendencia de los adolescentes hacia las crisis de identidad, se caracteriza por cambiar rápidamente las identificaciones con esto o de que la ideología o el grupo social, de modo que lo que parece un cambio radical en la personalidad puede aparecer en el transcurso de unos pocos meses. Estas alteraciones repentinas en la identificación elevan la cuestión de si el síndrome de la difusión de identidad de gran parte está presente. En tercer lugar, los conflictos con los padres, los hermanos y / o las autoridades escolares pueden ser malinterpretadas. Estos conflictos pueden reflejar las necesidades neuróticas dependientes y rebeldes, o pueden reflejar la patología severa en el área de OBS- 52

Diagnóstico diferencial en la adolescencia 53 relaciones con las ject y una manifestación del síndrome de la difusión de identidad. De hecho, los conflictos neuróticos de noborderina con los padres y las pendientes de la autoridad pueden intensificar y activar el potencial de las operaciones defensivas primitivas en un paciente esencialmente no enlorno, de modo que lo que aparece como control omnipotente, la identificación proyectiva y la devaluación pueden ser Ven a manifiesto en ciertas relaciones de objetos de algunos pacientes con noborderín. Cuarto, el comportamiento antisocial en la adolescencia puede ser una expresión de una adaptación "normal" o neurótica a un subgrupo cultural antisocial (y, por lo tanto, ser relativamente no maliñado), o puede reflejar la patología de caracteres graves y la organización de la personalidad de los personajes se enmascaró como una adaptación Tación a un grupo antisocial. En consecuencia, la etiqueta con frecuencia con uso indebido "Reacción de ajuste en la adolescencia" no es tanto un diagnóstico como una señal de alarma que indica la necesidad de evaluar en profundidad la estructura de la personalidad de un adolescente en conflictos sociales. Quinto, las reacciones narcisistas normales, neuróticas e infantiles, por lo que la frecuencia en la adolescencia puede enmascarar una estructura de personalidad narcisista grave, particularmente cuando no hay características antisociales para alertar inmediatamente al diagnóstico a la evaluación de la narcisista, en Además de la patología an-isocial,. La patología narcisista puede presentar no como conflictos típicos alrededor del control omnipotente, la grandiosidad y la devaluación, sino, más bien como una extraña oscilación entre el excelente funcionamiento escolar y la falla desconcertante en tareas competitivas. Sexto, la aparición normal de múltiples tendencias sexuales perversas en la adolescencia puede imitar la condensación de las características genitales y pregénitas (con el predominio de los conflictos agresivos) que es típico en la organización de personalidad límite. Como ya he dicho, la naturaleza de los

conflictos inconscientes predominantes no es un buen criterio de diagnóstico. Finalmente, las condiciones psicóticas más lentamente desarrolladas, como la enfermedad esquizofrénica crónica, pueden enmascararse como condiciones fronterizas porque la causa de la causa del predominio de la patología severa de las relaciones de objetos, la retirada social y la patología severa de los personajes en general. Además, aunque las alucinaciones se diagnostican en bastante facilidad, la formación insidiosa del engaño puede, al principio, se puede malinterpretar, por ejemplo,, por ejemplo, las tendencias hipocondríacas o la preocupación excesiva con la apariencia física. En lo que sigue, intentaré ilustrar estas dificultades en el diagnóstico diferencial de la patología límite en la adolescencia, así como la aplicación de los criterios de diagnóstico general mencionados. Ilustraciones clínicas Miss A. Un estudiante de estudiante universitario de l8-Año, de edad, se le remitió un diagnóstico preventivo de la organización de personalidad límite y la depresión neurótica grave. La señorita A había estado fallando en su trabajo escolar, aislada.

54 Las consideraciones de diagnóstico se encuentran socialmente, y se habían oscilado entre períodos de depresivo y retiro y otros períodos de contexto de los conteibles con amigos y familiares. Ella había tenido ferias de AF tanto homosexuales como heterosexuales, y el médico remitente la había encontrado al margen y distante. El síntoma predominante fue la severa desglose de la vida social en la escuela y el fracaso en sus estudios a pesar de la alta inteligencia. En la exploración de sus dificultades, resultó que la señorita A siempre había tenido inhibiciones sexuales, manifestada en una culpa severa sobre cualquier actividad sexual y en fantasías de masturbación de ser humillados, golpeados y esclavizados por hombres poderosos y sádicos. Aunque se había enamorado de varios hombres, siempre había sido rebelde por el interfino sexual real con ellos. Temeroso de otras mujeres con las que sintió que no podía competir, intentó establecer relaciones sumisas con mujeres dominantes. Ella había tenido algunas relaciones sexuales con las novias sin experimentar mucho placer sexual. En la escuela secundaria, siempre había sentido que un buen trabajo y estudios difíciles le permitiría encontrar su propia identidad profesional sin tener que involucrarse en relaciones sexuales con hombres o tener que competir con otras mujeres para los hombres. En la universidad, ella sintió que todos los caminos a la intimidad sexual se cerraron a ella, y su desesperación cada vez mayor sobre su incapacidad para superar estas dificultades, combinadas con el aumento de los sentimientos de culpa en las actividades sexuales "prohibidas", finalmente provocó la depresión de que Se intensificó hasta el punto de enterrar en serio con sus estudios. La señorita A pudo transmitir descripciones diferenciadas y vívidas de las personas más importantes con las que estaba involucrada y de sus recuerdos con ellos. Tenía un concepto integrado de sí misma a pesar de las características represivas severas, y presentó rasgos bastante típicos de una estructura de personalidad predominantemente histérica / masoquista.

. . . .

Mostró un claro compromiso con los valores y los ideales, un interés definitivo y autónico en ciertas áreas culturales y políticas, y sorprendentemente buen funcionamiento en situaciones interpersonales donde las importantes diferencias de edad hicieron que las relaciones potencialmente sexualizadas sean menos. Habiendo trabajado como voluntario en una organización social donde fue, con mucho, el participante más joven, pudo funcionar de manera excelente durante varios meses mientras vivía "como una monja". En este caso, un concepto integrado del yo y de otros indicaron que no había difusión de identidad; La vida sexual aparentemente caótica correspondió a una inquisición sexual subyacente con respecto a los hombres y la sumisión determinada por la culpa a las mujeres poderosas. La señorita A pudo establecer relaciones de objetos en profundidad en áreas no "contaminadas" por los conflictos sexuales, y ella dio evidencia de un superyó un superyo demasiado sádico y estricto, pero definitivamente integrado. La di-agnosis final era una personalidad histérica con características masoquistas, frigidez y depresión neurótica severa. La depresión del paciente mejoró con una psicoterapia orientada psicoanalíticamente a corto plazo, y ella era

El diagnóstico diferencial en la adolescencia 55 puede funcionar mucho mejor en su escuela y vida social. Más tarde, fue referida para el psicoanálisis para lidiar con sus problemas más profundos de carácter subyacente. La señorita B. Una escuela secundaria de 15 años de edad fue remitida de consulta debido a un reciente cambio dramático en su personalidad. La señorita B había estado cerca de su familia, tímida con otros, y un trabajador duro en la escuela. De repente, según sus padres, ella había adoptado un atuendo de "estilo hippie" acentuado dramáticamente, entró en una relación de amor tormentosa y apelente bastante subordinada con un niño varios años mayor que ella misma, y participó en una "escena de drogas" con un Subgrupo social de jóvenes rebeldes, poco convencionales. El ambiente tranquilo en el hogar había sido reemplazado por argumentos en curso y recriminación mutua, y los padres fueron perturbados por el surgimiento de la mentira frecuente y lo que vieron como un comportamiento manipulador y secreto, implícitamente deshonrado, que nunca antes habían observado en su hija. La niña había sido vista por un psicoterapeuta que había instado a los padres a ser más flexibles y tolerantes en su actitud hacia su hija. Por razones que no fueron claras, las tensiones fuertes se habían desarrollado entre el psicoterapeuta y los padres, con el paciente en el papel de la espectadora "incencial". Aunque el médico remitente se preguntó si esto era un paciente con la organización de la personalidad límite, la señorita clínica B me presionó como intelectualmente y emocionalmente más madura de lo que uno esperaría en su edad. Después de explorar su desconfianza inicial y su miedo de mí, que me veía como un "agente" de sus padres, pude transmitirle mi actitud de neutralidad con respecto a su estilo de vida, ideología y relación con su novio. Luego se abrió, describiendo lo que me pareció ser una relación profunda y significativa con el niño, un verdadero, romántico enamorarse, y una relación sexual satisfactoria con él. La señorita B fue, de hecho, "rebelarse" contra lo que vio

como los valores demasiado convencionales de su hogar, pero al mismo tiempo parecía estar haciendo planes realistas para su propia carrera y futuro. Estaba manteniendo en su trabajo escolar, fue bastante responsable de las tareas variables y los compromisos sociales, y reconoció abiertamente su disfrute de la olla ocasional fumando y formando parte de un grupo de "protesta", pero no parecía ser adicto. Tampoco había abandonado sus largos intereses en la cultura y el arte o sus estrechas relaciones con algunos amigos de larga data. Tenía una forma integrada de presentarse, un concepto diferenciado de otros significativos, una respuesta abierta emocional y emocionalmente con respecto a mis preguntas con respecto a los conflictos con sus padres y la relación con su psicoterapeuta. Mi principal preocupación fue el repentino cambio en su apariencia general y perspectiva, y le crié este asunto con ella durante un período de nueve sesiones. En el curso de estas reuniones, el cambio parecía menos patot.

56 consideraciones de diagnóstico lógicas de lo que había originalmente; Parecía reflejar un esfuerzo esencialmente normal para separar los vínculos familiares que experimentaba demasiado cercana y abrumadora. Llegué a la conclusión de que la señorita B era un adolescente relativamente normal. Las reuniones separadas y conjuntas con el paciente y sus padres recondicionaron la recomendación de su psicoterapeuta de que los padres respiraron el distanciamiento del paciente y su desarrollo de una vida social que no se ajustaba a sus propios estándares. Estos padres fueron de hecho inusualmente comprensivos y flexibles. Un seguimiento de un año indicó que las dificultades con los padres disminuyeron notablemente y la filatación con el novio había terminado seis meses después de la primera consulta; Estaba saliendo con otro niño, y ella estaba persiguiendo su trabajo y su vida social con bastante frecuencia. El Sr. C. Se refería a un estudiante universitario de 19 años de edad para lo que se destacó al médico remitente como la grandiosidad casi psicótica, la autoestimación y la patología severa de las relaciones de objetos. Este joven había tenido mucho tiempo en la historia y el arte, y había estado escribiendo ensayos que intentaban integrar enfoques ampliamente divergentes para ciertos problemas en la crítica histórica y de arte. Si bien el médico remitente no pudo evaluar la calidad real de ese trabajo, quedó impresionado por la alta inteligencia del paciente, sino que también se preocupó por el tono grandioso que el paciente usaba para transmitir su información y su actitud algo infantil, autofatulatoria. El Sr. C también generalmente derogó a la mayoría de las personas que estaban relativamente cerca de él. Su mundo de las relaciones con los objetos parecía consistir en muy pocos modelos altamente idealizados, por un lado, y muchas de las cuales se devaluaron las "mediocridades" (incluidas sus padres, otros miembros de la familia, y la mayoría de sus maestros, amigos y avisos), por el otro. Hubo momentos en que el médico remitente se preguntaba

si se enfrentaba a un genio, un paciente psicótico o una combinación de ambos. La razón inmediata de la consulta había sido el que crece el Sr. C detenido sobre su incapacidad para establecer una relación satisfactoria con una niña. Aquellas mujeres que admiraba parecían inaccesibles o fuertemente rechazadas de él, y el paciente era extremadamente tímido e inhibido con ellos; No pudo proporcionar mucha información sobre cómo su actitud interna afectó sus relaciones con estas niñas. Al mismo tiempo, las niñas que habían mostrado interés en él y con quienes había desarrollado algún tipo de relación que pronto se depreció y escapó de, temeroso para que los eximen. Había tenido asuntos sexuales ocasionales y más bien insatisfactorios con las novias, la imponexión ocasional y algunas idealizaciones que cambian rápidamente de mujeres inaccesibles. En general, el Sr. C experimentó una sensación de gran soledad, que se derivó de su separación activa de sus compañeros (porque los deprovió) y del patrón de sus relaciones con las mujeres. En Colonge, su actuación fue irregular; Hizo un nombre para él mismo

Diagnóstico diferencial en la adolescencia 57 Debido a su excelente conocimiento y conciencia en ciertas áreas, y al mismo tiempo (por razones que no estaban claras), recibió calificaciones deficientes en otros temas y experimentó un rechazo franco de algunos profesores e instructores, que se convirtió en crítico con fuerza. Se debe enfatizar que la combinación de timidez e inhibición con la actitud de "bravado" con la que expresó su superioridad intelectual, las dificultades con las niñas y sus estados de ánimo oscilantes bruscos podrían haber llevado a uno a pensar en él como un no demasiado atípico adolescente Su compromiso con los valores intelectuales y culturales, su arduo trabajo en ciertas áreas, su creatividad en su propio campo sugirió que tenía la capacidad de sublimar para la integración de su superyó. Tenía un buen control de impulso y tolerancia a la ansiedad y, a excepción de la impotencia leve ocasional, sin síntomas neuróticos. En una evaluación extendida, lo que más me impresionó fue la incapacidad del Sr. C para describir adecuadamente la naturaleza de su dificultad con las niñas y las razones que ciertos maestros y compañeros lo rechazaron. A pesar de su inteligencia, no podía transmitir una foto de sus padres, a sus maestros admirados, o las dos o tres niñas con las que estaba involucrado en ese momento. En resumen, la calidad de sus objetos se parecía notablemente pobres, y hubo una indicación definida de marcada división y la falta de integración de las representaciones de objetos. En contraste, su autoimagen y su auto concepto parecían consistentes e integrados, lo que refleja un propio serpurismo patológico. Confirmó adecuadamente su comprensión de la contradicción entre su concepto de sí mismo como una especie de genio, un importante contribuyente no reconocido a la cultura contemporánea en un área determinada, por un lado, y sus sentimientos de incertidumbre e inseguridad con respecto a las niñas. Y situaciones sociales, por el otro. Explicó que tenía necesidades emocionales para otras personas y que sin otras personas estaba obligada a sentirse sola. En la medida en que

necesitaba a otras personas y se preocupaba por su incapacidad para establecer relaciones con ellos, se sentía inseguro. Esto es lo que quería para: sentirse seguro y tranquilizado en sus relaciones con las mujeres para que esta área de "limitación" a su auto satisfacción se reduzca sustentalmente y luego podría dedicarse a sí mismo sin distracción a la búsqueda de su escritura. Se mantuvo las pruebas de realidad, y fue capaz de evaluar las manifestaciones reales de su sentido de superioridad en los interferencias de diagnóstico. Rápidamente vino a percibirme como amigable pero algo confundido, no demasiado brillante, bastante poco atractivo, un psamiástico y envejecido psiquiatra. Debido a que le había sido muy recomendable, estaba dispuesto a "darme una oportunidad", pero estaba seriamente preocupado por si podría ser ayudado en sus dificultades con las mujeres por un hombre que él mismo no se parecía a alguien que fuera muy atractivo para las mujeres.

58 Consideraciones de diagnóstico Este caso ilustra una patología de la superficie que imita ciertas características de ado-lescie suaves y una patología de caracteres graves subyacentes: a saber, una personalidad narcisista que funciona mejor que en un nivel de límite abiertas. El Sr. C fue remitido para el psicoanálisis, y un seguimiento después de dos años indicaron que pudo continuar su tratamiento a ese punto y que había establecido una constelación típica de las resistencias narcisistas en la transferencia. En ese momento, ningún cambio importante aún se había ocurrido en sus dificultades con las mujeres, aunque su conciencia de sus contribuciones a las dificultades en el trabajo, particularmente con sus maestros y superiores, había aumentado gradualmente. Hasta ahora, he descrito hasta ahora los casos en los que el funcionamiento de la superficie indica la posibilidad de la organización de la personalidad límite, pero la diagnóstica de una organización de personalidad neurótica, e incluso la normalidad, tenía que ser seriamente entretenido. Los siguientes casos ilustran el extremo opuesto del espectro: a saber, los casos en los que el diagnóstico diferencial se encontraba entre la organización de la personalidad del límite y la psicótica. La señorita D. La enfermedad manifiesta de un joven artista comenzó a los 17 años, cuando entró en su primer año de la universidad. En ese momento, se volvió cada vez más preocupada por los pensamientos sexuales extraños que interfirieron con su capacidad para concentrarse, una creciente sensación de alejamiento, y una necesidad desesperada de permanecer cerca de su madre en todo momento. La señorita D comenzó a cortar su piel, se retiró socialmente, permaneció en su habitación la mayor parte del tiempo, se sentía cada vez más deprimida, y hicieron varios tentamientos de suicidio al cortar a sí misma. El diagnóstico inicial (llegado a otro lugar) de depresión severa (presumiblemente depresión psicótica) fue seguida por un tratamiento de electroshock; Después de alguna mejora temporal, todos sus síntomas regresaron. La

hospitalización a corto plazo en varios centros de tratamiento y un tratamiento psicofarmacológico estándar que combina tranquilidades y medicamentos antidepresivos no llevaron ninguna mejora definitiva. Finalmente, se llevó a cabo un tratamiento hospitalario a largo plazo, en el curso de los cuales se planteó la pregunta sobre si la señorita D presentaba una enfermedad esquizofrénica crónica o una organización de personalidad límite. La mayoría de los psiquiatras que la vieron hicieron el diagnóstico de una enfermedad esquizofrénica. En una evaluación de diagnóstico extendida durante un período de varias semanas, encontré las siguientes características: estaba profundamente sospechosa de las motivaciones de su familia y todas las personas que la rodeaban en el hospital. No dio ninguna indicación clara del pensamiento delirante, sino que mostró una orientación paranoica genérica. Su discurso fue vaga y circunstancial, con silencios prolongados y bloqueando, creciendo en mi mente la pregunta de si presentó la desorganización formal de los procesos de pensamiento. La evaluación cuidadosa no reveló alucinaciones o delirios. Su de-

Diagnóstico diferencial en la adolescencia 59 Scripts de ella y de otros significativos fueron vagos, caóticos y contradictorios. Su efecto fluctuado entre períodos de confusión y desconcierto, momentos de depresión y otros momentos de tumuleo sutil. Cuando me enfrenté a la señorita D con su sospechosa, extrañamente, con las actitudes atraídas hacia mí, mostró una sorprendente conciencia de su propio comportamiento y de cómo estaba influenciando a la relación terapeuta / paciente. Interpretación de los mecanismos proyectivos predominantes (por ejemplo, de sus temores de que no me interesaría en ella o sería muy crítico con ella, cuando ella le diera indirectamente la evidencia de estas mismas tendencias) aumentó su conciencia de la situación de la realidad inmediata y bruscamente Redujo la vaguedad de sus comunicaciones. En resumen, la ausencia de alucinaciones y delirios, su capacidad para empatizar con criterios sociales ordinarios con respecto a la interacción inmediata paciente / terapeuta, y una respuesta integrada con la mejora transitoria de las funciones del ego a la interpretación de la defensiva primitiva Las operaciones en la transferencia temprana, todos reconfirmaron un mantenimiento sólido de las pruebas de realidad. Formulé el diagnóstico de una organización de personalidad límite con características predominantes esquizoides, masoquistas y paranoicos. Recomendé la psicoterapia y la discontinuación psicoanalíticamente psicoanalíticamente intensivas de todos los medicamentos y también sugirieron que el inicio de la psicoterapia se realice en un entorno hospitalizado estructurado hasta que pudiera controlar su comportamiento mutilante y suicida. Esta recomendación fue seguida; La señorita D se mantuvo en el hospital durante otros seis meses y luego continuó en psicoter pacientes ambulatorios de cuatro sesiones a la semana durante un período de cuatro años. Un seguimiento después de tres años de este tratamiento reveló una creciente sensación de autonomía; una creciente capacidad para estudiar y trabajar (en la medida en que

habría completado su educación universitaria y estaba desarrollando una carrera como artista), el comienzo de las relaciones heterosexuales normales con los hombres apropiados, la capacidad de alejarse de su hogar y lograr una sensación de autonomía interna y la desaparición completa de la autonomía. Las tendencias autoprotables y suicidas. Este caso ilustra la función crucial de la evaluación de las pruebas de realidad en el diagnóstico diferencial de la frontera de la línea fronteriza de los trastornos esquizofrénicos, particularmente esquizofrénicos. Miss E. Esta era una niña de l8-Año con una historia de varios epiusos de depresión severa, deterioro gradual en la escuela sobre los primeros dos a tres años, argumentos severos y crónicos con sus padres y aumentaron el aislamiento social. La falta de inhibición sexual presentada en relación con los niños y una tendencia a gravitar hacia aquellos que fueron rebeldes y socialmente aislados, manteniendo algunas amistades con algunos

60 Consideraciones de diagnóstico Personas con estas características durante varios años. Ella fue hospitalizada por la preocupación de sus padres de que su depresión podría volverse severa y que podría convertirse en suicida. En el hospital, ella era altiva, controlando, sospechosa y madipuladora. Ella insistió en que nada estaba mal con su psicología; Su único problema, dijo, era un dolor crónico en sus brazos, que presumiblemente se había desarrollado gradualmente debido a la dificultad que había experimentado en dormir durante la depresión extendida anterior. Pensó que sus problemas eran originalmente emocionales y habían causado la depresión, y la depresión, el insomnio, pero que el dolor en sus brazos era una consecuencia orgánica de la falta de sueño. Nada la ayudaría, ella insistió, excepto el tipo correcto de medicamentos, que estaba dispuesta a luchar durante todo el tiempo que sea necesario. El síntoma de dolor en sus brazos surgió gradualmente como un eje importante de organización en todas sus relaciones interpersonales. Reaccionó de manera bastante vio a enfrentarse a enfrentarse a su comportamiento manipulador, y sus tendencias para dividir personal y pacientes por igual en sus tratos en el barrio aumentaron con enfrentamientos. Debido a la combinación de operaciones defensivas primitivas claramente predominantes, particularmente denegación, división y tendencias pro-jectivas, y su falta de un concepto de auto integrado y un concepto diferente de otros, inicialmente se pensó que presentaba una organización de personalidad de bordesal. En mis entrevistas de diagnóstico, sentí que se mantuvo las pruebas de la realidad con respecto a su empatía con observaciones externas de su comportamiento inmediato y que no mostró una mayor desintegración en virtud del efecto de interpretación de las operaciones defensivas primitivas. Sin embargo, sentí que nunca podría ir más allá de su negación de todas las dificultades psicológicas y que la orientación hipocondríacamente con respecto al dolor en sus brazos nunca podría reducirse por las

pruebas de realidad ordinarias. Por lo tanto, la cuestión permaneció en qué medida se trataba de que esta era una delicadura hipocondríacal crónica, probablemente indicando, en un paciente que en ese momento no presentaba otras manifestaciones de depresión severa, la posibilidad de un esquizofrénico (o Enfermedad esquizoafectiva). Se recomendó la hospitalización a largo plazo y se realizó un enfoque de sondeo y expresión realizado para aclarar aún más este diagnóstico diferencial. Bajo el efecto de este enfoque de tratamiento, el comportamiento de la señorita E gradualmente comenzó a desorganizarse más; Finalmente, las alucinaciones claras y claras y otros delirios hipocondríacos y paranoicos se convirtieron en el MANO IFEST; El diagnóstico final fue el de la enfermedad esquizofrénica crónica. Este caso ilustra las dificultades de diagnóstico con los pacientes que presentan una sintomatología delirante monosímpoma crónica y se apunta nuevamente a la importancia crucial de las pruebas de realidad como parte del estudio di-agnóstico. Tanto los pacientes fronterizos como el esquizofrénico presentan una difusión de identidad de Seavery y predominio claro de la defensiva primitiva

Diagnóstico diferencial en las operaciones de la adolescencia 61. Es la presencia o ausencia de pruebas de realidad en un sentido estricto que permite la diferenciación diagnóstica. La incrustación de un engaño crónico aislado en una constelación de lo que parece ser una rebeldía adolescente más o menos grave puede oscurecer la organización de personalidad psicótica subyacente. Patología narcisista en la adolescencia Se debe decir al principio que probablemente sea solo los tipos de personalidad narcisista que vengan a nosotros para recibir tratamiento en la adolescencia. Muchas de las personalidades narcisistas de mejor funcionamiento consultan mucho más tarde en la vida, en relación con otros síntomas o cuando el inicio del proceso de envejecimiento amenaza las defensas narcisistas. Algunos adolescentes con personalidad narcisista también consultan por otros síntomas: fracaso escolar, por ejemplo,, por ejemplo,, por ejemplo,, por ejemplo, o desviación sexual, pero generalmente estas dificultades deben ser bastante severas para llevar a un paciente adolescente con la personalidad narcisista a un psiquiatra.. Por lo tanto, el diagnóstico de patología narcisista en la adolescencia generalmente implica que la patología es grave. Describo en otra parte (cap. 11) Un continuo de severidad de las características de la personalidad narcissis-ica. Aquí me limitaré a describir algunas características características de los pacientes con adolescentes con personalidad narcisista propiamente dichos. Estos son los primeros, un registro escolar contradictorio, con ambicciones y esfuerzos de conducción, por un lado, y un fallo casi inexplicable y la retirada de otras actividades, por el otro. La explicación se encuentra en la necesidad de los adolescentes, ya sea para ser los mejores o para devaluar esos campos en los que no pueden triunfar o pueden lograr su objetivo solo a través del esfuerzo persistente. Este patrón a menudo se enmascara con la depresión sintomática relacionada con el fracaso en la escuela. Solo una evaluación cuidadosa revela las características narcisistas predominantes de esa

depresión (sentimientos de descripción y vergüenza que no tienen triunfado) y la devaluación de lo que no viene fácilmente o no es inmediatamente gratificante. La dificultad para ser un "principiante" es característico de, aunque no es exclusivo para pacientes narcisistas. Otra característica frecuente de los adolescentes narcisistas es lo que uno podría llamar un hedonismo encantador "inocentemente", una búsqueda de placer y disfrute que a menudo ocurre con una naturaleza fácil y superficialmente amigable, una especie de actitud de Playboy de adolescentes que puede ser bastante atractiva. Tal actitud, combinada con talentos y alta inteligencia, puede organizar la dificultad que estos adolescentes tienen en comprometerse con cualquier objetivo de la vida o a las relaciones en profundidad. El calor superficial y la participación social revelan, en una exploración adicional, la pobreza típica de las relaciones de objetos y la ausencia de inversión a largo plazo en sistemas de valor y metas distintas de la autoadegranización.

62 Consideraciones de diagnóstico Los patrones de comportamiento sexual de los adolescentes narcisistas pueden incluir sentimientos de inferioridad (preocupación por un "pene pequeño") y la inhibición sexual hacia el otro sexo, combinados con promiscuidad sexual. La diferencia de los tipos más normales de promiscuidad sexual adolescente requiere un estudio en profundidad de la naturaleza de cada una de las relaciones sexuales, estos adolescentes participan, su capacidad para enamorarse románticos y su capacidad para una experiencia diferenciada de su pareja sexual. La combinación del control omnipotente, la grandiosidad y la devaluación con la rebeldía violenta contra los padres requiere una diferencia de una agitación emocional más normal adolescente. Un contraste normal o neutricular con el plontecero y el paciente narcisista-adolescente también puede presentar conflictos violentos con los padres y una tendencia a criticarlos y devaluarlos con amargura, pero esto generalmente se mitiga por la capacidad de valorar otros aspectos de los padres.. Además, el paciente neurótico tendría otras relaciones que no se ven afectadas por esta tendencia afirmativa y devaluativa. Los pacientes con noborderina no envían una división entre la devaluación general de los demás y algunos modelos exagerantes idealizados y muestran una concepción diferenciada y más integrada de al menos algunos objetos. En resumen, como he señalado el lo demás que (1975), la diferenciación de los casos fronterizos y narcisistas de sus homólogos normales y neuróticos depende de la capacidad de las adolescentes de la nonculta para experimentar la culpa y la preocupación, para establecer duraderos, Relaciones no optativas con amigos, maestros u otros, y para evaluar de manera realista a estas personas en profundidad. El noborderlina tiene un conjunto de valores de expansión y profundización constante, que pueden ajustarse o estar en oposición a la cultura circundante. Con la patología familiar severa (frecuente en todas las condiciones fronterizas y las personalidades narcisistas),

a menudo es difícil desacreditar la contribución del adolescente de los padres y los hermanos. A este respecto, el uso diagnóstico de la investigación familiar en casos difíciles y la observación de los patrones de transferencia inicial en la situación individual del tratamiento de psyogoterapéutico se complementa entre sí y pueden hacer una contribución crucial al diagnóstico. El diagnóstico diferencial de comportamiento antisocial en estos casos es un aspecto fundamental de la evaluación diagnóstica de los pacientes con adolescentes narcisistas. Varias combinaciones de las características narcisistas mencionadas pueden constituir un "adaptativo" más "adaptativo" y, paradójicamente, un tipo más maligno de patología narcisista adolescente. Un solo paciente, el hijo de un poderoso político, luchó con el estilo tradicional y dominante de su padre por rabietas crónicas en el hogar, pero se identificó con lo que vio como la actitud autoritaria de su padre al usar la influencia de su padre en la ciudad en la que vivían. Intentó aterrorizar a los maestros en la escuela, los vendedores y otros adultos invocando el poder de su padre para que se reúnen de su padre y cuando no se cumplan sus propias demandas. Al mismo tiempo,

Diagnóstico diferencial en la adolescencia 63 Haciendo uso de la riqueza de sus antecedentes, racionalizó su estilo de vida de búsqueda y placer centrado en una manera superficial pero inteligente como su identificación particular con el "antiestablecimiento". Para el diagnóstico, este tipo de paciente plantea la pregunta en qué medida presenta una adaptación relativamente no caligna a un entorno social de la expección, o en qué medida los factores ambientales están protegiendo la estructura de personalidad narcisista subyacente más profunda. Debido a que la patología narcisista de caracteres se suele reforzar en algún momento por algunas características narcisistas adaptables dentro de la familia, el problema de desenredar el paciente de la patología de la familia a menudo presenta dificultad. Una vez más, un enfoque cuidadoso en la calidad de las relaciones de objetos del paciente y de su integración de su superyó, junto con la evaluación individual y familiar, generalmente proporciona la respuesta. Antes de ofrecer algunas ilustraciones clínicas de estos temas de diagnóstico, se debe enfatizar que la verdadera patología narcisista generalmente se deriva de la infancia temprana y no es una consecuencia de la dinámica y la estructura familiar actualmente observables. Por lo tanto, la suposición de que la terapia familiar solo puede resolver la verdadera patología narcisista en un adolescente parece ser altamente cuestionable. Incluso en el caso de los pacientes con adolescentes con la más severa patología familiar, la verdadera organización de la personalidad límite no depende de la patología de la familia inmediata y respaldará el tratamiento individual a largo plazo. Al mismo tiempo, no se puede abordar un buen número de casos exclusivamente o inicialmente en el tratamiento individual porque la psicopatología del adolescente está protegida con éxito por la psicopatología de la familia y por la colusión consciente o consciente de la familia para mantener al paciente bajo su control. Por ejemplo, un paciente de Ig-Año con personalidad narcisista y características antisociales insistió en que vendría para

recibir tratamiento solo si sus padres le compraban un automóvil. Su padre estaba dispuesto a hacerlo, aunque expresé mi preocupación por este acuerdo como lo que representa una continuidad de los intentos crónicos de la parte de los padres para comprar al paciente. Finalmente, quedó claro que, sin una mayor explotación de su familia, el paciente no iba a aceptar la recomendación para el tratamiento conmigo o de ninguno de los acuerdos que había insistido como condiciones para tal tratamiento para comenzar. Me enfrenté a la familia con las alternativas de consultar a alguien que podría estar dispuesto a llevar a su hijo en un tratamiento bajo diferentes arreglos o restringir nuestros futuros contactos a los que les vemos sin su hijo para ayudarles a enfrentar mejor con su situación muy difícil. En este caso, una relación de apoyo de dos años con la familia les permitió finalmente deshacer el control omnipotente que su hijo había ejercido sobre ellos en el pasado, para exponerlo a las consecuencias directas de su comportamiento antisocial, y por lo tanto indirectamente a Llevarle a casa la necesidad de tratamiento. Aquí hay algunas ilustraciones de la condensación de pa-

64 Consideraciones de diagnóstico Thology en la adolescencia con patología familiar. Una niña antigua que disparó y gravó gravemente a su novio durante una pelea tenía un padre que también tenía un genio violento. Solía decir con orgullo que, si peor, se acercaba a lo peor, podía triunfar en sus negocios, golpeando su puño en la mesa. Sus esfuerzos para intimidar a los psiquiatras y agencias de tratamiento si sus deseos de proteger a su hija de la ley no se cumplieron fueron quizás más amenazantes que su impulsivo manejo de la pistola. Otra chica de 17 años, que se había comprometido en la prostituación a tiempo parcial, se colocó con su madre para interrumpir el tratamiento. El paciente le prometió a su madre que "se comportaría bien" hasta que estuviera fuera del hospital, y fuera del control del equipo de tratamiento, para que la madre pudiera presionar a todos que liberen a su hija y, por lo tanto, eviten continuar pagando lo que ella consideraba que había perdido dinero por el tratamiento. Otro ejemplo es el de un pintor en sus veinte años, con personalidad narcisista, múltiples adicciones a las drogas, promiscuidad homosexual y hetería, y la obesidad, cuyos esfuerzos para controlar la situación del tratamiento y utilizarlo por sus propios fines y Para escapar de cualquier control o supervisión externa (que experimentó como un insulto humillante) fue sostenidamente apoyado por su influyente familia. El paciente odiaba lo que experimentaba como el terapeuta "confrontar". La familia, siguiendo los deseos del paciente, presionó el hospital para un cambio en el servicio y logró seleccionar un terapeuta que pensaron que serían más compatibles con sus propias demandas. El terapeuta de "confrontar" fue reprendido por las autoridades del hospital, y la situación del tratamiento se corrompió en la medida en que la familia parecía dictar acuerdos de tratamiento con el propósito de garantizar su máximo comodidad y un mínimo de sentimientos de culpa. El paciente finalmente murió de una sobredosis de drogas, tal vez un suicidio, unos meses después de dejar el segundo servicio y el hospital. El

siguiente, y final, caso ilustra aspectos adicionales de los problemas de diagnóstico creados por los pacientes con límites de adolescentes con personalidad narcisista y tendencias antisociales. El diagnóstico de la personalidad antisocial surgió solo durante un largo período de evaluación y seguimiento. El Sr. F. El paciente, un senior de secundaria de Ly-Year, fue traído por sus padres debido a su desempeño escolar crónicamente pobre (a pesar de la demostración de IQ), su falta de motivación para cualquier seguimiento de estudios o una profesión, sus violentos rabietas. Cuando sus deseos no fueron cumplidos de inmediato por sus padres, y sus amenazas de violencia física. Tiraría los objetos en la casa, y a lo largo de los años, los padres se habían temer mucho de antagonizarlo. El más antiguo de cinco hermanos, el Sr. F fue extremadamente envidioso de cualquier cosa que sus hermanos y hermanas menores consiguieron que no lo hiciera. Durante un cuidado

Diagnóstico diferencial en la adolescencia 65 FUENTE INVESTIGACIÓN DE CUALQUIER HISTORIA PASADA DE MIENTRAS, RECHAJE, O EL BEBIOR ANTISOCIAL, los padres fueron muy reacios a proporcionarme información completa. Reconocieron que ocasionalmente había robado las cosas de ellos y a otros miembros de la familia, pero agregó una explicación de por qué tenía que hacer esto en términos de sus reacciones emocionales. También estaban muy preocupados por la "mala compañía" que estaba guardando, lo que creían que estaba "contaminándolo". Los informes de varios psicólogos escolares mostraron que fue considerado un joven muy enojado y sospechoso. Era tareas pasivas, impacientes y rápidas abandonadas que no parecían de inmediato alcanzables. Al mismo tiempo, tenía altas aspiraciones para el éxito, pero no estaba dispuesto a poner algún esfuerzo en lo que estaba haciendo. Era bastante difícil obtener una foto de él según lo obligado por las autoridades de la escuela y sus padres. Surgió como un joven guardado y aislado, excepto cuando hizo maduras amenazadoras a quienes lo rodeaban. En sus citas conmigo, el Sr. F fue vigilado, vague y al margen, pero este comportamiento cambió cuando sintió que no había más "amenazas" de una acción de sondeo o desconocida de mí. Cuando, por ejemplo, mencioné que había respondido todas las preguntas que quería preguntarle y que debería sentirse libre ahora para decirme lo que se sentía en sí mismo, me sentía, podría ayudarme a conocerlo mejor, comenzó a hablar con bastante libertad, pero esencialmente. Manera no involucrada. Mis esfuerzos por explorar la aparente contradicción en el FAODO del paciente entre los altos estándares que se estableció para sí mismo y su arduo trabajo, por un lado, y su tendencia a justificar siempre que sea posible, lo que me corresponde a mí como manifestaciones antisociales en su hijo llevó a aumentar. Tensión entre los padres. La madre acusó a su padre de otorgar a su Hijo, de no proporcionar suficiente estructura y firmeza, y ella dijo que le sentía temer a su hijo. Fue muy difícil para mí obtener una

imagen clara de la vida social de este joven; Parecía interesado solo en conducir un automóvil deportivo, paredes y beber. Él negó a tomar drogas, pero tuve la sensación de que él no me estaba diciendo la verdad. Dio una impresión superficial de tener miedo de no ser aceptado, pero detecté una nota subyacente de la definición y la afirmación automática durante toda la evaluación. Debido a las dificultades para obtener información completa del paciente y su familia, combiné mi propia evaluación clínica con la de un trabajador social psiquiátrico que conocía la estructura familiar total. Las pruebas psicológicas fueron llevadas a cabo por un psicólogo experimentado. La prueba reveló una patología severa de carácter y sin indicación del funcionamiento psicótico. El trabajador social psiquiátrico concluyó que también se actuó un conflicto crónico de marides entre los padres en sus argumentos que abarca al paciente. El padre era muy exigente de su hijo, pero también condenando extrañamente su comportamiento antisocial. El trabajador social se sentía.

66 Consideraciones de diagnóstico que hubo más robo y chantaje en el hogar (y quizás también en otras áreas de la vida del paciente) que nuestra primera impresión indicada. La madre parecía ser un tanto retirada de su hijo y estaba preocupada por sí misma, pero finalmente adquirió una conciencia más clara de la severidad de la situación y una sensación de rabia impotente con respecto a lo que estaba sucediendo. Mi diagnóstico final fue de una personalidad narcisista con características antisociales, y me preocupaba la colusión de la familia con la patología del Sr. F como un importante indicador de pronóstico negativo. Debido a las características antisociales, consideré una estructura social externa y una retroalimentación inversa como parte de los acuerdos de tratamiento general. La Recomendación final fue para la terapia familiar para toda la familia y la psicoterapia intensiva de la familia para el Sr. F, por un Thera-Pist diferente. También recomendé que el tratamiento comience con el movimiento del paciente a una escuela residencial o una alternativa equivalente a vivir en casa. La familia nunca aceptó esta recomendación. El paciente observó el apoyo de su padre por un largo viaje a otro estado y dinero para financiar una estancia extendida lejos del hogar, independientemente de cualquier otro plan que pueda tener para el trabajo o los estudios. El padre también consultó a varios otros psiquiatras y, finalmente, llegó a una actitud más "optimista" que abarca a su hijo, un deseo de darle una oportunidad "para crecer de todo esto" en lugar de presionarlo para continuar con el tratamiento. Un seguimiento de dos años proporcionó la siguiente información: el Sr. F acababa de regresar a su hogar para obtener la ayuda de su padre con los procedimientos legales contra él. Había estado en una lucha armada aparentemente conectada con grupos empujando drogas. La evaluación psiquiátrica en este momento reveló a un joven que parecía mucho más seguro de sí mismo, más depreciatorio, y ha sido arrogante de lo que había recordado desde hace dos años antes. Ahora transmitió la impresión de que

estaba empezando a participar en una carrera criminal. Reevaluación de la calidad de las relaciones de objetos y de cualquier evidencia que pueda indicar que no tenía una personalidad antisocial propiamente dicha (por ejemplo, relaciones no explotadoras, cualquier manifestación de preocupación o culpa, cualquier conciencia honesta de la naturaleza altamente inapropiada de su estilo de vida) no tuvo éxito, y concluí con el diagnóstico de una personalidad antisocial propiamente dicha. HE PROBADO ANTERIOR (Kernberg, 1975) que en todos los casos de comportamiento antionsalial en la adolescencia, se deben considerar una serie de factores importantes al formular un diagnóstico diferencial. ¿Es la etiqueta anticoncial legal o social, o es verdaderamente psiquiátrica? ¿El adolescente es verdaderamente antionso, o si la etiqueta se aplica más correctamente al subgrupo social al que se está ajustando el adolescente? ¿El comportamiento antisocial simplemente refleja una reacción neurótica típica a las cuestiones de la dependencia y la rebeldía de los adolescentes, o es parte de la patología de carácter grave, particu-

Diagnóstico diferencial en la adolescencia 67 en particular en una personalidad narcisista (¿el diagnóstico inicial en el caso que acaba de mencionar)? ¿O es un caso de personalidad antisocial adecuada (la diagnosis final en este caso)? Todas las personalidades antisociales tienen una organización de la persona de la mente fronteriza, como lo es cierto en las personalidades narcisistas. Aunque muchos pacientes con personalidad narcisista no tienen características antisociales, la frecuencia de dichas características en estos casos y su significado negativo pronóstico no se puede sobrevalorar.

Capítulo 4: Trastornos de la personalidad En la vejez en su estudio sociológico de la vejez, Simone de Beauvoir (1972) inscente a la sociedad para condenar a la gran mayoría de la gran mayoría de la edad de la pobreza, las viviendas incómodas y las viviendas incómodas y La soledad, y luego explica las posibilidades de la vejez. Estas posibilidades, en su opinión, ahora se les concede a solo un puñado de personas privilegiadas. Ella afirma: solo hay una solución si la vejez no es una parodia absurda de nuestra vida anterior, y eso es seguir persiguiendo fines de que le dan a nuestra existencia una promoción de personas a individuos, a grupos o a causa, trabajo social, político, intelectual o creativo. A pesar de la opinión de los morales, en el contrario, en la vejez que deseamos tener que tener pasiones lo suficientemente fuertes como para evitar que nos inflamemos a nosotros mismos. La vida de uno tiene valor siempre que uno atribuye el valor de la vida de los demás, por medio del amor, la amistad, la indignación, la compasión. Cuando esto es así, entonces todavía hay razones válidas para la actividad o el habla. A menudo se recomienda a las personas que "preparen" para la vejez. Pero si esto simplemente se aplica a dejar de lado el dinero, eligiendo el lugar para la jubilación y la colocación en pasatiempos, no seremos mucho mejor para ello cuando llegue el día. Es mucho mejor que no lo piense demasiado, sino a vivir una vida bastante comprometida, bastante justificada, de modo que uno pueda continuar en el mismo camino, incluso cuando todas las ilusiones se han desaparecido y se ha desaparecido. (págs. 54 * ~ 543) Para el psiquiatra clínico, tal estado de cosas requeriría cierta precondiciones mínimas: primero, una ausencia de o un control suficiente de la enfermedad física general para proteger al individuo de un dolor insoportable; segundo, ausencia o control suficiente de las restricciones en habilidades perceptivas, locomotoras y comunicativas, como las derivadas de la enfermedad cerebral orgánica y la psicosis; Tercero, la capacidad de invertir en relaciones con otras personas y

preocuparse por el mundo exterior en todos sus aspectos. Esta última capacidad implica que cualquier trastorno de la personalidad sea pres- 68

Los trastornos de la personalidad en la vejez 69 ENT son relativamente suaves. Además, implica que, además de los factores socioeconómicos y médicos que podrían interferir con un funcionamiento óptimo en el anciano, la cuestión del trastorno de la personalidad emerge como un factor significativo. Gianturco y Busse (1978), en una encuesta de problemas psiquiátricos, se contrarrestaron durante un estudio a largo plazo de los voluntarios de envejecimiento normal, señalaron la frecuencia de la hipocondriasis como una reacción psiconeurótica en este grupo de edad. Bromley (1978), recaudando problemas metodológicos con respecto al estudio de los cambios de personalidad en la vida adulta y la vejez, señala el problema complicado de diferenciar el comportamiento normal de adaptación de los trastornos de la personalidad general. Destaca la importancia de evaluar a los pacientes geriátricos en términos de disposición individual, situaciones psicosociales actuales e temas interaccionales para llegar a categorías de diagnóstico. Bergmann (1978) ha estudiado la prevalencia de los trastornos de la neurosis y la personalidad en la vejez y presenta una revisión crítica de la literatura. Deja la impresión de que, aunque los hechos apuntan a la existencia de reacciones neuróticas graves a las tensiones del envejecimiento y al sufrimiento significativo de los pacientes ancianos debido a los trastornos de la personalidad, aún no tenemos formas de evaluar y diagnosticar estas afecciones que son prejuscadas. Suficiente para ser muy útil. Estoy de acuerdo con Bergmann que tenemos notablemente poca información sobre el diagnóstico de trastornos de la personalidad en la vejez y, aparte de algunos informes clínicos, muy poca información sobre el tratamiento de pacientes individuales con trastornos de la personalidad. En la medida en que la experiencia clínica de trabajar con pacientes geriátricos apunta a una prevalencia significativa de los trastornos de la personalidad en la edad avanzada, uno no puede evitar la impresión de que debe haber sesgos o prejuicios profesionales o

culturales que hayan inhibido la investigación empírica en estos temas fundamentales. La antigua suposición en la literatura psicoanalítica que el psicoanálisis no debe intentarse con los pacientes más allá de sus cuarenta años, parece haber persistido. La renuencia por parte de los psicoanalistas para explorar psicoterapias psicológicas con personas mayores abandona el campo de las intervenciones psiquiátricas a aquellos que intentan aliviar el sufrimiento por parte de la general, la rehabilitación social, y Medios psicofarmacológicos. La exploración psicoanalítica de los pacientes en sus cuarenta y cincuenta ha indicado que el pronóstico para el tratamiento psicoanalítico de algunos trastornos de la personalidad, la narcisista y la personalidad histérica, por ejemplo, mejora con la edad, mientras que el pronóstico para Otros, la personalidad fantiles o del histérico, por ejemplo, es más pobre. Estas observaciones son impresiones clínicas en lugar de hallazgos de investigación empírica y no se aplican a los pacientes en sus sesenta y setenta. Sin embargo, aumentan la posibilidad de que las intervenciones psicoterapéuticas con algunos trastornos de la personalidad en pacientes mayores merecen ser explorados. Además de los sesgos culturales generales y la psicoanidad específica.

70 Consideraciones de diagnóstico Derivados alítácidos Existe la posible reticencia de los jóvenes psiquianos para tratar a los pacientes que por su aparición activan los conflictos universales de los padres y amenazan los límites generacionales vinculados a profundos tabúes infantiles. La exploración clínica de las desorden de la personalidad requiere no solo el conocimiento de las simples listas de verificación de los rasgos de comportamiento, sino también la experiencia de vida profunda. La única experiencia sólida, enriquecida por el conocimiento técnico de la patología del carácter, hace posible de manera probal de manera reencial para explorar la rigidez de los comportamientos, la incongruencia de las interacciones interpersonales y las inhibiciones emocionales en la búsqueda de tareas de vida importantes. Solo la combinación de conocimiento y experiencia permite a la taera confrontar a los pacientes con áreas de dificultad en su funcionamiento en contra de ser "lavado cerebral" por sus racionalizaciones de sus rigideces. Un joven psiquiatra puede sentir que no tiene la experiencia necesaria para adoptar la perspectiva de un paciente que tiene 20 o 30 años mayor de lo que es. Como he señalado en otro lugar (1980, cap. 7), en la mediana edad, ampliamos los límites de tiempo de nuestra identidad del ego. Es solo a medida que llegamos a la mediana edad que nos identificamos con nuestros padres, ya que los experimentamos cuando éramos jóvenes y fueron de mediana edad. Esta identificación se facilita, ya que repetimos en nuestras interacciones con nuestros propios hijos, las interacciones anteriores de nuestros padres con nosotros. Nuestra capacidad recién adquirida para identificar con nuestros padres, ya que en el pasado mejora nuestra capacidad de identificar con ellos, ya que ahora avanzan en la vejez. Y la exabación de nuestra capacidad para identificar en el futuro mejora nuestra capacidad para identificar con pacientes mayores. Sobre la base de mi experiencia clínica, sugiero que este proceso normal de desarrollo de una capacidad para identificar con las personas mayores pueda acelerarse enormemente

por la experiencia en el tratamiento de pacientes mayores durante los años de capacitación de residencia psiquiátrica. Sabemos que los límites sexuales normales (que bajo las circunstancias ordinarias nunca se cruden, pero no obstante, están involucrados en las escasas y emocionantes dietas, encuentros y malentendidos entre hombres y mujeres) se superan temporalmente de manera dramática en la experiencia de la psicoanalista. De identificarse con pacientes del otro sexo. De la misma manera, creo que el tratamiento de pacientes mayores puede acelerar la madurez emocional del psiquiatra clínico en la evaluación de la personalidad normal y anormal que funciona en todos los grupos de edad. Además, una vez que el psicólogo desarrolla una libertad interna para explorar la personalidad de los pacientes mayores sin sucumbir a los prejuicios e inhibiciones culturales (por ejemplo, la renuencia proverbial a explorar la vida sexual de los pacientes mayores), su diagnóstico de personalidad Los trastornos en pacientes mayores pueden ser mejorados significativamente. Algunas ilustraciones clínicas pueden estar en orden en este punto. Miss G. Una sola mujer de 63 años que sufrió de depresión relativamente leve pero crónica, diabetes, obesidad moderada y temor a

Los trastornos de la personalidad en la vejez de 71 años que participan en grandes reuniones sociales presentaban una personalidad histérica con características masoquistas. En el transcurso de cuatro años de psicoterapia, los sentimientos de amargura y lloramiento del paciente con la pérdida de sus oportunidades para las relaciones satisfactorias con los hombres y el matrimonio se convirtieron en un tema central que se expandió gradualmente en el análisis de sus interacciones masoquis de los hombres, su persistente sumisión inconsciente a su madre (que había muerto tres años antes del inicio del tratamiento, un momento en que los síntomas depresivos de la señorita G se habían intensificado), y su fuerte sentido de que una creciente inodastentracia física estaba haciéndola desagradure y ridículo a los ojos de los hombres en los que estaba ella. Interesto. Debería agregar que ella fue una de mis primeras casos de psicoterapia, que la traté bajo supervisión durante los primeros dos años de tratamiento, y que al comienzo del tratamiento tenía 26 años. El hecho de que estuviera experimentando capacitación psicoanalítica y un políneral personal, al mismo tiempo, resultó ser muy útil en las etapas difíciles del tratamiento. La señorita G había restringido su vida social porque se sentía inferior a otras mujeres. Ella oscilaba entre períodos cuando se sentía tan poco atractiva que no se atrevía a ir a reuniones de la comunidad religiosa y cultural y otras veces, cuando se sentía mejor en sí misma. Pero cuando se sentía mejor por sí misma, ella también se sintió dolorosamente recordó su edad y la inquietud y angustiado por el pensamiento de que ya no podía tomarse en serio como una persona sexual y una posible pareja sexual. Ella me sorprendió por su sentido de humillación, no solo para tener que contarme sobre sus actividades y fantasías masturbatorias, sino a tener tales deseos sexuales y al masturbarse en absoluto. Ella interrumpió una rematiación sexual con un hombre que comenzó en medio del tratamiento porque temía que encontraría a su asquerosa. La actitud prohibitiva de su

madre hacia la sexualidad se convirtió en un tema prominente del tratamiento. En la transferencia, eventualmente se atrevió a acusarme de la hipocresía: ¿cómo podría cuestionar su autodegración sexual cuando obviamente no podría sentirme atraída por una mujer como ella? Después de que mis sentimientos de culpa inicial sean, de hecho, no podía imaginarme tener una relación sexual con ella, descubrí, en la exploración privada de mis propias fantasías y motivos, que subyacen a las fantasías sexuales sobre las mujeres mayores que eran bastante perturbadoras debido a su Implicaciones edificadas. Una vez que podría acompañar estas fantasías internamente, pude explorar sin sentir la culpa, lo que fue lo que la hizo poco atractiva para mí y, presumiblemente, a otros hombres, a saber, los aspectos sutilmente autolagonados de su presentación. De sí misma, incluida la negligencia física, en cortos, sus tendencias masoquistas. En los últimos dos años de psicoterapia, me convertí mucho más en desafío de sus clichés culturales (algunos de los cuales habían compartido originalmente) con respecto a la conducta apropiada para una mujer en sus sesenta media y

72 Las consideraciones de diagnóstico tienen menos miedo de explorar con ella su competencia y la envidia de las mujeres más jóvenes, así como sus sentimientos similares hacia los hombres que, en su opinión, nunca envejecidos, sino, a diferencia de las mujeres, se mantuvieron eternamente atractivas. Las fuentes profundas de envidia de los hombres surgieron gradualmente y podrían explorarse como codificando su renuencia a participar activamente en asuntos sociales y políticos, así como en ella, habiendo abandonado a un contratiempo profesional mucho antes en su vida. Reanudó los estudios que le permitían mejorar su funcionamiento como administrador de una organización religiosa de alivio, y se sintió más libre sobre las amistades y las relaciones sociales con los hombres. Finalmente, estableció una relación sexual con un hombre que había sido un amigo durante muchos años, ahora era viudo, y cuyo interés de larga data en ella había devaluado previamente por razones inconscientemente masoquistas. He descrito en la escritura anterior sobre las relaciones de amor en la mediana edad (1976, cap. 8) Cómo las mujeres con personalidad histérica tienen un mejor pronóstico para el tratamiento psicoterapéutico cuando están en sus cuarenta años que en sus primeros años veinte, mientras que las mujeres con personalidad infantil tienden a presentar un Proser deficiente en ese punto que durante la adolescencia y la edad adulta temprana. A este respecto, Kahana (1979) ha señalado resultados favorables de manera similar en psicoterapia psicoanalítica con pacientes que sufren de personalizaciones obsesivas-compulsivas y masoquistas. El pronóstico cada vez más satisfactorio para la personalidad histérica también puede mantenerse cierto para la vejez. Berezin y Fern (1967) describen el resultado satisfactorio en la psicoterapia de una mujer de 7o-años con un trastorno de carácter histérico. En contraste, mi experiencia con los pacientes que presentan trastornos de la personalidad severidad dentro del espectro límite han sido mucho menos satisfactorios. Tengo otros lugares discutidos (1977) algunos de los

problemas pronósticos y psicétrapébicos relacionados con el narcisismo patológico en la vejez en la referencia a un caso informado por Berezin (1977). También he escrito sobre el deterioro de que las personalidades narcisistas se someten a la mediana edad (1980, cap. 8). Experiencia de personalidades narcisistas a lo largo de los años, un fallecimiento de su mundo de las relaciones de objetos internalizados, incluida la devaluación inconsciente de su propio pasado (para no sentir envidia de ese pasado) y de lo que otros tienen (para no envidiar a otros). Por lo tanto, estas personas no tienen a su disposición las gratificaciones normales que provienen de recuerdos de experiencias pasadas y de otros que aman. El narcisismo patológico, por lo tanto, conduce a un aumento del aislamiento social y un sentido interno de vacío. En muchos casos, el círculo vicioso de desaluación y vacío se vuelve insuperable. El Sr. H. Un destacado historiador con un grave trastorno de personal narcisista perdió todo interés en los asuntos políticos contemporáneos después de su jubilación forzada a los 65 años. Una depresión profundizada gradualmente fue claramente secundaria a la dramática devaluación de su mayor interés de la vida.

Los trastornos de la personalidad en la vejez de 73 años y su envidia de aquellos en su familia, que, a diferencia de sí mismo, persistieron en sus propios intereses y profesiones. Él se volvió intensamente resentido de mí porque era más joven que él. Una batalla importante se libró en la transferencia, y durante varios meses sentí que, si el paciente pudiera superar su intensa envidia y resentimiento de mí y aceptar mi ayuda en el luto sobre su trabajo perdido y las enormes oportunidades profesionales que habían ido con él, también podría mejorarlo. Comprenda cómo su devaluación vengativa de sus intereses pasados empobreció su vida actual. Pero su incapacidad para trabajar a través de su envidia en la transferencia llevó a una interrupción prematura del tratamiento. A pesar de ese fracaso particular, otros casos han sugerido que los pacientes que tienen cierta necesidad de dependencia y la capacidad de luto a la pérdida de oportunidades a menudo se pueden ayudar. Algunos pacientes de mediana edad con personalidad narcisista, a pesar de, o más bien debido a que, el empeoramiento de los síntomas depresivos secundarios a su estructura de personalidad narcisista, tiene un mejor pronóstico para el tratamiento psicoanalítico de lo que habrían tenido en su TWEN Corbatas o treinta. Si el tratamiento de las personalidades narcisistas en la vejez puede proporcionar características pronósticas positivas adicionales, parece una pregunta de investigación ex importante. Melanie Klein, en uno de sus últimos escritos (1963, cap. 4), se señaló por primera vez al valor pronóstico crucial, al tratar con la soledad en la vejez, del equilibrio entre la envidia y la gratitud. El diagnóstico y el tratamiento adecuado de la patología de la característica narcisista pueden tener una relevancia significativa para la adaptación a la vejez. Mis experiencias en el tratamiento de las personalidades infantiles en la vejez han sido limitadas pero interesantes. La Sra. /, Una mujer de 68 años con quejas hipochondríacas, el abuso de drogas múltiples de los tranquilizantes menores y el aumento del aislamiento social, fue referido para la psicoterapia por parte

de su internista, a quien estaba preocupado por su ingesta incontrolada de Sedantes. Si bien fue posible reducir la cantidad de medicamentos y obtener su compromiso de usar tranquilizantes menores solo bajo circunstancias muy específicas y restringidas, la pérdida de contactos e intereses sociales y el vacío de su vida personal resultó casi insuperable. Su marido le había divorciado los 23 años antes, y su ahora, los niños adultos, mantuvieron un contacto mínimo con ella. Ella vivía sola en un pequeño apartamento y contactos con experiencia con otras personas como una invasión de su privacidad. A ella le gustaba asistir a asuntos de comunidad y grupos de la iglesia, pero, por razones que permanecían oscuras a ella, no podía hacer amigos con cualquiera, y algunas personas lo habían dejado claro para que quisieran mantener su distancia. Su estilo impulso, infantil y agresivo de la comunicación tendía a alienar a otros. Sin embargo, ella intentó desesperadamente aferrar a las relaciones con la gente que era inapropiada o había indicado su falta de disponibilidad. Estaba interesada en salir con los hombres y fue invitado al parecer.

74 Consideraciones de diagnóstico propias de hombres de vez en cuando. Sin embargo, su exigencia excesiva y su incapacidad se interesan en la vida de los demás después de un rato, parecían alejarse a estos hombres. Sintió que su actividad masturbatoria era bastante satisfactoria y ese sexo a su edad con hombres con los hombres que no quería relacionarse con una forma más consistente era incómoda y degradante. Una prescripción de actividades y una vida regulada con involucraciones grupales sin demasiada demanda de intimidad resultó ser la solución óptima para ella. La Sra. J se benefició de la psicoterización de apoyo. Su caso plantea otra pregunta de investigación: si los diferentes tipos de trastorno de la personalidad y diferentes grados de gravedad del trastorno de la personalidad en la vejez requieren un enfoque de apoyo o expresivo. Este paciente, con una educación universitaria y un rico fondo cultural, tenía poco interés en los asientos intelectuales y culturales de su vida comunitaria y dependía para el entretenimiento principalmente en los chismes. En términos de mi propia reacción de la contratransferencia, me preocupé durante bastante tiempo si mi sentido de impotencia y desesperanza en trabajar con ella derivada de mi ansiedad por sus problemas en realidad o de un pesimismo relacionado con su edad. Sólo se gradué en la que me dio cuenta de que me enfrentaba las etapas finales de un fallo severa de funcionamiento de la personalidad que se había desarrollado durante muchos años. La Sra. J ilustra el hecho de que los problemas psicosociales más devastadores en la vejez pueden relacionarse con frecuencia no simplemente a las circunstancias sociales inmóviles, sino a los trastornos de la personalidad de larga data que gradualmente se descomponen a medida que los apoyos de la vida externa se alejan. Desde su revisión de la literatura del funcionamiento de las personalidades paranoicas, esquizoides e inadecuadas en la vejez Bergmann (1978) considere que, paradójicamente, estos pacientes pueden hacer mejores ajustes de los que se esperaría de su psicopatología. La

persona inadecuada, sugiere, proporciona un enfoque para la ayuda para la familia, para los amigos, e incluso a veces para contactos bastante casuales. Muestran gratitud, su dependencia y falta de logro les permiten que se ajusten al entorno que muchas personas con más orgullo y auto respeto más se encontrarían más incondicionales. Por otro lado, la postura de lucha de las personalidades paranoicas hostiles las mantiene intacta, el fracaso nunca es su propio, la mala salud podría remediarse si solo el médico le diera un tratamiento adecuado, etc. El mundo, en general, debe tomarse en un combate único; La vida presenta una lucha muy ocupada y desviada contra las fuerzas peligrosas y hostiles de la salida y hay poco tiempo para la desesperación, la depresión, el miedo y la ansiedad, (p. 62) En mi propia experiencia, algunas personalidades paranoicas en la vejez han podido mantener un solitario La postura de lucha en el medio ambiente, pero la medida en que tales pacientes se vuelven físicamente dependientes de otros y, por lo tanto, están expuestos a una intensificación de sus ansiedades para noides, es un factor importante. Además, en psicótico.

Los trastornos de la personalidad en la regresión de la vejez de 75 años, las personas mayores solitarias con personalidad paranoide pueden desarrollar grados exagerados de aislamiento social y negligencia física antes de que cualquier ayuda se presente. El Sr. K. Un hombre de 65 años, una personalidad paranoide, era un coholic crónico y patológicamente celoso de su esposa. Se vio obligado a retirarse prematuramente debido a un desglose en el trabajo relacionado con su alcoholismo y sus interacciones beligerantes con los superiores. Fue llevado al tratamiento por su esposa debido a los conflictos conyugales severos y su consumo continuo. Aunque el Sr. K inicialmente aceptó verme solo porque su esposa amenazó con dejarlo, finalmente se volvió posible que entendiera que no era el agente de su esposa, que si lo iba a verlo, estaba en términos de un contrato que se involucra a sí mismo y yo. Llevé a cabo una psicoterapia esencialmente de apoyo a lo largo de las líneas que he descrito en otros lugares (ver Cap. 9), con tacto, pero que lo enfrentan de manera consistente con su comportamiento arrogante y belicoso hacia mí y relacionando este comportamiento, una vez que podría reconocer su inadecuación, a Lo que había escuchado a su trabajo. Su mayor percepción llevó a una intensificación de su depresión, a su culpa por haber perdido su trabajo y a un aumento temporal en la bebida. Luego discutí con él los ciclos de culpa y autodestructividad autodestructivos y planteé la pregunta con él si tenía algo mejor que esperar de la vida que ahogarse en Alco. Sabiendo de la suposición paranoica del Sr. K de que sus ex colegas lo deprimirían si supierlaría que estaba en un tratamiento psicoterapéutico, utilizé su orgullo al ayudarlo a controlar el consumo de alcohol "para demostrarles que podía lidiar con la vida en su propio". Utilicé sus puntos de vista apasionados y paranoicos sobre la política y los eventos nacionales para estimularlo a participar más activamente en las Ferias Políticas locales. También pudo ayudarlo a evitar las relaciones personales que eran demasiado intensas, para aceptar sus

limitaciones en términos de intimidad, y concentrarse en hacerse un miembro deseable de los grupos de acción política. Un área en la que nunca pude reducir plenamente la naturaleza de sus distorsiones paranoicas de la realidad estaba en sus celos de su esposa. De hecho, el intento del Sr. K para convencerme de que era demasiado joven para saber cómo son las mujeres realmente, le permitieron mantener una actitud de superioridad sobre mí. Al mismo tiempo, él aceptó tratar de controlar su comportamiento para protegerla y ser más tolerante a sus "fallas". El resultado final fue una marcada disminución en el conflicto conyugal, la abstinencia de beber durante un período de al menos tres años (antes de que perdiera el contacto con él), y una creciente sensación de satisfacción con sus nuevas actividades. Confío en que estos ejemplos han ilustrado mis supuestos de que el pronóstico para los tipos individuales de trastorno de la personalidad puede variar en diferentes grupos de edad, que puede mejorar significativamente para los trastornos de la personalidad que funcionan a un nivel neurótico en contraste con esas funciones.

76 Consideraciones de diagnóstico a un nivel límite de organización de la personalidad, y que el equilibrio adaptable-inadaptativo relacionado con los rasgos de la personalidad patológica puede cambiar con las diferentes tareas y el entorno psicosocial en la vejez.

Capítulo 5: Problemas en la clasificación de los trastornos de la personalidad

Clasificación de los trastornos de la personalidad es problemático por varias razones. Uno es cuantitativo: ¿Qué tan intensa debe ser la perturbación para garantizarlo llamarlo un trastorno? Otra es semántica: una variedad de neuros de carácter de carácter, caracteres neuróticos, trastornos de carácter, disturbios del rasgo de la personalidad, perturbaciones de patrones de personalidad, trastornos de la personalidad (el término utilizado en el diagnóstico y enfermo estadístico), se ha aplicado a la Los mismos síndromes clínicos. Y detrás de estas diferencias semánticas, los problemas conceptuales, clínicos e ideológicos importantes, por ejemplo, el deseo de eliminar los términos psiconeuros de un sistema de clasificación, como se indica en la introducción a DSM-III. Por lo tanto, la elección de la Terminología puede surgir de los supuestos teóricos con respecto a los determinantes de la organización de la personalidad. Por ejemplo, una psicodinámica en lugar de un marco de referencia conductista influirá en gran medida en el ordenamiento o agrupación de las características de la personalidad patológica. En la práctica psiquiátrica clínica, los términos personajes y la personalidad se han utilizado indistintamente. Para el propósito de esta discusión, estoy usando los trastornos de la personalidad del término para referirse a las constelaciones de rasgos anormales o patológicos de carácter de intensidad suficiente para implicar una perturbación significativa en el funcionamiento intrapsíquico y / o interpersonal. Independientemente de las suposiciones teóricas del psicoanálisis, los datos derivados de una estrecha participación con el suministro de pacientes, en mi opinión, la evidencia clínica más fuerte disponible para su uso en relación con cualquier esfuerzo para clasificar los trastornos de la personalidad. Este punto de vista está teóricamente en armonía con los criterios que se detallan por Spitzer en la introducción a DSM-III: no hay ninguna suposición de que cada trastorno mental es una entidad discreta con límites

afilados (discontinuidad) entre ella y otros trastornos mentales, así como entre él y sin trastorno mental. . . . El enfoque adoptado en DSM-III es atheorético con respecto a la etiología o el proceso fisiopatológico, excepto por 77

78 consideraciones de diagnóstico aquellos trastornos para los cuales esto está bien establecido y, por lo tanto, se incluye en la definición del trastorno. . . . Este enfoque se puede decir que es "descriptivo" porque las definiciones de los trastornos generalmente consisten en descripciones de las características clínicas de los pedidos. Estas características se describen en el orden más bajo de inferencia necesarias para describir las características características del trastorno. . . . Para algunos trastornos. . . Particularmente los trastornos de la personalidad, es necesario un orden de inferencia mucho más alto. Por ejemplo, uno de los criterios para el trastorno de la personalidad límite es "la perturbación de identidad manifestada por la incertidumbre sobre varios temas relacionados con la identidad, como la autoimagen, la identidad de género, los objetivos a largo plazo o la elección de carrera, los patrones de amistad, los valores y las lealtades". (PP. 6-7) En otros lugares, la introducción enumera los objetivos de DSM-III de la siguiente manera: -Los utilidad cíclica para tomar decisiones de tratamiento y gestión en entornos clínicos variados; confiabilidad de las categorías de diagnóstico; -Aceptabilidad a los clínicos e investigadores de diferentes orientaciones teóricas; utilidad para educar a los profesionales de la salud; "Compatibilidad con la pintura con ICD-9, excepto cuando las salidas son inevitables; -Avaidando la introducción de la nueva terminología y conceptos que se rompen con la tradición, excepto cuando sea claramente necesario; -Crotando el consenso sobre el significado de los términos de diagnóstico necesarios que se han utilizado de manera inconsistente y evitando el uso de términos que se han sobrevivido de su utilidad; -Conseatividad con datos de estudios de investigación con la validez de las categorías diagnósticas; -Suitabilidad para describir sujetos en estudios de investigación; -Se responsive durante el desarrollo de DSM-III a las críticas de los clínicos e investigadores, (pp. 2-3) 'Desde un punto de vista clínico y de investigación, es importante que las constelaciones de los rasgos patológicos de

carácter descritos en cualquier clase de personalidad Los trastornos realmente corresponden a una experiencia clínica bien documentada. Si las implicaciones terapéuticas y pronósticas de diferentes trastornos de la personalidad se reflejaron en los criterios utilizados para diferenciarlos, las diferencias, en su caso, serían mucho más significativas. Una clasificación que respete las relaciones entre la estructura de la personalidad y la disposición a otros tipos de psicopatología fortalecería las definiciones descriptivas, independientemente de las diferencias teóricas sobre cómo se conceptualizarán las relaciones. Y la i. ICD-9 es la actual clasificación internacional de la enfermedad de la Organización Mundial de la Salud.

La clasificación de los trastornos de la personalidad 79 más criterios convergen en la justificación de cualquier constelación particular de rasgos de carácter patológico, más razones para incluir ese tipo de trastorno de la personalidad. Este sería un marco verdaderamente atEorético de referencia (si eso es lo que se busca en este momento). Pregunta seriamente una clasificación de trastornos de la personalidad en función de cualquier tipología preconcebida que establece un diámetro teórico de dimensiones de rasgo y luego intenta completarlo con posibles tipos clínicos. Pregunta aún más las clasificaciones más serias que claramente corresponden a un modelo particular de psicopatología y sistemas de clasificación más o menos idiosincrásicos que no tienen una base amplia en la psiquiatría clínica. Finalmente, cuestiono la agrupación de rasgos patológicos de carácter sobre la base de las preconcepciones no relacionadas con la psiquiatría clínica y las clasificaciones en las que existe la superposición bruta de varios tipos de personalidad. En otras palabras, las categorías individuales o trastornos específicos de la personalidad deben ser ampliamente representativos y capaces de ser diferenciados entre sí. En lo que sigue, exploro la clasificación de los trastornos de la personalidad en DSM-III a la luz de estas consideraciones con especial preocupación por la coherencia interna, la relevancia clínica y la correspondencia con los objetivos declarados propios de DSM-III. Para comenzar, el DSM-III ignora los tipos importantes y con frecuencia encontrados de trastornos de la personalidad, particularmente las personalidades histéricas y depredadas-masoquistas. DSM-III sostiene que el trastorno de personalidad histriónico corresponde a la personalidad histérica (p. 314), un punto realizado en otros lugares por Spitzer y Williams (1980). Esta ecuación, en mi opinión, es un error que refleja un intento de condensar toda la especie de patología de caracteres que van desde la personalidad histérica per se al histérico (EASSER y menor, 1965), infantil (Kernberg, 1975), o "Zetzel Tipo IV" (Zetzel, 1968) personalidad. Por lo tanto,

pasa por alto las contribuciones clínicas importantes que han proporcionado diferentes diferenciaciones de este espectro. DSM-III también, presumiblemente, incluye la personalidad depresiva-masoquista con los "otros trastornos afectivos específicos", a saber, el trastorno ciclotímico o el trastorno distímico. El trastorno disfrazado es un nuevo término para la neurosis depresiva. DSM-III, en referencia al trastorno cícloso y trastorno distímico, afirma, "otros términos para estos trastornos son trastornos de la personalidad cíclamos y depresivos" (p. 218). En mi opinión, confundir la neurosis depresiva con la personalidad relevante e ignorar las características de la personalidad depresiva, es un error. También se podría argumentar que el trastorno de personalidad evitativo a término recién acuñado corresponde a la personalidad depresiva, pero esto claramente no es así. Spitzer y Williams (1980) describen el trastorno de personalidad evitativo como parte de lo que DSM-II (Asociación Psiquiátrica Americana, 1968), llamada personalidad esquizoide (junto con el trastorno de la personalidad esquizootípico y el trastorno de personalidad esquizoide). Se pueden encontrar otras contradicciones entre el as-

80 consideraciones de diagnóstico se sumaron las características del trastorno de la personalidad evitadas y la personalidad relevante adecuada. La personalidad histérica, particularmente el concepto moderno de ello, es un tipo mucho más diferenciado, efectivamente funcionando que la personalidad infanitaria o del histerosoide. Este último parece imitarlo superficialmente, pero en la personalidad infantil, ambas desventajas intrapsíquicas e interpersonales de las relaciones con nosotros y los demás son mucho más severas y más generalizadas. La literatura sobre la personalidad histérica es abundante (ABRA-HAM, 1920; Marmor, 1953; Chodoff y Lyons, 1958; Easser y Menor, 1965; Shapiro, 1965; Blinder, 1966; Easser, 1966; Laughlin, 1967; Zetzel, 1968; Lazare, 1971; Mackinnon y Michels, 1971; Kernberg, 1975; Blacker y Tupin, 1977; y Krohn, 1978). Las dos últimas referencias enfatizan los aspectos estructurales en lugar de los aspectos psicodinámicos de la personalidad hysical, enriquecen su descripción clínica y aclaran sus diferentes manifestaciones en hombres y mujeres. Clínicamente, la personalidad histérica (como diferenciada de los tipos de personalidad más regresivos con los que ha tendido a confundirse en el pasado) surge como una labilidad emocional y calidez, una calidad histriónica pero controlada y socialmente adaptativa, una disminena a las crisis emocionales (Pero una presencia de profundidad emocional y estabilidad aparte de tales crisis), y la capacidad de las interacciones sociales apropiadas con la exención de las relaciones de objetos específicos que hayee las implicaciones sexuales. En términos más generales, las personalidades histéricas presentan una buena fuerza del ego y muestran un comportamiento infantil y regresivo solo en circunstancias que son acentuadas o simbólicamente sexuales. Son impulsivos, pero su impulsividad está restringida a estas interacciones sexuales o a rabietas emocionales ocasionales. Son esencialmente extrovertidos en el sentido de estar fuera y participan con otros. Tienen una tendencia a

"depender de la dependencia" solo en las relaciones sexuales, y sus necesidades dependientes y exhibicionistas también tienen un componente sexual. Los personalidades histéricas quieren ser amados, para ser el centro de atención y atracción, nuevamente solo en circunstancias con implicaciones sexuales. Las mujeres con personalidad histérica muestran una combinación de pseudohipersexualidad y en la invernancia sexual, reflejada en la provocación sexual y la frigidez y en las participaciones sexuales que típicamente tienen "cualidades triangulares" (como con hombres mayores o no disponibles, rechazo de hombres disponibles) y que satisfacen las necesidades masoquistas. La personalidad histérica es competitiva con ambos sexos y en el caso de las mujeres, por lo general, competitivas con otras mujeres para los hombres. La competitividad con los hombres contiene temores implícitos y conflictos en torno a la inferioridad consciente o inconscientemente, a la inferioridad a los hombres. Varios subendibles de un tipo de personalidad histérico "sumiso" o "competitivo" reflejan las fijaciones características de estos patrones masoquísticos y competitivos. Lo que normalmente emerge en el tratamiento, donde el comportamiento regresivo in-fantiles adquiere claramente las funciones defensivas contra el más

La clasificación de los trastornos de la personalidad 81 aspectos adultos de la participación sexual, es coqueto combinado con relaciones cálidas y altamente diferenciadas en profundidad con otras. En contraste, la personalidad infantil (con la que la personalidad histérica tendía a confundirse en el pasado) muestra la loca la lactancia emocional difusa, las relaciones indiferenciadas con otras personas significativas y las inversiones emocionales poco profundas. En contraste con la extrovertida socialmente apropiada de la personalidad histérica, la personalidad infantil se identifica con otros y proyecta intenciones irrealistas y fantásticas sobre ellos. Las personalidades fantiles tienen dificultades para entender a los demás, así como a sí mismos, en profundidad. Por lo general, muestran el síndrome de la difusión de identidad, y la naturaleza infantil y aferrada de todas sus relaciones se trata con la madurez general de la personalidad histérica a este respecto. Los rasgos dependientes y exhibicionistas son menos sexualizados en la personalidad infantil que en la personalidad histérica, en el sentido de que la personalidad infantil desea una dependencia infantil en sí misma en lugar de como una defensa contra compromisos sexuales más maduros. La personalidad infantil, crudamente y de manera inadecuada, utiliza un comportamiento sexualizado para expresar necesidades exhibicionistas. Esta personalidad tiende a tener menos inhibiciones sexuales y es más frecuentemente promiscuo que la personalidad histérica. Hay menos características represivas en la vida sexual de la personalidad infantil y las características disociativas más generalizadas, como la alternancia de fantasías y compromisos sexuales contradictorios (exprimidos en el comportamiento sexual infantil polimorfo). En la patología de las relaciones interpersonales, hay mucha menos diferenciación de las relaciones de objeciones específicas en la personalidad infantil que en la personalidad histérica, y el grado de alteración en cualquier relación interpersonal particular es proporcional a la intensidad de Participación o intimidad con la otra

persona. Esta diferenciación de las personalidades histéricas e infantiles tiene implicaciones terapéuticas y por lo tanto pronósticas. Corresponde a una larga historia de observaciones descriptivas y psicodinámicas, así como a las observaciones hechas fuera de un marco de referencia psicoanalítico. La descripción del trastorno de personalidad histriónica en DSM-III se relaciona con bastante claramente con la personalidad infantil y no a la personalidad histérica. Por ejemplo, los pacientes con histriónicos se describen como se aburren rápidamente con las rutinas normales, apareciendo poco profundas y carecen de autenticidad, y presentando amenazas suicidas manipulativas, sentimientos de despersonalización y, durante estrés extrema, síntomas psicóticos transitorios de insuficiencia. Severidad o duración para justificar un diagnóstico adicional (DSM-III, PP. 313-14). Para complicar aún más los asuntos, DSM-III describe el trastorno de la Personalidad de la Línea límite como presentando rasgos similares a los presentados por la personalidad histriónica. Ambos se describen como impulsivos o impredecibles,

82 Consideraciones de diagnóstico con patrones de relaciones interpersonales inestables e intensas, que muestran una ira inapropiada e intensa o la falta de control de la ira y la incapacidad afectiva, propensos a los gestos e intentos de suicidio, y presentando los esfuerzos de incienes para atraer la atención. Y tranquilidad. Si bien DSM-III describe explícitamente el trastorno de la personalidad límite como presentando una perturbación de identidad, las características de la personalidad histriónica en la práctica indican igualmente las perturbaciones de la identidad. Y tanto los trastornos de la personalidad histriónica como la línea fronteriza se describen como propensos a desarrollar episodios psicóticos breves. El trastorno de personalidad histriónico diagnóstico es, por lo tanto, equívoco, correspondiente al polo más regresivo del espectro histérico-infantil. Sin embargo, en todo caso, debe señalarse que DSM-I (Asociación Psiquiátrica Americana, 1952) también había olvidado la personalidad histérica en su época, y que DSM-II "redescubierto". La esperanza, por lo tanto, permanece para futuras redescubiertas de este trastorno de personalidad altamente prevalente. Otro ausente prominente del DSM-III es el trastorno de personalidad depresivo-masoísta, con más frecuencia conocido como la "personalidad masológica" o, en la literatura psicoanalítica, como el "masoquista moral". La personalidad depresiva fue referida por Kraepelin (1904), Tramer (1931), y Schneider (1950) y descrito por Fenichel (I945B) y laughlin (1967). Otras descripciones clínicas son proporcionadas por Gross (1974) y Kernberg (1975). Sin embargo, antes de continuar, se debe tener en cuenta que las descripciones clínicas llegaron a través de la exploración psicoanalítica, con sus características emergentes fenomenológicas, deben diferenciarse de las teorías etiológicas, psicopatológicas y psicodinámicas de Psicoanálisis. Para tirar los síndromes clínicos prevalentes porque fueron descubiertos, estudiados y descritos por psicoanalistas no son una expresión de la objetividad "atEorEE", pero puede revelar un

sesgo teórico contra el psicoanálisis. Frances y Cooper (1981), en una crítica relacionada de la separación artificial de los criterios descriptivos y dinámicos en DSM-III, estatal: "Algunas observaciones clínicas relacionadas con el" inconsciente dinámico "no son más inferenciales que las observaciones consideradas Descriptivo en DSM-III.... La tendencia de DSM-III para excluir las observaciones derivadas de un marco dinámico parece limitante arbitraria e innecesariamente" (p. 1199). Los pacientes con trastornos de la personalidad depresiva-masoquista generalmente funcionan bastante bien, generalmente dentro del espectro de la patología de caracteres de "alto nivel" (en mi opinión, una organización neurótica de personalidad en lugar de la personalidad). Tienen una identidad de ego bien integrada, muestran manifestaciones no específicas de la fuerza del ego (buena tolerancia a la ansiedad y control de impulsos), y tienen una conciencia moral excesivamente complicada pero bien integrada. Son capaces de establecer relaciones de objetos bien diferenciadas en profundidad.

La clasificación de los trastornos de la personalidad 83 después de la descripción de la risa (1967), se puede desglosar los rasgos de carácter del trastorno de personalidad depresivo-masoquista en tres categorías: (i) Rasgos que reflejan la función de superyo excesivamente grave; (2) aquellos que reflejan la sobredependencia sobre el apoyo, el amor y la aceptación de los demás; y (3) aquellos que reflejan dificultades en la expresión de la agresión. De muchas maneras, las tres categorías tienen el "metabolismo" defectuoso de las necesidades de dependencia como un tema predominante. Estos pacientes se sienten culpables debido a una intensa ambivalencia hacia los objetos amados y necesarios, y se frustran fácilmente si sus largos dependientes no se componen. Las características de "superyo" conspicuas de la personalidad depresiva-masoquista se reflejan en una tendencia a ser muy seria, responsable y preocupada por el desempeño y las responsabilidades del trabajo. Hay un sombrío sobre ellos, un exceso de información. Estos pacientes usualmente no tienen mucho sentido del humor, pero son altamente confiables y confiables. La exploración psicológica revela su tendencia a juzgarse con dureza y establecer estándares extremadamente altos para sí mismos. Estas personas generalmente consideradas, táctiles y preocupadas, también pueden ser muy duras en su juicio de otros. Bajo ciertas circunstancias, la crueldad de su superyó puede ser dirigida hacia otros en forma de "indignación justificada" (ver Schneider, 1950). Cuando estos pacientes no cumplen con sus propios altos estándares y expectativas, muestran las manifestaciones clínicas de la depresión. En circunstancias óptimas, el trabajo duro y el éxito externo pueden eventualmente proporcionar a estos pacientes una idea de haber cumplido con sus deberes y responsabilidades, y la vida puede ser más fácil para ellos en años posteriores. Pero si intentan lo imposible, pueden ser cada vez más despidos a medida que la vida continúa. Estos son los masoquistas morales que se inconscientemente se

ponen en circunstancias que inducirán el sufrimiento o que experimentan ese sufrimiento como el precio de los disfruentes que puedan permitir. Otros masoquistas morales son psicodinámicamente más cercanos al trastorno de personalidad histérico, especialmente a las mujeres con características de carácter depresivo y características inconscientes graves contra la libertad y el disfrute sexuales. Pueden tolerar una experiencia sexual satisfactoria solo cuando se lleva a cabo en condiciones de sufrimiento objetivo o simbólico. Los pacientes caracterizados por la personalidad depresiva-masoquista, también pueden mostrar una vulnerabilidad anormal a la decepción por parte de otros, especialmente la pérdida de amor o interés, y puede llegar a su manera de expresar simpatía, amor y afirmación. En contraste con las Personalidades Narcisísticas, que son demasiado recientes sobre la admiración externa sin responder internamente con el amor y la gratitud a aquellos que admiran y los aman, la personalidad depresiva-masoquista típicamente es capaz de responder.

84 Consideraciones de diagnóstico profundamente con amor, para estar agradecido. Sin embargo, estos pacientes se aferrarn y exigiron conscientemente y pueden desarrollar un descenso anormal de cumplimiento a la otra persona, junto con un aumento gradual de las demandas implicadas en su excesiva dependencia del otro. Si la patología del otro se adapta, el resultado puede ser una relación altamente satisfactoria en el amor y el matrimonio. El menor afortunado de estos pacientes muestra una sensibilidad excesiva a la pérdida de amor, un sentido inconsciente de ser rechazado y maltratado como una reacción a ligeros relativamente menores, y la tendencia a tomar represalias por un comportamiento percibido en otros al intentar hacer que los demás se sientan culpables. O rechazando el comportamiento por su propia parte. Su actitud de "¿Cómo podría hacerme esto?" Puede hacer que otros los rechacen, de hecho, iniciando así un ciclo vicioso que eventualmente puede amenazar incluso a las relaciones perdentes profundas. El sentido subjetivo de estos pacientes de ser rechazado, así como frustraciones y pérdidas reales, tiende a llevarlas a la depresión clínica. A lo largo de los años, ya que lauge (1967) ha señalado, la conciencia de sus enormes necesidades de los demás, el peligro de criar esperanzas demasiado alto y luego sentirse frustrado, puede provocar una reacción secundaria de la retirada cínica de las relaciones interpersonales. El "metabolismo" defectuoso de la agresión en el trastorno de personalidad depresivo-masoquista muestra en la tendencia de estas pacientes a ser depositadas en condiciones que normalmente producirían enojo o rabia. La culpa inconsciente sobre tal ira (reforzando la culpa inconscientemente experimentada debido a la agresión hacia los objetos anteriores de amor) puede comprender sus relaciones interpersonales. Tienden a experimentar ciclos en los que expresan la ira hacia aquellos que "legalmente" atacan o se sienten rechazados por, luego se deprimen, se disculpan demasiado, incluso sumisos y cumplen, hasta que la ira secundaria sobre el cumplimiento o la presentación se

acumula en el próximo ataque de rabia. La visión psicoanalítica tradicional que los pacientes que están deprimidos en la ira directa contra ellos mismos en lugar de contra otros parecen generalmente ilustrados por estos casos. La literatura psicoanalítica temprana solía incluir estos personalidades como subcategorías del carácter "oral" en un intento por clasificar la patología del carácter sobre la base de "puntos de fijación libidinales". En este esquema, el carácter histérico correspondió a las fijaciones genitales, el carácter obsesivo-compulsivo a las fijaciones sádicas anal-sádicas, y el carácter oral a las fijaciones dependientes de la mano. Esta clasificación anticipada se rompió por muchas razones. Sin embargo, clínicamente, el trastorno de personalidad histérico, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo y el trastorno de la personalidad depósión de la presresión son tipos de patholóficas de carácter que reflejan un alto nivel de organización de personalidad, una buena diferencia del tripartito Estructura intrapsíquica, identidad sólida del ego y un predominio de las operaciones defensivas centradas en la represión. Estos pacientes pueden estar sufriendo severamente de su carácter patología y

La clasificación de los trastornos de la personalidad 85, sin embargo, tiene un muy buen pronóstico con tratamiento psicoanalítico. El hecho de que dos de estas tres categorías se hayan omitido de la clasificación de los trastornos de la personalidad en DSM-III parece ser un deficiencia grave. El trastorno de personalidad evitativo en DSM-III parece ser algo relacionado con la personalidad depresiva, pero esto no es, aparentemente, la comprensión de Spitzer y Williams (1980), quienes señalan que la "distinción entre las categorías DSM-III de Schizoid. Y evitar: los trastornos de la personalidad de la hormiga se basan en si hay un defecto en la motivación y la capacidad de la participación emocional (Millon). Se está excluyendo que esta distinción descriptiva tenga implicaciones terapéuticas y probadas" (P. 1065). MILLON, uno de los miembros del Grupo de trabajo sobre la nomenclatura y las estadísticas responsables del DSM-III y del Comité Asesor sobre Trastornos de Personalidad, ha desarrollado su propio sistema teórico de clasificar los trastornos de la personalidad basados en una combinación de patrones de afrontamiento aprendidos. Estos "pueden verse considerados como formas complejas de comportamiento instrumental, es decir, formas de lograr un refuerzo positivo y evitar refuerzos negativos" (Millon, 1981, p. 59). La siguiente tabla resume la correspondencia entre la clasificación de Millon y la DSM-III. MILLON DSM-III Patrón dependiente pasivo Patrón dependiente Patrón dependiente activo Patrón histriónico patrón independiente patrón narcisista Trastorno independiente activo Patrón antisocial Trastorno antisocial Patrón ambivalente pasivo Patrón compulsivo Trastorno compulsivo Patrón ambivalente activo Patrón ambivalente Pasivo-agresivo Pasivo-Trastorno esquizoide del patrón separado Modelo separado activo Trastorno Eveniente de la personalidad Millon también ha desarrollado dos enventorías de autoinforme de diagnóstico informatizadas, el inventario multiaxial clínico de Millon y el inventario de salud de los comportamientos de Millon. Su libro de texto reciente (1981) proporciona

ilustraciones detalladas de sus puntos de vista sobre la clasificación y documenta la influencia que ha tenido en el Grupo de trabajo DSM-III, en la medida en que al menos 2 de las 11 categorías de trastornos de la personalidad en DSM-III (la personalidad dependiente El desorden y el trastorno de la personalidad evitativo) se relacionan directamente con su pensamiento. La calidad académica del análisis de Millones, la dimensión histórica de las clasificaciones de la personalidad y la patología del carácter que describe, y la consistencia interna de su sistema de clasificación personal debe ser de gran interés para todos luchando con estos problemas. Al mismo tiempo, el hecho de que la terminología de Millon, derivada de un sistema teórico altamente personal, que no está directamente relacionado con el psicólogo clínico ordinario.

86 Consideraciones de diagnóstico La experiencia de RIC, debería haber influido tan fuertemente en que este sector de DSM-III plantea cuestiones con respecto a la naturaleza atEGEA asumida de la clasificación propuesta y los objetivos explícitos de desarrollar una terminología aceptable para los clínicos e investigadores de Otras orientaciones teóricas y de evitar la introducción de la nueva terminología y conceptos que se rompen con la tradición, excepto cuando sea claramente necesario. La transmita de la descripción de Millon de su compleja relación e influencia en el Grupo de trabajo de DSM-III habla por él, si no para la sección de trastornos de la personalidad. El trastorno de personalidad evitativo se describe en DSM-III como la hipersensibilidad previa a la expresión al rechazo, la humillación o la vergüenza y una tendencia para interpretar eventos inocuos como ridiculización. Estas características no corresponden a la personalidad depresiva, se caracterizan tanto a los trastornos de la personalidad narticsistía y paranoico. La personalidad evitada se describe como no dispuesta a entrar en relaciones a menos que se les proporcione garantías inusualmente fuertes de aceptación no crítica. La personalidad depresiva-masoquista, por el contrario, tiene un enorme sentido de responsabilidad personal y la sensación de que tiene que hacer los esfuerzos máximos para encontrar y relacionarse con otros, que se refleja socialmente en las relaciones de superficie notablemente buenas con otros al costo del gran estrés., Tensión y dudas constantes que merece el amor y la amistad de los demás. En DSM-III, el trastorno evitativo de la personalidad se describe según lo aislado, similar a la personalidad esquizoide, excepto por un deseo de participación social y un estado de alerta particular a las críticas. La personalidad depresiva no presenta el aislamiento social del tipo y la gravedad que muestra la personalidad esquizoide. Además, que las personalidades esquizoides no presentan un deseo de participación social y no son sensibles a las críticas que están abiertas a la pregunta; La intensa participación clínica

con las personalidades esquizoides le revela que poseen una realidad intrapsíquica mucho más compleja de lo que inicialmente transmiten. Aquí, la negligencia de las exploraciones psicodinámicas de la personalidad esquizoide empobrece su descripción. En resumen, cualquier significado o utilidad clínica es proporcionada por el concepto del trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad depresivo-masoquista definitivamente falta en DSM-III. La llamada depresión neurótica del trastorno distino-neurótico o la neurosis depresiva, diríamos, no corresponde a la personalidad depresiva-masoquista, sino a un complejo sintomático que se puede activar por la descompensación de otros trastornos de la personalidad, como, Típicamente, la personalidad narcisista. O el trastorno distímico podría ser simplemente una expresión directa de un conflicto intrapsíquico inconsciente, no estructuralizado en la patología de caracteres. También faltan otros trastornos de la personalidad en DSM-III. Por ejemplo, el "como si la personalidad", la "personalidad sadomasoquista", y la "personalidad hipomanítica" faltan, y el personal inadecuado.

La clasificación de los trastornos de la personalidad 87 ITY de DSM-I y DSM-II también se ha retirado de la circulación. Se podría argumentar que estos se omitieron porque su base descriptiva es demasiado estrecha o están demasiado vinculados al psicoanálisis como un sistema órtico o su frecuencia clínica es baja. En mi opinión, aunque rara vez se cumplió la "personalidad inadecuada", correspondió a una constelación clínicamente existente. Por otro lado, los 11 Los trastornos de personalidad seleccionados para la discusión en DSM-III incluyen al menos 3 recién llegados de estado cuestionable: la personalidad evitada mencionada anteriormente; la personalidad dependiente, otra contribución aparente de Millon; y la personalidad esquizotípica. Ya he planteado algunas preguntas sobre la personalidad evitada; Aquí agregaría solo que encontré las ilustraciones clínicas de los tres tipos en el libro de casos DSM-III (Asociación Americana de Psiquiatría, 1981) problemática. El caso del "contable" (p. 59), una ilustración de un trastorno de personalidad evitada, se presenta en una descripción de dos párrafos que encontraría altamente inadecuado para cualquier diagnóstico de personalidad. El caso de la "hermana triste" (p. 175) se trata de una mujer solitaria que ha sido extremadamente temerosa de los hombres y recortes las posibles reiteraciones con ellos porque teme que eventualmente rechazarán, los campeones buenas causas, son competentes y responsables en su trabajo como El ayudante del maestro, y tiene, ya que solo contacta a una hermana y una amiga cercana de la escuela secundaria. Sobre la base de esta descripción de la cápsula, se podría aumentar la posibilidad de la presencia de una personalidad esquizoide o, en una exploración adicional, quizás características histéricas importantes. En cualquier caso, hay poca evidencia de su deseo de afecto y aceptación "sobre la aprobación incondicional", supuestamente centralmente en la personalidad evitada. Los casos de trastorno de la personalidad dependiente en el libro de casos DSM - // J plantean inmediatamente la cuestión de la relación entre el trastorno de

.

personalidad dependiente y el trastorno de personalidad agresivo pasivo. Este último es una categoría que emergió por primera vez en DSM-I y ha sobrevivido a través de DSM-II en DSM-III. Las descripciones originales (Whit- Man et al., 1954; Rabkin, 1965; Small et al., 1970) proporcionó una base relativamente estrecha y clínicamente relevante y clínicamente relevante, y este catory ha sido una bolsa de diagnóstico útil para los trastornos que hacen No caer fácilmente en ninguna otra categoría importante. Esta categoría, entonces, es una buena ilusión de un listo relativamente atenemente y es clínicamente útil. En DSM-III, el trastorno de personalidad dependiente ha reementado con una independencia recién asumida. El manual no hace referencia a los problemas de diagnóstico o a ninguna razón para distinguir esta clasificación del trastorno de personalidad agresivo pasivo. Los casos correspondientes en el libro de casos DSM - /// ilustran esta ambigüedad. El "psiquiatra terco", diagnosticado como un trastorno de personalidad agresivo pasivo (p. 40), se muestra fuertemente implícito, inapropiado (y

88 consideraciones de diagnóstico no reconocidas) actitudes dependientes hacia su esposa; La "sangre es más gruesa que el agua", el paciente (p. 47), que rompió con su novia, porque su madre desaprobó a ella, se diagnostica como dependiente, mientras que aún está muy claramente, lo que muestra un comportamiento pasivo-agresivo hacia su madre. La otra ilustración de caso de un trastorno de personalidad dependiente (p. 73), "empujado alrededor", un homosexual que resiente su papel excesivamente pasivo con su novio, pero tiene dificultades para obtener erecciones con otros hombres, parece presentar un trastorno de personalidad mucho más complejo que se puede sumar El trastorno de personalidad dependiente de la etiqueta. Sin embargo, en este caso, el diagnóstico fue solo "provisional", la razón era que "el comportamiento dependiente está claramente presente en su relación actual, pero existe información inadecuada para determinar si esto es característico de su funcionamiento a largo plazo". En otras palabras, la naturaleza displaneal del diagnóstico no se derivó de las distorsiones y la complejidad de su vida sexual. Este paciente, por cierto, también recibió el diagnóstico de la emoción sexual inhibida, pero su homosexualidad no se refería a diagnóstico. Podemos asumir, por lo tanto, que este paciente se sentía cómodo con su homosexualidad. El trastorno de personalidad esquizotípico presenta importantes problemas clínicos y teóricos. Spitzer y Williams (1980, pág. 1065) Estado: "Se desarrollaron los criterios para el trastorno de la personalidad esquizotípico para identificar a las personas que habían sido descritas como Schizizenia de Borderline (Spitzer et al.). Hay evidencia de que crónica La esquizofrenia es más común entre los miembros de la familia de individuos que fueron descritos como una esquizofrenia límite que en la población general (RosenthAi y Kety)". Aquí hay un sesgo teórico claro; Se creó una categoría que encajaría con un concepto de espectro de esquizofrenia basado en la investigación sobre características genéticas en la esquizofrenia. La evidencia del

concepto de un espectro de esquizofrenia es lo suficientemente convincente, pero se debe tener en cuenta que algunos de los familiares biológicos de los pacientes esquizofrénicos que presentan lo que Hoch y la polatina (1949) llamaron "pseudo-neurótico. La esquizofrenia," y otros han llamado "esquizofrenia límite" o "esquizofrenia ambulatoria", pueden sufrirse de versiones más levantes o subclínicas de enfermedades esquizofrénicas en lugar de un trastorno de personalidad. De hecho, toda la literatura contemporánea en la investigación sobre las condiciones de la frontera provino de un esfuerzo para aclarar si existe la "esquizofrenia límite" y la medida en que uno puede diferenciar a este grupo en (a) pacientes con estructuras "personalidad psicóticas" o "atípicas" o "atípico" o "atípico" o "atípico" o "atípico" Formas latentes "o" simples "o" residuales "de enfermedad esquizofrénica, y (b) Personalidades límite adecuadas, que definitivamente no son psicóticas. Los estudios epidemiológicos, incluidos los intervocos clínicos de los familiares biológicos de los probandos esquizofrénicos, pueden no proporcionar el tipo de evidencia discriminatoria sutil que responderían a estas preguntas, en contraste con el diagnóstico intensivo y el diagnóstico a largo plazo y la terapéutica.

La clasificación de los trastornos de la personalidad 89 participaciones con las poblaciones de pacientes, o la investigación empírica llevada a cabo por GRINKERT et al. (1968), Gunderson (1982), Perry y Klerman (1980), Kroll et al. (1981), y otros. En el libro de casos DSM-I / I, el "Clairvoyant" (p. 95), diagnosticado un trastorno de personalidad esquizotípico, presenta la depersonalización, la despierción, el pensamiento mágico, las ideas de referencia (que no fueron desafiadas a la referencia. Su calidad delirante), el discurso impar, la sospecha y la realización de la realización de la realización se evaluaron solo en la medida de determinar que no tenía alucinaciones o delirios. No tenemos forma de saber si sus ideas de referencia y su sospecha se exploraron adecuadamente. El comentario del libro de casos afirma: "El médico podría preocuparse por la probabilidad de un episodio psicótico anterior en este paciente, en cuyo caso los síntomas actuales serían indicativos de la fase residual de la esquizofrenia. En ausencia de tal historia, sin embargo, un diagnóstico de El trastorno de la personalidad esquizotípico es el más apropiado" (p. 96). El otro caso de la personalidad esquizotípica presenta el aislamiento social, el pensamiento mágico, la relación inadecuada, el discurso impar y la hipersensibilidad a las críticas (lectura en la crítica donde no se pretendía ninguno). Nuevamente, el comentario (p. 235) dice: "Hay muchas similitudes entre el trastorno de la persona esquizotípico y los síntomas que se ven en el subtipo residual de la esquizofrenia, pero la ausencia de un historial de características psicóticas abiertas descarta ese diagnóstico". En mi opinión, el diagnóstico del trastorno de la personalidad esquizotípico es problemático. Una cuidadosa evaluación de las pruebas de realidad en la situación clínica puede identificar a los pacientes la pérdida real de las pruebas de realidad y la estructura psicoides de la personalidad en contraste con aquellos en los que el mantenimiento de las pruebas de realidad corresponde claramente al diagnóstico de la personalidad esquizoide. Es como si se hubiera insertado

un extremo de la cola de la esquizofrenia en la sección sobre trastornos de la personalidad, la contraparte de la notable restricción de la esquizofrenia a una psicosis de al menos seis meses de duración, para que cualquier enfermedad esquizofrénica que dura incluso una Pocos días menos de seis meses se clasificarían como un trastorno esquizofreniforme. Sería preferible, me parece, no restringir a la esquizofrenia tan artificialmente y, desde un punto de vista clínico, para poder hacer el diagnóstico incluso en los casos que no tengan la imagen florida y donde el enfoque de tratamiento y el pronóstico sean diferentes de los correspondientes a Trastornos de la personalidad. En toda justidad, se podría argumentar también que la introducción de la diagnóstico del trastorno de la personalidad esquizotipal como intermediario entre el trastorno esquizofrénico y el trastorno de personalidad esquizoides reflejan un enfoque tan fivisticado para la interrelación de los diversos segundos de diagnóstico. Tors, la delimitación de un área oscura que vincula los trastornos de la personalidad con las psicosis. Sin embargo, encontramos que los trastornos de personalidad correspondientes en el lado afectivo se han clasificado entre los

90 Consideraciones de diagnóstico Trastornos afectivos. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, el desorden cíclamo (correspondiente a la personalidad cícola en DSM-II) está clasificada junto con el trastorno distímico o la neurosis depresiva dentro de los trastornos afectivos. Aquí el problema mencionado en la discusión de la personalidad depresiva se ve agravada. Si concebimos los trastornos de la personalidad en una secuencia de severidad de la personalidad depresiva a las personalidades hipomaníficas y cíclicas, con un área en la que los trastornos afectivos y la personalidad se superponen, todo el espectro afectivo de la personalidad. Los trastornos se mantendrían juntos, al igual que los trastornos esquizoides y esquizotipales. Sin embargo, DSM-III, restringe inconsistentemente la esquizofrenia y expande los trastornos afectivos. Frances (1980) ha llamado la atención sobre una inversión similar en el manejo de los trastornos del espectro en DSM-III. Esta consistencia también se extiende a una tercera dimensión, quizás incluso más importante que la relación de los trastornos de la personalidad a la esquizofrenia y los trastornos afectivos, a saber, la relación de las desorden de la personalidad a las neurosis sintomáticos o psiconeurosos. Debido a que las neumas se han dispersando a lo largo de DSM-III, la relación entre reacciones relativas y trastornos de la personalidad se corta, y la relación entre la personalidad histérica y la histeria de conversión y los trastornos disociativos han desaparecido. La histeria de conversión se ha dividido en un trastorno de somatización (cuando una mujer tiene más de 14 síntomas o un hombre más de 12) y trastorno de conversión (14 o menos síntomas en mujeres, 12 o menos síntomas en los hombres). La obsesiva personalidad compulsa de DSM-II ha sido renombrado por el trastorno personal de personal compulsivo "para evitar confusiones con trastorno obsesivo compulsivo". Esta disociación artificial de los trastornos de la personalidad de las neurosis sintonómicos y el cambio de nombre y el reorganización de los neuros

sintomáticos en todo el aumento del DSM-III en lugar de reducir los problemas de la relación entre los trastornos de la personalidad y la psicopatología en general. Además, se han colocado varios trastornos de la personalidad fuera del sector de la personalidad, como el disorbierno de la ya mencionada, los trastornos del control de impulsos que no están clasificados en otra parte, que incluyen la personalidad explosiva (bajo el nombre de trastorno explotador intermitente), y varios trastornos de la personalidad impulsivos (bajo el título de juego patológico, kleptomanía y piromanía), en la adición al trastorno de control de impulsos atípicos. En el diagnóstico de trastorno de la personalidad límite, el Grupo de trabajo DSM-III se enfrentó a la terminología a veces idiosincrásica utilizada por los médicos individuales, investigadores y teóricos y con sus diferentes ideas sobre lo que se incluyó este diagnóstico. Por ejemplo, Gunderson (1977, 1982; Gunderson y Singer, 1975; Gunderson et al., 1981) considera un trastorno de la personalidad límite de un estrecho, estrictamente delimentario.

La clasificación de los trastornos de la personalidad 91 ited entidad diagnóstica, con características clínicas que corresponden bastante estrechamente con las definidas en DSM-III y se corresponden aproximadamente a la personalidad infantil o a los tipos de personalidad infantil a lo que se refirió anteriormente. En contraste, GRINKER (1975) presenta un amplio espectro de condiciones fronterizas, al igual que Rosenfeld (19793, I979B), Searles (1978), Giovacchini (1979), Masterson (1980), y Rinsley (1980). Piedone (1980) y Kernberg (1975; Véase también Chaps, I y 2, arriba) Adopte una posición intermedia que considere la organización de la personalidad límite para que sea una entidad diagnóstica psicostruica en la que las predisposiciones genéticas, Psy- Las predisposiciones clodinámicas y las disposiciones temperamentales convergen. Para fines prácticos, la decisión debía hacerse si la organización de la personalidad límite debe introducirse como un concepto estructural (que indica la gravedad de la patología del carácter o el trastorno de la personalidad) o en un sentido restringido correspondiente a los conceptos de Gunderson y los demás. DSM-III optó por la definición restringida, pero la decisión no ha sido consistente. En primer lugar, el énfasis de Gunderson en el desarrollo de episodios psicóticos breves en estos pacientes no se incluyó entre los criterios esenciales, a pesar de la evidencia de la investigación clínica y de la investigación significativa, y se menciona solo como una idea de último momento: "trastorno distímico y depresión mayor como así como trastornos psicóticos, como una breve psicosis reactiva, pueden ser complicaciones" (DSM-III, p. 322). Además, DSM-III muestra una sorprendente superposición del trastorno de la personalidad límite y el trastorno de personalidad histriónica (mencionados anteriormente). Ambos se describen como presentando la patología severa de las relaciones de objetos, la inestabilidad afectiva, los actos físicamente autoadhuficientes, la impulsividad, la autocramatización y los trastornos psicóticos transientales. También se menciona la

perturbación de la identidad, correctamente mencionados por el trastorno de la personalidad límite, también se menciona para la personalidad histriónica. Papa et al. (1983) concluyeron que aunque el trastorno de la personalidad de la línea fronteriza podría distinguirse fácilmente de la esquizofrenia DSM-III y no pareció representar "el DISPONIBRE AFFECTIVO FRONTERO", no se podría distinguir en ninguno de los índices de Histrixnic y Trastornos de la personalidad antisocial. Parece que la inclusión de la personalidad límite y la personalidad histriónica representa algún tipo de solución de compromiso, con efectos de confusión. Tal vez el término trastorno de la personalidad histriónico y la descripción correspondiente se relacionan con el interés de D. Klein (1975, 1977) en la clasificación del espectro límite de acuerdo con la respuesta psicofarmacológica, y quizás su participación en el Grupo de trabajo influyó en ese etiquetado, al igual que la selección. De los trastornos de personalidad evitados y dependientes, refleja el pensamiento de Millon. En el concepto general del trastorno de la personalidad de Bor- derribación, estoy de acuerdo con el énfasis en Millon en la mensajería insuficiente de una clasificación de trastornos de la personalidad que consideraría la gravedad de la enfermedad además de una constelación particular de los rasgos de carácter patológico. Millon escribe:

92 consideraciones de diagnóstico Una aspiración temprana del Comité fue la diferenciación de los tipos de personalidad a lo largo de la dimensión de la severidad; Desafortunadamente, los criterios para tales distinciones nunca se desarrollaron. En lugar de dibujar discriminaciones de severidad, según lo propuesto tanto en Kernberg como a Millon, los asociados del Grupo de Tarea agruparon los síndromes de la personalidad en tres grupos sintomatológicos. El primero incluye los trastornos paranoicos, esquizoides y esquizotipales, unificados como un grupo en que sus comportamientos parecen extraños y excéntricos. El segundo grupo subsume los trastornos sustrionales, narcisistas, antisociales y fronterizos, agrupados sobre la base de su tendencia a comportarse dramáticamente, emocionalmente o erráticamente. El tercer grupo de grupos las personalidades evitantes, dependientes, compulsivas y pasivas, en los terrenos, que estos tipos a menudo aparecen ansiosos o temerosos. Una nota distribuida por el autor [es decir, Millon] para la discusión en la reunión del Grupo de trabajo de junio de 1978 abordó estos grupos recomendados de la siguiente manera: Nunca entendí la importancia de aquellas dimensiones que nos llevaron a los trastornos de la personalidad de agrupación de la manera descrita. Cualquier número de dimensiones diferentes podría haber sido seleccionada para agrupar los once trastornos de personalidad en cualquiera de un número casi infinito de disposiciones de conjuntos o comodidades. Por qué se seleccionó el específico en el texto que se seleccionó de estos no está claro para mí. ¿Tiene algún significado pronóstico, alguna importancia etiana, lógica en términos de un modelo teórico deductivo? Si tuviera que desarrollar un grupo de racimo o factorial para los trastornos de la personalidad, estoy seguro de que obtendría un esquema diferente al que se sugirió. Las características especificadas son lo suficientemente claras, pero de qué valor sepa que tres son "excéntricas", que cuatro son "emocionales /" y que cuatro aparecen "ansiosos". Mi propia preferencia sería para

dejar caer la agrupación por completo y enumerarlos alfabéticamente o para agruparlos. En términos de su prevalencia conocida o severidad potencial. (1981, p. 63) Millon luego compara sus puntos de vista con la mía, señalando con precisión que le doy la atención primaria. . . A las características estructurales internas de la personalidad, mientras que para Millon, el sistema social externo y la dinámica interpersonal reciben un estatus igual a la de la organización interna "(Millon, 1981, p. 63). En el lado positivo de este sector con preocupaciones de Trastornos de la personalidad en DSM-III, las descripciones del trastorno de personalidad paranoico y del trastorno de la personalidad narcisista son esencialmente satisfactorias. El primero de ellos es una buena ilustración de una descripción clásica de Psy Chiatría clínica que ha mantenido su utilidad clínica independientemente de las diversas concepciones teóricas de su etiología, psicopatología y tratamiento. La descripción del trastorno de personalidad narcisista incluye contribuciones recientes de estudios psicoanalíticos y reconocimientos de los criterios descriptivos. Derivado de investigaciones clínicas orientadas psicoanalíticamente. La única omisión se menciona de estos pacientes.

La clasificación de los trastornos de la personalidad 93 fuertes conflictos en torno a la envidia, tanto conscientes como inconscientes, y los grados de severidad clínica. La descripción del trastorno de la personalidad antisocial se basa en gran medida en el trabajo de Robins (1966), quien fue miembro del Comité Asesor sobre Trastornos de Personalidad del Grupo de trabajo DSM-III. Estoy de acuerdo con Frances (1980), también miembro de ese Comité, quien ha declarado: "Los criterios de diagnóstico DSM-III que especifican la personalidad antisocial se requieren claro y confiables y han sido los más cuidadosamente estudiados..., Pero pueden haber perdido El punto clínico más importante. Uso de crite-ria comparable a los DSM-III, aproximadamente el 80% de todos los delincuentes se diagnostican como antisociales / 'Frances Luego apunta a la ausencia de DSM-III de dichos criterios clínicos cruciales como" el individuo Capacidad de lealtad a otros, culpabilidad, ansiedad anticipada y aprendizaje de experiencias pasadas "(p. 1053). Ya me he referido brevemente al diagnóstico del trastorno de personal esquizoide, que es esencialmente aceptable, pero es algo impulso por no se incluye la consideración de las contribuyentes contemporáneas al estudio de las características clínicas y dinámicas de los pacientes con tal trastorno (Fairbairn, 1954; Guntrip, 1968; Rey, 1979). Las personalidades esquizoides pueden experimentar un agudo La conciencia de su entorno circundante, una extenuación emocional de los demás, y sin embargo, un sentido de la desdicha de los sentimientos. En contraste con lo que los Estados DSM-III (p. 310), muchos de ellos no son "sin humor ni aburridos y sin afectar en situaciones en las que una respuesta emocional sería apropiada", y experimentarían sufrimientos muy intensos debido a su falta de fácil acceso a sus sentimientos por los demás. Sin embargo, para fines prácticos, la categoría diagnóstica permite el diagnóstico clínico de este tipo común de trastorno de personalidad. En otros lugares (1976), he sugerido una clasificación de la pafestología de personajes basada en

criterios psicoanalíticos, psicostructurales. En un resumen altamente simplificado, esta clasificación concibe de un tipo de patología de carácter de alto nivel o neu-rotico, incluida, predominantemente, las personalidades histerizantes, obsesivas, compulsivas, obsesivas y depresivas y masoquistas; un nivel intermediario de patología de caracteres que incluye las mejores personalidades narcisistas de funciones, algunas personalidades infantiles y personalidades a paso agresivo; y una "Organización de Personas de Nivel inferior" o "Border-Línea" que incluye la mayoría de los casos de personalidades infantiles y narcisistas y prácticamente todas las personalidades esquizoides, paranoicas y hipomanácidas, además de las personalidades "como si" y todas las personalidades antisociales. Los criterios descriptivos-fenomenológicos de los diversos tipos de patología de caracteres y los criterios estructurales de la organización de la personalidad límite, fortalecen mutuamente la precisión del diagnóstico clínico y tienen relevancia pronóstica y terapéutica. Creo que, en resumen, que la clasificación DSM-III de la personalidad desorientada.

94 Consideraciones de diagnóstico Ders requiere revisión. Es notable cuántos problemas de diagnóstico han sido creados por esta sección relativamente pequeña del sistema de clasificación DSM-III y cómo se han ignorado los criterios y objetivos descritos en la introducción a DSM-III. Se ha introducido una nueva terminología por razones que no están claras; La experiencia clínica y las necesidades de los médicos han sido descuidados; y las categorías superpuestas se han incluido innecesariamente, mientras que las constelaciones esenciales faltan. DSM-III no es, por supuesto, único en las clasificaciones problemáticas; Hubo problemas significativos con DSM-I y DSM-II también. Si bien podemos esperar que DSM-IV mejore los asuntos, solo es realista esperar nuevos problemas junto con nuevas soluciones. En la parte inferior, el campo está en flujo, y los sesgos teóricos fuertes y conflictivos encuentran la expresión en las maniobras políticas activadas por el método burocrático por el cual se producen DSM. Para una efectividad máxima a la luz de nuestro conocimiento actual, una clasificación óptima de los trastornos de la personalidad debe incluir tanto un enfoque categórico para los diferentes tipos de constelaciones de personalidad como un enfoque dimensional que se refiere al grado de gravedad de estos trastornos y las relaciones internas de la subgrupos entre sí.

Parte Dos: Tratamiento de Personalidades Borderline

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

CAPÍTULO 6: Psicoterapia expresiva Antecedentes teóricos Debido a que los principales contribuyentes al estudio del tratamiento psicoterapéutico de las condiciones fronterizas gravitan hacia una definición amplia de la personalidad de bordes, los pacientes que escriben sobre pueden clasificarse en los diferentes encabezados en DSM-III y por Investigadores que tienden a preferir una definición más estrecha. Kinsley (1980) y Masterson (1976, 1978, 1980), por ejemplo, se requieren principalmente con pacientes que, en mi opinión (véase el capítulo 5), corresponden a la personalidad infantil. Sus pacientes también parecen corresponder con el concepto de Trastorno de la personalidad de Gunderson (1977, 1982) y con lo que DSM-III designa el trastorno de personalidad histriónico y el trastorno de la personalidad límite. Rosenfeld (19793) Focuses sobre todo en pacientes con límites con características predominantemente narcisistas y paranoicas, comparables a lo que describe DSM-III en los criterios para el trastorno de la personalidad narcisista y el trastorno de personalidad paranoico. Fairbairn (1954) y Rey (1979) se enfocan principalmente en las características esquizoides de las condiciones fronterizas características de los trastornos esquizoides y de la personalidad esquizoides en DSM-III. En resumen, la literatura sobre la psicoterapia intensiva de las condiciones fronterizas cubre un espectro de psicopatolina relacionada con varios tipos de patología de caracteres o trastornos de la personalidad. En mi opinión, todos estos tipos comparten las características estructurales de la Organización de la Personalidad Borderline; En opinión de los otros autores citados, comparten genéticos comunes (en un sentido psicoanalítico) y características de desarrollo. Mahler (1971, 1972; Mahler y Kaplan, 1977) ha proporcionado marcos clínicos y teóricos para estas características genéticas y de desarrollo. Todas las descripciones clínicas en las obras de los psicoteristas mencionados y en las obras de otros que han llevado a cabo intenciones.

98 Tratamiento de las personalidades límite para la psicoterapia siva con pacientes con límites incluyen características comunes a los pacientes con patología fronteriza (Winnicott, 1958, 1965; Bion, 1967; Khan, 1974; Volkan, 1976; Green, 1977; Poco, 1981). Con la excepción de BION, estas autoridades hacen una distinción entre la forma en que tratan a los pacientes con límites y la forma en que tratan a pacientes neuróticos, pacientes con patología de caracteres de noborderina y psicóticos. En otros lugares, he intentado sintetizar las características clínicas de los pacientes límite, en el proceso que desarrolla un marco explicativo de referencia, una teoría de relaciones de objetos psicostructurales, que vincula sus características descriptivas y estructurales con sus desarrollos de transferencia y el proceso psicoterapéutico. (1975, 1976, 1980). Los psicoanalistas y los psicoterapeutas mencionados han alcanzado conclusiones similares a las mías: la teoría de las relaciones de objetos constituye un marco de referencia valioso y proporciona una formulación explicativa tanto para las características clínicas de estos pacientes y su proceso psicoterapéutico. En el pasado, bajo la influencia del trabajo pionero de Knight (19533), el tratamiento considió óptimo para los pacientes con límites era de apoyo a la psicoterapia. Sin embargo, gradualmente, muchos médicos que trabajaron intensamente con los pacientes abordores se trasladaron a un enfoque psicoterético psicoanalítico (o expresivo) para la mayoría de esos pacientes. El psicoanálisis no modificado aún se consideraba posible para algunos pacientes. El Proyecto de Investigación de Psicoterapia de la Fundación de Menninger (Kernberg et al., 1972) intentó comparar los efectos de la psicoanalírea, la psicoterapia expresiva y la psicoterapia de apoyo, el espectro de los neumáticos de lo psicoanalíticamente derivado. Psicoterapias: para pacientes con "buena fuerza del ego" (en su mayoría patología de caracteres neuróticos y neurosis sintomáticos) y aquellos con "debilidad del ego" (patología de caracteres límite). Los resultados de la investigación

llevaron a la conclusión de que el mejor tratamiento para los pacientes con debilidad del ego puede ser un enfoque expresivo, con poca estructura proporcionada durante las horas de tratamiento y la mayor hospitalización concomitante (estructuración ambiental) como las necesidades pacientes. Este enfoque contrasta con un tratamiento puramente de apoyo, que proporciona una gran cantidad de estructura durante las horas de tratamiento, pero no el apoyo al hospital. Otros enfoques psicoterapéuticos derivados psicoanalíticamente para las condiciones del límite emplean más modificaciones de la técnica. Master-Son (1972, 1976, 1978), por ejemplo, ha diseñado una forma especial de psicoterapia orientada a la resolución de la "depresión del abandono" y la corrección y reparación de los defectos del ego que acompañan a la fijación oral narcisista. De estos pacientes alentando el crecimiento a través de las etapas de la separación, la individuación a la autonomía. Ha propuesto que la psicoterapia con los pacientes con límites que se inicie como apoyo y esa psicopoterapia intensiva, reconstructiva y psicoanalítica, generalmente es una expansión y superación de la psicología de apoyo.

Psicoterapia expresiva 99 Terapia. Masterson subraya la importancia de analizar las transferencias primitivas y ofrece una descripción ampliada de dos unidades de relaciones de objetos parciales divididas mutuamente (la unidad recompensa o libidinal, y la unidad de dibujo o agresivo), combinando así un punto de vista de relaciones de objeto con un modelo de desarrollo. Basado en el trabajo de Margaret Mahler. Rinsley (1977) y Puser (1977) son otros entre un creciente grupo de terapeutas orientados psicoanalíticamente que están combinando una teoría psico-estructural de relaciones de objetos con un modelo de desarrollo derivado del trabajo de Mahler (Mahler, 1971, 1972; Mahler y Purer, 1968; Mahler y Kaplan, 1977). Giovacchini (1975), Bergeret (1970), Green (1977), Searles (1977), y Volkan (1976) también han estado aplicando modelos derivados de la teoría de las relaciones de objetos. Searles se ha centrado particularmente en la comprensión de las características de la transferencia y los desarrollos de contrarrestación en el tratamiento del límite y los pacientes psicóticos. En Hartocollis (1978) y en Masterson (1978) y en Masterson (1978) se encuentran en Hartocollis (1978) y en Masterson (1978). Considerando que los autores estadounidenses basan su enfoque esencialmente en un modelo de psicología del ego que incorpora los recientes encontraciones de desarrollo y las teorías de las relaciones de objetos psicostructurales, la Escuela Británica de Psicoanálisis (originalmente identificada con ciertas texiones de relaciones de objetos) ha seguido Influir en los enfoques técnicos para los pacientes con límite. El trabajo de Little (1957, 1960, 1966) se centró principalmente en la técnica. Aunque asumió que la mayoría de los pacientes que describían eran abordores, su implicación de que estos pacientes presentaron una falta de diferencia entre el yo y el objeto y sus propuestas técnicas para ayudarlos a desarrollar una sensación de singularidad y la separación parecía centrarse en la patología de la diferenciación temprana. Surfase de separación - individuación. Sus

puntos de vista están algo relacionados con los de Winnicott, pero sus pacientes parecen estar más regresados que los que describió. Winnicott (I960B) destacó la necesidad del terapeuta de permitir que el paciente desarrolle su "verdadero yo" al evitar "imponerse" sobre él en ciertas etapas de regresión terapéutica. La función óptima del terapeuta en estas condiciones, dijo, fue como un objeto de "tenencia", similar a la maternidad básica para los pacientes que carecían de la maternidad normal. En tales humos, sugirió Winnicott, se produce una regresión silenciosa a lo que equivale a una forma primitiva de dependencia del analista experimentada como una "madre sostenida". Winnicott pensó que la presencia intuitiva y empática de la comprensión empática del analista era más útil que los efectos inquietos y intrusivamente experimentados de la interpretación verbal. Este concepto está relacionado con la teoría de Bion (1967) que la intuición intuitiva de la madre (BION lo llama "Reverie") le permite incorporar las experiencias primitivas fragmentadas de la fragmentación y proyectadas del bebé en los puntos de frustración y para integrarlos. Por medio de su intuición.

 La comprensión de la predicamento total del bebé en ese momento. La información de la madre, dice Bion, por lo que actúa como un "contenedor" que organiza el "contenido". De manera similar, los elementos dispersos, distorsionados y patológicos de la experiencia del paciente retrocedido se proyectan en el analista para que el paciente pueda usarlo como un organizador "contenedor", uno podría decir, de lo que el paciente no puede tolerar la experiencia en sí mismo. En resumen, tanto Winnicott como Bion, la capacidad del terapeuta que trabaja con los pacientes con límites para poder integrar aspectos cognitivos y emocionales en su comprensión de la situación terapéutica, con BION se centra en el aspecto cognitivo ("que contiene") en contraste con El énfasis de Winnicott en el emocional ("Holding") uno. Una fuente de alguna confusión en la literatura es que algunos que escriben en la psicoterapia de la personalidad límite tienden a no diferenciar la psicoterapia expresiva del psicoanálisis. Para mí, parece que estos escritores, para el ejemplo, Giovacchini (1978), Little (1981), Searles (1979), y Win- Nicott (1958, 1965), modificarán con suficiente, en cambio de su técnica para que lo que hagan en la práctica. No es psicoanálisis estándar. La ventaja, creo, de distinguir claramente entre la psicoterapia expresiva y el psicoanálisis es que permite una delimitación más aguda de un enfoque psicoterapéutico específico para los pacientes con límites. Sin embargo, esta revisión estaría desequilibrada, si no mencionara que la práctica clínica a menudo se desvía del tratamiento expresivo se recomienda en la mayor parte de la literatura. Un gran número de pacientes límite, quizás la mayoría, se tratan con una mezcla de técnicas expresivas y suministrativas o en una modalidad de tratamiento que emplea sesiones infrecuentes (una a la semana o menos), lo que significa un cambio de una modalidad externa prevista para un Modalidad de apoyo. La respuesta clínica a la intervención de crisis y la breve hospitalización, junto con una estructura ambiental

clara y firme, indica que un enfoque de apoyo es efectivo, al menos en tipos de psicoterapia a corto plazo. Otra observación clínica cotidiana es que muchos pacientes límite se mantienen a una base ambulatoria mediante una relación psicoterapéutica de apoyo a largo plazo. La literatura específica sobre la psicoterapia de apoyo de las condiciones fronterizas es muy escasa. Los enfoques de apoyo "puramente" anteriormente recomendados por Knight (I953B) y Zetzel (1971), y aún se han defendido por GRINKER (1975), ya que he notado, a la recomendación de que se usan técnicas de apoyo solamente. Para las etapas iniciales de la psicoterapia psicológica con tales condiciones (Masterson, 1978). Adler y Buie (1979), Modell (1976), y Volkan (1979) enfatizan los efectos de apoyo de la función de tenencia del terapeuta, pero proponen una técnica esencialmente expresiva para los pacientes con límites desde el inicio del tratamiento.

Psicoterapia expresiva 101 Sobre la base de los hallazgos del proyecto Menninger, he propuesto rechazar la asunción tradicional de Knight (I953B) y Zetzel (1971), entre otros, que cuanto más distorsionado o más débil el ego del paciente., Cuanto más apoye el tratamiento que necesita (Kernberg, 1975). También cuestiono la larga tradición de mezclar técnicas expresivas y suportativas, particularmente con la organización de personalidad límite. La observación clínica consistente es que el uso de técnicas de apoyo elimina la neutralidad técnica y, por la misma muestra, elimina la posibilidad de interpretar la transferencia. Debido a que el paciente límite induce en las fuertes corrientes emocionales del terapeuta que tienden a hacer que el terapeuta abandone una posición de neutralidad técnica, la interpretación de estas áreas de transferencia central se vuelve imposible. Al mismo tiempo, el terapeuta, en un esfuerzo por mantener una actitud esencialmente analítica, mientras que mezcla técnicas expresivas y de apoyo, tiende a contenerse a sí mismo o a sí misma en el uso de medidas de apoyo, lo que debilita tanto las características expresivas como de la psicoterapia. Utilizando las especificaciones de Gill (1954), se puede definir la técnica del psicoanálisis por parte de la adherencia constante a la posibilidad de una posición de neutralidad técnica; (2) Uso consistente de la interpretación como herramienta técnica; y (3) facilitación del desarrollo de una neurosis de transferencia de pleno derecho y de su resolución psicoanalítica únicamente por interpretación. De hecho, un espectro de psicoterapias psicoanalíticas que van desde psicoanálisis a psicoterapias de apoyo se pueden diferenciar en términos de estas tres características básicas. Lo que sigue es una descripción de la psicoterapia externa para pacientes con organización de personalidad límite. Técnica de psicoterapia expresiva La psicoterapia expresiva para las condiciones fronterizas se puede describir en términos de variaciones en los tres elementos técnicos de Gill. Debido a que las transferencias primitivas están disponibles de

inmediato, predominan como resistencias, y de hecho determina la gravedad de los disturbios intrapsíquicos e interpersonales, el terapeuta puede y debe centrarse en ellos de inmediato, comenzando al interpretarlos en el aquí y ahora. La reconstrucción genética debe intentarse solo a las etapas tardías del tratamiento, cuando las transferencias primitivas determinadas por las relaciones entre objetos parciales se han transformado en transferencias de nivel superior o relaciones totales de objetos. En ese momento, las transferencias se acercan a las experiencias más realistas de la infancia que se prestan a tales reconstrucciones. La interpretación de la transferencia requiere mantener una posición de neutralización técnica, ya que las transferencias primitivas no se pueden interpretar sin un mantenimiento firme, consistente y estable de los límites de la realidad en la THERA-

102 Tratamiento de personalidades límite Peutic Situación. El terapeuta también debe estar siempre alerta a la posibilidad de ser absorbida en la reactivación de las relaciones patológicas patológicas del paciente. En la medida en que tanto la interpretación de la transferencia como la posicion de la neutralidad técnica requieren el uso de aclaraciones e interpretación y contraindice, el uso de técnicas sugerentes y manipulativas, aclaración e interpretación son las técnicas principales. Sin embargo, el análisis de la transferencia, en contraste con el psicoanálisis, no es sistemático. El análisis de la transferencia debe centrarse tanto en la gravedad de actuar y en las perturbaciones en la realidad externa del paciente, que puede amenazar la continuidad del tratamiento, así como la supervivencia psicosocial del paciente. Debido a esto y también porque el tratamiento, como parte de la actuación de las transferencias primitivas, se produce fácilmente para reemplazar la vida, la interpretación de la transferencia debe estar codeseminada por tres conjuntos de factores: (i) los conflictos que predominan en la realidad inmediata; (2) los objetivos específicos generales del tratamiento, así como la diferencia consistente de los objetivos de vida de los objetivos de tratamiento (TICHO, 1972); y (3) lo que prevalece de inmediato en la transferencia. Además, la neutralidad técnica está limitada por la necesidad de establecer parámetros de técnica (Eissler, 1953). En ciertos casos, tales parámetros incluyen la estructura en la vida externa de los pacientes que no pueden funcionar de manera autónoma durante largos períodos de su psicoterapia. La neutralidad técnica es, por lo tanto, una línea de base teórica a partir de la cual se producen desviaciones una y otra vez, se reducirá por la interpretación. La interpretación del terapeuta de la comprensión del paciente (o malentendidos) de los comentarios del terapeuta es un aspecto importante de este esfuerzo para reducir las desviaciones de la neutralidad técnica. Con estas precauciones y observaciones en mente, los tres elementos esenciales técnicos y sus efectos específicos sobre la

organización de la personalidad límite se pueden examinar con mayor detalle. Interpretación La interpretación es una herramienta técnica fundamental en la psicoterapia psicoanalítica con pacientes con límites. De hecho, como he notado anteriormente, para proteger la neutralidad técnica tanto como sea posible, la sugerencia y la mainipulación están prácticamente contraindicados aquí. Se realiza una excepción cuando el potencial de actuación severa requiere estructurar la vida externa del paciente y usar un enfoque de equipo, lo que implica establecer límites y otras intervenciones en el campo social. Dichos esfuerzos de estructuración social e intervención deben considerarse parámetros de la técnica, que se interpretarán tan pronto y de la manera más completa posible para que puedan disolverse gradualmente. Algunos han cuestionado si los pacientes con enfermedad psicológica grave y debilidad del Ego pueden responder a la interpretación. Haz estos pa-

Psicoterapia expresiva 103 pacientes ¿Acepta las interpretaciones debido a su significado real o causa de sus significados mágicos de transferencia? La evidencia empírica indica que los pacientes con enfermedad psicológica grave pueden comprender e integrar los comentarios interpretativos del terapeuta, particularmente si sus distorsiones de estas interpretaciones son examinadas e interpretadas a su vez (FROSCH, 1970). En otras palabras, la dificultad del paciente en la integración de las comunicaciones verbales es en sí misma un producto de las operaciones defensivas primitivas, y esta dificultad puede interpretarse, particularmente a medida que las operaciones defensivas se activan en las reacciones del paciente a las interpretaciones del Thera-Pist. Sin embargo, como resultado del hecho de que las interpretaciones del paciente de las interpretaciones del terapeuta deben explorarse tan plenamente, la clarificación tiene prioridad sobre la interpretación. Esta demanda técnica crea diferencias cuantitativas entre la psicoterapia expresiva y el psicoanálisis. Mantenimiento de neutralidad técnica Esta es una herramienta técnica esencial, un requisito previo indispensable para el trabajo intermitente. La neutralidad técnica de ninguna manera excluye la empatía. Hay momentos en que la agresión regresiva del paciente en la transferencia produce reacciones contraagresivas en el terapeuta. En tales circunstancias, la neutralidad técnica depende de la capacidad emocional del terapeuta para mantener una actitud empática o una acción de "tenencia" (Winnicott) y su capacidad cognitiva para integrar o "contener" (bion) las transferencias expresadas fragmentalmente. Neutralidad técnica significa mantener una distancia igual de las fuerzas que determinan los conflictos intrapsíquicos del paciente, no la falta de calor o empatía. Uno todavía escucha comentarios que implican que los pacientes límite necesitan, en primer lugar, la comprensión empática en lugar de una teoría enfocada y las interpretaciones cognitivamente afiladas basadas en tal esfuerzo. Toda la

psicoterapia requiere como mínimo la capacidad del terapeuta para la auténtica calidez y empatía. Pero la empatía no es solo la conciencia emocional intuitiva del terapeuta de la experiencia emocional central del paciente en cierto punto; También debe incluir la capacidad del terapeuta para empatizar con lo que el paciente no puede tolerar dentro de sí mismo. La empatía de la Thera-Peutica, por lo tanto, trasciende a las interacciones humanas ordinarias. También incluye la integración del terapeuta, sobre un nivel cognitivo y emocional, de lo que se disocia o se divide activamente en pacientes con bordes. Sin embargo, el potencial del paciente para actuar severos, el desarrollo de situaciones de la vida o el tratamiento que amenazan, o ambas pueden requerir estructuración, no solo de la vida del paciente, sino de las sesiones de la psicoterapia. La neutralidad técnica se interesa constantemente con, amenazada o limitada, y una buena parte de los esfuerzos del terapeuta.

104 El tratamiento de las personalidades límite deberá concentrarse en volver repetidamente. Nuevamente, esta reducción de la neutralidad técnica representa una diferencia cuantitativa del psicoanálisis propio. La desviación del terapeuta de la neutralidad técnica en forma de comportamiento diurnetario puede ser de tal intensidad y / o duración que la neutralidad técnica no se pueda lograr o recuperar. Se han establecido modificaciones, en lugar de pa-rameters. En circunstancias óptimas, la interpretación gradual de las desviaciones temporales de la neutralidad técnica permite una reversión a una postura neutral, que maximiza la posibilidad de la interpretación de la transferencia y la resolución de transferencias primitivas. Análisis de transferencia Como se mencionó anteriormente, la interpretación de la transferencia es limitada en la psicoterapia expresiva y está codeterminada por un enfoque constante en la realidad inmediata de la vida del paciente y los objetivos de tratamiento final. Además, porque la interpretación de la transferencia primitiva conduce gradualmente a la integración de las relaciones de objetos parciales en las relaciones totales de objetos y, por la misma ficha, a una transformación de la transferencia primitiva a una transferencia avanzada o neurótica, ocurren cambios relativamente repentinos en la transferencia. De pacientes límite. Las transferencias más neuróticas o avanzadas, que reflejan desarrollos infantiles más realistas, aparecen al principio con poca frecuencia y luego con una frecuencia creciente a lo largo del tratamiento. El cambio de fases de transferencia a lo largo del tratamiento proporciona una atemporalidad general a las reconstrucciones genéticas e interfiere con su colocación histórica. Por lo tanto, la transferencia debe interpretarse en un modo "como si" atemporal "como" durante períodos de tiempo extendidos, una razón adicional para considerar la interpretación de la transferencia en estos casos como menos sistemáticas, y, por lo tanto, diferente de la interpretación de la transferencia en la situación psicoanalítica estándar. Sin

embargo, la interpretación de las constelaciones defensivas en estas condiciones es sistemática. En contraste con la psicoterapia exploratoria con pacientes mejor funcionales, donde ciertas defensas pueden interpretarse seleccionadas y otras no tocadas, la interpretación sistemática de las defensas en la psicopatología severa es crucial para mejorar la función del ego y la transformación y la transformación. Resolución de transferencias primitivas. La interpretación de la constelación de las operaciones defensivas primitivas que se concesiona, por lo tanto, debe ser lo más consistente posible, dada su predominio en la transferencia del paciente y en sus relaciones extratherianas. Directrices para la gestión de la transferencia porque la interpretación de la transferencia desempeña tan vital una parte en la psicoterapia expresante con los pacientes con límites, he reservado una descripción.

Psicoterapia expresiva 1055 ión de la estrategia y tácticas que recomiendo para un capítulo separado (cap. 7). Aquí ofrezco directrices más generales. 1. La transferencia predominantemente negativa de estos pacientes debe ser elaborada sistemáticamente solo en el aquí, y ahora, sin intentar alcanzar reconstrucciones genéticas completas. Con los pacientes límite, la falta de integración del autoconcepto y la falta de diferencia e individualización de objetos interfieren con la capacidad de diferenciar las relaciones presentes y de objetos pasados. Los pacientes confunden la transferencia y la realidad y no pueden diferenciar al terapeuta del objeto de transferencia. Las reconstrucciones genéticas completas, por lo tanto, deben esperar etapas avanzadas del tratamiento. Una interpretación genética prematura (por ejemplo, "reaccionas a mí de esta manera porque ves en mí la actitud de tu madre en tu pasado") puede provocar una condensación del pasado y el presente ("Tienes razón, y es terrible que, después de haber tenido una madre, tengo que tener un terapeuta exactamente como ella"). 2. Las constelaciones defensivas típicas deben interpretarse a medida que ingresan a la transferencia, ya que su interpretación fortalece el ego del paciente y produce un cambio intrapsíquico estructural, lo que contribuye a resolver la organización de la personalidad límite. Los deficientes del ego primitivo no fortalecen el ego del paciente, ¡sino lo debilitan! Su interpretación sistemática, por lo tanto, tiene poderosos efectos "de apoyo". 3. Los límites deben establecerse para bloquear la actuación de la transferencia, con la mayor estructuración de la vida del paciente fuera de las sesiones, como sea necesario para proteger la neutralidad del terapeuta. Aunque a veces se necesita interconecciones en la vida externa del paciente, la neutralidad técnica del terapeuta es esencial para el tratamiento. Además, es importante evitar la relación terapéutica, con su naturaleza gratificante y protegida, para reemplazar la vida ordinaria para que el paciente pueda satisfacer sus necesidades patológicas primitivas al actuar la transferencia durante y

fuera de las sesiones. El terapeuta debe estar alerta a esta ganancia de tratamiento secundaria, estar dispuesto a interpretarlo y, si se requieren límites externos, intente utilizar sistemas de apoyo social auxiliares (un trabajador social, enfermera, consejero y otros) en lugar de intervenir directamente en el paciente. Fuera de la vida y así eliminar la neutralidad técnica. 4. Los aspectos modulados menos determinados, de la transferencia positiva no deben interpretarse. Respetar estos aspectos de la transferencia fomenta el desarrollo gradual de la alianza terapéutica. Con los pacientes fronterizos, el enfoque en la interpretación debe estar en las idealizaciones primitivas, gravemente exageradas que reflejen la división de "todo bien" de las relaciones de objeto "todo mal". Estos deben interpretarse sistemáticamente como parte del esfuerzo para trabajar a través de los productos primitivos. La transferencia negativa debe interpretarse tan plena como sea posible. Este es el principal vehículo para fortalecer indirectamente la alianza terapéutica mientras se ocupa directamente con los conflictos primitivos alrededor

106 Tratamiento de las personalidades límite Agresión e intolerancia de la ambivalencia Característica de los pacientes límite. 5. Las interpretaciones deben estar formuladas así que las distorsiones del paciente de las intervenciones del terapeuta y de la realidad actual, especialmente las percepciones distorsionadas del paciente en la hora, se pueden aclarar sistematics. En otras palabras, la utilización mágica del paciente de las interpretaciones del terapeuta requiere la interpretación. Por ejemplo, la tendencia del paciente para escuchar la "cantidad" de la comunicación verbal de la Thera-Pistada en lugar de prestar atención a su contenido debe interpretarse constantemente. Además, es indispensable que las interpretaciones se basen en un marco de la realidad compartida por el paciente y el terapeuta: no puede haber interpretación de motivaciones inconscientes antes de que el paciente pueda estar de acuerdo con el Thera-Pist sobre lo que es la realidad en su interacción. ¡Solo se pueden interpretar las distorsiones de la realidad distónica al ego! La estrategia de interpretar la transferencia con los pacientes límite puede concebirse como lo que requiera tres pasos consecutivos, lo que representa, en esencia, la secuencia involucrada en el trabajo a través de las transferencias primitivas y su transformación en transferencias avanzadas o neuróticas. Transferencias primitivas Expresan relaciones de objeto de partes: es decir, unidades de aspectos de "saltado" del auto concepto relacionado con los aspectos de "división" de las representaciones de objetos en el contexto de un enlace primitivo afectivo de las representaciones de sí mismo y objetos. Las transferencias avanzadas o neuróticas involucran representaciones integradas o totales y de objetos, y reflejan más de cerca la experiencia real en la infancia. El primer paso consiste en un esfuerzo para reconstruir, sobre la base de la comprensión gradual del psicoterapeuta, la naturaleza de la relación primitiva o "parcial" que se ha activado en la transferencia. El terapeuta debe evaluar lo que, en cualquier punto, de los bits contradictorios de la comunicación verbal y

de comportamiento de los pensamientos, las sensaciones y las expresiones confundidas y confusas del paciente, es de relevancia emocional predominante en la relación actual del paciente con él. O ella. En otras palabras, el terapeuta, a través de la interpretación, transforma la inutilidad prevalente o la inutilidad en la transferencia, lo que literalmente equivale a una deshumanización de la relación terapéutica, en una relación emocionalmente significativa, aunque altamente distorsionada y fantástica.. En la práctica, el terapeuta usa sus propias fantasías, intuición y conocimiento previo del paciente para construir una interacción humana básica, extraña o extraña o poco realista, ya que puede aparecer, que se aproxima de manera óptima la fantasía central o la fantasía activada en la corriente. Situación terapéutica. Como segundo paso, el terapeuta evalúa esta relación de objeto predominante de cristalización en la transferencia en términos de la representación de autospresentación y objetos involucrada y aclara el efecto de la interacción correspondiente del yo y el objeto. El terapeuta puede representar un aspecto del auto y / o un objeto primitivo disfrazado del paciente.

Psicoterapia expresiva 107 Sentamiento, y paciente y terapeuta pueden intercambiar su promulgación de la representación de uno mismo u objeto. Estos aspectos de las representaciones de auto y objetos deben interpretarse, y la relación de objetos internos respectivos debe aclararse en la transferencia. En la práctica, la reacción del paciente a, la aclaración y las asociaciones derivadas del esfuerzo del terapeuta para describir lo que parece estar ocurriendo entre ellos en este momento, conduzca a enriquecimiento gradual y aclaraciones de "quién está haciendo qué con quién", o quién está experimentando qué es lo que está experimentando. A quién ", en esta fantástica relación con los objetos en la transferencia, y" etiquetar "los representantes de sí mismo y objetos del paciente a través de ciclos de proyección y reintroyección. Como tercer paso, la relación de objeto parcial particular activada en la transferencia debe integrarse con otras relaciones de objeto de partes, reflejar otras relaciones de objetos parciales relacionados y contradictorios, relacionados y contradictorios, hasta que la concepción real y la concepción interna de los objetos del paciente se puedan integrar y consolidado. En este proceso, los aspectos positivos y negativos del auto concepto están vinculados y se integran simultáneamente con los aspectos positivos y negativos correspondientes de las representaciones de objetos del paciente. La integración de las representaciones de sí mismo y de objetos, y por lo tanto, de todo el mundo de las relaciones de objetos internalizadas, es un objetivo estratégico importante en el tratamiento de los pacientes con la organización de personalidad límite. La integración de los afectos del paciente con, sus relaciones fantásticas o reales con objetos significativos es otro aspecto de este trabajo. Las disposiciones afectadas por el paciente reflejan la inversión libidinal o agresiva de ciertas relaciones de objetos internalizados, y la integración de los estados afectados fragmentados y fragmentados es un corolario de la integración de las relaciones de objetos intercalados fragmentados

y fragmentados. Cuando se ha producido una resolución de transferencias primitivas, las disposiciones integradoras afectadas que luego emergen reflejan más derivados de accionamiento coherentes y diferenciados. Las representaciones de objetos integrados luego reflejan imágenes parentales más realistas según lo percibido en la primera infancia. En este punto, se le puede ayudar a que el paciente limítrofe se le ayudará a llegar a un acuerdo con el pasado de manera más realista, en el contexto de las profundas transformaciones en su relación con el terapeuta y a otros significativos en su vida actual. Consideraciones pronósticas Existen pocos estudios de pronósticos sistemáticos de la psicoterapia a largo plazo de las condiciones fronterizas. Los hallazgos del proyecto Menninger indicaron que los pacientes con una fuerza del ego inicialmente baja, especialmente aquellos con inicialmente de baja calidad de las relaciones interpersonales, mostraron la menor importancia. Sobre la base de una evaluación clínica detallada de la población de pacientes de ese proyecto, sugiero que las características pronósticas incluyeron el tipo predominante de constelación de caracteres, cierto ego y super-

108 Tratamiento de las personalidades límite Las distorsiones del ego reflejadas en rasgos de carácter individuales, autodestructucación como formación de carácter, el tipo y la intensidad particular de las reacciones terapéuticas negativas, el grado y la calidad de la patología del superygo y la calidad del paciente. Relaciones de objetos (Kernberg, 1975). Hallazgos (inéditos) de Michael Stone en la evaluación de la distribución de los tipos de personalidad entre los pacientes de oficina fronterizos con respecto al resultado del tratamiento de acuerdo con las consideraciones de pronóstico que he sugerido. Los pacientes límite de los tipos de personalidad predominantemente histéricos, obsesivos, afectados, fóbicos, infantiles y pasivos tenían un resultado comparativamente exitoso. En contraste, la mayoría de los pacientes con límites con tipos de personalidad que eran predominantemente paranoicos, narcisistas, esquizoides, explosivos, hipomaníficos, inadecuados y antisociales terminados en la falla del tratamiento. Masterson (1980) destacó la importación pronóstica del grado de estrés de la vida temprana, el nivel de desarrollo de los Ego temprano, el grado de dominio de las tareas de desarrollo temprano y la efectacia de las relaciones sociales tempranas (relaciones de objeto). Aunque aparecen otras referencias pronósticas a lo largo de la literatura sobre la psicoterapia intensiva de las condiciones fronterizas, la evidencia con respecto a la mayoría de las características pronósticas postuladas aún no parece ser concluyente. Mi opinión actual es que los dos indicadores pronósticos más importantes son la presencia de características antisociales, que definitivamente empeoran el pronóstico para el tratamiento psicoterapéutico, y la calidad de las relaciones de objetos. Además, el desarrollo de reacciones terapéuticas negativas es una variable de proceso importante con importantes implicaciones negativas negativas. La importancia de otra personalidad y variables ambientales y de las técnicas, habilidades y personalidad de la técnica, así como su contraversa, todas requieren una investigación sistemática

adicional. La relación entre el proceso y el resultado de la psicoterapia a largo plazo, un factor crucial en la práctica clínica diaria, sigue siendo un área relativamente descuidados de la investigación de la psicoterapia. Una ilustración de caso El siguiente caso se enfoca en el desarrollo de patrones de transferencia que reflejan las relaciones internalizadas de las partes internalizadas y su transformación gradual en transferencias más avanzadas o neuróticas. También muestra el desarrollo de un importante cambio estructural intrapsíquico durante un período de cuatro años de psicoterapia expresiva, cuatro semillas a la semana. Miss L. Un artista latinoamericano en sus últimos años veintees presentó una organización de personalidad abordora con características masoquistas y esquizoides predominantes y una severa inhibición sexual, en la medida en que no pudo alcanzar el orgasmo en la masturbación. Sus fantasías sexuales fueron de mutilación de su propia y sus genitales de la pareja masculina fantástica en sexual.

Psicoterapia expresiva 109 coito. Ella había estado evitando estudiando cualquier verdadera participación con los hombres que ella encontró atractiva. En la transferencia, los siguientes patrones principales se desarrollaron secentemente durante los primeros cuatro años. Primero, deseaba que el terapeuta la violara y la matara en las relaciones sexuales porque solo en odio y la inflismo de la muerte podía encontrar el amor y el compromiso verdadero. Una imagen sádita, primitiva del padre oedípal, yacía en el núcleo de estas fantasías. Más tarde, se fantasía de ser el hijo dependiente de un padre maternal y se encontraba, si se le permitía chupar el pene del terapeuta, se cumplirían todas sus necesidades de calidez, amor, sexo y protección. Ahora deseaba que el terapeuta la sostenía cuando una madre sostiene a un bebé mientras ella chupaba su pene con su flujo interminable de semen o leche. Se quedó claro que una razón importante para su incapacidad de participar en las relaciones en profundidad con los hombres era su terror sobre la confusión de estas dos actitudes contradictorias y su terror de que su amor y odio se unirían en una situación insoportable de peligro: ella temía que ella ella El odio destruiría a ambos socios. Aún más tarde, en su tratamiento, cuando las fantasías sexuales sobre los hombres acordaban las cualidades más integradas, los temores de la señorita Les de los orgasmo surgieron como temores de "humedad incontrolable". No podía mostrar tristeza en las sesiones porque el llanto también significaba humedad incontrolable. El llanto, el gasm, y la orinar en momentos de entusiasmo sexual representaban la amenaza de pérdida de control, con una dependencia peligrosa de un objeto no confiable, su madre fría y frustrante. También temía que el orgasmo resultaría en una disolución de su personalidad en fragmentos impersonales. En resumen, el predominio de los mecanismos de división, el miedo a los conflictos relacionados con la frustración oral grave, y los peligros regresivos de la situación edípica bloquearon la emoción y el orgasmo sexual. En un momento aún más

tarde, la señorita L pude fantasear las experiencias sexuales más elaboradas con los hombres, en particular el terapeuta, que se centró en "se quede a sí misma" y orinar durante el orgasmo y que expresó sus anhelos por dependencia y gratificación sexual. De maneras más sintéticas. Ahora comenzó a salir con los hombres más libremente, participó en un gran esfuerzo con uno de ellos, y (tres años y medio después del tratamiento inicial) desarrollaron un bloqueo severo durante las sesiones, con largos períodos de silencio. También se dio cuenta de las prohibiciones internas contra cualquier mejora adicional o buenas experiencias con el terapeuta o a los hombres en general. Esto podría remontarse a un suminitivo primitivo de su superyergo de una naturaleza extremadamente sádica. Ahora se desarrolló un tipo primitivo de reacción terapéutica negativa, en la que surgió su presentación a una constelación de sumino sa-distérica, combinando la odiada y odiosa madre pregenital con el temido rival de edificación. Resultó que la fantasía anterior de un padre sádico representó un desplazamiento sobre él de esta misma imagen madre. Solo después de un trabajo prolongado a través de

110 Tratamiento de las personalidades límite Las presiones primitivas de su superego fue la señorita, finalmente, por primera vez, por primera vez en su vida, para establecer una relación sexual con un objeto de amor apropiado. ¿Cómo reflejan estos desarrollos de transferencia, reflejan un cambio estructural intra-psíquico significativo? El cambio del deseo del terapeuta para violarla y la mata al deseo de ser el hijo dependiente del polémonismo Padre, realmente reflejó una característica permanente de los conflictos de la señorita L's: su terror sobre la confusión de sus dos actitudes y temores contradictorios con respecto a los hombres.. Esta secuencia, luego, reflejó solo un patrón de relaciones de objetos internalizados, un patrón que cambió cuando se dio cuenta y capaz de tolerar el hecho de que su odio, sus deseos de muerte y temor de ser destruidos se dirigían hacia el mismo objeto en el que deseaba depender. En la transferencia, ella se puso capaz de temer y odiar al terapeuta, expresar la crítica de él, atacarlo y sospechar de él, y sin embargo, también expresar el anhelo y los sentimientos de calidez y dependencia de él. Su capacidad cada vez mayor para tolerar estas actitudes contradictorias le permitió superar esta importante constelación de transferencia y representaba la primera transformación en su patrón de transferencia, lo que refleja una transformación de una relación de objeto primitiva a una más integrada. Esta transformación se reflejó de manera conductual en una dininidad impresionante en la sospecha y temor de la señorita L sin el uso de la medicación. (Anteriormente había sido medicado masivamente por sus ataques de pánico, sin respuesta satisfactoria). La señorita L ahora podía hablar más, consistentemente, consistentemente, y pensativamente en las sesiones y comenzó a tomar los primeros pasos hacia relaciones más realistas y menos provocantes de miedo con otros gente. Se produjo una segunda transformación importante cuando la señorita L comenzó a describir sus fantasías y temores sexuales con más detalle en las horas; Esto se ocurre

en relación con su mayor tolerancia para disfrutar de los análisis genitales y dependientes en las relaciones fantásticas con el terapeuta y otros hombres. En este punto, ella comenzó a tener experiencias sexuales con hombres. También mejoró en sus actividades creativas y trabajando. Solo entonces surgió que una razón importante para su bloqueo en su trabajo artístico había sido las fantasías sexuales incontrolables que fueron desencadenadas por temas variables que intentaba explorar. Por ejemplo, una referencia a las diferencias entre hombres y mujeres inmediatamente evocó fantasías sexuales de penes y orinantes. Esta dificultad ahora disminuyó. Se produjo una tercera transformación importante en el momento de los bloqueos graves en las sesiones y la reacción terapéutica negativa relacionada con la activación de un introjecto primitivo de suupego materno. Superar este patrón de transferencia principal, lo que vuelve a reflejar una relación de objetos primitivos, permitió que la señorita L se convierta en objetivamente más independiente de ella

Psicoterapia expresiva 111 padres, separados de los valores de su madre y se volverán más afirmativos en su vida diaria. Debería destacar que muy poca información sobre estos problemas estaba disponible al inicio del tratamiento. El paciente había consultado por ansiedad y depresión grave y crónica, la desglose en su funcionamiento social, la incapacidad de desempeñarse en su trabajo artístico y en varios intentos de suicidio. Los esfuerzos psicoterapéuticos anteriores habían fracasado. Las sesiones con terapeutas anteriores (todos ellos hombres) habían consistido en silencios largos y estupenciales. Solo en retrospectiva, fue posible diagnosticar la naturaleza del bloqueo en las experiencias terapéuticas anteriores: se relacionó con la activación de las mismas fantasías sexuales primitivas que aterrorizaron al paciente. Su comportamiento negativo, sus terapeutas anteriores reflejaron el deseo de provocar ataques y castigo sexuales de los hombres y se castigacan por sus esfuerzos para superar sus problemas, es decir, para revelar contra el introjecto de la madre primitiva. Estas necesidades han motivado a sus intentos de suicidio, que habían interferido y se han complicado los esfuerzos de tratamiento previos. Para enfatizar nuevamente mi punto principal: en este caso, se necesitó un tiempo considerable con varios desarrollos de transferencia para diagnosticar la secuencia significativa de las relaciones de objetos internalizados que constituyeron conjuntamente una constelación persistente en la transferencia. Tomó aún más tiempo para lograr una transformación significativa de estas principales constelaciones en la transferencia. Esta transformación fue una condición previa para lograr un cambio en otras áreas de la vida del paciente. Debe subrayado que los cambios que se produjeron en este caso no se derivaron de los esfuerzos de apoyo, sugerentes o manipuladores de Thera-Pist, sino que siguieron naturalmente, espontáneamente e impredeciblemente las transformaciones en las relaciones de objetos significativos en el Transferencia.

CAPÍTULO 7: Gestión de la transferencia En psicoterapia expresiva, quizás la característica más sorprendente del tratamiento de los pacientes con la organización de personalidad límite es la activación prematura en la transferencia de las relaciones de objetos muy tempranas de conflictos en el contexto de los estados del Ego que se disocian entre sí. ¿Por qué "Prematureo"? Es como si cada uno de estos estados del EGO representa una reacción de transferencia regresiva y retrocesiva, dentro del cual se activa una relación de objeción internalizada específica. Esta transferencia está en contraste con el desarrollo más gradual de las relaciones de objetos internalizados a medida que la regresión ocurre en el paciente neurótico típico. La neurosis de transferencia ordinaria se caracteriza por la activación del yo infantil del paciente: el paciente recreaba los conflictos emocionales de este ser infantil con los objetos de los padres con experiencia en la infancia y la infancia. En contraste, las representaciones de sí mismo y objetos de los pacientes límite se activan en la transferencia de formas que no permiten la reconstrucción de los conflictos infantiles con los objetos parentales tal como se cumplen en la realidad. Con estos pacientes, la transferencia refleja una multitud de relaciones de objetos internos de aspectos disociados o separados del yo con representaciones de objetos disociados o separados de una naturaleza altamente fantástica y distorsionada. La causa básica de estos desarrollos es el fracaso del paciente del límite para integrar las representaciones de objetos y objetos determinados libbidas. El problema es que la intensidad de las representaciones de sí mismas y objetos agresivamente determinadas lo hace imposible de integrarlos con representaciones de objetos y de objetos determinados libbidos. Debido a la amenaza implícita a las buenas relaciones de objetos, reuniendo imágenes opuestas (amorosas y odiosas) del yo y de otros significativos desencadenarían ansiedad y culpa insoportable. Por lo tanto, una separación defensiva activa de tal ser contradictorio y objeto lm-

Gestión de la transferencia en psicoterapia expresiva 113 edades ocurre. En otras palabras, la disociación primitiva o la división se convierte en una importante operación defensiva. Al trabajar a través de los desarrollos de transferencia con pacientes con límites, el objetivo estratégico general es resolver estas disocidades primitivas y, por lo tanto, transformar las transferencias primitivas en las reacciones de transferencia de nivel superior características del paciente neurótico. Obviamente, esto requiere un tratamiento intensivo y a largo plazo, generalmente no menos de dos o tres sesiones a la semana durante un período de cinco a siete años. Los conflictos que generalmente emergen en relación con la reactivación de estas relaciones de objetos internalizadas tempranas pueden caracterizarse como una condensación patológica particular de objetivos pregénicos y genitales que desempeñan la influencia primordial de la agresión pregenital. La agresión excesiva, y especialmente la agresión oral, tiende a proyectarse y determinar la distorsión paranoica de las primeras imágenes de los padres, particularmente las de la madre. A través de la proyección de impulsos predominantemente orales y también sádicos, la madre es vista como potencialmente peligrosa. Esquí, de la madre se extiende al odio de ambos padres cuando el niño lo experimenta de manera secundante, como un grupo unido. Una '' contaminación "de la imagen del padre por la agresión proyectada principalmente en la madre y la falta de diferenciación entre la madre y el padre tienden a producir imágenes de padre-madre combinadas y peligrosas y, más tarde, una conceptualización de todas las relaciones sexuales tan peligrosas y infiltradas por la agresión. Conflictamente, en Se produce un esfuerzo por escapar de la rabia oral y los temores, se produce un" vuelo "a los esfuerzos genitales; este vuelo a menudo aturviste por la intensidad de la agresión pregenital, que contamina los listones genitales (Heimann, 19553). Las manifestaciones de transferencia de pacientes con organización de la persona límite pueden aparecer por

primera vez completamente caóticos. Sin embargo, gradualmente, surgen patrones repetitivos, lo que refleja las autorías primitivas y las representaciones de objetos relacionados bajo la influencia de las contracciones acaba de describir. Estos Aparecen en el tratamiento como patrones de transferencia predominantemente negativos. Las operaciones defensivas características de los pacientes límite (división, identificación proyectiva, denegación, idealización primitiva, devaluación y omnipotencia) se convierten en el vehículo de las resistencias de transferencia. Que estas operaciones defensivas en sí mismas tienen efectos de debilitamiento del ego parece ser un factor crucial en la severa regresión que pronto complica los desarrollos prematuros de transferencia. Una vez que un paciente fronterizo se embarca en el tratamiento, la fuerza crucial de descompensación es el aumento del esfuerzo del paciente para defenderse contra la aparición de las reacciones primitivas de la primitiva amenazadora, especialmente negativa y de transferencia mediante la utilización intensificada de las operaciones de la defensiva que han contribuido a "Ego debilidad" en primer lugar. Un culpable principal a este respecto es probablemente el mecanismo de identificación proyectiva.

114 TRATAMIENTO DE LAS PERSONALIDADES DE FRONTERA LÍNEA, descrito por MELANIE KLEIN (1946), Heimann (l955B), Money-Kyrle (1956), Rosenfeld (1963) y Segal (1964). La identificación proyectiva es una forma primitiva de proyección, convocada principalmente a externalizar imágenes de auto y objetos agresivos. La "empatía" se mantiene con objetos reales, en los que se ha producido la proyección, y está vinculada con un esfuerzo para controlar el objeto, ahora temido debido a esta proyección. En la medida en que el paciente mantiene la conciencia emocional del impulso proyectado (empatando con la "agresión" de los demás "), ilustra la ausencia o el fracaso de la reemensa (que caracteriza los niveles más altos de proyección). En la medida en que el paciente racionaliza su propia "contraaggresión", como motivado por la agresión de la otra hacia él, la identificación proyectiva puede ser complicada por una racionalización secundaria. En la transferencia, la identificación proyectiva se manifiesta típicamente como la intensa desconfianza y el miedo al terapeuta. El terapeuta se experimenta como atacando al paciente, mientras que el propio paciente siente empatía con la intensa agresión proyectada y trata de controlar al terapeuta de una manera sádica y abrumadora. El paciente puede ser parcialmente consciente de su propia hostilidad, pero siente que simplemente está respondiendo a la agresión del terapeuta y que está justificado en ser enojado y agresivo. Es como si la vida del paciente dependiera de su controlador bajo control. El comportamiento agresivo del paciente, al mismo tiempo, tiende a provocar sentimientos y actitudes contraagresivos del terapeuta. Es como si el paciente empujara la parte agresiva de su ser sobre el terapeuta y, como si la contratransferencia representara la aparición de esta parte del paciente desde el terapeuta (Money-Kyrle, 1956; ritero, 1957). Cabe destacar que lo que se proyecta de una manera muy ineficiente y contraproducente no es una agresión "pura", sino una representación de sí mismo o una representación de objetos

relacionada con ese derivado de la unidad. Las representaciones de sí mismo y objetos primitivos están en realidad unidades básicas de las relaciones de objetos primitivos (Kernberg, 1976). La característica de los pacientes límite es una rápida oscilación entre los momentos de proyección de una repelación automática, mientras que el paciente permanece identificado con la representación de objetos correspondientes y otros momentos en los que es la representación de objetos que se proyecta mientras el paciente identifica con el paciente con el paciente. La correspondiente auto representación. Por ejemplo, una imagen madre primitiva y sádica se puede proyectar en el terapeuta, mientras que el paciente exime a sí mismo como el pequeño niño asustado, atacado, pánico. Momentos más tarde, el paciente puede experimentarse a sí mismo como la imagen madre, proízida, moralística, extremadamente sáfienta), la madre primitiva, mientras que el terapeuta es visto como el niño culpable, defensivo, asustado, pero a la rebeldía. Estos recreación de roles complementarios en la transferencia también pueden inducir las reacciones correspondientes de la contrarreferencia en el terapeuta, un ejemplo de "identificación complementaria" (racker, 1957).

Gestión de la transferencia en la psicoterapia expressiw 115 El peligro en esta situación es que, bajo la influencia de la expresión de la intensa agresión por parte del paciente, los aspectos de la realidad de la situación de la contratransferencia de transferencia pueden ser de tal manera que se vuelva peligrosamente cerca de reconstituir lo originalmente Interacción proyectada entre imágenes de auto y objetos internalizados. En estas circunstancias, se pueden crear ciclos viciosos en los que el paciente, en el agarre de los derivados de accionamiento agresivo proyectado, proyecta su agresión al terapeuta y reintrojece una imagen severamente distorsionada del terapeuta, por lo que perpetuó la relación patológica de objetos tempranos.. Heimann (I955B) ha ilustrado estos ciclos viciosos de identificación proyectiva y la reintroyección distorsionada del terapeuta al discutir productos paranoicos. Strachey (1934) se ha referido a la cuestión general de la introyección normal y patológica del analista como un aspecto esencial del efecto de la interpretación, especialmente con respecto a la modificación del superyó. La proyección de alternación rápida de las imágenes de self imágenes y objetos que se reenvienta a la representación de las relaciones de objetos internalizadas tempranas patológicas produce una conversión de lo que es "interior" y "afuera" en la experiencia del paciente de sus interacciones con el terapeuta. Es como si el paciente tuviera un sentido de ser diferente del terapeuta en todo momento, pero al mismo tiempo que él y el terapeuta estaban intercambiando sus personalidades. Esta es una experiencia aterradora para el paciente, ya que refleja un desglose de los límites del ego. Como consecuencia, hay una pérdida de realización de la realización en la transferencia. Es esta pérdida que la más poderosamente interfiere con la capacidad del paciente para distinguir la fantasía de la realidad, pasó de la presente, y proyectó objetos de transferencia del terapeuta como una persona real. En tales circunstancias, la posibilidad de que una interpretación mutativa sea efectiva se amenaza seriamente. Clínicamente, esto parece que el

paciente está experimentando algo como "Sí, tienes razón al pensar que te veo, ya que vi a mi padre. Eso es porque tú y él son realmente idénticos". En este punto, se alcanza una "psicosis de la transferencia" (Kernberg, 1975, cap. 5). Prefiero reservar el término psicosis de la transferencia para designar la pérdida de las pruebas de la realidad y la aparición del material delirante dentro de la transferencia que no afecta notablemente el funcionamiento del paciente fuera del establecimiento de tratamiento. La hospitalización a veces puede ser necesaria para tal paciente, y a menudo es bastante difícil separar una reacción psicótica limitada de transferencia de una más amplia. Sin embargo, en muchos pacientes fronterizos, esta delimitación es fácil, y con frecuencia es posible resolver la psicosis de la transferencia dentro de la psicoterapia (Little, 1951; Reider, 1957; Romm, 1957; Holzman y Ekstein, 1959; Wallerstein, 1967). Actuar la transferencia se convierte en una resistencia principal a un cambio adicional; Por lo tanto, es importante que el terapeuta presente los parámetros de la técnica para controlarlo. El peligro es que el terapeuta puede parecer

 El paciente es prohibitivo y sádico, iniciando así un ciclo vicioso de proyección y reintroyección de los representantes sádicos y de objetos del paciente. El terapeuta puede contrarrestar este peligro al interpretar la situación de la transferencia, luego introduciendo los parámetros de estructuración según sea necesario, y finalmente lo interpreta la situación de la transferencia nuevamente, sin abandonar los parámetros. Algunos aspectos de esta técnica han sido ilustrados por Sharpe (1931) en demostrar cómo lidiar con los episodios agudos de ansiedad. La naturaleza de las transferencias primitivas en pacientes límite presenta ciertos problemas técnicos y peligros. El terapeuta puede tener la tentación de interpretar estas transferencias directamente, como si reflejaban las experiencias humanas reales o más primitivas; Incluso podría ir tan lejos como para interpretarlos como una reconstrucción genética de los primeros años o incluso en los primeros meses de vida, confunden o condensando la fantasía primitiva y el mayor desarrollo real. Este tipo de condensación es característica de algún trabajo kleiniano. El enfoque de Kleinian contiene, en mi opinión, dos errores: errores errores la elaboración intrapsícica bizarra primitiva de la experiencia psíquica para las características de desarrollo reales; y telescopia compleja, desarrollando lentamente la organización estructural de las relaciones de objetos interconalizados en los primeros meses de vida. Debido a que la transferencia actuando parece ser una reproducción tan significativa de los pasados conflictos, fantasías, operaciones defensivas y relaciones de objetos internalizados, el terapeuta puede verse tentado a interpretarlo como evidencia de un trabajo a través de estos conflictos. Sin embargo, la compulsión de la representación expresada a través de esta transferencia que actúa no se puede considerar a través de la transferencia, siempre que la relación de transferencia proporciona al paciente la gratificación instintiva de las necesidades patológicas, especialmente agresivas.

Algunos pacientes, de hecho, obtienen mucha más gratificación de sus necesidades instintivas patológicas en la transferencia de lo que sería posible en sus interácticas extraterráuticas. En este nivel regresivo, el paciente actuó sobre el esfuerzo del terapeuta para mantener un clima de abstinencia. Un segundo peligro puede resultar de asumir que, debido a la activación de los efectos del INTENSE en un paciente con poca capacidad para observar lo que está experimentando, el terapeuta debe centrarse en el funcionamiento del ego, a la negligencia de las implicaciones de las relaciones de objetos de lo que se activa en el Transferencia. El terapeuta puede enfocar, por ejemplo, en la dificultad del paciente para experimentar o expresar sus sentimientos o superar la situación, su tendencia a las acciones impulsivas, o su pérdida temporal de claridad lógica en lugar de en la interacción primitiva total (o las defensas contra ella) activadas. En la transferencia. Un error en la dirección opuesta sería interpretar la relación del objeto "de profundidad" sin pagar la atención suficiente a las funciones del ego del paciente. Un peligro aún más es que el terapeuta puede centrarse exclusivamente en el aquí, y ahora en el CON-

Gestión de la transferencia en psicoterapia expresiva 117 Texto de conceptualización de la transferencia como un "contador de contador" emocional correctivo, descuidando la tarea de integrar gradualmente la integración y los objetos en las relaciones de objetos internalizados más realistas y los tipos avanzados de transferencia permiten que lo permita un genético más realista. Reconstrucciones. Aquí, el terapeuta puede contribuir de mala gana o involuntariamente a la estadilidad de las transferencias primitivas (a medida que el tratamiento reemplaza la vida), lo que lo hace, por lo tanto, lo que incluye el crecimiento del ego del paciente. Se debe prestar atención simultánea a las relaciones de objetos internalizados primitivos pasados subyacentes en la transferencia, para que lo que se encuentre en la superficie y lo que sea más profundo se integra en las experiencias emocionales de la complejidad cada vez mayor. En este proceso, cualquier capacidad para la autoobservación y el trabajo autónomo sobre sus problemas, el paciente debe ser explorado, resaltado y reforzado para que se presente la atención al funcionamiento del ego del paciente, en particular a su función de observación de sí mismo, de la mano con la clarificación y la verbalización. De las relaciones de objetos primitivos reflejados en sus fantasías conscientes e inconscientes. La regla general de la interpretación de Fenichel (1941), para proceder de la superficie a la profundidad, ciertamente se aplica a los pacientes con límites. Es útil si compartimos por primera vez nuestras observaciones con el paciente, estimulándolo para integrarlas un paso más allá de lo que es inmediatamente observable, e interpreta más allá de su propia conciencia solo cuando está claro que él mismo no puede hacerlo. Además, cada vez que interpretamos más allá de la conciencia del paciente de la situación de la transferencia, debemos incluir en la interpretación las razones de su falta de confianza. En la medida en que las disposiciones de transferencia primitivas implican un cambio rápido a un nivel de experiencia profundo, el terapeuta que trabaja con los pacientes con límites

debe estar preparado para cambiar su enfoque de aquí, y ahora a la relación de objeto fantaseado pasada activada en la transferencia, una que a menudo incluye Bizarre y características primitivas que el terapeuta tiene que atreverse a hacer explícitas verbalmente hasta su comprensión lo permite. Además, el terapeuta debe estar alerta al peligro de que el paciente pueda interpretar lo que ha dicho como una declaración mágica derivada de un entendimiento mágico en lugar de un reúno de colocación de lo que el paciente le ha comunicado. Por lo tanto, los aspectos integrantes de las interpretaciones incluyen la interpretación consistente de la superficie y la profundidad. El mismo procedimiento se aplica a las comunicaciones del paciente. Cuando aparentemente se produce material "profundo" en estas comunicaciones, es importante primero aclarar la medida en que el paciente está expresando una experiencia emocional, una especulación intelectual, una fantasía o una condena delirante. Una pregunta que el termista a menudo tiene que preguntarse en el tratamiento de los pacientes límite: "¿Debería aclarar la realidad, o debería interpretar en profundidad?", Por lo general, se puede responder al evaluar las pruebas de realidad del paciente en este momento, su capacidad de autoobservación y la disor-

118 Tratamiento de las personalidades límite que gestionan los efectos de las operaciones defensivas primitivas en la transferencia. Idealmente, la aclaración de la realidad e interpretación en profundidad debe integrarse, pero que a menudo no es posible. Sorprendentemente, como la experiencia de uno con este tipo de tratamiento de los pacientes de bordesarrollo crece, uno encuentra cada vez más que lo que al principio parecía una simple manifestación de debilidad del ego o defecto del ego resulta ser el efecto de las operaciones defensivas muy específicas, activas y primitivas. Se dirigió a la plena conciencia de una relación de transferencia disociada que reinstalaba los conflictos intrapsíquicos. En otras palabras, este enfoque de tratamiento nos permite diagnosticar áreas de debilidad del ego, para evaluar los efectos del debilitamiento del ego de las operaciones defensivas primitivas y de las relaciones de objetos internalizados disociados, y para fomentar el crecimiento del ego por medios de intercepción esencialmente. Las aclaraciones de la realidad hecha por el terapeuta a menudo resultan que posteriormente han sido un apoyo innecesario que se alimenta a una cierta situación de transferencia. Cada vez que esto ocurre, es muy útil interpretar al paciente cómo en realidad no era necesario una aclaración aparentemente necesaria por el terapeuta. La pregunta a menudo surge si desea aclarar aún más la realidad del paciente o para interpretar el significado de su distorsión de la realidad. Si uno promueve la superficie a la profundidad, probando primero los límites del paciente que se desempeña y luego interpreta los aspectos defensivos de su falta de conciencia de una percepción apropiada de (o reacción a) realidad, uno generalmente se puede resolver esta pregunta de manera básicamente analítica. El Dan-Ger siempre existe que el paciente percibirá la interpretación del terapeuta de su negación defensiva de la realidad como un intento sutil de influir en él. Por lo tanto, además de una evaluación introspectiva de si el paciente puede ser correcto en este sentido, esta distorsión de la

interpretación de la línea del terapeuta también debe interpretarse. En esencia, la neutralización técnica, la interpretación de la transferencia, la explotación introspectiva del terapeuta de su contratransferencia, y el enfoque en las percepciones del paciente en la sesión están íntimamente relacionadas con herramientas técnicas. Un problema relacionado para el terapeuta que trabaja con las condiciones fronterizas se refiere a la medida en que debe interpretar en lugar de esperar hasta que el paciente esté listo para hacer más trabajo por su cuenta. En general, una vez que se haya logrado la comprensión operativa, creo que se obtienen pocas ventajas de simplemente esperar. En la medida en que las transferencias primitivas se activan rápidamente en las sesiones y tienden a perpetuarse en una compulsión de repetición, existe una ventaja en la interpretación del material completamente tan pronto como sea lo suficientemente claro y siempre que se convierta en una determinada disposición de transferencia se convierte en un Resistencia predominante de la transferencia. Algunos pacientes fronterizos activan un tipo de patrón de transferencia en una repetición menos a lo largo de muchos meses y años; Para ellos, la interpretación temprana puede no solo ahorrar mucho tiempo, sino que puede protegerlos de una actuación destructiva. Al mismo tiempo, un enfoque interpretativo que inflige.

Gestión de la transferencia En psicoterapia expresiva 119 rápidamente con las resistencias de transferencia en desarrollo no implica al pasar la capacidad de autoobservación del paciente: deseo estrenar nuevamente que la interpretación en profundidad debería incluir una evaluación continua de la capacidad de autoobservación del paciente y nunca debería justificar el Las esperanzas del paciente (o temores) de una relación mágica con un tero omnipotente. Muy a menudo, simplemente esperar a que el paciente mejore en sus capacidades de observación automática es de poca utilidad y riesgos que brinda distorsiones crónicas de la contra-transferencia que socavan gradualmente la posición de neutralidad técnica del terapeuta. Hay áreas en las que el terapeuta debe permitir que los pacientes sepan que él no puede o no puede hacer por ellos lo que no pueden o no lo harán por sí mismos. La relación de objeto intensa y profunda involucrada en cada sesión de psicoterapia a lo largo de semanas, meses, e incluso años de tratamiento tiene una calidad totalmente diferente de una relación de vida real en curso, y esto es algo que el paciente debe aceptar eventualmente. La actitud empática de los productos, derivada de su entendimiento emocional de sí mismo y de su identificación transitoria con y la preocupación por el paciente, tiene elementos en común con la empatía de la "Madre de Buena Madre" con su bebé (Winnicott). Sin embargo, también hay un aspecto totalmente racional, cognitivo, casi ascético al trabajo del terapeuta con el paciente que le da a su relación una calidad completamente diferente a la de una madre-infante. Debido a que los pacientes con buena fuerza del ego utilizan con frecuencia la intelectualización o las reacciones afectivas excesivas como una defensa (patología obsesiva-compulsiva frente a la histérica), tendemos a pasar por alto la conexión intencional entre los efectos y la cognición en los niveles anteriores de desarrollo y en el El funcionamiento psicológico más patológico o primitivo que conserva los modos de tal desarrollo temprano. Además, el enfoque tradicional en la

"catarsis" en psicoterapias psicoanalíticas (y la distorsión de este concepto en algunas modalidades psicoterapéuticas actualmente empleadas, que asume ingenuamente que la discusión afectiva producirá un cambio psicológico fundamental por sí mismo) nos ha impedido De reconocer que la aclaración e integración cognitiva son herramientas psicoterapéuticas básicas y potentes. Las formulaciones cognitivas del terapeuta fortalecen o amplían la integración de los efectos del paciente y las relaciones de objetos internalizados. La función de retención del terapeuta incluye astillas afectivas y cognitivas. Para formular interpretaciones con pacientes en un estado de revertir severa es interpretar la división de la defensa primitiva, lo que resulta en una integración de afectos y relaciones objetivas defensivamente disociadas y aumenta las capacidades cognitivas del paciente. No todos los conocimientos intelectuales son la "intelectualización"; El conocimiento auténtico tanto fomenta como es un conforme de cualquier crecimiento emocional. El terapeuta que lleva a cabo una psicoterapia interpretativa con

120 TRATAMIENTO DE LAS PERSONALIZADAS DE LÍNEA LÍNEA LIMPIEZA Los pacientes con límites necesariamente frustran los deseos del paciente al evitar que sean decisiones para tomar decisiones. El paciente puede permanecer desde hace mucho tiempo, desconoce que lo que está recibiendo es un estado de alerta, interurbano y preocupación consistentes frente a las muchas tentaciones para el terapeuta, bajo la embestida de la agresión del paciente, para enojarse, con sueño, retirado, indiferente, Impaciente, y similares. Tengo en otra parte (1975), dijo que es necesario profundizar el nivel de interpretación rápidamente cuando el paciente comienza a actuar. Aunque existe el riesgo de interpretar más allá del nivel de entendimiento emocional, el paciente ha alcanzado en ese momento, y un riesgo, por lo tanto, que la interpretación se rechazará o incorpore de manera intelectualizada o mágica: el enfoque en la relación del paciente con la interpretación permitirá corregir Dichos posibles defectos de los rápidos interpretaciones de la transferencia. Otro aspecto importante del análisis de la transferencia de las condiciones de la línea privilegiada es la naturaleza tenue de la alianza terapéutica en comparación con la de los pacientes neuróticos en el psicoanálisis. La Alianza Terapéutica (Zetzel, 1956; Greenson, 1965) vincula al analista con la parte de observación del ego del paciente, sin embargo, puede ser, en la situación del tratamiento. En la medida en que hay una parte de observación suficiente del ego del paciente neurótico, la Alianza Terapéutica (o, uno podría decir, la alianza con entidad de tareas entre el ego de observación del paciente y el analista) es un hecho, que normalmente no requiere demasiada atención. Sin embargo, incluso unidades de circunstancias ideales, en el caso psicoanalítico típico, hay momentos en que la intensidad de la relación de transferencia amenaza temporalmente a abrumar al ego observador del paciente. En esos momentos puede ser necesario enfocar la atención del paciente en esa complicación. En consecuencia, el ego de observación en el caso típico

de la frontera es tan limitado y frágil que la pregunta se haya planteado en qué medida es necesario enfocar la atención con fuerza, de manera consistente, en la alianza terapéutica: hay ocasiones en que el terapeuta necesita tomar medidas activas para Fortalecer la alianza terapéutica por los comentarios de apoyo orientados a la realidad o al proporcionarle información al paciente con respecto a los aspectos de la realidad del Thera-Pist. En mi opinión, centrarse en el uso defensivo o la naturaleza de las distorsiones de las percepciones del paciente, particularmente en sus distorsiones de las interpretaciones del terapeuta, es el mejor medio para fortalecer el ego de observación del paciente sin cambiar de una manera esencialmente Modelo analítico. Me parece que varios aspectos de la relación real entre el terapeuta y el paciente son un aspecto inespecífico, potencialmente terapéutico del tratamiento en todos los casos. Sin embargo, este aspecto de la relación total del tratamiento se limita en el caso psicoanalítico ordinario, y el análisis sistemático de todos los paradigmas de transferencia en la transferencia de la transferencia de despliegue debe conducir a un trabajo sistemático a través de la

Gestión de la transferencia en psicoterapia expresiva Los esfuerzos del paciente para utilizar la relación terapéutica como una función parental en la transferencia. En otras palabras, las implicaciones de apoyo no específicas de los aspectos reales de la relación en términos de la transferencia de plegado del paciente se convertirán automáticamente en parte del trabajo analítico y permanecerán en el fondo. En los pacientes con límites, por otro lado, la relación humana "real" no específica, que se refleja en la Alianza Thera-Peutic puede constituir una experiencia emocional correctiva importante, no en el sentido de que el terapeuta adopte una postura activa y manipuladora, sino en el Sentido de que una relación de trabajo tan positiva, que de diez años va más allá de lo que el paciente ha experimentado anteriormente, normalmente es gratificante. En la medida en que las circunstancias crónicas de la traumatización o la frustración del desarrollo temprano, y, por lo tanto, de las antiguas relaciones del paciente con los padres reales, son un aspecto importante de los antecedentes genéticos e históricos de los pacientes con límites, la relación real con el terapeuta puede realizar Funciones de los padres El paciente nunca ha experimentado antes. Además, la disponibilidad del terapeuta como "contenedor" (bion, 1967), como absorbente, organizador y transformador de la experiencia intra-psítica caótica del paciente (que el terapeuta primero intenta aclarar en su propia mente y luego transmitir a El paciente como parte de sus comentarios interpretativos), proporciona funciones cognitivas que se espera que el paciente neurótico se espera que se realice para sí mismo. En otras palabras, el terapeuta proporciona funciones de ego cognitivo auxiliares para el paciente límite, además de la seguridad implícita dada por su capacidad para soportar y no ser destruida por la agresión del paciente, por su no represalia, por su mantenimiento de una Actitud general de la preocupación y disponibilidad emocional para el paciente. Otros han enfatizado la importancia de las funciones de "tenencia" del

terapeuta con los pacientes con límites (Little, 1958.1960; Winnicott, I960B). Estos aspectos de la relación de Thera-Peutic, sin duda, desempeñan un papel vital en la psicoterapia psicoanalítica de los pacientes con límites, y, siempre y cuando ocurran dentro de un establecimiento de neutralidad técnica, constituyen un uso legítimo de la relación psicoterapéutica. Este uso tiene que ser diferenciado de la intensa transferencia del paciente, las demandas de transferencia de los terapeutas gratifican las necesidades que se frustraron previamente, que actúan en Loco Parentis, abandonando así la posición de neutralidad técnica y aumentando los aspectos suministrativos de la relación terapéutica. No puedo enfatizar lo suficientemente fuerte, la necesidad de que el psicoanalista y el psicoterapeuta que trabaje con los pacientes límite para analizar cuidadosamente todos estos intentos de la parte del paciente. Lo que realmente fortalece el ego del paciente no es la gratificación de las necesidades en el presente, y ahora que se negaron en el mismo, sino a un acuerdo con las frustraciones y las limitaciones anteriores en el contexto de una comprensión de las reacciones patológicas, los impulsos y las defensas que fueron Activado bajo aquellos anteriores cirugiosos cirugáticos.

122 Tratamiento de las posiciones de las personalidades límite y que contribuyeron con valentía al desarrollo y fijación de la debilidad del Ego. La cuestión de la percepción de los pacientes con límites que merece una discusión. En algunos pacientes fronterizos, uno encuentra lo que al principio parece una idea de las capas profundas de la mente y en la dinámica inconsciente. Desafortunadamente, esta es en realidad una expresión de la disponibilidad lista de funcionamiento de procesos primarios, que forma parte de la regresión general de sus estructuras de ego. Insight que viene sin ningún esfuerzo, no acompañado por cualquier cambio en el equilibrio intrapsíquico del paciente y, sobre todo, por cualquier preocupación por los aspectos patológicos de su comportamiento o experiencia, es una idea cuestionable. La visión auténtica es una combinación de una comprensión intelectual y emocional de las fuentes más profundas de las experiencias psíquicas de uno, acompañadas por la preocupación y la necesidad de cambiar los aspectos patológicos de esas experiencias. He enfatizado la importancia de mantener una actitud de neutralidad técnica para poder interpretar las transferencias primitivas que se producen en la interacción del paciente-terapeuta. No puedo enfatizar lo suficientemente fuerte como para que se pague un precio pesado cuando el terapeuta cede a la tentación de introducir técnicas de apoyo; La mejora inmediata es seguida por las racionalizaciones posteriores del paciente de los desarrollos de transferencia que no se pueden resolver de manera plena y, por lo tanto, limitar la personalidad de diversión. Cambia los objetivos de tratamiento. Sin embargo, como Loewald (1960) ha señalado con referencia a la situación psicoanalítica estándar, la función del terapeuta para interpretar la realidad emocional del paciente en sí misma es reflejar el hecho de que su ego está funcionando a un nivel más integrador que el ego del paciente es capaz de lograr en el momento de la regresión de la transferencia. La identificación del paciente con la función de interpretación del terapeuta es, por lo tanto, una experiencia de

crecimiento. Bajo tales condiciones, lo implica, como observa Loe-Wald, una identificación con una imagen de objeto del terapeuta y con una autoimagen: a saber, la imagen del paciente mismo según lo percibido por el terapeuta. Para decirlo de manera diferente, la identificación del paciente con la función de interpretación del terapeuta refleja una identificación con una relación de objetos diádicos de un tipo bueno o útil. Este proceso, que normalmente ocurre en formas sutiles y discretas en el tratamiento de pacientes neuróticos, está fuertemente acentuada en la psicoterapia psicoanalítica de las condiciones fronterizas, donde la difusión de identidad interfiere con precisión la función integradora que el El terapeuta puede proporcionar. Considerando que la función integradora y cognitiva es más importante en la situación terapéutica con los pacientes con límites que con los casos psicoanalíticos estándar para proporcionar una base para el crecimiento potencial, esta función puede, al mismo tiempo, provocar experiencias intensas de odio y Envidia en pacientes fronterizos: odio porque el aprendizaje significativo sobre uno mismo, en lugar de

La gestión de la transferencia en la psicoterapia expresiva 123 a la disociación defensiva, es siempre dolorosa y, por lo tanto, la actitud de ayuda del terapeuta, paradójicamente, también es dolorosa; Envy Debido a que la agresión primitiva con frecuencia toma la forma de las esfuerzos de Ehvioiis para destruir al terapeuta como una imagen materna que da. Por lo tanto, la interpretación de la necesidad inconsciente del paciente de rechazar o destruir la función integrativa del terapeuta puede ser un aspecto importante del trabajo interpretativo dentro de una posición esencialmente neutral técnicamente. El efecto de las operaciones defensivas primitivas, en particular la identificación proyectiva, no solo es atribuir cierta disposición mental al terapeuta, sino a inducir en él una determinada disposición emocional que complementa el estado afectivo del paciente, un impulso de actuar en una determinada dirección que complementa las necesidades de transferencia. Por lo tanto, la neutralidad es desafiada o amenazada, aunque, aunque, por lo mismo, se muestra cada amenaza momentánea para o desviarse de la neutralidad técnica, imparte información importante de la transferencia. La naturaleza primitiva de la transferencia activada en el paciente límite lidera al terapeuta, ya que se esfuerza por empatizar con el paciente, a cualquier capacidad que pueda tener por la conciencia de las reacciones emocionales primitivas dentro de sí mismo. Esto se ve reforzado por el comportamiento no verbal del paciente, especialmente aquellos aspectos que intentan controlar al terapeuta, para imponerle, por lo que hablar, el papel asignado a la imagen de sí mismo o objeto dentro de la transferencia activada por la primitiva. Probablemente todavía no sabemos lo suficiente sobre cómo el comportamiento de una persona puede inducir reacciones emocionales y de comportamiento en otra. La empatía del terapeuta, su uso creativo de la atención de manera uniforme, una actividad similar a la excitación, y el impacto directo de la percepción del comportamiento se combina para lograr una reacción regés por temporal

que le permita identificar con los niveles primitivos de funcionamiento del paciente. Para mantener el grado óptimo de la libertad interior para explorar sus propias reacciones emocionales y formaciones de fantasía en relación con el material del paciente, el terapeuta que trata a los pacientes con límite, debe estar particularmente preocupado de que intervenga solo cuando haya llegado a una posición técnicamente neutral. Es especialmente importante mantener una actitud constante de "abstinencia", en el sentido de no dar lugar a las demandas del paciente para la gratificación de la transferencia, sino, en lugar de interpretar estas demandas de manera plena y consistente. La humanidad, la calidez y la preocupación del terapeuta se presentarán naturalmente en su atención y trabajen con las dificultades del paciente en la transferencia y en su capacidad para absorber y, sin embargo, no reaccionar a las demandas que se derivan del dependiente primitivo del paciente, Necesidades sexuales y agresivas. Paradójicamente, puede ser muy útil para el terapeuta que trata a los pacientes con límites en la psicoterapia psicoanalítica a largo plazo o en el análisis también para tener una experiencia activa con una intervención breve y crisis

124 Tratamiento de las personalidades límite Tipo de tratamiento de otros pacientes de este tipo. Cuando el terapeuta se siente seguro de conducir, la psicoterapia de apoyo a corto plazo, la intervención de crisis y puede adherirse firmemente a una postura analítica, sentirá menos presión por "acción". Un amplio nivel de experiencia, la capacidad de llevar a cabo modalidades alternativas de tratamiento, y una evaluación diagnóstica cuidadosa y completa contribuye a la capacidad del terapeuta para mantener una posición serena y firme al tiempo que interpreta la transferencia de actuación y compleja del paciente. Desarrollos. Ilustraciones clínicas Miss M. Un estudiante graduado en sus últimos años veinteia había comenzado la psicoterapia psicoanítica (tres sesiones a la semana) debido a una reacción grave de depresión con pérdida de peso y ideación suicida, alcoholismo y una avería general en ella. Funcionando en la escuela, en su vida social, y en su relación amorosa con su novio. El diagnóstico fue la persona infantil con las características del límite, la reacción depresiva severa y el alcoholismo sintonómico. El tratamiento se realizó en sesiones cara a cara, ya que uso el sofá solo para el psicoanálisis (ver Kernberg, 1975). Al comienzo del tratamiento, había establecido ciertas condiciones que estaría dispuesta a ver a la señorita M de manera ambulatoria. Si no podía cumplir estas afecciones, la vería en psicoterapia hasta que se preparó para hacerlo, y ella permanecería en el hospital. Otros psiquiatras habían sido sugeridos por otros psiquiatras que habían visto a la señorita M, y yo también lo habían contemplado como una alternativa en caso de que ella probara que no pudiera asumir la responsabilidad de su funcionamiento en realidad. En la medida en que realicé estas condiciones, se podría decir que se produjo un proceso selectivo, que solo aceptaría una gama limitada de pacientes con límites y podía sufrir el tipo de enfoque de tratamiento propuesto. Sin embargo, debe señalarse que la señorita M tenía disponible como alternativa, la posibilidad de hospitalización a corto plazo (o largo plazo) y que

esperaría la hospitalización, si es necesario, como mínimo para reducir su capacidad para asumir la responsabilidad de tales funciones, ya que son indispensables para Tratamiento ambulatorio en cualquier caso. El AP-PROACH opuesto, para aceptar el tratamiento ambulatorio en una base menos realista, probablemente provocaría un curso de tratamiento más complicado y potencialmente desastroso. En otras palabras, un terapeuta no puede hacer justicia a las necesidades de su paciente si el terapeuta no tiene los requisitos mínimos y la libertad de implementación total de su conocimiento técnico y capacidades especiales. La señorita M se había comprometido a dejar de beber, no actuar sobre los impulsos suicidas, sino discutirlos abiertamente conmigo, si ocurrían, y cuando ocurrieron, y para mantener un peso mínimo al comer lo suficiente, sin tener el apetito. Un trabajador social psiquiátrico fue

Gestión de la transferencia en psicoterapia expresiva 125 Divindar una evaluación de la situación social total de la señorita M, incluida su recesión con sus padres, que vivían en una ciudad diferente, y estaba disponible para el paciente para sugerencia y consejos, si es necesario, con respecto a los problemas en su vida diaria. Nuestro entendimiento fue que el trabajador social transmitiría información completa sobre la señorita M para mí y que comunicaría al trabajador social solo la información que consideraba crucial y que el paciente me había autorizado explícitamente para transmitir. Mi enfoque psicoterapéutico era esencialmente psicoanalítico, y al momento de mantener una posición consistente de neutralidad técnica. En la sesión se describirá, que tuvo lugar unas semanas después del inicio del tratamiento, la señorita M parecía demacrada y angustiada; Estaba lloviendo pesadamente, y ella no había tomado precauciones para vestirse apropiadamente para que llegara sin impermeable o paraguas, empapado, la delgadez de su cuerpo aparente bajo su ropa mojada. Su blusa y pantalones estaban sucios, y ella parecía un poco despeinada. Comenzó a hablar inmediatamente sobre una prueba difícil que tuvo que tomar en la escuela de que temía que ella no pasara. Luego habló de una pelea seria con su novio; Se sentía celosa debido a su interés en otra mujer, una ex novia de su quiénes, el paciente había descubierto, se había encontrado en secreto. También expresó su preocupación por si sus padres le enviarían el cheque mensual (lo que lo producía en mí la fantasía que quería asegurarme: ella estaría pagando por su tratamiento; por lo tanto, incluso si estuviera harto de ella de lo contrario, todavía estaría en mi poder seguir de verla a pesar de ella. Naturaleza "improbable"). El flujo de comunicación verbal de la señorita M parecía ser interrumpido por una variedad de comportamientos no verbales. Esporádicamente, se quedó en silencio y me miró con una expresión de búsqueda, desconfianza y algo retirada; Hubo momentos de inapropiado, gaitismo artificial y rió forzado, que me transmitieron sus

esfuerzos conscientes para controlar nuestra interacción. Se hizo "confundida" al decirme donde había conocido a su novio y la otra mujer, lo que me hizo preguntarse si había estado bebiendo sin atreverme a avisarme. La información del trabajador social psiquiátrico vino a mi mente: la señorita M le había vuelto casualmente a ella que recientemente había tenido dolores de estómago y había estado vomitando, y el trabajador social se preguntó si el paciente necesitaba otro control médico. Ahora oscilaba entre momentos de preocupación y fuertes impulsos a expresar esta preocupación al paciente en términos del deterioro de su apariencia física, su salud y la cuestión de si realmente podía mantener el entorno de tratamiento ambulatorio que habíamos acordado. También estuve tentado a confrontarla con esos aspectos de su comportamiento que me hizo preguntarme si me estaba diciendo la verdad. Percibí un desgarro subyacente en ella y sintí que ella me estaba experimentando como una figura parental potencialmente crítica e inflexible.

126 Tratamiento de las personalidades límite que la regañarían por no ser sinceras o por comportarse mal. (Todo esto se superpuso sobre mi sentimiento de que ella deseaba desesperadamente que me hiciera cargo y corriera su vida). Ahora me doy cuenta de un creciente sentido de impaciencia en mí mismo, una combinación de preocupación por el paciente y la irritación de que el programa de tratamiento se estaba separado y desorordi- Se estaban hechos de demandas de Nate en el trabajador social psiquiátrico y en mí para cambiar los arreglos de tratamiento, movilizar a los padres de la señorita M y protegerla contra la inminente amenaza de despido de la escuela (otro aspecto de la realidad que la había llevado al tratamiento). Finalmente, sintí que la relación humana predominante promulgada en ese momento era de una niña asustada que quería una poderosa figura de alquiler (cuya identidad sexual en particular era irrelevante) para asumir el dolor, el miedo y el sufrimiento en general. Al mismo tiempo, pensé, odiaba que la figura parental porque estar tomada así podría ocurrir solo porque estaba sufriendo y no por preocupación natural, amor y dedicación a ella. Y tenía miedo de un ataque de represalia de esa figura de los padres necesitada y, sin embargo, ha resentido, porque ella proyectó sus propias demandas enojadas en él. Por lo tanto, sentí que tuvo que escapar de esa temida relación, tal vez tomándose en el olvido y creando una situación caótica en la que se rescatara sin tener que reconocer o relacionarse emocionalmente con el salvador como un enemigo. Le dije a la señorita M que, sobre la base de lo que parecía estar comunicando, tuve la sensación de que estaba expresando deseos contradictorios: quería asegurarme de que ella todavía estaba en control de su vida, y al mismo tiempo que ella estaba transmitiendo bastante dramáticamente que las cosas eran. Se desmorona, que no pudo manejar su vida, y que estaba corriendo el riesgo de enfermedad, la expulsión de la escuela y la pérdida de su novio. Agrego que, si fuera correcto, lo que pueda hacer bajo estas circunstancias sería desastroso para ella.

Si, por un lado, me exploré aún más si realmente podía manejar su situación de vida inmediata, ella experimentaría esto como un ataque. Por ejemplo, si planteaba la pregunta de si, en estas circunstancias, se sintió capaz de continuar abstenerme de beber, la consideraría una "examinación cruzada" que revelaba mi dureza básica y la sospecha de ella. Si, por otro lado, escuché con simpatía sin recaudar tales preguntas, consideraría esto como una expresión de indiferencia y aplazamiento. En cualquier caso, ella esperaría que solo sufre y decepción de mis reacciones potenciales a ella. La señorita M respondió que había estado preocupada porque había estado bebiendo y temía que la hospitalizaría si supiera. También había pensado que, debido a la tardanza de sus padres al enviarle el dinero, podría estar preocupado por recibir mi tarifa, y ella había estado enojada con sus padres y avergonzada por esta tardanza. Ella dijo

Gestión de la transferencia En psicoterapia expresiva 127, se sentía completamente desesperada en sí misma y no sabía cómo esta psicoterapia podría ayudarla. Dije que pensé que estaba preocupada, no estaba tan preocupada por si la psicoterapia la ayudaría, ya si estaba realmente interesada en ella o simplemente preocupada por los pagos pagados por las sesiones. También dije que me preguntaba si ella sintió que la única forma de obtener algo de mí era forzándola de mí, extrajiéndola, por así decirlo, presentándose a sí misma como una naufragia humana completamente indefensos. Añadí que, en estas circunstancias, cualquier ayuda de mí sería como la reacción irritada y enojada de un padre que prefiera no molestarse, sino que no tenga alternativa, sino a cuidar a un niño no deseado. La señorita M estalló en lágrimas y dijo que estaba desolada que se sintió porque su novio la estaba dejando, y se suma con la sensación real de que ella no tenía derecho a ser ayudado por mí, había mucha gente como ella, y solo por la conciencia afortunada de que sus padres tuvieran dinero. De lo contrario no estaría disponible. ¿Por qué debería ser tratada cuando había tanto sufrimiento en el mundo? Fue mejor renunciar. . . . En este momento, sentí que había ocurrido un cambio: ahora sus comunicaciones verbales y su comportamiento coincidían. Ella me contó sobre lo que realmente había sucedido durante los dos días anteriores, con consciente y preocuparse por su sentido del fracaso, mezclado con una extraña sensación de alivio por fallar porque sintió que no se merecía mejor. Sentí que la señorita M se estaba preocupando por sí misma en el proceso de esta intercambio, que la presión sobre mí para tomar el control estaba disminuyendo, y que estaba empezando a sentirse culpable por haberlo hecho en mantener su parte de nuestro acuerdo, mientras que también comenzaba a entender que esta fracaso era una expresión de su sentimiento de que ella No merecía ser ayudado. Lo que deseo estresar es que la situación de la transferencia se hubiera más coherente; Se estaba expulsando un patrón de caracteres masoquista en

una relación en su mayoría preggenitales y dependientes dependientes con una imagen parental frustrante. El conflicto intersistémico entre las características del superyó (culpa inconsciente) y la dependencia expresadas conjuntamente por su ego ahora reflejaron una relación típica de objetos neuróticos en la transferencia. Este desarrollo fue en marcado contraste con las manifestaciones caóticas y contradictorias anteriores de la sospecha implícita, la ira proyectada, la demandabilidad agresiva, el ocultamiento y la retirada. También subrayaría que la reducción de las manifestaciones de transferencia caótica en la relación de objeto predominante expresada en la transferencia permitió la exploración total de la transferencia y las situaciones de la vida. Los recursos del ego se activaron, lo que lo hizo innecesario para que yo intervenga en nombre del paciente. En otras palabras, el enfoque de una posición de neutralidad técnica permitió un fortalecimiento del ego del paciente, incluso si solo, aunque solo es temporal, y un fomento de su capacidad para combinar la comprensión en

128 Tratamiento de las personalidades límite de la sesión con un creciente sentido de responsabilidad por su vida fuera de las horas de tratamiento. Miss N. En contraste con la de la Srta. M, el caso de la señorita n ilustra la oscilación en la transferencia, en una etapa avanzada de tratamiento entre varios niveles de relaciones de objetos internalizados, con una progresión alternativa hacia relaciones avanzadas, neuróticas o totales de objetos, y se vuelve a ser de la primitiva. -Ojuntos, o relaciones de objetos límite. La señorita N fue abogada en sus primeros años treinta, presentando una organización de Personalidad límite con características predominantes obsesivas y esquizoides. La vi en psicoterapia psicoanalítica tres veces a la semana, durante más de cinco años. En el tercer año de tratamiento, después de la interpretación de las operaciones productivas primitivas en el contexto de la condensación de la centrado de material periódicante y prededípico en su búsqueda masoquista de un padre cálido, donando, pero también poderoso y sádico, se emergió el siguiente patrón de transferencia. La señorita N ahora experimentó su madre edípica y preeedipal combinada como una fuerza poderosa que le impide cualquier mayor mejora. Vaga e imprecisa discurso, bloqueo grave en las horas con un sentido de futilidad, demandas interminables de demostraciones de mi amor e interés de mi madre maternidad, y las acusaciones de que estaba fría y rechazando (es decir, la madre lo ataca internamente y externamente) se alternó con sexualidad. Reacciones de transferencia en las que me experimentó como un hombre sexualmente emocionante pero peligroso y poderoso que la asustó. Las cualidades de OEDIl del material se hacen más fuertes en el contexto de una integración de la transferencia que parecía reflejar aspectos más realistas de su infancia, mientras que el conflicto entre sus deseos para una relación sexual con un padre poderoso y su miedo al castigo de la La madre edificada adquirió las cualidades intersistémicas. Es decir, su introjecto de su madre coincidió más con características

más amplias de su superyó, y las contrapistas intrapsícicas ahora eran intersistémicas, en contraste con los conflictos caóticos y conscientes anteriormente predominantes entre los aspectos mutuamente disociados de las relaciones con ambos Padres. También estableció, por primera vez, una relación sexual con un hombre, pero finalmente intentó escapar de la relación de un sentido inconsciente de la culpa. Curiosamente, exigió a su novio como su novio más bien pasivo y sexualmente no amenazante y, al principio, lo encontró útil. Pero entonces percibió su incapacidad para soportar las fuerzas en ella que tendían a destruir una buena relación sexual (su madre introjunta) como decepcionante. En este punto, en medio de mi interpretación de los temores de la señorita N de los anhelos sexuales para mí como padre (porque estaban prohibidos por su madre interna), ocurrió un deterioro relativamente repentino, y sobre un período de varias semanas parecía retroceder. A lo que había caracterizado las primeras etapas de su tratamiento. Ahora presentó una comunicación verbal casi desordenada (al comienzo del tratamiento, había presentado una rumina obsesiva que casi ascendía a un desorden formal

Gestión de la transferencia en psicoterapia expresiva 129 Ganización de procesos de pensamiento), una incapacidad para escuchar lo que estaba diciendo, y una creciente sensación de que mi comprensión de ella era terriblemente incompleta, imperfecta y arbitraria. Por primera vez en su tratamiento, expresó un fuerte deseo de cambiar a otro, presumiblemente más cálido y más comprensivo terapeuta. Los esfuerzos para interpretar estos sentimientos como un escape regresivo de los aspectos edípicos de la transferencia no llevó a ninguna parte. En un momento, la señorita N Déjame saber que ella quería que yo solo dijera cosas perfectas y precisas que reflejarían de inmediato y claramente cómo se sentía y la aseguraría que estaba realmente con ella. De lo contrario, no debería decir nada más que escuchar pacientemente sus ataques a mí. A veces, me hizo prácticamente imposible decir una palabra porque la señorita N me interrumpiría y distorsionaría casi todo lo que estaba diciendo. Finalmente me senté para varias sesiones, escuchando sus largos ataques a mí mientras intentaba ganar más comprensión de la situación. Ahora me limito a señalar que entendí su gran necesidad de decir las cosas correctas, para tranquilizarla, darle a sus indicaciones que la entendí casi sin que ella tuviera que decir nada. Además, señalé que entendí que tenía mucho miedo de que cualquier cosa que pudiera decir era un intento de dominar, dominar o lavarla. Después de tal intervención, la señorita N se sentaría como si me exigiría a decir más, pero no lo hice. Luego, ella sonrió, que interpreté en privado como su reconocimiento de que no estaba intentando controlarla o decir nada más allá de mi reconocimiento de esta situación que respecta a la mediación. Debo enfatizar que en las primeras etapas de este desarrollo, había tenido que interpretar la actitud del paciente como un esfuerzo por controlarme, como un reflejo de su identificación con la actitud de su madre sádicamente percibida (su superyo) hacia ella (su superego) hacia ella enviado por mi). Pero en esta etapa, cualquiera de estos esfuerzos en la interpretación impulsó la

situación y no se útiles (en contraste con las intervenciones similares que habían sido muy útiles meses antes). Sorprendentemente, después de varias semanas de mi no hacer nada más allá de verbalizar la relación inmediata entre nosotros, ya que lo vi, la señorita N se sintió mejor, fue reaciada, y nuevamente tuvo sentimientos muy positivos y sexuales hacia mí. Sin embargo, mis esfuerzos para investigar la relación entre estos dos tipos de sesiones, aquellos en los que no podía aceptar nada de mí y tuvo que hacerse cargo de ellos y aquellos en los que parecía más positiva, pero temía a sus sentimientos sexuales, nuevamente llevó a estancarse. Después de unas semanas más, finalmente formulé la interpretación de que estaba promulgando dos relaciones alternativas conmigo: una en la que era como una madre cálida, receptiva, comprensiva y no controladora y otra en la que fui de nuevo una figura paterna, sexualmente tentadora y danero. La señorita N ahora dijo que cuando interpreté su comportamiento que vio

me as harsh, masculine, invasive; Cuando me volví a sentado y me escuché, ella me vio tan suave, femenina, algo deprimida, y de alguna manera muy calmante. Dijo que cuando ella sintió que la entendía de esa manera, como una persona tranquila, femenina y deprimida, pudo, más tarde, escucharme, aunque entonces "cometí el error" de volver a convertirse en una figura masculina y controladora. Ahora interpreté su doble división de mí (como masculino y femenino, y bueno y malo) como un esfuerzo por evitar el conflicto entre la necesidad de una relación cálida y cálida con una madre que podía entender y darle amor, pero que también prohibía el sexo con padre, y la necesidad de ser un Mujer femenina receptiva a un hombre masculino que estaba de pie para un fábrico que pudo "penetrar" a pesar de ella actuando como si ella lo hiciera, lo que le repertaba (pero, por la misma ficha, amenazando su relación con la madre). También interpreté que se "atascara" en esa situación, en esa situación, como reflexionar una condensación de una relación muy temprana con su madre, probablemente derivada del segundo o tercer año de vida, en el que sintió que su madre podía escucharla solo cuando la madre estaba deprimida y no aportada, mientras Cualquier interés activo de su madre parecía un control intolerable y el dominio. Añadí que esto reflejé a una persona más profunda por su incapacidad para cambiar a una relación dependiente con un hombre que, al mismo tiempo, sería sexualmente atractivo para ella: no tener la seguridad de una aceptación básica del amor de una madre que también respetó su autonomía. No podía tolerar sus sentimientos sexuales por su padre. Meses más tarde, pude señalar a la señorita N que su percepción de su padre como un hombre cruel, controladoras y sexualmente agresivas representó una condensación de su masculinidad y aquellas cualidades del dominio desplazado de la madre. Pero el paciente no podía integrar estos entendimientos, y el tratamiento continuó avanzando en la dirección de un trabajo

adicional sobre sus conflictos edípicos. Esta breve viñeta ilustra cómo, en una etapa avanzada de psicoterapia psicológica con un paciente fronterizo (después de años de trabajo a través de mecanismos defensivos primitivos y relaciones de objetos en la transferencia), se produjo un predominio gradual de conflictos edípicos, SI-Músicamente con un cambio hacia los conflictos intersistémicos. Sin embargo, existía, al mismo tiempo, un cambio regresivo hacia una etapa muy temprana de la separación, la individuación de la madre que requería un cambio temporal en mi actitud y mis comentarios interpretativos. Durante estados tan regresivos, mis interpretaciones se centraron menos en los mecanismos típicos de la frontera y las transferencias de objetos parciales y más sobre las necesidades conflictivas del paciente para diferenciarse de mí y para obtener una comprensión perfecta de mí. En resumen, los conflictos de diferenciación parecían temeralmente a predominar los conflictos de acercamiento patológico.

CAPÍTULO 8: Psicoterapia expresiva con adolescentes Las tareas fundamentales del terapeuta durante la evaluación temprana del paciente adlescente y su familia incluyen establecer el diagnóstico, el tratamiento recomendatorio y, sobre todo, deletrean los acuerdos que deben hacer posible el tratamiento. Es difícilmente debe subrayarse que el psiquiatra que evalúe a un paciente adolescente y su familia deben mantener una actitud técnicamente neutral. Debería tener un respeto total por el adolescente como una persona independiente y autónoma y debería aportarlo sin nociones preconcebidas sobre lo que haría o no sería adecuado en términos de las negociaciones del paciente con su familia. El terapeuta debe evitar ser juzgando o romanticista la adolescencia. Debería estar alerta a la tendencia de los adolescentes a pensar en él como representante de sus padres e igualmente consciente de que los adolescentes no necesariamente tienen una visión especial de las verdades básicas que se están afectadas a los adultos. Sobre esta base, el terapeuta puede explorar la consistencia interna de la imagen del adolescente de sí mismo, sus importantes relaciones de objetos y la integración y adecuación de su visión del mundo. La aceptación del adolescente dentro de sus propios supuestos y los sistemas de valores es más probable que permita una evaluación de la consistencia de su auto y las representaciones de objetos y estos sistemas de valor. Al mismo tiempo, el terapeuta debe mantener la distancia adecuada, en contraste con la lejanía protectora o la confección. El adolescente tiene tanto derecho a la privacidad como paciente adulto. Si un adolescente quiere la consulta, el psiquiatra debería verlo antes de ver a sus padres. Cómo llegan sus padres a la imagen, si en absoluto, deben negociarse con él. Si los padres solicitan una consulta, ya sea que se vea el adolescente, primero o la familia debe verse juntos. Si el terapeuta tiene reuniones preliminares con los padres antes de que comience la consulta o el tratamiento, cualquiera de los 131

132 Tratamiento de personalidades límite Las personalidades que existen potencial paranoico en el adolescente se reforzarán, y la postura neutral del terapeuta será más difícil de establecer. El mismo derecho a la privacidad se aplica a la información del adolescente. El paciente puede acordar permitir que parte de la información que ha proporcionado se discute en las reuniones con la familia, pero debe tener la opción de decidir que cierta información no debe compartirse. Naturalmente, si hay evidencia de que el paciente está reteniendo información importante, el terapeuta puede tener que recurrir a un equipo que pueda incluir a un trabajador social psiquiátrico, un consejero escolar, un psicólogo, un maestro y otros. Esto recauda de inmediato el problema de los intentos del paciente y / o su familia de lograr el control de la situación de tratamiento, una complicación con frecuencia encontrada en casos de adolescentes. Tipialmente, la familia o el paciente intentan dictar condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el tratamiento o la evaluación. Me parece preferible interrumpir una evaluación o tratamiento en lugar de aceptarlo sin menos condiciones óptimas. Muy a menudo, una expresión temprana y tranquila de la intención del terapeuta de reservar el derecho de evaluar o tratar al paciente o reírlo a otra persona si el terapeuta lo encuentra imposible de obtener suficiente libertad de acción ayuda a prevenir a un rango que actúe posteriormente o Luchando por el control omnipotente. A veces, la mejor ayuda que se puede dar es decirle a la familia que si el tratamiento no se puede cargar bajo ciertas circunstancias, los esfuerzos de tratamiento pueden ser inútiles. Paradójicamente, cuanto más severamente perturbó el paciente adolescente tardío, cuanto más se asemeja al tratamiento que se le da a un paciente adulto, por esta razón: en la psicoterapia de los pacientes adolescentes que funcionan bastante bien, el enfoque temprano es en lo normal. Desarrollar tareas de la adolescencia. Con los adolescentes que no funcionan bien, es necesario trabajar en las disposiciones de transferencia

primitivas severamente distorsionadas, y estos son similares a los que se encuentran en los pacientes con límites de adultos. Cuando (como con los pacientes con límites), las tareas normales de desarrollo de la adolescencia no se han logrado, la psicoanalítica, la psicoterapia, ya que conceptualizada para el tratamiento de los pacientes adultos, desempeña mejor el propósito de resolver transferencias primitivas, operaciones defensivas primitivas y la Ego y distorsiones del superego que se dirigen a la realización de estas tareas de desarrollo. La resolución de la psicopatología de bordes por medios analíticos permitirá la reanudación espontánea de los procesos de desarrollo normales más adelante. Debido a la diferencia de edad significativa y, por lo tanto, la diferencia en el papel y el estado entre el paciente adolescente y el psicoterista, el paciente generalmente está tentado a verse a sí mismo como "un adolescente" que se relaciona con un "adulto" estereotipado. Por ejemplo, la contención de los adolescentes límite, con la más mínima de las justificaciones, que el terapeuta piensa, se comporta y lo trata exactamente como lo hacen los padres del paciente pueden ser menos una manifestación de transferencia específica que un esfuerzo por la parte del paciente para evitar la conciencia de su confusión, sospecha, comportamiento despectivo, y

Psicoterapia expresiva con adolescentes 133 así, sobre los adultos significativos en su vida, los simpágramados a todos juntos. Como parte del examen sistemático de la interacción terapéutica, por lo tanto, el terapeuta puede tener que examinar la negación del paciente de la individualidad del terapeuta, así como de su propia individualidad al tomar ref-uge en el comportamiento estereotipado de un subgrupo cultural. Una posición de neutralidad técnica no significa que el terapeuta permita que el paciente le descargue todos los sesgos y estereotipos acumulados que protegen al paciente contra y reflejen su difusión de identidad. Es posible aclarar tales distorsiones sin decirle al paciente: "No, no soy la forma en que me ves". La declaración general, "no tienes razón para verme de esta manera en lugar de de muchas otras maneras; por lo tanto, debe haber significado para que sea tan importante para usted verme con precisión de esta manera", cubre el problema. Los pacientes con límites de adolescentes a menudo intentan inducir enérgicamente en el terapeuta las actitudes que acusan a los adultos, especialmente a sus padres, de tenerlo hacia ellos. Esto refleja, en particular, el mecanismo de identificación proyectiva. El estado de alerta del terapeuta a tales desarrollos puede permitirle interpretar el esfuerzo inconsciente del paciente para que se convierta en una imagen más parental. Al mismo tiempo, el terapeuta puede tener que resistir una tendencia a comportarse de manera opuesta a la familia de los adolescentes, ya que el paciente los describe como comportándose; El Thera-Pist debe tener cuidado de tratar de fomentar una buena relación terapéutica por medios seductores. Una actitud seductora hacia los adolescentes también se nutre por una idealización general de la adolescencia, por lo que prevalente en nuestra cultura, y por los esfuerzos inconscientes del terapeuta para defenderse contra la envidia inconsciente de los adolescentes por la romantización o Imitándolos. A veces, el esfuerzo del terapeuta para resistir los intentos del paciente de estereotiparlo, ya que convencional

puede resultar en un deseo de mostrarle al paciente que no es convencional. Por supuesto, el terapeuta debe ser poco convencional en los estereotipos culturales de pie promulgados en la transferencia; Pero su inconscentida debe surgir por medio de su postura coherente, empática, cálida, pero separada, ya que plantea preguntas sobre lo que está sucediendo en el tratamiento. Debe negarse a permitir que el paciente lo chupa a ciertos modelos a seguir y debe mantener la neutralidad técnica. En resumen, el análisis de los estereotipos culturales como defensas secundarias contra la aparición total de la difusión de identidad en la transferencia es un aspecto importante del tratamiento, particularmente en las primeras etapas de la psicoterapia con los adolescentes limítrofes. La psicoterapia expresiva y las estructuras familiares parece haber evidencia de montaje, derivadas de datos clínicos y reoquistes, que los adolescentes limítrofes provienen de la familia severamente patológica.

134 Tratamiento de las personalidades límite Hies (Shapiro et al., 1975; Goldstein y Jones, 1977). La pregunta se eleva a diez, hasta en qué medida, el paciente de adolescentes límite "simplemente" refleja la psicopatología familiar severa o está sufriendo de enfermedad "internalizada, estructurada". Creo que cada vez que un estudio cuidadoso del paciente adlescente demuestra la existencia de difusión de identidad y el predominio de las operaciones defensivas primitivas, debemos asumir que, independientemente de lo que la contribución familiar a esta enfermedad ha sido, el paciente tiene una FIDE buena. Patología fronteriza estructuralizada que reincidirá con un tratamiento individual intenso. Considerando que, en particular, los padres, en particular, los padres, pueden haber hecho contribuciones de diversión a la psicopatología fronteriza en su hijo, el diagnóstico de la organización de la personalidad límite implica estructuras intrapsícicas patológicas severas y de larga data que ahora tienen una existencia autónosa. Con el fin de llevar a cabo la psicoterapia expresiva, creo que es crucial que el terapeuta tenga una relación exclusiva con el adolescente y que la terapia familiar, si está indicada, sea llevada a cabo por otro terapeuta, el paciente debe incluirse en esa terapia familiar, la familia. El terapeuta debe tener la autorización del paciente de la familia y el paciente adolescente para comunicar sus observaciones al psicoterapeuta del paciente, estableciendo así un enfoque de trabajo en equipo similar a lo que recomiendo para aquellos pacientes límite cuya actuación severa no puede ser controlada. Para combinar la terapia familiar y la psicoterapia intensiva psicoanalíticamente orientada para el paciente con límite de adolescentes presenta complicaciones variables. Primero, los objetivos de la terapia familiar deben aclararse en un esfuerzo por diferenciar los objetivos a corto y largo plazo para todos los participantes. A veces no hay razones particulares para involucrar a la familia; La indicación de la terapia familiar debe derivar no de la predilección ideológica del terapeuta

para ese tipo de terapia, sino de las necesidades concretas, bien documentadas del paciente específico. El tratamiento familiar puede ser necesario debido a la contribución que la familia está haciendo la psicopatología del paciente o porque la patología del paciente está siendo apoyada por la estructura familiar o para prevenir, evitar o resolver la interferencia de la familia con el tratamiento del paciente. Se debe explorar la medida en que se relacionará el tratamiento familiar, el suministro o ser perjudicial para el tratamiento individual. Siempre existe un peligro de dilución de la transferencia, división de transferencia y actuación para el adolescente que se trata simultáneamente en terapia individual y familiar. Este peligro es mayor si el terapeuta familiar y el terapeuta individual no constituyen un equipo de tratamiento armonioso. En general, la división de la transferencia se evita mejor si los terapeutas conceptualizan toda la constelación de la familia, el paciente y ellos mismos como un sistema con respecto a la cual toda la información fluye hacia el psicoterapeuta individual.

Psicoterapia expresiva con adolescentes 135 El predominio de las operaciones de defensa primitivas, en particular la identificación de protección, la omnipotencia, la devaluación, la división y la demandación, pueden permitir que el paciente del límite de los adolescentes induzca la patología complementaria en el Los miembros clave de la familia con los que vive y provocan profetías autocumplidas en todas sus interacciones, que pueden convertirse en una resistencia extremadamente poderosa en el tratamiento. Es importante para que el terapeuta evalúe hasta qué punto el paciente se respeta a las presiones patológicas de sus padres y, a la inversa, está ejerciendo tales presiones sobre ellas. La respuesta a estas preguntas generalmente se encuentra en los desarrollos de transferencia, especialmente en los esfuerzos inconscientes del paciente para reproducir el comportamiento de sus padres en el terapeuta. Los análisis sistemáticos de tales intentos en la transferencia pueden ser el primer paso para ayudar al paciente a tomar conciencia de cómo perpetúa las condiciones patológicas en el hogar. Por ejemplo, la presentación patológica del paciente a lo que percibe, ya que el comportamiento sádico de sus padres generalmente se refleja en la recreación de la situación con los roles invertidos en la psicoterapia. Inconscientemente, los pacientes con adolescentes pueden tratar al terapeuta en formas omnipotentes y sádicas, proyectándole a su representación de su sufrimiento masoquísticamente, maltratada y devaluada, mientras se identifica con una imagen parental triunfante, sádica y grandiosa.. La comprensión del terapeuta de que las transferencias primitivas reflejan la activación de dichas relaciones de objeto de partes con una inversión de roles le permitirán interpretar esta relación de transferencia y luego aplicar su interpretación a las relaciones del paciente con su familia. El análisis sistemático de la interacción terapéutica, con un fuerte enfoque en la activación dentro de las relaciones de parte de partes primitivas, es el primer paso para la interpretación de las interacciones

patológicas del paciente en el hogar. Es importante tener en cuenta que dicha interpretación no es una reconstrucción genética y que las interacciones patológicas actuales con los padres pueden, a su vez, replicar una relación de objeto de partes. Esta relación de objeto parcial puede dividirse de forma defensiva de las relaciones de objeto contradictorias que deben ser examinadas primero. Solo por lo tanto, se puede obtener una comprensión de la relación total de objetos patógenos de sub-mentira contra la cual tanto la relación actual con los padres como los desarrollos de transferencia son defensas. La patología fronteriza y las tareas de desarrollo de la adolescencia por definición, los pacientes con límites de adolescentes tardíos no han logrado las tareas normales de desarrollo de la adolescencia, particularmente (1) consolando un sentido de identidad del ego; (2) Reconfirmar una identidad sexual normal, predominantemente heterosexual en la naturaleza, con la subordinación de la polivise parcial a los esfuerzos genitales y la integración inicial de las tendencias tiernas y eróticas en una relación de objeto relativamente estable, reflejada en la capacidad. Enamorarse (3) aflojando los lazos con los padres, en realidad

136 Tratamiento de las personalidades límite relacionadas con la diferenciación adecuada de los roles sexuales y generacionales en la expansión de las interacciones sociales con otros adultos y compañeros (y la correspondiente individualización intrapsíquica y estabilidad de las relaciones de objetos); y (4) reemplazando las regulaciones de superyo infantil por un sistema relativamente abstracto y paresificado, firmemente internalizado, pero flexible de la moral inconsciente y consciente que integra la tolerancia sexual de adultos con la represión firme de las luchas específicas directas. En contraste con los adolescentes normales, que experimentan un afligido real de los vínculos con los objetos infantiles, se refleja en el aumento de la distancia de y, sin embargo, profundizar las relaciones de objetos con los padres, los adolescentes limítrofes, sufriendo, como lo hacen, de la falta de diferenciación de las representaciones de objetos internalizados, se manifiestan. Participación excesiva, rebeldía violenta, sobredependencia y caos general en las relaciones interpersonales relativamente no estructuradas en el hogar. De manera similar, en psicoterapia, el paciente no solo existe una indiferencia a la terapeuta con sus imágenes de padres ni lo experimenta de manera defensiva como diferente de una manera fantástica, sino que desarrolla una alternancia caótica de las imágenes parterales parciales y parciales de partido y combinados., Y una negativa defensiva de experimentar al terapeuta de manera más realista de los padres. Para el paciente con límites de adolescentes, las diferencias entre el terapeuta y los padres a menudo significan solo un caos mayor; La indistentabilidad del terapeuta no puede ser captada. Esta situación puede dirigir fácilmente al terapeuta a asumir, por error, que el paciente adolescente necesita nuevos "modelos de identificación" y que los esfuerzos educativos directos puedan ser justificados como un medio para establecer el propio terapeuta como un modelo así. Pero la tarea de desarrollo del adolescente límite que debe completar sus procesos de la

individualización y la diferenciación se sirve mejor por interpretación y trabajo a través de transferencias primitivas. De lo contrario, las nuevas adaptaciones de la superficie al terapeuta pueden evolucionar, activar una calidad "como" en la interacción terapética y la presencia de lo que Winnicott (19603) llamó al falso yo. En contraste, la resolución de la transferencia primitiva por medios analíticos y la reanudación de los procesos de crecimiento normales en los adolescentes limítrofes van de la mano. En las etapas avanzadas del tratamiento, cuando el paciente adolescente reconoce gradualmente al terapeuta como un individuo diferenciado, la integración y la diferenciación de las imágenes de los padres se producirán en forma paralela. Este proceso puede ser ilustrado por las vicisitudes de los dos mecanismos de defensa de la idealización y la devaluación. La idealización primitiva de los modelos adultos o pares deficientes que representan las relaciones de objetos de partida dividida se trasladará gradualmente a los procesos de idealización que reflejen las formaciones de reacción contra la culpa y, más adelante, en la proyección normal de valores y aspiraciones idealizadas sofisticadas que emergen

Psicoterapia expresiva con adolescentes 137 en la misma enamorada en el amor y la idealización de los maestros admirados. Y la devaluación primitiva de los padres (la contraparte de idealizaciones primitivas divididas) se integrará gradualmente en un reconocimiento hipercrítico, hipercrítico, pero ambivalente de sus características realistas, una reacción de decepción que ahora contiene elementos de culpa y luto y Aceptación de la pérdida de imágenes parentales idealizadas primitivas. Si la postura analítica se mantiene constantemente, la relación real del paciente con el terapeuta eventualmente se convertirá en el terreno de prueba para una reanudación de los procesos de desarrollo normales. Otra área de patología de límites severa: la falta de integración de estructuras de superego, puede parecerse de manera de manera de manera de manera de manera de manera superticialmente las características normales de la redisolución parcial y la reproyección del superyó (Jacobson, 1964). La aparición de derivados de accionamiento sexual y agresivo disociado primitivos en condiciones de límite pueden enmascararse como las erupciones in-estancas de la adolescencia normal. Al principio, es difícil de diferencias difíciles de diferencias que surgen en la conciencia en el contexto de un auto concepto integrado y una constancia de objetos a partir de derivados de la unidad que expresan las relaciones de objetos parciales disociados. Sin embargo, un enfoque analítico constante de este material, los impulsos perversos homosexuales y polimorfos de la exploración del terapeuta a la luz de sus funciones dentro de las relaciones de objeto total o total activadas en la transferencia, diferenciarán las erupciones normales de la unidad de desarrollo de la estructura. Relaciones de objetos parciales y permiten la integración de las relaciones de objetos en lugar de la supresión prematura de ciertos derivados de accionamiento. El adolescente neurótico o normal reprimirá rápidamente ciertos derivados de accionamiento perverso poli-morfo e integrará a otros en su ego

conscientemente. El paciente con adolescentes límite, en contraste, puede tener que experimentar conscientemente y expresar en la transferencia (o en la transferencia actuando) unidades sexuales y agresivas que se disociadas y / o condensadas de varias maneras, durante muchos meses o años de tratamiento. Aquí, las tareas integrantes y represivas normales de la adolescencia finalmente seguirán la integración del yo y el superyó y de las bombarteras de reemplacimiento del ego. En otras palabras, la integración de la parte de las relaciones totales de objetos totales eventualmente logrará la sustitución de desaprobaciones impresivas. En resumen, creo que la finalización de las tareas normales de desarrollo de la adolescencia no requiere modificaciones especiales de la técnica psicoterapéutica propuesta para la organización de la personalidad límite en general; Como consecuencia de la resolución de las transferencias primitivas, se reanudará y se completará naturalmente en las etapas avanzadas del tratamiento. Es útil para que el terapeuta evalúe al principio, hasta qué punto se deben controlar los patrones de comportamiento severamente patológicos en o-

 Der para permitir que la psicoterapia se ponga en marcha. Si en su juicio, la relación psicoterapéutica no podrá "contener" patrones de comportamiento impulsivos que amenazan la vida del adolescente o el tratamiento, debe establecer un enfoque de equipo. Otro miembro del equipo debe llevar a cabo la responsabilidad de proporcionar una estructuración social suficiente para permitir la estabilidad de la situación terapéutica. Cabe destacar que el control externo debe ser instituido no solo para restringir ciertos comportamientos, sino también para aumentar la participación del adolescente en la vida ordinaria y para proporcionarlo con nuevos desafíos para evitar que la situación de tratamiento se convierta en su única experiencia social significativa. Los tipos y la gestión de actuar en la interacción psicoterapéutica están muy lejos de un modelo simplizado que relaciona las interacciones interpersonales actuales del paciente a las interacciones anteriores de una base individual. En la organización de la personalidad límite, la interacción actual expresa las estructuras intrapsíquicas patológicas que reflejan los tipos primitivos de interacción de una naturaleza fantástica, fantástica, tanto en el sentido de que son irreal, emocionalmente amenazadoras y extrañas, y en el sentido de que ellos manifieste una relación fragmentada, distorsionada, distorsionada, que solo refleja indirectamente las relaciones patógenas reales del pasado. El enfoque en las interactuaciones actuales en el tratamiento de las condiciones fronterizas, en la adolescencia, ya que con todos los pacientes límite, realmente comienza como un enfoque en la vida intrapsíquica del paciente, ya que se expresa en la interacción terapéutica. Los pacientes con límites de adolescentes, con su intolerancia a la experiencia subjetiva dolorosa, comienzan rápidamente a actuar en la transferencia como una defensa contra la experiencia y la introspección. La importancia de la neutralidad técnica del terapeuta radica precisamente en la necesidad de mantener la

objectividad, a fin de resaltar la distorsión del paciente por acción, lo que reemplaza una relación de transferencia primitiva. La organización de la personalidad límite siempre involucra una patología grave de caracteres y, por lo tanto, la expresión, principalmente por medios no verbales, de conflictos intrapsíquicos inconscientes en forma de patrones crónicos y repetitivos de comportamiento. Por lo tanto, los aspectos no verbales de la interacción con el terapeuta suministran información fundamental, reemplazando a una medida considerable de lo que el contenido de la comunicación verbal transmite en la situación psicoanalítica estándar. A través de su comportamiento no verbal, y por un uso particular de la lengua como la acción y como un medio para controlar la situación interpersonal, el paciente intenta activar sus relaciones intrapsíquicas de objetos de objetos en la interpersonal actual. De hecho, las transferencias primitivas pueden concebirse como unidades mutuamente disociadas de unidades extrañas, extrañas y primitivas de interacción que el terapeuta por sus interpretaciones

La psicoterapia expresiva con adolescentes 139 se transforma en la experiencia subjetiva del paciente. Uno podría decir que en esta transformación del conflicto intrapsíquico en la acción interpersonal, el paciente está recurriendo a un medio de comunicación y relación que, en términos genéticamente, previa el predominio de la comunicación verbal: la regresión en forma de comunicación es quizás el aspecto más importante. De regresión en la transferencia de pacientes límite. Para reformular esto de manera aún diferente, la expresión de su pasado intrapsíquico en términos de acción interpersonal, en lugar de recordar (en pensamientos o sentimientos), ilustra la prevalencia de actuar como una característica de los desarrollos de transferencia en pacientes con límites. Actuando fuera un concepto que se ha ampliado para incluir una amplia gama de fenómenos (Fenichel, 19453; Greenacre, 1950, 1963, 1968; Li-Mentani, 1966; Panel, 1957; Rosenfeld, 1966 A. Freud, 1968; Grinberg, 1968; Kanzer, 1968; Moore, 1968; Rangell, 1968; Panel, 1970), de la aparición de actos o comportamientos concretos en el curso de psicoanalítico. O sesiones psicoterapéuticas, actos que expresan una disposición emergente de transferencia, el paciente aún no puede tolerar subjetivamente, al desarrollo de comportamientos complejos hacia el terapeuta que exprese, en un desarrollo emocional conscientemente hacia él, el aspecto del pasado patógeno relacionado. Conflictos que aún se reprimen como una conciencia de una experiencia pasada (en contraste con presente); al desarrollo de comportamientos fuera del ajuste analítico que corresponden a aspectos de división de la transferencia; a las relaciones interpersonales perturbadas por el paciente que drenan los conflictos intrapsíquicos significativos durante el tratamiento en general. Las discusiones psicoanalíticas sobre el origen, el mecanismo y las funciones de actuación se complican constantemente por la inclusión de esta amplia gama de fenómenos, y me parece que los esfuerzos para restringir el significado del término o

redefinir subconjuntos de él (por ejemplo, "Actuar en" Como comportamiento temporal que expresa la transferencia en acciones en las horas) no ha sido particularmente útil (ver Rexford, 1978). He encontrado que es útil considerar actuar en el sentido más amplio como un aspecto esencial de los desarrollos de transferencias en pacientes con límites. En la medida en que el mundo social y interpersonal que cambia rápidamente el mundo de los adolescentes reduce temporalmente la estabilidad de sus estructuras sociales circundantes y fomenta la expresión de comportamientos experimentales antiguos y nuevos en todas las áreas, actuando en este sentido amplio es especialmente prevalente en los adolescentes de borregal. Una tarea crucial es diagnosticar cuando se realiza la salida, actuando, es decir, la expresión en acción del material de transferencia que aún no se puede tolerar en la conciencia subjetiva. ¿Cuándo se puede considerar el comportamiento patológico severa que depredó el comienzo de la psicoterapia y continúa aparentemente sin cambios por la relación psicoterapéutica? Primero, si y cuando se producen cambios significativos en una patente de comportamiento preexistente.

 deben explorarse en términos de los desarrollos en la transferencia. Es importante que el terapeuta realmente explore su significación en lugar de recompensar o castigar implícitamente los comportamientos que son favorables o desfavorables. Las razones de los cambios "positivos" deben explorarse con la misma actitud técnicamente neutral que las razones para el deterioro de los patrones. En segundo lugar, el desarrollo de un contraste sorprendente entre una relación psicoperapiéutica en la que "nada parece suceder" y las acciones dramáticas que se producen en la vida externa del paciente, independientemente de si dichas acciones predijeron el tratamiento, generalmente es una clara expresión de las desarrollos de transferencia.. Aquí, la situación típica de la patología de la línea fronteriza obtiene, en la que el paciente, incapaz de tolerar la experiencia intrapsíquica de sus conflictos, debe expresarlos en acciones, particularmente en dividir la transferencia. La disponibilidad de la relación terapética debería proporcionar idealmente un nuevo canal para expresar impulsos disgustados o reprimidos. Cuando esto no ocurre, cuando, en contrario, prevalece una atmósfera de vacío en la relación psicoterapéutica, esto debe interpretarse sistemáticamente. "El vacío" no significa solo que el paciente sienta que no tiene nada que decir o decirle al terapeuta. El vacío también puede representar el uso del lenguaje como una pantalla de humo en las horas, el llenado del vacío de las horas con las afirmaciones que reflejan el aprendizaje del paciente a "hablar de lenguaje de psicoterapia". La exploración constante de la realidad y los significados de su interacción con el paciente proporcionará el marco contra el cual el vacío o el contenido falso refleja, en contraste, la relación de objeto específica activada en la transferencia que requiere interpretación como la contraparte de división de donde la acción parece ser, a saber, en la vida exterior del paciente. En tercer lugar, actuando debe interpretarse bajo las condiciones sutiles pero frecuentes en

las que se realiza la acción en las horas y tiene el efectos de distorsión, fragmentación o destruyendo temporalmente los aspectos de la realidad de la relación paciente / terapeuta. Esta tercera categoría de condiciones es realmente el aspecto más importante del trabajo con transferencias primitivas. Lo que sigue son algunos tipos especiales de actuación en este tercio, restringido, sentido. Estos ejemplos clínicos también ilustran los principios generales involucrados en la interpretación de la transferencia con los pacientes con límites. Transformación de datos clínicos de una relación de objeto de partes en la transferencia en acción Miss O. Una niña de adolescentes fronterizas de Ly-Year, con características predominantemente infantiles o histriónicas se tragó una píldora de Darvon antes de ingresar

Psicoterapia expresiva con adolescentes 141 su sesión. Ella no era adicta a ninguna droga en particular, sino que ocasionalmente tomó una variedad de medicamentos como una forma de hacerse "sentirse bien". Este patrón deprimió el comienzo del tratamiento, pero ahora había cambiado al informe casual del paciente que había tomado una píldora antes de una sesión. Fue comprensivo de iniciar el tratamiento que le expliqué que fuera a todos los medicamentos y que no le recetaría ningún medicamento para ella como parte del tratamiento. De hecho, en este momento, hubo varios episodios de ansiedad y / o depresión relativamente grave que podrían resolverse solo por medios interpretativos, lo que ilustra por lo tanto la naturaleza defensiva de la solicitud de medicamentos del paciente. Los esfuerzos para estimular a la señorita O para explorar su comprensión de tomar el Darvon que esta vez no lo llevó a ninguna parte, excepto a ella, diciendo: "Sabes, lo hago con bastante frecuencia". Ella negó cualquier sentimiento en particular sobre cómo hacerlo a la sesión o rodear la decisión impulsiva de tomar una píldora. Se había visto bastante relajada y tranquilizada en la entrada en la sesión. Sin embargo, mientras me volvía, la invitaba implícitamente a seguir hablando, se acercaba cada vez más, finalmente expresando su temor de que la criticaría por haber tomado la píldora. Al principio, no sabía lo importante que era enfocarse en ella tomando la píldora y esperaba que surgiera un nuevo tema. Ahora, sin embargo, sentí que esto era de hecho el sujeto predominante en la mano y especulaba en privado que podría haber tomado la píldora como una expresión de desafío o para provocarme en un comportamiento crítico hacia ella y, por lo tanto, para aliviar sus sentimientos de culpa por experimentarse en una buena relación. Conmigo (Habíamos aclarado en el pasado que había prohibiciones internas profundas en una buena relación conmigo como una imagen paternal). También especulé en mi mente que la señorita O me dice que había tomado la píldora contrastada con su comportamiento secreto en el pasado, pero luego Sentí que era una

"honestidad" que no conducía a ningún otro lugar y detectaba una expresión en acción de su sentido de que las relaciones honestas no lo llevaron a ninguna parte. En ese momento, la señorita O comenzó a discutir madres totalmente diferentes; No pude conectarlos con ella haber tomado la píldora, y me sentí distraídos por mis pensamientos sobre ella después de haber tomado la píldora, y luego culpable por no pagar toda la atención a los nuevos problemas que estaba comentando. Unos minutos más tarde, la señorita O, de repente, me miró de manera inquisitiva y dijo que me estaba aburrida. Cuando le pregunté qué lo hizo pensar, ella dijo que me quedé desconcertada y distraída. Reconocí que su percepción era precisa y expresó mi desconcierto sobre su cambio de sujeto, sobre la naturaleza casual de su comentario sobre cómo tomar la píldora, como si fuera indiferente a su significado, en contraste con su preocupación por mi ser indiferente a algo que estaba diciendo después de eso. Añadí, sin embargo, que tenía razón al observar que, como consecuencia de mi comportamiento más seriamente que ella, yo

142 El tratamiento de las personalidades límite se habían distraído. Miss O dijo que sintió que le presté atención solo cuando tenía un problema. Respondí que me pregunté si había tomado la pastilla y me lo había contado como una expresión de su sentido que solo si ella se portaba mal, le prestaría atención. En este punto, evidenció sorpresa y se volvió reflexiva. Recordó que ella estaba realmente preocupada por si ella tendría algo importante para decirme antes de que ella decidiera tomar la píldora. Ahora experimenté nuestra interacción como reflexionando, a nivel de este aspecto de transferencia, la relación entre hija y madre indiferente que presta atención a su hijo solo cuando él o ella se comportan mal, mientras que el paciente estaba recreando el papel de la culpa desafiante aún. Niño, sumiso pero sospechoso, pero sospechoso. Más material en la hora confirmó esa impresión. Este caso ilustra una transformación relativamente simple de una experiencia emocional en una acción, con una negación inicial concomitante de la experiencia emocional. El siguiente caso ilustra una forma más compleja de actuación. La acción como un acreción de significados Miss P. Una chica fronteriza de l8-Año, de l8-año, con características marcadamente narcisistas que se quemaron repetidamente con los cigarrillos (y que habían sido tratados en varias ocasiones para quemaduras de tercer grado en sus brazos y piernas). SESIÓN que ella podría sentirse como quemarse durante la próxima ausencia de dos semanas de su terapeuta. Su comentario, realizado en el contexto de una discusión en curso durante muchas semanas de si ella podría controlar su tendencia a que se quemara si se le permitiera quedarse fuera del hospital (donde había sido un paciente hospitalizado), llevado a una discusión renovada de si sería un tratamiento ambulatorio para ella sería factible en este punto. Las preocupaciones realistas del terapeuta estaban en un fuerte contraste con la aparente indiferencia de la situación de la situación y a su actitud de expectativa de que todos los que cuidaban a ella naturalmente estarían preocupados y

hicieran algo para evitar que se quema. En ocasiones repetidas, el terapeuta había explorado con su atmósfera implícita de violencia y chantaje que ella creó a su alrededor, "inocentemente" obligando a sus padres, a su terapeuta y su trabajador social para que vaya a un análisis elaborado de cómo lidiar con ella mientras tratara con ella Ella sonrió, anunció su tentación de quemarse. Al comienzo de una de las últimas sesiones antes de la ausencia del Thera-Pist, la señorita P dijo que había hecho planes para pasar el tiempo de su ausencia en la casa de un grupo religioso que había sido muy apoyado en el pasado; Sintió que eso le proporcionaría un estímulo espiritual durante este período. La reacción del terapeuta a este anuncio fue un destello momentáneo de ira y luego un sentimiento de impotencia, seguido de la idea de

La psicoterapia expresiva con adolescentes 143 se resigna a dejar que lo hiciera como ella complacida sin explorar la isla más. En el curso de discutir esta sesión en particular con el terapeuta, aprendí a comprender completamente el comentario del paciente, tenía que tener en cuenta que estaba cambiando sus planes de repente y, al hacerlo, descartar con un gesto todas las discusiones serias y largas que habían tenido lugar. Entre sus padres, ella y su trabajador social con respecto a los planes para ella durante la próxima ausencia del terapeuta. El terapeuta le había proporcionado a ella y a la trabajadora social el nombre de otro psiquiatra que estaría disponible si es necesario durante su ausencia. Su cambio de planes ahora hizo que estos acuerdos se fueran irrelevantes. Además, la señorita P había pasado algunas semanas en esa casa religiosa en un momento en que se expresaba una rebeldía violenta contra sus padres en escapes frecuentes del hogar, el comportamiento autolicante y una búsqueda de padres sustitutos ideales, todos los cuales se habían explorado con gran detalle en antes. Etapas de la psicoterapia. Por lo tanto, su comentario informal sobre sus planes reflejaba su eliminación simbólica de la sustancia de un aspecto importante de su psicotery-apy. Además, reflejaba una depreciación muy concreta del terapeuta como el elemento clave en la constelación cambiada de su vida. Era como consecuencia de la psicoterapia que el comportamiento difuso, destructivo y caótico en todos los aspectos de su vida (de los cuales vivían en la casa religiosa era parte). La declaración de la señorita P también reflejó una inquietud casi estudiada, presentada de una manera natural y con pseudotones que acreditó su naturaleza impulsiva. Además, su intento de convencer al terapeuta de la gravedad de este nuevo plan, llegó de repente, entre dos sesiones, ilustró la forma espurosa en la que había estado usando comunicación verbal para transmitir la consideración aparente en las sesiones anteriores. Lo que es significativo es la forma fácil, relajada y bien organizada en la que la señorita P presentó

un plan que fue completamente disonante y destructivo en términos de todo lo que había estado sucediendo en el tratamiento. Y lo hizo en unos segundos, mientras que el análisis de las implicaciones de esa afirmación tomó literalmente una hora de mi tiempo de consulta. En otras palabras, esa declaración representó un "microscópico", pero una forma exigente y grave de actuación, que reflejaba, en lugar de una condensación de varios significados en una, una intensa acreción o compresión de múltiples significados de manera tan rápida e inmediata que Explotó temporalmente la capacidad del terapeuta para mantener o contener, para integrar la relación de objeto total que se está promulgando. Dichos episodios son frecuentes en el tratamiento de los pacientes con límites de los adolescentes. El impacto inmediato del comportamiento del paciente en el Thera-Pist puede ser precisamente el tipo de rabia, impotencia y discontinuidad de la relación emocional que el paciente intenta inconscientemente

144 Tratamiento de las personalidades límite Evite experimentar subjetivamente: esta es la realidad emocional que se ha traducido a la acción y en la violenta identificación proyectiva que afecta al terapeuta. La forma óptima de lidiar con este tipo de actuación es que el terapeuta deletrea los significados del comportamiento, gradualmente y muy plenamente, incluidas las razones para expresar en acción lo que el paciente no puede tolerar subjetivamente. El efecto neto de un intento de interpretación en tales puntos es que es posible que un breve comentario por parte del paciente tenga que ser seguida por declaraciones largas del terapeuta. Es como si el Thera-Pist, en una reconstrucción, tiene que explicar qué, en acción, se comunicó en un momento de tiempo, y el paciente a menudo puede acusar al terapeuta de hacer una montaña de un moldehill. Lo que se requiere del terapeuta aquí es una conciencia emocional completa de sus propias reacciones a la acción del paciente, combinada con la capacidad de contener esta reacción dentro de sí mismo sin, a su vez, tener que actuar en él, y luego tener que actuar en él, y luego el desarrollo graduado o la recreación de todos los aspectos emocionales de La relación que se comprimió en esa breve acción. El aislamiento de la comunicación significativa dentro de la acción crónica en la transferencia La situación que se describe aquí representa la polaridad opuesta de la acumulación de significados en las acciones repentinas que se describen. Me refiero a los pacientes con límites que, en los desarrollos concretos dentro de una hora o una breve secuencia de sesiones, proporcionan la clave para la comprensión de los patrones de transferencia complicados que parecen caóticos, aunque tienen una calidad extrañamente repetitiva durante un período de semanas o incluso meses. La señorita Q. Un adolescente límite con características severas esquizoides y las características masoquis y masoquis, llegaron a comprender en un momento, cómo experimentó que su madre se estaba deprimiendo cada vez que la señorita Q tuvo éxito o se sentía feliz. Su madre, el paciente se sintió, no

podía soportar su creciendo y se independizaba. Ella bombardeó a la señorita Q con preguntas, críticas y comentarios irónicos hasta que ella hizo que su hija se sintiera completamente indefensa y derrotada. Pero cuando la señorita Q se sentía firmada y deprimida, la madre se volvió muy cálida y apoyada; De hecho, el paciente sintió que cuando las cosas iban mal, realmente no había nadie que pudiera ser tan cálido y dar como su madre. Esta comprensión, obtenida en el contexto de un análisis de varias relaciones de objeto parcial que reflejó los aspectos de división mutuamente de este patrón de transferencia general, fue seguida por un período de mejora rápida en la confianza en sí mismo, la autonomía y la capacidad de estudiar y ampliar su vida social. Sin embargo, unos meses más tarde, la señorita Q revertida a períodos de insatisfacción crónica con el terapeuta y se reparten las complicaciones de que el terapeuta estaba controlando, rígido, dominante, que pudo

La psicoterapia expresiva con adolescentes 145 no tolera la idea de que se vuelva más independiente, y así sucesivamente. La interpretación de esta experiencia como una atribución al terapeuta de las características de su propia madre no llevó a ninguna parte. Por el contrario, la señorita Q pareció disfrutar de la parapasización irónica de las interpretaciones del terapeuta, "lo superan" paso a paso. Se produjo un largo período de tiempo en el que ninguna comprensión obtenida en las horas parecía tener ningún significado. Retrospectivamente, parecía bastante fácil interpretar la negativa de la señorita Q a escuchar, su destrucción casi alegre de todo lo recibido del terapeuta, como repetición de la relación con la madre con roles invertidos: la señorita Q ahora se había convertido en una madre sádica e intrusa que no podía tolerar El éxito del terapeuta. Sin embargo, durante las muchas semanas en que la señorita Q promulgó con éxito este patrón, el sólo el terapeuta se responsabiliza de su convicción de que este fue el significado de su comportamiento fue teniendo en cuenta que la comprensión de la transferencia total ganó transitoriamente en un episodio anterior. Aquí, la actuación fuera consistía no solo en la creación de una pantalla de humo que destruiría una comprensión más temprana que el paciente había logrado, sino también en la naturaleza muy aislada de entender que el paciente podía tolerar en sí misma. En resumen, el aislamiento de breves momentos de entendimiento en profundidad puede ser en sí mismo una forma de actuar, una expresión de la intolerancia al aprendizaje como un proceso continuo debido a, por ejemplo, la culpa severa inconsciente. La función central del terapeuta como polaridad diádica y los peligros de la contratransferencia que actúan los esfuerzos del terapeuta para integrar lo que está sucediendo de manera afectiva y cognitiva, al utilizar su experiencia subjetiva como punto de partida, debe ampliar su comprensión con cualquier evidencia objetiva que se convierta en Disponible con él a través del proceso de repetición, la secuencia característica dentro de los

paradigmas de transferencia predominantes repetitivos que son tan típicos de las condiciones fronterizas. Atención cuidadosa a las secuencias de los patrones de comportamiento dominantes que ha interferido repetidamente en el pasado permite al terapeuta transformar su experiencia subjetiva en el presente en una declaración interpretativa. El riesgo principal es su mayor vigencia sobre sus reacciones emocionales, que a su vez, pueden reflejar los problemas de contraatansferencia. Hay tentaciones narcisistas para el terapeuta cuando se coloca en el centro de entender la interacción del paciente / terapeuta. Muchos pacientes con límites, especialmente aquellos con diez valientes narcisistas, acusarán al terapeuta de la grandiosidad, de inyectarse artificialmente en una situación que, en la medida en que el paciente pueda ver, no tiene relevancia emofional para él. Reevaluar el conocimiento que tiene sobre la vida actual del paciente fuera de las horas, teniendo en cuenta el problema

lems that brought the patient to treatment and the therapeutic goals, and, above all, the determination to evaluate the immediate reality of the therapeutic situation before indulging in speculation will help the therapist to withstand the threats to his objectivity. Quizás el aspecto más difícil de la interacción terapéutica es la experiencia subjetiva del terapeuta como un reflejo de un aspecto proyectado de la autoevaluación de su paciente. En otras palabras, puede ser más difícil para el terapeuta tolerar lo que el paciente, mediante la identificación proyectiva, induce en él mientras el paciente promulga la experiencia de su representación de objetos. Por lo general, es menos difícil tolerar la interacción cuando el terapeuta representa la representación de objetos del paciente directamente. En la medida en que el paciente generalmente se ve a sí mismo, como víctima de un objeto frustrante, abrumador, no disponible o sádico, la identificación con la autoimagen del paciente en tales puntos puede amenazar la capacidad del terapeuta para contener esa reacción dentro de sí mismo y usarla para las interpretaciones. Una vez más, la comprensión teórica de la naturaleza de las activaciones recíprocas de las relaciones de objetos parciales, de las representaciones primitivas de sí mismo y objetos de manera alterna, debería ayudar al terapeuta a organizar su experiencia en tan momentos. La capacidad del terapeuta para tolerar su experiencia emocional sin tener que transformarlo en acción, para derivar su interpretación de la situación en lugar de actuar sobre ella directamente, es un factor de maféreo para ayudar a la acción de transformar al paciente a la experiencia subjetiva. Me parece que hemos subestimado la normalidad de muchos adolescentes y la gravedad de la psicopatología de muchos adolescentes que llegan a nuestra atención. La psicopatología en estos adolescentes debe abordarse con una perspectiva estratégica de largo alcance en lugar de medidas de apoyo simples y a

corto plazo.

Capítulo 9: Psicoterapia de apoyo En el contexto de comparar la aplicación adecuada de la psicoanalírea, la psicoterapia psicoanalítica expresiva y la psicoterapia psicológica de apoyo, he sugerido (1980, p. 200) que "nuestro que no se puede importar En cuanto a la psicoterapia de apoyo, puede ser reexaminada y reformulada a la luz de lo que ahora conocemos sobre la psicopatología severa". En lo que sigue, realizo esa reformulación. Algunos tipo de psicoterapia de apoyo, en forma relativamente "pura" o en combinación con técnicas psicoterapéuticas expresivas, ha sido durante mucho tiempo una importante modalidad de tratamiento en la práctica diaria de los psicoterapeutas. Por lo tanto, es sorprendente encontrar tan pocas descripciones detalladas de los principios y técnicas de psicoterapia de apoyo en la literatura psicoanalítica de los últimos 40 años. Antes de 1950, la literatura orientada psicoanalíticamente en psicoterapia de apoyo se ocupaba de la aplicación de principios y técnicas psicoanalíticas a la psicoterapia en general. En ese momento, la atención se centró en enriquecer la psicoterapia orientada psicoanalíticamente, y no se hicieron esfuerzos claros para distinguir entre técnicas de apoyo y expresivo. Sin embargo, al aplicar la teoría y la técnica psicoanalítica a un enriquecimiento de un enriquecimiento de "psicotery-apy con sentido común", se describieron muchas técnicas que más adelante se convirtieron en parte de lo que ahora vemos como psicoterapia de apoyo. Tal vez las contribuciones tempranas más completas son los textos por Schilder (1938), Levine (1942) y Alexander et al. (1946). Schilder describió el asesoramiento y la persuasión, apelando a la fuerza de voluntad, lo que describe el pasado, cambiando el entorno del paciente, el análisis de la adaptación social y la hipnosis para la catarsis, para limpiar las amnesias, para repetir una escena traumática y la sugerencia. De hecho, firmemente 147

148 Tratamiento de las personalidades límite Abogados por sugerencias en general. Todas estas técnicas fueron consonantes con lo que posteriormente se llamaba psicoterapia de apoyo. No hizo una distinción aguda entre lo que hoy llamábamos la teoría de la terapia y las técnicas prácticas, pero sí lo hicieron diferentes las técnicas que utilizarían el "médico general" de los métodos a utilizar el especialista. Este último incluyó hipnosis, psicocálisis y métodos psicoanalíticos modificados, como la psicoterapia a corto plazo. El título del libro de Levine, la psicoterapia en la práctica médica (1942), sugiere a la audiencia que apuntaba. Cubierto prácticamente el mismo Schilder Ground, y se centró en lo que podría denominarse técnicas de apoyo. De hecho, es impresionante ver cuántas de las técnicas descritas por Schilder y Levine todavía se practica ampliamente. Aunque Alexander et al. (1946) Discutió los principios de la terapia psicoanítica, incluidos en el encabezado "El principio de flexibilidad" la manipulación de la relación de transferencia, probablemente una técnica de apoyo importante. El suministro de una "experiencia emocional correctiva", que recomiendan, ahora se considera generalmente una variedad de técnicas de apoyo. A principios de 19505, tales psicólogos de Ego como Gill (1951, 1954), Knight (1952, 19533), Eissler (1953), y se criticaron a Alexander (1954). Reichmann, 1959) para borrar las distinciones entre el psicoanálisis y la psicoterapia. En el contexto de esta controversia, estos teóricos intentaron definir más claramente las diferencias entre el psicoanálisis y la psicoterapia y, dentro de la psicoterapia, entre las modalidades de apoyo y expresivas. Gill (1951, 1954), en particular, la percepción de la percepción, la percepción, el descubrimiento, o, simplemente, expresiva psicoterapia psicoanalítica de la psicoterapia supresora o suportativa y diferenció a toda la psicoterapia de la psicoanálisis. Fue Gill (1954) quien explicó más claramente el asumo teórico que el propósito de las técnicas de apoyo fue fortalecer las defensas del paciente y, por lo tanto, mejorar su funcionamiento general,

mientras que las técnicas expresivas estaban destinadas a debilitar las defensas del paciente, Reorganiza el ego y promueve la reorganización de la personalidad al lograr un cambio intrapsíquico estructural. Tanto la branquia (1951) como la bibrar (1954) declararon que las técnicas de apoyo y expresivas se combinan usualmente en cualquier tratamiento psicoterapéutico. Lascripción propusieron que el empleo de algunas técnicas sobre otras determinadas hasta en qué medida un tratamiento fue de apoyo o expresivo. El Proyecto Menninger hizo operativo la definición de modalidades de apoyo de apoyo y expresivas (Wallerstein y Robbins, 1956). El tratamiento de cada paciente se definió de acuerdo con donde cayó a lo largo del continuo de lo más expresivo (psicoanal.

Psicoterapia de apoyo 149 YSI) a la menor y la más compatible con la mayoría de la psicopoterapia de apoyo (psico-terapia de apoyo), que se determinó al estudiar el uso de cada uno hecho de las técnicas y principios básicos sugeridos por la bibraring (1954), a saber, sugerencia, abreacción, manipulación (apoyo), aclaración e interpretación (expresiva) (Luborsky et al., 1958). Los resultados del Proyecto Menninger indicó, inesperadamente, que los pacientes con debilidad al ego que fueron tratados con psicoterapia de apoyo, luego de la conceptualización tradicional que tales pacientes necesitan reforzar sus operaciones defensivas y que la resolución de las resistencias por interpretación es, por lo tanto, arriesgada, lo que hizo bastante mal (Kernberg et al., 1972). En contraste, muchos pacientes en esta misma categoría que fueron tratados con psicoterapia expresiva, lo hizo notablemente bien. Como se predijo, tales pacientes hicieron bastante mal con psicoanálisis no modificado. A lo largo de la década de 1960, varias contribuciones clínicas ayudaron a especificar y aclarar los componentes de apoyo de la psicoterapia. Novey (1959), iniciando la tendencia, concluyó que el apoyo se utiliza en todos los enfoques psicoperapiéuticos. Aunque no creía que la psicoterapia de apoyo representara un completo sistema de terapia en sí mismo, describió procedimientos técnicos específicos que tenían aspectos técnicos específicos, como el apoyo verbal directo y las implicaciones de apoyo de los últimos estados y otros comportamientos verbales, así como de los psicoter-apistas. Comportamiento no verbal. Hollon (1962) describió la técnica de psicoterapia de apoyo para pacientes ambulatorios deprimidos, y Macleod y Middelman (1962) informaron sobre un tratamiento ambulatorio de apoyo para pacientes perturbados crónicamente con debilidad grave del ego. Varias contribuciones psicoanalíticas sobre técnicas de apoyo se expandieron en la idea de que la brilla y la bibrar que se muestren el refuerzo seleccionado de ciertas estrategias defensivas pueden apoyar el funcionamiento del ego

mientras aún permite un enfoque exploratorio o interpretativo en este contexto. Tarachow (1963), por ejemplo,, por ejemplo, se sugirió a medidas que estaban profundamente apoyadas dentro de una psicoterapia psicoanalítica. Sus principios primordiales fueron para suministrar al objeto infantil en realidad, para suministrar desplazamientos y estabilidad. En contraste con un énfasis en el apoyo verbal, propuso que el apoyo más efectivo sea el que el terapeuta se permite ser real para el paciente de alguna manera implícita o indirecta. Gedo (1964), de acuerdo con el GRINKER (GRINKER ET, 1961), recomendó la psicoterapia de apoyo para los pacientes "cuya capacidad integrativa del EGO es insuficiente para tolerar la ansiedad generada por las interpretaciones de Los derivados del inconsciente, cuyas relaciones de objetos consisten predominantemente de transferencias cuya irracionalidad no se puede percibir, y cuya autorrepresentación es la de un niño que carece de autonomía" (p. 534).

150 Tratamiento de las personalidades límite Tal vez el texto más completo que describa, dentro de un marco psicológico, el espectro de aspectos expresivos frente a la técnica de la técnica en todas las fases y las vicisitudes de la psicoterapia es Dewald's (1971). Se puede encontrar una revisión crítica general de la literatura de la psicoterapia psicoanítica en el libro de libros de Wallerstein (1966) y su papel posterior relacionado (1969). Miller (1969) y Langs (1973) apuntan a los aspectos de apoyo de los enfoques de internación en psicoterapia, continuando la tradición de los 19505 y 19605, que vio la psicoterapia psicoanalítica como una combinación de apoyo. E técnicas interpretativas y los efectos de las intervenciones del psicoterapeuta, también con frecuencia con características ambas y de apoyo. En contraste, dos contribuciones significativas de Inglaterra consideran la psicoterapia de apoyo como una modalidad de tratamiento específica y brindan resúmenes integrales de sus técnicas (Stafford-Clark, 1970; Bloch, 1979). Schlesinger (1969) presenta un análisis interesante de los efectos de la psicoterapia de apoyo, ya que generalmente se practica, en restituir potencialmente la gama de exploración e intervenciones del terapeuta debido al miedo a ser "expresivo" con un paciente que presumiblemente solo sería Capaz de responder a una modalidad de tratamiento de apoyo. Destaca el propósito y los efectos de apoyo de las técnicas que son exageradas o expresivas y concluyen al recomendar que los términos de apoyo y expresivo ya no se usan para denotar diferentes tipos de psicoterapia. Prefiere usarlos para describir propósitos específicos, efectos y técnicas dentro de cada modo de terapia concreta. Mientras que no estoy de acuerdo con su idea de expandir el significado del término psicoterapia de apoyo para incluir fines y efectos en lugar de solo técnicas, encuentro sus observaciones con respecto a los efectos negativos de la justificación de la psicoterapia de apoyo y expresivo en la práctica de la psicoanítica. Psicoterapia en el 19505 y 19605 una contribución importante. Las definiciones que he dado de

psicoanálisis y psicoterapia expresiva (cap. 6) se basan en las técnicas empleadas en el tratamiento. Sin embargo, los efectos de las técnicas empleadas en psicoterapia expresiva varían, sin embargo, según la gravedad de la psicología del paciente. Como he notado en otros lugares (1980, p. 199), estas técnicas tienen efectos diferentes en el tratamiento de las condiciones fronterizas y la neurosis ordinaria y la patología del carácter de noborderín. Definiría la psicoterapia de apoyo técnicamente diciendo que no usa la interpretación, utiliza parcialmente una aclaración y liberación, y en su mayoría utiliza sugerencias y lo que llamo la intervención ambiental (similar al concepto anterior de la manipulación). Aunque el terapeuta debe permanecer muy consciente de la transferencia, supervise sus desarrollos y considere cuidadosamente las resistencias de transferencia en relación con su técnica al tratar con los problemas de los personajes de los pacientes y su con-

Psicoterapia de apoyo 151 Nección a las dificultades de la vida, la transferencia no se interpreta, y el uso de sugerencias y intervención ambiental elimina la neu-calidez técnica. En conclusión, el psicoanálisis, la psicoterapia expresiva y la psicoterapia de apoyo se pueden definir en términos de (i) las principales herramientas técnicas utilizadas (aclaraciones e interpretación versus sugerencias y intervención ambiental), (2) la medida en que se interpreta la transferencia y (3) El grado en que se mantiene la neutralidad técnica. Las indicaciones y contraindicaciones para la psicoterapia de apoyo se detallan en detalle en el Capítulo 10. Aquí diré solo que la terapia de apoyo generalmente es apropiada como un tratamiento de la última reincidencia, es decir, cuando se deben descartar otros modos. Otro punto se destaca. Por razones descritas en el Capítulo 10, es más fácil moverse de la psicoterapia expresiva a la de apoyo que en la otra dirección. Objetivos de tratamiento y responsabilidades de los pacientes Es importante al recomendar la psicoterapia de apoyo (y también la psicoterapia y el psicoanálisis expresivos) para aclarar temprano en la consulta o al inicio del tratamiento, los objetivos generales y los objetivos específicos del tratamiento, para definir al menos un área en la que el paciente y Los terapeutas están de acuerdo con respecto a estos objetivos, para distinguir los objetivos de tratamiento de los objetivos de la vida (TICHO, 1972), y para enfatizar que la psicoterapia se realiza conjuntamente por el paciente y el terapeuta. La función de los productos es contribuir con el conocimiento que puede ayudar al paciente a comprenderse a sí mismo y a sus conflictos mejor y, en consecuencia, trabajar de manera más efectiva en sus conflictos y problemas en realidad. Precisamente porque las oportunidades para el análisis sistemático de las transferencias primitivas del paciente y las percepciones mágicas y las expectativas son menos disponibles en esta modalidad de tratamiento que en las formas expresivas, es aún más importante en la psicoterapia de apoyo para crear una base racional para el

tratamiento que constituirá un Límite de la realidad contra la cual las distorsiones de la transferencia pueden ser diagnosticadas y modificadas posteriormente. Las responsabilidades continuas del paciente para su propia vida deben ser explicadas, y si se anticipa la necesidad de apoyo externo, se debe definir su estructura y relación con la psicoterapia. Una ventaja importante de la terapia de apoyo es que la frecuencia de las sesiones se puede ajustar, de dos o tres por semana a una por semana, una cada otra semana, o incluso menos. Sin embargo, las sesiones menos frecuentes, lo más importante es evaluar el trabajo que el paciente se llevó a cabo entre las horas de tratamiento en relación con lo que se ha aprendido en las sesiones, y lo más importante es que el terapeuta

152 Tratamiento de las personalidades límite Conecte activamente el contenido de una sesión con otra. De hecho, esta es una forma de no interpretación de trabajar con el mecanismo de división: una disociación activa de la vida del paciente de sus sesiones de psicoterapia o una división defensiva de una sesión de la siguiente se puede explorar en términos de la realidad de las tareas del paciente en El tratamiento. Es esencial que el terapeuta explore la vida plena, los conflictos y los patrones de las interacciones fuera de las horas de tratamiento, y en el proceso para desafiar la vaguedad, la falta de información y los efectos distorsionadores de los mecanismos primitivos de la denegación, la fragmentación de la experiencia emocional, devaluación, y similares. Una exploración activa de la vida de la vida del paciente con la presentación pasiva del terapeuta a la supresión defensiva del paciente o la vaguedad, tiende a resaltar los mecanismos de defensa primitivos del paciente y sus funciones de resistencia y constituye el primer paso en un desafío para Tales operaciones defensivas. Si bien la decisión con respecto a la frecuencia de las sesiones se puede hacer con más flexibilidad en la terapia de apoyo que en la terapia expresiva, existen peligros para establecer una frecuencia no relacionada con la naturaleza de la tarea y los objetivos del tratamiento. Por ejemplo, la motivación principal de un paciente para el tratamiento podría ser la existencia de un problema de vida urgente, y una frecuencia de tratamiento de una sesión por semana puede no hacer justicia a su objetivo debe tomar decisiones rápidas en las principales áreas de su vida. Una frecuencia de menos de una sesión por semana puede fomentar fácilmente en algunos productos la idea de que se espera que poco sea poco a la paciencia en tales circunstancias; Esto, a su vez, puede fomentar la pasividad del paciente y una actitud paraponosa hacia la terapia. En general, existe el peligro de asociar la infrecuencia relativa de las sesiones con tratamiento que es "segundo mejor" en calidad. (El peligro opuesto, por supuesto, es intentar realizar una psicoterapia

externa en una base de una vez a la semana o menos, lo que equivale a reinar o incluso abusar de la interpretación como una técnica). Los objetivos de la psicoterapia de apoyo pueden ir Ambientés con los objetivos modestos, pero incluso modestos pueden exceder las capacidades del paciente. Un objetivo modesto para el paciente que no se espera que pueda funcionar de forma independiente en el futuro previsible es permitirle funcionar de forma autónoma dentro de sus limitaciones, con un apoyo psicológico continuo. En otros casos, la psicoterapia de apoyo puede tener la función de permitir que el paciente gradualmente busque y haga uso de estructuras ambientales de apoyo alternativas, de modo que la psicoterización pueda terminar cuando el paciente pueda reemplazarlo con estos otros apoyos (Robert Michels, comunicación personal). En general, es preferible establecer metas y objetivos que aspiran a aumentar el nivel de funcionamiento y autonomía del paciente y para cambiar a una forma de psicoterapia de apoyo más "de la custodia solo cuando se aclare que la capacidad de cooperación del paciente, sus recursos intrapsíquicos y sociales., Son insuficientes para este ambicioso objetivo. En todos los casos,

Psicoterapia de apoyo 153 Es necesario estar alerta a la presencia de ganancia secundaria de tratamiento en forma de parasitismo social crónico. Hoy en día hay una gran cantidad de pacientes que se han convertido en "expertos" para mantenerlos en hospitales de día y otras instituciones sociales que brindan refugio y algunas comodidades de vida mínimas sin requerir que cualquier responsabilidad individual o un trabajo activo de ellos (John Cody, comunicación personal.). Algunas formas de psicoterapia pueden fomentar involuntariamente a tal ganancia secundaria. Conceptos erróneos Hay una gran cantidad de conceptos erróneos con respecto a la psicoterapia de apoyo. La primera es que es "fácil" realizar dicha terapia. Es desafortunado que, incluso dentro de los programas de residencia psiquiátrica orientada a psicoanalíticamente, los terapeutas menos experimentados a menudo se les asigna casos "de apoyo" y que los terapeutas más experimentados se les asigna "expresivos". De hecho, requiere más habilidad para aplicar principios psicoanalíticos para apoyar que la terapia expresiva. La razón es que, como parte de la terapia expresiva, los fenómenos de transferencia se exploran de manera consistente en profundidad, lo que ayuda naturalmente al terapeuta a resaltar las constelaciones defensivas del paciente a medida que se manifiestan en resistencias de transferencia y, por la misma token, a Aclare los temas dominantes de los conflictos intrapsíquicos inconscientes, sus implicaciones de derivación y relaciones de objetos. En la psicoterapia de apoyo, por el contrario, las manifestaciones de las defensas y las resistencias, de los rasgos de carácter patológicos y su activación en la transferencia, de resistencias de transferencia, y de actuar son menos evidentes, y su manejo requiere mucha experiencia y habilidad técnica. Idealmente, la terapia de apoyo debe enseñarse después de una base sólida en la terapia expresiva se ha logrado. La psicoterapia de apoyo es, ya que confío en que estoy dejando claro, no simplemente "terapia con sentido común". La psicoterapia comienza donde finaliza la efectividad del

sentido común. Una segunda idea errónea sobre la psicoterapia de apoyo es que las defensas al ego primitivas deben dejarse sin interrupciones porque, dado el equilibrio supuestamente frágil de las defensas por impulsos, las interpretación puede producir una mayor regresión. A este respecto, la visión tradicional es que incluso las sesiones frecuentes tienen un efecto regresivo, de modo que el ego más débil del paciente debe ser las sesiones de terapia menos frecuentes. Este supuesto no tiene en cuenta que la regresión en el tratamiento depende de la gestión de la transferencia y los efectos de las operaciones defensivas primitivas de interpretación. Tanto el Proyecto de Investigación de Psicoterapia de la Fundación Menninger y mi trabajo clínico con las condiciones de la línea fronteriza han proporcionado evidencia que indica que las operaciones defensivas primitivas son en sí mismas el debilitamiento del ego, sino que la interpretación

154 El tratamiento de las personalidades límite de estas defensas primitivas tiene efectos de fortalecimiento del ego. Esta es una de las razones básicas que abogo la psicoterapia expresiva para las condiciones fronterizas. Puede resumirse en el siguiente dictamen: Aunque la interpretación de la transferencia dentro de la psicoterización expresiva de las condiciones fronterizas no puede ser sistemática, la interpretación de las defensas primitivas en la interacción terapéutica debe ser lo más sistematica posible. Pero, ¿qué tiene que ver esta nueva comprensión del efectos de interpretación del ego de fortalecimiento de las defensas primitivas con una técnica de tratamiento de apoyo que, por definición, no es interpretable? En mi opinión, uno de los principales requisitos técnicos de la psicoterapia de apoyo no es un trabajo no interpretativo pero coherente con las defensas primitivas en la interacción tericológica. Otro concepto erróneo sobre la psicoterapia de apoyo es la transferencia misma, porque no debe interpretarse, no debe ser focada. Pero para ignorar las manifestaciones de transferencia da como resultado una distorsión gradual de la relación terapéutica, con el terapeuta que realiza un ajuste de pseudoadaptativo a los aspectos de la transferencia del paciente en lugar de aclararlo y enfrentarlo y, por lo tanto, al riesgo de arriesgarse a la activación.

Tion of turmoil reflecting primitive transference acting out. Se desarrolla una colusión silenciosa entre el terapeuta y el paciente con respecto a las áreas clave de los conflictos del paciente, un cese de la expresión activa de estos conflictos en la situación del tratamiento, y el fomento de los mecanismos de división y actuando en la vida externa del paciente. Estos desarrollos se reflejan típicamente en una relación crónica, superficialmente amigable pero básicamente distante en las horas de terapia, mientras que toda la acción parece ocurrir algo, donde, en su lugar, en la vida del paciente. Otro concepto erróneo común es que si el terapeuta ignora los desarrollos de transferencia

negativa y los intentos de mantener una actitud consistente, paciente, "permisible", el paciente podrá realizar una "identificación con el terapeuta". En consecuencia, dentro de una atmósfera de idealización benigna del terapeuta, el paciente resolverá su crecimiento psicológico. En otras palabras, ignorar la transferencia negativa permitirá pasar por alto o transformar la organización patológica del paciente y fortalecerá su ego en el proceso. Esta suposición se ilustra por la suposición tradicional de que el silencio del terapeuta es terapéutico per se, o por el malentendido y la sobreexprensión del concepto de "I960B) de Winnicott (i960B) de" tenencia ", como si no hubiera distorsiones inconscientes en el paciente. Las percepciones del servicio se derivan de la proyección sobre él de las funciones primitivas de suministro sádico y las relaciones objetivas agresivas y disociadas. La reacción negativa paradójica comúnmente observada a la mediación psicofarmacológica incluida como parte de la psicoterapia de apoyo ilustra los efectos de actuar en los aspectos de transferencia negativa no diagnosticados en relación

Psicoterapia de apoyo 155 a la medicación. Por lo general, se paga un precio pesado cuando el terapeuta atenta a utilizar los supuestos mágicos del paciente y las idealizaciones disociadas relacionadas con la modalidad de tratamiento de apoyo. Una idea errónea final, quizás la más generalizada de todos, es que la enfermera es la paciente, menos se puede esperar que participe activamente en psicoterapia. Por lo tanto, casi por definición, no se espera que los pacientes que están en psicoterapia de apoyo asumen la responsabilidad de sí mismos o que participen activamente en el proceso de tratamiento; La psicoterapia de apoyo se convierte en una modalidad de tratamiento que se "realiza" o "administrada" al paciente. Este concepto erróneo fomenta la pasividad y hace una gran contribución a los estancamientos de tratamiento. TÉCNICAS BÁSICAS La técnica básica de la psicoterapia de apoyo consiste en explorar las defensas primitivas del paciente en el presente, y ahora, con el objetivo de ayudarlo a lograr el control sobre sus efectos por medios no analíticos y fomentando una mejor adaptación a la realidad haciéndolo consciente de la Efectos desorganizados de estas operaciones defensivas. En el proceso, la transferencia negativa de IFEST y suprimida (a diferencia de inconsciente o reprimida), se puede resaltar, reducido mediante un examen constante de la realidad de la situación del tratamiento, y se utiliza para la aclaración de problemas interpersonales relacionados. En la vida del paciente. Considere, por ejemplo, un paciente con personalidad paranoica que utiliza la identificación proyectiva, es hipersensible a las críticas, se experimenta a sí mismo como atacado por otros mientras lo está inconscientemente provocándolos a la tachuela, y se experimenta a sí mismo como se controla con sáxica mientras se está controlando sáblemente mientras se está controlando sádicamente mientras se está controlando ella. Tal control sobre los demás por medio de su comportamiento sospechoso y de control. Dicho paciente puede ser ayudado gradualmente centrándose

en una forma poco afectiva, persistentemente desafiante, pero no amenazante de cómo los patrones de sus interacciones con otros tienden a repetirse. El análisis de estas dificultades con otros naturalmente se ayudará al hecho de que el terapeuta ya ha observado a los seres similares en relación con el paciente con él. Sin embargo, muy a menudo, el análisis sistemático del comportamiento del paciente en relación con otros puede ser la primera etapa en la posterior exploración del mismo comportamiento en la situación del tratamiento. En otros casos, en contrario, la exploración temprana de la transferencia en el presente y ahora debe preceder a la exploración de estos temas en las interacciones extraterráuticas. Este último orden de prioridad es particularmente útil cuando predomina la transferencia negativa manifiesta. Si no se resuelve, esta transferencia puede amenazar la continua del tratamiento y constituir un desafío importante para la alianza de tratamiento. O considerar al paciente cuyas operaciones de división se reflejan en

156 Tratamiento de personalidades límite Idealización primitiva de algunas personas y devaluación total de los demás. Una exploración cuidadosa de las relaciones del paciente puede revelar cómo los antiguos ídolos se devaluan repentinamente o cómo sus juicios sobre otros cambian rápidamente de la idealización extrema a la devaluación total. El terapeuta puede mostrar al paciente cómo estas secuencias predecibles tienden a debilitar la objetividad del juicio del paciente de los demás y amenazar sus relaciones con ellos y cómo una reflexión crítica sobre cualquier juicio extremo de otros puede ayudarlo a discriminar su realidad. Otro ejemplo, otro ejemplo, la aclaración de la negación se manifiesta en la negligencia de un paciente de responsabilidades graves en su trabajo, junto con suposiciones míticas de que lo que se niega no tendrá ningún efecto. Existe una diferencia importante entre darle un asesoramiento a un paciente sobre cómo manejar su vida y ayudarlo a comprender cómo ciertas formas "autoatisfactuales" de funcionamiento son perjudiciales para sus intereses. El terapeuta no debe darle un asesoramiento a un paciente sobre los problemas que el paciente puede poder manejar solo, pero está evitando defensivamente. La función del terapeuta es familiarizar al paciente con las defensas primitivas y sus efectos en su evaluación de los procesos de realidad y toma de decisiones. En consecuencia, a los esfuerzos para anular los rasgos de carácter patológicos y los productos primitivos por asesoramiento con respecto al comportamiento más "normal", el terapeuta atenta a familiarizar al paciente con los aspectos conscientes y preconscientes de sus dificultades intrapsíquicas y ayudarlo a usar tal Knowlight, que el paciente tiene potencialmente y está evitando activamente. La psicoterapia de apoyo puede ser muy "permisiva" al aumentar la libertad interna del paciente para la toma de decisiones por un enfoque de enfrentamiento activo; Por otro lado, lo que a menudo se parece a la actitud permisiva de la tolera del Thera-Pist, en realidad puede reflejar la columnación inconsciente con las tendencias autodegrados del

paciente. A diferencia de la posición de neutralidad técnica que caracteriza el psicoanálisis y también es un punto de referencia constante en la psicoterapia expresiva, en la psicoterapia de apoyo, el terapeuta está deliberadamente partidista a las necesidades de la realidad externa y consciente de la PA- Las necesidades emocionales de los pacientes, en otras palabras, el terapeuta está promoviendo tanto la adaptación como la expresión de impulsos. Puede haber ocasiones en los conflictos de adaptación con la expresión de impulsos, en cuyo caso el terapeuta debe reconocer el conflicto y estar disponible para explorarlo con el paciente. Permítanme ilustrar este punto con un ejemplo en el que el Thera-Pist está revestiendo claramente con la "ID" del paciente. El Sr. R. Un hombre en sus treinta años no se atrevió a masturbarse porque pensó que su religión lo prohibiera. El Sr. R nunca fue a la iglesia o dio ninguna otra indicación de que las consideraciones religiosas fueran de importancia para él. En lugar de ayudarlo directamente a superar su inhibición sexual, me fusioné constantemente la contradicción entre esta interdicción religiosa en particular y su actitud generalmente informal hacia la religión. El pa-

La psicoterapia de apoyo 157 al paciente respondió al alternativamente, sospechándome al alternativamente a provocar que dejara caer su religión y haciéndole sentirse culpable para que él también se volvería más religioso en otros aspectos de su vida. Eventualmente, trató de convencerme de los peligros de la masturbación, identificando implícitamente con su superyó sádico mientras proyectas sus impulsos sexuales en mí. Poco a poco me pudo transmitir a él lo crítico que sus actitudes sobre la sexualidad parecían ser, independientemente de sus convicciones religiosas. Le señalé que, aunque asumía que no era miembro de su grupo religioso, estaría muy molesto si mi comportamiento no tuviera que cumplir con las costumbres de ese grupo. El Sr. R pudo reconocer eso, y más tarde, también se dio cuenta de cómo condenativamente su actitud era con respecto a las actividades sexuales de otras personas en su vida. Este desarrollo, a su vez, llevó a mi observación de que era muy crítico para sí mismo también con respecto a los asuntos sexuales, y que su convicción religiosa sirvió solo como una racionalización para una actitud emocional generalizada y enraizada. El Sr. R él mismo entonces relacionó esta actitud crítica hacia la sexualidad a las experiencias en su pasado y a sus padres perhinales con hostel. A este respecto, agregaría que siempre que tal conocimiento ocurra como un subproducto de un enfoque esencialmente de apoyo, es más bienvenido, pero no debe tentar a uno inmediatamente para ir más allá de los límites generales del enfoque de apoyo. En otras palabras, la Therpy de apoyo no desalienta a los pacientes de profundizar su conocimiento sobre sí mismos, sino que funcionan exclusivamente con material consciente y preconsciente. Debido a que las operaciones defensivas suelen ser las primitivas de las primitivas de identificación política, proyectiva o división en lugar de la represión u otros tipos de nivel superior, el material de fantasía primitivo emerge en la conciencia y las operaciones defensivas correspondientes en las manifestaciones de comportamiento, todo lo cual facilita

Trabajo terapéutico con estas defensas y contenidos en terapia de apoyo. Volviendo al Sr. R, estuve aquí claramente en el lado de la gratificación por impulsos, la "ID", pero en lugar de desafiar las racionalizaciones del paciente de su inhibición sexual determinada por el superyo, exploré con él el conflicto en el aquí, y ahora en el La transferencia, en la relación del objeto se activó cuando el paciente se identificó con una figura de suyorego sávego mientras se proyecta una representación de autoprotación impulsada. En el siguiente ejemplo, en contraste, me quedé en el lado de la realidad externa. El Sr. S. un hombre a finales de los años cuarenta alternó entre el comportamiento excesivo y rebelde hacia las personas en una posición de autoridad. Poco después de que comenzó a trabajar en una posición que había querido, comenzó a hacer comentarios muy críticos sobre su jefe. Realicé que estaba poniendo en peligro el trabajo que había trabajado de largo y paciencia para obtener, y tan pronto como las primeras manifestaciones de estos renovados

flicts with authority emerged in the treatment, I addressed the question. Dije que si su jefe era, como él afirmaba, un hombre hipersensible y vengativo, ni siquiera una expresión leve de ira o resentimiento en la parte del paciente amenazara su futuro en ese trabajo. El Sr. S inmediatamente me acusó de querer que se comportara sumisamente y de tomar el costado de su esposa (que le había advertido sobre perder su trabajo) y de otras autoridades que siempre lo estaban culpando. El Sr. S también me acusó de querer que continúe en una situación laboral que lo estaba pagando bien para que pudiera pagar por su tratamiento conmigo, independientemente de las humillaciones y los sacrificios que este trabajo conlleva. La activación en la transferencia de este patrón de vida se intensificó rápidamente, con un uso masivo de mecanismos proyectivos. Comencé por claridad a la realidad de la situación de tratamiento; Es decir, que de hecho esperaba que él me pagara nuestra tarifa acordada y no podría verlo si no podía hacerlo. Añadí que debería perder su trabajo presencial, confiaba en que pudiera encontrar otro que le permita continuar el tratamiento. En lo que a mí respecta, si continuó o no en este trabajo actual no era la esencia, pero debería pensar si estaría más satisfecho con las alternativas razonablemente disponibles. Encontré su atención sobre cómo en el pasado se había quejado amargamente porque había perdido empleos que en Retro-SPECT habían parecido atractivo para él. Durante varias sesiones, este enfoque orientado a la realidad de la intensa transferencia negativa manifiesta llevó a un aumento de las pruebas de realidad en la situación del tratamiento, a una disminución en la intensidad de esa transferencia, y a la aceptación del Sr. S de la posibilidad de que pudiera ser razonable para que él intente controlar su comportamiento. En el trabajo para no jaccionar su trabajo, mientras que todavía explora sus sentimientos sobre su jefe conmigo. Solo fue entonces cuando le señalé cómo, en

su escalada de ira y su sospecheza hacia mí, casi había vuelto a crear conmigo la situación que describía en su trabajo, lo que ilustra así su propensión a juzgar a las personas en posiciones de autoridad. También le dije que parecía adquirir una capacidad nueva y bastante impresionante para retroceder, observar su comportamiento y cambiarlo a la luz de una mejor comprensión. Este ejemplo ilustra la exploración, la aclaración y la reducción por la confrontación repetida con la realidad de la transferencia negativa manifiesta; la activación y aclaración de la identificación proyectiva en el contexto de la exploración aquí y ahora ahora de una relación de objeto primitiva y activada en la transferencia; y un enfoque generalmente de apoyo a la patología de la característica paranoica. Otro principio general de la psicoterapia de apoyo es abstenerse del uso de las declaraciones de asesoramiento, las declaraciones "de apoyo" y la "manipulación" de "asistencia", si lo hacen, explotaría las disposiciones de transferencia primitivas unanalizadas. Aclaración, confrontación, intervención ambiental.

Psicoterapia de apoyo 159 ciones, e transmitiendo directamente la opinión del terapeuta en asuntos en los que el paciente necesita un consejo objetivamente que opere a través de canales racionales y transmite que el terapeuta tenga confianza en el juicio crítico del paciente, en su capacidad de entendimiento y para usar su comprensión. Constructivamente Estoy rechazando el concepto tradicional de manipulación como una técnica de apoyo, a pesar de su uso benigno por los psicoanalistas interesados en la psicoterapia de apoyo. Creo que ha denigrado implicaciones tanto para pacientes como para psicoterapia de apoyo. Ciertamente, no podemos evitar los efectos sugestivos de las intervenciones racionales, o, a un nivel más profundo, las reverberaciones de transferencia poderosas pero no diagnosticadas relacionadas con todo lo que decimos y realizamos durante el tratamiento del paciente en la psicoterapia de apoyo. Sin embargo, si el terapeuta proporciona información, considera cuidadosamente y limitado, y la expresión directa de apoyo sobre la base de la consideración racional, se pueden obtener algunos efectos de apoyo directos y se pueden reforzar los límites de la realidad en la situación del tratamiento. Es solo en contra de estos límites de la realidad que podemos detectar defensas primitivas y distorsiones de transferencia en el tratamiento y el paciente actuando en la realidad externa. Esto también significa que cuando deseamos introducir medicamentos como parte de la terapia de apoyo, deberíamos explicar su razonamiento y lo que el paciente puede esperar de él. La medicación debe usarse en dosis farmacológicamente efectivas en lugar de para efectos de placebo. Si los efectos de placebo se desarrollan, deben diagnosticarse sin interpretarlos necesariamente, pero sin intentar explotarlos tampoco. De manera similar, si se introducen técnicas de modificación de comportamiento directo en psicoterapia de apoyo, como la terapia sexual, la hipnosis o la orientación activa para enfrentar la evitación fóbica, se debe continuar un enfoque esencialmente racional. Las

razones para introducir tales técnicas deben encajar en el contexto de los objetivos y procedimientos de tratamiento general. Si estas técnicas se introducen arbitrariamente, el sentido de responsabilidad del paciente, que el terapeuta ha estado tratando de cultivar, será socavado; Tratará de tales técnicas mágicamente o ocultará la transferencia al dividir las reacciones de transferencia del terapeuta a la técnica recién introducida. En otras palabras, es importante que el terapeuta mantenga la lógica interna y la consistencia de su esquema conceptual, sus técnicas y los entendimientos verbalizados que definen los objetivos y las responsabilidades del paciente y el terapeuta en la situación del tratamiento. Otro principio general es que las acciones del paciente a lo largo del tratamiento deben evaluarse en términos de su relación con la transferencia de la transferencia y la gratificación de las necesidades emocionales básicas en formas adaptativas en la realidad social del paciente. Es cierto que, debido a que un análisis sistemático de la transferencia no se intenta en estos casos, una exploración completa de la actuación de la transferencia está menos disponible. Pero actuando fuera

160 Tratamiento de las personalidades límite El yo también es menos indeseable que en las modalidades de tratamiento expresivas, y el nuevo aprendizaje adaptativo que se involucra potencialmente en dicha actuación debe ser diagnosticada y respaldada. Etapas iniciales del tratamiento Es crucial definir al inicio de las principales cuestiones en la vida del paciente y en su psicopatología que se explorarán y modifican en el curso del tratamiento. Esta es una condición previa para definir los objetivos del tratamiento y de los roles del paciente y el terapeuta para obtenerlos. Los objetivos del tratamiento deben ser realistas, que se lograrán por los mecanismos que puedan explicarse y discutir con el paciente en lugar de al suponer que, simplemente al reunirse, el paciente y el terapeuta lograrán mágicamente y conjuntamente lograrán una solución de los problemas del paciente. Es importante plantear la pregunta temprano si la intervención ambiental directa está justificada o necesaria, cómo se llevará a cabo y si existe la necesidad de establecer límites al comportamiento del paciente como un requisito previo para el tratamiento. Las tendencias severamente destructivas o autodestructivas en la vida inmediata del paciente pueden requerir precauciones tan realistas. Es necesario destacar la responsabilidad del paciente a comunicarse honestamente con el terapeuta. El paciente debe saber que se espera que realice un trabajo por su cuenta entre las sesiones. El Thera-Pist debe establecer una función de monitoreo por la cual puede evaluar de la sesión a la sesión cómo el tratamiento está influyendo en el paciente fuera de las horas. Se debe esperar que el paciente mantenga al terapeuta bien incorporado sobre los desarrollos en su vida y comuníquese con prontitud y plenamente en áreas de conflictos y dificultades. Las instrucciones iniciales para el paciente deben transmitir estas expectativas e invitarlo a comunicarse libremente y abiertamente en las sesiones; Si no hay problemas de presión, la nueva información o "reportando la recuperación", el paciente debe expresar libremente lo que

. . . . .

viene a su mente durante las horas. Las indicaciones y las contraindicaciones para el tratamiento psicofarmacológico y / u otras técnicas terapéuticas especiales deben evaluarse plenamente en las etapas iniciales del tratamiento en lugar de introducirse al azar más adelante en respuesta a la falta de mejora del paciente. En otras palabras, una integración estratégica de diversas técnicas de tratamiento como parte de un plan de tratamiento general es preferible a una introducción al azar de nuevas modalidades en respuesta a la transferencia, y las contrarrestaciones. Una evaluación cuidadosa y detallada de la personalidad del paciente y sus interacciones en su vida externa deben proporcionar información sobre sus patrones de carácter dominante y los patrones relacionados en sus correcciones de objetos significativos. Esta información hace posible predecir el futuro.

Psicoterapia de apoyo 161 desarrollos en la vida del paciente, para planificar las intervenciones diagnósticas y terapéuticas en estas áreas, y para llevar a cabo trabajando a través de un marco distintivo de indiferencia. Dentro del puesto terapéutico, el terapeuta debe diagnosticar defensas primitivas predominantes y anticipar las intervenciones técnicas orientadas a trabajar con ellos. Dañar los factores ambientales, las influencias antihiterouticas derivadas del entorno del paciente y de las fuentes ambientales de ganancia secundaria, deben diagnosticarse para la exploración en las sesiones y para la posibilidad de intervención ambiental. Un problema importante en la práctica de la psicoterapia de apoyo puede ser la imitación injustificada de la técnica psicoanalítica del terapeuta en el sentido de "sentarse atrás" y dejar la iniciativa para estructurar el contenido de las horas completamente al paciente. Esto generalmente fomenta las formas sutiles de transferencia que actúan; El paciente se desplaza a una actitud dependiente pasiva hacia el tratamiento, y los productos primitivos van bajo tierra en la transferencia. Se debe expresar al paciente a hablar abiertamente, no solo sobre sus conflictos, pensamientos y sentimientos, sino también sobre desarrollos significativos entre las horas. Mientras se debe alentar al paciente a comenzar cada hora, informando espontáneamente al terapeuta sobre su vida, el terapeuta debe hacerse las siguientes preguntas: ¿es lo que el paciente me está diciendo realmente importante o crucial? ¿Está relacionado con sus quejas iniciales o con los problemas que ahora estamos explorando? ¿Está relacionado con nuestros objetivos de tratamiento comunes? ¿Está relacionado con los problemas que estamos explorando actualmente? ¿Refleja lo que el paciente ha hecho con lo que examinamos en nuestra última sesión o sesiones? ¿Incluye nuevos problemas importantes para la exploración psicoterapéutica? El terapeuta evalúa así la colaboración activa del paciente con el tratamiento, la presencia o ausencia de continuidad en contra de los mecanismos de división, y, a un

nivel más profundo, la naturaleza de los desarrollos de transferencia. Gestión de la transferencia para ponerlo con mayor generalmente: se pueden utilizar transferencias positivas moderadamente intensas para el trabajo psicoterapéutico, pero la idealización primitiva intensa debe tratarse con cautela debido a los procesos de devaluación concomitantes que generalmente son activos en alguna otra área del paciente La vida. Las transferencias negativas latentes deben detectarse para la planificación estratégica, y la transferencia de manifiesto negativa debe explorarse activamente, clarizarse y reduzgarse de manera realista y totalmente examinando las fantasías, sentimientos y comportamientos relevantes conscientes y preconscientes y reforzando las consideraciones de la realidad.. Como dije anteriormente, la cuidadosa exploración de patrones de comportamiento repetitivos en la vida del paciente puede permitir la exploración de patrones similares en la transferencia posterior. El examen-

162 El tratamiento de las personalidades límite y la reducción realista de un cierto patrón de transferencia en las sesiones pueden abrir el camino para explorar dificultades similares en otras áreas de la vida del paciente. Es importante que el terapeuta tenga en cuenta que, en la medida en que tolera la expresión de la ambivalencia intensa hacia él, está llevando a cabo una función de mantenimiento, en el sentido de Winnicott (IGFOB). Esto reafirma al paciente de la permanencia del terapeuta; El paciente descubre que el terapeuta no se desmorona bajo el impacto de la agresión del paciente, que es posible mantener una buena relación con el terapeuta, incluso en presencia de frustración y enojo, lo que reduce los temores del paciente sobre sus propios impulsos y Fomenta el fortalecimiento de las funciones integrativas del Ego. El terapeuta ciertamente debería apoyar la búsqueda espontánea de los orígenes del paciente de su comportamiento actual en el grado en que estos se refieren a recuerdos conscientes o preconscientes. Sin embargo, el terapeuta que trabaja principalmente con material consciente y preconscioso, debe recordarse constantemente que los informes sobre el pasado del paciente necesariamente se colorearán por funciones defensivas y que a menudo, lo que la apare de las causas en el pasado realmente refleja las justificaciones y las racionalizaciones del presente. Dificultades caracterológicas. Las reconcublicciones pseudogenéticas, mediante las cuales el terapeuta usa la magia de un enfoque analítico asumido para vincular el presente presente al pasado consciente, puede reforzar los propios mitos del paciente sobre su pasado y le brindaron justificación para sus puntos de vista actuales y comportamiento. Pero una actitud general de "es posible que no sepamos de dónde proviene todo esto, pero esto es lo que significa ahora y cómo le afecta a usted y cómo tenemos que trabajar con" representa una base más realista y menos mágica para el trabajo introspectivo en la parte del paciente. Un tipo de transferencia frecuente y complicado que actúa, se está presentando el paciente como

la víctima indefensa del maltrato o la frustración por parte de otras personas. Si un paciente explica todos sus síntomas como consecuencia natural de la "realidad" de un cónyuge hostil, es importante reconocer las necesidades poco cumplidas del paciente, pero también para señalar sus propias contribuciones a sus frustraciones. Mientras que en psicotery-apy o psicoanálisis expresivo, existe la posibilidad de trabajar a través de patrones sadomasquísticos en la transferencia mediante la interpretación, en la psicoterapia de apoyo, dichas interacciones deben explorarse directamente en términos de su realidad. El terapeuta con táctica, sin embargo, consistentemente se enfrenta al paciente con cómo contribuye a sus propias dificultades. Esto puede aumentar temporalmente los desarrolladores de transferencias negativas manifiestas, que luego permitirán la exploración de las mismas dificultades en el aquí, y ahora de las horas. Al mismo tiempo, una exploración completa y detallada de las dificultades del paciente, por ejemplo, en las interacciones con su cónyuge, puede abrirse sorprendentemente por la carretera para nuevas fuentes de gratificación y la ignoración masoquista del paciente de

Psicoterapia de apoyo 163. A menudo, el trabajo cuidadoso con la "lógica oculta" de las reacciones de otras personas al paciente puede aumentar indirectamente el conocimiento del paciente sobre sí mismo. En este punto, puede ser útil comparar los enfoques de la transferencia en psicoanálisis, psicoterapia expresiva y psicoterapia supporativa. En el psicoanálisis, las defensas del paciente contra una conciencia total de sus disposiciones de transferencia se exploran sistemáticamente, lo que conduce a una transformación gradual de latente en transferencias manifiestas. Las reacciones de transferencia se evolucionan en una neurosis de transferencia de pleno derecho. El análisis sistemático de la neurosis de transferencia permite su resolución como una resistencia contra la conciencia del pasado inconsciente. Luego, la información sobre el pasado contenido en la transferencia se puede integrar con la recuperación del paciente del pasado previamente inconsciente a través de la MEMORIA y la reconstrucción. En psicoterapia expresiva, el enfoque en la transferencia es menos sistemático. El enfoque combinado en el patén predominante de la transferencia, los conflictos predominantes en la situación de vida inmediata del paciente, y los objetivos de tratamiento de largo alcance permiten a la terapeuta en cualquier sesión para decidir cuán extensivamente y profundamente el patrón de transferencia predominante debe ser explorado. Este enfoque, realizado con pacientes con buena fuerza del ego, evoluciona en un análisis limitado de los patrones de transferencia. Con los pacientes que presentan debilidad del ego, es decir, la organización de la personalidad limítrofe, la disponibilidad de material de transferencia primitiva disociada pero consciente permite la interpretación de las transferencias primitivas, lo que lleva a su transformación en transferencias "neu-roticas" más avanzadas. Estos pueden interpretarse en profundidad, aunque generalmente no se logra una reconstrucción completa del pasado inconsciente. En la psicoterapia de apoyo, el terapeuta trabaja con las manifestaciones de transferencia,

particularmente la transferencia negativa manifiesta. El esfuerzo para trabajar de manera clarificante y confrontación con los efectos de desorganización y retroceso de las operaciones defensivas primitivas (para lograr la reducción de sus efectos de debilitamiento del ego) puede llevar a la activación de los desarrollos de transferencia negativa manifiesta en las horas, que luego deben ser exploradas y resuelto, como se ilustra anteriormente. En todos los tipos de tratamiento, el trabajo con la transferencia comienza con manifestaciones de transferencias concretas y preconscientes y se persigue a las fantasías aquí, y ahora las fantasías del paciente sobre el terapeuta se expresan y clarifican completamente. Sin embargo, en la psicoterapia de apoyo, esta exploración no está conectada interpretativa con la relación inconsciente del Pagenta con el terapeuta o con su pasado inconsciente. Es, en su lugar, se usa para enfrentar al paciente con la realidad de la situación del tratamiento y con distorsiones paralelas en su vida externa. El comienzo del trabajo con las manifestaciones de transferencia es la misma en los tres modales.

164 Tratamiento de las ideas de personalidades fronterizas, pero el punto final es muy diferente. Si un paciente en psicoterapia de apoyo presenta al terapeuta con un material de fantasía reorvivo muy primitivo, la comunicación no se descuida, sino que se remonta a los problemas de la realidad. En psicoterapia expresiva, la dirección se invierte: el camino habitual es de la realidad a la exploración de la fantasía subyacente.
Mecanismos de cambio ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se obtienen cambios en la dirección de los objetivos terapéticos en la psicoterapia de apoyo? En primer lugar, en un enfoque terapéutico directo, no manipulativo, no mágico, las funciones del Ego del paciente se prueban, se activan y se fortalecen, en particular, en las áreas de las pruebas de realidad y la autoconciencia, y en la tolerancia e integración de afectos contradictorios, Experiencias, y comportamientos. La inspección cuidadosa de las operaciones defensivas primitivas, incluso sin su resolución anapítica, debe permitir una disminución en su control previamente desconocido sobre las funciones adaptativas del ego y, por lo tanto, debe aumentar la fuerza del ego. A un nivel más profundo, la activación controlada de las relaciones de objetos primitivos en la transferencia, actuó parcialmente en momentos de transferencia negativa de manifiesto relativamente estable, así como en momentos de los cambios rápidos de ideal para devaluar la transferencia, permite una consolidación. De la confianza básica de las representaciones de autoiosos y objetos libibinalmente investidos y, de hecho, debería permitir una identificación parcial con el terapeuta. Esta identificación, sin embargo, en contraste con la identificación disociada y primitiva con el terapeuta que ocurre en función de la idealización narcisista o por el refuerzo de los mecanismos de división que dividen al mundo en objetos totalmente buenos y todos malos. La estimulación directa de una expresión más adaptativa de ambas operaciones defensivas y la gratificación de impulsos puede generar gradualmente una mejora

general en el equilibrio de impulso / defensa. Los efectos inespecíficos de todas las intervenciones terapéuticas (ver Kernberg, 1980, cap. 10) también operan aquí; Las funciones afecativas de "tenencia" y cognitiva "que contiene" del terapeuta tienen una importancia significativa en los pacientes con debilidad del Ego.

Capítulo 10: Indicaciones y contraindicaciones Para las modalidades de tratamiento basadas en psicoanalíticamente que han descrito las características distintivas de los diversos tipos de psicoterapias basadas en psicoanalíticamente, podría ser apropiado deletrear las indicaciones generales y las contraindicaciones para cada uno, así como para el psicoanálisis propio. Estos criterios no pueden basarse exclusivamente en el diagnóstico de la organización de personalidad predominantes (neurótica frente a la frontera) o en ese diagnóstico junto con la constelación predominante de los rasgos de carácter patológicos. La práctica de permitir factores externos o circunstanciales, por ejemplo, las circunstancias financieras, los factores sociales o geográficos, las preferencias y las habilidades personales de los psicoterapeutas, o las presiones externas en el terapeuta, para determinar la elección del tratamiento, es lamentable. Lo que es el tratamiento óptimo para cada caso debe tener prioridad. A veces, sin embargo, estos factores externos pueden reiniciar cambiando de lo óptimo a lo factible. Muy a menudo, compartir con un paciente lo que pensamos que sería el tratamiento óptimo para él, así como nuestra preocupación por la ausencia de condiciones realistas para dicho tratamiento, puede movilizar la participación activa del paciente. La capacidad del paciente para movilizar sus propios recursos psicológicos y psicosociales a menudo es sorprendente. El psicoanálisis, aunque la mayoría de los pacientes fronterizos, como se han establecido, lo mejor con la psicoterapia psicoanalítica modificada, existen algunos que pueden ser alizzados sin modificaciones de la técnica, y recientemente me he vuelto más optimista en este sentido. Además del potencial de vigilancia de los primeros años que actúa y la medida en que hay un ego de observación, perpaps los criterios más importantes para si un paciente límite es ANA-165

166 El tratamiento de las personalidades límite Lixables son, primero, hasta qué punto existe una cierta integración de sumino, de modo que el paciente presenta solo tendencias antisociales muy limitadas; y, en segundo lugar, la medida en que las relaciones de objetos han evolucionado de modo que al menos algunas transferencias avanzadas y neuróticas (en contraste con más primitivas) estén disponibles. Cuando las tendencias antisociales están marcadas, generalmente hay un peligro de que la distorsión consciente y la mentira invadirá el tratamiento, lo que hace que el psicoanálisis sea muy difícil, incluso imposible. Cuando el paciente tiene cierta capacidad para las relaciones diferenciadas en profundidad con otras personas, hay menos riesgo de que las transferencias primitivas tengan efectos desorganizados en la situación analítica. Por lo tanto, cuando las características de edificación diferenciadas están fuertemente presentes desde el inicio del tratamiento, y se pueden indicar tipos de transferencias integradas realistas, además de las condiciones caóticas, extrañas y fragmentadas de las condiciones fronterizas, se puede indicar el psicoanálisis. Este es particularmente el caso de las personalidades infantiles con características histéricas que funcionan en un nivel límite. El psicoanálisis es el tratamiento de la elección para los pacientes que padecen personalidad histérica, personalidad obsesiva-compulsiva y personalidad depredada-masoquista. El psicoanálisis también se puede indicar para pacientes con histeria de tipo-dos o de tipo-dos o tipo zetzel y tipo tres, es decir, pacientes con una mezcla de formas infantiles e histéricas. (Zetzel-type uno histérsics corresponden a la personalidad histérica propia, y Zetzel-Tipo-Cuatro a los casos más severos de personalidad infantil). Aquí, las consideraciones individuales pueden determinar que incluso si la organización de personalidad de línea de frontera está presente, el tratamiento debe ser psicópata análisis. Una consideración similar se obtiene con las personalidades narcisistas que, a pesar de una organización de

personalidad fronteriza subyacentes, no presentan características de la frontera manifiesta (ausencia general del control de impulsos, la tolerancia a la ansiedad y la canalización sublimatoria) u otros pronósticos. Indicadores negativos (infiltración del yo morizo patológico con agresión, cualidades antisociales, deterioro extremo o pobreza de las relaciones de objetos). En resumen, el psicoanálisis es el tratamiento de la elección para los pacientes con una organización de personalidad neurótica, para las personalidades narcisistas, no funcionan en un nivel de límite abiertas, y para pacientes que manifiestan algunas estructuras mixtas infantiles e histéricas. Ciertos requisitos, sin embargo, existen para el psicoanálisis. Dado el hecho de que el psicoanálisis requiere cuatro o cinco sesiones semanales, el tiempo y el dinero deben estar disponibles, excepto en las ciudades grandes donde los institutos psicoanalíticos ofrecen un tratamiento de bajo costo como parte de sus funciones educativas. Es útil considerar para pacientes con psicoanálisis cuya personalidad y potencial social y cultural son prometedores. El tema aquí es un esfuerzo para maximizar el beneficio de un tratamiento tan caro y largo. El psicoanálisis generalmente presupone al menos inteligencia normal, un

Indicaciones y contraindicaciones para el tratamiento 167 Patología de las relaciones de objetos que son relativamente moderadas, solo características antisociales leves, una motivación adecuada para el tratamiento y la capacidad de introspección o visión. Las manifestaciones no específicas de la debilidad del ego deben estar ausentes. La psicoterapia expresiva de la psicoterapia expresiva es el tratamiento de la elección para la mayoría de los pacientes con una organización de personalidad límite, específicamente para aquellos con personalidad fantiles, personalidad narcisista con características de frontera abierta, personalidad narcisista con condensación de la grandiosa patológica Self con la agresión, y los pacientes que presentan una mezcla de rasgos de personalidad paranoicos narcisísticos y fuertes. La personalidad esquizoide, la personalidad paranoica y la personalidad sadomasoquista con predominio de la autodestrucción y sin características siestas que amenazan la vida son otros tipos adecuados para psicotery-apy expresivo. Los pacientes con autodestructividad crónica grave (como las tendencias de autocutación, las tendencias suicidas como "forma de vida" y la anorexia nerviosa) son adecuadas para este tipo de psicoterapia, si se puede proporcionar una estructura externa suficiente para prevenir o controlar la actuación que de otro modo puede amenazar la continuación del tratamiento o la vida del paciente. El establecimiento de dicha estructura social no debe evitar que el terapeuta mantenga una postura esencialmente neutral. Personalidades hipomaníticas y "como si" las personalidades con Pseudologia fantastica tienen un pronóstico menos prometedor para la psicoterapia expresiva, particularmente para los casos de pseudologia fantastica, debido a la tendencia a mentir. La psicoterapia expresiva también tiene ciertos requisitos generales que se detallan en las categorías de diagnóstico mencionadas. En todos los casos, es importante que sea posible llevar a cabo el tratamiento con una estructuración mínima de las horas. Si se proporciona una estructura externa, el

tratamiento debe ser realizado por un equipo para que se pueda mantener la neutralidad técnica del terapeuta. En otras palabras, el terapeuta no debe intervenir directamente en la vida del paciente, y cualquier intervención sea necesaria debe ser responsabilidad de los demás miembros o miembros del equipo (un trabajador social, quizás o un consejero o enfermera). Los pacientes deben poder preservar la honestidad básica en sus comunicaciones verbales, y las características antisociales severas, incluso en un paciente, sin la personalidad antisocial, pueden ser apropiadas contraindicar la psicoterapia expresiva. Algunas formas graves de reacciones terapéuticas negativas en las que el paciente identificante con un objeto primitivo extremadamente sádico puede contraindicar la psicoterapia externa, pero es difícil juzgar esto antes de que esté en curso (excepto cuando las observaciones correspondientes se hayan documentado bien en intentos anteriores de psicoterapia). En lo largo

as there is the hope that the acting-out aspects of severe negative therapeutic reactions can be contained by the overall structure of the treatment, the therapist can try expressive psychotherapy. El compromiso de un paciente con la psicoterapia expresiva incluye una tontereza y una capacidad para cumplir un contrato para asistir regularmente, al menos dos o tres veces por semana. En mi opinión, la psicoterapia expresiva llevada a cabo de una vez por semana o menos suele ser completamente inadecuada. Con tales sesiones infrecuentes, es imposible hacer justicia al análisis de la transferencia requerida en este tipo de psicoterapia, y existe un riesgo intensivo de centrarse en la transferencia, desestimando así los desarrollos en la vida del paciente entre las horas y artísticamente. Separando la exploración de la transferencia del análisis de la situación de la vida del paciente. O bien, en un esfuerzo por actualizarse, el terapeuta puede verse obligado a enfocarse tanto en la situación de la vida del paciente fuera de las sesiones de que las manifestaciones de los conflictos del paciente en la transferencia se producen sin punto. Los pacientes que son candidatos por psicoterapia expresiva deben estar dispuestos a abstenerse de las drogas y el alcohol y de otros comportamientos físicamente autodestructivos. Si sienten que tales tendencias están fuera de control, deben estar dispuestas a reconocerlos abiertamente y aceptar informes breves. Los pacientes que son alcohólicos, drogadictos o sui- cidales crónicos no deben someterse a una psicoterapia expresiva si esos síntomas no se pueden controlar. Finalmente, esperamos al menos la inteligencia normal como un requisito previo para participar en la comunicación verbal altamente simbólica y abstracta que forma parte de la psicoterapia expresiva. La psicoterapia de apoyo dentro del amplio espectro de neurosis sintomáticos, la patotona de carácter y las condiciones fronterizas, es decir, toda la psicoterapia de apoyo a la

psicopatología no psicossicótica, rara vez, si es la modalidad del tratamiento de la elección. De hecho, creo que, como regla general, la indicación para la psicoterapia de apoyo para estos pacientes se deriva de la contraindicación por psicoterapia expresiva. En la medida en que los pacientes con buena fuerza del ego, es decir, neurosis sintomáticos y patología de caracteres de noborderina, responden a todas las modalidades del tratamiento psicoanalíticamente derivado, pero en particular a la psicoterapia o el psicoanálisis expresivo (Kernberg et al.., 1972), la psicoterapia de apoyo se indicaría solo si el paciente carece de motivación o mentalidad psicológica o carece de la capacidad o la voluntad de participar en las dos o tres sesiones por semana requeridas mínimamente para la psicoterapia ex-presiva. Es preferible cuando se considera la psicoterapia, primero en

Indicaciones y contraindicaciones para el tratamiento 169 Evalúe las indicaciones y contraindicaciones para la psicoterapia expresiva; De hecho, estrictamente hablando, es preferible primero determinar si se indica el psicoanálisis y si el paciente está analizable. Si no, la siguiente pregunta es si se determina la psicoterapia expresiva. Solo si todas las modalidades expresivas están contraindicadas, debe considerarse la psicoterapia de apoyo y se adopte una técnica de apoyo estrictamente definida. Quiero subrayar que la aparente falta de tiempo, motivación, introspección y mentalidad psicológica de un paciente, cualquiera de las cuales, si lo haría, si exacciones, contraindicar, la psicoter-apy, se evaluaría probablemente antes de establecerse en la psicoterapia de apoyo. Es ventajoso en todos los casos para llevar a cabo la evaluación institucional del paciente con un enfoque expresivo y de permitir el tiempo antes de tomar la decisión de emprender psicoterapia de apoyo. Un enfoque psicosalítico para el estudio de diagnóstico facilita la evaluación de las instituciones y contraindicaciones para todo el espectro de modalidades psicoanalíticas del tratamiento, y deja la carretera abierta para la psicoterapia expresiva o el psicoanálisis. Con el mismo diagnóstico. La historia pasada del paciente de los compromisos psicoterapéuticos puede ser de importancia fundamental para evaluar su capacidad para participar en cualquier forma de psicoterapia. Otros problemas pueden inclinar el equilibrio hacia un modo de apoyo en lugar de un expresivo. Si la enfermedad del paciente está proporcionando un grado sustancial de ganancia secundaria, el pronóstico para la psicoterapia expresante no es buena. Otras cuestiones que exhiban la terapia de expresión, la terapia expresiva incluyen la desorganización de las circunstancias de la vida externa lo suficientemente graves como para requerir intervenciones ambientales; un sentido general de la utilidad para tal intervención ambiental debido a los desarrollos potencialmente dañinos en la vida actual del paciente; una ausencia crónica de relaciones de objetos reales (pacientes

con aislamiento social grave); y la presencia de manifestaciones no específicas graves de la debilidad del ego. La gravedad de algunas de estas características, sin embargo, también puede contraindicar la psicoterapia de apoyo. Por ejemplo, la mentira crónica (incluso sin una estructura de personalidad antisocial), una historia de reacciones theréuticas negativas con comportamiento agresivo violento y actos destructivos o autodestructivos, y la actuación masoquista implacable, puede aumentar las dudas de cualquier tipo de psicoterapia. Podría ser iniciado a una base ambulatoria. Un período de hospitalización breve o extendida puede aclarar estos problemas y ampliar significativamente el rango potencial para todas las intervenciones psicopéricas. La psicoterapia de apoyo es una modalidad ideal para la intervención de crisis. Una técnica de apoyo dentro de las sesiones combinadas con intervenciones directas en el entorno del paciente proporciona un tiempo efectivo * tratamiento limitado. Este enfoque debe diferenciarse de la psicoterapia expresiva a corto plazo, un tipo especial de terapia que está curvatoria

 (Davanloo, 1980). Una pregunta interesante y probablemente todavía abierta es en qué medida una mezcla de técnicas de apoyo y expresivo es menos dañino o más efectivo en la breve psicoterapia o la intervención de crisis que en el tratamiento a largo plazo. Cuando las circunstancias se encuentran en contra de cualquier organización de tratamiento realista o indique un pronóstico extremadamente pesimista, la pregunta debe plantearse si se indica cualquier tipo de psicoterapia. El terapeuta debe aceptar el hecho de que algunos pacientes no pueden ser ayudados por ninguna intervención psicoterapéutica. Dicha conciencia aumenta automáticamente el estado de alerta para establecer requisitos mínimos para el tratamiento, la necesidad de un contrato con el paciente que implica que el paciente asume algunas responsabilidades durante el tratamiento, y una consonancia realista entre los objetivos de tratamiento y los procesos de tratamiento. También reduce las posibles tendencias hacia el exceso de celo terapéutico o espíritu mesiánico, lo que puede ser muy auto-derragado. Dentro del amplio espectro de la organización de la personalidad límite, la psicoterapia de apoyo se indica para la personalidad inadecuada (según lo define el DSM-II) y para los pacientes con patología de caracteres graves y la organización de personalidad límite que presentan características antisociales crónicamente graves, aunque no es una personalidad antisocial. Apropiado. (Vea el capítulo 5 para la discusión diagnóstica correspondiente). La personalidad antisocial tiene un pronóstico extremadamente deficiente para todas las mocalidades de tratamiento psicoanalíticamente basadas en base y probablemente no deben ser tratadas por tipos ordinarios de psicoterapia. La psicoterapia de apoyo también está indicada para todos los pacientes con organización de personalidad de bordesal que no cumplen con los requisitos de psicoterapia expresiva o psicoanalítica, aunque serían adecuados para tal modalidad sobre la base de su

constelación predominante de la patología del carácter. La psicoterapia de apoyo también tiene sus requisitos previos. El paciente debe presentar un nivel de inteligencia acorde con lo que aún es una forma verbal compleja de tratamiento, es decir, un cociente de inteligencia de al menos 75 a 100. El comportamiento autodestructivo grave debe ser controlable proporcionando apoyo en las horas y estructurando la vida del paciente fuera de las horas. Si una técnica psicoterapéutica de apoyo no puede contener la autodestructividad del paciente, que puede ser una contraindicación para cualquier tratamiento ambulatorio en este punto, y el paciente puede requerir hospitalización a corto o largo plazo. De manera similar, el desarrollo de reacciones terapéuticas negativas del tipo mencionado anteriormente, ya que la psicoterapia expresiva de la contraindicación potencialmente debe controlarse mediante medidas directas en las sesiones, así como al estructurar la vida del paciente fuera de las sesiones. Paradójicamente, reforzando las consideraciones de la realidad como parte de la tecnología

Indicaciones y contraindicaciones para el tratamiento 171 Nique de psicoterapia de apoyo tiende a reducir los efectos de las reacciones terapéuticas negativas graves, que pueden empeorar con un enfoque expresivo que proporciona una estructuración insuficiente de la vida del paciente. La psicoterapia de apoyo también requiere una situación de vida que no sea tan caótica o destructiva que una modificación del comportamiento del paciente, más que de un entorno imposible, sigue siendo una primera tarea razonable. En primer lugar, las contraindicaciones generales para las modalidades de tratamiento psicoanalíticamente basadas en todo, como se mencionó anteriormente, el diagnóstico de una estructura de personalidad antisocial prácticamente contraindece cualquier modalidad de psicoterapia basada en psicoanalitio. Además, donde la ganancia secundaria de la enfermedad supera el sufrimiento del paciente, el pronóstico para la psicoterapia es extremadamente desfavorable. Por ejemplo, los pacientes con síntomas neuróticos crónicos, rasgos hipocondríacos y dificultades interpersonales severas que se han declarado incapaz de cualquier trabajo y se aseguran de una pensión estable por el resto de sus vidas pueden tener razones realistas (además de los inconscientes) para aferrándose a sus síntomas. La falta de voluntad o la incapacidad para asistir a las sesiones regularmente, las perturbaciones severas en la comunicación verbal, y un IQ muy bajo son obvias contraindicaciones. Hay algunos pacientes cuyos implacables actuación de las tendencias autodestructivas no son controlables, ya sea debido a una necesidad no remitida de destruirse a sí mismos o debido a una combinación de tales necesidades con un entorno psicosocial conspirador en el que las relativas clave inconscientemente o desean conscientemente al paciente. Muerte. Los pacientes con una tendencia crónica a mentir, incluso sin una estructura de personalidad antisocial, tienen un pronóstico muy pobre. Realización de modalidades de tratamiento A veces, un error al sugerir psicoanálisis o psicoterapia expresiva para

pacientes con límites, es inevitable, y es necesario, después de un período de tiempo, para revisar la modalidad de tratamiento. Es relativamente fácil o seguro cambiar la modalidad del psicoanálisis a la psicoterapia. Esto se puede hacer debido a la conciencia del analista de que la actuación persistente y grave del paciente no puede ser controlada por la interpretación sola y amenaza la continuidad del tratamiento o incluso la supervivencia física o psicológica del paciente. A veces, las condiciones de realidad (a menudo provocadas en parte o total por la enfermedad del paciente) se deterioran e interfieren con el trabajo analítico. En otras ocasiones, la prevalencia de transferencias primitivas y operaciones de defensa primitivas evoluciona en una psicosis de transferencia de pleno derecho, con una pérdida de la realización de la realidad en las horas de tratamiento y la imposibilidad de reconstituir un ego de observación.

 en estas circunstancias, el analista puede reevaluar la situación con el paciente, aclarar la naturaleza de los problemas que cambian inesperadamente la situación terapéutica total y transforman el análisis en la psicoterapia. En la práctica, esto generalmente también significa llevar a cabo entrevistas cara a cara: no veo ninguna ventaja y solo desventajas en la realización de la psicoterapia psicoanalítica en el sofá en lugar de cara a cara (1975). Cuando las circunstancias se invierten, es decir, cuando lo que comenzó como una psicoterapia expresiva debería, en la opinión del terapeuta, ser transformado en el psicoanálisis, la situación es más difícil. Por lo general, en estas circunstancias, el analista ha desarrollado algunas posturas no neutrales y ha establecido parámetros o incluso modificaciones de la técnica, que pueden distorsionar la relación de transferencia con tal medida que el análisis se vuelve difícil o imposible. Por lo tanto, cuanto más neutral técnico, la posición del psicoterapeuta en una psicoterapia expresiva con pacientes con límites, más fácil será un cambio de un psicoanálisis si se indica. Ahora, el analista tiene que preguntarse a sí mismo en cualquier medida que ha utilizado técnicas de apoyo (en forma de comentarios manipulativos o sugerentes) o se realizó un uso de apoyo de la transferencia en lugar de analizarlo. Si el analista puede responder a estas preguntas satisfactoriamente en el sentido de que las distorsiones o salidas de la transferencia principal de la neutralidad se pueden resolver analíticamente, el caso aún puede desplazarse a la psicoanálisis. En otras ocasiones, especialmente si un cambio de la psicoterapia al psicoanálisis parece indicado después de meses o incluso años de tratamiento, es decir, cuando el paciente ha mejorado lo suficiente en la psicoterapia para hacer posible el psicoanálisis, puede ser preferible evaluar la situación plenamente con el paciente, estableció ciertos objetivos que Se debe lograr en la psicoterapia en sí, antes de terminarlo, y luego considerar la posibilidad de terminar la psicoterapia y el

psicoanálisis inicial, si aún se necesita, más tarde. Bajo estas condiciones, el paciente debe permanecer sin tratamiento durante al menos de 6 a 12 meses para que el efecto total de la psicoterapia pueda reevaluarse después de que haya funcionado de manera independiente durante un tiempo y el proceso de luto relacionado con la termina de la psicoterapia ha tenido una oportunidad. Para ser resuelto. El paciente debe iniciar el psicoanálisis con un analista diferente. Indicaciones para la hospitalización Ciertos aspectos de la estructura de la personalidad del paciente límite, los síntomas, la situación de vida y / o la actitud hacia su enfermedad pueden hacer que cualquier forma de psicoterapia psicoanalítica ambulatoria sea prácticamente imposible. Cuando se requiere hospitalización, el tratamiento puede ser breve (varios días a tres meses) o a largo plazo (tres meses a un año o más).

Indicaciones y contraindicaciones para el tratamiento 173 La hospitalización a corto plazo generalmente se indica cuando la estructura / síntomas / y las circunstancias de la vida de la Personalidad del paciente hacen que el tratamiento ambulatorio sea impracticable. La hospitalización a largo plazo se indica en su mayor parte sobre la base de la actitud del paciente hacia su enfermedad. Los objetivos del tratamiento con el hospital a corto plazo incluyen una evaluación de diagnóstico comprensiva, intervenciones terapéuticas para controlar los síntomas / un diagnóstico de la situación familiar del paciente y / o los sistemas de apoyo social y las circunstancias traumáticas o de conflicto, y una evaluación de lo óptimo. Tratamiento ambulatorio indicado después de la discusión, incluidas las capacidades del paciente para mantener dicho tratamiento aspectivo. El objetivo principal del tratamiento hospitalario a largo plazo para la organización de la personalidad de la línea fronteriza es la modificación de las características de la personalidad de estos pacientes que se dirigen contra su capacidad para participar y mantener la psicoterapia ambulatoria. Las características clave de la personalidad que deben modificarse en el tratamiento hospitalario a largo plazo incluyen las actitudes del paciente hacia su enfermedad y el tratamiento / que es / falta de introspección o entre visión, mala motivación para el tratamiento, y una ganancia secundaria significativa de enfermedades. Las características más negativas pronósticas para la psicoterapia ambulatoria, a saber, las tendencias antisociales graves y el deterioro o la abreviatura de las relaciones de objetos residuales, buenas e internalizadas, pueden ser indicaciones adicionales para el tratamiento hospitalario a largo plazo. Por lo tanto, los objetivos del tratamiento hospitalario a largo plazo involucran los aspectos más profundos del funcionamiento de la personalidad y requieren una exploración total de la personalidad del paciente dentro del hospital (véase Chaps. 20-22). Las características de la personalidad que garantizan la hospitalización a

corto plazo incluyen la gravedad extrema de los aspectos inespecíficos de la debilidad del ego que conlleva el riesgo de actuación destructiva o autodestructiva, un sentido paralizado de caos con la avería en todo funcionamiento social y comportamientos que, Sin ser agudamente peligroso para el paciente o para otros, ponga en peligro el futuro del paciente e implica que está "quemando los puentes" detrás de él. Características de la personalidad (o más bien, su interacción con el terapeuta) también incluye una predisposición generalizada al desarrollo de reacciones terapéuticas negativas. Los síntomas que garantizan la breve hospitalización, incluyen aquellos que implican un peligro inmediato para el paciente u otros, como las tendencias suicidas agudas / ataques de rabia incontrolables con una tendencia hacia la violencia física / abuso de drogas y / o alcoholismo que el paciente no puede controlar / y Comportamiento antisocial que / sin ser intencionalmente autodestructivo / es potencialmente por sus efectos. Las características sintonómicas también incluyen regresión aguda en la transferencia en el caso de los pacientes que se someten a psicoterapia ambulatoria, que van desde desarrollos psicóticos en la transferencia solo (psico de transferencia) hasta reacciones psicóticas agudas generalizadas. Los episodios psicóticos agudos en pacientes con límites pueden reflejar la regresión de la transferencia, muy severa

174 Tratamiento de las formas de personalidades límite de la reacción terapéutica negativa, los efectos del abuso de drogas, el alcoholismo o la agitación emocional extrema. Obviamente, las características de la personalidad y los síntomas como razones para la breve hospitalización no siempre pueden ser diferenciados considerablemente, y se refuerzan unos a otros. Las situaciones de la vida que pueden justificar la breve hospitalización de los pacientes límite incluyen un desglose temporal de los sistemas de apoyo social del paciente; un ciclo vicioso derivado de los efectos desorganizados del paciente en su familia; y las reacciones patológicas, maladaptivas o inapropiables de la familia a la enfermedad del paciente. Una avería provocada al alejarse de la universidad o al regresar a casa después de una ausencia, puede generar tal ciclo, y una breve hospitalización puede proteger al paciente y estabilizarlo, así como su sistema de apoyo social. En resumen, todas las características de personalidad, sintomáticas y ambientales mencionadas hasta ahora generalmente representan indicaciones para la hospitalización a corto plazo, particularmente en el caso de un primer episodio psicótico, desglose social o desarrollo de empeoramiento sintomático. Los epidelomados repetidos de este tipo pueden revelar posibles intervenciones terapéuticas que estabilizan el funcionamiento del paciente sin hospitalización, o, de lo contrario, sugerente la necesidad de hospitalización a largo plazo. La falta de una estructura de tratamiento adecuada capaz de mantener al paciente en una configuración de tratamiento ambulatoria puede justificar una breve hospitalización incluso con pacientes cuya crisis podría ser manejada sin tratamiento hospitalario. Si es un primer episodio de desglose en un paciente que se ha involucrado en una psicoterapia intensiva y a largo plazo, la adecuación de este apénio de tratamiento debe ser reevaluado, junto con la posibilidad de que lo que sucedió fue el desarrollo de una reacción terapéutica negativa o una Regresión aguda de transferencia. Estas

evaluaciones de diagnóstico y pronóstico pueden ser facilitadas por una breve hospitalización. Indicaciones adicionales para la hospitalización a corto plazo se derivan de las incertidumbres diagnósticas, por ejemplo, nuevos desarrollos sintomáticos que plantean preguntas de diagnóstico complejas. Además, una interrupción de una psicoterapia ambulatoria adecuada puede ser la consecuencia de las circunstancias externas que interfieren con las horas programadas regularmente. Una intención de ansiedad grave o depresión dentro de una situación de tratamiento ambulatoria continua puede constituir otra razón para la hospitalización a corto plazo. Las indicaciones para la hospitalización a largo plazo en la práctica coinciden con las islas relacionadas con la actitud del paciente hacia su enfermedad. Las características que se refieren a la actitud del paciente hacia su enfermedad incluyen una capacidad para la invasión, la motivación para el tratamiento y la ganancia secundaria de la enfermedad. Con respecto a la capacidad de introspección, me refiero no solo al mantenimiento de la realización de la realidad en un sentido estricto, sino una combinación de conciencia cogida y emocional y preocupación por su enfermedad, para que las experiencias del paciente deseen ser ayudadas. Puede haber evidencia de

Indicaciones y contraindicaciones para el tratamiento 175 Desglose de personalidad severa, intensificación de síntomas potencialmente destructivos o autodestructivos, y agitación social y desglose en el funcionamiento del paciente sin su presentación de dicha introspección y preocupación, y que en sí mismo puede convertirse en una razón importante para Una breve hospitalización. En contraste, una ausencia de introspección durante un período prolongado de tiempo frente a un mal funcionamiento crónico, que conduce a la reacción de cualquier tratamiento psicoterapéutico, incluso en ausencia de la pérdida de la realización de la realización, puede ser una indicación de hospitalización a largo plazo. La motivación para el tratamiento generalmente van de la mano con la introspección, pero hay pacientes cuya motivación para el tratamiento es de un tipo primitivo, un deseo de ser atendido al mismo tiempo que se niega a tomar cualquier responsabilidad por sí misma, que también puede militarmente contra la iniciación o el mantenimiento de un Relación psicoterapéutica ambulatoria. El rechazo del paciente a aceptar la responsabilidad por sí mismo puede implicar los riesgos de comportamiento destructivo o autodestructivo. Por ejemplo, algunos pacientes se resultaron en otra parte (cap. 16), como la presentación de "suicidio como una forma de vida", puede ser perfectamente consciente de la naturaleza de sus síntomas, desean ser ayudados, y sin embargo, se niega a aceptar la responsabilidad de alertar a su psiquianas. Impulsos suicidas incontrolables incluso en ausencia de cualquier otra ganancia secundaria significativa de enfermedad. Aquí, lo que podría llamarse la ganancia primaria de comportamiento autodestructivo como un triunfo inconsciente sobre o vengarse contra una imagen paterna odiada, puede militararse contra el tratamiento ambulatorio, justificando la hospitalización a corto plazo (para prevenir un intento de suicidio agudo) y, en otros Casos, hospitalización a largo plazo para alcanzar cambios más fundamentales en la actitud del paciente hacia su enfermedad como condición para un tratamiento

ambulatorio adicional. En pacientes con organización de personalidad límite, la ganancia secundaria de enfermedad es, en general, difícil de separar de la ganancia primaria. Las ganancias obvias derivadas de una relación parasitaria con la familia, la explotación financiera de otros, el control omnipotente sobre el medio ambiente expresado simbólicamente por síntomas autodestructivos que mantienen a la evidencia de los dedos de los dedos de los pies, todos pueden representar una indicación por mucho tiempo. -Termor de hospitalización orientada a modificar las actitudes del paciente en esta área, así como para ayudar a la familia a superar que se está controlando por la patología del paciente. La hospitalización a largo plazo también se puede indicar para los pacientes en un tratamiento ambulatorio psicoterapéutico intensivo apropiado apropiados para el impuesto, si presentan una forma grave de reacción terapéutica negativa, si el tratamiento no está fallando a tallar los efectos destructivos de la actuación crónica o la no remitible, Los patrones de vida autodegrados, o si la inversión en las responsabilidades normativas de la vida se está reemplazando por una inversión exclusiva en la psicoterapia en sí ("psicoterapia como reemplazo de la vida"). En todos estos casos, los objetivos del tratamiento de pacientes hospitalizados a largo plazo incluyen primero

176 Tratamiento de las personalidades límite de todos, el logro del cambio significativo de la personalidad relacionado con la reanudación de la reanudación del tratamiento ambulatorio. Las indicaciones adicionales para la hospitalización a largo plazo incluyen la falta de cambio en la impulsividad crónicamente grave y actuando, comportamiento antionso cial crónico que no se puede reducir por medio de un tratamiento ambulatorio, y el abuso de alcohol o drogas, de manera similar, a pesar de la estructuración social adecuada del entorno del paciente y Incluso de las horas de tratamiento dentro de una psicoterapia de apoyo, no se pueden controlar. Hay algunos casos en los que se puede indicar hospitalización a corto o largo plazo, pero efectivamente reemplazada por hospitalización a tiempo parcial a corto o largo plazo en hospitales diarios, mediante la colocación en una casa residual o a mitad de camino, o por la provisión de un social adicional. Sistema de apoyo, como trabajador social psiquiátrico, consejero o enfermera.

Parte Tres: Personalidades narcisistas: Teoría clínica y tratamiento.

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

CAPÍTULO II: Enfoques psicoanalíticos contemporáneos para el narcisismo Los tres enfoques principales para el estudio del narcelismo normal y patológico en el pensamiento psicoanalítico contemporáneo se deriva del documento de Freud (1914) sobre el narcisismo. Un enfoque kleiniano El primer enfoque, relativamente desconocido en este país y en base a la teoría de las relaciones con los objetos de Melanie Klein, está representada por la obra de Herbert Rosenfeld. Tiene sus raíces históricas en la descripción de las resistencias narcisistas de Abraham (1919) en la transferencia, el documento de Joan Riviere (1936) sobre la reacción terapéutica negativa, y el estudio de Melanie Klein (1957) en envidia y gratitud. En una serie de cuatro papeles altamente condensados publicados entre 1964 y 1978, Rosenfeld detallaba las características estructurales de las personalidades narcisistas y sus desarrollos de transferencia en el curso de Psy-Choanálisis. Por lo tanto, vinculó, por primera vez, un enfoque kleiniano para el tratamiento con un análisis descriptivo y característico de un grupo específico de pacientes y desarrolló la primera teoría contemporánea del narcisismo patotógico. Las personalidades narcisistas, Rosenfeld propone, han introducido omnipotentamente un objeto de pieza primitiva y / o que se proyecten omnipotentamente su propio yo "en" un objeto, de por lo tanto, negando cualquier diferencial o separación entre el yo y el objeto. Esto permite que estos pacientes deniguen cualquier necesidad de dependencia de un objeto externo. La dependencia implicaría la necesidad de un objeto amado y potencialmente frustrante que también se odie intensamente, con el odio tomando la forma de envidia extrema (Rosenfeld, 1964). La envidia, Rosenfeld asume, después de Klein, es una expresión intrapsíquica primaria del instinto de muerte, las primeras manifestaciones: 179

180 personalidades narcisistas de la agresión en el ámbito de las relaciones de objetos. Las relaciones de objetos narcisistas permiten evitar sentimientos agresivos causados por la frustración y de cualquier conciencia de la envidia. Dichos objetos externos a medida que el paciente necesita de manera realista se usa a menudo para la proyección de todas las partes indeseables del paciente "en" en ellos; En tratamiento, por lo tanto, el analista se utiliza como un "lavabo". La relación con un "analista de lavamanos" es exageradamente gratificante para el paciente narcisista porque todo lo que se desata se descarta en el analista, y el paciente atribuye a sí mismo todo lo bueno que proviene de la relación. Estos pacientes, Rosenfeld continúa, tienen una imagen automática altamente idealizada y niega omnipotemente cualquier cosa que interfiera con esta imagen. Pueden asimilar rápidamente los valores e ideas de otras personas y declararlos a ser suyos, o pueden devaluar y destruir inconscientemente lo que reciben de los demás (porque de otra manera evocaría una envidia insoportable) y, por lo tanto, tener un sentido crónico de insatisfacción con lo que reciben de otros.. Rosenfeld (1971) examina una complicación adicional de estas estructuras de personalidad, derivadas de la contaminación de su auto-idealización por la idealización de las partes destructivas omnipotentes del yo. La infiltración del yo patológico "enojado" por agresión primitiva le da a estos pacientes una calidad de autodestructividad violenta. Bajo estas condiciones, hay un odio inconsciente de todo lo que es bueno y valentable, no solo en objetos externos, sino también en los aspectos potencialmente buenos del propio yo dependiente normal del paciente. En casos extremos, tales pacientes se sienten seguros y triunfantes solo cuando han destruido a cada uno más y, particularmente, cuando han frustrado los esfuerzos de quienes los aman. El sentido del poder del paciente parece derivar de su impermeabilidad a todas las "fraguras" humanas habituales. En resumen, las personalidades extremadamente narcotísticas pueden

tener una fusión maligna de unidades libidinales y agresivas involucradas en el yo "loco", en el que la agresión predomina fuertemente. Es extremadamente difícil "rescatar" las partes sanas dependientes del yo de su posición atrapada dentro de la estructura narcisista. Rosenfeld (1975) vincula esta teoría con las formas más severas de reacción terapéutica negativa. También sugiere que la abuela inconsciente de estos pacientes puede tomar la forma de fantasías que han incorporado tanto a los aspectos masculinos como femeninos de sus objetos internos y externos para que sean totalmente inmunes a cualquier necesidad sexual, así como a cualquier necesidades dependientes El desglose de estas estructuras nargissísticas puede provocar experiencias casi delirantes de un tipo paranoico, que debe superarse por la interpretación para que el paciente pueda avanzar hacia una situación de la verdadera dependencia: en la posición relevante y la experiencia de los conflictos edípicos. El propio gobierno femenino patológico de estos pacientes refleja una más primitiva, severa,

Los enfoques psicoanalíticos contemporáneos 181 y una resistencia más intratable al tratamiento que los sentimientos de culpa inconsciente que se derivan de un superyo sádico que es característico de las formas más leves de reacción terapéutica negativa. A diferencia de algunos otros autores de Kleinian, Rosenfeld ha estado interesado en los aspectos fenomenológicos de la patología del carácter y su diagnóstico diferente. Esto ha hecho que sea más fácil integrar sus observaciones clínicas, si no su pensamiento metapsicológico, con la corriente principal del pensamiento psicoanalítico. Creo que Rosenfeld nos ha proporcionado descripciones importantes de las características clínicas de los pacientes narcisíticos, así como de sus transferencias. No estoy de acuerdo con su suposición de que la envidia es una manifestación de un instinto de muerte innato y con su tendencia a interpretar los conflictos narcisistas como si reflejaban los desarrollos casi exentos en el primer año de vida. También estoy en desacuerdo con su suposición de que las personalidades narcisistas niegan la separación entre sí mismo y objeto. Denen las diferencias entre el yo y el objeto, pero no la separación; Solo en las estructuras psicóticas encontramos una pérdida real de la diferenciación de auto-objeto. Este es en realidad un malentendido bastante común. Se refleja en la transferencia de "fusión" de Kohut (1971) y en muchos otros autores sobreexpressed del concepto de relaciones "simbióticas". El mismo malentendido resulta en la falta de diferenciar a los pacientes que niegan las diferencias con el analista de los pacientes que en realidad no pueden separar sus experiencias corporales o pensamientos de los del terapeuta. La situación del latí es característica de los pacientes esquizofrénicos en materia intensiva, pero no de la psicopatología no psicótica. La flojo del uso del término psicótico en la formulación kleiniana es uno de sus principales problemas. Además, cuestiono la suposición de Rosenfeld de que los pacientes con la mayoría de los pacientes narcisistas (así como el límite) pueden y deben ser

psicoanalizados. Yo creo que hay contradicciones entre sus recomendaciones terapéuticas y al menos algunos de los casos que él mismo presenta. De hecho, Rosenfeld más tarde (19793) concedió que no se deben analizar algunos pacientes narcisistas abiertamente fronterizos, particularmente aquellos con características violentamente agresivas, no deben analizarse. Además, ha sugerido modificaciones en la tecnología con algunos pacientes narcisistas en momentos de regresión severa (1978). Sin embargo, sobre todo, no estoy de acuerdo con la suposición kleiniana de Rosenfeld que se producen las principales etapas de desarrollo en el primer año de vida. Por lo tanto, por ejemplo, afirma (1964): "En las relaciones de objetos narcisistas, la ombotencia juega una parte prominente. El objeto, generalmente un objeto parcial, el seno, puede incorporarse omnipotemente, lo que implica que se trata como la posesión del bebé.; O la madre o el seno se utilizan como contenedores en los que se proyectan omnipotentamente las partes del yo que se sienten no deseables, ya que causan dolor o ansiedad" (PP.

182 Personalidades narcisistas 332-333). Este colapso kleiniano de todo el desarrollo en el primer año de vida y, técnicamente hablando, el tratamiento de todos los materiales primitivos, como si reflejara un nivel más temprano de desarrollo. Encuentro altamente cuestionable. Sin embargo, estoy de acuerdo con el estrés de Rosenfeld sobre la necesidad de interpretar las transferencias positivas y negativas de los pacientes narcisistas, y me encuentro especialmente importante en su enfoque en grupos específicos de pacientes narcisistas en los que el grandioso autosuficiente condense a las críticas agresivas y libidinales. También encuentro sus observaciones clínicas con respecto a las transferencias narcisistas muy útiles. Aunque mi enfoque de estas transferencias se diferencia de su suya, mi interpretación debe mucho a las aclaraciones operativas de Rosenfeld. Mi enfoque técnico, a diferencia de Rosenfeld, se centra en las implicaciones de transferencia del material sin intentar relacionarlas inmediatamente a sus asumidas fuentes genéticas; De hecho, cuanto más primitiva sea el material, más precaución se requiere antes de intentar las construcciones genéticas, ya que a un nivel de regresión de este tipo se produce una gran cantidad de reestructuralización intrapsíquica y condensación de fantasías de muchas fuentes. Mi enfoque, en contraste con la técnica general de Kleinian, también se centra mucho más en la participación del paciente en la exploración analítica; Me muestre reacio a dejar que el paciente "aprenda" sobre mis teorías y de probabilidad mucho más cautelosa y gradual que los Kleinianos en la expansión de la conciencia del paciente sobre el material inconsciente. Los pacientes aprenden rápidamente la lengua y las teorías de su analista; Esto crea un problema con el material "confirmatorio" para todos los enfoques teóricos, pero tal vez en particular con la formulación autorizada de las interpretaciones que caracterizan la escuela Kleinian. Y, por supuesto, ya que el mismo Rosenfeld ha señalado, los pacientes narcisistas están más ansiosos por aprender las teorías de sus

analistas para varios propósitos defensivos. Kohut y la psicología del yo en una serie de papeles y dos libros (1971, 1977) Heinz Kohut propusieron una metapsicología, explicaciones clínicas y un procedimiento therámico completamente diferente para los trastornos de la personalidad narcisista. En esencia, Kohut argumentó que existe un grupo de pacientes cuya psicopatología es intermediaria entre las psicosis y las condiciones fronterizas, por un lado, y las psiconeuras y los trastornos de carácter más suave, por el otro. El grupo de trastornos de la personalidad narcisista que considera que se analiza, en su opinión, se diferenciara solo por sus manifestaciones de transferencia, no por criterios puramente clínicos descriptivos. Uno diagnostica la personalidad narcisista en la situación psicoanalítica al reconocer el desarrollo de dos tipos de transferencia,

Enfoques psicoanalíticos contemporáneos 183 Idealización y duplicación. La transferencia idealizante refleja la activación therámica de una imagen de padres idealizada y se deriva de un "autobatchado" araquecológico y rudimentario. El paciente se siente vacío y impotente cuando está separado de este objeto de transferencia idealizado. Kohut sugiere que la intensidad de la dependencia de estos autolectados idealizados se debe al deseo del paciente de sustituirlos por un segmento faltante de la estructura psíquica. El equilibrio narcisista del paciente es salvaguardado solo a través del interés y la aprobación de las réplicas actuales de los autolectados traumáticamente faltantes del pasado. En segundo lugar, el paciente desarrolla una propensión a la reactivación de un ser grandioso en la situación psicoanalítica. Esta activación cuenta con recuento para el desarrollo de transferencias de espejo en el análisis. Estas transferencias de espejo se pueden diferenciar de acuerdo con tres niveles de retransmisión. La más arcaica es una transferencia de "fusión" en la que la expresión del autor grandioso envuelve al analista. Una forma menos arcaica es el "alter ego / 'o" germial ", una forma aún menos arcaica es la transferencia" espejo "en un sentido estrecho. La forma más arcaica representa el renacimiento de una etapa temprana de la identidad primaria de la identidad primaria de sí mismo y observación.. El Alter Ego, o ThinSpress, la transferencia refleja el asumo del paciente de que el analista es como él o similar a él. A través de la transferencia de espejo en un sentido estrecho, el paciente experimenta el progreso como separado, pero significativo, solo en la medida en que se necesita por la reacción. Conectado grandioso mismo por su propio propósito. Kohut propuso que dos tipos de transferencias, idealizando y duplicación, representan la activación en la situación psicoanalítica de una etapa de desarrollo arrestada, de un propio apagado arcaico. La fragilidad de ese yo arcaico requiere la empatía y las funciones normales de duplicación de la madre como" autoaptidáctico ", cuyo amor y

ministerios permiten la consolidación del propio propio grandioso y, más tarde, su desarrollo gradual de formas más maduras de autoestima y confianza en sí mismo a través de los tipos arcaicos cada vez menos arcaicos de duplicando. Al mismo tiempo, las relaciones óptimas con el software de reflejo también facilitan el desarrollo de la idealización normal del autobatchado que representa la perfección original de la grandiosa propia, ahora parcialmente conservada en la relación con un autobatjunto tan idealizado. Esta idealización culmina finalmente en lo que Kohut llama a la "Internalización de transmutación" del Solicitó un autobatjunto idealizado en una estructura intrapsíquica que originará el ideal del ego y proporcionará las cualidades idealizadoras para el superyó, preservando así la nueva regulación internalizada de sí mismo. -Estancia. La psicopatología narcisista, en esencia, Kohut propuso, deriva del fracaso traumático de la función de la maternidad empática y del fracaso del desarrollo no perturbado de los procesos de idealización. Estas fallas traumáticas provocan un arresto de desarrollo, una fijación en

184 Personalidades narcisistas El nivel del GRANDIOSO INFANTILA ARCHAIC, y una búsqueda infinita del código propio idealizado necesario para completar la formación de estructuras, todas las cuales se reflejan en las transferencias narcisistas mencionadas anteriormente. En el tratamiento, el psicoanalista debe permitir el desarrollo de la idealización narcisista del paciente de él y no debe molestarlo por interpretación prematura o consideraciones de la realidad. Esto permite el despliegue gradual de las transferencias de espejo. El paciente revive las experiencias traumáticas anteriores con una psique más madura y adquiere nuevas estructuras psíquicas, con la ayuda del analista como el código propio, por el proceso de transferencia de la internalización. El psicoanalista debe ser básicamente empático, centrándose en las necesidades y frustraciones narcisistas del paciente en lugar de en los derivados de la unidad y los conflictos que surgen en momentos de frustración narcisista en la situación analítica. Las fallas inevitables en la empatía del psicoanalista provocan circunstancias traumáticas en la situación del tratamiento, la fragmentación temporal del Seror de la grandiosa arcaica, con la activación de la rabia narcisista, las experiencias de ansiedad difusa, la despersonalización, Las tendencias hipocrondicionales, o incluso más regresión patológica en una reconstitución delirante del yo grandioso en la grandiosidad fría paranoica. En cada una de estas condiciones de frustración narcisista, el psicoanismo explora con el paciente donde y cómo el analista ha fallado en ser apropiadamente empáticamente y cómo se relaciona esto con las fallas anteriores de los objetos significativos de la infancia del paciente. Kohut insiste en que esto no requiera el establecimiento de parámetros de técnica y que represente una modificación de la técnica psicoanalítica estándar para pacientes no narcisistas, solo en que subraya la empatía del analista en el "objetivo Neutralidad" y se enfoca en las vicisitudes del yo más que en las unidades y los conflictos interestructurales (aún no existentes). Kohut

ha sugerido una diferencia fundamental entre la patología preeedipal o narcisista y la psicopatología edípica vinculada a las neurosis orina y los trastornos de carácter no narcisistas. La psicopacología de la etapa de desarrollo que comienza con la cohesión del propio propio grandioso arcaico y termina con la integración de la internalización del ideal del ego debe examinarse en términos de las vicisitudes de lo que Kohut ha llamado el "yo bipolar." Sugirió que un polo, la mayor parte de la grandiosidad nuclear del yo, se consolida en las ambiciones nucleares de la primera infancia, mientras que el otro polo, la mayor parte de las estructuras de objetivos idealizadas nucleares del yo, se adquiere un poco más tarde. Estas dos polaridades del yo derivan, respectivamente, de la aceptación de la duplicación de la madre, lo que confirma la grandiosidad nuclear, y su tenencia y cuidado, que permiten las experiencias de fusión con la omnipotencia idealizada de sí mismo. Las ambiciones nucleares y los ideales nucleares están vinculados por un área intermediaria de talentos y habilidades básicas. Kohut consideró estas estructuras componentes del ser bipolar como

Los enfoques psicoanalíticos contemporáneos 185 que reflejan tanto el origen como la sede de la psicopatología temprana, en consecuencia a las unidades y la psicopatología derivada de conflictos de la estructura tripartita de la mente que caracterizan el período edípico. Ha acuñado los términos que se convierte en un hombre trágico para referirse a la psicopatología del narcisismo y al hombre culpable para referirse a la psicopatología edípica que evoluciona bajo la influencia de las unidades> conflictos intrapsíquicos inconscientes y la estructura trifitada de la mente. Ve la agresión, la codicia y la voreciente en los trastornos de la personalidad narcisista como productos de la desintegración del yo, no los factores motivacionales de esa desintegración. Kohut reemplazó su terminación narcisista a término (1971) antes de la Transferencia de Libido con Transferencia de Bolsos, ilustrando así su abandono de su concepto de libido narcisista y objeto como "cualitativamente" diferente entre sí (en lugar de lo determinado por el Objeto en el que se invierte la libido). Este cambio resuelve el problema creado por el supuesto anterior de Kohut de que las diferentes cualidades se inherentes a la libido narticsistía y dirigida a objetos. Además, es consistente con su estrés en el desarrollo intrapsíquico temprano, como no relacionado con las vicisitudes de desarrollo de la libido y la agresión. De hecho, Kohut abundó la consideración de las unidades y el conflicto como grandes fuerzas motivacionales en las primeras etapas del desarrollo. Creía que lograr la interdelización normal de transmutación del proyecto de autofactor idealizado en una estructura innopsíquica contribuye a la consolidación de la estructura intrapsíquica tripartita según lo definido por Freud y permite el desarrollo de la conducción determinada, oedípal, Conflictos intrapsíquicos inconscientes. Como he señalado en el trabajo anterior (1975) 71, creo que Kohut ha descrito acumulado la importancia de la idealización en la transferencia. De hecho, ha contribuido fundamentalmente a la aclaración de las transferencias narcisistas al describir la

grandiosidad y la idealización como característica de ellas. Pero se ha perdido las diferencias entre los tipos patológicos de idealización activada en las transferencias narcisistas y los tipos más normales de idealización que reflejan la operación defensiva temprana de la idealización y sus modificaciones posteriores bajo el impacto de la integración de las relaciones de objetos. Por lo tanto, colapsa (i) la idealización que refleja parte de una defensa contra la agresión al dividir la idealización de la devalificación, (2) idealización como una formación de reacción contra la culpa, y (3) la idealización como una proyección de un yo grandioso patológico. Al aceptar en lugar de analizar la idealización en la transferencia, se pierde las diferencias entre los diversos niveles de desarrollo de este mecanismo de defensa. Además, Kohut ha confundido las interacciones patológicas de las condiciones de la línea fronteriza y el narcisismo patológico con su rápido intercambio de representaciones de auto y objetos, con fenómenos de fusión verdaderas que se obtienen solo en psicosis. Los casos de Kohut están lejos de parecerse a los fenómenos de fusión verdaderos, como el desarrollo en las transferencias simbióticas de los pacientes esquizofrénicos. Este

186 Las personalidades narcisistas son parte de un problema mayor: la confusión entre las declaraciones de un paciente sobre sus experiencias y la naturaleza real y el grado de regresión. Por ejemplo, un paciente diciendo que se siente confundido o, como si se queda separado, no significa necesariamente que él está sufriendo una "fragmentación de sí mismo". Además, Kohut no diferencia el propio Ser Patológica grandioso de la autoformación normal en la infancia y la infancia. En consecuencia, sus esfuerzos para preservar el propio Ser grandioso y permitir que se vuelvan más adaptados en el resultado de no resolver la patología de las relaciones de objetos internalizados, con limitaciones cruciales en los efectos del tratamiento de estos pacientes. Esta falta de distinguir lo normal de la grandiosidad patológica constituye un problema importante en la teoría de Kohut. Su declaración de que el yo tiene una línea de desarrollo independiente de la de las relaciones de objetos bien puede reflejar la consecuencia de un tratamiento que intenta preservar, proteger y reforzar el propio gobierno grandioso. Uno tiene la impresión de que el objetivo es simplemente reducir el gobierno grandioso gradualmente, de modo que no tendrá un efecto demasiado perturbador sobre los demás. Solo anal-ysis sistemática de las transferencias positivas y negativas del yo de granizado patológico, lo que lleva a la gradual descubrimiento de sus funciones defensivas y su reemplazo eventual por un ser normal, permite la resolución de la patología en los sectores de las relaciones narcisistas y de objetos de estos pacientes. Kohut descuida la interpretación de la transferencia negativa e incluso fomenta artificialmente la idealización en la transferencia. En mi opinión, su es un enfoque de apoyo, reeducativo para los pacientes narcisistas, porque les ayuda a racionalizar sus reacciones agresivas como resultado natural del fracaso de otras personas en su pasado. Este problema aparece de manera consistente en el material de la caja presentado tanto por Kohut como en la psicología de Goldberg del Sí mismo: un libro de

casos (1978). Por ejemplo, con el Sr. I, referido en los libros de Kohut y, ampliamente, en Dockberg CaseBook, el analista casi siempre interpretó la rabia o la ira del paciente como consecuencia de las fallas de los analistas u otras personas. El analista no exploró los aspectos no escocesos de las fantasías y reacciones del paciente hacia él o los conflictos sexuales (con respecto a sus impulsos homosexuales hacia el AnaDIST y su comportamiento sexual sádico hacia las mujeres), excepto a medida que estaban conectados con el Frustración de la grandiosidad del paciente o su idealización del analista. El rechazo de la teoría de la impulsión de Kohut, ya que un modelo teórico corresponde a su ignoración de la agresión en la transferencia, excepto cuando lo ve como una reacción natural a los fracasos de los demás (particularmente los analistas). Kohut también descuida el análisis de los aspectos inconscientes de la transferencia, es decir, la naturaleza defensiva de las exentencias conscientes del paciente del analista. Falta de analizar experiencias inconscientes y

Los enfoques psicoanalíticos contemporáneos 187 distorsiones de la situación psicoanalítica que median entre el pasado consciente y el pasado inconsciente se alimenta de la tendencia del paciente para elaborar el pasado sobre la base de una reorganización consciente de ese Pasado, en contraste con la reorganización radical del pasado inconsciente que evoluciona como parte de trabajar a través de la neurosis de transferencia. Kohut, por supuesto, implica que tales pacientes no pueden experimentar una neurosis de transferencia de pleno derecho. Tal vez sus pacientes no lo hicieron, pero si es así, creo que no lo hagan de hacerlo, lo que resultó de la protección y el refuerzo del analista del Ser Patológico Grandioso. Al restringir el concepto de empatía a la conciencia emocional del analista sobre el estado subjetivo central del paciente, Kohut descuida la función más amplia de la empatía psicoanalítica por la cual el analista se da cuenta de lo que el paciente experimenta y lo que es Disociando, reprimiendo o proyectando. Es muy fácil que el analista considere una intervención "empática" cuando se ajusta a su propia prueba y las expectativas o necesidades conscientes del paciente. Algunas verdades fundamentales sobre sí mismos que el paciente está evitando de manera defensiva puede producir dolor y sufrimiento cuando primero se enfrenta a ellos, incluso de la manera más táctica y comprensiva. Si se toma empatía, en la práctica, protegiendo al paciente de las verdades dolorosas sobre sí mismo, en particular al fortalecer ciertas resistencias de transferencia narcisista, entonces el concepto se estrecha severamente. Además, la empatía nunca se ilustra en los escritos de Kohut o en el CaseBook como empatía con la agresión exigida, lujuriosa y alegre de un paciente. Esa crueldad y el sadismo pueden ser placentero, está ocultado por las referencias a las condiciones frustrantes que los motivan. Por todas estas razones, el mismo concepto de transferencia se encuentra en los ejemplos de Kohut, y la experiencia consciente actual del paciente está directamente relacionada con el pasado en su mayoría

consciente. Creo que es significativo que Kohut no lograra diferenciar su concepto de auto objeto, una representación primitiva y altamente distorsionada de otros, de las representaciones de objetos más o menos distorsionados o realistas de las etapas de desarrollo preeedipal y edípicas. Las representaciones de ser invierten de libibinual y agresividad y objetos no tienen lugar en el sistema teórico de Kohut. Por lo tanto, en condiciones de frustración y fracaso (incluyendo, por supuesto, frustración narcisista y fracaso), solo hay una amenaza de traumatización o fragmentación del yo. No se hace mención de las representaciones de objetos frustrantes "malos", la imagen de una madre "mala", por ejemplo. El mundo intrapsíquico de Kohut solo contiene imágenes idealizadas de sí mismo y otras (autobatchs). Esta restricción teórica no explica la reproducción en la transferencia de las relaciones internas con objetos "malos", una observación crucial no solo en el narcisismo patológico sino en todos los casos de psicopatología severa. Este problema teórico corresponde a la negligencia de Kohut, a nivel clínico, de la interpretación de la transferencia negativa. Reconociendo a un paciente

188 Personalidades narcisistas La agresión en la transferencia, según lo causado por el "fracaso" del analista, se opone a interpretarla como una distorsión de la transferencia que refleja la activación de la agresión inconsciente hacia un objeto interdenizado anterior. Kohut ha señalado la coherencia interna entre sus formulaciones teoretiminas y su enfoque clínico, un argumento atractivo que debería contribuir a la evaluación de su teoría. Estoy de acuerdo en que el pensamiento de Kohut es consistente, pero creo que es erróneo. El apénio psicoanalítico al Ser Patológico Grandiose que conduce a su resolución impulsa la aparición en la transferencia, no simplemente de fragmentos de fragmentos y piezas de componentes de accionamiento, pero de relaciones de parte-objeto altamente diferenciadas. Estos pueden ser explorados y resueltos con un enfoque interpretativo que permita su transformación en relaciones y transferencias de objetos totales o totales, y, por lo tanto, permite la resolución del conflicto intrapsíquico primitivo y la consolidación de un yo normal. Al ignorar las implicaciones de la transferencia de estados regresivos, considerándolos simplemente como "fragmentos del yo", Kohut se ha mantenido aprendiendo sobre las capas más profundas y primitivas del aparato psíquico. Ha reconocido que su enfoque provoca una mejora en el segmento narcisista de la personalidad, pero no en el segmento relacionado con el objeto. En contraste, una interpretación psicoanítica sistemática del Ser Patológico Grandiose y de los estados no integrados, primitivos, los Estados del EGO-ID que surgen en este proceso supera la resolución simultánea de la patología narcisista y la patología relatada. De relaciones de objetos internalizados. Como se mencionó anteriormente, Kohut consideró que en pacientes que han logrado la integración de la internalización del autobatjunto idealizado en el ideal del ego y la consiguiente integración del superyó, existen las condiciones para la consolidación de la estructura tripartita y para el desarrollo de Conflicto intrapsíquico determinado, edípico, inconsciente. Sin embargo, la

pregunta se puede plantear, en qué medida, esta es una solución comprensiva que será abandonada por los seguidores de Kohut a favor de una psicología más completa del yo, en total sustitución de la metapsicología freudiana. Esta ambigüedad teórica se refleja en la suposición de Kohut, mientras que las vicisitudes de la consolidación y la maduración del yo no se derivan de las unidades o los conflictos intrapsíquicos, la emergencia, a veces de traumático. La fragmentación del Ser Norrose Arcaico, de los derivados de accionamiento sexual y agresivo refleja los productos de desintegración del yo. Así, en el pensamiento de Kohut, el yo no se deriva de las unidades, sino que genera unidades por fragmentación. La teoría de Kohut ha dejado una serie de preguntas sin respuesta: si la teoría del instinto se abandona, ¿qué motiva el yo? ¿En qué te indica? Si la agresión y la libido son productos de desintegración, ¿cómo se puede explicar su presidencia? ¿Por qué los coordenos no se someten al desarrollo?

¿Enfoques psicoanalíticos contemporáneos 189 transformaciones? ¿Y qué, si alguna, la función, desempeñan las relaciones de objetos en las etapas preeedipales del desarrollo? Creo que las respuestas a estas preguntas, creo que los Adherentes de la teoría de Kohut del Ser finalmente tendrán que lidiar con los temas de motivación, el desarrollo temprano y el papel de las relaciones de objetos. Ego-Psicología Objeto de las relaciones de objetos Las críticas anteriores han incorporado muchas de mis propias ideas teóricas en el narcisismo normal y patológico. (Consulte también Kernberg, 1975, 1976, 1980.) En resumen, podría agregar que mi enfoque difiere del punto de vista psicoanalítico tradicional derivado del examen de narcisismo de Freud (1914), según el cual primero Existe una libido narcisista y más tarde una libido del objeto. También se asume con los puntos de vista de Kohut (1971) que la libido narcisista y la libido de objetos comienzan hacia fijarse y luego evolucionan por separado y que la agresión en las personalidades narcisistas es secundaria a sus lesiones narcisistas. Es mi creencia de que el desarrollo del narcisismo normal y patológico siempre implica la relación de las representaciones de autosiciones para objetar representaciones y objetos externos, así como los conflictos instintivos que involucran tanto la libido como la agresión. Si mis formulaciones son válidas, parece que el estudio del narcisismo no puede divorciarse del estudio de las vicisitudes tanto de la libido como de la agresión como de las relaciones de objetos internalizados. El concepto del yo. Estoy proponiendo que se mantiene armoniosamente cerca del concepto original de Freud del ICH, el I, el ego (ver cap. 14). Se reúnene a y depende del inconsciente dinámico como una corriente subyacente que influye en el funcionamiento psíquico. La razón básica que propongo definir el yo como la suma total de las representaciones de autos integradas de todas las etapas de desarrollo en lugar de simplemente como simplemente una representación de autospresentación "compuesta" deriva de la función central que desempeña esta

organización o estructura en desarrollo. Creo firmemente de que la importancia de diferenciar el ser normal del yo patológico (grandioso). El yo de las personalidades narcisistas y del yo determinado, disociado o dividido en conflicto en la organización de la personalidad límite justifica el uso de este término. Mi concepto se trata el yo como una entidad puramente psicológica cuyo origen y desarrollo normal y patológico ahora exploraré brevemente. Jacobson (1971) y Mahler (Mahler y Porter, 1968; Mahler et al., 1975) ampliaron nuestra comprensión de la continuidad genética y del desarrollo que existe en una amplia gama de psicopatología no orgánica. Tanto Jacobson como Mahler utilizaron un concepto estructural. La refusión patológica regresiva e incluso la fragmentación de las representaciones de sí mismo y objetos en enfermedades y esquizofrenia maníacas y depresivas que el Jacobson describió correspondiente a la representación de sí mismo y un objeto indiferenciado

190 personalidades narcisistas en la psicosis simbiótica de la infancia que se describe Mahler. La investigación de Mahler sobre la separación normal y patológica, la separación, particularmente, que especifica la subfase de acercamiento en relación con la psicopatología límite, aplicó el concepto de Jacobson a la participación de la incapacidad para lograr la constancia de objetos en las condiciones fronterizas. Mahler proporcionó la evidencia clínica que nos permitió establecer horarios para las etapas de desarrollo de las relaciones de objetos internalizados propuestos por Jacobson. Mi propio trabajo sobre la patología de las relaciones de objetos internalizados de las condiciones fronterizas evolucionó en el contexto de ese marco teórico. Por lo tanto, ahora es posible, dentro de la metapsicología freudiana, a ANA-LYZE para la relación de manera enero y genética entre varios tipos y grados de psicopatología y una falta de lograr etapas normales de integración de las relaciones de objetos internalizados y el yo. (1) La enfermedad psicótica está relacionada con la falta de representaciones diferenciadas a sí mismo y observación, con un consiguiente desenfoque no solo de los límites entre las representaciones de sí mismo y de objetos, sino también de los límites del ego. La pérdida de la realización de la realidad es, por lo tanto, una característica estructural clave de la psicosis. (2) Las condiciones del límite se caracterizan por la diferenciación de las representaciones de sí mismo y de objetos y, por lo tanto, por el mantenimiento de las pruebas de realidad, pero también por una incapacidad para sintetizar el yo como un concepto integrado y los conceptos de otros significativos. Un predominio de mecanismos de división y representaciones de auto-desaprobadas o divididas relacionadas con múltiples derechos y objetos, caracteriza la estructura del ego de estas afecciones y explica la fijación defensiva a un nivel de falta de integración del yo y la falla de la integración de su superygo (Kernberg, 1975). (3) Mi investigación sobre la psicopatología y el tratamiento de las personalidades narcisistas ha proporcionado

evidencia clínica en apoyo de las siguientes ideas: (a) Aunque el narcisismo normal refleja la inversión libidinal del yo (como se define anteriormente), el Ser normal constituye en realidad un Estructura que ha invertido componentes integrados con la libido y la agresión. La integración de las autorías "buenas" y "malas" en un concepto de autocompleto resistentes que incorpora en lugar de disociar las diversas representaciones de autosiciones componentes es un requisito para la inversión libidinal de un yo normal. Este requisito explica la paradoja que la integración del amor y el odio es un requisito previo para la capacidad de amor normal. (b) Las resistencias narcisistas específicas de los pacientes con patología de caracteres narcisistas reflejan un narcisismo patológico que difiere del narcisismo adulto ordinario y la fijación o la regresión al narcisismo infantil normal. En contraste con este último, el narcisismo patológico refleja la inversión libidinal, no en una estructura integrada normal, sino en una estructura autopratea patológica. Este autopresidente patológico contiene

Enfoques psicoanalíticos contemporáneos 191 Real Ser real, ideal, y representaciones de objetos ideales. Las representaciones de sí mismo y de un objeto devaluado o agresivamente determinadas se dividen o se disocionan, reprimidas o proyectadas. La resolución psicoanalítica del Ser Grandeose como parte de un análisis sistemático de las resistencias narcisistas de caracteres que produce regularmente a la superficie (es decir, se activa en la transferencia) Relaciones de objetos primitivos, conflictos, estructuras de ego y operaciones defensivas Característica de las etapas de desarrollo que predean la constancia de objetos. Sin embargo, estas transferencias siempre están condensadas con conflictos derivados de manera edificada, de modo que son sorprendentemente similares a los de los pacientes con la organización de personalidad límite. (c) La resolución por tratamiento psicoanalítico de estas transferencias primitivas y sus conflictos inconscientes relacionados y sus operaciones defensivas permiten la integración gradual de las representaciones contradictorias y objetos que contienen inversiones libidinales y agresivas y, en el proceso, la integración. y consolidación de un yo normal. Ayuda, las relaciones de objetos se evolucionan de parciales en total a las que se pueden lograr la concentración de objetos, y tanto el amor propio y la inversión patológica de los demás se resuelven. (d) el narcisismo patológico se puede entender solo en términos de las vicisitudes de derivados de accionamiento ibbidinal y agresivo; El narcisismo patológico refleja no solo la inversión libidinal en el yo más que en los objetos u representaciones de objetos, sino también la inversión libidinal en una autoprisis patológica. De manera similar, las características estructurales de las personalidades narcisetas no se pueden entender simplemente en términos de fijación a un nivel de desarrollo temprano normal o de la falla de ciertas estructuras intrapsycicas para desarrollar; Deben ser vistos como consecuencia del desarrollo patológico y el desarrollo del superego, derivado del desarrollo patológico del yo, como se

define ahora. (4) La ausencia de controversia con respecto al concepto del yo, ya que se aplica al espectro más saludable de la psicopatología, refleja el hallazgo clínico de un yo integrado y la capacidad de las relaciones de objetos en profundidad, como lo que refleja el logro de la constancia de objetos de estos pacientes. Los pacientes neuróticos presentan un autocontrol integrado y normal sobre los aspectos conscientes y preconscientes del ego, aunque también incluye aspectos no conscientes. Este ser normal es la organización supraordinada de funciones clave de ego clave, como las pruebas de realidad, la sintetización e integración. El hecho de que los pacientes neuróticos pueden tener dificultazos graves en sus relaciones con otros y, sin embargo, pueden mantener una función de observación de su ego, para presentar un "ego razonable y cooperativo" como parte de su armamento para el tratamiento psicoanalítico, es un reflejo de que tienen disponible un yo integrado. (5) Esto nos lleva, finalmente, a un concepto de ser normal que, en contraste con el Ser Patológico Grandiose, surge naturalmente, ya que la estructura intrapsíquica trifitiva está construida e integrada. De ambos

192 Personalidades narcisistas Puntos de vista clínicos y teóricos Podemos definir así como una estructura integrada que tiene componentes afectivos y cognitivos, una estructura incrustada en el ego, pero derivada de los precursores del ego: Subtructuras intrapsíquicas que predan la integración de la estructura tripartita. Esta visión representa un cambio gradual alejado del concepto salenonificado de RAPAPORT (1960) de los orígenes y características de la estructura trifitada. Las barreras represivas que permanecen en efecto y que mantienen el equilibrio dinámico de la estructura tripartita, también mantengan la sombra de la influencia y el control inconscientes sobre el yo, no en términos de una energía psíquica abstracta concebida de las líneas hidráulicas sino en términos de reprimidos. Relaciones de objetos internalizados, invertidos libidinales y agresivos, lo que se esfuerza por la reactivación a través de la invitación del campo intrapsíquico e interpersonal del yo. Aspectos clínicos para fines prácticos, podemos clasificar el narcisismo en el narcisismo normal, infantil y patológico. Narcisismo infantil normal, de importancia aquí solo porque la fijación en o la regresión para los objetivos narcisistas infantiles es una característica importante de toda la patología del carácter, se caracteriza por una autocalentía normal, aunque excesivamente infantil y un mundo interdenizado normal de las relaciones de objetos. El narcisismo adulto normal existe cuando la autoestima está regulada por medio de una estructura normal normal relacionada con representaciones de objetos internalizados totales y integrados normales; por un superforme integrado, en gran parte individualizado y abstracto; y por la gratificación de las necesidades instintivas dentro del contexto de las relaciones de objetos y los sistemas de valor estables. En contraste, el narcisismo patológico se caracteriza por una autopratación anormal que puede ser de dos tipos. Freud describió un tipo por primera vez por Freud (1914) como una ilustración de "Elección de objetos narcisistas". Aquí, el Ser del paciente está identificado patológicamente con un objeto,

mientras que la representación del yo infantil del paciente se proyecta en ese objeto, creando así una relación libidinal en la que se han intercambiado las funciones del yo y el objeto. Esto se encuentra con bastante frecuencia en casos de homosexualidad masculina y femenina. Nuevamente, aunque los conflictos narcisistas son severos en estos pacientes que en aquellos con patología de caracteres del tipo narcisista infantil normal, presentan un yo normalmente integrado y un mundo interdenizado normal de las relaciones de objetos. Un segundo y más distorsionado tipo de narcisismo patológico es la personalidad narcisista propia, un tipo específico de patología de caracteres que se centra en la presencia de un propio ser patológico grandioso. Los pacientes con personalidad narcisista funcionan a lo largo de una amplia gama de eficaz social. Su funcionamiento superficial puede mostrar muy poca perturbación. Solo en la exploración de diagnóstico, estos pacientes revelan una reducción excesiva.

Enfoques psicoanalíticos contemporáneos 193 Gree de auto-referencia en sus interacciones con otros, una necesidad excesiva de ser amados y admirados, y una curiosa contradicción entre un concepto muy incumulado de sí mismos y sentimientos ocasionales de inferioridad. Además, tienen una necesidad excesiva de homenaje de los demás, su vida emocional es superficial y, mientras que generalmente presentan cierta integración de su auto-experiencia consciente, lo que los diferencia del paciente típico con la organización de personalidad límite, tienen una ausencia notable de la capacidad de Un concepto integrado de otros, siente poca empatía por los demás, y presenta un predominio de las mismas operaciones de defensa primitiva que caracterizan a la organización de la persona con la persona límite. Las personas con personalidades narcisistas tienden a ser excesivamente entusiastas de otras personas, idealizar a algunas personas, de las cuales esperan suministros narcisistas, y depreciar y tratar con despreciar a aquellos de quienes no esperan nada (a menudo, sus antiguos ídolos). Sus relaciones con los demás son frecuentemente explotadoras y parásitas. Debajo de una superficie que suele ser encantadora y atractiva, uno siente la frialdad y la crueldad. Por lo general, se sienten inquietos y aburridos cuando ninguna fuente nueva alimenta su atención propia. Debido a su gran necesidad de tributo y adoración de los demás, a menudo se consideran excesivamente dependientes. Pero, de hecho, no pueden depender de nadie debido a una profunda desconfianza subyacente y devaluación de los demás y un inconsciente "estropear" de lo que reciben relacionados con los conflictos sobre la envidia inconsciente. En el tratamiento psicoanalítico, si y cuando su propia grandiversidad se explora y se resuelve sistemáticamente por medio de la interpretación, evidencian los intensos conflictos en los que predomina la condensación de temas edípicos y preeedipales, con una influencia primordial de Fuentes preeedipales de agresión vinculadas a sus conflictos específicos sobre la envidia. En otras palabras,

debajo de la estructura protectora del Ser Patológica Grandiose, revelan los conflictos típicos de la Organización de Personas límite. Su falta relativa superficial de las relaciones de objetos es una defensa contra las relaciones de objetos internalizados, intensamente patológicos e internalizados. La estructura psíquica de la personalidad narcisista, tal como se describe, tiene la relevancia para el tratamiento, explicando tanto el desarrollo de reacciones terapéuticas negativas relacionadas con las fuentes inconscientes de la envidia y la posibilidad de resolver, simultáneamente con la resolución de su patología. Grandioso mismo, la patología de sus relaciones de objetos internalizados. Este concepto de estructura psíquica también tiene importantes implicaciones teóricas. En contraste con el pensamiento psicoanalítico tradicional, ese grave narcisismo refleja una fijación en una etapa narcisista temprana de desarrollo y un incumplimiento del amor de los objetos, lo que obtiene en estos casos es que un desarrollo anormal del amor propio coexiste con

194 Personalidades narcisistas Un desarrollo anormal del amor para los demás: el narcisismo y las relaciones de objetos no se pueden separar entre sí. En el nivel más alto de funcionamiento de las personalidades narcisistas, encontramos pacientes sin síntomas neuróticos, con buena adaptación de la superficie, y con muy poca conciencia de cualquier enfermedad emocional, excepto por un sentido crónico de vacío o aburrimiento, una necesidad excesiva de tributo de los demás y para personal. El éxito, y una incapacidad notable para la comprensión intuitiva, la empatía y la inversión emocional en otros. Los pacientes altamente inteligentes en este nivel de funciones narcisistas de personalidad pueden parecer bastante creativas, pero una observación cuidadosa de su productividad durante un largo período de tiempo dará evidencia de superficialidad y voluríficas. Pocos de estos pacientes llegan al tratamiento a menos que sean suficientes de algunos síntomas neuróticos de complicación; Tienden a desarrollarse, a lo largo de los años, las complicaciones secundarias a su patología narcisista, que empeora su funcionamiento en la edad media y avanzada, pero, de manera paralizada, también mejora su pronóstico para el tratamiento psicoanalítico en los años medio (Kernberg, 1980; ver también cap. 4). En esa etapa de la vida, tienden a desarrollar reacciones depresivas crónicas, un uso altamente inapropiado de denegación, devaluación y, a veces, los rasgos de personalidad hipomaníficos se defiendan contra la depresión, y un creciente sentido de empestamiento y de haber desperdiciado su vida. La gama media del espectro de la psicopatología narcisista corresponde a los casos típicos que acabo de describir, lo que idealmente tiene una institución para el psicoanálisis estándar. En el nivel más severo del espectro de la patología narcisista, encontramos a los pacientes que, a pesar de las funciones defensivas que el Autofordeo Patológica proporciona una continuidad en las interacciones sociales, las características precisas de la frontera prematura, es decir, la

falta de control de impulso, falta de ansiedad. Tolerancia, paro severo de sus capacidades sublimatorias y una disposición a reacciones de rabia explosivas o crónicas o distorsiones severamente paranoides. Muchos de estos pacientes responden bien a la psicoterapia expresiva modificada en lugar de al psicoanálisis propio. El tratamiento coincide con el descrito para la organización de la personalidad límite (ver chaps. 6 y 7), modificada a la luz de la técnica psicoanalítica descrita a continuación. Cuando la psicoterapia expresiva está contraindicada, se recomienda un enfoque de apoyo para estos pacientes. Una dimensión crucial pronósticamente a lo largo de la cual se puede explorar las estructuras de la personalidad narcisista es la medida en que la agresión se ha integrado en el propio propio grandioso patológico o, por el contrario, permanece restringido a los subyacentes, disociados y / o reprimidos Relaciones de objetos primitivos contra los cuales el autosorforante patológico representa la principal estructura defensiva. Uno puede describir una secuencia de desarrollo de la integración de la agresión en el aparato psíquico, de (i) disociación primitiva o división de un objeto invertido agresivamente

Enfoques psicoanalíticos contemporáneos 195 Relaciones de las relaciones de objetos invertidas libbidas, a (2) condensación posteriores de tales relaciones de objetos agresivos primitivos con derivadas de accionamiento sexual en el contexto de luchas sexuales perversas polimorfas, a (3) Canalización predominante de la agresión en una estructura de carácter narcisista patológica con la inversión directa de la agresión por parte de la grandiosa patológica. Las tres de estas fijaciones de desarrollo y / o rejuutas se pueden encontrar en las personalidades narcisistas, cada una con las que las diferentes características clínicas. Cuando se disocionan, invertidos agresivamente las relaciones con los objetos parciales se manifiestan directamente, nos encontramos con la personalidad narcisística que funciona con límite abiertas, con impulsividad general y una propensión a los desarrollos paranoicos y la rabia narcisista. Cuando se ha producido condensación con unidades sexuales parciales, las fantasías y actividades polimórficas sádicamente infiltradas se manifiestan. Cuando la agresión primitiva se infiltra directamente con el propio Ser Patológico, se produce un desarrollo particularmente ominoso, quizás mejor descrito como narcisismo maligno (ver capítulo 19). En esta última instancia encontramos pacientes narcisistas cuya grandiosidad y auto-idealización patológica se refuerzan por el sentido de triunfo sobre el miedo y el dolor a través de infligir miedo y dolor a los demás, y también los casos en los que se ve aumentado la autoestima por el placer sádico de la agresión. Vinculado con derivados de accionamiento sexual. Personalidades narcisistas con tipos alegres de crueldad; Pacientes que obtienen una sensación de superioridad y triunfo sobre la vida y la muerte, así como el placer consciente, por la autoinstilación de Seavere; y los pacientes narcisistas con una combinación de rasgos de personalidad parecía y explosiva, cuyo comportamiento impulsivo, ataques de rabia y culpa son canales importantes para la gratificación instintiva, todos pueden reflejar la condensación de la agresión y una

grandiosa propia y de mayo. Encuentre la situación del tratamiento una salida bienvenida y estable para la agresión que se exhibe contra el cambio intrapsíquico estructurado. Sin embargo, en otras personalidades narcisistas, el propio gobierno grandioso está realmente libre de la agresión expresada directamente. Los mecanismos represivos protegen al paciente contra las relaciones de objetos primitivos subyacentes que condensan los derivados de accionamiento sexual y agresivo. En estos casos, la "rabia narcisística" o las reacciones paranoicas se desarrollan en etapas posteriores del tratamiento como parte del proceso terapéutico y tienen implicaciones mucho menos ominosas. Todavía hay otros casos en los que se ha producido una integración sublimatoria de la agresión, relacionada con las estructuras de caracteres neuróticas en las que la agresión se ha integrado con las estructuras de superyo existentes; Estos pacientes tienen un tipo clínicamente más favorable de agresión autodirigida y capacidad para la depresión. Además, algunas personalidades narcisistas que funcionan en el nivel más alto pueden haber logrado una integración sublimatoria de la agresión en funciones de ego relativamente adaptativas, persiguiendo

196 Personalidades narcisistas Objetivos ambiciosos con una integración apropiada de derivados de accionamiento agresivo. Un tipo de personalidad narcisista relativamente poco poco frecuente y particularmente complicada es la personalidad "como si", que difiere del tipo habitual de "como si" la personalidad (con su camaleón, como siempre cambiando, pseudohiperemocional, y Cualidades de pseudoadaptativo). Las cualidades "como si" en los pacientes que tenga en mente reflejan las defensas secundarias contra un propio goldología patológica. Estos pacientes recuerdan a Marcel Marceau que mimina al hombre que quita una máscara tras otra y descubre la desesperación de que no puede desgarrar el último. Estos pacientes se desplazan de la Ley para actuar sin saber quién es el actor, aparte de eso, es una suma de impersonaciones. Por lo general, esta constelación de carácter protege al paciente de los temores paranoicos severos; Con menos frecuencia, contra la culpa inconsciente. A la luz de la integración de o defensas contra la agresión descrita, los casos más graves pronósticos son aquellos con una infiltración patotológica de la agresión en la grandiosa yo y aquellos en los que se encuentran secundarios, "como si" las características representan una defensa contra fuertes subyacentes Rasgos paranoicos. Un factor final que también tiene una importancia pronóstica crucial para el tratamiento de las personalidades narcisistas es la medida en que las tendencias antisociales se integran en la patología de caracteres narcisistas del paciente. Cuanto más fuertes las tendencias antisociales, los más pobres del pronóstico. Por lo general, las tendencias antisociales van de la mano con la falta de integración de las funciones de Supergo normales y también con la falta de desarrollo de una capacidad modulada de reacciones depresivas. La calidad de las relaciones con los objetos también se relaciona inversamente con las tendencias antisociales. Cuando las tendencias antisociales se manipulan en pacientes que también presentan una infiltración sádica de la grandiosa propia patológica o la

expresión directa de un comportamiento sexual severamente sádico, el pronóstico empeora significativamente.

Capítulo 12: Estrategias técnicas en el tratamiento de personalidades narcisistas El aspecto más importante del tratamiento psicoanalítico de las personalidades narcisitarias es el análisis sistemático de la grandilidad patológica, que se presenta a sí mismo en la transferencia. Lo que es único sobre la patología de caracteres narcisistas es que el propio propio grandioso patológico se utiliza en la transferencia precisamente para evitar el surgimiento de los aspectos disociados, reprimidos o proyectados de las representaciones de sí mismas y objetos de las relaciones de objetos primitivos. El efecto de la activación de la gran cantidad en la situación psicoanalítica es una distancia básica, una indisponibilidad emocional, una ausencia sutil pero crónica de los aspectos normales o "reales" de una relación humana entre el paciente y el analista en el que el paciente trata al paciente. Analista como un individuo específico. En contraste, la activación de una auto-idealización patológica sobre la parte del paciente, alternando con una proyección de tal autoalización en el analista, transmite la impresión de que solo hay una persona ideal y grandiosa en la habitación y un complemento aún en la sombra.. Las reversiones frecuentes de roles entre el paciente y el analista ilustran este patrón de transferencia básicamente estable. En otra parte (1975), he descrito las manifestaciones de esta constelación de la transferencia en detalle, su reclutamiento, a su servicio, de mecanismos de defensa primitivos y sus funciones, y el análisis de sus diversos aspectos. Aquí solo hubiera subrayado que el analista debe interpretar, entre otras cosas, el mecanismo del control omnipotente por el cual el paciente intenta característicamente rediseñar el analista a satisfacer sus propias necesidades. El analista debe dar la impresión de ser brillante y con conocimientos para que el paciente sentirá que está en presencia del mayor terapeuta de todos los tiempos. Sin embargo, el analista no debe ser demasiado brillante para que evoque la envidia y el resentimiento del paciente. El analista tiene que ser tan bueno como el paciente; Ni mejor, evocando la

envidia, ni peor, provocando la devaluación y la sensación de pérdida total. 197

198 Personalidades narcisistas Los esfuerzos sistemáticos del analista para ayudar al paciente a comprender la naturaleza de esta transferencia en lugar de cumplir con sus expectativas de la admiración y la reconfirmación del yo grandioso, por lo general, evoca la ira, la rabia o una repentina devaluación del analista y sus comentarios.. Las reacciones similares se siguen característicamente las veces, cuando el paciente ha sentido una comprensión importante y ayudó a provenir del analista, comprender y ayudarlo con dolor con la conciencia del funcionamiento autónomo e independiente del analista. La tolerancia del analista de dichos penetres de rabia o devaluación, su interpretación de las razones para las reacciones del paciente permite gradualmente al paciente integrar los aspectos positivos y negativos de la transferencia: para integrar la idealización y la confianza con la rabia, el desprecio, y desconfianza paranoica. Detrás de la activación aparentemente simple de la rabia narcisista radica en la activación de las relaciones específicas, primitivas e inconscientes de objetos internalizados del pasado, típicamente de las representaciones de propósitos de división y objetos que reflejan los conflictos condensados edípicos / preeedipales condensados. En este contexto, los períodos de empacidad y el sentimiento del paciente de que "nada está sucediendo" en la situación del tratamiento a menudo se puede aclarar como una destrucción activa e inconsciente de lo que el paciente está recibiendo del analista, un reflejo de la incapacidad del paciente para depender de la Analista como una figura materna que da. Los ávidos esfuerzos del paciente para obtener conocimiento y comprensión del analista para incorporarlos como algo con fuerza, en lugar de que se reciba algo con gratitud, contribuya a la espuma inconsciente de lo que se recibe, una reacción emocional compleja fue clarificada por primera vez por Rosenfeld (1964) y uno que usualmente lleva mucho tiempo para resolver. Típicamente, los largos períodos de autoanálisis intelectual, durante los cuales el paciente trata al analista, por ausencia

(que puede provocar una contraversa negativa en la forma de aburrimiento), es seguida por o interviene con períodos cuando el paciente espera con entusiasmo y absorbe en TerEpretaciones, intentos de superar al analista, incorpora rápidamente lo que ha recibido como si él mismo lo supiera todo, solo una vez más sentirse extrañamente vacío, insatisfecho, ya que no habiendo recibido nada después, ya que fue, como lo fue, metabolizado.. De la misma manera, el paciente típicamente, por proyección, supone que el analista no tiene un interés genuino en él, es tan egocéntrico y explotador a medida que el paciente se experimenta, y no tiene conocimientos o condenas autenticistas, sino solo un número limitado de Trucos y procedimientos mágicos que el paciente necesita aprender e incorporar. Cuanto más corrompe el superyó del paciente, y cuanto más necesita para prometer representaciones de sí mismo y objetos devaluados, cuanto más sospecha al analista de presentar características de manera similar y devaluada. La emergencia gradual o el avance de las transferencias más primitivas pueden cambiar esta imagen general a la expresión de la desconfianza paranoica y la agresión directa en la transferencia. La aparente interrupción de lo que

Las estrategias en el tratamiento 199 pueden haber aparecido anteriormente como una relación "ideal", en un sentido más profundo, la activación de una relación más real, aunque ambivalente y conflictiva en la transferencia, lo que refleja la activación de las relaciones de objetos primitivos en ella. Algunas defensas de carácter crónico común y particularmente difíciles que tienden a distorsionar la situación psicoanalítica de manera gradual e incretera se discuten a continuación. Las defensas de carácter secundario según el carácter de carácter, me refiero aquí no a la personalidad "como si", como generalmente se describe, sino al subgrupo de pacientes narcisistas (mencionados en el capítulo 11) que parecen estar jugando. Los pacientes con tales características pueden aprender a imitar el "analizador perfecto", aparentemente transmitiendo elementos significativos del pasado con la consideración adecuada y en las dramáticas. Aprenden a "asociarse perfectamente", incluidos los cambios apropiados de la sensación de pensar, desde la presente a la realidad, desde la fantasía hasta la realidad. Solo el hecho de que su relación emocional con el analista no logra profundizar revela su calidad AS -IE. Los temores paranoicos que puedan surgir cuando no se puede lograr una jugada en respuesta a la interpretación del analista de esta misma condición revela el verdadero punto de conflicto. La activación de la ansiedad y el dolor de la AU- TESTICA puede llevar al comienzo de la exploración de la función de este comportamiento. Episodios micropsicóticos paranoicos Este término se refiere aquí a los desarrollos en algunas personalidades narcisistas cuando las resistencias narcisistas se trabajan a través y también en otros tipos de patología de caracteres cuando los mecanismos proyectivos masivos están desestimados y el paciente está intentando defender Él mismo contra lo que experimenta como sentimientos de culpa insoportables alternando con el sentido de que el analista atacado masivamente. (Para más detalles, vea el capítulo 19.) En tales puntos, el paciente puede, por ejemplo, adquirirá transitoriamente la convicción de que el

analista le está mintiendo, engañándolo, traicionándolo de alguna manera, intentando provocarlo artificialmente o hacer que sufra, o la obtención sáfiera. Placer de manipularlo de varias maneras. El analista también puede ser percibido como deshonesto o corromper en esos momentos, especialmente, por supuesto, por pacientes que luchan con un sentido de corrupción o deshonestidad en sí mismos. En otras ocasiones, el analista se percibe como intentando que el paciente se sienta culpable o probado por lo que le obliga a que se sometiera a los puntos de vista rígidos y convencionales del analista.

 El problema es que tales episodios paranoicos pueden resolverse mediante un sellado de la transferencia paranoica en lugar de mediante el trabajo auténtico. La profunda convicción del paciente de la falta de energía del analista se mantiene reprimida o se divide en otros desarrollos de transferencia. Esta solución de compromiso puede proteger temporalmente el sentido de seguridad y autoestima del paciente, pero eventualmente conduce a la reacción de tales episodios paranoicos. La convicción del paciente de la "maldad" del paciente se acumula gradualmente de episodio al episodio, eventualmente conduciendo a una actuación masiva, una interrupción repentina del tratamiento, o un tipo artificial de terminación, con el paciente. Insistiendo en que nunca pudo confiar en el analista y que la terminación es una escucha de un enemigo peligroso. Fue solo la dolorosa experiencia del fracaso de algunos tratamientos psicoanalíticos que parecían en el camino a la resolución de varios tipos de patología de caracteres graves que me permitieron diagnosticar esta constelación de episodios paranoicos. He aprendido a trabajar en otros casos al vincular interpretación de los episodios, al analizar el proceso patógeno "sellando sobre" durante las mejoras temporales, y al estar generalmente alerta a la continuidad enmascarada por las aparentes discontinuidades en la transferencia. En términos más generales, las resistencias de los personajes que provocan una discontinuidad en el proceso psicoanítico a lo largo del tiempo son una causa importante de los estancamientos analíticos y debe alertar al analista la posibilidad de que el paciente no sea analizable. El problema de la ganancia secundaria y primaria en contraste con las ganancias secundarias derivadas de ciertos síntomas neuróticos, todos los rasgos de carácter patológico proporcionan una "ganancia secundaria" que es muy difícil de diferenciar de la motivación primaria e inconsciente de la constelación de carácter patológico. Paradójicamente, las cualidades adaptativas de muchos tipos de patología de caracteres

graves mejoran el funcionamiento del paciente y disminuyen su motivación para el cambio. Los ejemplos clásicos son las ventajas derivadas de ciertos rasgos narcisistas en la adolescencia y la edad adulta temprana que empeoran el pronóstico para el tratamiento en ese momento, mientras que estos pacientes tienen un mejor pronóstico en la edad medio, o cuando se obtiene de manera derivada de Se reduce la patología narcisista. La eficacia social de algunos caracteres contraphóbicos proporciona otro ejemplo. Sadismo caracterológico. Me refiero aquí a ciertos pacientes narcisistas cuyo propio goldología patológica se infiltra con la agresión primitiva y cuyo sadismo es ego-sintónico (una condición elaborada en el capítulo 19). Para estos pacientes, la situación analítica en sí misma es tan gratificante que

Las estrategias en el tratamiento 201 eliminan la necesidad de cambio, lo que conduce al estancamiento terapéutico. En la medida en que el analista puede mantener la empatía con su paciente sin presentarle masquísticamente y puede proporcionar límites estrictos en realidad, sin cumplir con los aspectos sádicos de la contrarreencia, pueden tener una influencia crucial en el resultado del trabajo con estas resistencias de caracteres. Estos son, obviamente, los casos en los que la analizabilidad está en cuestión; Las condiciones bajo las cuales el analista puede ayudar a tales pacientes, también contienen los casos en que el psicoanálisis está contraindicado, pero la psicoterapia expresiva es el tratamiento de la elección. La represión severa defendió caracterológicamente: la personalidad "aburrida" Esta subsección discute a los pacientes con una inteligencia al menos normal y con frecuencia sup au, cuyos mecanismos represivos no solo son altamente efectivos y rígidos, sino que son reforzados por su carácter patología. En tales pacientes, un sistema complicado de racionalización y controlado "viviendo" de formaciones de reacción protege de manera secundaria la represión, y / o las crisis emocionales se esconden, detrás de su explosividad, el mantenimiento de las represiones subyacentes básicas. Es difícil vincular este patrón a cualquier tipo particular de patología de caracteres. Se puede observar en personalidades histéricas, obsesivas y narcisistas y, a veces, en pacientes que, a pesar de su falta de conciencia de la realidad emocional, están muy dispuestos a sufrir psicoanálisis durante muchos años. A estos pacientes, que no presentan una estructura de personalidad narcisista, sin embargo, transmiten una adaptación de PSEUTORÁREALIZADA, PSEU-DOREALISTA a la situación de tratamiento que corresponde a una adaptación "sólida" similar a la vida fuera de su área particular de alteración simpática. Es como si experimentara psicoanálisis solo como una oportunidad "educativa" que aumenta aún más su adaptación sin lograr una experiencia auténtica del inconsciente dinámico. He

visto algunos casos de este tipo y he supervisado el tratamiento de los demás. La literatura anterior describió los casos en los que el inconsciente no parecía emerger como prevaleciendo, sino de esta categoría general, las constelaciones más específicas de los tipos de reacción terapéutica negativa, la patología del carácter narcisista y otras resistencias de caracteres se han cristalizado. Creo que sigue siendo un residuo de tales casos que requieren una mayor exploración. Algunos de estos pacientes escapan de nuestras capacidades dijirnósticas actuales y se diagnostican ahora solo en términos de los estancamientos en sus análisis. Etapas avanzadas del tratamiento Después de varios años de exploración sistemática de las funciones defensivas del Ser Patológico Grandiose en la transferencia, se puede alcanzar una etapa en el tratamiento psicoanalítico de las personalidades narcisistas en

202 Personalidades narcisistas que el propio auto se desintegra en sus constituyentes. El paciente promulga las relaciones de objetos internalizados en una alternancia repetitiva o entre cambio con el analista de las representaciones del propio objeto ideal e ideal del paciente, y un objeto real. En otras palabras, el paciente puede alternarse, sin embargo, se identifique con los aspectos idealizados, manipuladores, persecutorios, sádicos, manipuladores, deshonestos, sádicos o triunfantes de los aspectos idealizados o reales de las representaciones iniciales del yo y los objetos al proyectar el Funciones complementarias de representación perseguida, devaluada, frustrada, derrotada o explotada y objeto en el analista. O el paciente puede proyectar dichas representaciones de componentes del seror de la grandiosa en el analista mientras identifica con los roles complementarios de las representaciones de sí mismas y objetos. Esta etapa en el tratamiento rara vez se alcanza ante el tercer año de psicoanálisis; Si aún no se ha vuelto evidente para el quinto año, uno puede tener que preguntar si la resolución del Ser Patológico Patológica del paciente es posible. Con mayor frecuencia, el trabajo a través de esta etapa se extiende desde el tercer año hasta la fase de terminación del psicoanálisis. En las etapas finales de la resolución de la Situación Grandiosa, la situación de tratamiento generalmente se asemeja al del caso psicoanalítico ordinario, ya que el paciente ahora puede establecer una dependencia real del analista, puede expresar sus conflictos previos y preeedipales. En un fashion diferenciado, y puede normalizar simultáneamente sus relaciones de objetos patológicos y sus mecanismos reguladores narcisistas. Debido a que el autolorsoforieso patológico protege al paciente de los intensos conflictos intrapsíquicos, por lo que es típico de la patología límite, los conflictos no conscientes que surgen en la transferencia en esta etapa son sorprendentemente similares a los de la organización de la personalidad límite en general. A lo largo de estos años, se puede establecer una alianza terapéutica, lo que

impide que las regresiones psicóticas en la transferencia, impide que el analista controle severa actuación sin abandonar una posición de neutralidad técnica, y facilita el desarrollo del paciente. Observando ego y de una relación de objeto confiable con el analista. Todo esto permite que el tratamiento psicoanalítico proceda sin establecer parámetros de técnica, como a menudo sean necesarios en el tratamiento de pacientes narcisistas con el funcionamiento de la frontera manifiesta. Durante las etapas avanzadas del tratamiento de las personalidades narcisistas, a menudo observa una oscilación entre períodos de idealización y transferencia abiertamente negativa, en el curso de la cual la idealización narcisista patológica descrita anteriormente se sustituye gradualmente por niveles más altos de idealización. Es importante explorar la naturaleza cambiante de estos períodos de idealización renovada. A diferencia del nivel superior a la idealización narcisista, el paciente ya no ve al analista como una proyección de su auto idealización (idealización narcisista), sino que lo ve como una figura ideal de padres (o parentales combinados) que ha sido capaz de

Las estrategias en el tratamiento 203 toleran la agresión del paciente sin contraataquear o ser destruyadas por ella. Este tipo de idealización avanzado contiene elementos de culpa, que expresan el reconocimiento del paciente de su agresión; También contiene gratitud, que expresa la comprensión del paciente de la confianza y la confianza del analista en él, reflejada en la inquebrantable a través de la adherencia táctil a la verdad de lo que ha estado sucediendo en su relación. Períodos de transferencia predominantemente negativa, caracterizada por la rabia, la activación de una relación con una madre amenazadora, sádica, deshonesta y manipuladora o una figura de madre / padre condensada, puede evolucionar gradualmente en la identificación alternativamente del paciente con este sádico Imagen parental o con la imagen complementaria de la víctima perseguida de la agresión de los padres, identificándose así a sí mismo y al analista, con las representaciones de objetos y objetos disociados o separados previamente. El análisis de la activación alternativa de estas representaciones de sí mismo y objetos de esta "unidad de relación de objeto" en particular puede integrarse gradualmente con las relaciones entre objetos de división disociada o dividida, para que las autorrepectativas se unen gradualmente en un yo integrado y representaciones de objetos en un concepto integrado de los objetos parentales. En las etapas avanzadas del tratamiento, después de esta interpretación sistemática de las transferencias positivas y negativas, ha permitido la integración del objeto parcial en relaciones totales de objetos (en otras palabras, después del logro de la constancia de objetos con una integración de las buenas representaciones de autosiciones y malas y Representaciones de objetos malos), la disolución de la grandiosa patología y las resistencias narcisistas en general permite el surgimiento del narcisismo infantil normal en el contexto del análisis de las relaciones condensadas edípicas y preeedipales. Durante las etapas avanzadas del tratamiento de las

personalidades narcisistas, una capacidad normal para depender del analista reemplaza gradualmente la incapacidad anterior para depender de él. Ahora, el paciente puede usar las interpretaciones para continuar su autoexploración en lugar de un punto de partida para la expropiación codiciosa de los conocimientos ocultos del analista. El paciente ahora puede hablar de sí mismo al analista en lugar de hablar solo para hablar solo o al analista solo como una súplica de gratificación. El paciente ahora puede experimentar nuevas fuentes de gratificación y seguridad de la certeza de que puede aprender sobre sí mismo, para tratar creativamente con sus propias dificultades, y, sobre todo, mantenerse segura dentro, en forma de representaciones internalizadas de buen objeto, de lo que ha recibido de El analista. El sentido de la riqueza interna derivada de la gratitud por lo que ha recibido y la confianza en su propia bondad generalmente produce una disminución en las reacciones envidias del paciente y en su necesidad de

204 personalidades narcisistas devaluan lo que desencadenaría la envidia; El paciente puede observar un aumento paralelo en su capacidad de aprendizaje emocional e intelectual. El paciente, en resumen, se siente gradualmente libre de su sentido interno de vacío, la calidad patológica, impulsada de sus ambiciones y la sensación crónica de aburrimiento y inquietud. En el área de sus conflictos sexuales, además de la activación y la resolución potencial de los conflictos edípicos condensados con las islas preeedipales, el paciente ahora puede tolerar y resolver las raíces preeedipales más profundas de la envidia del otro sexo, que es tal Aspecto prominente de las dificultades sexuales de las personalidades narcisistas y una fuente básica de su rechazo inconsciente de una identidad sexual que tendría que limitarse a "un solo sexo". Grunberger (1979) describió las fantasías narcisistas inconscientes de ser ambos sexos simultáneamente, lo que protege a algunos pacientes narcisistas de envidiar al otro sexo. Clínicamente, el cambio en esta fantasía inconsciente y el trabajo a través de la envidia influyen en la creciente capacidad del paciente narcisista para enamorarse y permanecer en el amor, y en particular establecer un compromiso sexual y emocional definido sin sentir crónicamente que le falte algo (Kern-Berg, 1976). En esta etapa, la resolución de algunos pacientes de su envidia inconsciente y desordenada del otro sexo puede provocar la aparición de celosía como una nueva capacidad emocional, una entrada dolorosa en los conflictos triangulares de la etapa de edificación. He destacado la importancia primordial de un análisis sistemático de las resistencias de transferencia narcisista, es decir, de la grandiosa propia en la transferencia. Esto no implica un curso de acción artificialmente autorizado en el tratamiento de pacientes con patología narcisista. Hay muchos casos en los que, en las etapas iniciales del tratamiento, otros conflictos neuróticos derivados de varias fuentes o vinculadas con problemas de realidad parecen dominar el material del paciente. El analista tiene que ocupar lo que

parece emocionalmente dominante en la situación analítica primero y se deja guiarlo por el paciente. Tarde o temprano, se alcanza un punto en el análisis de estos casos donde las transferencias narcisistas se convierten en el tema emocional dominante; Estos deben ser recogidos, trabajados y resueltos. Esta tarea se hace más difícil por el hecho de que la patología de caracteres narcisistas, como toda la patología del carácter, se muestra típicamente en los aspectos no verbales del comportamiento del paciente. Además, lo que el comportamiento no verbal del paciente refleja en estos casos no es solo una relación de objeto inconsciente específico del pasado reactivado en la transferencia, sino un esfuerzo inconsciente más genalizado, sutil, pero abrumador para eliminar todo, "Reales", pasados y presentan relaciones de objetos distintos de la activación del Ser Patológico Grandioso. Esa destrucción o deterioro en la situación analítica de todas las demás relaciones de transferencia específicas del pasado del paciente afecta la relación

Estrategias en el tratamiento 205 del paciente al entorno psicoanalítico de formas sutiles y crónicas, no solo en comportamientos específicos y actitudes hacia el analista. Puede aparecer primero en la conciencia emocional del analista de la extraña ausencia de cualquier relación díada real en la transferencia, como si estuviera sola en la oficina o como si el paciente estuviera solo; El analista puede experimentar subjetivamente a una pérdida transitoria difusa, paralizando su propio sentido de identidad. Sin embargo, sería peligroso concluir, que la concentración del analista en su propia reacción emocional al paciente es una guía exclusiva para el diagnóstico e interpretación de las resistencias narcisistas. Siempre existe el peligro de que otras fuentes de las reactivas de la contratransferencia influyan en la percepción del analista del paciente y que en presencia de cualquier patología de carácter predominante, incluida la patología narcisística, el analista puede centrarse de manera rígida o prematuramente en el anal-Ysis de carácter o de ciertos aspectos congelados de la transferencia. El conocimiento debe centrarse simultáneamente sobre las implicaciones del contenido verbal de las horas (el análisis de las asociaciones libres), sobre las manifestaciones de comportamiento no verbal, sobre el impacto de la personalidad del paciente en el entorno psicoanalítico, y en El tipo de relación implícita y subyacente con el analista que se está activando. La observación del comportamiento del paciente, el análisis cognitivo de todos los datos y la empatía tanto con la experiencia subjetiva del paciente como con lo que se ha disociado ni proyectado en ese punto, proporciona una base amplia para la interpretación. Estoy haciendo hincapié en la importancia de mantener un amplio espectro de datos psicoanalíticos en lugar de sobrevalorar cualquier aspecto en particular de estas fuentes de información. Tales perspectivas múltiples, incluido un enfoque en la experiencia subjetiva central del paciente, sobre las experiencias disociadas del paciente, y en el significado directo de las comunicaciones verbales y no

verbales, deben complementarse con la voluntad del analista para explorar varias hipótesis. Tratar con el mismo material durante un período de tiempo, decidir su valor, en su apropiación a la luz de las respuestas totales del paciente. Sin embargo, una condición para la aplicación de múltiples hipótesis a lo largo del tiempo, es la disponibilidad para el psicoanalista de una integración coherente de dichas hipotecas, en contraste con la aplicación errática de las teorías o formulaciones diferentes de contratación implícitamente. El marco de desarrollo evolucionado a partir de la psicología del ego contemporáneo a la luz de la teoría de las relaciones de objetos debería permitir el establecimiento de un marco integrador de este tipo para tratar con el amplio espectro de la psicopatología que hoy puede ser explorado psico-analíticamente. Modell (1976) y Volkan (1976), al tiempo que se aproxima a las personalidades narcisistas dentro de un modelo de relaciones de objetos de la psicología del ego, muy estrechamente relacionadas con la que se basa en mi técnica, en la etapa inicial del análisis de estos pacientes, el idealización narcisista

206 Personalidades narcisistas y la incapacidad del paciente para absorber las interpretaciones se respetan en una función de "tenencia" que corresponda a una fase de "capullo" del análisis. Sin embargo, estos autores piensan que el analista debe interpretar gradualmente el gobierno grandioso narcisista y, por lo tanto, facilitar la activación de los niveles primitivos de los niveles de las relaciones de objetos internalizados en la transferencia. A partir de ese momento, creo que su enfoque corresponde en gran medida a la que se describe aquí. Psicoterapia de apoyo con personalidades narcisistas en el Capítulo 11 I Clasificé las personalidades narcisistas de acuerdo con la severidad de su patología en casos abiertamente fronterizos y casos de funcionamiento de la línea antioplizante, y en el Capítulo 10 recomendó el psicoanálisis como el tratamiento de la elección para este último En contraste con la psicopoterapia expresiva para el primero. Pero a veces, cuando la psicoterapia expresiva está contraindicada, es necesario utilizar la psicoterapia de apoyo para estos pacientes. Además de las consideraciones generales dadas anteriormente, un dominio de las siguientes características de pronóstico negativo sugiere que es preferible la psicoterapia de apoyo. En algunos pacientes, el propio Gorrose Patológica se infiltra con la agresión, de modo que el paciente se presente con ideales conscientes de crueldad y destructividad que puedan ser manifestados en perversiones sádicas o en disfrute consciente de la vida de otras personas, en violencia, y en formas severas de autoestructividad física. Otros factores que sugieren que la terapia de apoyo sería más apropiada incluyó características antisociales graves, ausencia crónica de volvías reales con otros seres humanos (por ejemplo, una restricción de toda la vida sexual a las fantasías de masturbación), anclada caracterológicamente y Reacciones de rabia crónica racionalizadas, y episodios psicóticos paranoicos transitorios. En todos estos casos, es aconsejable llevar a cabo una evaluación extensa con un enfoque de sondeo,

expresivo y decidir sobre una modalidad de tratamiento supportativa solo por exclusión. Nuevamente, como en todos los casos de psicoterapia de apoyo, las metas de tratamiento deben establecerse junto con el paciente, se debe esperar su cooperación activa, y debe monitorearse el trabajo entre las sesiones de psicoterapia. Típico en la psicoterapia de apoyo de estos pacientes es la activación de ciertos mecanismos de defensa que son característicos de la psicopatología narcisista y que deben centrarse y trabajar con formas de no interpretación. El desarrollo aparente del paciente de la intensa dependencia del terapeuta puede ser una pseudodependencia, pinchada rápidamente por las devaluaciones radicales del terapeuta. Es importante, por lo tanto, mantener una relación terapéutica realista, centrándose en las responsabilidades del paciente en el proceso de tratamiento, advirtiéndolo tácticamente contra idealizaciones no realistas y expectativas del terapeuta.

Estrategias en el tratamiento 207 en lugar de alimentarse directamente a su relación aparentemente dependiente con el terapeuta. Es útil evaluar cuidadosamente las reacciones de decepción del paciente a las sesiones de tratamiento para su función implícita de desalentar al terapeuta y sus orígenes en los desarrollos anteriores en la psicoterapia. Por ejemplo, después de que el paciente haya recibido una nueva participación significativa del terapeuta, se puede esperar decepciones paradójicas (relacionadas con la envidia inconsciente de actuación); Estos deben ser señalados al paciente en términos de una secuencia observable de comportamiento. La idealización patológica primitiva típica de la personalidad narcisista debe ser reconocida en términos táctiles y sus efectos potencialmente negativos en el funcionamiento independiente del paciente señalado. El paciente puede ver las cualidades de Dios en su terapeuta, pero se le debe ayudar a comprender que es difícil identificarse con una cifra de este tipo sin tener problemas graves en la vida ordinaria o para aceptar la responsabilidad de la vida independiente cuando un terapeuta de Dios parece atar mágicamente a los problemas. Naturalmente, la conexión entre las idealizaciones primitivas y la rápida espuma de las idealizaciones por las reacciones de desaprobación y la devaluación subyacente también pueden ayudar al paciente a adquirir cierta distancia de sus tendencias a idealizar lo contrario en la misma. Derrotando formas. Los pacientes con reacciones intensas de rabia vinculadas a la frustración de las necesidades narcisistas, particularmente si estas reacciones de rabia evolucionan en episodios de cálsica psicótica paranoico, requieren una evaluación muy activa y minuciosa de todos los elementos en la realidad de la Interacción terapéutica que puede haber provocado la rabia del paciente y sus distorsiones paranoicas del terapeuta. Bajo los efectos de los mecanismos proyectivos, las distorsiones del paciente de la realidad de la interacción terapéutica deben aclararse de manera cuidadosa y con cuidado para reducirlos. El problema aquí es que el paciente

puede experimentar cualquier esfuerzo para aclarar la realidad inmediata como crítica o sádicamente acusatoria por parte del terapeuta. Es esencial que el terapeuta aclare una y otra vez que no está culpando al paciente, que, por el contrario, está tratando de ayudar al paciente a comprender la relación entre sus percepciones y su reacción emocional, considerando menos de si estas percepciones eran realistas. Hay momentos en que la realidad de la interacción no se puede aclarar de inmediato. En estas circunstancias, la tarea es simplemente reconocer que el paciente y el terapeuta pueden percibir la realidad de manera completamente diferente sin necesariamente tener que aceptar que una u otra de estas percepciones es correcta. En la práctica, una declaración como "Creo que entiendo la forma en que está viendo mi comportamiento, y no estoy discutiendo con él; al mismo tiempo, debo decirles que lo veo de manera diferente, aunque también reconozco su percepción. ¿Crees que puedes tolerar que trabajamos juntos mientras que cada uno de nosotros reconoce a la

208 Personalidades narcisistas Otros de que nuestras opiniones son completamente diferentes? "A menudo es suficiente para continuar trabajando dentro de una transferencia psicótica temporal, como un episodio micropsicótico para antaño. De hecho, la tolerancia del terapeuta de la rabia narcisista de un paciente. Y la distorsión paranoica en la transferencia y su reconocimiento de reconocimiento del coraje del paciente para mantener su relación a la luz de una situación tan estresante puede poner las bases para la exención posterior de las reacciones de rabia del paciente y los patters de caracteres patológicos en otros Interacciones interpersonales. Al mismo tiempo, el análisis de lo que puede estar sucediendo en otras personas que interactúan con el paciente, el análisis de sus sentimientos heridos o las reacciones grandiosas o despectivas hacia el paciente, ya que los describe, puede abrir el camino para la exploración posterior de patrones reactivos similares En el mismo paciente. El análisis de la grandiosidad y el comportamiento de preciatorio del paciente proyectado en otras personas, garantiza mucho tiempo, causa de su potencial para llevar al estudio de reacciones similares en la transferencia. Es importante analizar las fuentes de la desconfianza consciente y preparada del paciente en las relaciones sexuales (derivadas de la envidia inconsciente del otro sexo y la profunda patología preeedipal en relación con la madre que contribuyen a las distorsiones narcisistas de las relaciones de amor). La inspección cuidadosa de las fuentes conscientes y preconscientes de desconfianza y abundación de las parejas sexuales puede tener un valor preventivo. Por el mismo, los pacientes narcisistas con promiscuidad sexual requieren una aceptación tolerante de su comportamiento. Deben ser ayudados a ser conscientes (y permanecer tolerantes a esta conciencia) de su incapacidad para mantener las relaciones sexuales estancadas y de su consiguiente soledad y aislamiento. Este es un área que requiere un tacto especial y la paciencia. La búsqueda de un paciente grandioso de la mujer que no está disponible,

por ejemplo, y su implacable destrucción de relaciones valiosas con las mujeres que se puede representar, se podría decir, una tragedia existencial. El terapeuta, al compartir su comprensión de las necesidades tanto del paciente como de su realidad externa, puede permitir que el paciente intente nuevas soluciones al problema, aunque el terapeuta no haya ofrecido ayuda directa. En circunstancias óptimas, tal enfoque puede llevar a una reducción de las expectativas conscientes del paciente en sus relaciones con el otro sexo, un comportamiento más cuidadoso en sus relaciones con los socios, la tolerancia de algunas frustraciones a la luz de la conciencia de la soledad alternativa-crónica. Desafortunadamente, la psicoterapia de apoyo generalmente es mucho más limitada que las modalidades expresivas del tratamiento para lograr el cambio en el área psicosexual. Un paciente que actúa fuera de la necesidad de un control omnipotente en las horas de las ventajas puede restringir la independencia de la acción del terapeuta. En formas sutiles pero profundamente influyentes, el paciente obliga al terapeuta a intentar

Las estrategias en el tratamiento 209 sean tan buenas como el paciente, espera que él sea, sin ser mejor que o diferente del paciente, lo que amenazaría la autoestima del paciente. En la práctica, esto requiere que el terapeuta se dé cuenta del uso de las reacciones de decepción del paciente para controlarlo. El terapeuta debe diagnosticar dichas reacciones de decepción, ventilarlas plenamente y ayudar a el paciente a tolerar sus decepciones en el terapeuta y, en consecuencia, en otros. En el contexto, la exploración realista de tales decepciones puede llevar al paciente a la conciencia de sus demandas excesivas sobre los demás y los conflictos sociales que estos provocan. La evaluación no crítica de estos temas puede brindar una gran ayuda para los pacientes que desconocen cuán activamente están destruyendo sus oportunidades en el trabajo y la vida social. Un problema importante con algunos pacientes narcisistas que funcionan con un nivel abiertamente límite es la discrepancia entre sus altas ambiciones y su incapacidad para realizar estas ambiciones. Muchos pacientes prefieren ir a bienestar en lugar de sufrir la humillación de trabajar en lo que consideran un trabajo inferior. La exploración activa de esta contraestación y el énfasis del terapeuta en los efectos negativos de la eficacia social sobre la autoestima pueden ayudar al paciente a lograr una solución comprensiva entre su nivel de aspiraciones y su capacidad. La tendencia narcisista de los pacientes a "incorporar" con entusiasmo ", lo que reciben del terapeuta y lo convierten en su tendencia relacionada con" robo "no consciente del terapeuta en un esfuerzo por compensar la envidia de él y de reconfirmar la patología del paciente. Grandiose Self (Rosenfeld, 1964) -May en realidad Fomentar el trabajo psicoterapéutico en la psicoterapia suministrada. El paciente puede adoptar las ideas y las actitudes del terapeuta como las suyas y usarlas en su vida diaria, mientras aún se tranquilizan a sí mismo que puede hacerlo solo. Si tal identificación con el THERPIST tiene funciones adaptativas, incluso si se basa en tipos patológicos de idealización, debe tolerarse y su

fortalecimiento de la autonomía del paciente aceptada. De hecho, este mecanismo tiene efectos potencialmente positivos en la psicoterapia de apoyo de las personalidades narcisistas mediante el acuerdo de los efectos potencialmente negativos de su envidia inconsciente.

Capítulo 13: Análisis de caracteres en línea con los esfuerzos anteriores para enriquecer un enfoque de psicología del ego a la técnica psicolítica con la teoría de las relaciones con objetos (ver Kernberg, 1980, cap. 9), mi objetivo aquí es integrar mis ideas con respecto a las características estructurales. De patologías de carácter severo con la teoría de la técnica de Fenichel (1941). Las propuestas de Fenichel para los criterios metapsicológicos para la interpreencia, incorporados y revisaron críticamente las recomendaciones técnicas de Wilhelm Reich (1933) para analizar las resistencias de los personajes. De acuerdo con mi entendimiento, los conflictos intrapsíquicos inconscientes no son simplemente conflictos entre impulso y defensa, sino que tienen entre dos unidades opuestas o conjuntos de relaciones de objetos internalizados. Cada una de estas unidades consiste en un yo y una representación de objetos bajo el impacto de un derivado de accionamiento (clínicamente, una disposición afectiva). Tanto el impulso como los despedidos consideran expresión a través de una relación de objeto internalizado inexplemente imbuido. Los rasgos de carácter patológicos realizan funciones defensivas dominantes y crónicas en el equilibrio psíquico de pacientes con paimatología de carácter grave. Todas las defensas de los personajes consisten en una constelación defensiva de las representaciones de sí mismo y objetos dirigidos contra una constelación de sí mismo y de objetos opuestos y temidosos. Por ejemplo, un hombre que es extraísmo sumiso puede estar operando bajo la influencia de una unidad que considera una representación de autospresentación que se somete felizmente a una representación poderosa y protectora de los padres (objeto). Pero este conjunto de representaciones lo defiende contra una representación reprimida que se rebele sobre una representación de padres sádicas y castres. Estas relaciones de objetos internalizadas en conflicto pueden, en circunstancias óptimas, reactivarse en la transferencia, en cuyo caso CARACTER 210

Análisis de caracteres 211 Las defensas se convierten en resistencias de transferencia. Formular la interpretación de estas resistencias de transferencia en términos de sus relaciones de objeto induldeizada hipótesis pueden facilitar la reactivación de estas representaciones de uso y objetos componentes en la transferencia, transformando así la defensa del carácter "endurecida" en un activo Conflicto intrapsy chic y transferencial. La habietia del personaje de la habilidad del paciente, los rasgos de carácter más patológicos adquieren funciones de transferencia específicas y se convierten en resistencias de caracteres y resistencias específicas de transferencia simultáneamente (Fenichel, I945B, PP. 29, 537). La formación de compromiso entre el impulso y la defensa representada por estos rasgos de carácter patológicos también conduce a una gratificación de impulsos más o menos disfrazada en la transferencia. El hecho de que, en casos graves, los rasgos de carácter patológicos se entrometen de manera prematuro y constante en la situación de la transferencia significa que el paciente parece ingresar prematuramente una etapa de distorsión grave en su relación con el analista, que se parece a la neurilidad de la transferencia ordinaria, pero también difiere de eso. La neurosis típica de transferencia en los casos menos devasados lleva algo de tiempo para desarrollarse y generalmente está acompañado por una disminución de las manifestaciones neuróticas del paciente fuera de las sesiones analíticas. Sin embargo, la transferencia del paciente que sufre de una patología severa de carácter, parece consistir en la jugada del paciente en las sesiones un patrón que también persiste simultáneamente en el resto de su vida. Además, la gravedad de la patología se refleja en el grado en que se expresan rasgos de carácter patológicos en el comportamiento no verbal en la situación del tratamiento en lugar de a través de la libre asociación. Para complicar aún más los asuntos, la habilidad de la patología del personaje, más se examinó la conducta no verbal del paciente, que examinó durante

muchas semanas o meses, también muestra un desarrollo paradójico. Los cambios caóticos ocurren desde el momento hasta el momento en cada sesión psicoanalítica, lo que hace que sea muy difícil seleccionar el material predominante para la interpretación. Y, sin embargo, durante un período de semanas, meses o incluso años, se puede detectar una estabilidad extraña en ese aparente caos. Un conjunto inconsciente, altamente específico de distorsiones emerge en la relación del paciente con el analista que refleja las relaciones de objetos internalizados activados de defensiva. Estos deben resolverse como parte del análisis de la transferencia para obtener un cambio intrapsíquico estructural significativo. Con frecuencia, se activan alternativamente dos conjuntos contradictorios de las relaciones de objetos primitivos, funcionando como defensas entre sí; A veces, su disociación mutua es la resistencia dominante que debe ser trabajada. O bien, una relación de objeto primitiva específica adquiere una influencia sutil, sutil, sutil, pero controlante sobre la relación del paciente con el analista y se expresa, a uno mismo en una distorsión del entorno psicoanalítico con el tiempo en lugar de en los desarrollos concretos que fluctúan la sesión por sesión.

212 Personalidades narcisistas Viñeta clínica El Sr. T. A profesionales en el campo de la rehabilitación social, un hombre soltero a mediados de los años treinta, consultado debido a las dificultades en sus relaciones con las mujeres y en su trabajo con los clientes, una capacidad severamente limitada para la empatía, y Un sentido general de insatisfacción expresado en experiencias de aburrimiento, irritabilidad e incertidumbre sobre el significado que la vida se sostuvo para él. Sufrió de una personalidad narcisista sin límite abiertos o características antisociales. Su actitud inicial hacia la participación en el psicoanálisis y el método de libre asociación estuvo marcado por una fuerte ambivalencia. Por un lado, me consideró uno de los analistas más deseables en la comunidad profesional local relativamente pequeña donde trabajé; Por otro lado, pensó que el psicoanálisis era una técnica bastante anticuada y "passe", y consideraba lo que experimentaba como mi rígido mantenimiento de una postura psicoanalítica como pomposa y peatonal. Su propio enfoque teórico y fondo estaban casi diametralmente optimizados a las vistas psicodinámicas. En las primeras etapas de su psicoanalíaco, el Sr. T también estuvo extremadamente preocupado por mi interés en lo que estaba diciendo; Él me sospechó de la indiferencia total y interpretó cualquier movimiento que hice detrás del sofá como actividad que no tiene relación con él (como equilibrar mi chequera). Se hizo muy enojado cuando no recordaba un nombre o un evento que había mencionado en una sesión anterior. Las asociaciones gratuitas del Sr. T se centraron en su relación con su última amiga. Al principio, la consideraba muy atractiva y deseable, pero gradualmente descubrió las deficiencias en ella que lo hizo sentir que estaba cada vez más de él de él, lo que era de ella y lo llevó a querer terminar la relación. En este contexto, su súperidad general de las mujeres, su temor de que lo explotaron, surgió como un tema importante. Este miedo podría ser rastreado de nuevo a la relación con su madre, una socialita localmente prominente que dominó a su padre y a quien había

experimentado como dominante, intrusivo, deshonesto y ma-nipulativo. El paciente describió a su padre como un hombre de negocios trabajador y eficaz, retirado y no disponible crónicamente durante la infancia del Sr. T. Durante los dos primeros años de su psicoanálisis, la conexión entre sus reacciones a su novia, su madre, y yo se hizo cada vez más evidente. Fuego hipócritamente que me interesaba en él cuando en realidad lo estaba usando por mi propio interés financiero, o pretendía escucharlo cuando estaba comprometido en mis propias actividades. De manera similar, su chica fingió amarlo, pero solo estaba interesada en extoitirlo social y financieramente. Gradualmente, también se hizo evidente que en su tratamiento de ella mismo era dominante y explotador,

Análisis de caracteres 213 Esperando que ella adivine su estado de ánimo y responda a sus necesidades sin que le presten atención a la de ella. Cada vez que intentara consciente de su contribución a sus dificultades, el Sr. T me acusó enojado de tratar de hacer que se sienta culpable y de actuar de la forma en que su madre hizo hacia él. Me vio tan astuto, intrusivo, dominante y culpable provocando, al igual que su madre. En la transferencia, mi promulgación de la réplica de su madre ahora parecía completa: O bien me quedé en silencio, indiferente, y solo pretendía estar interesado en él o en realidad me interesaban lavarlo con mis puntos de vista haciéndole sentirse culpable y sádicamente disfrutando de ese control. Esfuerzos para transmitirle a Él que le atribuyó aspectos de su propio comportamiento hacia las mujeres que no podía tolerarse eran inútiles. Rompió con su novia y, varios meses después, estableció una nueva relación con una mujer que pronto se convirtió en un fax de la anterior. Durante el próximo año, los mismos temas parecían repetirse sin cesar en la asociación libre y en su relación conmigo. Poco a poco llegué a la conclusión de que la promulgación de la relación con su madre en la transferencia y con sus novias satisfacía propósitos poderosos y instintivos. Era como si lograra obtener alguna satisfacción secreta (al menos parcial) de sus necesidades no reconocidas por el control sádico de las mujeres que vio. Las mujeres también sirvieron como receptáculos para la proyección masiva de su madre, brindando así ratificaciones por sus ataques a ellos. En el tercer año de su psicoanálisis, me di cuenta de que la relación del Sr. TS en la transferencia, básicamente, no había cambiado desde la iniciativa de tratamiento. Tampoco tuvo su descubrimiento de las experiencias de la infancia con su madre (que explicó, aparentemente, sus relaciones actuales a sus novias y para mí) dieron como resultado cualquier cambio de sus condenas conscientemente sostenidas sobre su presente o pasado. También noté en su continua sospecha y enojo hacia mí una fácil activación de fantasías de detener el

tratamiento. Aunque nunca se detuvo, no tenía la sensación de certeza sobre su compromiso en el análisis que tuve con otros pacientes que podrían perder sesiones ocasionales cuando actúan las reacciones negativas de la transferencia, sino sin agitar mi convicción de que regresarían. Con este hombre, sentí una fragilidad en nuestra relación y una falta definitiva de profundización. También observé, durante un período de meses, que el Sr. T escuchó a mis interpretaciones con entusiasmo, pero luego estuvo de acuerdo con ellos, con la implicación de que anteriormente había alcanzado las mismas conclusiones, no estaba de acuerdo con ellos de inmediato, o intentó discutir conmigo sobre ellos. Interpretaciones que no aceptó de inmediato, simplemente despidió. En otras ocasiones, apareció muy interesado en una interpretación y, de hecho, intentó usarlo en la suya.

214 clientes narcisistas de personalidades, pero nunca dio evidencia de hacerlo para profundizar su comprensión de sí mismo en sus horas conmigo. En resumen, sus reacciones a mis interpretaciones reflejaron una incapacidad crónica para depender de mí para una mayor exploración psicológica. En su lugar, parecía alternativa a extraer las interpretaciones de mí y apropiarlas por su propio uso. Abraham (1919), Rosenfeld's (1964), y mis propias observaciones (1975) sobre las resistencias de transferencia narcisista se aplican claramente a este paciente. Cuando intenté interpretarle estas dinámicas a él y a explorar las funciones de su actitud, surgió que el Sr. T se estaba protegiendo a sí mismo contra los intensos sentimientos de envidia de mí, utilizando para que su propio rinde plantea lo que viera como nuevo y bueno que venía de mí. Estos sentimientos enviados y las defensas contra ellos reflejaban los conflictos preeedipales y edípicos. Gradualmente se hizo evidente para él que, aunque, por lo tanto, podría protegerse de sentirse envidioso de mí, él estaba autorizando a usar mis comentarios por su propia autoexploración. Este descubrimiento nos llevó de nuevo a su actitud inicial despectiva y crítica hacia el psicocálisis en lugar de su afirmación de su propia aplicación muy diferente a los clientes. Durante un período de tiempo, el Sr. T comenzó a entender que estaba dividido entre sus opiniones de mí como alguien que podría ser fundamental para ayudarlo a superar sus dificultades con las mujeres, alguien de quien, por lo tanto, se sentiría extremadamente envidioso, lo cual fue intolerable, y alguien que no tenía que envidiar en absoluto., Que reconfirmaría su convicción de que no se esperaba nada del psicoanálisis. Este análisis de su actitud hacia mis interpretaciones y, por implicación, de su actitud claramente contradictoria y constantemente oscilante hacia mí, su sentido de inquietud y soledad en las sesiones. Sintió que incluso si lo que estaba apuntando hacia él era preciso, lo que hacía, así que implicaba un grandioso triunfo sobre él y mostrando en mi parte; Como resultado, se sintió impotente, perdido y rechazado por mí. En este

contexto, en el cuarto año de su psicoanálisis, se produjo el seguimiento del episodio más bien prolongado. El Sr. T se mantuvo cada vez más alerta a lo que pueda experimentar como mis deficiencias, tanto dentro como fuera de las sesiones. Desconocido para mí, desarrolló una red de información sobre mí que se extendió a través de varios grupos relacionados en la pequeña ciudad donde vivimos y culminamos en su establecimiento con un grupo de miembros de la comunidad psiquiátrica local de la comunidad psiquiátrica local que profundamente Resentido la institución en la que estaba y mi papel en ello. El Sr. T comenzó a extraer de una persona que se sentía especialmente hostil para mí que el paciente me consideraba dañándome, mientras alimentaba su información de contacto sobre mis deficiencias como analista. Cuando esta información, amplificada, regresó a mi paciente a través de una tercera persona, se alarmó y "confesó" a mi proceso. Que él

El análisis de caracteres 215 tuvo durante semanas reteniendo todos estos desarrollos de mí en el mismo, ilustra la tenuencia de la relación terapéutica, las limitaciones en las asociaciones libres del paciente, y la distorsión en el entorno psicocalíalítico. Mi reacción emocional inmediata a la confesión del Sr. T fue intensa. Me sentí herido y enojado, controlado por el paciente e indefenso. Tomó las horas antes de que me di cuenta de que la relación del Sr. T con su madre se había activado ahora con roles invertidos, que ahora se estaba identificando con el agresor, y que yo, en la contratransferencia, se identificaba con él como víctima de las manipulaciones de su madre. También me dio cuenta del intenso temor del paciente de que podría tomarme la represalia o abangarlo y que este miedo se mezcló claramente con sentimientos de culpa. Después de explorar sus fantasías sobre mi represalia y rechazarlo, comentó espontáneamente que eso es lo que sentiría como hacer en circunstancias similares, dije que su descripción de su propio comportamiento se reafirmó sus descripciones del tratamiento de su madre, una interpretación que él Ahora podía aceptar. También le dije que su conciencia de que su curiosidad sobre mí contenía elementos agresivos lo hizo menos necesario para que ella niegara estos sentimientos. El Sr. T luego dijo que había encontrado el intercambio de información con el grupo hostil emocionante. Se había sentido todo el tiempo que estaba transgrediendo nuestra comprensión esencial sobre la comunicación abierta, arriesgando, ya que lo vio, la continuación de su relación conmigo, pero también experimentando un sentido de libertad y poder que era emocionante, incluso intoxicante. De hecho, agregó, ahora que ya no temía que lo tiraría, podía ver algo "bueno" en toda la experiencia. Una mayor exploración llevó a su conciencia de que su sentido de satisfacción, poder y emoción provino de su sentimiento de que podría controlarlo y manipularme, y yo estaba realmente limitado por mi actitud y alítica. Nunca antes había visto nuestra relación en este contexto. Esto, a su vez, llevó a una mayor exploración de

su ahora activa relación con mí en la que se atrevió a identificarse con su madre, reconociendo un profundo sentido de poder y satisfacción para expresar la agresión de que nunca se había atrevido a aceptar en sí mismo, mientras aparecía en el papel de sí mismo, Dominó sin poder hacer una persona que él como su propia madre. Esta agresión incluía elementos de envidia determinada por oralmente y impulsos anal-sádicos con condensación con los impulsos castres (que se hicieron dominantes en etapas posteriores del análisis). Por primera vez, el Sr. T pudo experimentar una identificación con la imagen que había proyectado de su madre a lo largo de todos estos años. Al mismo tiempo, logró el contacto con los componentes agresivos y revueltos de su envidia de mí. Durante los próximos meses, se hizo posible señalarlo cómo su imagen de sí mismo como ayuda menos, vacía, derrotada y solitaria de las mujeres explotadoras con respecto a

216 Personalidades narcisistas Defensa contra la autoimagen opuesta, en la que se identificó con su poderosa madre y se dividió de manera sáxica en relativa a las mujeres y a mí, como sus esclavos impotentes. El resultado fue una integración de la representación de autospresentación sádica resplanada previamente disociada y reprimida que se identifica con su madre y la autónoma vacía e impotente, establecida contra ella. Como consecuencia, y en el contexto de la integración de estos afectos contradictorios y las autorrepectativas, el Sr. T se hizo más capaz de explorar su relación con ella en profundidad y profundizar su participación de su relación con las mujeres y también a su madre. En cuanto a eso, una nueva imagen de mí comenzó a surgir en la transferencia. Recibí un padre tolerante y cálido hacia el cual el paciente experimentó los anhelos dependientes y sexuales, marcando, por primera vez, un cambio en la naturaleza del paradigma de transferencia predominante y en su experiencia del pasado. Se pueden resaltar varios aspectos técnicos de este caso. Primero, la activación temprana de las resistencias de transferencia (la ira del Sr. T y la sospecha de mi falta de interés en él) repetían aspectos de sus relaciones con las mujeres. Por lo tanto, podría integrar inmediatamente el análisis de las resistencias de los personajes con los principales temas que surgen a través de la asociación libre (su relación con sus novias). A continuación, la naturaleza parcial de su propia representación, su incapacidad relacionada para profundizar su relación emocional, así como a sus novias, y la versión correspondiente de su pasado de su pasado surgió gradualmente como un auto-perpetuando, Glo-Bal. Resistencia a avance adicional en el tratamiento. Ahora, mi enfoque en la actitud del paciente hacia mis interpretaciones permitió la interpretación del aspecto más generalizado de su estructura de personalidad narcisista, a saber, su identificación con una representación materna sádica como un constituyente central de su propio apresuramiento de su propio ser patológico. El trabajo a través de esa

característica en la transferencia fue necesario para cualquier movimiento adicional en el proceso psicoanalítico. Se debe enfatizar que el comportamiento emocionado y sádico hacia mí, relacionado con una representación disociada, estaba disponible como una experiencia consciente en las relaciones del Sr. T con varias mujeres, donde se expresó solo en rabietas de temperamento y las tormentas emocionales prolongadas que estaban "justificadas" por Su proyección masiva de la imagen de la madre en las mujeres. Por lo tanto, esta auto representación en particular estaba consciente, pero se disociaba de las experiencias autónomas en las que el Sr. T se sentía solitario e inferior. Se racionalizó y se protegió contra estos sentimientos por las operaciones defensivas primitivas, en particular la identificación proyectiva. La expresión de este grandioso y un patrón sádico en la transferencia y su integración, mediante la interpretación, con autosiciones contradictorias del niño derrotado y explotado marcó la finalización exitosa de un análisis sistemático del carácter correspondiente. Resistencias que habían surgido por primera vez en relación con mis interpretaciones. En retrospectiva, el pa-

El análisis de caracteres 217 Ente podría entender que, al rechazar mis interpretaciones, así como en cooperarlos, había promulgado sutilmente el papel de su madre y también su propio papel como un niño frustrado. Este desarrollo también ilustra una diferencia interesante entre la grandiosa propia narcisista y las representaciones de autos derechos normales disociados o reprimidos contra los cuales está defendiendo el GRANDSOSE. El auto-concepto dominante del paciente fue de sí mismo como un niño maltratado entendente a la indemnización. Este concepto se escondió detrás de una explotación auto-justicia y bien racionalizada de las mujeres y un despido despectivo de lo que podría agitar su envidia. En contraste, el aspecto sádico, enojado, sin embargo, del yo que surgió en la transferencia también formó parte de la autoprentra de la autoprentad, paradójicamente más cercana a la autenticidad y la profundidad en relación con los objetos que la representación de la superficie de la superficie defensiva.. En el nivel más profundo, su concepto de su madre distérica incluía la proyección sobre ella de sus propias sensaciones ragítas de muchas fuentes. Desde un punto de vista aún diferente, la sensación de estancamiento que experimenté a lo largo de una parte importante del tercer año de tratamiento podría interpretarse de manera retrovisual que se interpretará de manera retrovisora como consecuencia del mecanismo del control omnipotente. El paciente estaba interfiriendo con éxito con mi interpretación de los aspectos agresivos disociados de su Ser, acusándome enojado de tratar de hacer que se sienta culpable cada vez que intenté interpretar aspectos agresivos de su comportamiento que no podía aceptar en sí mismo. Era como si tuviera que funcionar como una madre dominante o, de lo contrario, retraí impotencia en el fondo. Mi dolor y mi reacción enojada después de su actuación de los aspectos negativos de la transferencia señalados, además de mi propio potencial de contratransferencia, la activación dentro de su imagen de sí mismo como el indefenso, atacado y herido a los

niños pequeños enfrentados a una madre abrumadora. Por lo tanto, mi reacción emocional podría ayudarme a analizar aún más un aspecto de su experiencia de sí mismo en relacionarse con su madre, mientras se apunta a su promulgación del papel de su madre en su relación. Esta formulación hace uso de los conceptos de identificación concordante y complementaria en la contratransferencia propuesta por la retaja (1957), que enfatizó una perspectiva de relaciones de objeto en el análisis de la contratransferencia. Estrategias de análisis de caracteres La gravedad de la patología del carácter no es suficiente para indicar si la interpretación de las resistencias de los caracteres debe administrarse antes o más tarde. En este sentido, la propuesta de Fenichel (1941, p. 67) que se examine deficiencias de los caracteres de acuerdo con lo predominante en cualquier punto de la situación analítica es un enfoque razonable para el tema práctico de cuándo interpretar las resistencias de los personajes. Sugiere primer trabajo-

218 Personalidades narcisistas con las defensas habituales y continuas de los personajes del paciente en OR- dernan a "liberar la personalidad de su rigidez" y trabajar con otras resistencias de caracteres solo cuando se han convertido en resistencias de transferencia (p. 68). Pero uno primero tiene que saber si lo que se está enfrentando es la resistencia a los personajes y, si es, si es económicamente predominante en ese momento. Fenichel sugiere que funciona "en el punto de los conflictos instintivos más importantes. Es el punto de los conflictos más importantes en este momento" (1941, p. 47). En mi opinión, el criterio económico de la interpretación se determina por el punto de la disposición más alta de afecto en el material. En la medida en que los accionamientos (ya sea que funcione como parte de la defensa o en el lado del impulso del conflicto) se manifiestan como las relaciones de objetos internamente invertidos de manera afectiva, la relación de objeto afectiva predominante en la situación analítica representa el conflicto instintivo económicamente dominante también. Pero el dominio afectivo no es equivalente a las manifestaciones de la consciencia o la superficie. A medida que Fenichel lo puso: "Porque debemos operar en ese punto donde el afecto está realmente situado en este momento; debe agregarse que el paciente no conoce este punto y primero debemos buscar los lugares donde se encuentra el afecto" (1941, p. 45). Propongo que la evaluación de (i) el contenido de las asociaciones gratuitas, (2) la naturaleza prevaleciente de las interacciones en la relación paciente / analista, incluido el comportamiento noverbal del paciente durante las sesiones, y (3) la relación general del paciente con el El establecimiento psicoanalítico durante un período de meses o incluso años hace posible discernir si los rasgos patológicos de carácter han invadido la transferencia, lo que resulta en una condensación de la transferencia y las resistencias de los personajes, y si estas resistencias de caracteres se han vuelto afectivamente predominantes, por lo tanto Justificando la máxima prioridad como el foco de las

. . .

interpretaciones psicoanalíticas. Si la Asociación GRATUITA se está realizando satisfactoriamente, si las resistencias que surgen en el contexto de explorar las posibles restricciones de la libre asociación pueden interpretarse, independientemente de si estas están directamente relacionadas con la transferencia, y si la conciencia del paciente de su vida intrapsíquica como Bueno, ya que su relación emocional con el analista se profundiza con el tiempo, entonces la interpretación del comportamiento no verbal en las sesiones puede esperar hasta que se pueda incorporar naturalmente en los temas de las sociales libres y la transferencia. Se encuentran situaciones clínicas específicas en las que el comportamiento no verbal emerge enérgicamente en las sesiones y en el que los afectos y las relaciones de objeción implicadas por el comportamiento no verbal del paciente y las comunicaciones verbales son congruentes o complementarias. Cuando existe una consonancia entre el material no verbal y verbal, la comprensión de las implicaciones de transferencia de ambos generalmente permite un entendimiento más profundo de ambos. En otras palabras, si el material verbal y no verbal indi-

Análisis de caracteres 219 Cates La naturaleza de los problemas que predominan afectivamente en el contenido de la hora, se puede aplicar el principio económico de interpretación en el sentido de trabajar en el punto del conflicto instintivo actual más importante (Fenichel, 1941, p. 47). Por lo general, el material también se puede entender simultáneamente en términos del principio dinámico, es decir, en términos de un conflicto entre impulso y defensa, y la decisión se puede hacer en qué aspecto del lado de defensa del conflicto debe explorarse antes del aspecto del impulso. La congruencia entre el comportamiento y el contenido y el dominio afectivo en la hora generalmente significa, por la misma muestra, que la "unidad" de las relaciones de objeto involucrada también es dominante en la transferencia. La aclaración del ordenamiento dinámico de impulso y defensa generalmente también tiene aspectos topográficos, lo que permite una interpretación de la superficie a la profundidad, de la conciencia al inconsciente. Por lo general, encontramos una consonancia de las comunicaciones verbales y no verbales en pacientes con una estructura intrapsíquica tripartita bien consolidada, cuyos conflictos también tienden a organizarse intersstemicamente. Por lo tanto, es posible aclarar qué sistema-ego, superyó o ID, la organización dependedente predominante corresponde a qué otro sistema está derivado del impulso. Por lo tanto, también se aplican los criterios estructurales de la interpretación. Sin embargo, en otras situaciones clínicas, los conflictos reflejados en el contenido verbal y el material interactivo parecen disonante o incongruente. Los efectos fuertes en el contenido verbal y el desarrollo de interacciones afectivas agudas o crónicas que reflejan los rasgos de carácter "congelados" del paciente parecen extrañamente no relacionados entre sí, lo que aumenta la cuestión de lo que realmente es predominante. Bajo estas circunstancias, la aplicación de los criterios propuestos a continuación generalmente permite que uno esté activado en una decisión con respecto

a qué material debe tratarse primero y cómo abordarlo. Es útil considerar primero si las asociaciones gratuitas del paciente están continuando satisfactoriamente o si existe una supresión consciente significativa del material. Independientemente de lo que facilite la comprensión de los motivos de la supresión consciente y las implicaciones de transferencia relacionadas tengan prioridad aquí. Una comprensión del significado de la transferencia de lo que está motivando al paciente contra el cumplimiento total de la asociación gratuita, generalmente también proporciona una respuesta a lo que es afectivo predomante en la sesión y si se relaciona principalmente con el contenido verbal o a los aspectos del comportamiento no verbal del paciente. Ahora, si la Asociación GRATUITA parece estar procediendo satisfactoriamente, la cuestión de lo predominante en la transferencia se puede examinar con mayor facilidad y ayuda al analista a decidir si predomina el material verbal o actitudinal. Sugiriendo que, con dos unidades "de las relaciones de objetos simultáneas y paralelas" reveladas en la situación psicoanalítica (una en el comportamiento, la otra en el contenido verbal), el que tiene ambos

220 Personalidades narcisistas La dominalización de la transferencia y el dominio afectivo adopta la precedencia interpretativa. Sin embargo, si, el dominio afectivo y el dominio de la transferencia divergen, creo que el dominio afectivo (la aplicación del principio económico) debería tener prioridad. Debería enfatizar que todos los aspectos defensivos e impulsivos, verbales y no verbales, autosuficientes y no verbales, de los materiales tienen componentes afectivos, de modo que el "dominio afectivo" no significa la búsqueda de algún afecto particular o una de una persona conscientemente dominante, o una vinculada. Sólo con defensa o impulso. El afecto predominante es el efecto predominante en la situación inmediata total que cuenta, no su acceso a la conciencia. Una rabieta de temperamento histérico, por ejemplo, puede defenderse contra otro afecto dominante en la situación inmediata de la transferencia. El enfoque que estoy sugiriendo difiere de la insistencia de Wilhelm Reich (1933) que las resistencias de transferencia ancladas en el carácter siempre se interpretan primero. También difiere de la insistencia de la de Gill (1980, 1982) de que la transferencia siempre se le da la mayor prioridad para la interpretación; Hay momentos en que la inversión afectiva es la más alta en los problemas de extratransferencia o en la exploración del paciente de los aspectos de su pasado. El hecho de que todo material analítico tenga componentes de transferencia no significa que el material de transferencia predomina automáticamente. A veces, un tema que ha dominado enérgicamente la transferencia durante muchas horas, por ejemplo, por ejemplo, la insatisfacción crónica de un paciente sobre "no recibir nada del analista", a una vez que se desplaza de repente a un desplazamiento de una tercera persona. Aquí, el dominio afectivo y la transferencia siguen siendo consonantes, aunque la transferencia se encuentra temporalmente desconectada (que puede facilitar realmente su interpretación). Además, a veces los cambios rápidos en la transferencia en sí, lo que

complica la tarea de detectar incongruencia entre la comunicación verbal y no verbal, esperando una cristalización en torno a una de las diversas cuestiones de manera afectiva, exención, debería permitir que el analista decida cuál es la afectiva (y, por lo tanto, económicamente) predominante. Aquí, es preferible una actitud de "esperar y ver", en mi opinión, al punto de vista topográfico exclusivamente de centrarse en lo que en el material es el más cercano a la conciencia. Nunca hay solo una "superficie" al material. Hay muchas configuraciones de superficie, y el punto en el que penetrar en la superficie a la profundidad (el criterio topográfico) depende de lo que realmente es dominante en la situación total. Obviamente, cuando se puede ayudar al paciente a adquirir conciencia sobre las disposiciones emocionales simultáneas, fuertemente no relacionadas en la situación analítica, la exploración de sus asociaciones a esta observación en sí misma ilumina los problemas involucrados. Durante los períodos de mayor resistencia, el material más importante puede ser relativamente distante de la conciencia (particularmente en las estructuras de la persona con mecanismos represivos fuertes). Aunque estoy de acuerdo en que, una vez que uno ha decidido qué material es el más importante, este compañero.

Análisis de caracteres 221 RIAL debe explorarse de su lado defensivo o aspectos (que incluyen la consideración de algunas configuraciones conscientes o preconscientes relacionadas con él), el acceso a la conciencia no indica en sí mismo predominio temático. Aquí estoy cuestionando una tendencia general para que el analista siempre proceda de la superficie hacia abajo, desde el material consciente hasta el inconsciente, sin tener en cuenta lo que es económicamente predominante. Sin embargo, también cuestiono la tendencia a llegar a las interpretaciones genéticas prematuras de las fantasías inconscientes reflejadas en las relaciones de objetos fijadas caracterológicamente en la transferencia. Mantenerse cerca de las manifestaciones de la superficie de las resistencias es tan problemática como la búsqueda del "nivel más profundo" de un conflicto de cierta, "profundo", generalmente significa genéticamente temprano. Creo que el AnaSt debería interpretar en profundidad en la sensación de enfocarse en los conflictos inconásticos que predominan en cualquier sesión en particular, los aspectos inconscientes de la transferencia en el presente y ahora. (¡Pero aquí, y ahora debe estar relacionado con el ahí, y entonces también, cuando existen discrepancias importantes entre la comunicación verbal y no verbal, cuando la libre asociación parece estar procediendo satisfactoriamente, pero sin una profundización real del material, y cuando, además, allí, allí. Are indications of stalemate in transference develop-
ments—or a loss of previously gained understanding of the current na-
ture of the transference—I have found it helpful to give clear prece-
dence to the analysis of the object relations aspects of the patient's
attitudes over those derived from Sus comunicaciones verbales. La misma "regla" se aplica a las situaciones en las que el paciente está actuando repetidamente o parece estar desarrollando un fuerte potencial para actuar. Dar prioridad a la comunicación no

verbal también se aplica a situaciones en las que la dispersión emocional general, una exacerbación de los mecanismos de división, resulta en la fragmentación afectiva y se convierte en una importante resistencia a la transferencia, que ocurre particularmente en fuertemente esquizoides Personalidades. También daría preferencia a la interpretación del comportamiento sobre la de las comunicaciones verbales disonantes para los pacientes con estilos de vida "viviendo", aquellos cuyas asociaciones libres permanecen fijadas a un nivel de superficie, o aquellas que carecen de una actitud cooperativa reflexiva y cooperativa. En todos estos casos, la recomendación de Reich que las actitudes se interpretarán antes del contenido verbal y que se considere una aplicación especial del principio de interpretar la "superficie" antes de "profundidad", "Defensa antes del contenido", sigue siendo válida. De manera similar, la patología del carácter límite, en la cual se grave actuando los colores, la etapa inicial del tratamiento, también requiere una interpretación rápida de los significados de la transferencia de los rasgos de carácter patológico. En otras palabras, cuando la Asociación GRATUITA "se atasca" en el contexto de la importante activación de los patrones de comportamiento patológico en la situación analítica o en la vida externa del paciente, la exploración analítica de estos

222 Personalidades narcisistas Se indica a las personalidades narcisistas y la aclaración de su relación con la transferencia. Para ponerlo todavía diferente: desde un punto de vista económico, las discrepansiones entre el comportamiento verbal y no verbal requieren un enfoque interpretativo para la imagen total generada por estas discrepancias. En la práctica, por lo tanto, las resistencias de los personajes en la transferencia deben ser atendidas desde el principio. En otros casos, las distorsiones severas en relación con el entorno psicoanalítico se hacen evidentes durante un período de tiempo. En la viñeta presentada anteriormente, después de un período de progreso en el tercer año del análisis, un estancamiento teretico destacó la patología de la relación del paciente con las interpretaciones y al analista en general (los sutiles compromisos se solucionan entre la idealización envidiosa y devaluación). En otros casos, al igual que los descritos por Reich, las asociaciones libres del paciente aparentemente fluyen, con abundantes cambios sobre los cambios presentes y pasados y flexibles de afectos a los pensamientos intelectuales, desde la fantasía hasta la realidad, desde la transferencia hasta la vida externa del paciente, etc. por lo tanto, imitando las descripciones de 1919 y las de 1955 de Ferenczi de la libre asociación libre), pero sin una profundización real de la relación de la transferencia o cualquier manifestación de un comportamiento no verbal en particular en las sesiones que se prestarse a explorar el Transferencia. En estos casos, nuevamente es la relación total en el analista que se distorsiona usualmente, y es esta distorsión que se debe diagnosticar, particularmente, ya que afecta la relación del paciente con las interpretaciones del analista. Aquí la interpretación de los rasgos patológicos de carácter coincide con la interpretación de la actitud del paciente hacia el analista de interpretación. En condiciones de tales estancados, este tema tiene una alta prioridad. De lo contrario, tales pacientes generalmente adquieren un "aprendizaje" superficial de

las teorías de la psicoanalista como una forma de resistir defensivamente la conciencia total de sus conflictos intrapsíquicos inconscientes, con efectos terapéuticos limitados con conversidad. En estas circunstancias, es importante aclarar los aspectos noiciosos de la interacción del paciente / analista en el presente, y ahora como un paso crucial para la comprensión completa de la relación del objeto que se está reproduciendo, sin intentarlo prematuramente para lograr las reconcesiones genéticas. Aquí, y ahora las intervenciones no deben conceptualizarse como se corta artificialmente, disociadas de sus aspectos allí, y luego. Sin embargo, la emisión de su relevancia para el pasado debe mantenerse en suspenso hasta que los aspectos inconscientes de la transferencia se exploren plenamente. El paciente a menudo le resulta más fácil aceptar una interpretación de la transferencia si se hace una referencia tentativa al origen infantil de una determinada actitud hacia el progreso; Por lo tanto, las reconstrucciones genéticas no deben reservarse para las etapas finales del análisis. Pero aquí estoy enfatizando la necesidad primero de aclarar lo desconocido en el presente: un paso erróneamente tallado en muchos pacientes con patología severa de caracteres.

Análisis de caracteres 223 La explicación de la fantasía inconsciente de un paciente sobre la base de una relación de objeto específica promulgada por su comportamiento crónico no verbal en las sesiones corresponde a una construcción psicoanalítica. Pero es necesario seguir esta construcción con una reconstrucción genética solo después de que las asociaciones del paciente transformen gradualmente esta fantasía en una relación de objeto antecedente, con la aparición de nueva información sobre su pasado y un reordenamiento natural de la información nueva y antigua en esta área. El establecimiento de la secuencia genética real de dicho material recuperado requiere que el analista ordene y reordee activamente estas unidades genéticas de los conflictos inconscientes del paciente (Blum, 1980). La exploración del analista de sus propias reacciones emocionales al paciente en condiciones de estancamiento puede ser crucial para el diagnóstico de las distorsiones crónicas de la contraversión (que son más generalizadas, aunque menos intrusivas que los desarrollos de contraatansferencia aguda) y Transferencia sutil pero poderosa que actúa que podría no haber sido diagnosticado. En este sentido, el análisis de la reacción emocional titral del analista es una "segunda línea" de enfoque cuando la primera línea de exploración de la transferencia directa-directa) demuestra insuficiente (He- Mann, 1960; Kernberg, 1975). El análisis de un "intercambio" implícito y, para el paciente, a menudo completamente inútil, los "intercambios" de las relaciones con el analista, destaca las ventajas de estudiar los respuestas afectivos del momento a momento del analista al paciente. Dichos análisis también apuntan la forma de diferenciar las reacciones de la contraversión en un sentido estricto (los conflictos no escocesos del analista se activaron en respuesta a la transferencia del paciente) de la respuesta emocional global del analista al paciente. Sabemos que estos dos aspectos de las reacciones del analista son complementarios. Sin embargo, para fines prácticos, la distinción facilita una

exploración más abierta del cambio de momento a momento en las consecuencias afectivas del analista y las fantasías sobre las actitudes inmediatas del paciente y las disposiciones de actitud crónica, enriqueciendo así. El analista se desempeña el contenido verbal de la comunicación del paciente. ¿Necesito subrayar que la utilización del analista de su propia reacción emocional al paciente ciertamente no significa compartir esa reacción con el paciente? Consideraciones metapsicológicas Ahora vuelvo a considerar los criterios económicos, dinámicos y estructurales de Fenichel para interpretar las resistencias de los personajes, combinandolas con la interpretación de las relaciones de objetos internalizados representados en tales resistencias de caracteres. Con respecto al criterio económico, he enfatizado primero la necesidad de interpretar el material que es afectivo predominante, mientras que el cuestionamiento simultáneo a si la cercanía a la conciencia es un criterio significativo para determinar este predominio de afectos. Este

224 Personalidades narcisistas Ver subyute todo lo que he dicho con respecto a la dificultad para elegir problemas económicamente predominantes cuando la información derivada de las comunicaciones verbales y no verbales del paciente no es congruente. Con respecto a los criterios dinámicos de interpretación, informé anteriormente (1980, cap. 10) que, cuando la regresión de la transferencia es grave o en pacientes analizables con la organización de personalidad límite, la predominio de la división sobre los mecanismos represivos permite la alternancia de la conciencia de Los componentes dinámicamente opuestos del conflicto intrapsíquico para que el acceso a la conciencia per se no sirva para indicar cuál es la defensa y que el aspecto impulso del conflicto. Desenga y el impulso se puede intercambiar rápidamente en los revendimientos alternos de las relaciones de objeto activadas que son típicas de las relaciones de objetos parciales, y los impulsos conflictivos son conscientes y se disocian mutuamente o se dividen en lugar de reprimidos. Aquí, la conciencia y la inconsciencia ya no coinciden con lo que está en la superficie y lo que es profundo, lo que se defensa y lo que es el contenido. Pero mientras que el enfoque topográfico de la interpretación (el ordenamiento del material de la superficie a la profundidad) ya no tiene para tales estructuras límite, la decisión de momento a momento de la cual se encuentra el estado del ego activado defensivo dirigido contra el cual otro estado del ego "impulsivo" es muy importante. Por lo tanto, tanto los criterios económicos como los dinámicos de la interpretación, lo que explican por Fenichel siguen siendo completamente relevantes. Esto nos lleva a los aspectos estructurales de la interpretación de las resistencias de los personajes en varios niveles de severidad de la psicopatología. Las consideraciones estructurales con respecto a la interpretación de las resistencias de caracteres se refieren a la organización de la relación de objeto internalizada predominante activada en la transferencia en el contexto de un rasgo o patrón de carácter particular. Cuando

diagnosticamos las "unidades" de las relaciones internalizadas de objetos, estamos diagnosticando las subestructuras de la estructura tripartita. De hecho, estamos aplicando una perspectiva estructural en la que la estructura general de Tripsite aún no puede (o ya no) ser operativa. La actitud del paciente, como se mencionó anteriormente, refleja la promulgación de una representación automática relacionada con la afectación de una representación de objetos o la promulgación de una representación de objetos (con la cual el paciente parece ser identificado en este momento) relacionado con la autoridad a sí misma (ahora proyectado en el analista). Una consideración principal aquí es la medida en que las representaciones de sí mismas y objetos están arraigadas en aspectos más amplios del ego o superegó al paciente, lo que refleja conceptos, valores y disposiciones emocionales integradas de ego y su superego, lo contrario, la medida en que se disocian o se dividen de otras representaciones de sí mismas y objetos. Las relaciones entre objetos parciales son más perturbadas, extrañas, fantásticas que las relaciones de objeto total. Este último resulte más experiencias de la infancia ordinarias que, aunque reprimidas, se integran con el ego y el superego del niño. En el contexto de estas elaboraciones de los aspectos estructurales de

Análisis de caracteres 225 rasgos de carácter patológico en la transferencia, surge una pregunta importante. ¿La relación de objeto activada refleja los conflictos intersistémicos o intrasísticos? Y en el caso de un conflicto intersysteiflic, ¿a qué agencia las representaciones de autos representaciones y las representaciones de objetos correspondían? O, ¿qué relación de objeto corresponde a la defensa y cuáles al lado del impulso del conflicto, y en qué agencia está incrustada cada uno? En los conflictos intrasistémicos, las relaciones de objetos internalizados de división pueden aparecer por primera vez, se delimitaron mutuamente, pero intrínsecamente indiferenciado, en tiempo, pero vago, y siempre altamente fantástico y poco realista. Deben traducirse a una experiencia afectiva inteligible en el aquí y ahora, una fantasía promulgada por ellos dentro de la cual los aspectos defensivos e impulsos, a su vez, deben aclararse en términos de los cuales la relación de objeto de división adquiere una función defensiva momentánea contra un op- posando (impulsivo) uno. Atención al intercambio entre el paciente y el analista de las representaciones de sí mismo y de objetos: la alternancia de los roles complementarios en la transferencia, debe integrarse en la interpretación de la interpretación de estas expresiones del conflicto. Esa tarea a menudo requiere un seguimiento relativamente rápido y imaginativo de lo que parecen ser las acciones caóticas. El analista está señalando sistemáticamente al paciente cómo se siente bajo el impacto de una autorreponerse y la representación de objetos particulares activada en diferentes momentos puede permitir que el paciente analzable con la patología de carácter grave alcance un grado de integración y empatía consigo mismo y con sus objetos que contribuyan para transformar parte-objeto en relaciones totales de objetos. En la VI- Gnette clínica presentada anteriormente, el Sr. T's gracias a la conciencia de su identificación con su imagen sádica-madre, así como con su auto-imagen tratada errónea y frustrada condujo a su conciencia y la eventual

tolerancia e integración de la contradictoria. Las tendencias en sí mismo, del amor y el odio, y de sus experiencias de auto explotador y devaluada previamente proyectaron a sus novias. A medida que surgen transferencias regresivas en el tratamiento, el ego observador del paciente puede ser arrastrado temporalmente por ellos. Es importante que el analista mantenga una imagen clara de cómo una persona "normal" respondería, en las circunstancias, a los comentarios interpretativos del analista. Esta persona teóricamente "normal" generalmente está representada por el trabajo de colaboración del ego de observación del paciente con el analista, pero puede estar casi totalmente faltante, temporalmente en todos los pacientes, y cronalmente en pacientes con patología de carácter grave. Con los casos graves, por lo tanto, la evocación del analista de una contraparte "normal" al comportamiento regresivo real del paciente se vuelve crucial. Esto significa que el analista tiene que "dividirse". Una parte de él está "experimentando": comprensiva al paciente en regresión y transforma su comportamiento en la construcción de una fantasía inconsciente promulgada. Otra parte de él es "distanciamiento", una objetividad de la pintura precisamente a veces cuando

226 Personalidades narcisistas La objetividad es la más desafiada. La función de límite en la mente del analista entre la fantasía y la realidad requiere su tolerancia de fanáticos primitivos y emociones y de discrepancias internas entre la participación de lo que está sucediendo y el nivel en el que se puede abordar el paciente. El analista debe poder mantener las convicciones firmes para continuar con la flexibilidad. A largo plazo, cuando el análisis de caracteres se persigue sistemáticamente, puede surgir una situación paradójica. Algunos pacientes les resulta mucho más fácil hablar de su pasado que sobre los aspectos inconscientes de su relación actual con el analista. El propio analista puede comenzar a preguntarse si está descuidando la exploración del pasado en su énfasis en el presente. Otros pacientes pueden "saltar" sobre el pasado real y vincular el presente consciente con lo que asumen son los niveles más profundos de los conflictos pasados: "fácilmente" conectan los conflictos actuales con, por ejemplo, "ansiedad de la casualidad", pero no emergen aspectos concretos y dolorosos de la infancia. Trabajo cuidadoso a través de las resistencias de los personajes, manteniendo un estado de alerta constante a si el paciente está cambiando, no solo su experiencia actual de la situación psicoanalítica, lo que indica así cambios auténticos en los patrones de transferencia, sino también cómo experimenta su pasado, por lo tanto, expresando el trabajo de la transferencia. Los patrones pueden confirmar la autenticidad del trabajo psicoanalítico, en contraste con una traducción mecánica de las dificultades actuales en los propios mitos rígidamente mantenidos con respecto a su pasado.

Capítulo 14: Auto, el ego, afecta y impulsa el ego y los problemas terminológicos. Una encuesta de la literatura psicoanalítica sobre las teorías del ego y los conceptos del yo revela una considerable confusión terminológica. Que los términos que los términos ego y uno mismo se usan de manera intercambiable, a veces se distinguen cuidadosamente entre sí, y a veces tratan ambiguamente, probablemente, probablemente se debe a la forma en que Freud usó estas palabras, la forma en que Strachey los tradució, y las elaboraciones posteriores que otros hicieron en ellos.. Freud conservó a lo largo de sus escritos, el ICH alemán, "i", para el ego, como una estructura mental y una agencia psíquica, y también para el yo más personal, subjetivo y experiencial. En otras palabras, Freud nunca se separó de lo que pensamos como la agencia o el ego del sistema de la experiencia. Este uso de ICH resultó en un sacrificio de claridad y precisión, pero mantuvo el significado de la palabra abierta. La ambigüedad resultante del uso de Freud de ICH se ha completado, me parece que, por la decisión de Strachey de traducir ICH como "ego", una palabra que tiene una calidad impersonal que parece ser lo suficientemente apropiada para la teoría estructural de Freud (1923), pero Menos accesorios para el yo más personal, subjetivo. Hay innumerables ejemplos del uso de ICH antes de 1923 para desinuar la experiencia subjetiva y la autoestima, lo que Rapaport podría haber designado críticamente la "antropomorfización" del concepto Ego. Esta característica del concepto de Freud de ICH, que considero una fuerza, no persiste la debilidad a lo largo de su trabajo. El ejemplo más drofatico es probablemente su declaración en la civilización y sus descontentos (19303), donde la edición estándar, fiel al original alemán, 227

228 Personalidades narcisistas Lee (p. 65): "Normalmente, no hay nada de lo que estemos más cierto que la sensación de nuestro yo, de nuestro propio ego". La versión alemana dice (i930B, p. 423), "Normalerweise IST IST UNS NICHTS GESICHERTER ALS DAS Gefuhl Unseres Selbst, Unseres Eigenen Ichs". ¡Aquí mismo y el ego están explícitamente equiparados! Creo que la traducción de Strachey de ICH de Freud, como "ego", ha tenido un efecto en nuestra comprensión del pensamiento de Freud. Estoy de acuerdo con Laplanche y Pontalis en su extensa discusión de este tema (1973, p. 131) que Freud siempre mantuvo la ambigüedad, la tensión interna de su concepto de ICH, para indicar sus propiedades del sistema, así como el hecho de que, como parte de Estas propiedades del sistema, el ego es el asiento de la conciencia y, con ello, la conciencia de uno mismo o del yo como una persona. Una segunda fuente de dificultad es el uso del yo para describir a la persona o individual que interactúa con otras personas o "objetos", como lo hizo Hartmann en 1950: pero en realidad, al utilizar el narcisismo término, dos conjuntos diferentes de opuestos a menudo parecían ser fusionados en uno. El que se refiere al yo (la propia persona) en contrapunto al objeto, el segundo al ego (como un sistema psíquico) en contradicción a otras subestructuras de la personalidad. Sin embargo, lo opuesto a los objetos CathExis no es CathExis del EGO, sino CathExis de la propia persona, es decir, autocatéxis; Al hablar de la autocatéxis, no implicamos si esta cattexis está situada en la identificación, el ego o el superego. Esta formulación tiene en cuenta que en realidad encontramos "narcisismo" en los tres sistemas psíquicos; Pero en todos estos casos, hay oposición a (y reciprocidad con) Object CathExis. Por lo tanto, se aclarará si definimos el narcisismo como la cattexis ibbidinal, no del ego, sino del yo. (También puede ser útil aplicar la autonspresentación del término en lugar de la representación de objetos). [P. 127] Hartmann está aquí haciendo una distinción que, como veremos, permitimos el desarrollo de las contribuciones cruciales de Jacobson

.

(1964) a la psicología del ego: la distinción entre el yo como la persona y la representación intra-psítica de la Persona o auto representación, un tercer término que requiere aclaración. Jacobson (1964), refiriéndose a estos problemas de confirmación terminológica, dijo: "Se refieren al uso ambiguo del término ego; es decir, a la falta de distinción entre el ego, que representa un sistema mental estructural, el yo, Lo que definí anteriormente, y las autopresentaciones. Hartmann (1950)... Sugería el uso del último término (análogo a las representaciones de objetos) para las representaciones de endopsíquicas inconscientes, preconscientes y conscientes del yo mental y mental en el sistema. Ego. He trabajado con este concepto durante años, porque lo encontré indiscutible para la investigación de los trastornos psicóticos" (pp. 18-19). Jacob, hijo, de acuerdo con Hartmann, define el Ser "como referido a toda la persona de un individuo, incluida su cuerpo y partes del cuerpo como

Self, ego, afecta y conduce bien como su organización psíquica y sus partes. . . . El 'Self es un término descriptivo auxiliar, que apunta a la persona como sujeto en distinción del mundo circundante de los objetos "(1964, p. 6). Me parece que Hartmann, al intentar liberar el término ego de Freud's La ambigüedad, empobreció. Al igual que Strachey, quería dar la consistencia del concepto del ego. Y al colocar el" yo "en contradización al objeto, Hartmann en efecto eliminó el" yo "de la meta psicología. La definición de ser en el El glosario de términos y conceptos psicoanalíticos (Moore y Multa, 1968) confirma esta idea. Se afirma:" La persona tal de un individuo en realidad, incluido su cuerpo y su organización psíquica; La propia persona ", en contraste con las" otras personas "y los objetos fuera de uno mismo. El "yo es un concepto de sentido común; Sus aspectos clínicos y metapsicológicos se tratan bajo la autoimagen, la auto resentimiento, etc. Consulte el ego, la identidad, el narcisismo "(p. 88). Para llamar a uno mismo un" concepto de sentido común "la elimina de manera efectiva de la consideración psicoanalítica.. En mi opinión, la separación fatídica de Hartmann del concepto de ego de sí mismo de sí mismo y del yo de la autorrepuesta creó un problema en el desarrollo histórico de la teoría psicoanalítica; separó artificialmente los aspectos estructurales, experienciales y descriptivos del ego Funciones Esta separación no complicada innecesariamente conceptualizando las relaciones entre las funciones de ego" impersonales ", la subjetividad y la estructura del carácter. Por ejemplo, el esfuerzo de Jacobson (1964) para desarrollar una metapsicología de los aspectos experienciales de la El yo se hizo más difícil por lo que sintió que era necesario diferenciar, a cada paso, los Ego funcionan de las funciones de sí mismo, la inversión afectiva de las autorrepectativas y las representaciones de objetos de la activación difusa de los efectos. Por lo tanto, propongo eliminar de una mayor consideración, con el propósito de esta discusión, el uso del concepto de ser en lugar de objetar. Tal concepto de sí mismo

conduce a descripciones "psicosociales" o interferentes y para confundir a los conceptos sociológicos psicoanalíticos, una confusión encontrada, por ejemplo, en algunos de los escritos de Erikson. El reemplazo de lo topográfico por el modelo estructural del aparato psíquico llevó a Freud para examinar las raíces del ego en la identificación como precipitado de la identificación, y para continuar con la idea de que el ego se depende del aparato de la percepción y conciencia. El ego se convirtió en un aparato de regulación y adaptación a la realidad simultáneamente con su desempeño de funciones defensivas y compromiso de las soluciones para conclusiones entre la identificación, el sumino y la realidad externa. La perspectiva estructural de Freud aparentemente le hizo reducir su énfasis en las funciones de la autoconciencia y la autocensión, en la regulación de la autoestima dentro del Ego; O tal vez fue llevado temporalmente a comprender algunas de estas funciones en su mayoría en términos de conflictos intersistémicos. Sin embargo, Freud también mantuvo una ambigüedad en su concepto de los 229.

230 Personalidades narcisistas Orígenes del ego, y no es una coincidencia que las relaciones de las relaciones objetaran, así como la psicología del ego contemporáneo, tengan su origen en su formulación de la estructura del ego. Su declaración citada en "El ego y la identificación" (1923, p. 29) sigue siendo pertinente: cuando sucede que una persona tiene que renunciar a un objeto sexual, a menudo se produce una alteración de su ego que solo se puede describir como una creación del objeto dentro El ego, como ocurre en la melancolía; La naturaleza exacta de la sustitución es aún desconocida para nosotros. Puede ser que por esta introyección, que es un tipo de regresión al mecanismo de la fase oral, el EGO facilita que el objeto se dé por vencido o haga que el proceso sea posible. Puede ser que esta identificación sea la única condición bajo la cual la ID puede renunciar a sus objetos. En cualquier caso, el proceso, especialmente en las fases tempranas del desarrollo, es una muy frecuente, y hace posible que suponga que el carácter del ego es un precipitado de objetos-catálexes abandonados y que contiene la historia de esas opciones de objetos. Esto se encuentra en consonancia con el papel de Freud (1914) "en el narcisismo" y con su comprensión del superyó como también derivado de la internalización de los objetos parentales. Jacobson rescató el "yo" al elaborar el concepto de autorreponerse. Y justo cuando encontró este concepto indispensable para investigar trastornos psicóticos, por lo que lo he encontrado indispensable para comprender la patología neurótica, límite y narcisista, así como el desarrollo normal. En la medida en que el yo como persona es una entidad psicosocial, de comportamiento e interrentable, sugiero que se reemplaza "a sí mismo" con "carácter". El carácter reúna varias configuraciones de estructura de ego normal o anormal que se extiende en patrones de comportamiento repetitivo. Es cierto que las defensas de los personajes incluyen la expresión simbólica de las representaciones de sí mismo y de objetos, y, por lo tanto, tienen una calidad de autorreposición, pero creo

que los términos de defensa de caracteres, la formación de caracteres y la estructura de caracteres son más precisos y clínicamente más útiles que la del yo cuando se refieren a la persona. En su lugar, propongo, para reservar el término auto por la suma total de las autorrepectativas en la conexión íntima con la suma total de representaciones de objetos. En otras palabras, propongo que definir el yo como una estructura intrapsy, que se origina en el ego y está claramente incrustada en el ego. Para conceptualizar el Ser de esta manera es permanecer cerca de la insistencia implícita de Freud, que el yo y el ego están indisolublemente vinculados. La inversión libidinal del yo, así definida está relacionada con la inversión libidinal de las representaciones de otros significativos, y la inversión libidinal de la propia persona de uno corresponde a la inversión libidinal de otros (objetos externos). Todas estas inversiones están relacionadas y refuercen entre sí.

El yo, el ego, afecta y impulsan los problemas de desarrollo, me parece que la teoría estructural, particularmente laaborada por Jacobson (1964) y Mahler (1979), contiene un concepto de desarrollo rico y sofisticado del yo, un Elaboración de los duales aspectos de la ICH de Freud. Hay dos aspectos de las formulaciones de Freud (1923) sobre el origen del ego que se han elaborado y se integran gradualmente con las formulaciones psicoanalíticas contemporáneas con respecto al desarrollo más temprano. La primera es su idea de que el ego se diferencia de la identificación, o una matriz original de ID de ego indiferenciada, por su cristalización en torno a la percepción del sistema. El segundo es su sugerencia de que el ego es un precipitado que resulta de la internalización de las representaciones de objetos invertidos instintamente. Que la percepción y la conciencia del infante deben activarse particularmente cuando él o ella está interactuando en la madre y que evolucionan las inversiones instintivas de ella debe dejar las huellas en el campo de conciencia de la época temprana, son declaraciones suficientemente amplias para cubrir muy contrastantes Enfoques psicoanalíticos. Sin embargo, las diferencias entre los enfoques psicoanalíticos competidores, sin embargo, en una serie de cuestiones que nos llevan directamente a la cuestión del origen del yo (como lo he redefinido). Primero, ¿podemos concebir que un bebé tiene la capacidad de diferenciarse de la madre desde el principio de la vida? Melanie Klein (1946) y su seguidor Segal (1979), así como Fairbairn (1954) del Grupo Medio Británico, aparecen claramente para pensar que, mientras que Jacobson, Mahler y yo, y también Winnicott (1958, 1965) pregunta esta idea y asuma una etapa inicialmente indiferenciada. Si se asume un estado inicialmente indiferenciado de diversa duración variable, ¿contiene una representación de autosexual omnipotente "puramente narcisista", o contiene representaciones de sí mismas indiferenciadas? Esta pregunta aparentemente abstracta es crucial, en mi opinión, para formular una metapsicología contemporánea de

narcisismo. Jacobson (1964) propuso restringir el término narcisismo primario a la etapa indiferenciada del desarrollo, que vio como una de las catas de accionamiento no diferenciadas del "yo psicofisiológico primario", marcado solo por los estados de aumento y disminución. Tensiones. Al mismo tiempo, consideró el auto psicofisiológico un concepto puramente descriptivo, no relacionado con las consideraciones metapsicológicas. Jacobson vio el origen del ego que vinculaba íntimamente a las imágenes de auto fusionadas originalmente y las imágenes de objetos, a lo que estoy llamando la representación de auto / objeto ori-ginally indiferenciada en ella. Ella vio esta impresión a la que invirtió con qué, después de la terminología de Freud, llamó "narcisismo secundario". Ella aquí le dio lo que creo que es la respuesta contable-psicológica contemporánea prevalente a esta pregunta: que el primer incinco-

232 Personalidades narcisistas Tual, particularmente libidinales, la inversión es para una representación de sí mismo / objeto indiferenciado. Más tarde, la diferenciación gradual de las representaciones de sí mismo y objetos resultará en una inversión diferenciada de libido (y agresión) también. Como se construyen las representaciones de autos representaciones y representaciones de objetos diferenciadas, por lo que es la inversión libidinal en la representación de sí mismo y en la representación del objeto. Con la diferenciación de sí mismo y objeto, la inversión del objeto externo se experimenta como una continuación de la inversión de su versión anterior, indiferenciada. Las representaciones de objetos y los objetos externos ahora se invierten simultáneamente y se refuerzan mutuamente. Esta vista, que contrasta con los supuestos psicoanalíticos anteriores sobre el estado prolongado del aislamiento psicológico del bebé del ambiente humano, se apoya por la observación real del bebé y las reacciones discriminatorias impresionantemente tempranas a los estímulos ambientales que reflejan los objetivos. Interacción con él. La formulación de Jacobson resuelve, en mi opinión, la cuestión del origen de la inversión instintiva de sí mismo y los objetos, la cuestión de si el nar-cissismo representa la inversión de objetos o si ocurren simultáneamente. Su formulación también vincula la formación de estructuras dentro del Ego a la creación de representaciones internalizadas de sí mismo y objeto como prioridad organizando subestructuras. Crea la base para una descripción de las vicisitudes de las representaciones de sí mismo y de objetos, múltiples, contradicionales, no integradas al principio, consolidándose gradualmente en conceptos de auto y objetos integrados. Las formulaciones de Jacobson contribuyen con un fondo teórico contra el cual para ver la investigación de Mahler (1979) sobre la psicosis autista y simbiótica de la infancia y en las etapas de la separación normal y anormal, la individualización. Mahler proporciona datos de observación directa y psicoanalíticos que

permiten que uno rastree las etapas del desarrollo, Jacobson postulados. Sin embargo, Jacobson presionó la etapa del "narcisismo primario" a una fase más sensa de la descarga difusa en el "yo psocopofiscotiótico" deja oscurecer el tema del origen y el desarrollo de las unidades y su relación con Inversión instintiva de las representaciones de sí mismo y objetos. La formulación de los inversiones de Jacobson de auto y objetos asume que las unidades libidinales y agresivas difieren en la naturaleza. Otra pregunta sobre el desarrollo del ego y el yo se relaciona con la pregunta: ¿El auto se origina solo de los estados felices de la fusión con la madre y sus representaciones de auto / objeto no diferenciadas por la madre, o se origina en la integración de tales estados con los estados de fusión de uno mismo y objeto ¿Las representaciones se desempeñan el impacto de las experiencias dolorosas, aterradoras, frustrantes o incluso catastróficas? Esta pregunta es crucial porque evolucionan los esquemas de desarrollo completamente diferentes de acuerdo con la forma en que uno lo responde.

Self, el ego, afecta y conduce a 233, probablemente todos los psicoanalistas que han tratado con esta pregunta estarían de acuerdo en que los estados gratificantes y felices constituyen el núcleo de la autoservicio o la auto-experiencia del ego. Algunos irían tan lejos como para considerar la construcción de un concepto integrado del yo sobre la base de las experiencias de fusión tempranas como lo que constituyen el Ser final, integrado, normal. En tal visión, el Ser Normal reflejaría el derivado de tono apropiado de la representación de auto / objeto fusionada originalmente feliz. Según este punto de vista, las experiencias frustrantes y la agresión, estos disparadores no serían parte del yo original, pero serían parte de la experiencia "no yo", una amenaza externa para el yo, no se vinculó intrinaticamente con ella. Aunque Kohut en realidad no formuló un modelo integral del primer desarrollo, su teoría (1971, 1972, 1977) podría adaptarse a esta línea de pensamiento. A un nivel metapsicológico, este pensamiento permite omitir la agresión de la teoría del ego y el desarrollo propio. El concepto alternativo es que el desarrollo propio también ocurre en momentos de mayor frustración y experiencias dolorosas o traumáticas. Tales ex perdencias determinan la construcción de representaciones de auto / objeto fusionadas bajo las auspicios de frustración y dolor. Estas representaciones mentales se invierten con agresión. Más tarde evolucionarán en experiencias aterradoras, agresivas y devaluadas del yo y en representaciones aterradoras, agresivas y sádicas de los objetos. Eventualmente conducen a la existencia de los múltiples representaciones contradictorias y objetos que son tan desafiantes para el desarrollo del niño durante la separación, la individuación de separación. Estas representaciones mentales explican la fijación patológica en la subfase de acercamiento del desarrollo (Mahler, 1971), cuando se diferencian las autorrepectativas y representaciones contradictorias de los objetos significativos resultan en el síndrome de la difusión de identidad. En contraste, la integración normal de las representaciones

contradictorias de sí mismo y objetos marca la transición de la separación-individualización "hacia la constancia de objetos". Este concepto de desarrollo personal bajo afecciones libidinales y agresivas es común a Jacobson, Mahler y yo, y también a Fairbairn y Klein; El modelo de desarrollo de Winnicott deja la impresión de cierta ambigüedad en este sentido. Porque en el pensamiento kleiniano, el problema de la diferenciación de sí mismo y de objetos no se ha expresado (con la excepción de un examen parcial en un documento por Bick [1968]), la correlación de Jacobson, Mahler's y mis puntos de vista con Kleinian Los esquemas de desarrollo no se pueden lograr realmente. El supuesto de Fairbairn (1954) de un ego integrado "prístino" desde el nacimiento aumenta otros problemas con respecto a los horarios de desarrollo. El concepto de origen de las autorrepectativas y la autoexistencia bajo el impacto de los estados invertidos agresivos y libbidos de

234 Personalidades narcisistas La fusión conduce a un concepto de auto como producto de la eventual integración de tales autopresentaciones contradictorias y de la integración correspondiente de los derivados de inversiones de accionamiento libidinales y agresivas también. De hecho, el modelo que estoy proponiendo concebir el yo, al igual que los derivados de accionamiento libidinales y agresivos integrados en el contexto de la integración de sus autoridades componentes. Este modelo resuelve la cuestión desconcertante de cómo se correlacionan la formación de la estructura psíquica, el desarrollo propio y el desarrollo instintivo. También sugiere una explicación para el concepto de neutralización de las unidades (Hartmann, 1955). El yo, entonces, es una estructura del ego que se origina en las representaciones de autoprocesas primero construida en la fase simbiótica indiferenciada en el contexto de las interacciones de la madre-bebé bajo la influencia de experiencias tanto gratificantes como frustrantes. Simultáneamente, la conciencia de la percepción del sistema evoluciona también en funciones más amplias del Ego: el control de control sobre la percepción, la motilidad voluntaria, la creación de trazas de memoria afectivas y el sistema preconsciente. El yo como una estructura psíquica se origina tanto de las autorrepresentaciones emergentes de libidez como agresivamente. Es, en resumen, una función de ego y estructura que evoluciona gradualmente a partir de la integración de sus representaciones de componentes en una estructura supraordinada que incorpora otras funciones del ego, como la memoria y las estructuras cognitivas, y los conductores a las características duales implicadas en Ich de Freud. Fuerzas motivacionales: las unidades, afecta y las relaciones de objetos, creo que no es una coincidencia que las controversias en el psicoanálisis sobre el concepto del yo estén tan estrechamente relacionadas con las controversias sobre la teoría del instinto, especialmente sobre la naturaleza y el papel de la agresión en el desarrollo temprano. Análogo a la reacción a los descubrimientos de

Freud que abarca la sexualidad infantil que imputó al psicoanálisis una preocupación mórbida y exagerada por la sexualidad, la teoría del instinto de doble instinto de Freud ha seguido desperdiciando fuertes reacciones culturales contra el concepto de agresión como Un instinto básico. Los psicoanalistes "ortodoxos" generalmente se encuentran en una perspectiva distinta, severa y agresiva de la vida, así como en las dificultades de los pacientes. El modelo de desarrollo (1971, 1977) de Kohut (1971, 1977), enfatizando la naturaleza central del Ser cohesivo (la fuerza motivacional de la que no se explica y solo está implícita como una unidad maturable autogeneradora), es sino una de muchas psicológicas y Las teorías psicoanitarias culturistas que rechazan explícitamente o implícitamente la teoría del instinto, en particular la agresión y la base biológica del desarrollo humano. Tal vez un incumplimiento de reexaminar la teoría del instinto, particularmente la relación entre los efectos y las unidades, a la luz de los nuevos datos neuropsicológicos y de observación-desarrollo, ha contribuido a la incertidumbre

Self, el ego, afecta y impulsa la mancha con respecto a las fuerzas motivacionales del primer desarrollo. Que esto es más que un problema puramente teórico, que es directamente relevante para la cuestión del origen y el desarrollo del yo y, por lo tanto, del narcisismo, debe ser evidente de lo que he dicho en la sección anterior sobre el desarrollo de los primeros representaciones de uno mismo y objetos en el contexto del infante / madre. Interacción. Lo que sigue es un esfuerzo para integrar los hallazgos de los estudios neuropsicológicos contemporáneos de afectos e investigaciones sobre el desarrollo infantil con una formulación revisada de la teoría del instinto dual. El comportamiento afectivo influye firmemente en las relaciones de objetos desde el nacimiento en (Izard, 1978; Izard y Buechler, 1979). Una función biológica central de los patrones afectivos innatos, con sus manifestaciones conductuales, comunicativas y psicofisiológicas, es indicar las necesidades de los infantes para el medio ambiente (la persona de la maternidad) y, por lo tanto, iniciar la comunicación entre el bebé y la madre, que marca el comienzo de Vida intrapsíquica (Emde et al., 1978). Las investigaciones recientes nos han sorprendido con la descripción de un alto grado de diferenciación en las comunicaciones infantiles / madre, presente desde muy temprano (Hoffman, 1978). La teorización neuro-psicológica ahora asume el almacenamiento de la memoria afectiva en la corteza límbica, que, como los experimentos de estimulación cerebral directa, lo indiquen, permite la reactivación de los aspectos cognitivos y afectivos de la experiencia pasada, en particular la Colorante subjetivo y afectivo de esa experiencia (Arnold, 1970). Los efectos, operando como el sistema motivacional más antiguo, están, por lo tanto, íntimamente vinculados con la fijación por la MEMORIA de un mundo internalizado de las relaciones de objetos (Kernberg, 1976). Si asumimos que las estructuras de memoria afectiva que reflejan relaciones placenteras de bebés y madre, en las que las representaciones de sí mismas y objetos aún no son

indiferenciadas, se acumulan por separado de las estructuras de memoria afectivas desagradables en las que las representaciones de sí mismo y objetos también son indiferenciadas, parece Lógico para elevar las siguientes preguntas: ¿La activación determinada biológicamente afecta a un reflejo de la activación de las unidades libidinales y agresivas (o aún indiferenciadas), o se afecta a sí mismas, en lugar de impulsar las fuerzas murimventacionales esenciales? O estas estructuras afectivas en lugar de servir para vincular a ser el havior con el registro intrapsíquico de las interacciones del bebé con su madre para que el sistema motivacional principal consiste en relaciones de objetos internalizados en lugar de afecto o impulsos. Sugiero que los efectos son el sistema motivacional principal, en el sentido de que están en el centro de cada uno de los primeros años de gratificación y frustrantes eventos concretos, los bebés experimentan con su entorno. Afecta a un enlace una serie de representaciones de sí mismas indiferenciadas, de modo que gradualmente un mundo complejo de las relaciones de objetos internalizadas, algunos de los demás teñidos, otros desagradables, se están construyendo. Pero incluso mientras que los efectos están vinculando las relaciones de objetos internalizados en 235

236 Personalidades narcisistas Dos series paralelas de experiencias gratificantes y frustrantes, "buenas" y "malas" se están transformando las relaciones de objetos internalizados. El afecto predominante del amor u odio de las dos series de relaciones de objetos internalmente se enriquece, modulado y cada vez más complejo. Eventualmente, la relación interna del bebé a la madre, desempeña el signo de "amor" es más que la suma de un número finito de los estados de afecto de amor con cree. Lo mismo ocurre con el odio. El amor y el odio se convierten así en estructuras intrapsíquicas estables, en continuidad genética a través de varias etapas de desarrollo; Por esa misma continuidad, se consoliden en la libido y la agresión. La libido y la agresión, a su vez, se convierten en sistemas motivacionales de supraordinado jerárquico que se expresan en una multitud de diferenciaciones diferenciadas a las disposiciones en diferentes circunstancias. Afecta, en resumen, son los bloques de construcción, o constituyentes, de unidades; Los afectos eventualmente adquieren una función de señal para la activación de las unidades. Al mismo tiempo, las respuestas afecativas tempranas no diferenciadas no diferenciadas evolucionan en afecta diferenciadas con componentes subjecientes divergentes, implicaciones cognitivas y características de comportamiento. Varios autores han clasificado afecta fenomenológicamente (Plutchik, 1980). La naturaleza cambiante de las respuestas afectivas al mismo objeto externo y sus representaciones internas no lo hace por sí mismo, lo que permite establecer la continuidad en el desarrollo del conflicto intrapsíquico inconsciente mediante afectos "primarios". Sin embargo, la libido y la agresión, se manifiestan clínicamente en un espectro de disposiciones afectadas y afectan a los estados. Por lo tanto, podemos rastrear clemente la amplia gama de estados afectados y sus correspondientes relaciones de objetos a la agresión, la libido, o en las etapas posteriores de los desarrollos, condensaciones de estos dos unidades.

. .

Además, la relación con un objeto cambia bajo la influencia de la activación biológica de los nuevos estados afectados, que surgen a lo largo del desarrollo y causan la calidad de los impulsos para cambiar. Por ejemplo, los esfuerzos libidinales preeedipal para el cambio de madre bajo el impacto de los estados afectados sexualmente togados que surgen durante la etapa de edificación. Estos afectos se organizan a los impulsos genitales que operan en continuidad con las lides libidinales anteriores. Pero la calidad subterránea y las implicaciones motivacionales son diferentes. De manera similar, la agresión dirigida hacia el mismo objeto libidinal, también se manifestó en varios estados afectivos agresivos de los componentes, trasciende a cada uno de estos afectos agresivos concretos y, especialmente después de la condensación y la integración de los impulsos agresivos y libidinales, ocurre o contribuye a una nueva complejidad de las relaciones de objetos y un nuevo conjunto de estados de afecto integrados o más complejos e integrados (como tristeza, ternura, culpa o anhelo). ¿Deberíamos mantener el término unidad para estos jerárquicamente supra-

¿Self, ego, afecta y conduce 237 sistemas motivacionales de agresión y libido de 237? Lamentablemente, esta discusión se confunde por el resultado de traducir al inglés de Freud TRIEB e INMSTYTT. Freud prefería Trieb, mejor traducido como "Drive", precisamente porque concibió a las unidades como sistemas motivacionales psíquicos relativamente continuos en la frontera entre lo físico y lo mental, en contraste con los instintos, que vio como se discontinuó, Disposiciones de comportamiento rígidas, innatas. Desafortunadamente, la edición estándar traduce a Trieb en su mayoría, si no es consistente, como "instinto". A la luz del concepto prevalente contemporáneo de instintos en biología (Tinbergen, 1951; Lorenz, 1963; Wilson, 1975), el término componentes instintivos para perceptivos innatas, conductuales, comunicativos, Los patrones experienciales psicofisiológicos, y experienciales subjetivos, es decir, afecta, parece apropiado, en contraste con el uso del término impulsos para la libido y la agresión de los sistemas motivacionales. El concepto de los impulsos psicológicos de Freud en contraste con los instintos biológicos aquí se adapta a los desarrollos biológicos contemporáneos (Kernberg, 1976). Habiendo explicado cómo veo la relación entre las unidades y los efectos, me apresuré a agregar que las unidades se manifiestan simplemente, sino por la activación de una relación de objeto específica, que incluye un efecto y en el que la unidad está representada por un deseo o deseo específico. La fantasía inconsciente, la naturaleza edificada más importante, incluye un deseo específico dirigido hacia un objeto. El deseo se deriva del impulso y es más preciso que el estado del afecto, una razón adicional para rechazar un concepto que haría afecto en lugar de impulsar el sistema motivacional jerárquicamente suprendente. De la misma manera, si las unidades se manifiestan clínicamente por deseos concretos hacia los objetos, y si las unidades se originan en las experiencias cargadas de afecto con el siguiente objeto, ¿no se puede conceptualizar el sistema motivacional principal como las

relaciones de objetos internalizados? ¿Es la búsqueda de un objeto el sistema motivacional principal? Fairbairn pensó claramente así, y, a la luz del rechazo de las unidades de Kohut (1977) a los sistemas motivacionales para los niveles de desarrollo preeedipal, parece que también lo pensó. Tengo varias razones para no estar de acuerdo. Primero, la organización de la realidad intrapsíquica en términos de amor y odio es más importante para nuestra comprensión de la continuidad en el desarrollo intra-psíquico, el conflicto inconsciente y las relaciones de objetos que se tratan que en el hecho de que estos estados contradictorios se dirigen originalmente hacia el mismo objeto-madre, o que, en la fase de edificación, un objeto masculino y un objeto son los destinatarios de las necesidades y esfuerzos dominantes del niño. La relación entre la libido y la agresión, y entre las luchas premonteras y genitales, proporciona poder explicativo para las relaciones contra la contra las mismas objetos. En segundo lugar, la naturaleza misma de los esfuerzos agresivos da como resultado una lucha contra la consolidación de las relaciones de objetos e incluye como un importante

238 Personalidades narcisistas plantean la eliminación del objeto frustrante, peligroso o competidor. En este sentido, es típico de las teorías de las relaciones de objetos que ponen las relaciones de objetos como el sistema motivacional principal para descuidar la importancia de la agresión y, por lo tanto, del conflicto intrapsíquico inconsciente. Tercero, el cambio fundamental en la calidad de la libido bajo el impacto de los desarrollos edípicos mencionados anteriormente, en otras palabras, la importancia central de la sexualidad genital infantil, también se subtiene generalmente en las teorías que consideran la relación con el objeto como jerarquista. Igalmente supraordinado a las unidades. Volviendo a la cuestión de las fuerzas motivacionales que determinan la orina del ego y el yo, creo que mi reformulación propuesta de la teoría de doble instinto resuelve la cuestión con respecto a la maduración y el desarrollo de la libido y la agresión, dejó abierta por Jacobson. También proporciona un modelo psicoanalítico para el primer desarrollo que hace justicia a la función crucial de los afectos en la activación de las primeras interactiones infantiles / madre. Además, explica la relación de afecto a la internalización y desarrollo de representaciones de sí mismo y objetos. Creo que esta opinión es acorde con las formulaciones de Spitz (1965, 1972) con respecto a los organizadores del desarrollo de Ego temprano y también con los hallazgos de Mahler. Finalmente, proporciona un puente entre la teoría de Freud del ego como evolucionando desde la conciencia de la percepción del sistema, por un lado, por un lado, y del precipitado de las relaciones de objetos, por el otro, sin tener que asumir un grado de diferenciación temprana inconmensure con nuestro presente. Conocimiento del desarrollo infantil.

Parte Cuatro: Regresiones severas: Diagnóstico y tratamiento.

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

El capítulo es: estancamientos en el tratamiento, muchos pacientes límite no cambian significativamente a lo largo de años de tratamiento a pesar de los esfuerzos de los terapeutas calificados de varias orientaciones. Be- Causa de mi interés particular en estos pacientes, he tenido la oportunidad de actuar como consultor en el tratamiento de muchos de estos casos. Lo que sigue son algunas consideraciones generales con respecto a los temas con frecuencia involucrados en el hecho de que el paciente no cambie y algunas sugerencias para la gestión de estancamientos terapéuticos. Las reacciones terapéuticas negativas son una causa importante de estancamiento. Sin embargo, creo que es preferible discutir estos temas en términos de la falta de cambios significativos y restringir el significado de la reacción terapéutica negativa al empeoramiento de la condición del paciente, particularmente como se redujo en la transferencia, en momentos en que está consciente o inconscientemente Percibiendo al terapeuta como un buen objeto que está intentando brindarle ayuda significativa. Las reacciones terapéuticas negativas derivan de (i) un sentido inconsciente de la culpa (como en las estructuras de carácter masoquista); (2) la necesidad de destruir lo que se recibe del terapeuta porque la envidia inconsciente de él (típica en personalidades narcisistas); y (3) la necesidad de destruir al terapeuta como un buen objeto debido a la identificación inconsciente del paciente con un objeto primitivo y sádico que requiere sumisión y sufrimiento como una condición mínima para mantener cualquier relación de objeto significativo (como en algunos límites y muchos pacientes esquizofrénicos que Confunde el amor y el sadismo [Kernberg, 1975]). Mis hallazgos parecen consonantes con los de los demás (Olinick, 1964; Rosenfeld, 1971, 1975; Valenstein, 1973; ASCH, 1976) que, desde diferentes puntos de vista clínicos y teóricos, subrayan la importancia de Los conflictos preeedipales, la agresión severa y los problemas estructurales que involucran a representaciones tempranas de sí mismo y objetos (en lugar de los

conflictos de superego / ego posteriores) en una reacción terapéutica negativa. Estas dinámicas son altamente relevantes para los 241.

242 Regresiones severas de la emisión de por qué muchos pacientes fronterizos que aparentemente se seleccionaron apropiadamente para el tratamiento psicoterapéutico, y en los que uno explica un cambio significativo: no se ha cambiado significativamente. La persistencia del comportamiento patológico y la falta de respuesta a la psicoterapia intensiva a menudo reflejan reacciones terapéuticas negativas subyacentes que pueden infiltrarse en toda la situación de tratamiento durante meses e incluso años. El estancamiento terapéutico puede manifestarse desde el comienzo del tratamiento o puede hacer su aparición después de años de terapia han producido un cambio significativo. A pesar de que el terapeuta es naturalmente más optimista cuando se desarrolla un estancamiento terapéutico después de años de tratamiento que ya ha logrado un cambio significativo, tales estalamientos tardíos a menudo son tan intensos como para hacer que el terapeuta dude su estimación de cambios previos. El deterioro en la transferencia y en la vida entera del paciente puede ser tan grave que parece que todo el cambio anterior parece haberse anulado. Las características que se encuentran con más frecuencia tanto en los casos en que no se produce ningún cambio desde el inicio del tratamiento y en aquellos que desarrollan esta complicación después de muchos meses o años, primero, primero, se modifican la grandiosidad en las estructuras narcisistas graves. Estos pacientes pueden deshumanizar la situación del tratamiento. Incluso los pacientes narcisistas que parecen estar funcionando a un nivel de noborderina pueden negar completamente cualquier realidad emocional en la transferencia. Otras personalidades narcisistas pueden tener que negar retrospectivamente la ayuda que han recibido del analista, experimentando toda la mejora debido a sus propios fortalezas, a menudo "a pesar de" el analista, y finalizar el tratamiento con una devaluación tertera del analista mientras Todavía llevando su mejora "auto-originada" en un inconsciente "robo" del trabajo o creatividad del analista.

La actuación masoquista grave relacionada con la presentación y la identificación de triunfantes con una formación de superego sáfese implacable, también característica de los estancamientos, ya que es una identificación aún más primitiva con un objeto "loco" sádico que proporciona amor solo en el Contexto de sufrimiento y odio. Cualquier relación satisfactoria es, por lo tanto, equivalente a matar, y ser asesinado por la imagen parental necesaria y, por lo tanto, perderla. Para triunfar sobre todos aquellos que no sufren de un destino humano tan horrible, es la única protección contra un sentido del desastre psíquico total. La necesidad de neutralizar o derrotar los esfuerzos del terapeuta puede evolucionar en un ciclo vicioso. A medida que el terapeuta persiste en ayudar al paciente frente a la falta de respuesta obvia o incluso empeorando la condición del paciente, la envidia y el resentimiento del paciente del compromiso y la dedicación del terapeuta pueden reforzar su culpa por maltratar el THEREPIST (OMS, en contraste con las otras experiencias del paciente, no se replica al odio con el odio) y, por lo tanto, su necesidad de escapar de la culpa.

Los estancamientos en el tratamiento se pueden sentir a los pacientes severamente retrocedidos, pueden sentirse aliviados cuando el terapeuta pierde la paciencia y los "contraataques". Y aunque el paciente puede racionalizar su alivio por la idea de que el terapeuta es "humano después de todo /" en un nivel más profundo, generalmente hay un aumento en las defensas contra los sentimientos de culpa; El paciente actúa sádicamente su triunfo sobre el terapeuta, con el peligro de Reconfirmar los ciclos de interacciones patológicos en los que se ha involucrado con otros significativos en el pasado. A veces, en condiciones de estancamiento terapéutico crónico, uno puede observar la aparición aparentemente extraña de alguna mejora en el funcionamiento del paciente fuera de las sesiones. O el El paciente puede aparecer cada vez más dispuesto a continuar con una situación terapéutica imposible sin cesar. En algún momento es, como si el tratamiento hubiera reemplazado la vida y el paciente estuviera expresando en su comportamiento un comando urgente deseo y mágico de que el tratamiento continúe para siempre (por lo tanto, sin ningún cambio), esa realidad se deje a un lado en un Colusión inconsciente entre el terapeuta y el paciente. El terapeuta puede sentirse intuitivamente que el paciente experimentará cualquier desafío para este equilibrio estable como un acto increíble de crueldad, como si el terapeuta lo arrojara a los leones. En medio de un estancamiento de este tipo, los pacientes pueden juzgar con bastante directamente que el terapeuta los compense por su sufrimiento pasado al dedicar su vida totalmente a ellos. Pero, independientemente de la medida en que el terapeuta salga de su camino para acomodar los deseos del paciente, eventualmente, los siguientes temas tienden a ser prominentes: primero, el paciente puede destruir el tiempo en el sentido de perder su perpectivo a tiempo; Es decir, se enfoca en cada sesión como si el tiempo se detuviera entre las sesiones y, como si ambos pacientes y terapeutas vieran, y el tratamiento continuara, para siempre. En segundo lugar, esta

destrucción del tiempo puede ir acompañada de ignorar y rechazar específicamente la evidencia de la preocupación y la dedicación del terapeuta. Es como si la sospecheza del paciente y la destrucción destructiva de la destrucción del terapeuta estuvieran orientados a destruir el amor con la crueldad, mientras proyecta esta crueldad hacia el terapeuta. Las acusaciones implacables que implican que el terapeuta no ama lo suficientemente al paciente es la más frecuente, pero no las manifestaciones más severas de esta tendencia. En ocasiones, en ocasiones, cuando el terapeuta puede, de hecho, estar agotado de manera tan interna que se retira temporalmente de los intentos activos de trabajar con el paciente, las acusaciones del paciente a menudo disminuyen, y una misteriosa colusión inconsciente fomentando parálisis y vacío. En la situación psicoterapéutica puede durar. En tercer lugar, el paciente puede intentar convencer al terapeuta que la comprensión psicológica y la empatía no tienen lugar en este lugar. Si este esfuerzo tiene éxito, el terapeuta puede pensar que debe pensar que debería reemplazar su comprensión concreta de la dinámica de la transferencia por formulaciones más generales de arrestos de ego, falta de capacidad para

244 Regresiones severas Entendimiento emocional, déficits cognitivos y similares. Por supuesto, existen pacientes con tales límites en su funcionamiento del ego, por ejemplo, una incapacidad para la comunicación simbólica como parte de la función cerebral mínima. Sin embargo, lo que es sorprendente en estos casos es que un estudio inicial cuidadoso o revisión de los casos en consideración revela que, en contraste con aquellos con una disfunción cerebral mínima, no revelan tales déficits, y que a menudo, por el contrario, temprano en el tratamiento, muchos de los paces. Los pacientes habían dado cierta evidencia de una capacidad de comprensión psicológica. A veces, incluso los terapeutas muy experimentados pueden tener que pedir ayuda en los puntos cuando la comprensión humana ordinaria ya no parece funcionar, solo para encontrar de la observación de otros que el paciente ha dado evidencia de mucha más comprensión de lo que ha estado sucediendo de lo que ha revelado al terapeuta. (Este fenómeno se ha producido con una frecuencia dramática en el trabajo de consulta con tales casos). En resumen, algo muy activo en el paciente intenta destruir el tiempo, el amor y la preocupación y la comprensión cognitiva. Creo que el terapeuta está aquí frente a la activación de los niveles más profundos de la agresión. A veces es desesperado resolver estos sevas estancados de tratamiento; Sin embargo, a veces es posible hacerlo con un enfoque esencialmente analítico. Para este fin, ciertas tácticas terapéuticas y actitudes se vuelven cruciales. La impaciencia en el "aquí y ahora" en primer lugar, en lugar de renunciar a una actitud pasiva de "esperar y ver" en cada hora, mientras que en realidad se está volviendo cada vez más desanimado a medida que pasa el tiempo, es útil para que el terapeuta supere la paciencia, usualmente Mantiene durante un período prolongado de tiempo con impaciencia, un resumen para aceptar pasivamente la destrucción del trabajo psicoterapéutico concreto en cada sesión. El terapeuta debe contrarrestar activamente la actuación de la agresión severa. Esta "actividad" no

significa que haya abundado la posición de neutralidad técnica. Hay momentos en que el terapeuta puede sentirse agotado, incapaz de pensar o decir nada. Cuando el tratamiento permanece en un estancamiento, el termio a veces puede sentir que no solo no se está realizando nada en la sesión, sino que no tiene nada nuevo que ofrecer. Él es, por así decirlo, completamente paralizado en términos de cualquier pensamiento, sentimiento o intervención que pueda influir en la situación. Para que el terapeuta sea forzado en un sentido tan subjetivo, refleja la destrucción o la negación de la importancia de la interacción actual. Tal situación solo puede evocar ansiedad en el terapeuta. El terapeuta puede sentir que necesita un nuevo comienzo, pero no sepa dónde comenzar; Se siente responsable de las tareas sin cumplir y un

STALEMATES EN EL TRATAMIENTO 245 SENTIDO DE LA CULTURACIÓN POR PERMITAR AL PACIENTE CONTINUAR EN UNA SITUACIÓN QUE ES LAS QUE EL TERAPETOR PUEDE MIRSE, NO ES ASITIO. Tales sentimientos también activarán cualquier potencial de contratransferencia. El terapeuta puede beneficiarse al explorar esto completamente dentro de sí mismo, utilizando malos momentos en el tratamiento del paciente por aprender más sobre sí mismo. Si y cuando el terapeuta puede asegurarse de que su intervención se determinará no por sus propias necesidades de contratransferencia, sino por las necesidades reales del paciente, entonces, confrontar a la paciente activamente con el hecho de que no está sucediendo nada y que tanto paciente como de thera-pistan tengan la tarea urgente de explorando por qué esto es así. De hecho, esta puede ser la tarea principal para ambos participantes. Si el paciente reacciona con ira y sospecha de estos esfuerzos para examinar y resolver un estancamiento terapéutico, su distorsión de lo que está haciendo el terapeuta debe interpretarse. Un paciente en análisis inmediatamente se quedó dormido cada vez que el Ana-listería se centró en la transferencia; Nunca se quedó dormido en otras ocasiones. El paciente extendió gradualmente este comportamiento a todas las situaciones cuando el ANA -STA hizo comentarios que el paciente sospechara que estaban indirectamente relacionados con un esfuerzo por centrarse en la transferencia, incluidos todos los comentarios relacionados con la caída del paciente, a su caída dormido cuando el analista com-Mentido sobre el peligro de que se duerme, y así sucesivamente. Retrospectivamente, esto puede parecer un caso extremo, casi divertido de represión, pero mientras que estaba sucediendo, reflejaba el esfuerzo inconsciente del paciente para derrotar al analista, a quien percibió como una imagen de padre sádico. El analista se centró en concentrarse cada vez más en la extraordinaria tranquilidad del paciente y la falta de preocupación ante este desarrollo, que había provocado un estancamiento terapéutico

que dura meses. En el proceso, el enfoque de la integración se amplió hasta que la vida entera del paciente parecía centrarse en su tendencia a quedarse dormida durante las horas analíticas. El análisis sistemático de este comportamiento finalmente reveló su función como una actuación de la transferencia negativa que se deriva primero, de la rebelión contra el padre edípico, y más tarde, desde conflictos con la madre preeedipal. Apenas necesita subrayarse que el terapeuta debe intervenir solo cuando no está bajo la balanceo de afectos hostiles negativos hacia el paciente. Dicha agresión hacia el paciente puede ser una reacción "normal", pero generalmente se condensa con cualquier potencial de reacciones agresivas de contraversa existe en el terapeuta. El Thera-Pist debe contener esta reacción y usarlo para la comprensión. El paciente puede alarmarse de lo que percibe como la agresiva actitud de la agresividad del terapeuta y la interpretación de los temores del paciente de que el terapeuta está a punto de detener el tratamiento como represalia contra los esfuerzos inconscientes del paciente para socavar que puede ser un im-
portant step in clarifying the nature of this transference situation. Mi punto es que es mejor que el terapeuta se arriesgue a convertirse en un "toro

246 regañaciones severas en una tienda de China "que permanecer paralizadas, se encogieron en colusión pasiva con la destrucción del tiempo del paciente. Como mínimo, un apénico activo reconfirma para el paciente la preocupación del terapeuta, su intolerancia determinada de imposible. Situaciones, y su confianza en la posibilidad de un cambio. Particularmente con los pacientes que han estado en el tratamiento durante muchos años, el terapeuta puede encontrarlo cada vez más difícil enfrentar su creciente conciencia de la falta de cambio. La acumulación de culpa por la fuga lo toleró el estancamiento sobre una Período prolongado, realista o poco realista, como puede ser, es un impedimento más para cambiar, se deriva del terapeuta. Centrarse en los objetivos de tiempo y tratamiento El terapeuta necesita recordar al paciente de la falta de progreso en el tratamiento, para que se enfoque una y otra vez. Los objetivos de tratamiento general establecidos al inicio del tratamiento y el aspecto aparente del paciente de estos, mientras que asume una actitud que el tratamiento debe y podría continuar para siempre. A este respecto, el terapeuta debe enfatizar las diferencias entre los objetivos de tratamiento realistas y los objetivos de la vida del paciente, como lo señaló Ticho (1972). Por ejemplo, una mujer de 45 años que había divorciada a su esposo como la última recreación de una larga serie de relaciones sadomasóquistas con hombres (todos los cuales concluyeron en su frustrado y designado por su abandono de ella) desarrollaron un prolongado Rage Re-Action al terapeuta porque no respondió a sus avances amorosos hacia él. La interpretación cuidadosa y bastante plena de los significados de este patrón durante un período prolongado de tiempo no había llevado a su propia solución. Cuando el terapeuta finalmente se dio cuenta de que el paciente había mantenido la fantasía secreta de casarse con él como parte de su decisión inicial de ingresar al tratamiento, la enfrentó con esta información. Frente a esta confusión poco realista de sus objetivos de vida y sus objetivos de tratamiento, el paciente terminó

enojado el tratamiento y se negó a continuar o iniciar el tratamiento con otra persona. El tema de los objetivos de tratamiento debería haberse explorado desde el comienzo de su tratamiento. Centrarse en la destrucción de la realidad externa El enfoque en los objetivos amplios del tratamiento debe complementarse con un fuerte enfoque en la realidad inmediata del paciente. Por lo general, en estancamiento extremo, prolongado, el paciente también descuida las circunstancias de su realidad inmediata y revela un sentido casi consciente de triunfo en derrotar sus propios esfuerzos, un triunfo sobre el terapeuta, cuya imposición se reconfirma cada Día como se desarrollan situaciones imposibles y se corte la distidad. Es esencial que el terapeuta interprete lo incon.

Stalmates in Tratamiento 247 Scioscas (ya veces conscientes) de rabia hacia él expresadas en la ruleta rusa del paciente en su vida diaria. El paciente tendrá que asumir la responsabilidad de su situación de vida inmediata, así como por sus planes de largo alcance. Esta es una responsabilidad que creo que esperamos de cualquier paciente que se someta a la psicopoterapia psicoanalítica de manera ambulatoria, y constituye la realidad de la realidad contra la cual se puede evaluar e interpretar la transferencia que actúa la transferencia. En estancamiento extremo, actuar puede tomar la forma de quemar todos los puentes en la vida externa actual y en el futuro, con la expectativa implícita de que el terapeuta asumirá la plena responsabilidad; Esto debe ser interpretado constantemente. Todo esto apunta a la necesidad crucial de una evaluación inicial cuidadosa de las indicaciones y contraindicaciones para el psicoanálisis o la psicoterapia psicoanalítica intensiva de los pacientes con límite (y otros). Ilustra lo que he sugerido anteriormente (cap. 6) son los tres problemas que codeteran las prioridades para el trabajo interpretativo en cada sesión con los pacientes con bordesal: el patrón de transferencia predominante en cualquier momento en particular, la situación de vida inmediata del paciente y los objetivos generales de la Tratamiento. Interpretaciones del amor y la preocupación disociada El terapeuta también puede ser útil en las condiciones descritas por interprensión sostenible de la división entre las actitudes enojadas, exigentes y contraproducentes de los pacientes en la transferencia y sus períodos de comportamiento tranquilo, amigable, relajado y preocupado. Hacia el terapeuta. Existe la necesidad de traer tales islas de Ego de observación potencialmente, particularmente de la preocupación por sí mismo permanente, junto con el área principal de la personalidad, donde la agresión se domina y no se puede verificar. Aunque esta táctica puede parecer obvia en la teoría, en la práctica, uno no puede subestimar el alivio que un terapeuta puede experimentar de al menos unos pocos momentos tranquilos, relajados, "buenos"

en sus interacciones con un paciente cuyo tratamiento se está convirtiendo en una pesadilla para él. El terapeuta puede tener la tentación de colirarse con mecanismos de división en el paciente como una forma de preservar sus propios buenos sentimientos sobre el paciente frente a su agresión generalmente implacable. El terapeuta debe hacer un esfuerzo deliberado para tener en cuenta que el paciente ha dado evidencia de una capacidad para trabajar en sus problemas (de lo contrario, no estaría en el tipo de tratamiento en el que se encuentra), y el terapeuta también debe recordar los aspectos "buenos" del paciente. Es esta confianza en el potencial del paciente, una confianza básica en su capacidad de aprender, lo que permite al terapeuta que lo confronte activamente sin colusizar en las islas defensivas de amabilidad y sin ahogarse en sentimientos culpables derivados de las acusaciones del paciente de que la El terapeuta lo está atacando.

248 Regresiones severas En otras palabras, la confianza en lo que el paciente podría convertirse es la base de la fuerza a partir de la cual se puede llevar a cabo la confrontación para que esté libre de implicaciones punitivas. Paradójicamente, el terapeuta que puede mantener este tipo de confianza en el potencial del paciente sin negar el aspecto defensivo de la "amabilidad" de la "amabilidad" de la candidatura de la agresión que abarca todo será más libre y más efectiva para enfrentar la transferencia negativa que la Terapeuta que intenta mantener una imagen de las "buenas cualidades" del paciente disociadas de los aspectos desagradables o aterradores de su comportamiento. Un corolario de esta actitud es esperar nada en términos de cambio inmediato, de corto alcance en las sesiones, para mantener una actitud constante de desafío en cuestión de hora a hora, mientras que espera que cualquier cambio tardará mucho en tiempo. El paciente puede estar dispuesto a "mejorar" para el bien del terapeuta, tentando así al terapeuta que se alimente de sus esfuerzos para reemplazar la vida con la situación del tratamiento. El terapeuta también tiene que interpretar este aspecto. A largo plazo, la combinación de la impaciencia sublimada en cada sesión, una atención interrogada y preocupada, una expectativa de ningún cambio inmediato y, sin embargo, la confianza que abarca las perspectivas de cambio a largo plazo puede proporcionar un efecto muy fuerte y de apoyo para el tratamiento. La alternativa a esta actitud optimista es una presentación tranquila y casi masológica al control omnipotente del paciente en las sesiones, un esfuerzo por mantener una imagen del paciente como una "persona agradable", el desarrollo gradual de la compasión para el paciente (una manifestación frecuente. De la contraaggresión de la Therpist), y la tendencia a renunciar repentinamente en algún momento en lo que podría llamarse un rabieto de temperamento silencioso. Una decisión realista de terminar el tratamiento debe ser el resultado de un proceso continuo en el que el paciente y el terapeuta

comparten la creciente convicción de que no mucho más se puede lograr en una situación de tratamiento determinada. Ganancia secundaria de tratamiento en condiciones de estancamiento crónico Puede ayudar al terapeuta a reevaluar si el paciente tiene algo mejor que es mejor esperar que su situación actual y su situación de tratamiento. A veces, el paciente en estancamiento terapéutico crónico o la reacción terapéutica negativa se las arregla para contaminar la mente del terapeuta con la creciente convicción de que el paciente no puede esperar algo mejor de la vida de lo que tiene en este momento, que el paciente realmente no sería capaz de tener una fábrica más satisfactoria. Vida si estaba funcionando por su cuenta. Este problema se vuelve particularmente importante con los pacientes de mediana edad y mayores, con quienes no se puede mantener la ilusión de que si todo lo demás falla, los jóvenes tienen sus propias promesas para el futuro. Por supuesto, es importante evaluar al comienzo del tratamiento, ya sea el pa-

Los estancamientos en el tratamiento se cumplen 249. Si y cuando se cumplan sus objetivos de tratamiento, tendrá algo mejor que esperar que su situación actual. Si el terapeuta está convencido, por ejemplo, que la vida del paciente ha pasado, que la cantidad de destrucción que el paciente ha incurrido en términos de la posibilidad de amor, vida familiar, trabajo o creatividad, y fuentes de gratificación en general es tal que no haya Mucho que esperar, entonces quizás no haya ninguna razón para someter al paciente a la psicoterapia psicoanítica intensiva. Es cierto que a veces un cambio en la actitud interna del paciente hacia la vida puede ser lo que está dirigido, pero esto debería ser un objetivo de tratamiento compartido claramente, compartido. Como una ilustración: un paciente llegó al tratamiento porque su esposa lo había abandonado por otro hombre. Su objetivo de tratamiento inicial era ser saludable psicológicamente para que pudiera recuperar a su esposa. Solo después de cierta discusión sobre el tratamiento y los objetivos de la vida, fue capaz de realizar plenamente que el tratamiento psicológico no solo no garantizaría que su esposa recuperara, pero ni siquiera le aseguraría la posibilidad de formar otra relación satisfactoria con una mujer; Lo máximo que podría esperar fue un cambio en aquellos actitudes internas que interfirieron con el potencial de una buena relación. La posibilidad disminuida de encontrar una pareja satisfactoria satisfactoria y particularmente un socio marides a medida que la vida sigue siendo parte de la discusión de los objetivos de tratamiento y vida. Estas condiciones previas permiten a la Thera-Pist, durante los períodos de extenso estancamiento, reconfirmar internamente su confianza en que el paciente tiene potencialmente algo mejor que esperar. La tolerancia del terapeuta para la agresión, debe tenerse en cuenta que los pacientes con límites están luchando contra un pasado aterrador y son incapaces de proyectar en el futuro cualquier concepción de una vida mejor de lo que han tenido. Por lo tanto, la convicción del terapeuta de que el paciente puede vivir una vida mejor y que la

pérdida, la enfermedad grave y el fracaso pueden ser tolerados y trabajados, si no están completamente surcados, se vuelve muy importante. La creencia del terapeuta de que es posible que "comience de nuevo" puede convertirse en un instrumento poderoso en la interpretación y trabajar a través de la transferencia. Los objetivos de tratamiento realistas incluyen la aceptación, no solo de las deficiencias no resueltas sino de la inevitibilidad de la agresión en la vida ordinaria. Es esencial que el terapeuta llegue a un acuerdo con y tolere la agresión tanto en sí mismo como en otros. La tolerancia del terapeuta de su propia agresión y la de las personas que ama, pueden facilitarle la intruición de la agresión del paciente. Para enfrentar la existencia de la agresión directa y mantener una actitud realista sobre las limitaciones de la relación terapéutica, está en contradicción a tal anti avión a

250 ACESIONES SEVERAS TIC ACTITUDES TIC Como frialdad obsesiva, retiro narcisista, "unidad mesiánica" con el paciente, y sobre todo, una negación ingenua y pollyannaña de la ambivalencia de todas las relaciones humanas. La capacidad del terapeuta para aceptar verdades sobre sí mismo y su propia vida puede permitirle expresar su comportamiento en su comportamiento la convicción de que el paciente también podrá aceptar verdades sobre él y su vida. La honestidad no comprometida en enfrentar a las perspectivas más turbulentas y dolorosas de la vida puede convertirse en parte de intervenciones muy concretas con pacientes que tienen estancados a largo plazo en el tratamiento. La confianza del terapeuta de que el paciente puede tolerar y aceptar la verdad sobre sí mismo expresa confianza en sus recursos potenciales. Por ejemplo, la salida de los terapeutas de sus propias fantasías sobre las necesidades de los pacientes mayores para el sexo, la compañía y la eficacia social puede ayudarlo a reducir el uso defensivo del paciente de la vejez como dispositivo para hacer que el Thera-Pist se sienta culpable o como racionalización para Renuncia autodestructiva. La función de tenencia del terapeuta en estancamiento terapéutico crónico, el terapeuta realiza una función de "tenencia". He observado períodos en el psicoanálisis o la psicoterapia psicoanítica de los pacientes límite donde, como sugiere Winnicott (19603), se produce una regresión silenciosa a lo que equivale a una forma primitiva de dependencia del analista, experimentada como una "tenencia madre". En esos momentos, la presencia intuitiva y empática de la comprensión empática del analista puede ser preferible a los efectos perturbadores e intrusivamente experimentados de las interpretaciones verbales. Tales períodos de tranquilidad e intianza, en los que el "verdadero yo" del paciente puede surgir más allá de su "falso yo" (sus esfuerzos artificiales, pseudoadaptivos), difiere dramáticamente de la situación en los estados crónicos de estancamiento donde el sentimiento del paciente no es Ser entendido o amado por el

terapeuta y de la intrunidad del terapeuta es un producto de la negación defensiva del paciente de sus propias necesidades y esfuerzos destructivos. Es cierto que durante los períodos crónicos de actuación fuera de la destructividad en la transferencia, el silencioso y sentado que restante del terapeuta puede aliviar temporalmente la ansiedad y la rabia del paciente. Pero este alivio a menudo resulta reflejar la satisfacción fantaseada del paciente de su agresión, por ejemplo, su fantasía de que sus ataques envidiosos han destruido los procesos creativos del terapeuta, en particular la capacidad de pensamiento creativo en particular. Por lo tanto, la tolerancia aparente del terapeuta para el paciente, ya que puede a un nivel más profundo, alimente la experiencia del paciente del terapeuta como ceder a sus demandas y destrucción. Esta situación es radicalmente diferente de los momentos de preocupación silenciosa y empatado por parte del terapeuta que se cumplen con el conciencia del paciente.

Estalmados en el tratamiento 251 ness de estas características del terapeuta. Sin embargo, hay otra función de "tenencia" ejercida por el terapeuta en momentos del estancamiento crónico de Thera-Peutic: a saber, que proporcionó su confianza en curso que el paciente puede cambiar, su preocupación por el paso del tiempo, y su inconvenencia para situaciones crónicas imposibles.. Creo que una actitud esencialmente analítica, reflejada en una posición de o movimiento en curso hacia la neutralidad técnica, proporciona el fondo óptimo para un enfoque interpretativo para los pacientes con límites. Dicha "tenencia", "Madres", o funciones "emocionalmente correctivas", ya que están implícitas en este contexto (Winnicott, 19603; Modell, 1976) tienen un valor terapéutico importante, pero por razones que son más complejas que una simple recreación o Compensación de la recreación de una relación de madre-hijo (infantil) normal. La propuesta de Mahler (1971) que la patología límite está relacionada específicamente a la subfase de acercamiento del proceso de separación, me parece coincidir con mi propuesta de que el problema con los pacientes con límites no es la falta de diferenciación del yo de la fiebre Pero la falta de integración de la "buena" y la "mala" representaciones de sí mismo y de objetos. El principal problema con estos pacientes es su incapacidad para lograr una relación amorosa satisfactoria con un objeto que se puede confiar y confiar en la fatiga de su agresión hacia ella, a pesar de su conciencia de las deficiencias y frustraciones derivadas de ese objeto, y en el contexto de Tolerando la culpa dolorosa, la preocupación y el gratitud hacia ese objeto querido. Para que el paciente acepte la cercanía y se entienda y confíe en el terapeuta, requiere la aceptación de su propia agresión y confía en que no destruirá al terapeuta o su amor por el terapeuta. Para que el terapeuta pueda "mantener" el paciente significa aceptar la realidad de la agresión del paciente sin estar demasiado cubriéndose, confiando en el potencial del paciente para amar a pesar de sus dificultades actuales para expresar el

amor, y creer en la posibilidad de que la vida tiene la vida. Algo para ofrecer al paciente a pesar de sus limitaciones. Por ejemplo, las tendencias hipocondríacas severas de un paciente dijenadas cuando podía experimentar una capacidad para expresar amor y preocupación por su esposa e hijos. Sentir que ahora era capaz de darle posible que acepte la posibilidad de su enfermedad y muerte futuras. Anteriormente, había percibido inconscientemente la muerte como la condena final, como se tragaba por su propia "naturaleza malvada" en un mundo vacío y desprovisto del amor. Otro paciente, una mujer con una personalidad narcisista cuya vida centrada en mantener una semejanza de juventud y disfrazarse cuidadosamente todas las manifestaciones del proceso de envejecimiento, podría aceptar "dejar ir" en el sentido de mirar su edad y aceptar el proceso de envejecimiento cuando su miedo sobre ella. Envidia terrible de

252 Regresiones severas Los jóvenes disminuyeron y cuándo, a pesar de esta envidia, ella pudo investigar el interés en los jóvenes que la rodeaban en su vida diaria y trabajaban. Para que el paciente pueda aceptar que se "celebró", para confiar en otra persona, también significa aceptar la posibilidad de "dejar ir", con el conocimiento de que todas las relaciones son limitadas e inciertas. El requisito esencial para aceptar esta posibilidad es un tono de los temores sobre la propia agresión. El logro de esta capacidad en el tratamiento se refleja en el hecho de ser capaz de aceptar la cercanía al Thera-Pist incluso con las limitaciones de tiempo de las horas de tratamiento y para aceptar que el terapeuta tiene una vida propia más allá del paciente y las sesiones con él. Hice subrayado que no es suficiente que el terapeuta esté emocionalmente disponible, cálido y simpático y para tolerar la agresión sin responder de las formas contragrantes; En todo momento, debe mantener una claridad intelectual, expresada de buenas razones por las que hace o no realiza ciertas intervenciones. También debe mantener una conciencia de los límites realistas de la efectividad de sus intervenciones. El tratamiento de los pacientes con límites suele ser un proceso lento, incierto y repetitivo de exploración de significados, confrontación, pruebas de hipótesis interpretativas y trabajando a través de patrones de caracteres autodestructivos en lugar de experiencias de descubrimiento repentino o conciencia catártica.. Los primeros, generalmente débiles signos de cambio en cualquier patrón de carácter rígido (como la grandiosidad maligna, el narcisismo autodestratado, crónicamente triunfante, el masoquismo, la denegación total de la realidad emocional, o el engañoso autoperpetuante de los trucos antisociales. La explotación) puede ser tan breve y transitoria de que cualquier esperanza originalmente provocada por los cambios tan tempranos se corrige pronto. El logro del cambio en la constelación predominante de las relaciones de objetos internalizados es un proceso largo y lento. Esta es una razón más por la que la impaciencia con el

estancamiento en cada sesión debe estar acompañado de gran paciencia por la ausencia de cambio (mientras que permanezca consciente de esta ausencia) durante un largo período de tiempo. Las manifestaciones de crecimiento en la capacidad de amor, preocupación y gratitud son generalmente complejas, turbias y poco claras al principio; En contraste, el odio a menudo tiene una calidad de dibujo de límites aclarantes, precisos y límites. Mientras que el paciente, en el proceso de experimentar el odio del terapeuta, puede ser preciso, claro, emocionado o incluso elificado, la preocupación del terapeuta por su paciente en ese momento puede tener un efecto confuso e incluso un tanto desorganizado en su propio pensamiento. Y, sin embargo, esta confusión y turbulencia son la materia prima para la creciente comprensión del terapeuta del paciente. Las primeras etapas de la "humanización" del paciente pueden tomar la forma de caos, depresión y sufrimiento. No hay una manera fácil en el largo camino hacia la comprensión.

STALEMATES EN TRATAMIENTO 253 La expectativa de que nuestro creciente conocimiento acortará el tratamiento psicológico de la patología de caracteres graves y los trastornos límite pueden representar una ilusión más sobre el proceso, la técnica y el resultado de la psicoterapia. Pero la posibilidad de diagnosticar los principales patrones de transferencia que refleja los conflictos predominantes en el área de las relaciones de objetos de pacientes límite después de un período limitado de tratamiento parece una consecuencia realista de nuestro creciente conocimiento sobre estos pacientes. Dicho diagnóstico temprano debería permitirnos definir más concretamente, después de un período inicial de psicoterapia, lo que se pueden esperar cambios significativos en estos patrones y sus respectivas secuencias: aquí puede ser un área para la investigación sobre el proceso y el resultado de la psicoterapia intensiva.

Capítulo 16: Diagnóstico y gestión clínica de pacientes con un diagnóstico de suicidio para evaluar el potencial de suicidio durante un estudio diagnóstico inicial es obviamente más difícil que cuando el terapeuta está familiarizado con el paciente. La evaluación del riesgo suicida en pacientes que se ven por primera vez en una evaluación de diagnóstico debe incluir la consideración de la severidad clínica de la preadolescencia, los trastornos afectivos superiores a la realización de la personalidad límite, y la autopruimiento crónica y el suicidio como una "forma de vida". La severidad clínica de la depresión Este enfoque de diagnóstico incluye tanto la intensidad de la ideación suicida como de los planes para la acción, así como en la medida en que la depresión afecta a ser de comportamiento, estado de ánimo y ideación. La gravedad de la depresión puede medirse por el grado en que se desacelere el comportamiento, la ideación se desacelera (y la concentración, por lo tanto, afectada), y la tristeza se vuelve a colocar con un estado de ánimo vacío y congelado con un sentido subjetivo de despersonalización. Además, la presencia o ausencia de síntomas biológicos de depresión (reflejada en los patrones de alimentación, el peso, los patrones de sueño, las funciones digestivas, el ritmo diario del afecto depresivo, los patrones menstruales, el deseo sexual, el tono muscular) suministran información crucial sobre el Gravedad de la depresión. En general, la severo la depresión clínica que acompaña a la ideación e intención suicida, la ACUTER el peligro. En pacientes con episodios depresivos importantes que no sufren de organización de personalidad de línea fronteriza, el riesgo de suicidio está particularmente marcado durante la etapa de recuperación de la depresión paralizada; En los pacientes límite, por el contrario, su impulsividad crónica propaga el riesgo de suicidio sobre todo el episodio depresivo. El peligro es especialmente urgente en pacientes que exhiben las tres series de indicadores (ideación suicida y 254

Gestión de pacientes con un potencial suicida 255 intención, retraso depresivo de funciones psíquicas y características biológicas de la depresión) simultáneamente. En contraste, hasta qué punto el comportamiento histriónico está presente, la exhibición dramática de efecto en las personalidades infantiles, es menos relevante para la evaluación de la severidad de la depresión y el riesgo de suicidio. Puede haber un peligro agudo de suicidio en pacientes cuyo comportamiento dramático supera al terapeuta para desestimar la gravedad de la depresión o cuya alegría momentánea y la labilidad general de afecto transmiten la falsa impresión de que la depresión no es grave. Lo que me ha impresionado en la evaluación del suicidio potencial de los pacientes con borregales es la inutilidad de las racionalizaciones conscientes de los pacientes, como la expresión de "necesidades de dependencia", de "desesperanza" de manera consciente experimentada, "la pérdida de la capacidad de" confianza, "De sui- cida como" grito de ayuda ", y las otras racionalizaciones de su depresión que estos pacientes a menudo expresan en la entrevista inicial. En la práctica clínica, la pregunta no es si un paciente tiene una sensación general de "desesperanza", sino a qué, concretamente, no tiene esperanza: ¿Realiza el amor de un objeto con experiencia ambivalentemente experimentada? ¿Poder controlar un objeto o para llevar a cabo un acto de venganza? De manera similar, el problema no es si puede "confiar" al terapeuta, no hay razón para esperar que un paciente confíe en cualquiera que apenas sepa, pero si está dispuesto a comunicarse honestamente sobre sí mismo, independientemente de cómo se sienta sobre el terapeuta. Una característica común de todas estas cuestiones es la necesidad de evaluar la ganancia secundaria de comportamiento suicida, lo que conduce a la evaluación del suicidio como una "forma de vida". El mal uso de los conceptos psicoanalíticos en la construcción de hídricos dinámicos para evaluar el potencial de suicidio puede ser un factor clave para no diagnosticar adecuadamente y tratar los

pacientes con límites fronterizos severamente suicidas. Los factores psodinámicos son de hecho importantes, pero deben evaluarse sobre la base de las relaciones de objeto actualmente promulgadas con el terapeuta en lugar de ser evaluadas sobre la base de las fantasias conscientemente ex presionadas por el paciente. El trastorno afectivo mayor superpuesto a la organización de la personalidad límite, los pacientes con enfermedades maníacas-depresivas de Bona Fide pueden presentar una organización de personalidad de línea fronteriza como los antecedentes caracteres estables contra los cuales se desarrollan los episodios afectivos cíclicos. El diagnóstico y la gestión clínica son más complicados con estos pacientes que con el tipo de pacientes maníbicos más frecuentemente encontrados con una organización de personalidad neurótica o normal. En mi experiencia, muchos pacientes con organización de personalidad límite responden menos satisfactoriamente que sus contrapartes normales o neuróticas a un tratamiento psicofarmacológico para una enfermedad afectiva importante y la distinción entre

256 Regresiones severas Los episodios psicóticos y períodos latentes de la enfermedad afectiva son menos claros. El peligro es excelente, en tales circunstancias, que el médico subestimará la gravedad de las intenciones suicidas, especialmente si la historia del paciente sugiere que tales intenciones han sido crónicas y más integradas con su estructura de personalidad básica que en realidad el caso. Un potencial suicidio agudo y grave puede ser subestimado si el paciente tiene una larga historia de alteraciones severas de personalidad con depresiones de reorganización sin intención suicida. Cuando la presentación de sintomatología afectativa es hipomanínea en lugar de depresiva, existe un peligro aún mayor de faltar el potencial de suicidio vinculado a un cambio repentino en una fase depresiva. La autoinstilación crónica y el suicidio como "forma de vida" El diagnóstico DSM-III del trastorno de la personalidad límite de la DSM-III enfatiza las tendencias cronablemente suicidas y autolestantes como características importantes de estos pacientes. Clínicamente, se encuentra estas tendencias en pacientes con personalidad fantiles, la personalidad narcisista que funciona en un nivel de extracción manantial, "como si", personalidades, y otros pacientes con organización de personalidad limítrofe cuya característica principal es Pseudologia fantastica. Finalmente, algunos pacientes atípicos, crónicos psicóticos pueden imitar este tipo de paciente límite. Para fines prácticos, es útil evaluar a todos estos pacientes de manera descriptiva y psicodinámica (es decir, en términos de las funciones de las operaciones defensivas y las relaciones de objetos primitivos que dominan en la transferencia). Dicha evaluación combinada permite la distinción de varios subgrupos. (i) Una constelación frecuente es la presencia de comportamiento crónico de autocinda en pacientes con personalidad predominantemente infantil y organización de personalidad límite, el tipo que corresponde muy estrechamente al diagnóstico descriptivo del trastorno de la personalidad límite en DSM-III. Clínicamente,

el comportamiento de autoprotusión y / o los gestos de suicidio emergen a veces de ataques intensos de rabia o rabia mezclados con brillos temporales de depresión. Una exploración adicional con frecuencia muestra que estos gestos están diseñados para establecer o restablecer el control sobre el medio ambiente al evocar sentimientos de culpa en otros, cuando, por ejemplo, una relación con una pareja sexual se rompe o cuando los padres optimizan fuertemente al paciente. Deseos. En otras ocasiones, el comportamiento suicida o de autopruimiento puede ser una expresión de culpabilidad inconsciente sobre el éxito o sobre la profundización de una relación psicoterapéutica: este último es un tipo relativamente benigno de reacción terapéutica negativa. Los pacientes con antecedentes de reacción terapéutica negativa que tienen características infantiles que se combinan con características depresivas y masoquistas están particularmente en riesgo de intentos de suicidio.

Gestión de pacientes con un potencial suicida 257 (2) Un tipo de comportamiento crónico de autoprotusión crónico, con frecuencia vinculado con tendencias suicidas, es una expresión de lo que estoy llamando el narcisismo maligno (ver capítulo 19). Este fenómeno se encuentra en pacientes con organización de personalidad límite y una estructura de personalidad predominantemente narcisista que funciona en un nivel de límite abiertas, es decir, con una falta general de control de impulsos, tolerancia a la ansiedad y canalización sublimatoria. Estos pacientes tienen estilos de vida tan caóticos como la de la personalidad infantil, con los que están confundidos con frecuencia. Sin embargo, en contraste con la intensa dependencia y el comportamiento de aferramiento de las personalidades infantiles (o, más en general, de los pacientes con límites sin narcisismo patológico), estos pacientes se distorsan básicamente de y no están involucrados con otros; Sus ataques de rabia y / o depresión ocurren cuando su grandiosidad patológica es desafinada y experimentan un sentido traumático de la humillación o la derrota. El narcisismo maligno se refiere a los pacientes que presentan una infiltración de la agresión en el serimoción patológico que caracteriza a la personalidad nargissística. En contraste con el tipo ordinario de personalidad narcisista, estos pacientes experimentan una mayor autoestima y confirmación de su grandiosidad cuando pueden expresar la agresión hacia sí mismos o hacia los demás. El placer en la crueldad, las perversiones sexuales sádicas, así como la autopruimiento agradables, son parte de esta imagen. El sentido que estos pacientes transmiten de ser capaz de dañar con calma o incluso matarse a sí mismos, en contraste con el miedo y la desesperación y los esfuerzos de "suplicar" de sus familiares y personal para mantenerlos vivos y mantener sus contactos humanos, ilustran una dramática distorsión de la gratificación de autoestima. La grandiosidad de los pacientes se cumple con su sentimiento de triunfo sobre el miedo al dolor y la muerte y, a un nivel no escaso,

por su sentido de estar en control sobre la muerte. Algunos pacientes con anorexia nerviosa pertenecen a este subtipo. Ambos tipos de pacientes que acaban de describir pueden además que, además, el abuso de drogas crónico, alcoholismo o ambos. En estas circunstancias, los riesgos de sui- cida aumentan y el pronóstico es incluso menos favorable, especialmente para los pacientes con narcisismo maligno. Si estos pacientes también presentan características órdiciales (típicamente, deshonestidad con respecto a su uso de medicamentos o al cohol), el riesgo de suicidio se mejora aún más. Los pacientes que simultáneamente muestran la impulsividad general, la deshonestidad, las tendencias autolicativas crónicas, el consumo de alcohol y / o el abuso de drogas, y una profunda aleación interpersonal o una indisponibilidad emocional pueden desarrollar un comportamiento suicida en cualquier momento; El riesgo no se puede evaluar con precisión en ningún punto específico. Este hecho tiene que ser aceptado como un peligro incorporado en cualquier esfuerzo de tratamiento. En mi experiencia, las dos causas más frecuentes del suicidio por los pacientes psiquiátricos hospitalizados son un control insuficiente sobre la vida del paciente.

258 Regresiones severas durante el tratamiento de pacientes con esta combinación desastrosa de síntomas y la descarga prematura de los pacientes deprimidos psicóticamente que están mejorando clínicamente. (3) Un tercer tipo de comportamiento suicida y autoprónico crónico está presente en ciertas condiciones atípicas, crónicas psicóticas que imitan las condiciones del límite. Los ejemplos son algunos pacientes esquizofrénicos crónicos (la verdaderamente "esquizofrenia pseudoneurótica") / algunos pacientes con enfermedades crónicas esquizoafectivas, y algunas con psicosis de parapoides crónicos que presentan una personalidad integrada mucho mejor. Estructura que es cierta en la mayoría de los casos de esquizofrenia paranoica. Estos pacientes a menudo no cumplen con los criterios para la enfermedad psicótica de manera puramente descriptiva. Solo un diagnóstico estructural (ver chaps, I y 2) revela la pérdida de las pruebas de realidad. Estos son pacientes con una organización de personalidad esencialmente psicótica cuyas depresiones intermitentes pueden adquirir características psicóticas con ideas depresivas sobrevaloradas o incluso delirantes. Cuando estos pacientes no están en un episodio depresivo, se retiran socialmente y están al margen en las interacciones terapéuticas. Con frecuencia revelan una historia de intentos extraños de suicidio marcados por grados inusuales de cruceros o características altamente idiosincrásicas (correspondientes a sus fans autistas sobre transformaciones corporales o psicológicas). También se puede incluir aquí aquellos pacientes que intentan suicidarse bajo el efecto de las delirios persecutorios o las demandas alucinantes. De hecho, he visto a varios pacientes que albergan delirios que están condenados a morir o que tienen órdenes de matarse a sí mismos. Estos delirios pueden extenderse a lo largo de los años dentro de un contexto de depresión, alejamiento esquizoide, o características de personalidad para nudo. Gestión clínica La primera área de preocupación es la gravedad de la depresión, que,

supervisada en una organización de personalidad límite, puede implicar un riesgo suicida agudo. En mi opinión, los pacientes con organización de personalidad límite y una enfermedad afectiva importante superpuesta que presentan la ideación suicida requieren hospitalización inmediata, tratamiento psicofarmacológico para el trastorno afectivo, y, si existe un historial de falta de respuesta al tratamiento psicofarmacológico. O un potencial de sui- cida extremadamente agudo, tratamiento electroconvulsivo. Los pacientes que presentan una historia de intentos de suicidio extraño, la organización de personalidad psicótica o un síndrome psicótico en la actualidad (ya sea esquizofrénico, esquizoafectivo, o paranoico) y la ideación suicida, lo que garantiza al menos el hospital de diagnóstico. Tratamiento intensivo del síndrome psicótico. Obviamente, si estos pacientes también presentan falta de honestidad en sus comunicaciones con el terapeuta, tienen que ser considerados riesgos de suicidio alto. En todos los casos, el tratamiento del síndrome psicótico tiene prioridad sobre el

Gestión de pacientes con suicidio potencial 259 Tratamiento del trastorno de personalidad subyacente. En la práctica, esto generalmente implica un tratamiento psicofarmacológico, al menos breve hospitalización, posiblemente tratamiento electroconvulsivo y un mapeo cuidadoso de la historia psiquiátrica previa del paciente en preparación para la evaluación del riesgo suicida a largo plazo una vez que la psicosis aguda ha sido resuelto. La combinación de impulsividad crónica en un paciente límite con el potencial agudo para un intento de suicidio en un episodio maníaco y / o depresivo de complicación requiere hospitalización, incluso si la historia pasada del paciente es bien conocida y, aparentemente, tranquilizante y ha logrado establecer un Relación psicoterapéutica con una psiquianas de evaluación. Quizás el período más peligroso del tratamiento de tales pacientes es cuando se están recuperando de una depresión psicótica aguda grave. Es más probable que se produzcan intentos de suicidio en esta etapa en cualquier caso, y, en estos casos, las intenciones suicidas están borrosas por la reaparición de la patología de carácter severo habitual del paciente. La descarga prematura de pacientes deprimidos debido a su mejora sintomática aparentemente dramática y su enfática negación de intenciones suicidas es un factor importante alentando el suicidio después de tal secreción. Esta práctica se ha vuelto más frecuente, dada la combinación de presiones financieras, burásicas e ideológicas para una descarga más rápida de pacientes de hospitales psiquiátricos. En pacientes con organización de personalidad límite que no presentan una enfermedad afectiva importante o cualquier otro síndrome psicótico y donde la intención de suicidio y el estado de ánimo depresivo no están acompañados por síntomas biológicos de depresión o la desaceleración del comportamiento, el contenido del pensamiento o el estado de ánimo, en otras palabras, donde La depresión en sí no parece ser clínicamente grave: se puede plantear la cuestión del tratamiento ambulatorio. Una variable crucial es la presencia de

características antisociales, en particular cualquier evidencia de deshonestidad en lo que dice el paciente sobre sí mismo. Si la historia pasada muestra la retención de información de otros psiquiatras o psicoterapeutas, especialmente la información con respecto a los intentos de suicidio, el alcoholismo o el abuso de drogas, es preferible asumir que la información del paciente no puede considerarse confiable en el presente, tampoco, para hospitalizarlo para un más Evaluación cuidadosa de su posible potencial y comportamiento suicida. Los pacientes que muestran falta de preocupación por sí mismos y una actitud indiferente, despectiva o insípida hacia el diagnóstico, mientras que la evidencia presentadora de comportamiento suicida, debe considerarse potencialmente deshonestos y, por lo tanto, en alto riesgo de suicidio. Enfrentando tactantemente al paciente con la discrepancia entre su comportamiento suicida y su aparente falta de preocupación por la que se puede aclarar hasta qué punto los mecanismos de división y la negación, ya que contra la manipulación y la deshonestidad conscientes, son responsables. La rabia de un paciente cuando se enfrenta con aspectos contradictorios de su comportamiento dará al diagnóstico.

260 retrocesiones severas alguna base para evaluar el potencial suicida; Un paciente que es evasivo y al margen no permite una evaluación en profundidad de su realidad psíquica. En todos los casos, el diagnóstico tiene que evaluar no solo las comunicaciones de los verbales del paciente, sino también su comportamiento total. Esta observación puede aparecer superflua si uno no observó tan con tanta frecuencia una tendencia peligrosa de diagnósticos para subestimar las muchas formas de agresión humana y la agresión contra el yo puede tomar. Los pacientes con características infantiles y masoquistas que no presentan la adicción a las drogas o el alcoholismo, cuya actitud depende y se aferran en lugar de al margen o se retira, y cuya comunicación honesta sobre ellos mismos se combina con la expresión de preocupación por encima de su enfermedad puede ser tratada tentativamente de manera externa si lo hacen Puede convencer al psiquiatra examinador de su compromiso de no actuar sobre sus impulsos suicidas o ponerse en contacto con él de inmediato si creen que no pueden controlar estos deseos para que se pueda iniciar la hospitalización. Sin embargo, con pacientes cuyas intenciones o comportamiento suicidas emergen en el curso de un tratamiento psicoterapéutico adecuado e intensivo y que dan evidencia del desarrollo de una reacción terapéutica negativa crónica, es imprudente confiar en cualquier contrato de este tipo. Es preferible iniciar a estos pacientes en una nueva relación psicoterapéutica con un terapeuta diferente en el hospital. Obviamente, si el historial pasado indica que el paciente ha podido responder positivamente al tratamiento psicoterapéutico, se fortalece la posibilidad de iniciar el tratamiento de manera ambulatoria. En todos los casos, si el diagnóstico está convencido, sobre la base de una evidencia sólida en la historia pasada del paciente, así como en su interacción actual, que el paciente se está comunicando con él honestamente, su estimación diaria con respecto al potencial suicidio del paciente es más preciso. Si se indica la hospitalización, pero el paciente se

niega a aceptarlo, la responsabilidad del psiquiatra incluye la movilización de todos los recursos sociales y de la gravedad para permitir el inicio del tratamiento en condiciones óptimas. Bajo ninguna circunstancia, el psiquiatra llevara a cabo el tratamiento en condiciones de que aumenten el peligro del suicidio. Aquí, la tendencia inconsciente a "jugar a Dios" es contraparte para ingenuitaria peligrosa al descuidar la gravedad de las tendencias destructivas en el paciente y su familia. Un factor precipitante frecuente del suicidio por casos de bordes en el tratamiento ambulatorio es, desafortunadamente, el acuerdo de psicoterización para tratar a tales pacientes en circunstancias menos que óptimas, por ejemplo, permitiéndoles rechazar ciertos aspectos del tratamiento (medicamentos, Atención diurna, participación familiar, etc.) o aceptando su incapacidad para asistir a las sesiones regularmente o comunicarse abiertamente. Discusión consistente y sencilla de la sui-

La gestión de los pacientes con un potencial suicida 261 CIDE potencial es un aspecto clave del tratamiento hospitalario de todos los pacientes con límites con estas características suicidas crónicas. Hice señalar anteriormente que la descarga prematura de pacientes con mayor enfermedad afectiva cuando su mejora clínica de la depresión maximiza su riesgo de sui-cida es un error clásico. Un error igualmente devastador y desafortunadamente frecuente es el esfuerzo de la parte del personal del hospital para involucrar a los pacientes de origen general en las interacciones agradables y gratificantes mientras ignoran o niegan la gravedad de sus comportamientos malignos, manipuladores y deshonestos. El peligro de reforzar los mecanismos de división al tratar todas estas señales de advertencia como episodios aislados y centrar la atención en los aspectos "positivos" de las interacciones de los pacientes no pueden ser subrayados. Confrontación constante de los patrones de comportamiento contradictorios del paciente, un enfoque constante en su falta de preocupación por sí mismo, sobre cómo socava las relaciones potencialmente útiles con los demás, en su incapacidad de colaborar con los esfuerzos de tratamiento, todos tienden a crear una tendencia inmediata, Turmago y expresión abierta de agresión en el campo inter-personal del paciente en el hospital. Sin embargo, de la misma manera, sin embargo, la capacidad del paciente para asumir la responsabilidad de sí mismo, por colaborar honestamente con los esfuerzos psicoterapéuticos, puede ser mejor diagnosticado bajo circunstancias de comunicaciones abiertas y directas, y enojadas, y los planes de postdiscarge realistas. Se puede desarrollar más fácilmente. En consecuencia, una atmósfera de amabilidad superficial y de la negación subyacente de las dificultades del paciente a menudo eventúa en un comportamiento autodestructivo, autosuficiente o suicida, una vez que el paciente haya abandonado el hospital. En muchos casos, la gravedad del potencial autodestructivo crónico del paciente no se

puede reducir significativamente incluso durante períodos prolongados de hospitalización. A veces, la aceptación de un riesgo crónico de suicidio es el precio del tratamiento ambulatorio, que uno espera desafiará al paciente un estilo de vida más productivo y con una relación psicoterapéutica en el contexto del mundo real, a diferencia del entorno hospitalario artificialmente protectivo. ¿Qué se puede hacer para reducir los riesgos de suicidio de los pacientes en tales circunstancias? En primer lugar, las ganancias secundarias de comportamiento suicida deben ser diagnósticas y controladas. Amenazas y comportamientos suicidas crónicos que reflejan las tendencias sádicas disociadas a la familia del paciente, lo que le permite dominar a la familia y combinar la ganancia primaria y secundaria de enfermedades, debe interpretarse y ponerse bajo control. El trabajo con la familia del paciente puede convertirse en una parte crucial del tratamiento. Es importante que los pacientes aprendan que sus amenazas de suicidio no tienen poder sobre el terapeuta. El terapeuta debe transmitir al paciente que se sentiría triste pero no responsable si el paciente se mató a sí mismo y que su vida no se vería significativamente afectada por un evento de este tipo. El terapeuta crea así.

262 Regresiones severas Una base saludable para una nueva relación de objeto, a diferencia de aquellos que el paciente ha tenido con su familia. En segundo lugar, el terapeuta debe decirle a la familia del paciente que el paciente se apta a suicidarse, lo que le indica que el paciente sufre de lo que podría describirse como un cáncer psicológico de donde podría morir en cualquier momento. El terapeuta debe decirle a todos aquellos que están dispuestos a que está dispuesto a participar en un esfuerzo psicoterapéutico para ayudar al paciente a superar esta enfermedad, pero no debe garantizar una firma de que tenga éxito o garantizará la protección del suicidio durante el largo período de tratamiento. Esta definición realista del tratamiento puede ser una forma más efectiva de proteger la relación psicoterapéutica de la participación de la participación destructiva de otros miembros de la familia y de los esfuerzos del paciente para controlar la terapia al inducir en el terapeuta una "contrarresta indirecta" (ritero, 1968), caracterizado por sentimientos de culpa y temores paranoicos con respecto a terceros. En tercer lugar, con pacientes que presentan un potencial suicida o autolicante crónicos, que se debe explorar el potencial de manera consistente y tejida en el análisis de todas las interacciones con el terapeuta. Es difícil hacer una justicia completa a esta recomendación técnica sin ofrecer material clínico detallado. Para fines prácticos, el trabajo con tal suicidio crónico se convierte en un aspecto esencial de la técnica psicoterapéutica, un elemento siempre presente en las interpretaciones del terapeuta del material. Cuarto, es importante que el terapeuta que trate a los pacientes límite con un potencial de suicidio crónico en un entorno ambulatorio no acepte acuerdos de tratamiento imposibles que requieren esfuerzos inusuales o medidas heroicas de su parte. A largo plazo, cada vez que se exige más del terapeuta de lo que sería razonable en el tratamiento psicoterapéutico promedio, el resultado final es un refuerzo del potencial autodestructivo del paciente. A veces, incluso los psicoterapeutas, así como el personal

del hospital, pueden desarrollar gradualmente el deseo inconsciente (e incluso consciente), lo que un paciente imposible "desaparecería", recreando así en la constancia de los deseos de muerte de la muerte del paciente, así como los deseos de la muerte de su familia hacia él. A este respecto, NaIVete con respecto al posibilidad de suicidio de un paciente no se combina con poca frecuencia con NaIVETE, lo que responde a la actitud de la familia hacia el paciente, específicamente, sus deseos de muerte hacia lo que consideran un miembro imposible de la familia. El personal del hospital a menudo se enfrenta a una familia que ha realizado intentos vigorosos de obtener la descarga de un paciente que es agudamente sui-cidal, a menudo bajo la promesa de transferir al paciente a otro entorno psicoterapéutico, solo para luego "inocentemente" darle al paciente el paciente el paciente. El tiempo y el lugar para matarse a sí mismo. La mejor manera de contrarrestar los deseos de muerte del paciente es llevarlos muy en serio y considerar la "astaminación" que aportan al entorno inmediato del paciente. Mientras te estresto en otro lugar (ver cap. 19), la aceptación del terapeuta de

Gestión de pacientes con potencial suicida 263 La posibilidad de fallar con un paciente es un elemento crucial en el tratamiento de los pacientes con narcisismo maligno y un posible potencial de suicidio. La fantasía inconsciente o consciente del paciente de que el terapeuta quiere desesperadamente al paciente que se mantenga vivo y que el paciente, por lo tanto, tiene poder sobre el terapeuta, así como la vida y la muerte, deben ser explorados y resueltos en el tratamiento. Cada suicidio intentado o completado implica la activación de la agresión interna, no solo dentro del paciente, sino dentro de su campo interpersonal inmediato. El psicoterapeuta que parece reaccionar solo con dolor y preocupación para el paciente suicida está negando su propia contraestión y juega en la dinámica del paciente. El terapeuta debe ser capaz de empatizar con las tentaciones suicidas del paciente, con su anhelo de paz, con su emoción de la agresión autodirigida, con su placer de vengarse contra otros significativos, con su deseo de escapar de la culpa, y con el emocionante sentido del poder. Involucrado en instancias suicidas. Solo ese tipo de empatía por parte del terapeuta puede permitir que el paciente explore estos problemas abiertamente en el tratamiento. Cualquier relación psicoterapéutica que se extiende durante muchos meses en condiciones poco realistas, sin comunicación honesta y responsabilidades claramente delimitadas y aceptadas por parte de ambos participantes, también puede estar jugando en el potencial suicida del paciente. Hay momentos en que un psicoterapeuta, reconociendo la imposibilidad de la situación del tratamiento, tiene que tener el coraje de terminarlo, incluso si el paciente usa la amenaza del suicidio para tratar de mantener vivo una relación sadomasoquista. Dicha terminación del tratamiento debe corresponder a no a un impulsivo que actúa de la contratransferencia, sino a un plan bien pensado que puede tener que incluir hospitalización temporal, mientras que el psicoterapeuta se disgina del tratamiento, un trabajo extenso con la familia y / o consulta extendida por el Psicoterapeuta con un

colega experimentado. La mejor manera de ayudar a algunos pacientes es que la Thera-Pist reconozca honestamente que puede que no pueda ayudarlos, que pueden ser ayudados mejor por un colega o que no se pueden ayudar en absoluto en esta etapa de nuestro conocimiento y los recursos terapéuticos.

CAPÍTULO I?: Contrarresta, regresión de la transferencia y la incapacidad de depender de las dimensiones de la contraataferencia La relación entre la contrarresta y la personalidad de la psicoanalista se puede considerar de acuerdo con al menos tres DI-Mensiones conceptuales. El primero es lo que llamaría una dimensión espacial, o "campo / 'y tiene que ver con lo que realmente se incluye en el término contrapesado. Pienso en este campo como una serie de círculos concéntricos, los internos que representan los estrechos conceptos de la contratransferencia, los exteriores Representando los conceptos más amplios. La dimensión temporal diferencia aguda a partir de reacciones de contraatansferencia" permanente "a largo plazo. Una tercera dimensión está representada por la gravedad de la enfermedad del paciente. La contrarresta de la contratransferencia" campo "de la contratransferencia se define estrechamente, Como prevalece dentro de la Psicolona del Ego, es la reacción inconsciente del analista al paciente (Poco, 1951; Reich, 1951). Uno puede restringir el término más a la reacción no consciente del analista a la transferencia del paciente (Kernberg, 1975). Este concepto está en línea con el significado original de la contratransferencia en la literatura psicolítica y permite adecuadamente los" puntos ciegos "en la parte inferior del material del paciente derivado de los conflictos neuróticos no resueltos del analista. Un segundo círculo más amplio que abarca el primero extiende el concepto a las reacciones totales e inconscientes del analista al paciente. Este concepto incluye los respuestas emocionales apropiados del analista a las transferencias del paciente y a la realidad de la vida del paciente y los efectos emocionales en la situación de tratamiento determinada por la propia realidad del analista, ya que puede verse afectado por el paciente. Las 264

Contratransferencia y regresión de transferencia 265 Justificación Para este concepto más amplio de contrarresta, se deriva de los efectos en el tratamiento de las transferencias profundamente regresivas de los pacientes con límites, lo que caracteriza a la paimología de carácter grave en general, y el inconsciente (y consciente) Destructividad de algún límite narcisista y pacientes paranoicos, que pueden amenazar no solo al tratamiento, sino también el paciente, e incluso la vida del analista. Un círculo aún más amplio incluye, además de los dos mencionados anteriormente, la reacción específica habitual de cualquier analista particular a varios tipos de pacientes, una reacción que incluye disposiciones de contrarresta y manifestaciones según lo definido y los rasgos generales de la personalidad del analista. Ciertos rasgos de personalidad pueden activarse en ciertas situaciones de tratamiento, con funciones tanto defensivas como adaptativas en respuesta a las onslas de transferencia. Se ha definido mucha controversia aparente con respecto a la gestión de la contraparte de las diferentes formas en que se ha definido la contrarresta. Una definición integral que incluye el campo espacial de los fenómenos de la contraversión de la contrarresta, al tiempo que se diferencia claramente los componentes de este campo puede resolver el problema. La dimensión temporal Tres tipos de reacciones de contraatansferencia se pueden distinguir sobre la base del tiempo. Las primeras reacciones agudas o de corta duración, que, de acuerdo con la contratransferencia, se pueden determinar únicamente por la transferencia del paciente o por la interacción total del paciente / analista. Los siguientes son distorsiones de la contratransferencia a largo plazo: distorsiones sutiles, graduales e insidiosas de la actitud de la actitud del analista hacia el paciente durante un período prolongado de tiempo. Como se ha señalado la Torre (1956), estos a menudo son reconocidos solo retrospectivamente. Ocurren usualmente en trabajar con un patrón de transferencia particular, especialmente en las primeras etapas del

tratamiento, cuando la resistencia intensifica ese patrón. La resolución de ese patrón de transferencia por interpretación puede iluminar la distorsión crónica de la contraversión, que ahora desaparece, junto con el cambio en la transferencia. El analista se puede alertar a sí mismo a las reacciones de contrarrescribir a largo plazo al comparar la reacción "especial", un paciente dado evoca en él con sus reacciones a otros pacientes. Finalmente, una reacción de contratransferencia aún más extendida es la "contrarresta permanente" descrita por Reich (1951), que cree (y estoy de acuerdo), refleja la patología del personaje del analista. Es difícil que se le dice que la personalidad de la analista juega un papel en cualquier analizador. Su posición de neutralidad técnica no significa que el paciente no pueda distinguir y reconocer muchos aspectos de la realista.

266 Apariencia severa de regresiones, comportamiento, actitudes y reacciones afectivas. De hecho, uno podría decir que los pacientes cuelgan la tela de su transferencia en las protuberancias de la personalidad del analista. Considerando que estos aspectos reales del analista se prestan a la ración de los desarrollos de transferencia, no niegan el origen en el pasado de la transferencia del paciente, y no necesariamente no se dirigen a la patología del personaje del analista. Los pacientes se convierten en expresión rápidamente al detectar las características de la personalidad del analista, y las reacciones de transferencia a menudo surgen primero en este contexto. Pero para concluir que todas las reacciones de transferencia están en la parte inferior, al menos en parte, las reacciones inconscientes o conscientes a la realidad del analista es malinterpretar la naturaleza de la transferencia. La transferencia es el aspecto inapropiado de la reacción del paciente al analista. El análisis de la transferencia puede comenzar por el "abandono abierto" del analista la realidad de las observaciones del paciente y explorar por qué las observaciones particulares son importantes en cualquier momento en particular. Si el analista es consciente de las características realistas de su personalidad y es capaz de aceptarlas sin la defensividad o denegación narcisista, su actitud emocional le permitirá transmitir al paciente: "Entonces, si está respondiendo a algo en mí, ¿cómo entendemos la intensidad de ¿Tu reacción? Pero la patología del carácter del analista puede ser tal que la reacción de la transferencia del paciente a él resulte en la erosión de la neutralidad técnica. Cuando el analista es incapaz de discriminar entre las percepciones realistas e irreales del paciente de él, la contraparte está funcionando. Contrarransferencia y la gravedad de la patología del paciente. He descrito en el trabajo anterior (1975) un continuo de reacciones de contrarransferencia, que van desde respuestas al paciente analítico típico que establece una neurosis de transferencia bien diferenciada a las reacciones a Un paciente psicótico

con transferencia psicótica. Reacciones de contraatansferencia a las condiciones fronterizas y narcisismo patológico Oc- cupice una posición intermedia en este continuo. Cuanto más retrocedió al paciente, más obligue al analista a reactivar las características regresivas en sí mismo para mantenerse en contacto con el paciente. Esto trae la personalidad total del analista al primer plano. Cuanto más le resulte al paciente, cuanto más sus conflictos patógenos característicos se infiltren por la agresión primitiva, expresados en la transferencia como ataques directamente o indirectos en el analista. Tales ataques activan una respuesta emocional en el analista que se refleja, como señaló Winnicott (1949), su reacción no solo a la transferencia, sino también a la relación de paciente / analista total. Bajo tales circunstancias, el concepto más amplio de contrarrestar

La referencia y la transferencia de regresión 267 la transferencia se vuelve operativa. Cuanto más retrocedió al paciente, más globales serán las reacciones emocionales del analista. Las reacciones globales del analista, entonces incluyen las disposiciones de la contrarrencia de los disturbios solo en un sentido restringido, pero también lo que el ritero (1957) llama "identificaciones complementarias" con las representaciones de objetos activados y proyectados del paciente. La comprensión del analista de las relaciones de objetos internalizadas activas inconscientemente en la transferencia se enriquece así. Sin embargo, en contraste con la retaver, subrayaría que en una posición de contrarrescna complementaria, el analista puede identificar no solo con los "objetos internos" del paciente, sino también con sus representaciones de autorización proyectadas, mientras que el paciente promete sus identificaciones con un objeto internalizado. Representación. La activación en la situación psicoanalítica de una relación de objeto interdenal primitiva dentro del cual el paciente y el analista mantienen su reciclismo, pero intercambian repetidamente sus roles (identificándose alternamente con representaciones de auto y objetos) tiene un diagnóstico fundamental y terapéutico Funciones. Para utilizar estos desarrollos terapédicamente, el analista debe mantener estrictos límites analíticos para controlar la actuación y preservar su libertad interna para fantasear ("reverie") para diagnosticar los aspectos proyectados de las relaciones de objetos del paciente. El analista también debe separar continuamente dicho material proyectado de sus propias disposiciones de contratransferencia (en un sentido restringido) y debe transformar su introspección en las interpretaciones de transferencia que preservan una calidad atemporal hasta que el material confirmatorio supere la colocación genética. En otras palabras, la tolerancia del analista para las distorsiones de su experiencia intrapsíquica bajo el impacto de la regresión de la transferencia en el paciente puede convertirse en empatía con lo que el

paciente no puede tolerar dentro de sí mismo. La empatía puede generar eventualmente generar conocimiento crucial para las interpretaciones de transferencia. Grinberg (1979) ha propuesto diferenciar la contratransferencia complementaria del analista, derivada de la activación en él de las relaciones de objetos internas anteriores bajo la influencia de la transferencia del paciente, de la "continua política proyectiva", cuando tales tallos de activación casi Enteramente de la transferencia del paciente. Esta disfunción propuesta enriquece el análisis de las reacciones de la contratransferencia. En la práctica, siempre existe una relación complementaria entre el mundo interno del paciente y el del analista activado en los desarrollos de contrarrestación. A medida que aumenta la gravedad de la enfermedad del paciente, su expresión de la realidad emocional toma formas no verbales, incluidas las comunicaciones conductuales que pueden incluir esfuerzos sutiles o crudos para ejercer el control sobre el analista. Estos esfuerzos pueden ser tan extremos para amenazar los límites de la situación psicoanalítica (un fenómeno examinado aún más en el

268 Regresiones severas Siguiente sección). Sin embargo, dichos desarrollos no deben llevar al error de la frecuencia de expandir el concepto de contrarrescrafías para incluir a todos los problemas que el analista tiene en el manejo de pacientes difíciles. Los errores debido a la falta de experiencia o el conocimiento son solo eso, no de contratransferencia. La regresión de la contratransferencia y la transferencia en vista de las dimensiones a lo largo de las cuales se pueden clasificar la contratransferencia y sus conexiones con la personalidad del analista, creo que existe una ventaja en el mantenimiento de un concepto completo de contrapesión. Para vincular la reacción inconsciente del analista a la transferencia con su reacción emocional total al paciente, permite diagnosticar cómo la transferencia del paciente conduce a distorsiones en la situación psicocialinalítica y también para evaluar la realista exaltada del analista. Las reacciones y su contratransferencia en un sentido más restringido. Bajo circunstancias ordinarias, la patología del personaje del analista o las restricciones de personalidad deben tener poco o ningún efecto. Pero con pacientes gravemente patológicos cuya intensa agresión primitiva se infiltrea la transferencia, la personalidad del analista se someterá a reacciones de contrarrencia en un sentido amplio, lo que puede resultar en activar sus rasgos de carácter patológico. Especialmente cuando el tratamiento está estancado y, en presencia de reacciones terapéuticas negativas graves, las reacciones emocionales más amplias de los AnaSt pueden depender de sus características de personalidad. Quizás el aspecto más vulnerable de la personalidad del terapeuta bajo estas condiciones extremas es su creatividad como psicoanalista. Por la creatividad me refiero a la capacidad de transformar el material del paciente imaginariamente en una formulación dinámica integral o en una fantasía central organizada o en una experiencia particular que ilumina vívidamente y contrariamente que ilumina todo el material de nuevas formas. La creatividad psicoanalítica está íntimamente relacionada con la

preocupación por el paciente y de mantener la conciencia de las cualidades positivas del paciente frente a su agresión que no se remite. Una de las fuentes de esta creatividad es la capacidad del analista para sublimar su agresión a través de la "penetración", aclarando los aspectos de la técnica analítica. La preocupación, como ha señalado Winnicott (1963), tiene raíces profundas en el deseo de deshacer la agresión al proporcionar amor a un objeto significativo. Obviamente, la creatividad del analista también expresa los aspectos sublimatorios de su inversión libidinal en el paciente. Es natural que la agresión del paciente se dirigiera precisamente a esta creación. El paciente narcisista en particular enfoca su envidia en esta creatividad anaderica, la fuente de lo que está recibiendo del analista. Cuando el analista se enfrenta al esfuerzo del paciente para denigrar, neutralizar y, en general, destruir su equipo técnico, autoestima y

Contransferencia y transferencia de regresión 269 Seguridad personal, su confianza en su capacidad para contrarrestar estas tendencias por tolerancia, comprensión y trabajo interpretativo creativo, sin negar la gravedad de la agresión en la transferencia, le permite continuar trabajando con el paciente y, por lo tanto, continuar trabajando con el paciente y, por lo tanto, continúe trabajando con el paciente Para ser un buen objeto para el paciente a pesar de la agresión indicada hacia él. Pero la preocupación por el paciente, especialmente en momentos de vigencia violenta de la transferencia negativa, también hace que el analista sea más vulnerable. Su intento de mantenerse en contacto con el "buen auto" de un paciente, mientras que se calificaron por sus comentarios y silencios y para mantener no solo respeto por el paciente, sino que una conciencia de los aspectos amorosos y adorables de su personalidad requiere que esté emocionalmente abierto al paciente. Esto, por supuesto, expone al analista aún más a la embestida de la agresión del paciente. El retiro defensivo del ataque, la afirmación afilada de las fronteras sociales que nos protege de los asaltos sádicos en circunstancias sociales ordinarias, se reduce deliberadamente en la situación analítica, una circunstancia que puede tentar al paciente a la falta de irrazonación extrema y exigencia. De la misma manera, la amenaza de culpabilidad insoportable obliga al paciente a recurrir cada vez más a los mecanismos proyectivos primitivos para justificar su agresión; y la proyección primitiva, en particular la identificación proyectiva, es un poder interpersonal poderoso que "descarga" la agresión en el analista. El paciente puede provocar el analista en contraaggresión y luego, triunfalmente, utilizar este desarrollo como una racionalización de su propia agresión. Al tratar a los pacientes con límites fronterizos o pacientes con la patología de carácter de derrota, hay momentos en que las fantasías paranoides que abarca a estos pacientes pueden invadir el tiempo libre del analista en formas casi astutas, que ilustran la reversión de las fantasías

perseguidoras en la transferencia. Finalmente, debido a que el analista significa el débil y sumergido propio de la paciente, el paciente puede proyectar sus autopresentaciones buenas o idealizadas en el analista, casi "para la custodia", y, sin embargo, debe atacarlos bajo los efectos de la agresión y la envidia, originalmente autodirigidos. El ritero (1968) ha enfatizado el alto riesgo, en tales circunstancias, que el paciente reforzará con éxito cualquier rasgo masoquista que el analista aún pueda retener. A largo plazo, los pacientes con regresión crónica grave y una agresión primitiva prevalecen en la transferencia, o pacientes con reacciones terapéuticas negativas graves reflejadas en su "estropaje" coherente del trabajo del analista y su disposición positiva hacia ellos, necesariamente activan el analista. Las defensas narcisistas normales, orientadas a proteger su creatividad y autoestima. Esto ahora puede complicar sus reacciones agudas de contrapesión. De la misma manera, la capacidad del analista para supliquese, que protege y preserva su creatividad y su autoestima frente a la agresión, puede volverse crucial para delimitar, localizar y

270 Regresiones severas que se mantienen dentro de los límites razonables Cualquier reacción de la contraversión que desarrolla. Contrarransferencia y la incapacidad de depender de los analistas de manera extraña, las situaciones clínicas recién descritas se pueden producir cuando hay una regresión de transferencia mínima y casi total ausencia de agresión manifiesta en la transferencia. Estoy pensando en ciertos pacientes que tienen una incapacidad crónica para depender del analista. Estos pacientes presentan resistencias sutiles, generalizadas y de transferencia altamente efectivas contra ser dependientes del analista y contra la regresión relacionada en la transferencia en general. Características clínicas en la superficie, estos pacientes transmiten la impresión de que son incaptibles de establecer una relación de transferencia; Parece que están enviando una "resistencia contra la transferencia". Sin embargo, esta resistencia es parte de un complejo patrón de transferencia que refleja un subproyecto particular de patología de caracteres narcisistas. Debido a que la dependencia del término es vaga y ambigua, este patrón requiere una mayor aclaración. No me refiero a los pacientes que presentan una resistencia aguda o crónica contra "dependiendo" en el analista porque temen sujetar a una imagen parental temida o tienen miedo de los anhelos heterosexuales o homosexuales o tener formaciones de reacción contra la pasiva. Necesidades orales y contra la intensa ambivalencia de muchas fuentes. Me refiero, más bien, a los pacientes que, desde el principio del tratamiento, establezcan una relación notablemente estable con el analista caracterizado por dificultad para hablar con él sobre ellos mismos. Hablan con el analista para influir en él o hablar con ellos mismos sobre sí mismos, dejando al analista la sensación de que ha sido eliminado de su conciencia. Estos pacientes tienen una gran dificultad para escuchar al analista como un estímulo para una mayor autoexploración. Tienen una forma constante, inquebrantable y automática de escuchar como si

estuvieran buscando significados ocultos, para las intenciones del analista, para los "mecanismos" que operaban en su mente, sus teorías y técnicas. No pueden permitirse sorprenderse por lo que surge en sus propias mentes en respuesta a sus comentarios. Conciben al psicoanálisis como un proceso de aprendizaje en el que el conocimiento proviene del analista, a ser examinado y evaluado por ellos y luego asimilado o rechazado conscientemente. Estos pacientes no pueden concebir ningún conocimiento sobre ellos mismos que puedan surgir de su inconsciente, sorprendiéndolos, y que requieren un trabajo verdaderamente colaborativo con el analista para que sean incorporados e integrados. Por lo general, tienen grandes dificultades en la experiencia.

La referencias de contraatanes y la transferencia de la tristeza, la depresión y la culpa, lo que reflejaría preocupaciones más profundas por su mundo interno; no pueden concebir inconscientemente la máxima relación con una buena relación madre / hijo y no puede, en un sentido inconsciente, "cuidado" por sí mismos. Ilustran dramáticamente la incapacidad narcisista de amarse a uno mismo y confiar en el mundo interno. Aunque lo que estoy describiendo es una configuración típica de transferencia de personalidades narcisistas, no todas las personalidades narcisistas presentan estas características. Esta configuración en particular no está vinculada a la fallidad de la patología narcisista, que generalmente se expresa en patología extrema de las relaciones de objetos, las características antisociales y las regresiones de transferencia paranoica (incluidos los micropsicogoticepisomas paranoicos). Por lo tanto, uno puede encontrar la incapacidad de depender de pacientes narcisistas con pronósticos tanto favorables como muy desfavorables para el tratamiento. Además, aunque esta configuración de transferencia, una vez detectada, es bastante similar de un caso a otro, los conflictos subyacentes y las disposiciones de transferencia reprimidas varían mucho. Por ejemplo, en el curso de la resolución de esta resistencia a la transferencia, se puede encontrar reacciones depresivas relacionadas con la culpa inconontable, las tendencias paranoicas severas que reflejan los conflictos condensados o los conflictos preeedipales, o conflictos homosexuales. Algunos pacientes presentan una incapacidad general para experimentar plenamente las emociones y verbalizarlos en relación con circunstancias traumáticas muy tempranas. La descripción de McDougall (1979) de los desarrollos de contratransferencia bajo tales circunstancias corresponde a mi propia experiencia. Impacto en el analista La imagen de transferencia que estoy describiendo tiene un efecto profundo en la contratransferencia del analista y desafía seriamente su creatividad. En primer lugar, en la medida en que estos pacientes nunca forman

realmente una relación emocional profunda con el analista, transmiten la impresión de que no se está transforme. Particularmente para el analista inexperto o que duele, los pacientes que pueden asociarse libremente, que parecen tener la libertad de sumergirse en la fantasía primitiva, los recuerdos de la infancia y la expresión emocional, y, sin embargo, que no se desarrollan la transferencia, pueden ser desconcertantes e inquietantes. La situación es muy diferente de la creada por el paciente obsesivo, cuya intelectualización y racionalización, aislamiento, formación de reacción y otros desfesos de alto nivel transmiten una dificultad para experimentar emociones, aunque el paciente está profundamente involucrado en la transferencia. En segundo lugar, este escrutinio constante de los pacientes narcisistas de las interpretaciones del analista, su implacable escaneo "interpretativo" de todos sus comentarios, puede tener un efecto paralizante en las comunicaciones del analista durante un período prolongado de tiempo. Este es un esfuerzo más efectivo en control que el intento narcisista habitual de mantener las interpretaciones del analista.

272 Regresiones severas dentro de un cierto rango, para asegurarse de que no dice nada inesperado (que evocaría la envidia del paciente) o cualquier cosa demasiado fácilmente devaluada (que desencadenaría reacciones de decepción severas). En contraste con estas "restricciones de rango" en lo que el paciente puede aceptar del analista, los pacientes que se encuentran en revisión reciben todo en formas que tienden a neutralizar o eliminar el impacto emocional directo de la interpretación. Salen del analista la impresión de que se ha estado hablando con sí mismo o que sus comunicaciones, una vez expresadas, se han evaporado antes de alcanzar al paciente. Además, la detección consistente del analista provocó inevitablemente, en consecuencia, en el mapeo cuidadoso de los pacientes de sus características "reales", sus peculiaridades e idiosincrasias. El analista puede tener la sensación incómoda de estar expuesto a un escrutinio un tanto benigno, quizás ligeramente irónico, divertido, o obyamente sospechoso, un intento más generalizado de control que los ocurrenes en cualquier otra relación analítica. Además, estos pacientes "aprenden" la lengua del analista, su esfuerzo, sus expresiones preferidas, por lo tanto, que pueden combinar las descripciones con consideraciones interpretativas de manera hábilmente "empalmada" que el analista ya no puede diferenciar la emoción de la intelectualización o la voluntaria. Fantasía de teorías psicoanalíticas. De hecho, el paciente, él mismo no puede diferenciar lo que es auténtico, lo que proviene de él, y lo que ha aprendido del analista. Todo se asimila en una estructura psicológica que evita que el paciente o el analista aprendan sobre los aspectos inconscientes de la patología del paciente. Al final, el propio paciente es víctima de su incapacidad de depender del analista. El efecto de estos desarrollos en el analista puede ser una pérdida de espontaneidad. En lugar de trabajar con atención uniformemente suspendida, puede intentar a la defensiva controlar sus propias comunicaciones. La aparición de la falta de participación y el desarrollo de la

transferencia durante un largo período de tiempo puede inducir en el analista un sentido desalentador de que nada está sucediendo, sin que su poder señale donde se encuentra la dificultad. Finalmente, puede llegar a sentir un sentido de parálisis y futilidad. Incluso puede terminar en colusión con el paciente, dividir la sesión de la sesión en un patrón repetitivo de rendirse y comenzar de nuevo. Enfoque terapéutico No es muy difícil diagnosticar un estancamiento derivado de una defensa crónica contra la dependencia. Sin embargo, para resolverlo, impone los límites de la capacidad del analista para trabajar con reacciones de contratransferencia a lo largo de todo el espectro de las dimensiones que se describen anteriormente, especialmente su capacidad de mantener su creatividad. En particular, este estancamiento impone a la

La regresión de la contratransferencia y la transferencia 273 la fantasía evocadora del analista, su capacidad para utilizar su conocimiento emocional sobre cómo un paciente y un analista se relacionan entre sí bajo circunstancias ordinarias. Me refiero a lo que Loewald (1960) se describe como la relación subyacente entre el paciente y el analista en la situación psicoanalítica: una persona se atreve a depender de otra, y la otra a su vez acompañe a la dependencia de la dependencia de la autonomía de la primera persona. Es útil para que el analista mantenga en fantasía una imagen clara de cómo un análisis "normal" podría responder a sus intervenciones, explorando sus propias reacciones mientras se experimenta en una relación abierta y segura con el analista. Estas condiciones están presentes cuando el ego observador del paciente está trabajando en colaboración con el analista. La capacidad del analista para experimentarse tanto como analista como como un paciente en una posición dependiente puede crear un marco altamente subjetivo y experimentado, pero realista, que se realiza contra el cual la incapacidad del paciente para depender puede ser diagnosticada y interpretada gradualmente. La atención cuidadosa a las reacciones del paciente a las interpretaciones es la mejor guía para explorar y resolver esta complicada capacidad de transferencia. El paciente puede, en su esfuerzo por diagnosticar "cómo el analista lo hizo", imputar a la intelectualización de los analistas y las teorías extrañas o las reacciones de "contrarresta". Esto puede abrir la carretera para aclarar con el paciente lo difícil que es para él concebir la posibilidad de que el analista haya respondido espontáneamente y que esté interesado en ayudar al paciente a mejorar su autocomprensión en lugar de en manipularlo o lavarlo de cerebro con las teorías. En este contexto, el analista puede sugerir que el paciente está depreciando su propia vida de fantasía y la capacidad de la experiencia emocional, aunque parece estar cuestionando la capacidad de la introspección espontánea. Las reacciones típicas de las personales

narcisistas que, después de sentirse ayudado o entendidas por el analista, desarrollan una mayor necesidad de negar tal ayuda o comprensión también se puede usar para aclarar este patrón facilitando la interpretación de las operaciones de arranque (Rosenfeld, 1964). A veces, la "falta de sentido" o la falta de contacto emocional entre pacientes y analistas, pueden repetir una relación patógena específica con los objetos parentales. El paciente desesperado, enojado y obstinado evaluó al analista que demuestre la diferencia entre el presente encuentro analítico y el pasado. La envidia inconsciente del analista, percibió como independiente y segura en su creatividad, y la necesidad correspondiente a estropear su trabajo complice ese desafío. La dificultad es que la interpretación de este patrón puede ser capturada de manera prematura y demoniosa por el paciente y tejido en sus asociaciones y su negación de la realidad psíquica. Aquí, el trabajo consistente y la atentividad al uso defensivo de la percepción intelectualizada puede resultar útil. Con bastante frecuencia, el enfoque en la identificación inconsciente del paciente.

274 severas regresiones con un objeto frustrante, sádico y perseguidor de su pasado, lo que lo hace desconfiando tanto al analista como a su propio mundo interno (en Bot-Tom, un introjecto materno agresivo y rechazado, quien niega las necesidades dependientes del paciente. Con su vida emocional en general), puede aclarar y resolver este patrón en el contexto del análisis de las identificaciones de los componentes de la grandiosa. Aquí, la auto idealización del paciente que niega su necesidad de otros se condensa con la identificación con un agresor (que aún no se ha descascarado como un agresor hacia el yo normal, infantil, dependiente del paciente). Un interesante desarrollo en pacientes que comienzan a trabajar a través de este tipo de transferencia es la tendencia, siempre que se haya logrado una nueva comprensión, para volver a la negación de cualquier relación emocional con el analista. Por lo tanto, el patrón, que originalmente había sido consistente y permanente, ahora comienza a oscilar, reapareciendo cuando la relación de transferencia se profundiza. La interpretación repetida de este patterna cuando el analista reconoce su reemerga puede facilitar el trabajo, aunque la repetición a menudo puede evocar en el paciente la queja de que el analista continúa centrándose en los mismos problemas y, por lo tanto, está negando el progreso del paciente. En estos pacientes, el desarrollo de disposiciones de transferencia severamente regresivas y reacciones emocionales intensas, incluso si son fuertemente paranoides, indica el movimiento en comparación con la resistencia a la transferencia previamente estable. El pronóstico para los pacientes que nunca se puede convertir incluso para entender la naturaleza de esta incapacidad para depender del analista es mucho más pobre. Para diferenciar estos dos tipos de pacientes lleva tiempo. La aceptación intelectual de la interpretación del analista de la incapacidad del paciente para depender de él debe diferenciarse de la comprensión emocional, que eventualmente se traduce en turnos en la transferencia.

El Capítulo es: Aspectos clínicos de la patología de Superego severo Los dos indicadores de pronósticos dominantes para el tratamiento psicoanalítico y psicólico de los pacientes con la organización de la personalidad límite y las personalidades narcisistas son la calidad de las relaciones de objetos y la calidad de Funciones de sumino. La calidad de las relaciones de objetos se refiere a las relaciones internas del paciente con otros significativos, no simplemente a la naturaleza de sus intercambios interferentes. Si el paciente, a pesar de su severa psicopatología, todavía puede relacionarse con otra persona en profundidad, para preservar una relación duradera, no social y no parasítica con una persona que está cerca de él, es capaz de mantener relaciones de objetos. En contraste, el paciente que está totalmente aislado socialmente, en el que ninguna relación profunda con nadie está disponible a nivel de conciencia consciente y preconsciente, el paciente cuya única participación significativa con otros ocurre como parte de las fantasías de la masturbación y el paciente que Presenta solo la conciencia minuciosa o el interés en las características, preocupaciones y deseos de los demás, todos revelan daños graves en el ámbito de las relaciones de objetos. Para mantener la honestidad social ordinaria y experimentar un sentido apropiado de culpa y la responsabilidad moral en las relaciones con otras personas, hable por la capacidad de mantener las funciones básicas de su superygo. En contraste, una deshonestidad generalizada en las relaciones humanas y la falta de preocupación y la responsabilidad en todos los intercambios humanos indican la ausencia o deterioro de las funciones de superyo. Naturalmente, la gravedad de la pafestología del superyó se refleja en el grado de comportamiento antisocial presente. Sin embargo, es importante recordar que la patología del superego debe evaluarse sobre la base de la relación interna de la persona con su entorno social en lugar de de acuerdo con las definiciones convencionales o legales de lo antisocial. El tratamiento psicoanalítico de las personalidades narcisistas

revela en 275.

276 Regresiones severas interesantes y relaciones complejas entre la patología del superyógo y la calidad de las relaciones de objetos. Las personalidades narcisistas de todos los grados de la verdad revelan características antisociales con una frecuencia sorprendente. Incluso aquellos con un funcionamiento social relativamente adecuado, cuya grandiversidad patológica se les proporciona a las gratificaciones bien compensadas de la autoexpreso y cuyas interacciones sociales superficiales y capacidad para una inversión más profunda en otros todavía están disponibles, pueden presentar un comportamiento antisocial crónico en forma de Robo y falsificaciones en su trabajo o en sus actividades sexuales. Debido a que tales características antisociales son tan importantes, las investigaré en todos los pacientes con personalidad narcisista (incluso aquellos con un funcionamiento social aparentemente muy bueno) y a menudo han encontrado que surgen discrepancias entre una calidad relativamente no dañada de las relaciones de objetos y un severo insospechado Patología de Superego. En contraste, algunos pacientes narcisistas que funcionan en un nivel de límites abiertos y muestran una patología extrema y generalizada de las relaciones de objetos tienen funciones de superega sorprendentemente intactas. Es solo en el afortunadamente pequeño subgrupo de patología narcisista, donde la infiltración agresiva del propio Ser Patológica, da lugar a lo que llamo narcisismo maligno (vea los chaps. 16 y 19), eso es, grandiosidad ego-sintónica Combinado con la crueldad o el sadismo y los rasgos de personalidad para noides severos, que el deterioro de las relaciones de objetos regularmente van de la mano con el deterioro de las funciones de SupereOgo. He encontrado que todos los pacientes con estructura de personalidad antisocial presentan patología narcisista de derrotas, destrucción de su mundo interno de relaciones de objetos, y patología de superyo extremo y generalmente no tratable. Dichos pacientes están en los límites no solo de la analizabilidad sino del tratamiento con las psicoterapias psicoanalíticas

modificadas. La evaluación de la calidad de las relaciones de objetos, de la patología del superyó, y de la naturaleza del narcisismo patológico nos dice si un paciente es tratable. CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBIDO Las ideas de Edith Jacobson sobre el desarrollo de las estructuras de SupereOgo son un marco de referencia más valioso para comprender las vicisitudes de la formación de superyo temprano normal y patológica. Por lo tanto, resumiré las contribuciones pertinentes de Jacobson antes de expandirse en su marco teórico para explicar la gravedad de la patología de su superygo en consideración aquí. Jacobson (1964) describe tres etapas anchas o capas de formación normal de suyfergo. La primera y la capa más profunda está representada por los primeros primarios de SA-DISTRIC que reflejan la internalización de las imágenes de objetos fantásticos, sádicamente prohibitivos y punitivos o, más bien, el "malo"

Aspectos clínicos de la patología del superyó 277 Representaciones fusionadas de sí mismo y objetos que los proyectos infantiles en la madre frustrante y otros objetos como parte de un esfuerzo para negar su agresión. Una segunda capa se basa en la fusión de las autorrepresiones ideales y las representaciones de objetos ideales; La integración de esta capa constituye el ideal del ego y representa un esfuerzo final para reconstituir la relación simbiótica invertida libidalmente original con la madre en un nivel más alto de aspiraciones y demandas intrapsíquicas. Bajo circunstancias óptimas, se produce un tono de los primeros precursores de superyo más sádico y más allá de los primeros, que se repiten dentro del superyo en evolución de los procesos de integración de las relaciones de objetos buenos y malos que ocurrieron anteriormente dentro del EGO. Jacobson ha notado cómo dicha integración y tonificación lo permiten, a su vez, la internalización de una tercera capa de determinantes de SuperOgo, a saber, los aspectos realistas, exigentes y prohibitivos de los padres que caracterizan las etapas posteriores de la Fase de edición edificada y provocar la consolidación final del superyó como una estructura integrada. A lo largo de la siguiente etapa del desarrollo, la latencia, los procesos de la despersonificación, la abstracción y la individualización se producen en el superpago, lo que provoca la regulación de la autoestima por afecto y demandas más enfocados, delimitados, cognitivamente diferenciados, en contraste con el Anteriormente, las regulaciones controladas por el superego de la autoestima mediante cambios de estado de ánimo generosalizados. Los sentimientos específicos de la culpa y la autocrítica reflejan una elaboración sofisticada de desarrollo de los estados de ánimo deprimidos bajo la influencia de la integración de SupereOgo. El supego maduro se caracteriza por el control ejercido a través de cambios de humor leve o modulada, sensaciones de culpa y un sentido creciente de autonomía, mientras que un superyo patológico, mezquino y primitivo se caracteriza por el predominio de severos. Estado de

ánimo depresivo. Además, los sentimientos de inferencia y vergüenza reflejan la participación del ideal del ego en la regulación del superygo del ego; Cuanto mayor sea el defecto en la integración de SupereOgo, más sentimientos de inferioridad y vergüenza predominan sobre la capacidad de experimentar afectos deprimidos modulados (como la tristeza) y los sentimientos de culpa diferentes. La siguiente etapa del desarrollo del superego se produce en la adolescencia. JA- COBSON describe la replección parcial, la reprovision y la redissión del superyó que ocurren, ya que el adolescente refuerza las prohibiciones infantiles contra las luchas de los oedipales. Al mismo tiempo, el adolescente debe identificarse con un modelo adulto de comportamiento sexual para integrar los aspectos tiernos y eróticos de los impulsos sexuales. Aquí, la medida en que se produce una redisolución parcial y la reproición del superyó y la medida en que la identidad normal del ego aún se mantiene diferenciadas a los adolescentes normales y neuróticos de su límite y las contrapartes narcisistas (Jacobson, 1954, 1961, 1964).

278 Regresiones graves Consideraciones clínicas Niveles de patología del superego El espectro de la patología del superego que se presenta a continuación ilustra fallas en los diversos niveles de formación de superego descritos por Jacobson. Desmriba un continuo de severidad de la patología del superyógo que vaya de la personalidad antisocial prácticamente intrédita a los pacientes con patología de caracteres neuróticos. Mi énfasis está en las relaciones entre la patología del superyó, la patología de los objetos. Revelaciones, el narcisismo patológico y las vicisitudes de la transferencia de estos pacientes. La personalidad antisocial La patología del superyó más extrema se encuentra en pacientes con trastorno de personalidad antionsalíaco, los psicópatas en un sentido estricto. Estos pacientes se encuentran al terapeuta, plenamente conscientes de que están mintiendo. Superan los requisitos "morales" de la realidad externa a la que tienen que pagar el servicio de labios, pero no entienden que estos representan un sistema de moralidad auténtico que otras personas han internalizado. En su lugar, perciben las demandas morales del medio ambiente como un sistema de "advertencia" aceptado convencionalmente, para ser explotado por los corruptos (como ellos) y sometidos por el ingenuo y el astuto. Estos pacientes pueden mentir y engañar de manera efectiva. Entienden que pueden ser atrapados, pero no entienden que sus mentir y hacer trampa afectarán la relación interna de los demás. Debido a que no pueden experimentar una inversión auténtica de amor en otros, no pueden apreciar la diferencia entre dichas inversiones que otros pueden tener para ellos y para la explotación y manipulación despiadadas. Tienden a destruir la posibilidad de cualquier relación emocional con el terapeuta sin entender que lo están haciendo. Su capacidad de mentir refleja efectivamente una integración del yo de una especie, pero es una basada en el propio Gordo Patológico de la personalidad narcisística y uno totalmente identificado con el planeamiento. Algunos de estos pacientes presentan una

infiltración de esta grandiosa propia con agresión y una posterior búsqueda de ego-sintonía con la gratificación de los impulsos sádicos. Hay un continuo del psicópata pasivo, explotador y parasitario al criminal franco sádico. Las condiciones sociales que facilitan la expresión de la agresión primitiva y la crueldad proporcionan un alojamiento natural para estas estructuras de personalidad. Excepto en circunstancias inusuales, el tratamiento psicoterapéutico está contraindicado para estos pacientes. Los miembros abiertamente sádicos de esta categoría pueden ser demasiado peligrosos para tratar en el entorno psicotericídico ordinario, y la promulgación de un triunfo sádico manifiesto a través de

Aspectos clínicos de la patología del superyó 279 La depreciación extrema del terapeuta combinada con la explotación financiera directa o de otra persona puede convertirse en una experiencia aterradora para el terapeuta. Con psicópatas pasivos o parasitarios, puede ser solo una confusión con su comportamiento antisocial que desencadena las regas violentas paranoicas en la transferencia, dentro de la cual activan una grandiosidad sádica similar a la del tipo directamente agresivo (mientras que Todavía proyectando esta tendencia al terapeuta). Un paciente, una personalidad antisocial con características predominantemente sádicas, entró en un tratamiento psicoterapéutico bajo presión de su familia y para evitar ir a la cárcel debido a su participación en los interrupciones y el robo. Habló abiertamente durante sus sesiones conmigo sobre un robo planificado. Dejó en claro a través de amenazas sutiles pero inequívocas que sabría cómo protegerse en caso de que me lo pidiera dañarlo informándole a la ley. Es difícil transmitir el sobrepropiado sentido de superioridad y seguridad que este hombre expresó. Su sonrisa relajada sugirió que me depreció totalmente, y hubo momentos en que logró paralizar mi pensamiento para que fuera difícil para mí intervenir en absoluto. Decidí interrumpir el tratamiento después de llegar a la conclusión de que la combinación de problemas legales y temas teráuticos estaba fuera de mi capacidad. Otro paciente con personalidad antisocial y una historia de robo y explotación parasitaria de los demás, pero sin ninguna evidencia de violencia manifestante, un hombre que generalmente se describió como pseudoversubromisivo y astuto, robó cosas de mi oficina. Aunque al principio no podía estar seguro de que él era responsable de los objetos que faltaban, me encontré observándolo en las sesiones y revisé a mi oficina cuando se fue. Después de que finalmente recaqué una pregunta con respecto a un pequeño objeto que había desaparecido de mi sala de espera después de una sesión con él, el paciente "congendió" que lo había tomado y lo llevó de vuelta. Sin embargo, dio ninguna evidencia de

vergüenza o culpa, y las sesiones que siguieron (hasta que la inserción del tratamiento unas semanas más tarde) estuviera marcada por mi sentido que no estaba de mala gana en un juego de observación para proteger mi propiedad. Cuando intenté explorar las implicaciones psicológicas de esta interacción, el paciente rechazó, con diversión, mi insistencia en la vivienda en un episodio que era "una cuestión del pasado". Personalidad narcisista con comportamiento antisocial ego-sintónico El siguiente nivel en el continuo de la patología de su superyo está representada por personalidades narcisistas que funcionan en un nivel de límite abiertas y con características antisociales, pero no una personalidad antisocial, y pa- Los pacientes con formas malignas de narcisismo patológico cuyo sentido agresivo de derecho se expresa en el comportamiento antisocial ego-sintónico. Estos pacientes desarrollan características paranoicas severas en la transferencia.

280 Regresiones severas incluso si su personalidad descriptiva no incluye rasgos paranoicos dominantes. Incluso pueden desarrollar regresiones paranoicas deliránicas en la transferencia. Las sesiones de un paciente con una personalidad narcisista y las características paranoides se dominaron por su grandiosidad y su bravado. Llenó las horas con quejas sobre la estupidez, la ignorancia y la injusticia de varias autoridades y me obligaron a escucharlo en silencio, con la implicación de que estaba de acuerdo con él, o, si me atrevía "a cuestionar cualquiera de sus declaraciones, para convertirse en un ejemplo más. En su mundo de las autoridades desleales. Junto con su grandiosidad casi inepenetrable, fue un encanto que le permitió hacer declaraciones realmente escandalosas. Mientras no lo contradiera abiertamente, mantuvo una manera divertida y amistosa en las horas. También me mintió considerando un comportamiento antisocial en el que estaba comprometido, especialmente con las drogas; En algunas ocasiones, fue solo la comunicación de la policía a sus padres, que llegó a un trabajador social y, finalmente, que me lo permitía saber qué estaba pasando en su vida. Una vez confrontado, admitió fácilmente que había estado mintiendo, defendiendo su comportamiento como per- fectamente lógico en un mundo de autoridades de mente estrecha y restrictiva. Este paciente, sin embargo, en contraste con los mencionados anteriormente, también fue capaz de expresar sutilmente aspectos dependientes en su relación conmigo; Se volvió muy molesto si no lo volviera a ver en su tiempo regular, y estaba extremadamente perturbado por ningún retraso en comenzar sus sesiones. Aunque finalmente interrumpió el tratamiento, mantuvo contacto ocasional conmigo, consideró la posibilidad de reanudar el tratamiento en el futuro, y posteriormente pudo participar en períodos limitados de tratamiento psicotericídico con otros terapeutas. De acuerdo con la información de seguimiento confiable, al menos los aspectos antisociales de su funcionamiento disminuyen gradualmente. En estos pacientes, el

comportamiento antisocial tiene una calidad agresiva, enfurecida y vengativa que es la contraparte de su tendencia severamente paranoica para atribuir reacciones similares a todos los demás. La mentira y el trampa son ego-sintónicos en el contexto de su imagen del mundo como un lugar donde uno debe engañar y mentir o matar para sobrevivir o debe asegurar su seguridad psicológica al estar más allá del miedo a la muerte. Hay más agresión y sadísmo salvaje que la deshonestidad de las calles o glees en estos pacientes, y muy a menudo se puede encontrar un remanente de honestidad ordinaria en sus relaciones sociales emocionalmente no involucradas. Jacobson (1971), en su descripción de la necesidad paranoica de traicionar, señala la historia de la infancia de los pacientes que se caracteriza por el tratamiento, la negligencia, la crueldad y la discordia conyugal severa entre los padres. Estos pacientes temprano desarrollaron una actitud sumisa y masoquista hacia los padres, mientras que su hostilidad subyacente encontró la expresión en las crueldades que infligieron a sus hermanos menores y en intentos.

Aspectos clínicos de la patología del superyó 281 para engañar a otros miembros de la familia entre sí. Jacobson describe la alternancia entre la agresividad abierta y los rasgos paranoicos, por un lado, y la sumisión y la traición junto con otras tendencias antisociales, por el otro. En el extremo más patológico del espectro, incluida la personalidad antionsalítica y la personalidad narcisista con fuertes características antisociales y / o el narcisismo maligno, existe una clara predominación de la capa más primitiva de su superyo sádico. Precursores. Estos incluyen una expresión de agresión que se designa prácticamente por cualquier integración con los precursores de superyo idealizados y un impulso para el poder y la destrucción de todas las relaciones de objetos (que no sean un complemento de "esclavos" totalmente sumisos y explotados "que permiten La promulgación del poder que aspire los precursores de su superyo sádico a). En la personalidad antisocial, es, como si el paciente se identificara con un poder primitivo, despiadado, totalmente inmoral que pueda obtener satisfacción solo a través de la expresión de agresión no mitigada y no requiere racionalización para su comportamiento y sin adherencia a ninguna Valor sistent que no sea el ejercicio de tal poder. En la personalidad narcisista con características antisociales y en el narcisismo maliguo, sin embargo, existe al menos una disponibilidad inicial de los precursores de superyo idealizados en el sentido de una condensación de los primeros primeros de los primeros de una expectativa de un Primitivo ideal- iza tipo. El comportamiento sádico y explotador del paciente es "moralmente justificado", al menos para sí mismo. En la transferencia, tales pacientes no psicopáticos reaccionan con una rabia intensa si se desafía la "justificación" por su comportamiento cruel y explotador. Es como si estos pacientes identificaban no simplemente con un asesino sádico, como en el caso del psicópata, sino con una deidad extremadamente cruel, un Dios despiadado y egocéntrico. La activación de las ideas paranoicas en las transferencias de estos

pacientes refleja la promulgación de la grandiosidad sádica y la crueldad de esta capa más primitiva, no mitigada o no neutralizada de la formación de superoplas. La presencia de imágenes parentales sádicas o violentas, así como los factores constitucionales que interfieren con la neutralización o el control de la agresión primitiva, es presumiblemente, de manera etiológicamente dominante aquí. La identificación inconsciente del paciente de su propio ser grandioso con las características de estos primitivos, los precursores de su superyo sádico también indica la fragilidad o la falta de disponibilidad de las rejuicios alternativos de objetos internalizados y la destrucción de todos los seres investidos libbidos y Representaciones de objetos. El pasado interdenizado de las relaciones de objetos no cubiertas por la reconstrucción genética en pacientes con los niveles graves de patología del superyó que se describe típicamente incluye la imagen de las figuras de los padres abrumadoras experimentadas como omnipotentes y cruel. Estos pacientes invariablemente consideraron que cualquier relación buena, amorosa y mutuamente gratificante con un objeto

282 Severas regresiones severas o, si están disponibles, fueron frágiles, destruidas fácilmente, y, incluso peor, una invitación directa a atacar por la parrédula y cruel. Por lo general, tenían la sensación de que la presentación total a de hecho, la absorción total en el poder del padre cruel y omnipotente era la única condición de supervivencia y, por lo tanto, todos los vínculos con los objetos alternativos, pero debían cortarse. Finalmente, el sentido estimulante del poder y el disfrute logrado una vez que se completó la identificación con un objeto ombligo cruel, le proporcionó un sentido de libertad de miedo, dolor y temor y la convicción de que la gratificación de la agresión era el único modo significativo de relacionarse con los demás. La deshonestidad en la transferencia, el siguiente nivel de patología de Superego está representado por los pacientes que reprimen o distorsionan crónicamente información importante sobre sus vidas o experiencias subjetivas, en otras palabras, aquellos que mienten por omisión, así como a la comisión en la situación del tratamiento. Estos pacientes incluyen a los pacientes con límites sin conspicua psicopatolina narcisista, así como algunos pacientes narcisistas que funcionan en un nivel abiertamente límite. Aquí, la deshonestidad es en gran parte de una naturaleza "protectora", hay poco comportamiento antisocial directo o abierto, y la calidad de las relaciones de objetos se mantiene mejor. A veces, la gravedad relativa de la patología de SuperOgo puede pasarse por alto durante períodos prolongados en el tratamiento. Los ejemplos típicos incluyen a los pacientes que omiten hablan de aspectos importantes de sus experiencias e interacciones de la vida diaria porque temen que el analista critique o tratará de interrumpir tales comportamientos. Los pacientes a veces "confesan" su comportamiento al analista solo para continuar adelante, con la suposición implícita de que su confesión les alivia la responsabilidad de sus actos. El analista debe decidir si acepta la continuación de este comportamiento al recibir la información en silencio o asumir la responsabilidad de interrumpirlo. En

contraste con el paciente con el síntoma más restringido de cuidar secretos en un área sobre la cual siente vergüenza o culpa extremo, pero que no implica un comportamiento antisocial o autodestructivo importante y al paciente que opera bajo el dominio de la negación inconsciente, quien es Cognitivamente totalmente consciente de una cierta experiencia o comportamiento, pero inconsciente su implicación emocional, el paciente que se encuentra crónicamente es plenamente consciente de la importancia cognitiva como la importancia emocional de los problemas suprimidos. La señorita U. una mujer con una historia de abuso de drogas crónicas y alcoholismo estaba involucrado con un hombre que era un traficante de drogas. Durante un largo período de tiempo, ella retuvo deliberadamente su conciencia de las actividades delictivas de su amigo. Ella "confesó" solo cuando la muerte de un

Aspectos clínicos de la patología del superygo 283 El amigo cercano, que ella sospechaba que había sido causado por el grupo criminal al que pertenecía su novio, produjo una intensa ansiedad en ella. Exploré con sus factores que le habían impedido que ella me contara sobre la cultura criminal que la rodeaba. Surgió que bajo su temor de que le prohibiera que continuara la relación con su novio o terminaría su tratamiento debido a mi indignación sobre su participación con un grupo sombreado de personas, ponemos el temor más profundo de que le habría traicionado a su novio. Sobre sus actividades para mí; Esto pondría en peligro mi vida porque su grupo podría eliminarme una vez que "sabía demasiado / 'esta revelación llevada, a su vez, a perderte la expresión de su miedo con respecto a sus propios deseos de muerte hacia mí y su sumisión masoquista a una situación social que percibió como peligrosa para Su propia vida. En las primeras etapas del tratamiento, la señorita U, una personalidad típica infantil con la organización de personalidad límite, había revelado libremente las fantasías masturbatorias que involucran a las orgías sexuales con sus padres. Me había preguntado en privado hasta qué punto había sido testigo de o Participó en actividades sexuales incestuosas o perversas en la primera infancia. Estas fantasías masturbatorias finalmente resultaban tener orígenes genéticos mucho más complejos y no representaban experiencias sexuales directas de ese tipo en la primera infancia. Sin embargo, varios meses después de la divulgación de su acostado habitual. Para mí, con respecto a la naturaleza de las actividades de su hijo, surgió una nueva información sobre su pasado inconsciente, sugirió que su madre le había sentido crónicamente a la envenenada por el padre de la señorita U, así que teme que solía que el perro de la familia probara la comida antes de que ella lo comiera. El paciente había actuado en la transferencia de su identificación tanto con la madre, que fue amenazada por un marido asesino, y con los febreros asesinos, que estaba "envenenando" la relación conmigo, así como la

potencialmente causando mi muerte. Denegación de la responsabilidad moral El siguiente nivel de patología del superego se caracteriza por lo que podría resumirse como denegación de la responsabilidad moral por las acciones de uno. En consecuencia con el grupo anterior de pacientes mencionados, principalmente con la organización de la personalidad de línea fronteriza, pero sin características narcisistas dominantes, este grupo está representado por pacientes con personalidad narcisista típica, pero sin un comportamiento antisocial en un sentido estricto o en la transferencia. En estos casos no encontramos supresión consciente, omisión sistemática o distorsión de cierta información, sino, más bien, una revelación de "innovientos" de experiencias y comportamientos contradictorios, separados.

284 Regresiones severas por una barrera de negación mutua: una manifestación del mecanismo subyacente de la división, lo que lleva a la denegación de la preocupación, de un sentido de responsabilidad y de los sentimientos de culpa. Estos pacientes no se encuentran conscientemente en el sentido ordinario de la palabra. Su deshonestidad está negándose a aceptar la responsabilidad de la relación de sus sentimientos, intenciones y acciones. De hecho, es sorprendente la facilidad con la facilidad de estos pacientes, que generalmente tienen un historial de comportamiento manipulativo, controlante y explotador con otros, pueden "lavar cerebrales" al terapeuta con la lógica de sus despidos y preocupaciones personales de la responsabilidad personal y de los caballeros por ellos mismos y para los demás. Claramente, estos pacientes muestran una continuidad cognitiva de sus estados mentales, pero mantienen una discontinuidad afectiva que los protege de la ansiedad o la culpa y de cualquier identificación con los valores morales. Parece que ilustran simultáneamente el uso defensivo de la división y el comportamiento totalmente egocéntrico que uno puede observar en los niños antes de que se haya realizado la integración de su superego. Además, muestran un empobrecimiento significativo en su capacidad de inversión en profundidad en las relaciones con los objetos. Su capacidad para hacer que el analista dugara a sus propios juicios de valor e incluso sus conceptos ordinarios de responsabilidad y culpa es imprensiva. Estos pacientes, en resumen, tienen un talento extraño para corromper los sistemas de valor del analista en relacionarse con ellos. La siguiente ilustración es típica. La señorita V. Una mujer joven con una personalidad narcisista y sin las características de la frontera manifiesta, una noche le dijo a un hombre que lo amaba y que él era el único hombre en su vida. Se estaba desarrollando una relación sexual intensa entre los dos. Simultáneamente, ella también estaba desarrollando una relación intensa con otro hombre. Unas cuantas noches después, también le dijo al segundo

hombre que lo amaba y que era el único hombre en su vida. La señorita V habló sobre esto bastante abiertamente en las sesiones. Cuando planteé la pregunta, ya sea que esta fue una fuente de conflicto para ella, ella primero me tranquilizó que no era porque los dos hombres no se conocieran. Después de que había comprobado que ella significaba esto en toda la sin-cereza, le pregunté si podría ser una fuente de conflicto para ella que le había dicho a ambos hombres, casi al mismo tiempo que los amaba y que cada uno era su único amor. La señorita V, muy importante, dijo que había sido completamente sincera al hacer estas declaraciones a ambos hombres, que sus sentimientos habían cambiado completamente de la noche en la que había hablado con el primer hombre a la noche en que había hablado con el otro. Sintió que sus hombres siempre podían estar seguros de que ella era honesta con ellos. Ella dijo que nunca hizo ningún secreto del hecho de que sus sentimientos cambiaron y, por lo tanto, ella no podía garantizar a nadie "amor eterno". Una de sus principales quejas, de hecho, fue la falta de apreciación de su honestidad y el comportamiento contradictorio de los hombres con los que había estado involucrado. Al principio, los hombres aceptaron una relación en la que ella

Los aspectos clínicos de la patología del superyó 285 serían muy amorosos y dando, aunque dejó en claro que no podía asegurarles de lo que sus sentimientos estarían a largo plazo y que necesitaba preservar su libertad. Eventualmente, sin embargo, incluso los hombres que pagaron el servicio de labios a sus declaraciones a principios de al principio se enojaron mucho porque ella se involucraría con otros hombres más adelante. La señorita V no estaba celosa cuando sus hombres se involucraron en otros asuntos de amor; Por el contrario, estos fueron un alivio de bienvenida. La incapacidad de experimentar los celos es bastante frecuente en las personalidades narcisistas. Observmente, ella sufrió de patología severa de las relaciones de objetos, una necesidad para comprometerse de profundidad a cualquier persona o para permitir que se desplomara completamente a nadie. Sin embargo, en contraste con los casos mencionados anteriormente, este paciente tuvo una actitud más apropiada e incluso considerada hacia las personas con las que no estaba intensamente involucrada e inequese; Mantuvo un sentido ordinario de honestidad en sus relaciones sociales. En relación con mí, demostró durante muchos meses una grave falta de participación aparente, pero sin la omisión o la comisión. La señorita V eventualmente se enteró de que un abandono radical de toda esperanza de amor la defendió contra los profundos temores de la decepción y la rabia. La exploración de estas características en la transferencia abrió la carretera para explorar la patología de sus relaciones de objeto. La patología del superego de estos pacientes se refleja en ausencia de preocupación, la falta de capacidad para un sentido de responsabilidad moral y culpa, y las racionalizaciones de su comportamiento presentadas con una lógica desarmada. La sintonía con el ego de su comportamiento que no es abiertamente antisocial hace que sea muy difícil para que el terapeuta les ayude a darse cuenta de que hay un problema detrás de esta aparente falta de problemas "morales". Dicho paciente puede

experimentar cualquier preocupación "moral", el analista podría expresar, como no solo crítico, sino también perseguidor y sádico. En contraste con las personalidades antisociales que son "honestas" sobre sus actividades antisociales sin ninguna preocupación o culpa, la señorita V y los casos que representa no son explotadores abiertamente de otros o antisociales. Su incapacidad a los objetos de las relaciones de los objetos en profundidad es al menos tan autodestructiva, ya que es destructiva para sus relaciones con otros. Con los pacientes que presentan una deshonestidad en la transferencia y la capacidad de asumir la responsabilidad moral, existe la falta de integración del superyó normal, una no disponibilidad relativa de la internalización ordinaria del tercer nivel de prohibiciones y demandas de los padres realistas. Estos pacientes presentan una disociación entre los precursores de suyorego sátiro y la superego se reflejan clínicamente en el comportamiento antisocial racionalizado en el contexto de las transferencias paranoicas vinculadas con la proyección en el analista de los precursores de superyo sádico. Los primeros superyos idealizados pueden proyectarse en el analista en otras ocasiones o en otros objetos de transferencia hacia los cuales se trata la sumisa masoquista con la deshonestidad en la transferencia paranoica. En el caso de un

286 Regresiones severas La consolidación de un serorforieso patológico, que se incorpora a los primeros precursores idealizados, mientras que los precursores de superyo sádico se proyectan en forma de tendencias paranoicas. A pesar del dominio de la devaluación y otras operaciones de defensa primitivas, que dañan su mundo internalizado de las relaciones de objetos, todos estos pacientes todavía pueden mantener temporalmente a mantener las relaciones de objetos idealizados, y algunas veces los rudimentos de los niveles más altos de formación de superyo se reflejan en su capacidad de mantenimiento. Honestidad ordinaria convencional. El predominio de los primeros precursores sádicos tempranos en todos los casos examinados hasta el momento tiene efectos devastadores sobre la internalización de las relaciones con los objetos. En el mundo interno de estos pacientes, y por lo tanto, en sus percepciones de su realidad interpersonal, uno es extremadamente poderoso y despiadado o uno está amenazado con ser destruido o explotado. Si las buenas relaciones objetos están en constante peligro de destrucción por parte de tales fuerzas malignas, pueden ser devaluadas debido a su debilidad implícita. De esta manera, la patología primitiva de Superego y la patología de las relaciones de objetos interconalizados se refuerzan mutuamente. Algunos pacientes en este nivel intermedio desarrollan un modo de comunicación completamente falso, cínico e hipócrita, un borrado de todos los juicios que implican una comparación de los objetos buenos y malos. Niegan la importancia de cualquier inversión en objetos como condición para maniobras exitosas en el caos de las relaciones humanas. Lo que podría llamarse la deshonestidad del "espectador inocente" reemplaza la identificación peligrosa con el tirano cruel. Cuando la detonación de la situación principal y crónica impregna la situación del tratamiento, se puede haber logrado una deshumanización defensiva de las relaciones de objetos, de modo que ya no exista un peligro de que el amor sea destruido por el odio o que el odio evocará

represalias devastadoras. Estas características se encuentran en un menor grado, pero, por la misma muestra, se pueden estudiar más fácilmente en pacientes con patología Superego más lejana, aquellos que presentan la falta de un sentido de responsabilidad por sus propias acciones. Aquí ha habido precursores de subrayos suficientemente idealizados disponibles para permitir al menos la auto idealización de un gobierno grandioso y una integración mínima de precursores sádicos e idealizados de superyo, en la medida en que se pueda mantener un sentido ordinario de la moral convencional. Estos pacientes, sin embargo, al fragmentar todas las implicaciones emocionales intensas con otras personas significativas, hacen que sus relaciones humanas sean sombrías o irreales, y están protegidas de los desarrollos paranoicos al eliminar por completo la "amenaza" de sus necesidades de dependencia y, con esa dependencia, por Demandas y prohibiciones, expectativas y anhelos, gratificación y frustración. De este modo, eliminan toda la intimidad humana. Paradójicamente, entonces, pacientes con personalidad narcisista, una inca-

Aspectos clínicos de la patología del superyó 287 Paridad para aceptar una sensación de continuidad en su responsabilidad y preocupación por los demás, pero sin deshonestidad manifiesta, combine una ausencia relativa de características antisociales con una ausencia notable de la capacidad de las relaciones de objeto en profundidad. El ego contradictorio y las características del superego como parte de la patología general de la frontera en general, se debe encontrar el siguiente nivel de patología del superego en la mayoría de los pacientes con la organización de personalidad límite, pero sin las características antiso-ciales y / o narcisistas mencionadas anteriormente. Estos pacientes son conscientes de los impulsos fuertes y contradictorios de que no puedan controlar. Expresan espontáneamente la preocupación de que en los Estados mentales contradictoria a la actual aceptable, pueden sentir o actuar de manera inaceptable a ellos ahora. Clínicamente, esta condición puede ilustrarse por parte de los pacientes con tendencias suicidas severas y disociadas que, sin embargo, se refieren a su potencial suicida y están dispuestos a pedir ayuda cuando se sienten amenazados por impulsos tan poderosos. La capacidad de estas pacientes para experimentar la preocupación por ellos mismos y para los demás y a tolerar los sentimientos de culpa cuando actúan agresivamente hacia aquellos que aman, indica tanto una etapa inicial de la internalización de las funciones de superEgo como una capacidad mucho más fuerte para la inversión emocional en otros, tanto los signos pronósticos favorables. La patología de Superego aquí es realmente parte de la patología general de la organización de la personalidad límite y refleja el predominio de las operaciones defensivas primitivas, una tendencia a disociar defensivamente y las presiones de superyo de proyectos como parte de la activación de los mecanismos de división general. Dichos pacientes pueden presentar un funcionamiento superficial que parece más caótico, contradictorio e inmaduro (en el

sentido de estar perpetuamente en la agitación emocional en sus relaciones de objeto) que el del nivel anterior de patología narcisista. Sin embargo, sus adjuntos aferrados a otros, sus intensas afectaciones contradictorias, señalan que han preservado una capacidad de las relaciones de objetos. En este nivel, los precursores de su superyo sádicos y idealizados están disponibles, y, aunque el funcionamiento del superego todavía puede disociarse en gran medida, ya existen funciones de superego más avanzadas relacionadas con la internalización de imágenes parentales más realistas en el momento de las etapas posteriores de Desarrollo edípico. Comportamiento antisocial que expresa la culpa inconsciente finalmente, con el logro de un nivel de desarrollo en el que se produce la asociación de los precursores de superyo sádico e idealizados contradictorios y con la consiguiente disminución de la reproyección de los primeros.

288 Regresiones severas en los precursores de su superego en las imágenes de edificación de los padres, la internalización de la tercera capa de formación de superyó. La internalización y la integración supraordinada del nivel edípico de funciones de superego permiten el desarrollo de la pafestología de suministro ordinaria en el paciente neurótico o del desarrollo normal de su superygo en general. Aquí, la calidad de las relaciones de objetos refleja la integración del concepto normal normal y de las representaciones de objetos internalizados. La abreviación de las características antisociales, el mantenimiento de un sentido individualizado de moralidad, la capacidad de las relaciones de objetos en profundidad, y la ausencia de narcisismo patológico se acompaña y refleja la presencia de un sólido, al menos parcialmente abstraído, individualizado y Estructura superonificada de Su- PEREGO. En estas condiciones, la promulgación del comportamiento antisocial refleja fantasías inconscientes específicas relacionadas con una presentación esencialmente masoquista a un suminario sádico pero bien integrado, la necesidad de expiación de la culpa inconsciente poco realista. El nivel final correspondiente de la patología del superego es la de los pacientes con una organización de personalidad neurótica y un superyo bien integrado pero excesivamente grave. Aquí, la culpa inconsciente de su superego, generalmente se refleja en varios tipos de inhibiciones y formaciones de síntomas y la represión de las necesidades instubes agresivas y / o sexuales en el contexto de conflictos predominantemente oedípicos relativamente Sin distorsionar condensación con características preeedipales. La mayoría de estos pacientes no presentan una patología específica del superego que no sea un predominio inconsciente de una moral infantil vinculada con una fijación sobre las producciones y demandas de edición previsa. Estos pacientes generalmente no presentan características antisociales; Son honestos y tienen un sentido de valores morales; Tienen una amplia gama de relaciones de objetos internalizados, integrados

integrados, también. Una integración normal del auto concepto reemplaza la integración patológica de un gobierno grandioso de la patología de caracteres narcisistas. En algunos casos, sin embargo, el comportamiento antisocial seleccionado puede reflejar la actuación de la culpa inconsciente. Estos son "delincuentes de un sentido de culpa" (Freud, 1916), que representan solo una pequeña proporción de pacientes con comportamiento antisocial. Característicamente, los pacientes con pafestología de superego a este nivel no presentan las reactacciones paranoicas severamente regresivas en la transferencia que uno encuentra en pacientes con comportamiento antisocial de los niveles de patología del superygo mencionados anteriormente. Un paciente a cargo de un laboratorio de investigación en las ciencias físicas tuvo una necesidad compulsiva de falsificar sus datos de investigación para que estén de acuerdo con los resultados que deseaba. Luego, porque se sintió tan culpable, repitió los mismos experimentos varias veces para asegurarse de que sus datos falsificados no eran confiables! En una ocasión, cuando sus hallazgos reales parecían apoyar sus hallazgos manipulados, no confiaba en ellos y tuvo que repetir los experimentos una y otra vez durante un período de tiempo excepciado. Los resultados netos fueron el riesgo de ser encontrado.

Los aspectos clínicos de la patología del superyó 289 y que tienen su carrera profesional destruida y una reducción dañina de su productividad. La sumisión inconsciente a una imagen de padre sádica y enviativa, que, en la mente del paciente, no pudo tolerar el éxito profesional del paciente, y la actuación de ambos éxitos como rebelde y deshonestidad, como una búsqueda de castigo, podría ser trabajado a través de un Periodo de análisis extendido. Este paciente no presentó otras características antisociales. Sufrió una forma de patología de subrayos circunscritos a un nivel de desarrollo de un superyo integrado en el contexto de la patología neurótica del carácter. La secuencia que he descrito sugiere las relaciones entre el desarrollo de Superógo y la patología narcisista, las tendencias paranoicas, la destrucción de las relaciones de objetos internalizados y el comportamiento antisocial. En los niveles más bajos de nuestro espectro, la calidad de las relaciones de objetos y la del funcionamiento del superego prácticamente coinciden; En los niveles intermedios de patología, las relaciones entre el desarrollo del superygo y la calidad de las relaciones de objetos se vuelven más complejas y variadas. Finalmente, al enfocarse en las vicisitudes de la psicopatología en el extremo severo del espectro de las distorsiones del superge, esta formulación debería fortalecer la opinión de que los procesos por los cuales se desarrolla el superyó y se extiende durante un período de tiempo mucho más largo. De lo que originalmente se asumió. Los desarrollos significativos de su superago normal o patológico se llevan a cabo desde el segundo y tercer año de vida en, precedentes y influyen crucialmente en la integración del superyódo de edificación y edípica. Otros desarrollos de Superego se producen en la adolescencia, así como, presumiblemente, en la vida adulta.

Capítulo 19: Regresión paranoica y narcisismo maligno Como ya he mencionado (ver especialmente el capítulo 12), los pacientes con personalidades narcisistas que están en proceso de resolución de las grandias patológicas que presentan complicaciones tan severas que el tratamiento puede estar estancado. O destruillado prematuramente. Debido a que el cuadro clínico es de una condensación de grandiosos y esfuerzos sádicos (una reflexión de un yo morizado patológico que se ha infiltrado con la agresión), llamo a este fenómeno narcisismo maligno. El narcisismo maligno se manifiesta en forma de distorsiones particulares en la transferencia, a veces desde el inicio del tratamiento, a veces se ha producido un cierto grado de regresión en la transferencia. En cualquier caso, el narcisismo maligno se caracteriza por cualquiera o todos los siguientes: (i) regresiones paranoicas en la transferencia, incluidos "episodios micropsicóticos paranoicos"; (2) autodestrucción crónica o suicidio como triunfo sobre el analista; (3) una deshonestidad mayor y menor en la transferencia; y (4) triunfo sádico manifestante sobre el analista, o la grandiosidad maigilosa. Descripciones clínicas Regresión paranoica Estos desarrollos paranoicos en la transferencia se caracterizan por la aparición en el paciente de la intensa sospecheza del analista, que puede asumir las cualidades y características delirantes y puede durar un segmento de una sola hora a varias semanas o (rara vez) meses. A supera la transferencia, el paciente no parece sufrir de regresión psicótica. Por el contrario, sus objetos de las relaciones con otros significativos a menudo parecen aclarar o adquirir cualidades idealizantes de separación.

Regresión paranoica y narcisismo maligno 291 En medio de tales episodios, es difícil para muchos pacientes continuar en el sofá. Tienen que sentarse y mirar al analista para no sorprenderse por él, para evitar ataques repentinos, y evitar lo que a menudo equivale a un control sádico de él como parte del dominio de los mecanismos proyectivos. En este contexto, he observado, en este contexto, el desarrollo de fenómenos alucinantes en la transferencia, como la percepción de los olores fecales, las distorsiones en la forma en que el paciente percibe al analista u objetos en la oficina y las distorsiones de lo que dice el analista. Los episodios paranoicos pueden desaparecer tan repentinamente como comenzó, sin ningún trabajo apreciable en la transferencia y con una reactivación concomitante de la grandiosa autoselosa en el paciente. De hecho, la falta de trabajo y resolver dichos epiodises paranoicos puede provocar una reorganización temporal de la grandiosa propia patológica y, al mismo tiempo, una transferencia de una transferencia de condenas paranoicas disociadas o disociadas sobre el analista de uno Episodio a la siguiente. Las quejas, por lo tanto, se acumulan y explotan gradualmente y pueden desarrollar periódicamente y eventualmente pueden conducir a la interrupción del tratamiento. Característicamente, estos episodios paranoicos comienzan repentinamente alrededor de una ambigüedad en la situación de tratamiento o en la actitud del analista, que el paciente interpreta de manera paranoide. Por medio de la identificación proyectiva, el paciente intenta inconscientemente inducir en la animosidad, el odio, la deshonestidad o la manipulación del que el paciente ahora lo acusa. Estas regresiones paranoicas deben distinguirse de ataques intensos de rabia (rabia narcisista), que los pacientes narcisistas comúnmente se divienten cuando se frustran en sus necesidades narcisistas, y de las reacciones de transferencia fuertemente negativas con las características paranoicas que pueden Evolucionar en las etapas tardías del análisis de los pacientes con todo tipo de patología de caracteres

cuando surgen niveles profundos de formaciones de superego en la transferencia. A diferencia de los pacientes neuróticos ordinarios, los narcisistas malignos que sufren dichas regresiones paranoicas carecen de la capacidad de continuar confiando en el analista en medio de los temores paranoicos en la transferencia. Autodestrucción Como triunfo sobre el analista, esta constelación clínica se caracteriza por un comportamiento físico o emocionalmente autodestructivo cuando el paciente, en la transferencia, se experimenta como amenazado en su "equilibrio de poder" actual con el terapeuta. En contraste con el comportamiento autolesurador o suicida cuando el paciente ha experimentado un rechazo real, un síntoma presentado por muchos pacientes límite, incluidos aquellos con personalidad narcisista, aquí la autodestructividad se desencadena por un desafío para los pacientes conquistados o Fantasías inconscientes de la grandiosidad o poder. El paciente

292 Severas regresiones La determinación de tomar una acción autodestructiva refleja no simplemente "la rabia se volvió contra el yo", sino, típicamente, una actitud calmada, determinada, incluso eufórica. A veces hay disfrute consciente de la idea de "engañar" al terapeuta, un placer casi sádico en preparaciones ocultas para actos autodestructivos. Por ejemplo, un paciente quemó gravemente sus brazos, y, mientras asistía a sesiones de psicoterapia con ropa con mangas largas para cubrir sus heridas profundas y festionadas, le dijo alegremente al terapeuta qué tan bien estaba sintiendo. A menudo, el paciente espera la consternación del terapeuta, la sensación de impotencia, la preocupación y el miedo por la vida del paciente como la confirmación más fuerte de su triunfo sobre el terapeuta. La característica más prominente de estas tendencias autodestructivas es el sentido del poder de las experiencias del paciente en relación con el ANA -STA. El paciente se vuelve víctima y victimador en uno; Puede adquirir una sensación de libertad del miedo, así como un sentido de triunfo sobre el ansidente (a quien percibe, pero impotente ante el comportamiento autodestructivo del paciente). Esta constelación autodestructiva plantea la cuestión del diagnóstico diferencial de varios tipos y grados de masoquismo. En un sentido clínico, la patología de caracteres masoquistas y las correspondientes desarrollos de transferencia masoquis y correspondientes pueden clasificarse en un espectro de concentraciones, desde lo más benigno hasta el más maligno. En un extremo, encontramos los casos de masoquismo moral correspondientes a sentimientos de culpa inconscientes, y el desarrollo de reacciones terapéuticas negativas que se reflejan a la culpa tan inconsciente en la transferencia. Estos pacientes usualmente tienen características de personalidad depresivas y masoquistas y una estructura intrapsíquica tripartita bien integrada; Incluso durante la actuación masoquista, las tendencias autodestructivas son al menos en parte ego distónico. Un segundo nivel de patología de caracteres masoquistas y los

desarrollos correspondientes en la transferencia se reflejan en la estructura de la personalidad sado-masoquista y en las transferencias en las que existen alternaciones entre el comportamiento sádico y el comportamiento masoquista y los rasgos de carácter contradictorios, a veces reflejando la identificación con el Agulación y a veces el auto-castigo sin sintón ego como una expresión de ataques de recaudación de culpabilidad no conscientes en el atacante sádico ahora proyectado. Las desviaciones sexuales masoquistas generalmente corresponden a uno de estos dos niveles de estructura de personalidad masoquista, al igual que muchas perversiones sadomasquísticas. A un tercer nivel de severidad de las tendencias autodestructivas, encontramos reacciones terapéuticas negativas como una expresión de envidia inconsciente del analista, un desarrollo prevalente dentro de las transferencias de pacientes narcisistas que requiere atención a largo plazo y trabajando, pero esencialmente no es un Aspecto del narcisismo maligno. Aquí, sin embargo, el término masoquismo ya no se aplica como un auto-castigo destinado, deseado. Por el contrario, el comportamiento contraproducente es un subproducto de la necesidad del paciente de evitar la envidia del terapeuta útil.

Regresión paranoica y narcisismo maligno 293 En el nivel más severo de autodestructividad, encontramos la tendencia a la identificación inconsciente con una imagen parental primitiva y sádica, en la que el suicidio o la autoinstilación adquiere la función de la expresión libre de La agresión, un sentido del control total sobre el destino de uno, y el castigo vengativo de un objeto (analista) que difiere o amenazaría el objeto sádico primitivo con quien se identifica al paciente. Además, a este nivel la destrucción de fantasía o la desaparición del yo se vuelve equivalente al poder sobre la persistencia o la desaparición de todo el mundo. Aquí, el Ser Patológico Grandioso, identificado con un objeto agresivo triunfante, triunfante, triunfante, refleja la condensación de la libido y la agresión a su nivel más maligno y revestido. Cualquier amenaza percibida para el control omnipotente del Ser sádico grandioso debe responderse con la destrucción de esa amenaza: básicamente, la función de conservación de la vida y la vida útil de la vida del terapeuta. Finalmente, en relación con estas características verdaderamente malignas de la autodestructividad como un rasgo de carácter activado en la transferencia, también puede haber un brillo de esperanza de que el analista rescate al paciente desde la muerte y la autopruimiento. Es este nivel más profundo de autocremmacia, la promulgación de una identificación con una representación de objetos primitivos, sa-distérica, que se vuelve predominante en la transferencia de algunos pacientes con narcisismo maligno. La señorita W. Una personalidad narcisista y el alcoholismo crónico expresaron continuamente la rabia contra aquellos que no fueron criados a medida que estaba en lo que experimentaba como el mundo helado de extremadamente ricos, aliadamente no disponible, a pesar de los padres, a pesar de los padres, interesados solo en el Comportamiento de la superficie del paciente y sus hermanos, no en sus sentimientos o bienestar emocional. La señorita W, de alta inteligencia y un atractivo atractivo físico, los hombres tratados con crueldad y se ahogaron en Alco, cuando sus

intolerables anhelos por amor vinieron a la superficie. En la transferencia, a veces me percibía como una edición más de una imagen parental poderosa e indiferente, que combinaba las características de ambos padres y contra las que sentía una rabia intensa. A veces, ella me miraba como un terapeuta auténticamente amable y agradable, pero incompetente, incapaz de empatizar completamente con su sufrimiento o para soportar sus poderes destructivos. A un nivel más profundo, fue extremadamente resentida de la posibilidad de que pueda vivir en un mundo no contaminado por las terribles experiencias de su propio mundo. Desde el principio, la señorita, me advirtió triunfalmente que el tratamiento estaba destinado a fallar. Mi voluntad de continuar a pesar de los episodios de actuación severa que involucre el abuso de alcohol, así como el otro comportamiento autodestructivo, solo reforzó sus puntos de vista de mí. A pesar de su actitud crónica congelada, altiva y al margen, me transmitió un sutil pero presionando la esperanza de que no me rendiría, que la rescataría a pesar de ella misma. La grandiosidad manifiesta y la actitud despectiva hacia mí, sin embargo, fueron altamente efectivos para distorsionar la NA-

294 Severas regresiones de nuestra relación, de modo que se tuvo que ocupar mucho tiempo con claridad la naturaleza compleja de sus estrategias autodestructivas y tratar con sus esfuerzos interminables para socavar el tratamiento al movilizar a los familiares y otros profesionales para preguntarme. La señorita W finalmente se transfirió a otro psiquiatra directamente después de un intento suicida que apenas se administra para sobrevivir. Ese tratamiento, a su vez, se interrumpió unos meses más tarde, y el paciente salió de la ciudad. Otro paciente, el hijo de un prominente cirujano, sufrió una forma recurrente de cáncer de piel y sintió que un triunfo que se convirtió en causa de mi inconsciencia, por un período de varias semanas, que el crecimiento candidicentemente había reaparecido en su piel y que había logrado ocultar esto de un médico examinador. Aún otro paciente, una ilustración típica de los intentos de suicidio crónico como una "forma de vida", tuvo el siguiente sueño poco antes de un intento de sui- cida importante. Soñó que era la asistente del director de un asilo de ancianos que había invitado a todos los familiares de sus ancianos a una parte a una parte que se celebrara en otro lugar. Después de alejarse de la amabilidad y la tacto extrema, el director, con la asistencia del paciente, reunió a todos los presos en un área cerrada y pareada y se acercó a los gastos. En las asociaciones a este sueño, se convirtió en aparición de que el paciente se identificó simultáneamente con el director asesinado del asilo de ancianos y con los reclusos victimizados. La deshonestidad en la transferencia. Me refiero aquí al paciente que, en una determinada etapa de tratamiento, retiene información importante del terapeuta para que su subenda de la situación de la transferencia y de la vida del paciente deba verse afectada. Me referí a estos casos en el Capítulo 18 al describir la deshonestidad mayor y menor en la transferencia, incluidos los casos relativamente menos graves de negación de la responsabilidad por las acciones de uno. La mayor y crónica, la honestidad, en particular, aumenta la cuestión de

si está presente el narcisismo maligno. Pero algunos pacientes combinan aspectos "menores" de suicidios crónicos deseos con un incumplimiento de la responsabilidad de sus acciones y formas sutiles de deshonestidad; El resultado asciende al narcisismo maligno en la transferencia. Un paciente con tendencias suicidas crónicas habían estado reflexionando en voz alta sobre su reciente libertad de deseos suicidas. Esto me hizo preguntarme si esas referencias casuales podrían ser herederas un nuevo intento de suicidio. Pregunté si estaba segura de que no tenía deseos suicidas en este punto y si debemos considerar una vez más la posibilidad de que ella necesite ayuda adicional para evitar que actúe sobre tales deseos.

Regresión paranoica y narcisismo maligno 295 El paciente declaró categóricamente que no estaba de humor suicida y me aseguró que no había riesgo de que ella intentara suicidarse. Dije que su estado de ánimo se había movido rápidamente en otras ocasiones; ¿Estaba segura de que ella no actuaría por suicidio desea que su estado de ánimo vuelva a cambiar? Una vez más, ella me aseguró que ella no llevaría a cabo ningún gesto suicida en su estado de ánimo actual. Pero, agregó, por supuesto, su estado de ánimo podría cambiar, en cuyo caso, su seguridad para mí, naturalmente, ya no sería válida. Aquí, la falta de un sentido de preocupación y responsabilidad por sí misma y los conflictos subyacentes que involucran a la agresión disociada surgieron directamente en la transferencia. Fue muy difícil apuntar a la agresión implícita hacia mí, así como hacia ella en este caso. Primero, yo había liberado de estar impresionado por la lógica incuestionable de su declaración. En este caso, un largo análisis de su devaluación de mi preocupación por ella tuvo que preceder a la exploración de su devaluación, lo que reflejó en el nivel más profundo de su identificación con una imagen materna "superior" e indiferente. Expresión directa del triunfo sádico sobre el analista Este comportamiento incluye la rabia consciente, ego-sintónica y la devaluación del terapeuta acompañado de una sensación de triunfo sobre él, ya que su respuesta es experimentada como menos sádica que el paciente. El paciente puede insultar al terapeuta en muchas sesiones, y el sentido del ego-sintónico de certeza y seguridad con el que trata al terapeuta como un idiota incompetente puede convertirse en muy gravalos. Los aspectos sádicos de esta devaluación pueden incluir amenazas de violencia u otras formas de agresión psicológica. Esta constelación también puede ser designada la grandiosidad maligna: un triunfo omnipotente sobre el analista durante un período prolongado de tiempo reafirma la seguridad del propio GRANDOSOSE PATHOLÓGICO del paciente, ex presiona la devaluación y la venganza contra el mundo amenazador. De las relaciones de objetos

internos externalizados con éxito en el analista, y a menudo se acompaña de deshumanización extrema en la transferencia. Esta característica se encuentra en un espectro de pacientes, de la personalidad antisocial propiamente dicha a ciertas personalidades narcisistas con características paranoicas y anémicas. Estos pacientes presentan tendencias de desperdicio muy fuertes, sin sintonía con el ego y un sadismo bien racionalizado en sus relaciones con los demás. La mentira suele ser menos un problema; De hecho, estos pacientes se detienen a una afirmación arrogante o sádica de su comportamiento antisocial. Los adictos a las drogas con esta personalidad característica experimentan un sentimiento de superioridad tan pronto como la droga les libera de la difería en otros o de las gratificaciones controladas "externamente". Como dije al comienzo de este capítulo, el narcisismo maligno.

296 Las regañaciones severas pueden manifestarse en la transferencia, ya sea desde el inicio del tratamiento o después de un cierto período de tiempo, lo que refleja una regresión en la transferencia. Esta observación puede estar relacionada con el diagnóstico diferencial de las constelaciones más severas de la infiltración agresiva de la GRANDIACIÓN AUTO, es decir,: (i) la personalidad antisocial propiamente dicha; (2) pacientes con desviaciones sexuales o perversiones que incluyen comportamiento sádico y abiertamente potencialmente mortal; (3) personalidades narcisistas con tachuelas de rabia sin sintonía ego, características antisociales o tendencias paranoicas; y (4) Personalidades narcisistas con características abiertamente limítrofe. Este diagnóstico diferencial es importante porque las dos primeras categorías suelen ser inmejorables por la psicoterapia expresiva y presentan el síndrome del narcisismo maligno al principio. Todas las demás personalidades narcisistas, que pueden desarrollar narcisismo maligno en etapas posteriores de su tratamiento, tienen un pronóstico mucho más favorable. La personalidad antisocial presenta, además de un trastorno típico de la personalidad narcisística, comportamiento antisocial crónico, incapacidad para experimentar la culpa o la preocupación, la explotación despiadada de los demás por medios parásitos o vio-lentes, Intolerancia a la ansiedad y falta de un sentido realista de tiempo. El pervertido sádico presenta un comportamiento sádico manifiesto, ya sea vinculado a otras actividades sexuales o no, que es intensamente emocionante y gratificante y abiertamente violenta y peligrosa para la integridad física de otras personas. Tales casos no experimentan culpabilidad ni remordimientos por su comportamiento fuera de los episodios sádicos, como lo fue cierto de un joven que venció a las mujeres y le lanzó ladrillos de los tejados cuando se emocionó sexualmente. Categorías (3) y (4), además de no cumplir con los criterios para catterías (I) y (2), presente a primera clase grandiosa y despectiva. Estas características, sin embargo,

sobre la exploración y la confrontación, resultan ser ego-distónico y conflictivo. El surgimiento de estos pacientes de tipos de grandiosidad más malignos en el tratamiento refleja una regresión de transferencia que es pronósticamente grave, pero menos que la grandiosidad sádica totalmente ego-sintónica que es evidente desde el comienzo del tratamiento. La capacidad del paciente para establecer una relación dependiente con otras personas mejora la implicación pronóstica de este síndrome. Ya he descrito casos con estas características, que van desde la personalidad antisocial no tratable hasta la personalidad narcisista con el comportamiento antisocial ego-sintónico (ver capítulo 18); El narcisismo maligno y la patología de Superego de Seaverego van de la mano. Consideraciones teóricas en circunstancias óptimas, en etapas avanzadas del tratamiento de las personalidades narcisistas, uno observa una oscilación entre períodos de idealización y transferencias abiertamente negativas, en el contexto de las cuales

Regresión paranoica y narcisismo maligno 297 Las relaciones de objeto mutuamente disociada, idealizadas y persecutorias se integran gradualmente. Formas primitivas de idealizaciones basadas en la autoeficiencia y la división de la idealización del cambio de agresión a ideas más maduras que son formaciones de reacción contra la agresión y contienen elementos de culpa. Las transferencias predominantemente negativas ahora reflejan conflictos condensados edípicos y preeedipales con imágenes de padres tempranas. La integración gradual de estas transferencias hostiles e idealizadas permite la integración de un yo normal y una consolidación de la identidad del ego, y amplía la capacidad de mantener las relaciones de objetos en profundidad, lo que también restablece la capacidad de dependencia normal. En la mayoría de los pacientes con personalidad narcisista, a pesar de la absorción prevaleciente de los precursores de superyo idealizados en el Multido de Superego en el Ser Patio-Lógico, un remanente de los precursores de su superyo idealizados se reinician fuera de la grandiosa propia. Este remanente se condensa con precursores de superyo sádicos anteriores, lo que lleva a su neutralización mutua. La integración de estos precursores facilita la internalización y cierto grado de integración de las imágenes de los padres más realistas relacionadas con las etapas de edificación posteriores, lo que pone la base de las funciones de suminOgo que permanecen disponibles a pesar de que el propio propio grandioso patológico predomina como el principal regulador de la autoestima. Estos pacientes como regla no desarrollan el síndrome de narcisismo maligno en las etapas de la regresión de la transferencia. Comparando estos desarrollos relativamente benignos en las etapas avanzadas del tratamiento de las personalidades narcisistas con los desarrollos malignos detallados en la sección anterior, se sorprende a la naturaleza central de la patología del superego en los casos malignos. Todos los pacientes con las regresiones malignas en la transferencia descrita en el suminito de la transferencia de

Superego Lacunae (Johnson, 1949), o la ausencia de un sentido de la moralidad de un dinólogo. En contraste, las personalidades narcisistas en fases avanzadas más benignas muestran cierta capacidad para la idealización que no está vinculada a la auto-idealización, para la inversión y la preocupación por sus relaciones con los objetos, y para el mantenimiento de un sentido ordinario de moralidad. Propongo que el narcisismo maligno ilustre un profundo nivel de patología del superopero caracterizado por (i) la ausencia de precursores de superyo idealizados (derechos idealizados e objetos idealizados que normalmente constituyan el ideal primitivo del ego) que no sean aquellos en- Teguated en el Ser Patológico Grandiose; (2) el predominio del nivel más temprano de precursores de sudiciones sádicos, que representan, debido a su poder excesivo, las únicas representaciones de objetos internalizados confiables disponibles; y (3) la consolidación intrapsíquica de un status quo en fantasía que permite la supervivencia cuando las únicas representaciones de objetos confiables disponibles parecen ser de enemigos sádicos. Si esta formulación es precisa, los casos de personalidad narcisista con

298 Regresiones graves El narcisismo maligno en la transferencia iluminaría el núcleo mismo del complejo edificio constituido por las capas sucesivas de la integración de Superego originalmente descrita por Jacobson (1964). En todos estos casos, la resolución psicoanalítica de la grandiosa autopista patológica se basa en la ausencia de precursores de subrayos idealizados subyacentes (excepto aquellos que se absorbieron en el propio yo patológico) y el predominio no pospuesto de no neutralizado., Precursores de superyo sádico, que expresan una condensación de agresión preeedipal y edípica de manera no mitigada. En ese momento, es, como si ambas, invertidas libbidas, y las autorrepresas injustificadas, estuvieran reforzando el predominio de estos precursores de superyo sádico. La muy fragilidad de las autoridades invertidas libbidas en presencia de los precursores de superyo agresivos y dominantes que dominan el peligro de la destrucción de lo que no se ajusta o incorporado por el sadismo intrapsy chico dominante. Esto es, podríamos decir, una versión de lo que una persona normal experimentaría en la pesadilla del mundo de Orwell's 1984. Las agresivas autonimpresentaciones confirman, en presencia de estos precursores sádicos de superpago, que todas las interacciones humanas significativas y confiables son de naturaleza agresiva.. La cuestión de la etiología de estas retrocesiones de transferencia y del narcisismo maligno en general se responde más fácilmente en un contexto clínico que en un marco teórico. Los esfuerzos del analista para resolver las transferencias narcisísticas en el presente y ahora, para explorar los significados inconscientes de la transferencia del paciente como primer paso antes de la pregunta "¿De dónde viene todo esto?" Se puede elevar, representar una puerta segura para el inicio del trabajo constructivo y reconstructivo. El paciente, como he enfatizado en el Capítulo 12, tiene que modificar sus puntos de vista rígidos sobre el presente antes de que esté listo para reexaminar sus mitos rígidamente relacionados con su pasado a la luz de un nuevo

material emergente en la Asociación Libre. Teóricamente, estas transferencias reflejan las vicisitudes de la formación de suministro temprana defectuosa y la falta de consolidación de las relaciones totales de objetos en el contexto de la integración de la identidad del ego. La pregunta, entonces, puede formularse de la siguiente manera: qué experiencias reales y / o fantásticas y / o qué defensas contra ambas son responsables de una transformación ma-lignita del mundo de las relaciones de objetos que conduce a la devaluación y la esclavitud sádica de la esclavitud potencialmente buena. Relaciones de objetos internalizados por parte de un yo integrado, pero cruel, omnipotente y "loco" (Rosenfeld, 1971). El grandioso patológico y el auto sádico reemplaza a los precursores sádicos del superyó, absorben toda la agresión, y transforma lo que de otra manera serían componentes sádicos sádicos en una estructura anormal que luego se exhibe contra la internadera. De más tarde, componentes más realistas de su superego. Sugiero muy tentativamente que algunos o todos los aspectos de los siguientes

Regresión paranoica y narcisismo maligno 299 El escenario del pasado del paciente está involucrado aquí: (i) la experiencia de objetos externos como omnipotentes y cruel; (2) una sensación de que cualquier relación buena, amorosa y mutuamente gratificante con un objeto es frágil, destruida fácilmente, y, aún peor, contiene las semillas para el ataque por el objeto abrumador y cruel; (3) una sensación de que la presentación total a ese objeto es la única condición para la supervivencia y, por lo tanto, todas las vínculos con un objeto bueno y débil deben cortarse; (4) Una vez que se logra la identificación con el objeto cruel y omnipproteciente, un sentimiento emocionante de poder y disfrute, de la libertad del miedo, el dolor y el temor, y la sensación de que la gratificación de la agresión es el único modo significativo de relacionarse con los demás; y (5) como alternativa, el descubrimiento de una ruta de escape por la adopción de un modo de comunicación completamente falso, cínico o hipócrita, un borrado de todo juicio que implica una comparación entre los objetos buenos y malos, y la negación de la importancia de cualquier relación de objeto o exitosa. Maniobras en el caos de todas las relaciones humanas. En esta última instancia, la posición deshonesta del espectador inocente reemplaza la identificación danerosa con el cruel tirano o la sumisión masoquista a él. Todos estos peligros, rutas de escape y concepciones aterradoras de la realidad humana representan un deterioro dramático y extremo en las relaciones de objetos internalizados. La condensación de derivados de accionamiento sexual y agresivo de estos pacientes es similar a la del espectro límite. Las fantasías sexuales de estos pacientes son sorprendentemente similares a las de los pacientes con perversiones sexuales. Hay una agresividad consistente de todos los deseos sexuales. La penetración genital se vuelve equivalente a destruir los genios o al llenado de cavidades del cuerpo con excremento. El pene como fuente de veneno invadiendo el cuerpo es la contraparte para nomplamente no disponible los senos que pueden

incorporarse solo por la destrucción canibalista. La falta de diferenciación de los objetivos sexuales, de modo que los fanáticos orales, anal y genitales se condensan y simultáneamente expresen impulsos y amenazas de todos los niveles de desarrollo psicosexual, corresponde a una deducción paralela de las características sexuales de las características sexuales de Hombre y femenino, para que los impulsos homosexuales y heterosexuales se mezclen caóticamente. Estos pacientes presentan lo que Meltzer (1973) ha llamado las características de "confusiones zonales" y "transferencia perversa". La promiscuidad sexual puede defenderlos de una profunda participación con una pareja sexual que los amenazaría con la irrupción de la violencia incontrolable. Estos pacientes también presentan "analización", la regresión sádica de todas las relaciones de objetos tienden a negar la diferenciación sexual y generacional (descrita por Chasseguet-Smirgel, 1978), en la que las relaciones de objetos se "digieren" al estado de las heces indiferenciadas "" En esta formulación, los síndromes del narcisismo maligno pueden entenderse como soluciones de compromiso alternativas a este estado intrapsíquico dramático asumido. Las regresiones paranoicas se pueden ver como los intentos del paciente de identificar

300 regañaciones severas tifican con sus propios precursores sádicos sádicos como una alternativa a ser atacados, humillados, destruidos y explotados por estos mismos precursores proyectados en el analista. De la misma manera, su desesperada súplica de que el analista no se renove con tales distorsiones sádicas, que demuestre la bondad y la confiabilidad, a pesar de la agresión del paciente, refleja una búsqueda de un remanente de un buen objeto relación. Cuando el paciente es crónico autodestructivo y suicida en un intento inconsciente de triunfar sobre el analista, se ha producido un proceso más maligno. El paciente ha internalizado el conflicto paranoico (externalizado bajo la regresión paranoica) y, mediante una refusión regresiva en la fantasía, ha obtenido una identificación primitiva con el agresor simultáneamente con la promulgación del papel de una víctima. Las autoinstilaciones de los pacientes y los ataques suicidas desesperados no solo son un triunfo sobre sus necesidades, sino que también representan la libertad del miedo por la identificación con el agresor y produce un sentimiento profundamente gratificante de estrecho y pertenencia al unirse al agresor como víctima. Este tipo primitivo de masoquismo se ve al final de 1984 de Orwell en el amor de la víctima torturada por el sádico "hermano mayor", que finalmente destruirá su vida. La autodestrucción de la autodestrucción del paciente es un acto de desafío y desafío a la capacidad del analista para enfrentar la agresión tan masiva. El conocimiento puede tener que demostrar su poder de supervivencia antes de su capacidad de amor y su confiabilidad. Es típico de estos desarrollos de transferencia que la interpretación de suicidio desea como un ataque al analista disminuye las presiones suicidas y desenmascara la intensa rabia hacia él. Con la deshonestidad mayor y crónica en la transferencia, se ha producido una deshumanización defensiva de todas las relaciones de objetos, de modo que ya no existe un peligro de que el amor sea destruido por el odio o el odio que evoca represalias devastadoras. La mecanización de todas las

relaciones de objetos, la retirada de las inversiones emocionales profundas en la emoción puramente erótica y agresiva, elimina los peligros que se experimentan plenamente en los otros modos de defensa. El poder de los primeros primeros sádicos se ha desmantelado eliminando la dependencia por completo, eliminando las expectativas y los anhelos, la gratificación y la frustración, y, de hecho, la intimidad. Jacobson (1971) ha señalado la necesidad del paciente paranoico de traicionar, lo que refleja una repentina reversión a una rebelión agresiva de la sumisión masoquista a un temido enemigo. Estas revocaciones aparecen en la historia de algunos pacientes paranoicos y se repiten en la transferencia. Finalmente, la identificación consciente con un agresor sádico auto-justicia niega la existencia de todas las necesidades de las relaciones de dependencia y objetos, de toda responsabilidad y preocupación por sí mismo, y refleja tanto a la corrupción de todas las relaciones de objetos como de un tipo primitivo de Identificación con el agresor. En casos extremos, esto transforma la puramente narcisista en la personalidad antisocial. Clínicamente, he observado

Regresión paranoica y narcisismo maligno 301 (Kernberg, 1975) que, si bien muchas personalidades narcisistas presentan características antisociales (y esto empeora su pronóstico) / todas las personalidades antisociales presentan las características de la personalidad narcisista. Estructura más la destrucción particularmente grave de sus funciones de suupogo. En resumen, entonces, estoy proponiendo que el desarrollo de un grandioso propio patetoso empobrezca significativamente la función de su superyego normal porque los precursores de superyo idealizados se incorporan a este Ser Patológico Grandioso. Este desarrollo deja a los precursores sávegos sávegos no descreídos y claramente predominantes y fomenta su proyección en forma de rasgos de personalidad paranoicos como alternativa a una consolidación de suministro con un sadismo excesivo de autodirigido. Indica circunstancias óptimas, ciertos precursores de superego idealizados permanecen disponibles para la neutralización de los precursores de su superyo sádico y permiten la internalización de los niveles posteriores de los introjectos de sumin0, lo que determina la capacidad de la moralidad ordinaria y la protección de la capacidad de cierto grado de un grado de mayor. Relaciones con objetos ordinarios, dependencia y preocupación, con un sentido de responsabilidad personal. Cuando, en las personalidades narcisistas, los conflictos graves en torno a la agresión temprana resultan en precursores superyográficos abrumadores. Estos restos de funciones de superegocio neutralizado fallan; La moral ordinaria y, con ella, la capacidad de preocupación, la responsabilidad y los sentimientos de culpa sufren. Al mismo tiempo, dado el abrumador poder de las relaciones de objetos internalizados sádicos, la condensación del ser grandioso con agresividad compensa la debilidad potencial y la fragilidad de todas las relaciones de objetos idealizados, y el aprensivo patológico se vuelve poderoso y sádico y Consolida la corrupción general de los sistemas de valores internalizados. Hay un paralelo entre la disponibilidad de alguna inversión en las

relaciones de objetos, al menos la esperanza de la posibilidad de amor, y la ausencia de los aspectos más malignos del deterioro del superego reflejado en características antisociales. El deterioro severo y la corrupción de las relaciones de objetos primitivos y de los restos de una capacidad de funciones de superygo van de la mano; De hecho, estas condiciones se reinician íntimamente en sus orígenes. En consecuencia, se puede considerar la búsqueda por parte de algunos pacientes para un sentido primitivo de bondad, felicidad, cumplimiento y bienestar a través del alcohol, las drogas o los tipos de sexualidad fragmentados para contener la semilla de lo que podría convertirse en una búsqueda del amor, en contraste con el frío. Calidad deshumanizada, vengativa y destructiva del psicópata. Sin embargo, al mismo tiempo, para algunos pacientes, el propio propio grandioso patológico puede proporcionar una estructura intrapsíquica más adaptable que las tendencias graves paranoicas o primitivamente masoquistas, a partir de las cuales dicha estructura las protege. Hay algunas personalidades narcisistas cuyos seres de grandiosidad patinales no deben analizarse; Más bien, se debe intentar un tipo de apoyo de apoyo orientado para mejorar la adaptación a sí mismos y a su realidad psicosocial.

302 PRESULTAS GRAVES Consideraciones técnicas Muchas de las consideraciones técnicas que siguen pueden incorporarse en psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica; Otros reinician la introducción de los parámetros de la técnica que hace que sea la posibilidad de mantener un marco psicoanalítico. Cortar todos los tipos de narcisismo maligno en las regresiones de transferencia descritas anteriormente, los problemas básicos con respecto a la probabilidad de resolución terapéutica de estas regresiones incluyen los siguientes: (i) la capacidad restante del paciente para mantener una relación dependiente con el psicoanalista, (2) la capacidad del paciente para tolerar el mantenimiento de una situación psicoterapéutica o psicoanalítica cuando predominan las transferencias negativas fuertes, y (3) la disponibilidad de los acuerdos de tratamiento que protegen de manera realista al paciente de una actuación severamente destructiva o autodestructiva. Que podría poner en peligro no solo la continuidad del tratamiento sino la vida útil del paciente (o incluso el psicoanalista). Desde un punto de vista práctico, la tarea más urgente para enfrentar las regañaciones malignas en la transferencia es limitar las acciones destructivas o autodestructivas del paciente. Es importante que el analista pueda trabajar sin temor a los asaltos físicos. Al igual que en el tratamiento de la Oficina de los pacientes psicóticos, la primera tarea del analista es asegurar un descenso realista de seguridad para el paciente y en lugar de asumir omniperentemente que puede manejar la situación que pueda surgir. La autodestructividad física aguda debe estar suficientemente bajo control para que el analista tenga un campo libre para la intervención interpretativa. Lo mismo ocurre con los pacientes cuyo comportamiento agresivo puede amenazar la vida o el bienestar de los demás. Un paciente cuyo comportamiento incluye, por ejemplo, el control de su entorno improvisado por amenazas físicas repetitivas en el punto de pistola debe remontar este comportamiento antes de que su significado pueda entenderse y

trabajar. Esto no significa que el analista comience a otorgar oremos al paciente, pero que él discuta con el paciente los motivos de la necesidad de controlar este comportamiento. El terapeuta debe dejar claro que dicho comportamiento debe estar firmemente bajo control como condición para continuar con el tratamiento. El análisis de esta dramática desviación de la neutralidad técnica puede y debe seguir adelante. Con los pacientes que sufren de anorexia nerviosa, por ejemplo, es indispensable que se logre un peso óptimo y mantenido antes de que se realice la exploración psicoanalítica de los conflictos subyacentes. Un segundo nivel de prioridad es el análisis de mentira crónica. Mientras la comunicación verbal se utilice principalmente para destruir una relación honesta entre el paciente y el terapeuta, todo lo demás tiene que esperar. Tal se debe aclarar, confrontado y resuelto, analíticamente, si es posible,

Regresión paranoica y narcisismo maligno 303 o por medio de control social externo y confrontación constante (que generalmente indica la necesidad de psicoterapia de apoyo). El análisis consistente de Dishanjsty como un problema importante, la transferencia, la transferencia conduce de forma frecuente a su resolución gradual en el contexto de la reactivación de las reactivaciones subyacentes paranoicas, primitivamente masoquistas o corruptas, involucradas. Un tercer nivel de prioridad es el análisis de la incapacidad crónica del paciente para depender realmente del analista. Esta es la capacidad más típica de la transferencia en el caso de las personalidades narcisistas, a las que me he referido más extensivamente antes (CHAP. 12 y 17). La característica más destacada de la activación de la grandiosa propia infiltrada agresiva es la necesidad de destruir el analista psicológicamente: sus interpretaciones, su creatividad, sus valores como un buen objeto autónomo, y sus posesiones. Las motivaciones inconscientes para que las necesidades implacables destructivas incluyen la envidia del analista como un objeto que nutre un objeto, típico de las personalidades narcisistas en general, y, más allá de eso, la envidia del analista por no ser víctima de la misma patología que el paciente. La conciencia aguda de que el analista puede ser capaz de alegría que su propia vida se vuelva intolerable para el paciente encarcelado por su propio yo distoso y grandioso. Además de actuar fuera de la envidia inconsciente y consciente, estos pacientes, al tiempo que prometen su gobierno grandioso y sádico en la transferencia, pueden proyectar inconscientemente en el analista los restos de su auto, infantil, infantil, potencialmente dependiente, como para Caja de seguridad. Esta es una repetición en la transferencia del encarcelamiento intrapsíquico y el ataque sádico en la parte saludable de su ser infantil por la parte patológica grandiosa, sádica. La misma proyección para el mantenimiento de seguros inconscientes también puede involucrar a los restos de sus buenas representaciones de objetos. Un paciente me

describió una nueva novia para mí. En contraste con varias mujeres que había mencionado anteriormente, esta chica sonaba más real, y podría visualizarla más claramente; También la experimenté, a través de su nariz, tan decente y agradable. Cuando señalé este cambio en la naturaleza de su descripción, el paciente inmediatamente e irónicamente descaliciado lo que dije, agregando triunfalmente que ya estaba perdiendo interés en la niña. Durante las próximas semanas, experimenté un sentido de luto por la pérdida de su relación con esta mujer. Levanté la pregunta con el paciente, ya sea que podría estar tratando de inducirme en mí, un sentido de luto por una relación que no se atrevió a experimentar. Esta interpretación fue recibida primero con sonrisas despectivas y, finalmente, con la acusación de enojada de que, a mi manera, estaba tratando de hacerle sentir culpable. Sin embargo, varias semanas después, el paciente pudo aceptar su propio arrepentimiento y culpa por su tratamiento de esta mujer, a quien ahora reconoció como muy valioso. El tipo de esfuerzo más frecuente para destruir la interpretación del analista.

304 severas regresiones severas, su seguridad interna y su creatividad como un terapeuta que el paciente se expresa implacablemente el proceso analítico, las compasiciones crónicas de que el tratamiento no está ayudando, que el analista no está diciendo nada nuevo, y así sucesivamente. Mientras se devaluora simultáneamente de manera rápida y perentoriamente cualquier interpretación posterior que el analista podría ofrecer. El paciente puede despedir repentinamente el trabajo interpretativo cuidadoso realizado durante un período de muchas sesiones. Lo que es más característico y llamativo es que en tan momentos de despido, que al paciente son aparentemente ilustraciones de la falla del analista, el paciente parece feliz y triunfante. De hecho, es esta expresión de triunfo después de reducir las interpretaciones del analista, en un fuerte contraste con las quejas crónicas de que no se presentan nuevas intervenciones del analista, que proporciona la clave a la función inconsciente del sentido del paciente de que no es siendo ayudado Si el analista ahora intenta interpretar la devaluación del paciente de sus interpretaciones, la respuesta más característica del paciente es la rabia de ser "lavado de cerebro" y sometido a lo que considera intentos de control sagio y omnipotente. De hecho, un desarrollo frecuente en estos casos es la promulgación de luchas de poder en la transferencia y la proyección de la deshonestidad y el control sádico en el analista. El siguiente caso ilustra estas características. El Sr. X. Un hombre con personalidad narcisista y una regresión paranoica en la transferencia me señaló en una ocasión que le había cargado por una sesión que habíamos acordado cancelar. Dijo esto con un aire de naturalidad y certeza que, a pesar del hecho de que no tuve indicación escrita o recuerdo del acuerdo, reconocí que podría haber cometido un error y no le cobré por esa sesión. Cuando la misma situación se repitió unos meses más tarde, me sentí bastante seguro de que era poco probable que hubiera cometido este error dos veces. Le pregunté al Sr. X si podría estar en error. Reaccionó con furia

intensa, acusándome de manera halgrada de mentir. Mis esfuerzos por explorar con él La naturaleza de estas fantasías solo aumentó su rabia, su sentimiento de que le estaba acusando de ser un mentiroso, y su percepción inquebrantable de lo que describió como mi despiadía y la insensibilidad al estar dispuesto a mentir para proteger mi infalibilidad. Cuando intenté vincular su percepción de mí con su percepción sorprendentemente similar de su madre, a quienes congendientemente experimentó como altamente manipulador, justo y deshonrado, protestó furiosamente contra mis esfuerzos para lavar a su madre, así como a mí mismo. Este desarrollo en la transferencia desapareció gradualmente sin resolverse. Después de unas pocas semanas, la actitud del Sr. X se convirtió en la de una víctima generosa dispuesta a perdonar y olvidar. Aparentemente había resuelto la extracción de la contradicción entre su confianza en mí como su analista y su convicción de que le había mentido atribuyendo mi "error" a una

Regresión paranoica y narcisismo maligno 305 proceso inconsciente en mí, lo que refleja los sentimientos negativos contra él de que no era consciente de la naturaleza básicamente orgullosa y obstinada, que estaba dispuesto a tolerar debido a mis características redentoras como su analista. Unos meses más tarde, una enfermedad grave de un miembro de su familia requería que el Sr. X se ausentera de la ciudad, y cambié una cantidad de sus citas para permitir mantener la continuidad de su tratamiento. En ese momento, fui hiperalert a cualquier posible mal ententencia con respecto a nuestro calendario y se hizo plenamente consciente de cómo se controlaba los controles con respecto a nuestros acuerdos, en particular con respecto a sus tarifas mensuales. Por supuesto, la misma situación se repitió a sí misma, y el Sr. X nuevamente me acusó de haberlo sobrecargado. Ahora me quedé firmemente con firmeza por mi afirmación de que el error era suyo, y que este error debe reflejar la activación de un tema importante en su vida intrapsíquica en la relación conmigo. El Sr. X se sorprendió de que, después de haberlo mintido dos veces (como ahora afirmó nuevamente con total condena), no solo me atrevería a jugar el mismo truco sino para acusarlo de mi propio comportamiento. Me hizo bastante obvio que no solo hubiera un resurgimiento inmediato de sus brotes paranoicos anteriores en la transferencia, sino también una intensificación de ellos, lo que refleja una acumulación de episodios previamente no resueltos de este tipo. Su regresión paranoica había asumido claramente proporciones delirantes. Señalé al Sr. X que creía la sinceridad de sus afirmaciones, que no tenía ninguna duda de su convicción de que tenía razón, y eso, doloroso, ya que esto debe ser para él, tuve que decirle de mi convicción igualmente fuerte que no le había mentido; De hecho, había tomado tantas precauciones que abarcaron su factura que estaba absolutamente segura de que no le había sobrecargado. Añadí que tendría que considerar si yo también estaba absolutamente convencido de lo

que estaba diciendo, aunque en su opinión está totalmente equivocado, o de hecho estaba mintiendo. Si creía que estaba mintiendo, podría tener que concluir que no debía confiar en su analista, porque el menos que uno podría esperar de su analista era que sea absolutamente honesto con sus pacientes. El Sr. X fue sorprendido por lo que dije y le preguntó si le estaba diciendo que lo estaba lanzando. Le aseguré que no quería tirarlo, pero no vio ninguna otra alternativa que no sea estas dos conclusiones para él: cualquiera de nosotros vivíamos, en este momento, en dos realidades incomparables, como si uno de nosotros estuviera loco, o si no estuviera en tratamiento con un tratamiento, Mentiroso crónico, y despiadado. Luego, el paciente se acumuló enojado para acusarlo de estar loco. Le dije que si fuera cierto que estábamos viviendo en realidades mutuamente irreconciliables, ambos debemos tener una experiencia similar a la de una persona normal que enfrentó la locura, y me pregunté si podía tolerar tal experiencia. El paciente ahora se volvió más reflexivo. Dijo que realmente no lo hizo.

306 Las regañaciones severas creen que estaba mintiendo o que estaba loca. Dije que me di cuenta de lo doloroso que debía enfrentarse a un mundo de locura, ya sea en sí mismo o en una persona que es extremadamente importante para él. Esta declaración marcó el comienzo de la reanudación del trabajo psicoanalítico, con el establecimiento de un parámetro de técnica: nuestro reconocimiento mutuo de la incompatibilidad total de nuestros entendimientos de la realidad como un sujeto básico que se explorará en el tratamiento. Debería agregar que, ante la (al menos temporal) la imposibilidad de resolver la identificación proyectiva del Sr. X por interpretación, una firma se mantiene en un límite mínimo de la realidad en la situación del tratamiento facilitó la continuación del tratamiento. Una vez que el paciente es consciente de que el analista puede tolerar sus mutuamente concepciones incompatibles de la realidad, él mismo puede ser capaz de tolerar tal estado de cosas, un primer paso hacia su reconocimiento de su pérdida de exitosos de la realidad. El paciente ahora puede desarrollar una tolerancia de experimentar un estado psicótico: una convicción delirante con respecto a los AnaSt. En esencia, la capacidad de la analista para tolerar la realidad psicótica del paciente puede llevar a la tolerancia del paciente un núcleo psicótico en él mismo, un reconocimiento que fomenta el restablecimiento de la realización de la realización en la transferencia. El mismo enfoque técnico puede ser útil en el caso de desarrolladores alucinatorios, pseudohallucinatorios e ilusorios en la situación del tratamiento. La atribución del paciente al analista de los rasgos grandiosos, sádicos, deshonestos, deshonestos, incluso delirantes, a menudo pueden reflejar las características similares a las que el paciente había descrito en sus figuras parentales. Tanto las cualidades paternas como las maternas, reales y fantásticas, pueden combinarse para consolidar el grandioso mismo sádico. Importantes antecedentes genéticos de la consolidación del yo grandioso se pueden activar directamente y por identificación proyectiva en la transferencia. Sin

embargo, es característico de tales desarrollos de transferencia, que a los que atiende a la interpretación, rastrear sus vínculos con sus antecedentes genéticos, generalmente fallan. La razón principal es que generalmente es imposible interpretar las distorsiones de la transferencia en términos del pasado antes de que la transferencia se haya convertido en ego-distsonic. El analista puede verse tentado a estar de acuerdo con el paciente que sus padres deben haber sido tan terribles, ya que ahora percibe que el analista sea. Pero tal acuse de recibo es altamente cuestionable desde un punto de vista texico y clínico. Primero, el analista no está en posición de saber si los padres del paciente fueron, de hecho, como se describe o si la descripción corresponde a una distorsión intrapsíquica antigua o retrospectiva; En segundo lugar, su reconocimiento de la realidad de las percepciones del paciente con respecto a los padres puede calmar temporalmente al paciente, pero generalmente es seguido de esfuerzos reforzados para convencer al analista que su habio es imposible también. Si el analista intenta someterse a la grandiosa y un control distino del paciente, el resultado puede ser desplazar la transferencia negativa

Regresión paranoica y narcisismo maligno 307 Volver a los parentales y otros objetos, pero el precio pagado es la imposibilidad de elaborar plenamente y trabajar a través de este paradigma de transferencia central. A corto plazo, la firma del analista se mantiene en realidad en realidad puede aumentar la rabia del paciente y tentarlo de abandonar la sesión, a veces incluso el tratamiento, o, con mayor frecuencia, continuar sus ataques al analista. A largo plazo, y en circunstancias óptimas, el paciente puede eventualmente aceptar la realidad de sus distorsiones del comportamiento del analista y de experimentar la culpa y la preocupación por sus ataques irrazonables al analista, pero también alivio porque el analista ha sobrevivido a los ataques Y sigue ahí, emocionalmente disponible para él. Dichos desarrollos positivos durante un período prolongado de tiempo tienen una función terapéutica crucial. Señalan el comienzo de la liberación del yo dependiente del paciente, el ser normal de su encarcelamiento por parte del patio, sádico, sádico, grandioso. El reconocimiento del paciente de su propia agresión inapropiada y su posterior desarrollo de la capacidad de experimentar culpa y preocupación puede indicar el comienzo de la internalización de los precursores normales de su superyó y de una relación de objeto en profundidad que tolera la ambivalencia e implica el comienzo. Intención de las relaciones de objetos totales, en contraste con las relaciones de objetos parciales. El riesgo de interrupción prematura del tratamiento y de los ciclos crónicos y vívesos de ataque y contraataque experimentado por parte del paciente es la contraparte negativa de tal resolución exitosa de la activación de esta transferencia extremadamente regresiva. Para resolver los desarrollos paranoicos a largo plazo en la transferencia se requieren que el analista sea paciente, alerta y firme. Es importante subrayar, al principio, el riesgo de que el paciente pueda interrumpir el tratamiento e interpretar esto como un triunfo de su propio yo sobre su propio ser normal y de la salud. Es igualmente importante que el paciente se dé

cuenta de que el analista puede sobrevivir sin él y que, en contraste con la ilusión (o engaño) de la ilusión (o engañamiento) de que su autoprolle a la pañal, el analista continuará perfectamente bien y, por su cuenta, incluso si el paciente termina el tratamiento. También es importante interpretar los esfuerzos del paciente para distorsionar que el analista no se siente amenazado por la posible interrupción del tratamiento como lo que significa que el analista está rechazando o es indiferente hacia él. En el tratamiento de pacientes con narcisismo maligno, me he ayudado a tener en cuenta que los objetivos del trabajo interpretativo son, primero, para mantener una afirmación constante de la realidad en la situación del tratamiento al interpretar todas sus distorsiones y, segundo, para ayudar al paciente a llegar al paciente. Puede reanudarse explorando su propio inconsciente mediante la libre asociación, en contraste con enfocar todas sus energías para explorar y controlar la mente y las comunicaciones del analista. En otras palabras, el marco de referencia dentro de el cual las regañas

308 Regresiones severas SIVI Las transferencias de narcisismo maligno deben ser trabajadas a través de la meta de la reincorporación o el inicio de una relación de analítica ordinaria, en la que el paciente puede permitirse depender verdaderamente del analista explorando su inconsciente en el Reconoció la presencia de la AnaSt, ya no se experimenta como maligna. El patológico, sádico, grandioso, ataca de manera infinual, lo que nunca es la experiencia, lo más útil. La malignidad de esta destrucción de lo que es útil, especialmente explota el hecho de que todas las interpretaciones son hipótesis, para ser confirmadas o rechazadas por las reacciones inconscientes del paciente a ellos. Si las reacciones del paciente son altamente negativas a las hipótesis interpretativas que lo golpean con razón, surge una situación muy diferente. El analista debe diagnosticar e interpretar tales inmediatos que se declaran lo que es útil. Esto a menudo significa que tiene que pensar en el paciente entre las sesiones. Para ponerlo de manera diferente, estas transferencias tienden a ocupar la mente de la analista más allá de las sesiones, y dicha preocupación debe entenderse no como una reacción de contraatansferencia patológica, sino como una reacción normal a transferencias muy destructivas. La actuación fuera de la agresión hacia el analista puede tomar la forma de sesiones faltantes, no pagar facturas, calmar el analista e incluso robar objetos de él o destruir objetos en su oficina, conversar en un comportamiento hostil real fuera de las sesiones contra el analista o las personas. Relacionado con él, o realizando gestos suicidas como una expresión no escocesa de triunfo sobre el analista fallido. Además de la interpretación consistente, en particular de la actitud contradictoria de un paciente que se aferra al tratamiento, al aire, aparentemente comprometido en los esfuerzos para destruirlo, dichos desarrollos pueden requerir que el analista estableciera límites más allá de lo cual no continuará el tratamiento. Señalar la alegría del paciente durante el comportamiento sádico, devaluantable en las sesiones puede ayudarlo a conscientes

de los aspectos destructivos de lo que se racionaliza como "indignación justificable". Cuando un paciente amenazó con arrojarme un cenicero pesado, me logró si él podría asegurarme que pudo controlar tales impulsos; De lo contrario, dije, no podría continuar la sesión con él. Otro paciente dejaría el sofá para sentarse en una silla en el otro extremo de la habitación y leerme, en una voz enfurecida, desde un libro sobre técnica psicoanalítica que ofrece recomendaciones que sentía que se oponía totalmente a las mías. Aquí, no hubo amenaza de violencia física, y no sentí que cualquier acción de mi parte estuviera obligada a mantener los límites de una situación analítica. Un tercer paciente una vez salió de mi oficina y me gritó del corredor, donde circulaba otros pacientes y personal, que pensaba que mi licencia médica debería ser revocada de inmediato. En este caso, dije firmemente al pa-

Regresión paranoica y narcisismo maligno 309 pacientes que continuaría su tratamiento solo si me hubiera hablado de manera que preservaría la privacidad de nuestro intercambio. Para discutir los problemas abiertamente con el paciente antes de que se salgan de las manos pueden prevenir las interrupciones repentinas del tratamiento, iniciado no solo por el paciente, sino también por el analista. Estoy familiarizado con varios casos de narcisismo maligno en el que el analista intentó mantener una apariencia de una relación analítica al no interpretar el comportamiento agresivo del paciente y, poco después, se realizó una decisión relativamente a sudadera para rescindir el tratamiento. El paciente puede intentar destruir lo que recibe de la AnaSt y para intimidarlo de varias maneras sutiles. Puede usar el lenguaje que aparentemente indica información o expresa fantasías o curiosidad sobre el analista. Declaraciones, como "Te extrañé desde la última sesión" o "Me siento bien por lo que está diciendo / 'o un paciente que solicita la aclaración de una interpretación puede parecer que traiga un alivio temporal de las tensiones al igual de la situación del tratamiento. Sólo en retrospectiva son tales Sin embargo, las declaraciones reconocidas como el vacío del significado. Sin embargo, el analista aprende a reconocer por su tono o colocación temporal en las horas de tales problemas de comunicaciones verbales. Otros pacientes pueden intentar" lavar el cerebro "al analista con las texiones idiosincrásicas sobre Comportamiento humano y ocupar efectivamente mucho tiempo con estas teorías mientras actúa los aspectos principales de la transferencia en un área diferente. Los pacientes que mientes crónicamente al analista pueden transmitir una artificialidad en la situación analítica que el analista primero atribuye a su propia dificultad para experimentar Empatía con el paciente. El analista puede buscar razones de contraatansferencia más profunda para esta falla en la empateza, solo para descubrir muchos meses después de que se haya restaurado la comunicación total en el

tratamiento que había estado registrando con precisión la calidad" como "de la transferencia, lo que Bion (1970) podría haber designado un" k "o una relación de transferencia" parásita ". El Sr. Y. Un político prominente con una personalidad narcisista y un tipo disociado de actividad homosexual (los episodios homosexuales fueron altamente sintónicos altamente ego durante su desarrollo, pero completamente repudado por él en otros momentos), ocultó la naturaleza de su Las escátas homosexuales, solo insinuando indirectamente al hecho de que estaba recogiendo hombres en baños públicos en áreas de pueblo donde, debido a su prominencia pública, podría ser reconocido y fácilmente chantajeado. Sus vagües referencias a varios episodios en los que pensó que se le reconoció finalmente, me alertó el peligro agudo en el que se estaba colocando. Mis esfuerzos insistentes para aclarar este problema lo llevaron a acusar enojado de un sesgo puritano y antihomasexual convencional. Pero también me vio como un tonto porque era tan lento para darme cuenta de que el peligro era que su habio se estaba provocando, un peligro que también experimentara como altamente emocionante.

310 retresiones severas de g. También quedó claro que, mientras me estaba comunicando su comportamiento peligroso, sintió que era mi responsabilidad preocuparse por eso y no tenía necesidad de sentirse culpable al respecto. En general, yo era un enemigo sádico tratando de sujetarlo y destruir su único placer en la vida, un terapeuta indiferente, distante, totalmente egocéntrico, o, de lo contrario, un tonto ingenuo. El Sr. Y, es de interés tener en cuenta, descrito en grandes asuntos triangulares complejos ocasionales, como su búsqueda de hombres que estaban dispuestos a dejarlo ir a la cama con sus esposas a cambio de la presentación homosexual a ellos, las implicaciones edificadas de las cuales se reflejaron en Abundantes asociaciones que vinculan tales experiencias con su infancia. La urgencia de explorar su actual actuación, el peligro extremo de sus actividades homosexuales en curso y temerario, se desvaneció así en el fondo, hasta que me desperté a las verdaderas urgencias en su situación de vida total. Aquí, se grave la autodestrucción y la falta de honestidad en sus comunicaciones constituían conjuntamente una importante resistencia a la transferencia que requiere el trabajo a través de antes de que se pudieran elaborar más aspectos del material total. El análisis consistente de estas diversas alternativas, y de su jugando a la ruleta rusa, mientras que externalizan conmigo sus conflictos se relacionaron con una preocupación mínima por sí mismo, finalmente transformó que se activa repetitivamente en un conflicto intrapsíquico. La confrontación constante del paciente del terapeuta que se encuentra detronismo, se puede experimentar como un ataque sádico. De hecho, los pacientes que presentan una grave patología del superego debido a su intolerancia a los precursores de suministro de tristes y su proyección de tales precursores en otros en otros, por lo que el analista, experimentará algún comentario que apunte a sus problemas en el comportamiento ético, la preocupación, la responsabilidad o la culpa como un Ataque sádico. Es posible

que el analista, en la contrarrestancia, pueda experimentarse como un perseguidor sádico. El analista tiene que ser firmemente moral, incluso si el paciente le acusa de ser crítico. A veces, la necesidad del analista de tranquilizar a sí mismo y al paciente que, a pesar del comportamiento del paciente, el analista todavía acepta y "empatiza" con él puede ser usado por el paciente. El paciente interpreta la comprensión y la tolerancia del analista como colusión sutil con un comportamiento antisocial. De esta manera, el analista puede fomentar de manera responsable y sin querer una corrupción en la transferencia que, si bien puede reducir la intensidad de la regresión paranoica, en realidad lo considera con el problema más maligno de un mayor deterioro del funcionamiento del superyó al paciente. Es inevitable transformar primero la deshonestidad en la transferencia en transferencias de paranoides de manera aguda, en el curso de las cuales los conflictos primitivos con los precursores de superyo sádico se llevan a la situación de la transferencia y luego pueden ser trabajados a través de allí. Los peligros, entonces, son: Primero, un "inocente", juguetón o seductor de paso de paso de la

Regresión paranoica y narcisismo maligno 311 Honestidad en la relación terapéutica, que fomenta la corrupción adicional del potencial de suministro del paciente; y, en segundo lugar, si la regresión paranoica se desarrolla, pero no se trabaja completamente, una rigidificación en la transferencia en un punto de dicha regresión paranoica. Una vez que el paciente haya podido reconocer la naturaleza fantástica de sus distorsiones paranoicas del psicoanalista y, en este contexto, en este contexto, la naturaleza inapropiada de sus ataques violentos en el analista, los períodos de culpa de derrotamiento y las reacciones depresivas pueden indicar su La tolerancia de las funciones de superyo interdenizado, en otras palabras, la reinternalización de sus precursores de subrayos agresivos y la autodirección de su agresión. La capacidad de una relación de objeto en profundidad que el analista aporta al tratamiento de estos pacientes gravemente enfermos, su absoluta honestidad y su intervoltibilidad, proporcionan un marco implícito de una posible relación de objeto normal que no está disponible para el paciente durante largos períodos del tratamiento, pero óptimamente estará dentro de su alcance emocional al final. La falta de capacidad para las relaciones de objetos dependientes normales, una capacidad que damos por sentado en el paciente común que entra en el psicoanálisis, se convierte en el principal obstáculo en el tratamiento de pacientes con psicopatología narcisista grave, pero también parte del marco de referencia del analista que le permite aclarar La naturaleza de esta dificultad y para resolverlo anedalmente. En este sentido, el paciente tratable con narcisismo maligno representa una expresión extrema del desafío y el ataque a una relación de objeto tan básica, y la capacidad de la analista para resistir tal atacar es una condición más para la tratabilidad de tales pacientes. En todos los tipos de narcisismo maligno que he descrito, las relaciones de objeto que se encuentran en fantasías conscientes y preconscientes sobre el analista deben ser exploradas plenamente. La imagen del

paciente del analista como sa- disttra, deshonesto, indiferente, doméstico, corrupto y estúpido, su percepción inútil del analista como asesino, un psicópata o un tonto de un montante, debe llevarse plenamente en el Abierto para que pueda descubrir la fuente de estas distorsiones. ¿Qué experiencias reales o fantásticas en la primera infancia, qué interpretación entre la fantasía inconsciente y las experiencias reales eran responsables de tal estado de cosas es otro asunto, menos importante como una reforma para tratar el narcisismo maligno que la expectativa de que, en el Proceso de resolución de este patrón en la transferencia, el camino que conduce a este desastre en el desarrollo temprano se aclarará.

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

PART FIVE: Hospital Treatment

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

Capítulo 20: Filosofías contrastantes del tratamiento hospitalar para la psicopatología grave contribuciones psicoanalíticas al tratamiento hospitalario durante la primera mitad de este siglo Los grandes hospitales estatales, viviendas de cientos a miles de pacientes, tuvieron sus tareas esenciales para proteger a la comunidad de pacientes mentales y para prever. Estos pacientes durante un largo período de tiempo se pueden aplicar un entorno de apoyo dentro del cual se podría aplicar el tratamiento médico. Fue en los pequeños hospitales psiquiátricos privados, con una vivienda entre 50 o menos y 300 pacientes, que la proporción de personal / paciente del alto personal permitió el desarrollo de una nueva filosofía del tratamiento hospitalario basado en principios psicoanalíticos. Esta nueva corriente se expresó a través de tres enfoques paralelos: el enfoque interpersonal y culturalista de Harry Stack Sullivan (y el enfoque "psicobiológico" relacionado de Adolf Meyer); El enfoque de la psicología del ego, aplicado por William Menninger, Robert Knight y Paul Feder; y el enfoque de las relaciones de objetos británicas, aplicadas por primera vez por Thomas Main a "casos especiales" (la mayoría de ellos pacientes con organización de personalidad limítrofe) en el hospital y gradualmente se integran con el enfoque sociológico de Alfred Stanton y Morris Schwartz (Kernberg, 1976, 1980). El Sullivanian acerca el trabajo de Sullivan en el Hospital Sheppard y Enoch Pratt, en Towson, Maryland, de 1923 a 1930 y, posteriormente, en el Castnut Lodge Sanitarium en Rockville, Maryland, se resume en varios Los escritos teóricos y clínicos de Sullivan mismo (19533, I953B, 1954, 1956, 1962) y por sus principales discípulos, especialmente Frieda Fromm-Reichmann (1950), Harold Searles (1965), y Otto Will (1967). Estas vistas fueron reencontradas por las formulaciones de Adolf Meyer (1957) en el tratamiento hospitalario, AR-315

El tratamiento del hospital 316 se encontró con el hospital de Johns Hopkins, y por el trabajo de Lewis Hill (1955) en Sheppard-Pratt. Sullivan destacó que la investigación psicológica se puede aplicar solo a situaciones interpersonales, que pueden ser experiencias intrapsycicas reales o fantásticas. Destacó que las necesidades corporales instintivas normalmente se condensan con la necesidad de otros seres humanos y propusieron que la disociación entre las esfuerzos de las necesidades y las necesidades corporales básicas para los sentimientos de seguridad derivados de la apreciación de otros (que determinan la autoestima) Es una causa básica de la psicopatología. En un cierto nivel de severidad, la disociación de la necesidad de la satisfacción de la satisfacción de la seguridad produce la disociación de ansiedad severa de un buen yo de un ser malo, y una transformación malévola relacionada de la capacidad normal de la licitación en la sospecha paranoica y el odio a sí mismo. La tarea esencial del tratamiento del hospital es superar esta disociación por medio de interacciones interpersonales psicoterapéuticas intensas con el terapeuta, que aplica las necesidades disociadas en la resolución de enfoque y percitación de las distorsiones de transferencia ("parataxicas"). La resolución de la ansiedad severa relacionada con tales conflictos disociativos fomenta el crecimiento en la relación interpersonal, el paciente establece con el terapeuta. La estructura social del hospital está dirigida a facilitar la generación de información sobre todas las interacciones del paciente. El paciente se ha aleado para expresar sus necesidades patológicas y regresivas sin ser rejectadas o abandonadas. El personal del hospital debe interactuar con el paciente en términos de su disponibilidad como personas en lugar de en función de habilidades específicas. Toda la información recopilada de las interacciones del paciente dentro de la configuración del hospital debe canalizarse al terapeuta, de modo que pueda integrarlo y usarlo en su trabajo psicoterapéutico. El psicoterapeuta, con sus intervenciones interpretativas, es el

instrumento terapéutico princuloso. La transferencia negativa del paciente se interpreta a la luz del significado de las distorsiones paratas que se promulgan. La transferencia positiva se utiliza principalmente para facilitar el crecimiento del paciente a través de la reanudación del desarrollo normal de las gratificaciones interferencias en la situación terapéutica y, en segundo lugar, en las relaciones promoviendo el crecimiento con otros miembros del personal. De acuerdo con Searles (1965), estableciendo una relación "simbiótica" en la terapia de los pacientes esquizofrénicos y clasificando gradualmente los límites del ego del paciente y la realidad de la situación permite que el paciente se separa de su ser del terapeuta y consolidar sus límites de ego. En resumen, la orientación de Sullivania se centra en la dinámica de la interacción actual en el hospital, en la participación de alertas de todos los pernos en la recopilación de información, y sobre la interpretación de todas las interactuaciones del psicoterapeuta. El programa del Milieu del Hospital debe facilitar la psicoterapia, pero no es tan esencial como el paciente.

Filosofías contrastantes 317 Interacciones con el terapeuta y la provisión dentro del hospital de modelos inividuales para que el paciente se identifique. El enfoque del ego-psicología Desde 1927 hasta 1931, Ernst Simmel (1929), en el Tegel Sanatorium, cerca de Berlín, intentó desarrollar nuevos métodos de tratamiento hospitalario basados en principios psicoanalíticos. Después de que los nazis cerraron el sanatorio, las ideas de Simmel inspiraron a William Menninger (1936, 1943) y, más tarde, Rob- ert Knight (19533, I953B). La orientación al ego-psicología de estos autores, gradualmente, se enriqueció gradualmente por las teorías de Paul Feeder (1952), Heinz Hartmann (1964), y David Rapaport (1967), se centró en el tratamiento del hospital, no de Pacientes esquizofrénicos (interés mayor de Sullivan), pero de pacientes con neurosis graves y patología de caracteres. Estaba estudiando a este grupo de pacientes que Caballero desarrolló su comprensión pionera con respecto a las condiciones de la frontera, primero en la C. Menninger Memorial Hospital en Topeka, Kansas (entre 1937 y 1951), luego en Austin Riggs Sanitarium En Stockbridge, Massachusetts. En este concepto de psicología del ego, el hospital constituye un entorno protector que permite el diagnóstico de las transferencias de los pacientes mientras se protege contra las consecuencias de la actuación destructiva o autodestructiva. La transferencia del paciente puede ser para otros miembros del personal o a toda la institución, así como al terapeuta, de modo que su comportamiento total debe ser explorado. El tratamiento con el hospital debe incluir psicoterapia psicoanalítica o psicoanálisis, así como una restación selectiva de comportamientos inapropiados, el análisis de estos comportamientos y la explicación de la necesidad de esta restricción. Al mismo tiempo, el hospital debe proporcionar salidas socialmente aceptables para las necesidades instintivas. El programa de actividades terapéuticas debe fomentar la expresión sublimada de necesidades agresivas. Las experiencias de trabajo, recreación, estudio y expresión

artística (las cuatro áreas principales de las actividades terapéuticas en el hospital) ofrecen oportunidades para compromisos adaptables entre impulso y defensa y, por lo tanto, tienen funciones directas de fortalecimiento del ego. La disponibilidad de una estructura hospitalaria óptima, ni demasiado rígida ni demasiado desolada, también tiene funciones de creación de ego. La vida diaria en el hospital proporciona experiencias de crecimiento y aprendizaje al aumentar directamente la autoestima del paciente como consecuencia de su funcionamiento más efectivo en el hospital, disminuyendo los temores del paciente de los impulsos inconscientes al proporcionar controles externos y ofrecer nuevos modelos para la identificación. Este concepto de tratamiento con el hospital de la Malla del Hospital fomenta la participación activa del paciente en las actividades terapéuticas en toda la estadía en el hospital.

318 Tratamiento del hospital Este enfoque estuvo en línea con la psicoterapia de apoyo que Knight (I953B) se sistematizó para pacientes con límites, una estrategia de tratamiento que destacó la búsqueda de una expresión más adaptativa de impulso y defensa por medio de interpretar selectivamente algunas áreas al dejar a los demás sin tocar y por Fortalecimiento directamente de los ego adaptativo y sublimatorio funcionamiento en las horas de terapia también. El trabajo de Federna (1952) con pacientes psicóticos se centró en la pérdida de límites del ego, que los pacientes creían que la FEEDN se creía como la pérdida de un órgano sensorial (que ayuda al ego a distinguir la realidad de la fantasía). Esta pérdida se determinó, en su opinión, por un retiro de catálexas libidinales de los límites del ego. En el tratamiento psicoterapéutico de los pacientes esquizofrénicos, su sugerido FIERN, fue importante fomentar la recaíz de los límites del ego al hacer hincapié en la delimitación entre el propio propio paciente y los demás, al enfocar el interés del paciente y la inversión libidinal en un Relación de transferencia positiva con el terapeuta y evitando los desarrollos de transferencia negativa, y al proporcionar una estructura clara a su alrededor para facilitar su redefreenciación de su entorno. La estructura del hospital se prestó a este enfoque psicotericial. El hospital limita claramente el espacio, el tiempo, los roles y las actividades, lo que facilita la reconsolidación de los límites del ego a través de todas las actividades e interacciones diarias del paciente. El concepto de Hartmann (1964) de la esfera libre de conflictos del ego también influyó en el enfoque del ego-psicología del tratamiento del hospital. La terapia con el Medio del Hospital podría aprovechar los recursos del ego del paciente mediante la creación de cualquier fuerza residual que el paciente tenía y evitando experiencias regresivas que fomentan la expresión de la agresión primitiva, no neumalizada y, por lo tanto, conduzca a una mayor pérdida de límites de ego. El enfoque del ego-psicología, en definitiva, destacó la importancia de un

entorno estructurado centrado en la confluencia de las características de fortalecimiento del ego en el medio ambiente y en la psicoterapia del paciente, y la exploración de la transferencia negativa en pacientes con debilidad del ego, particularmente en psicótica. Los pacientes (donde la mayor parte de la Burmen del Tratamiento se colocó en el Programa de Milos del Hospital). Enfoques de las relaciones de los objetos del ego-psicología El enfoque de las relaciones de objetos del ego-psicología se deriva de una variedad de fuentes, algunos de ellos británicos, algunos americanos. Bajo este encabezado, caen mis propias ideas en el tratamiento del hospital. Thomas Main (1957) describió las reacciones del grupo de enfermeras que tratan a los pacientes con límites (y algunos psicóticos) que se habían convertido en "casos específicos" en el hospital del castillo cerca de Londres. El principal encontró que estos pacientes activaban fenómenos grupales en el personal de enfermería similar a los de los "grupos de suposiciones básicas" descritos por Wilfred Bion en 1952.

Las filosofías contrastantes 319 bion luego (1961) elaboraron en su teoría del fenómeno regresivo que ocurren en grupos pequeños cuando falla su estructura de tareas (grupo de trabajo). Bion describió el desarrollo de las reacciones emocionales básicas de CETAIRI dentro de un grupo de este tipo ("Grupo de supuestos básicos"), reacciones que existen potencialmente en todo momento, pero se activan especialmente en momentos de descomposición del grupo de tareas. Sus descripciones de la suposición de "vuelo de lucha", la suposición "dependiente", y la suposición de "emparejamiento" son lo suficientemente conocidas por no requieren una mayor elaboración aquí. Lo que es relevante aquí es la conclusión de la principal que los pacientes regresados (particularmente en la línea fronteriza) pueden, en ciertas condiciones, activar sus relaciones de objetos intrapsíquicos en las relaciones interpersonales con el personal hospitalario, provocando en su campo social una recreación de los conflictos dentro de su mundo intrapsíquico. La activación de la proyección masiva, la necesidad de control omnipotente, denegación, idealización primitiva y, sobre todo, la división en el personal de enfermería refleja tanto los mecanismos intrapsíquicos del paciente como los medios de comportamiento por los cuales las relaciones del personal son dis- Tortado por el mundo intrapsíquico del paciente. En 1954, Alfred Stanton y Morris Schwartz, en un estudio clásico basado en su investigación en Chestnut Lodge, propuso que la estructura social y administrativa del hospital psiquiátrico tenga un impacto significativo en el funcionamiento del paciente individual y esa patología social. Refore la psicopatología individual. Stanton y Schwartz estudiaron los efectos de la desglose en la moral del personal y de la desacuerdo sobre el personal de la emoción patológica de los pacientes, en particular la activación del síndrome de "caso especial". Ilustraron cómo los "divisiones" y los conflictos encubiertos en los campos interpersonales y sociales del hospital pueden

intensificar los conflictos intrapsíquicos y la desorganización en el límite y en algunos pacientes psicóticos. Stanton y Schwartz y Main proporcionaron así un conjunto complementario de formulaciones que iluminaron la relación entre los conflictos sociales en el hospital y los conflictos intrapsíquicos en pacientes con regresión severa. El hallazgo de que los conflictos intrapsíquicos del paciente y las posibles escisiones y sus esfuerzos dentro del sistema social del hospital se refuerzan mutuamente constituyen un puente más importante entre la comprensión del hospital como un sistema social y la comprensión de la activación de la patología de las relaciones de objetos internalizados de ese sistema social. Estos hallazgos y consideraciones teóricas me llevaron a investigar las formulaciones teóricas generales de la Escuela Británica de Relaciones de Objetos Británicos, especialmente la descripción de Fairbairn (1954) y Melanie Klein (1940, 1945, 1946) de las operaciones defensivas primitivas, las relaciones de objetos primitivos, la agresión primitiva y las transferencias primitivas que reflejan todos estos factores. Las ideas en el papel pionero de Main de 1957, en Bion (1952, 1961),

El tratamiento hospitalario de 320 y en Stanton y Schwartz (1954) se integraron por primera vez en una filosofía del tratamiento hospitalario y se aplicó en el Hospital Menninger a principios de 19705 (Kernberg, 1976). Estos conceptos también influyeron en la contrapartida de la Ameri- no, el Instituto de Tavistock para las relaciones humanas en Lon- Don, el A. K. Instituto de arroz de la Escuela de Psiquiatría de Washington, que aplicó las contribuciones de Kenneth Rice a la psicología grupal (1965) en conferencias. Para los profesionales de la salud mental en todo Estados Unidos desde fines de 19605. El diagnóstico de las operaciones defensivas primitivas, en particular los mecanismos de división, en el paciente y en el grupo social bajo los efectos de las interacciones patológicas del paciente en el hospital resultó en un énfasis relacionado en la interpretación de las transferencias primitivas en la psicoterapia del borde fronterizo hospitalizado y Pacientes psicóticos y un estrés en la agresión primitiva como fuente fundamental de conflictos intrapsíquicos. Este trabajo interpretativo con la transferencia difirió de los enfoques de la FEEDEN (que había recomendado la construcción de la transferencia positiva y evitando la transferencia negativa) y la Escuela Sulli- Vaniana (que se centró en el potencial de crecimiento de los desarrollos actuales en contraste con el análisis de Problemas intrapsíquicos, genéticos en la transferencia). Al mismo tiempo, el vínculo teórico entre las ideas de Stanton y Schwartz sobre el entallado del Medio del Hospital y los principales, con respecto a las funciones intrapsíquicas del paciente, sugirió que el Milieu del Hospital tenía un uso terapéutico, además de servir como un eficiente ego. Dispositivo. Podría servir como un entorno dentro de el cual los conflictos intrapsíquicos del paciente podrían ser jugados en el contexto de los procesos del grupo, diagnosticados en el campo social por parte del personal del hospital, y regresaron al trabajo psicoterapéutico individual con el paciente. Por lo tanto, los efectos del enfoque de las relaciones de los objetos del ego-psicología

incluyeron un enfoque renovado en la psicoterapia psicoanalítica, especialmente con los pacientes que presentan una patología grave de caracteres y la organización de personalidad límite, una exploración psicoanalítica de procesos grupales y un Reorganización del tratamiento hospitalario para permitir una combinación de estos métodos individuales y grupales. En contraste con la psicopoterapia de apoyo con las condiciones fronterizas y las funciones de apoyo correspondientes del Milieu del Hospital desarrolladas por Knight, esta aplicación más nueva enfatizó la interpretación de la transferencia del paciente en la psicoterapia individual y los procesos del grupo regresivo en el hospital.. Enfoques sociológicos STANTON y SCHWARTZ's (1954), encontrar que los desacuerdos encubiertos entre el personal podrían causar un comportamiento regresivo en pacientes individuales, señalaron los efectos potencialmente antihiterouticos del tratamiento hospitalario. William

Las filosofías contrastantes 321 Caudill (1958) en el Instituto Psiquiátrico de Yale (otro Hospital psiquiátrico de Piscina Pequeña, Piscapolítica) estudió los efectos de las relaciones entre el personal y los pacientes en el desarrollo de pacientes individuales en el entorno hospitalario. Encontró que el aislamiento de los pacientes del personal, alentado por una estructura hospitalaria jerárquica, afectó negativamente el tratamiento de los pacientes individuales, así como el funcionamiento de los pacientes como grupo. Caudill describió cómo imponente un "papel de paciente" en el paciente, a través de las presiones de pares para la socialización y para aceptar el sistema de valor de los médicos, junto con la oposición de los pacientes a la autoridad (en particular al personal de enfermería), fomentar la ignorancia mutua de los pacientes y el personal, Estereotipos, y alternaciones entre la permisividad y la restricción en forma de "espolvoreadas", que influyen fuertemente en todo el tratamiento realizado en el hospital. Ivan Belknap (1956) y ERVING GOFFMAN (1961) estudió los efectos de la estructura social del Hospital sobre el tratamiento de los pacientes psiquiátricos en grandes instituciones públicas. Sus conclusiones destacaron aún más bruscamente que los investigadores mencionaron previamente los efectos regresivos y degradantes del sistema jerárquico tradicional en los grandes hospitales, donde el deterioro del autoestimento del paciente y la atmósfera general complementó el arbitrario y Control autoritario ejercido por los eculares más bajos del personal jerárquicamente organizado. Goffman comparó la vida en el gran hospital psiquiátrico a sus estudios de otras "instituciones totales", como ejércitos, cárceles, campos de trabajo, barcos en el mar y monasterios. Señaló las dramáticas discrepancias entre los objetivos ideales de las instituciones y su funcionamiento real según lo determinado por la conveniencia y la tradición. Goffman describió la "deshumanización" del paciente para que pudiera tratarse más fácilmente como otra unidad en un "lote", la regulación de todas las

actividades por el "Sistema de privilegios", que consiste esencialmente en medir la salud de un paciente en términos de su La obediencia, y el proceso por el cual el paciente se adapta a las condiciones reales de la vida institucional. Como resultado de estos estudios e informes en la década de 1950, se desarrolló un sólido consenso en la década de 1960 que el Hospital Pizamián Público Gran Litro tradicional incluyó importantes características antipotucas y que la hospitalización a largo plazo en sí podría afectar adversamente el tratamiento de muchos pacientes. Esta convicción se fusionó gradualmente con las ideas políticas que prevalecían en los $ 1960, cuando se cuestionó la autoridad tradicional en general. La oposición a la guerra en Vietnam, las aspiraciones de la contracultura, y la influencia en los Estados Unidos del Movimiento de la antipsiquiatría que entonces evolucionaron en Europa resultó en un fuerte columpio del péndulo. Se solicitó tratamiento hospitalario en general, y se buscaron alternativas a la hospitalización a largo plazo (en algunos casos a todos los tratos hospitalarios para los pacientes psiquiátricos). Paradójicamente, sin embargo, mientras que las conclusiones de estos sociológicos.

322 Estudios de tratamiento hospitalario Preguntó el tratamiento hospitalario psiquiátrico en general, una tendencia contraria evolucionó a partir del estudio de las características autoritarias en pequeños hospitales psiciativos. Esta tendencia contraria fue el esfuerzo por transformar el hospital psiquiátrico tradicional en un sistema social no autoritario, democráticamente inmediatamente similar. El objetivo era proporcionar a los pacientes nuevas fuentes de crecimiento emocional y autoestima a través de su participación para determinar la naturaleza y las actividades de su vida diaria en un entorno protegido. Aquí, los estudios sociológicos de Stanton y Schwartz y de Caudill y los diversos enfoques psicoanalíticos convergieron. El concepto de la comunidad terapéutica surgió como un desafío directo a los efectos regresivos y antihiperáuticos del modelo médico tradicional hiercólico del hospital psiquiátrico. Main (1946) y Max, Jones (1953) desarrolló originalmente el concepto de la comunidad terapéutica como una modalidad de tratamiento; Sus objetivos incluyeron la democratización del proceso de tratamiento. La modalidad de tratamiento de la comunidad terapéutica es una elaboración del "enfoque del equipo" para el diagnóstico y el tratamiento que ha surgido gradualmente en la psiquiatría contemporánea. Tradicionalmente, la autoridad de toma de decisiones se distribuye entre diversas disciplinas de acuerdo con las tareas que realiza cada una. En la comunidad terapéutica típica, el objetivo es minimizar los niveles jerárquicos derivados de la experiencia, los títulos y los títulos profesionales y para maximizar la democracia en el proceso de toma de decisiones. Los modelos de la comunidad terapéutica se desarrollaron en varios hospitales en los Estados Unidos en la década de 1960, especialmente en Fort Logan en Colo- Rado, en Austin Riggs, y en el Instituto Psiquiátrico de Yale. Estos primeros experimentos fueron seguidos por solicitudes en el Hospital Menninger, en el Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York, y en la División de Westchester del Hospital de Nueva York. Por lo tanto, mientras

que el terreno antiautólogo y profodemocrático de la crítica fomentada de 19605 de los hospitales psiquiátricos, se hizo un resultado simultáneamente en el desarrollo de nuevos modelos experimentales de administración hospitalaria que vinculaban la estructura administrativa. Con el uso de procesos de grupo. También facilitó el examen del sistema social total en el que el paciente desarrolló su vida en el hospital. Los enfoques de la comunidad terapéutica fortalecieron los nuevos conceptos de tratamiento hospitalarios y de los hospitales y enriquecieron dramáticamente la armadura de modalidades y técnicas de tratamiento dentro del hospital psiciatico. Desde una perspectiva histórica, estas dos tendencias contradictorias de la década de 19605, una hacia la eliminación de hospitados psiquiátricos, especialmente del tratamiento hospitalario a largo plazo, y el otro hacia el enriquecimiento del tratamiento hospitalario psiquiátrico con nuevas modalidades terapéuticas, reflejó un Nueva fase en la dialéctica entre las grandes instituciones públicas y los pequeños hospitales psiquiátricos. A corto plazo, a principios de 19705, la primera tendencia hacia la significación.

Philosophies contrastantes 323 No se pueden restricciones y eliminación del tratamiento hospitalario. Pero en la segunda mitad de los años 770 $, los resultados de vaciar los grandes hospitales estatales generaron una conciencia sobria de las diferencias entre los conceptos determinados ideológicamente de eliminar el tratamiento institucional, por un lado, y la realidad de cómo les fue los pacientes en al-Ternativas al tratamiento hospitalario, por el otro. Psiquiatría comunitaria, desinstitucionalización y transinstitucionalización La introducción de los neurolépticos en la década de 19505, se expandir gradualmente a un amplio armamento de tratamiento psicofarmacológico en la Duración de 1960, contribuyó a una disminución dramática en La población de pacientes residentes del estado grande y los hospitales mentales del condado en los Estados Unidos. Desde un máximo de 559,000 en 1955, el número de pacientes residentes en los hospitales mentales estatales disminuyó a 200,000 en 1970 y 193.000 en 1976. Esta tendencia se reforzó por el auge de los centros de salud mental comunitarios en todo el país a fines de 1960 $ y principios de 19705. Fuertes corrientes ideológicas que incorporan la crítica social de los efectos negativos de la institucionalización, la filosofía de "antipsiquiatría" (que consideró que todos los tratamientos basados en modelos medicos jerárquicos tradicionales sospechan y querían promover la autonomía, el respeto propio y la autodeterminación de pacientes psiquiátricos), las aspiraciones democráticas de la comunidad terapéutica, el optimismo generado por los efectos de tratamiento psicofarmacológico y el movimiento de salud mental comunitario, todos estos combinados en la promoción de la desinstitucionalización de Los pacientes mentales como una aspiración primaria de la profesión psiquiátrica. Varios hallazgos de investigación, altamente publicitados porque encajan en esta atmósfera social, indican la efectividad de las alternativas a la hospitalización. Pasamanick et al. (1967) comparó una población de pacientes

hospitalizados con una población experimental de pacientes que reciben atención domiciliaria especialmente diseñada. Significativamente, menos de los pacientes hospitalizados pudieron permanecer en la comunidad después de completar su tratamiento que los pacientes de la población de atención domiciliaria. Sin embargo, un reploraje de seguimiento de cinco años presentó una perspectiva más pesimista, lo que sugiere que había poca diferencia entre los pacientes que se ubicaron en el cuidado del hogar y los hospitalizados; El seguimiento mostró que los resultados eran uniformemente pobres. Herz (1971; Herz et al., 1975), comparando el tratamiento hospitalario con el tratamiento hospitalario con el tratamiento hospitalario de una población seleccionada porque ambas modalidades de tratamiento se consideraron apropiadas para todos ellos, concluyeron que los pacientes hospitalizados tenían una tasa de readmisión más alta que el hospital del día. Los pacientes y que, después de cuatro semanas, una mejora significativa de los pacientes hospitalizados del día en los pacientes hospitalarios.

324 Se produjo tratamiento hospitalario. En una revisión crítica de la investigación y la literatura recientes sobre las ventajas y desventajas de la hospitalización, Herz (1980) concluye que el hospital del día no es solo una alternativa factible a la atención hospitalaria, sino que es generalmente preferible, excepto por lo menos perturbado, agudamente Pacientes psicóticos y pacientes gravemente deteriorados y crónicos que no tienen sistemas de apoyo social adecuados en la comunidad. Al mirar hacia atrás sobre los esfuerzos de investigación que respaldaban el supuesto de que las alternativas a la hospitalización pueden ser preferibles en el tratamiento de muchos pacientes psiquiátricos, uno no puede ayudar a notar la diferencia entre la calidad de la atención alternativa proporcionada en los estudios experimentales y las alternativas reales a la atención hospitalaria. Gran mayoría de los pacientes psiquiátricos. La Ideos de "antihospitalización" inhibió una evaluación completa de los costos sociales y financieros de los acuerdos de tratamiento alternativos en comparación con los del tratamiento hospitalario para los pacientes mentales. En muchos casos, las legislaturas estatales y los comisionados de salud mental adoptaron con entusiasmo la filosofía de la deshospitalización, porque significaba una disminución significativa en la población hospitalaria de su sistema y, por lo tanto, en la carga financiera para los gobiernos estatales. El resultado fue una extraña alianza entre las legislaturas de mente económica y los administradores psiquiátricos, por un lado, y los psiquiatras de salud mental de la comunidad idealistas, por el otro. Y cuando decenas de miles de pacientes fueron liberados literalmente de grandes instituciones a las comunidades locales sin sistemas de apoyo adecuados, las comunidades se programaron. De 1975 a 1980, una serie de consultas e informes revelaron las condiciones de vida smosticales de los antiguos pacientes mentales desinstitucionalizados. Se hizo evidente que un efecto del movimiento de desinstitucionalización había sido una "transinstitucionalización" (Robert

Michels, comunicación personal); Los enfermos crónicos simplemente habían sido abandonados de la sartén al fuego. Ahora vivían en hogares de ancianos deficientemente, deficientes, deficientes, deficientes, deficientes, y otros lugares no deseados. Otra consecuencia negativa de permitir que las consideraciones ideológicas tengan prioridad sobre las necesidades de los pacientes, fue evidente en la función de muchos centros de salud comunitarios. Para democratizar el tratamiento, se hicieron esfuerzos para involucrar a la comunidad local en funciones de liderazgo en estos centros. Comunidad "Participación" (interpretada como control comunitario por muchos), garantizada por los grupos asesores obligatorios que representarían los intereses de los consumidores y los ciudadanos, en la práctica fomentó una organización política de ciertos grupos comunitarios que utilizan la participación en los centros comunitarios de salud mental para fines solamente. Indirectamente relacionado con el tratamiento de los enfermos mentales. En algunos asances, profesionales de la salud mental, en un esfuerzo por involucrar a la comunidad local en el tratamiento de pacientes mentales, capacitados a no profesionales a

Las filosofías contrastantes 325 se refieren a funciones profesionales, renuncian a los controles de calidad, y se deteriore un deterioro de la calidad de los servicios que llevó, en algunas circunstancias, a los graves conflictos políticos entre los grupos de la comunidad CDRITMUNITY y los funcionarios de salud mental. Quizás el problema más grave que desanime significativamente el movimiento de salud mental de la comunidad y trajo la desaprobación generalizada en la segunda mitad de la década de 19705 fue la discrepancia entre las muchas funciones que se esperaba que realizaran y la insuficiencia de su personal. Nuevamente, el choque entre ideología y buenas intenciones, por un lado, y realidades fiscales y requisitos técnicos, por el otro, fue dramático. En un esfuerzo por controlar el costo de los centros de salud mental de la comunidad operativa, se hicieron esfuerzos consistentes para reemplazar a los profesionales más caros (psiquiatras) por profesionales menos costosos y menos capacitados, lo que lleva a una disminución significativa en el nivel de funcionamiento profesional, decepciones por la parte de la mayoría El personal profesional altamente capacitado (y, por el mismo token, con exceso de trabajo), insatisfacción con la calidad de la atención médica proporcionada, los síntomas de agotamiento y, finalmente, el abandono de los psiquiatras del sistema de salud mental de la comunidad. En retrospectiva, la polarización entre el tratamiento hospitalario y el tratamiento comunitario parece motivado ideológicamente y técnicamente absurda. Sobre la base de la evidencia clínica y de investigación, un amplio espectro de modalidades psiquiátricas de tratamiento, que incluye la disponibilidad de tratamiento hospitalario a corto y largo plazo en conjunción con hospitalización parcial y todas las demás modalidades ambulatorias, parece ser el modelo óptimo de cuidado. Una perspectiva contemporánea sobre el tratamiento del hospital psiquiátrico Quizás la tendencia más importante para surgir en los últimos años es el reconocimiento de la necesidad de desarrollar servicios

particulares para las poblaciones particulares de pacientes, en contraste con la tendencia tradicional a tratar a todos los pacientes mentales como un grupo homogéneo. Dentro del propio hospital psiquiátrico, se necesitan servicios específicos para servir a diferentes poblaciones. Por ejemplo, un gran hospital estatal psiquiátrico debería ser subdividido idealmente para proporcionar servicios de tratamiento tanto agudos como a largo plazo. Dentro del servicio a largo plazo, algunas instalaciones deben estar orientadas al tratamiento intensivo de la patología del carácter, otros para el tratamiento de pacientes psicóticos crónicos, gravemente deteriorados, otros al apoyo de custodia de pacientes orgánicos gravemente enfermos (cada uno de ellos con diferentes empleo y programas). Los hospitales psiquiátricos pequeños necesariamente tendrían que especializarse en solo algunas áreas, excepto donde el personal / proporción de pacientes es muy alto; La variedad de tratamientos ofrecidos se pueden aumentar, pero los costos de tratamiento también serían muy altos. Los servicios hospitalarios para el tratamiento agudo y a corto plazo esperarían el

326 Tratamiento del hospital Duración promedio de la estancia para fluctuar de 30 a 90 días. Tales servicios serían ideales para tratar la enfermedad psicótica aguda y proporcionar una gama completa de diagnósticos y tratamiento psiquiátricos, así como un uso sofisticado del armamento de la psicofarmacología, la rehabilitación psicosocial y el inicio de después de la tarea. Dichos servicios agudos pueden especializarse aún más en el tratamiento del alcoholismo y la adicción a las drogas, la enfermedad afectativa, la esquizofrenia o la psicosis reactiva transitoria que reflejan el síndrome cerebral orgánico agudo o la regresión temporal de las condiciones de la línea fronteriza. Servicios especializados para niños infantiles y adolescentes representan una modalidad más diferenciada del tratamiento hospitalario. Se puede realizar alguna intervención de crisis concomitantemente con una breve hospitalización, aunque la mayor parte de la intervención de crisis se llevaría a cabo en un entorno hospitalario o ambulatorio. La hospitalización a largo plazo se indica para pacientes con una reversión crónica que no han respondido al tratamiento y no pueden funcionar en nada más que en un hospital bien estructurado y para pacientes con episodios psicóticos frecuentes y prolongados, donde tanto psicotherici-penenic y Las modalidades psicofarmacológicas del tratamiento parecen indignadas. La hospitalización a largo plazo está firmemente indicada para los pacientes con patología de caracteres graves y condiciones fronterizas que son extremadamente autodestructivas o están presentadas. Tal funcionamiento desorganizado que necesitan la protección del hospital para participar en un programa terapéutico. Los pacientes con organización de personalidad limítrofe y bajo control de impulsos, severa actuación, reacción terapéutica negativa, motivación baja para el tratamiento y características antisociales en este grupo. Sin embargo, su programa puede ser diferente de la requerida para un subgrupo de pacientes esquizofrénicos que no responden al tratamiento psicofarmacológico y parecen potencialmente receptivos a

la psicoterapia intensiva. Este subgrupo también requiere hospitalización a largo plazo, pero con una estructura diferente del tratamiento hospitalario. Los modelos de la comunidad terapéutica se indican particularmente en el tratamiento a largo plazo de la patología del carácter y las condiciones fronterizas, mientras que las versiones modificadas de la comunidad terapéutica también pueden tener algún valor en el tratamiento hospitalario a largo plazo de los pacientes esquizofrénicos. La hospitalización a largo plazo orientada en gran medida a las funciones de custodia se determina para los pacientes cuyo tratamiento activo ha demostrado ser ineficaz y que no pueden vivir en un entorno menos estructurado que un hospital psiquiátrico. En resumen, la conciencia parece estar creciendo que una población paciente relativamente pequeña pero significativa de pacientes crónicos, graves enfermos, psicóticos y orgánicos requiere un apoyo de custodia, y que un entorno hospitalario contemporáneo que funcione de manera óptima puede ser muy preferible para ellos una existencia vegetariana en el Periferia de la comunidad local.

Filosofías contrastantes 327 La experiencia clínica y la investigación con respecto a la efectividad de los hospitales diarios ha establecido la importancia de esta modalidad terapéutica. Los hospitales diarios pueden ser una alternativa viable para la intervención aguda de crisis a corto plazo y para todos los casos que requerirían hospitalización a largo plazo, pero donde se puede proporcionar una estructura más restringida, como el hospital del día. Por ejemplo, muchos pacientes fronterizos podrían ser tratados en un hospital de día como alternativa a la hospitalización a largo plazo, mientras que la destructividad severa y la autodestrucción de otros pacientes con límites contraindicarían cualquier cosa, pero la hospitalización completa. Otros programas de hospitales diarios deben centrarse en las necesidades de transición de los pacientes que se mudan del tratamiento hospitalario, especialmente el tratamiento hospitalario a largo plazo, al tratamiento ambulatorio y la comunidad. Los objetivos y técnicas de tratamiento deben variar notablemente para cada uno de estos grupos de pacientes. Tratamiento psiquiátrico para pacientes hospitalizados, por ejemplo, orientados a lograr un cambio intrapsíquico estructural significativo en la organización de personalidad límite para que el paciente pueda moverse a una configuración de tratamiento ambulatoria no posible antes, requiere una psicoterapia intensiva en el hospital y el diagnóstico y Utilización there-peutic de procesos grupales y modificaciones de la comunidad terapéutica. Dicho programa de tratamiento del hospital es muy diferente de lo que se requiere para el apoyo social continuo y la rehabilitación gradual de los pacientes esquizofrénicos crónicos severamente retrocedidos. Una distribución funcional de los recursos humanos y financieros dentro del gran hospital psiquiátrico podría permitirle proporcionar en cierta medida el tratamiento intensivo dado por el pequeño hospital. La modificación del gran hospital público de esta manera eliminaría algunas de sus diferencias significativas del pequeño hospital psiquiátrico privado. El

desarrollo de servicios geriátricos especiales es una nueva tendencia que puede cambiar dramáticamente el entorno del hospital para pacientes mayores que anteriormente se mezclaron indiscriminadamente con la población esquizofrénica crónica. Los servicios geriátricos especiales a corto y largo plazo pueden contribuir significativamente a una estancia hospitalaria reducida para algunos pacientes geriátricos, en particular para aquellos con trastornos afectivos. La función del Hospital Día como un entorno de transición para los principales pacientes hospitalizados se complementa con el desarrollo de las casas de la mitad, los programas de vivienda en apartamentos (donde los ex pacientes del hospital comparten la responsabilidad y la vida en un entorno de apartamentos), el cuidado de los hogares de acogida y los clubes ambulatorios y las organizaciones sociales que pueden ser Organizado alrededor de las clínicas ambulatorias. El concepto de continuidad de la atención ha sido revisada de manera crítica en tiempos recientes. Es caro y generalmente no funcional tener el mismo personal a lo largo del progreso de un paciente desde pacientes hospitalizados hasta el día-hospital hasta el tratamiento ambulatorio. El personal de pacientes hospitalizados se sobrecarga gradualmente.

328 Tratamiento hospitalario con una creciente Población de Pacientes después de la Poderca y la Poderacería, lo que lleva a la incurtencia y la ineficiencia en la utilización de los recursos de tratamiento. Idealmente, la continuidad de la atención debe ser proporcionada por un terapeuta principal que comience con el paciente en el hospital y mantiene una relacionatura psicoterapéutica con el paciente fuera del hospital. En este sentido, un programa de hospital hospitalario integrado con un personal de psiquiatristas que se compromete completamente a ese programa parece más importante que el mantenimiento del contacto entre el paciente y su psicoterapeuta anterior, el tratamiento hospitalario, especialmente cuando está involucrado el tratamiento de pacientes hospitalizados a largo plazo; Aquí suele ser preferible cambiar a los terapeutas. Actualmente, en las instituciones privadas líderes a la vanguardia de la atención hospitalaria psiquiátrica, las modalidades de tratamiento incluyen una amplia gama de métodos grupales, diversas aplicaciones del tratamiento de la milieu del hospital, los enfoques de la comunidad de Thera-Peúticos, el tratamiento psicofarmacológico, el psicofaccial Rehabilitación, y psicoterapia. El enfoque del equipo para los pacientes psiátricos desarrollados en los últimos 20 años conciben la enfermería, el trabajo social psiquiátrico, las actividades terapéuticas y la psicología como partes integradas del tratamiento médico y psiquiátrico. Cada profesional en estas diversas disciplinas aporta habilidades especiales y una interacción personal con el paciente, en el que la transferencia y los desarrollos de contrarrensferencia se utilizan como parte del diagnóstico del entorno social total que rodea al paciente. Este entorno social inmediato se ve afectado por los conflictos intrapsíquicos del paciente y, a su vez, influye en el paciente. La red de experiencias formales e informales, individuales, pequeñas, grupos pequeños y grandes en grupo en el hospital es el fondo contra el cual se pueden diagnosticar las múltiples transferencias y contrarrestantes que se dieron en

situaciones individuales y grupales. Me parece que el hospital se concibe mejor como un entorno social experimental dentro del cual el paciente puede mostrar sus constelaciones predominantes de las relaciones de objetos internalizados patógenos, y en los que estas relaciones de objetos activadas pueden diagnosticarse y modificarse terapéuticamente en el contexto de individuo y grupo. Interacciones psicoterapéuticas. Las contribuciones del psicoanálisis al tratamiento hospitalario y las contribuciones de los enfoques de la comunidad terapéutica han facilitado un concepto de administración y estructura hospitalaria que minimiza los peligros del hospital como una "institución total" y maximiza la oportunidad de nuevas experiencias de aprendizaje. Una tarea importante que enfrenta la psiquiatría estadounidense hoy en día es desenredar el nuevo conocimiento técnico obtenido en los últimos 50 años a partir de las distorsiones ideológicas y extrapolaciones sociales de ese conocimiento. En la práctica, la utilización óptima de este conocimiento requiere que el hospital psiquiátrico permita el uso de las reacciones emocionales del personal a los pacientes con fines terapéticos y promover una atmósfera de apertura y una función.

Filosofías de contraste 329 TIONAL: en contraste con una estructura autoritaria-administrativa, una estructura administrativa funcional no es democrática. La distinción entre la administración funcional y la organización política detibcratica es un aspecto del nuevo aprendizaje que se está integrado en este momento. De la misma manera, los conceptos modernos de la gestión organizacional pueden ser de los conocimientos y habilidades que el psiquiatra del hospital contemporáneo tiene que adquirir. Además, el psiquiatra del hospital debe combinar el conocimiento de la gama completa de tratamientos psicofarmacológicos y psicosociales que ahora están disponibles, incluida la experiencia en la diagnosis y la utilización terapéutica de los procesos grupales.

CAPÍTULO 21: El modelo comunitario terapéutico del tratamiento hospitalario para la psicopatología severa, suposiciones subyacentes durante más de una década, he estado observando la efectividad y las limunaturas de las modalidades de tratamiento de la comunidad terapéutica. La Comunidad Thera-Peutic ha transformado los tipos más tradicionales de tratamiento de la milieu hospital, abrió nuevas carreteras al tratamiento hospitalario de la patología de caracteres graves, y arrojó nueva luz sobre los requisitos administrativos óptimos para los hospitales psiquiátricos. Algunas de estas nuevas ideas no solo fueron imprevistas sino que revelaron consecuencias no deseadas de esta modalidad de tratamiento. Whiteley y Gordon (1979, pp. 105-27), después de señalar que el término comunidad terapéutica es uno de los más mal utilizados y malentados en la psiquiatría moderna, lo defina como "un proceso de tratamiento especializado específico y especializado Utilizando los fenómenos psicológicos y sociológicos, en el grupo grande, circunscrito y residencial. A este respecto, es una extensión intensificada de la terapia de la milieu que tiene más implicaciones y aplicaciones generales para los pacientes de todas las categorías en la comunidad del hospital mental". En el transcurso de su excelente revisión de la historia y los recientes desarrollos de modelos de la comunidad terapéutica, White-Ley y Gordon introducen una dimensión adicional a su concepto: una ideología. De hecho, tanto los originadores principales como los de Jones, los modelos de la comunidad terapéutica, destacaron su convicción del valor de los procesos de tratamiento de democración y de proporcionar un "ajuste terapéutico con una organización estructurada (en lugar de médicamente determinada) en la que Todo el personal y los pacientes se involucran" (Main, 1946, pp. 66-70). Jones (1953) señaló el aplanamiento del pico jerárquico, el papel que difumina y la comunicación abierta como una expresión de un entorno terapéutico desmotáutico. Creo que es de este intento de combinar técnicos y de IDEO-

330.

El modelo de la comunidad terapéutica 331 conceptos lógicos, es decir, la noción de la comunidad terapéutica como una modalidad de tratamiento y como democratización del proceso de tratamiento, que los nuevos hallazgos y las ventajas terapéuticas, así como las deficiencias y problemas, de este enfoque. Emerger. Aunque varios autores podrían describir los aspectos esenciales de este enfoque de manera algo diferente, la orientación básica que se destina de Jones y Main enfatizó las siguientes características: (1) Tratamiento comunitario. El personal y los pacientes, funcionando conjuntamente como una comunidad organizada, realizan el tratamiento de la población del paciente; Los pacientes participan activamente y son agentes co-responsables en su propio tratamiento, no receptores pasivos. (2) Cultura terapéutica. Todas las actividades e interacciones se relacionan con el objetivo de reeducar y rehabilitar socialmente a los pacientes. El funcionamiento óptimo de los pacientes en la comunidad terapéutica es la primera fase para promover su funcionamiento óptimo en la comunidad externa. (3) Living-Learning-Confrontation. Un flujo abierto de comunicación entre los pacientes y el personal proporciona comentarios inmediatos con respecto a los comportamientos y reacciones observados. Una exploración de las funciones de estos comportamientos en los comportamientos nuevos y alternativos y alternativos, los comportamientos experimentales ayudarán a los pacientes a enfrentar la comunidad terapéutica y en la comunidad externa. Los métodos utilizados para llevar a cabo estos objetivos incluyen reuniones grupales (grupo pequeño, grupo grande y grupo de tareas) para facilitar la comunicación abierta, generar presiones para la socialización y la rehabilitación, y para fomentar un proceso democrático de toma de decisiones. Tres tipos de reuniones son comunes a los modelos de la comunidad terapéutica, aparte de la categoría de reuniones de grupos pequeños, grandes, y de grupo: (1) la reunión de la comunidad. Esto incluye a todos los pacientes y todo el personal, y tiene como objetivo

examinar el entorno social total en el que participan el personal y los pacientes, las distorsiones e interferencias con un flujo libre de comunicación de cualquier fuente, y el desarrollo y la posible resolución de procesos antidemocráticos y autoritarios. (2) Gobierno del paciente. Independientemente de la forma específica, los modelos de la comunidad terapéutica tienden a fomentar la organización de los pacientes con el fin de participar en los procesos sociales y de toma de decisiones. (3) reunión del personal. Esta reunión complementa al gobierno de pacientes, ex presiona el concepto de toma de decisiones democráticas entre el personal y alabora el personal para estudiar cómo están influenciados por las presiones de las fuentes administrativas y de otro tipo, así como por su interacción con los pacientes. La reunión del personal permite la distribución democrática de la autoridad en lo que respecta a las tareas, en contraste con las decisiones jerárquicas desde arriba. Se implica una serie de supuestos relacionados con el cambio terapéutico.

332 tratamiento hospitalario en conceptos de la comunidad terapéutica. Primero, se asume correctamente, creo que, que los pacientes como individuos y como grupo pueden ayudarse unos a otros. En segundo lugar, los pacientes que funcionan en una configuración de grupo pueden reaccionar en formas "normales" apropiadas y responsables como un grupo, en contraste con las interacciones patológicas de los pacientes individuales fuera del establecimiento de grupos. En tercer lugar, de la misma manera, el personal, ya que un grupo puede funcionar patológicamente y antihernado, aunque, como individuos, pueden ser maduros y hábiles. De hecho, la experiencia clínica ha confirmado que la patología y la eficacia social de los grupos no coinciden con la patología y la efectividad social de sus miembros individuales. Cuarto, se asume que el autoritarismo es antihuceriaco y que las decisiones tomadas sobre la base del "poder" en lugar de la "razón" miliate contra los mejores intereses de los pacientes. Creo que este supuesto es correcto si uno define el autoritarismo como asumir la responsabilidad de tomar decisiones más allá de lo que está funcionando funcionalmente. Estoy sugiriendo que la antinomia no es de la toma de decisiones autoritarias versus democráticas, sino de la toma de decisiones autoritarias versus funcional. Con esta cualificación, estoy de acuerdo con la suposición general, documentada abundantemente en la literatura, de los efectos negativos, a veces devastadores de los sistemas de tratamiento de autoridad en el bienestar y la mejora de los pacientes. Incluso una estructura organizativa autoritaria que aparentemente afecta solo a los escalones superiores del personal no puede ayudar a afectar a todos los participantes en la comunidad terhéutica. El autoritarismo se transmite mediante mecanismos psicológicos complejos a lo largo de la escala jerárquica, particularmente mediante la presentación e identificación con el agresor, y tiende a erosionar la autenticidad de las relaciones de pacientes / terapeutas en todo el sistema hospitalario. Una

administración del hospital autoritaria puede transformar los arreglos de tratamiento, distorsionándolos para que confundan libremente el equipo terapéutico tratando de aplicarlos. Dichas distorsiones en la disposición de tratamiento pueden promover un pseudoadaptación del paciente al sistema hospitalario e interferir con su desarrollo de la autonomía y el crecimiento. Una estructura hospitalaria autoritaria, casi por definición, interfiere con una evaluación abierta y continua del hospital como sistema social. Una quinta suposición es que, en contraste con los sistemas de tratamiento autoritario, los conceptos de la comunidad terapéutica implican que la democratización del proceso de tratamiento es en sí mismo terapéutica. La democratización aumenta la autoestima del paciente, la efectividad de su funcionamiento y la honestidad de sus comunicaciones y la promoción directa de crecimiento. Mi experiencia me lleva a desafiar este supuesto. Los resultados de la democratización de los procesos de toma de decisiones en los hospitales a menudo han sido una mezcla de terapéuticos y antihiteroico. Más sobre esto más tarde. Sexto, la toma de decisiones colectivas en un entorno abierto en la reunión pública.

Se supone que el modelo de la comunidad terapéutica se asume que es terapéutica porque nutre a la democrática en los procesos autoritarios. Más tarde, examino las ilusiones implicadas en este supuesto. Séptimo, se supone que los pacientes pueden ayudarse unos a otros como en divididos y, en el proceso, a desarrollar habilidades interpersonales y creatividad, así como la fuerza del ego. Sobre la base de mi experiencia, creo que esto es notablemente cierto. Sin embargo, los pacientes también pueden tener efectos muy destructivos entre sí; Para cada David y Lisa que se ayudan mutuamente, uno puede encontrar un psicópata potencialmente conducir a otro paciente al suicidio. La comunidad terapéutica y su estructura de padres, el problema es cómo preservar las eminentes ventajas de la comunidad terapéutica, su utilización terapéutica del hospital como sistema social, la activación de los potenciales de los pacientes para contribuir a su propio tratamiento, el desarrollo de habilidades y Responsabilidades del personal a los escalones más bajos, el conocimiento creciente sobre la interacción entre el mundo interno de los pacientes y los conflictos estructurados en el medio ambiente, las experiencias emocionales correctivas proporcionadas por la comunidad terapéutica y el aumento de la moral del personal, sin caer en serio. A veces, las desventajas devastadoras, que estoy a punto de describir, de esta herramienta terapéutica, por lo demás efectiva. El requisito previo más importante para el desarrollo de una comunidad terapética es que esté integrado funcionalmente con la estructura administrativa del hospital psiquiátrico o general dentro del cual opere. Este requisito puede parecer trivial, no fue que, en la práctica, los líderes de las comunidades terapéuticas son tan a menudo inocentes con respecto a las estructuras administrativas, los límites y las limitaciones de su institución. Algunos de ellos son igualmente inocentes con respecto a una teoría general de la administración o la gestión institucional que permitiría un análisis completo de las factibles administrativas y las

restricciones para una comunidad terapéutica dentro de ese entorno particular. Desafortunadamente, incluso la literatura en la comunidad terapéutica no considera suficientemente la relación entre la estructura de la comunidad terapéutica y la organización en la que debe caber. Por ejemplo, Marshal Edelson (1970), uno de los teóricos más sofisticados de este campo, no es propenso a reemplazar un estudio de restricciones administrativas con una declaración de convicciones ideológicas. Sin embargo, al mismo tiempo que describe explícitamente las implicaciones administrativas y profesionales de la relación entre la administración hospitalaria y el director de la socio-terapia, de hecho presenta modelos de funcionamiento organizativo en los que no hay una estructura administrativa clara que vincula, por una, la autoridad conferida en el Comunidad terapéutica con la del hospital general.

334 Administración de tratamiento hospitalario. Aunque reconoce el potencial de tensión y conflictos en su modelo, su solución propuesta es consultiva, no organizativa / administrativa. Si la comunidad terapéutica es explorar abiertamente el sistema social actualizado por la comunidad del paciente / personal, no puede evitar la activación del estrés y los conflictos latentes en el sistema, con las consecuencias de las influencias sobre la dimensión política del proceso de toma de decisiones en la institución. El supuesto de que se puede realizar un enfoque puramente observacional, aclarante e informativo de los conflictos en el sistema social, se puede realizar en términos interpretativos técnicos y neutrales. Como evidencia, ofrezco este escenario con frecuencia encontrados: un grupo entusiasta establece un modelo de comunidad terapéutica en un sector del hospital; se forma una "sociedad ideal" que genera gratificación, excitación, esperanza, y tal vez un espíritu mesiánico tanto en el personal como en los pacientes, para que se siga más tarde por la amarga decepción debido a la "falta de participación" y el rechazo aparente de esta sociedad ideal por el hospital dentro del cual tiene desarrollado. El resultado final es que la tarea se abonza, la comunidad terapéutica se derrumba, y los líderes emigran a un sistema diferente para iniciar el ciclo de nuevo, o en la práctica privada en una profesión de salud mental. Una comunidad terapéutica debe ser limitada en tamaño; La comunidad del paciente / personal debe numerar entre 80 y 100 participantes como máximo. Esto significa que las comunidades terapéuticas se pueden establecer solo en hospitales psiquiátricos muy pequeños o en servicios relativamente pequeños dentro de un hospital más grande. No es una coincidencia que algunos de los modelos más exitosos hayan operado dentro de pequeños hospitales psiquiátricos, donde las complejidades de relacionarse con estructuras administrativas más grandes son menos evidentes. Cuando el líder de la comunidad terapéutica es plenamente consciente de la estructura organizativa de la

institución, del grado y la estabilidad de la autoridad delegada (y, por lo tanto, al sistema terapéutico que está a cargo de), entonces los límites de la autoridad consisten en toda la comunidad, así como en su individuo. Los miembros se pueden definir y considerar cuando se estudian los conflictos activados dentro del sistema terapéutico y a través de los límites de la comunidad terapéutica. El líder de la Comunidad Terapéutica requiere aramontemios administrativos claros que vinculan a la comunidad a su entorno, y el liderazgo comunitario debe tener la capacidad de deletrearlos. En el último recurso, el contraste ideológico con las convicciones técnicas sobre la organización política democrática a menudo influyen en los líderes de las comunidades terapéuticas y los miembros del personal que comparten estas convicciones para operar como si constituyeran a un partido minoritario en un estado gobernado por el liderazgo autoritario.. Inconscientemente o inconscientemente, confunden la exploración del sistema social con un medio político para cambiarlo. El objetivo terapéutico de la comunidad terapéutica.

El modelo de la comunidad terapéutica 335 nity se confunde con el objetivo político de democratizar una institución de atención médica. Eventualmente, tanto el personal como los pacientes pagan el precio por esta confusión. El apoyo de la estructura de los padres para el sistema de la comunidad terapéutica requiere una redefinición y renegociación constante. Por lo tanto, el líder debe tener la capacidad de llevar a cabo una función política, no en términos de conceptos democráticos, sino en términos de formas efectivas de influir en los individuos y los grupos a través de los límites determinados por la tarea en la institución. Las habilidades básicas requeridas para el liderazgo de la Comunidad Terapéutica también incluyen un sólido conocimiento del funcionamiento y la gestión del grupo de grupos pequeños, grandes y de trabajo; un sólido conocimiento de la psicopatología individual y de su posible influencia en distorsionar procesos de grupos pequeños en el medio ambiente; y una comprensión sólida de los principios psicoterapéuticos. Estos requisitos determinan los problemas involucrados en la capacitación de un liderazgo apropiadamente calificado. Otro requisito para el desarrollo de una comunidad terapéutica es una definición clara de la autoridad, los roles y las funciones de todos los miembros del personal individual, así como de grupos de enclaves organizados formalmente que realizan sus funciones. La Autoridad delegada a la comunidad de Thera-Peutic debe a su vez, se distribuirá funcionalmente dentro de ella. El peligro es que los procesos grupales que están diseñados para alentar la toma de decisiones compartidos también pueden desenfocar la cuestión de cuya responsabilidad es llevar a cabo esas decisiones, así como la naturaleza del sistema de inspección, control y monitoreo de las funciones de la comunidad. Otro danador es que los roles y la experiencia tradicionales que se han importado "en la comunidad terapéutica pueden ser subutilizados o que la autoridad pueda delegarse sobre los motivos políticos para aquellos que no tengan habilidades técnicas adecuadas. Un

enfoque igualitario que descuida las diferencias individuales en capacidad, habilidades y capacitación puede prevalecer, lo que resulta en la ineficiencia y los residuos en el uso de los recursos humanos disponibles. La erosión de las habilidades que se produce en grupos pequeños y grandes en virtud del efecto de la regresión en el funcionamiento de los grupos básicos, el funcionamiento del grupo se amplifica considerablemente por el fallo a utilizar las habilidades disponibles causadas por la ambigüedad administrativa dentro de la comunidad terapéutica. Las comunidades terapéuticas a menudo se han percibido como una amenaza por el liderazgo administrativo y profesional tradicional de los hospitales psiquiátricos. En la medida en que la autoridad adquirida en la profesión médica estaba siendo desafiada en nombre del Egalitarianismo, la amenaza era lo suficientemente real. Más allá de eso, los líderes de la estructura de los padres se sentían amenazados por el escrutinio de la distribución de la autoridad, las funciones y similares. Un examen abierto del hospital, ya que un sistema social se convierte inevitablemente en un monitoreo del proceso administrativo, con todos los desafíos políticos que implica. Puede ser argumentado, por supuesto, que este es un desarrollo muy saludable para algunos sistemas hospitalarios petrificados. Pero los defensores de THERA-

336 El tratamiento hospitalario, las comunidades peéticas no deben sorprenderse por la posiciones activas o sutiles que evoca en la administración del hospital. La comunidad terapéutica también es una amenaza para la relación tradicional paciente / médico y a las relaciones tradicionales entre el personal interdisciplinista. En términos de la vida de democratización en un hospital psiquiátrico, esto es, por supuesto, una ventaja; Pero en términos de la utilización óptima de todos los recursos terúticos, ha tenido consecuencias imprevistas y parcialmente negativas. El personal relativamente poco educado en los escalones más bajos puede ser investido con más autoridad, pero al mismo tiempo con un escrutinio más directo de su funcionamiento. En consecuencia, sus relaciones con sus supervisores administrativos y profesionales serán tensos. Las contradicciones entre la desigualdad social, la desigualdad en los salarios y las expectativas de trabajo, dictadas por el medio ambiente dentro del cual las funciones hospitalizadas, y el desarrollo de una atmósfera igualitaria en la comunidad terapéutica, afilan la conciencia de los conflictos sociales reales y Las contradicciones que están más allá de la capacidad de la comunidad terapéutica para resolverse satisfactoriamente. El resentimiento a fuego lento y los sentimientos de culpa sin resolver en varios niveles jerárquicos pueden aumentar las tensiones entre el personal y complicar aún más el análisis, y mucho menos la resolución, de las tensiones en el sistema social de la comunidad terapéutica. Todo esto aumenta el peligro de disminuir la eficiencia profesional. La activación de los procesos de grupo regresivos, las comunidades terapéuticas también pueden convertirse en una amenaza real o experimentada para el tratamiento de los pacientes. Debido a la cantidad de personas involucradas y el esfuerzo por mantener un flujo relativamente abierto de comunicación, las reuniones de pacientes, las reuniones del personal y la reunión de la comunidad, adquirir características de los procesos de gran grupo; Los efectos retrocesivos de estos

procesos pueden afectar la evolución de los pacientes individuales en la comunidad de formas antihuadas. En otra parte (Kernberg, 1976, cap. 9; 1980, cap. 11) HE HABILIDADA EL PELIGRO DE PACIMIENTO QUE PACIENTES COMO UN GRUPO PUEDEN REGISTRO DE LOS ASUNTOS DE ASUMPIOS BÁSICOS: el funcionamiento del grupo de asuntos básicos no está disponible, cuando las tareas realizadas. Los pacientes no son significativos pero triviales, cuando la delegación de la autoridad del personal a paciente es ambigua, y cuando el líder del personal es ineficaz. Bajo tales circunstancias regresivas, los grupos de pacientes pueden volverse intolerantes a los individuos, establecer una dictadura del grupo que adquiere características de una moralidad primitiva y fomentar la subida de personalidades con características narcisistas y antisociales a las posiciones de liderazgo. El personal puede contribuir a esta regresión mediante una denegación de diferencias individuales entre los pacientes individuales, mediante una creencia implícita de que todos los pacientes tienen las mismas necesidades y se deben esperar a reaccionar o participar de manera similar. Grupos de pacientes y personal.

El modelo de comunidad terapéutica 337 puede entrar en una colusión inconsciente en interferir con el desarrollo autónomo de los pacientes individuales y al permitir una invasión inconsciente de la privacidad que corresponde al grupo total que actúa de la agresión contra los miembros individuales. Sin embargo, la comprensión de que los procesos grupales regresivos pueden producir un empeoramiento de los síntomas en pacientes individuales pueden, sin embargo, también dar lugar a la suposición errónea de que toda la patología del paciente corresponde a los procesos grupales, negando así que la psicopatología puede ser de naturaleza individual. Dicha actitud promueve una idealización defensiva de los procesos grupales que se alimentan de las expectativas mágicas de tratamiento de los pacientes ("Si el grupo funciona bien, los pacientes mejorarán"). Además, los grupos pueden desarrollar una necesidad exagerada de formalizaciones y rituales como defensa contra la violencia (que grupos grandes en particular tienden a generar), una defensa que puede funcionar bien para el grupo, pero restringe las necesidades del paciente individual. El control de los procesos grupales no estructurados por los pacientes más retrocedidos, los monopolizadores crónicos, los manipuladores altamente efectivos, o simplemente los pacientes más violentos pueden distorsionar significativamente el contenido de las reuniones y la asignación de recursos, lo que reduce así el tiempo de tratamiento de muchos pacientes. Las tendencias sádicas no reconocidas y disociadas de individuos pueden infiltrarse en el proceso de grupo en forma de acentuación de las rigididades burañistas, que sirven para controlar la violencia, al tiempo que lo expresan de manera sutil. Esta formalización excesiva de los procesos grupales, combinada con convencionalidad rígida (especialmente con respecto a los problemas sexuales), puede resultar al lanzar la comunidad terapéutica a los procesos grupales restrictivos de latencia y la adolescencia temprana. Bajo las condiciones de los reformolucios básicos de Supuestos (1961), se

incrementan todos los efectos negativos de los procesos grupales. Los conceptos muy conceptos del igualitarismo, la democracia y la confianza en los efectos beneficiosos de la comunicación abierta pueden alimentarse a las expectativas mesiánicas inherentes a la construcción del grupo de supuestos básicos "dependientes" o "emparejamiento", fomentando así un entorno hospitalario poco realista que Detiene el reingreso funcional de los pacientes en el mundo externo. Bajo la reversión en condiciones de vuelo de lucha, la exacerbación de las luchas sociales dentro del hospital derivada de las tensiones de Intrastaff puede mezclarse naturalmente con la búsqueda de pacientes "fiestas" ad hoc "y las ideologías militantes que surgirán la violencia. Los defensores de las comunidades terapéuticas a menudo desconocen que la construcción de una "sociedad ideal" dentro de un hospital puede fusionarse fácilmente con las necesidades de los pacientes para negar sus propios conflictos, tanto intrapsíquicos como interperpersonales, y las contradicciones reales en el mundo externo a las que eventualmente debe volver. Por lo tanto, los pacientes se adaptan a la vida hospitalaria, pero no están preparados para reentrados en el entorno externo. O puede haber una suposición sutil de que todas las personas son esencialmente buenas y que

338 TRATAMIENTO DEL HOSPITAL La comunicación abierta permite la eliminación de distorsiones en las percepciones de sí mismo y otras que son la causa final de la conlícita patológica y la estructura psíquica patológica. Esta posición filosófica niega la existencia de fuentes intrapsíquicas inconscientes de la agresión, en llamativa contradicción con lo que el personal y los pacientes pueden influir en pacientes en un hospital psiquiátrico. Los factores intrapsíquicos versus los factores interpersonales Jones (1953, 1956) recomiendan comunidades terapéuticas para pacientes con patología de caracteres graves que requieren hospitalización; Comete la reeducación y la resocialización efectuada por la comunidad terapéutica como la principal, si no la modalidad de tratamiento exclusiva para tales pacientes. Él transmite la impresión de que ve a estos pacientes como víctimas sociales que requieren apoyo educativo y presiones para brindarles nuevos roles sociales y vocacionales. Esta opinión descuida la importancia de los determinantes intrapsíquicos para la psicopatología y apoya la ilusión de que una atmósfera social saludable en el hospital puede reemplazar la psicoterapia y producir un cambio de personalidad fundamental. Creo que este concepto confunde un ambiente psicepteroutico orientado a desarrollar tratamientos intensivos individuales y grupales con los tratamientos en sí mismos. Asumir que los pacientes son víctimas de las fuerzas sociales irracionales y, de hecho, están expresándolas y que una sociedad racional (una sin contradicciones intrínsecas obvias) permitirá que su restauración completa sea la salud es atractiva pero ingenua. Probablemente no sea una coincidencia que la idea de la comunidad terapéutica tenga un atractivo especial para la contracultura de la 19605. En la década de 1980, la calidad utópica de las ideas y suposiciones de muchos de los modelos se ha vuelto más transparente. La falta de diferenciar lo social de los factores intrapsíquicos que influyen en la psicopatología puede promover una aplicación defectuosa de la teoría de los sistemas a la situación psicoterapéutica. El

supuesto de que la psicopatología de los pacientes refleja directamente las contradicciones en el medio ambiente puede resultar en localizar la etiología exclusivamente en el sistema social. Aquí el enfoque de la principal y la descripción de los procesos grupales de BION divergen bruscamente de Jones. Esta falta de diferenciar al intrapsíquico de la intervera, mientras que continúa estudiando las relaciones entre los dos resultados en la falta de definición de claramente las indicaciones y limitaciones de las modalidades y técnicas de tratamiento de grupos y evalúe críticamente los efectos de la combinación y la superposición de diversos. Tratamientos. Es fácil, por ejemplo, para que los métodos de grupo proliferen en una comunidad psicoterapéutica, de modo que eventualmente los mismos problemas y problemas se discuten desde diferentes perspectivas en diferentes lugares sin tener en cuenta la

El modelo de la comunidad terapéutica 339 Economía de los recursos humanos que se consume. Además, existe la posibilidad ubicua de que la discusión simultánea se active los mecanismos de división de los mismos problemas en diferentes entornos. En la ORY, por supuesto, toda la información fluye en la comunidad, el personal y las reuniones de los pacientes; Sin embargo, en la práctica, desbordando las agendas y la difusión de la información de la información en contra de la integración de la información. A largo plazo, la pérdida de la privacidad puede ser menor que la pérdida de tiempo y los recursos humanos provocó cuando los mocalidades y técnicas de tratamiento no se diferencian entre sí. Edelson (1970) intentó resolver el problema de la relación entre la socioterapia y la psicoterapia al mantenerlas completamente separadas. En mi opinión, esa solución aísla artificialmente a la dinámica del paciente como se manifiesta en su psicoterapia de la dinámica del paciente en la comunidad terapéutica. El resultado es empobrecer tanto la psicoterapia como las modalidades sociales del tratamiento. Mis propias experiencias en las principales comunidades terapéuticas diferentes durante un período de más de una década me han llevado a las siguientes conclusiones. Para comenzar, el elemento de tiempo es de importancia crucial para determinar el éxito o el fracaso de la configuración de la comunidad terapéutica. En las unidades para pacientes retrocedidos agudamente, con una rotación rápida relacionada con un corto período de estadías y problemas médicos agudos que requieren constantemente atención urgente, los enfoques de la comunidad terapéutica parecen trabajar menos. Pero para los pacientes con dificultades de carácter crónico, en unidades con rotación lenta y estadías prolongadas, los beneficios de la comunidad terapéutica se vuelven mayores. Esto parece confirmar la idea de Jones de que se indican los enfoques de la comunidad terapéutica para estos pacientes. Además, nuevamente relacionados con la dimensión del tiempo, los efectos de corto a seis

meses (de uno a seis meses) de las comunidades terapéuticas pueden ser sorprendentemente diferentes de los efectos a largo plazo. Las ventajas de las comunidades terapéuticas predominan fuertemente durante un período de tiempo más corto, mientras que los problemas que generan predominan a largo plazo. A corto plazo, la activación del potencial de los pacientes para ayudarse mutuamente, la altura de las contradicciones internas del sistema de tratamiento social, que a menudo se puede resolver a medida que se les diagnostica, y los efectos emocionantes y exhilas de los procesos grupales fortalecen los bonos entre los pacientes, entre el personal., Y entre pacientes y personal y conducen rápidamente a aumentos en el conocimiento sobre los pacientes que pueden usarse con fines terapéuticos. Sin embargo, en el entorno de tratamiento a largo plazo (seis meses a años), sin embargo, los resultados difieren. Las agendas de las reuniones comunitarias y todos los grupos de toma de decisiones tienden a sobrecargarse. Los esfuerzos para estimular a los pacientes y el personal para participar libremente típicamente resultan en el surgimiento de las resistencias grupales y los grupos de supuestos básicos, en el desarrollo de pasivismo.

340 El tratamiento hospitalario entre los pacientes y el personal, en igual, en largos silencios, que pierden el tiempo, o en la erupción de tal abundancia de material primitivo que lo clasifican en términos de prioridades para la comunidad ocupa el tiempo excesivo. EFTS para resolver estos problemas al hacer que las reuniones sean más formales. Crea el peligro de la burocratización, de desacelerar el proceso de toma de decisiones, y una vez más la agenda se sobrecarga. Gradualmente, la necesidad de la toma de decisiones administrativas y las negociaciones entre la comunidad terapéutica y el entorno externo que dan lugar a las presiones de realidad fomentan una nueva red informal de toma de decisiones. Esta estructura administrativa ad hoc puede, paradójicamente, ser funcionales de manera opreta, pero también puede percibirse como contrarreste a la idea de la toma de decisiones compartidas y, por lo tanto, requerirá un análisis adicional y las negociaciones prolongadas de las necesidades de la comunidad obvia. Los pacientes que tienden a ser manipuladores y / o violentos, que están impulsados a probar los límites de su poder y control, frecuentemente presenta otro problema. Por ejemplo, los pacientes con anorexia nerviosa y aquellos que usan intentos de suicidio para controlar el medio ambiente crean conflictos agonizantes para el personal de enfermería entre su deseo de proteger la idea de permisividad en el servicio y la necesidad de mantener el control sobre la acción que amenaza la vida. Que algunos de los pacientes más violentos y manipuladores lo administran dramáticamente para llamar la atención sobre ellos mismos y absorber los recursos de tratamiento excesivo es una de las características más consistentes del funcionamiento de la comunidad terapéutica. En teoría, todos los pacientes se presentan con el mismo modelo de tratamiento social; En la práctica, los pacientes violentos y manipuladores pueden ser recompensados por una mayor atención, mientras que otros pacientes se desvanecen en el fondo. El espíritu mesiánico, la

emoción y la alta moral que las comunidades terapéuticas inspiran a corto plazo pueden oscurecer el peligroso que se extiende sobre el personal derivado de la falta de una distribución racional de los recursos y la ignoración de las limitaciones de tiempo. Eventualmente, el agotamiento del personal, particularmente entre el personal de enfermería, puede traer solicitudes de mayor personal y la necesidad de que el personal médico superior pase más tiempo con la enfermería. La pasividad se desarrolla entre el personal, quien continúa asistiendo a todas las reuniones, pero participa menos y menos, y el personal y los pacientes con características de personalidad narcisistas tienden a ascender a posiciones de liderazgo. Porque las personalidades narcisistas no tienen ningún compromiso real con los objetivos de grupo, no serán sensibles a la tensión intrapsíquica y los congritos bajo tales circunstancias difíciles. Pero la facilidad con la que se adaptan perficialmente a los procesos del grupo, especialmente cuando son el foco del interés de un grupo y la admiración, los impulsa a las funciones de liderazgo. Esto promueve una emocionante intimidad pseudo y tiende a erosionar sentimientos profundos, así como un control de calidad en el servicio (Kernberg, 1980, cap. 11).

El modelo de la comunidad terapéutica 341 Otra manifestación del agotamiento y regresión del personal es el crecimiento en la auto-absorción del personal. Un observador externo del desarrollo de las comunidades terapéuticas durante un período de tiempo siempre se debe representar que la proporción de tiempo gastada directamente con los pacientes mencionados y que el número de reuniones grupales que involucran al personal solo aumenta. Al mismo tiempo, el agotamiento ocurre con frecuencia entre el liderazgo de las comunidades terapéuticas, de modo que después de tres a cinco años hay una fuerte tendencia a los jefes de servicio que están interesados y se comprometen a las comunidades terapéuticas para que abandonen sus posiciones. Una pregunta evitada con frecuencia es la relación costo / beneficio de la Comunidad Thera-Peutic en comparación con el tratamiento tradicional del hospital psiquiátrico. Los hallazgos anteriores indicaban que cuando el personal insuficiente está disponible para tratar a los pacientes en primer lugar, como en las grandes instituciones estatales (donde se estudiaron los efectos sociales dañinos de los hospitales mentales tradicionales), el uso de métodos grupales permite un aumento en los contactos pacientes / personal y un Humanización de canales de comunicación jerárquicamente rigidificados entre pacientes y personal. Sin embargo, la necesidad de un tratamiento individual de los pacientes no se resuelve por un cambio de este tipo organizativo, y se produce una selección natural en la que solo se pueden ayudar a algunos pacientes. En un entorno hospitalario psiquiátrico moderno, con proporciones adecuadas para pacientes / personal, enfoques multidisciplinarios y un complemento adecuado del personal psiquiátrico en la edad, las comunidades terapéuticas permiten intensificar el tratamiento individual de los pacientes y enormemente enriquecer. La comprensión de los pacientes ganados en la unidad y las modalidades de tratamiento y las técnicas orientadas a ayudarlas. Sin embargo, este efecto positivo tiende a neutralizarse a largo

plazo porque el tiempo de los miembros del personal más experimentado se ocupa de las reuniones grupales, reduciendo su disponibilidad para contactos individuales con pacientes. Además, los miembros menos calificados del personal son pasivos en las reuniones grupales, ni participan ni necesariamente aprendizan mucho, mientras que sus habilidades para relacionarse con pacientes individuales están subutilizados. En resumen, se desarrolla una distribución irracional e imprecnómica de los recursos. Este inconveniente está empeorado por la tendencia del personal de la comunidad terapéutica a retirarse de la unidad de hospital matriz. El trabajo en la comunidad terapéutica genera un ambiente emocionalmente intenso pero protegido. El personal quiere permanecer junto con los pacientes y resistir un flujo abierto de otro personal y a los alumnos a través de la unidad por períodos limitados de aprendizaje y eventual exportación de conocimiento de la nueva Mobernalidad de Tratamiento. Las configuraciones de la comunidad terapéutica a veces son más reacias a tolerar a los estudiantes y a los alumnos que tienen que irse después de un período de tiempo limitado. Existe el peligro de que los miembros del personal individual puedan dejar de ser aceptables para lo que le sucede a los pacientes entre las reuniones del grupo. Un pa-

342 El tratamiento del hospital La familia de Tient se percibe a menudo como una fuerza externa intrusiva, y las comunicaciones con los miembros de la familia pueden disminuir mientras el personal está totalmente comprometido en el mundo interno de la comunidad terapéutica. Por lo tanto, el reingreso de los pacientes en la sociedad puede sufrir. El tratamiento de las familias suele ser manejado por los trabajadores sociales psiquiátricos, que pueden compensar la postura interna de la comunidad terapéutica por un intensa y intensa tratamiento familiar. El problema es que la mayoría de las familias pueden terminar en una terapia de familia intensiva en lugar de en el trabajo psiquiátrico de la realización de la realidad. El trabajador social puede racionalizar este resultado en términos de la concepción psicosocial de la enfermedad emocional implícita en los modelos de la comunidad terapéutica ("El paciente es un producto de sus circunstancias familiares"), pero el número de trabajadores sociales que se requiere para llevar a cabo esta función de límite también aumenta. El control de calidad tiende a sufrir cuándo los miembros del personal están involucrados tan intencionadamente con los demás que el personal superior le resulta incómodo para tomar decisiones con respecto a las promociones, la cocción y el gusto y evaluar si se está produciendo suficiente aprendizaje. Durante un período de tiempo, uno esperaría que el personal relativamente junior o inexpertado debería poder asumir las funciones de la comunidad terapéutica, lo que permite que el personal sea dedique su tiempo a un trabajo individual con pacientes y / o actividades educativas y de investigación. Esta redistribución óptima del tiempo y las funciones tiende a ser descuidadas. En el entusiasmo inicial y la emoción del personal y los pacientes que trabajan juntos, los conflictos de personalidad entre el personal tienden a ser sumergidos en los esfuerzos de los objetivos comunes. Sin embargo, a lo largo del tiempo, tales problemas de personalidad se reafirman a sí mismos y, a menudo, no se pueden incluir en el análisis de los conflictos entre el

personal, porque la teoría de la comunidad terapéutica y de la toma de decisiones democráticas no tiene espacio para los enfrentamientos de personalidad insalubles. En interés de la paz, las distorsiones en el proceso administrativo pueden evolucionar. Paradójicamente, las cuestiones de personalidad ahora pueden ser más importantes que en el modelo jerárquico de administración hospitalaria, donde las normas, regulaciones estrictas y las expectativas jerólicas burocráticas tienden a disminuir el impacto directo del funcionamiento de la personalidad.

Capítulo 22: Tratamiento hospitalario a largo plazo del límite severo y la patología narcisista en el tratamiento de pacientes con psicopatología grave, especialmente aquellas con patología de caracteres fronterizos y narcisistas, he encontrado una modificación del modelo de la comunidad terapéutica integrada con indi- Psicoterapia viidual efectiva. El modelo que estoy proponiendo en común con otra comunidad terapéutica se acerca al esfuerzo para examinar abiertamente el sistema social total dentro del cual los pacientes y el personal interactúan en una unidad; Reconocimiento de la necesidad de establecer una estructura administrativa funcional y no autorínea que realmente permita el examen de los procesos de toma de decisiones y de las fallas en la suposición de responsabilidad y en el desempeño de la tarea por parte de los pacientes y el personal; y la alta prioridad dada a examinar la realidad de la vida del paciente en la unidad y su relación con la tarea de la rehabilitación social del paciente. Sin embargo, el enfoque descrito aquí difiere de otros modelos de comunidad terapéutica, ya que no se basa en una ideología igualitaria con respecto a las funciones de los pacientes y el personal; No aspira a desinstalar los procesos de tratamiento; Limita estrictamente a la autoridad con la comunidad del paciente / personal en contraste con el delegado específicamente al personal; No está intentando crear una atmósfera de permisividad por su propio bien; y, en el sentido de que está fuertemente preocupado por prevenir y corregir la difusión de roles del personal como parte de un enfoque constante en la utilización óptima de los recursos humanos y en la rentabilidad. Si los canales de comunicación entre el personal y entre los pacientes como grupo y el personal, ya que se mantiene lo suficientemente abiertos como para explorar los conflictos internos generados en torno a cada paciente, se puede obtener conocimiento inmediato de la psicopatología de cada paciente. De hecho, el conocimiento más inmediato puede estar disponible, especialmente con respecto a los pacientes con

actuación severa, que sería posible a través de la exploración psicoanítica en las sesiones de psicoterapia individuales durante la misma 343

344 Tiempo de tratamiento del hospital. La integración del conocimiento, por lo tanto, adquirida con la adquisición obtenida de la psicoterapia individual y grupal, refuerza plenamente la utilización del entorno social total del hospital con fines terapéuticos. El desarrollo de dicho enfoque de tratamiento requiere que todos los miembros del personal realicen dos conjuntos de funciones simultáneamente. El primero está relacionado con su formación especial y con antecedentes profesionales: deben interactuar con los pacientes mediante tareas específicas que diferencian a sus profesiones o disciplinas de otros y que corresponden a diferentes aspectos de la adaptación del paciente a la realidad. La segunda función es más personal: cada miembro del personal debe utilizar sus reacciones emisivas naturales a las interacciones de los pacientes individuales con él para diagnosticar una relación humana particular así promulgada y las fantasías implicadas en la constelación emocional generada en el campo social. Las reacciones emocionales de los miembros del personal a pacientes individuales deben ser diagnosticados y reunidos en una imagen que eventualmente les permite asignar las reparaciones de objetos internas importantes, activados y conflictivos del paciente en todo el entorno hospitalario. Las funciones específicas del personal de enfermería se relacionan con la creación y la recreación de un ambiente doméstico en la unidad. Las funciones específicas de las actividades terapéuticas (ocupacional, vocacional, artística y recreativa) se relacionan con la retención de las principales áreas de trabajo activo normal y tiempo de ocio fuera del hogar. Las funciones específicas del trabajo social psiquiátrico se relacionan con las interacciones del paciente con su entorno familiar inmediato, especialmente familiar y con la construcción de puentes entre la vida hospitalaria y ese entorno social externo. Las funciones específicas del psicoterapeuta individual y grupal (con mayor frecuencia, pero no siempre un psiquiatra o psicólogo) se relacionan con la exploración de la

psicopatología del paciente mediante los desarrollos de la transferencia y el análisis de la transferencia total / contrarresta. Constelación expresada en la situación de la psicoterapia, así como en el campo social circundante. Finalmente, la función del hospital o administrador de la unidad de la unidad o el tribu principal del paciente (generalmente, aunque no siempre es un psiquiéspedor / administrador) es coordinar los esfuerzos de todo el personal de las distintas disciplinas mencionadas, en otras palabras, para encabezar el sistema de tareas interdisciciliares a cargo del diagnóstico continuo y el monitoreo de las interacciones del paciente en su campo social, con el doble propósito de ajustar el programa social / rehabilitado según sea necesario y proporcionar información al psicoterapeuta individual. Un problema práctico que justifica inmediatamente la atención es la pregunta de si la función de psicoterapia y la función de gestión hospitalaria ("terapia hospitalaria") debe ser realizada o puede ser realizada por la misma persona o si es preferible si es preferible un sistema dual. Idealmente, estas dos funciones deben estar separadas; Sin embargo, hay formas de condensación.

Tratamiento a largo plazo 345 ellos, durante la etapa inicial del tratamiento hospitalario o incluso durante largos períodos de tiempo. Los requisitos técnicos para el manejo adecuado de la relación psicoterapéutica (particularmente los esfuerzos para evitar actuar de la contratransferencia) y para evitar las distorsiones autoritarias en el proceso de toma de decisiones con respecto a los pacientes individuales, agregan complicaciones importantes a la psicoterapeuta tan condensada / Roles de administrador. El modelo propuesto de tratamiento hospitalario tiene ciertos requisitos prácticos que nos llevan a la teoría subyacente de la organización del servicio o la unidad. Primero, la utilización de las reacciones emocionales del personal a los pacientes con fines terapéuticos requiere que el personal sea seleccionado no solo sobre la base de antecedentes profesionales y habilidades, sino también para ciertas características de la personalidad: apertura, voluntad e interés en explorar sus reacciones emocionales a los demás y la libertad. De la psicopañología severa que distorsionaría indebidamente sus interacciones en condiciones sociales no estructuras. Las personalidades con características excesivamente paranoicas, histster-oid-infantiles, o narcisistas, son candidatos deficientes para tal trabajo. En segundo lugar, es importante que se proporcione una estructura administrativa que facilite la exploración abierta de las reacciones humanas; Es decir, una estructura noúritaria que requiere una actitud no respectiva, abierta, de mente abierta. Por supuesto, una aceptación no autopista no juzgada de todo el desempeño del personal puede ser muy perjudicial para el aprendizaje, a la selección del personal y al uso óptimo del tiempo de personal. Aquí, creo, es una contradicción interna inevitable del modelo propuesto. En tercer lugar, para que los miembros del personal exploren abiertamente sus reacciones a los pacientes, deben preservar constantemente el comportamiento socialmente apropiado hacia los pacientes y claramente delimitar sus límites personales de sus funciones profesionales.

Para ser espontáneo y abierto en sus interáciciones con pacientes, no significa que los miembros del personal deben hablar de sus vidas personales. Para mantener la privacidad del personal también significa que las interpretaciones de las reacciones emocionales y el comportamiento del personal hacia los pacientes que incluyen cualquier cosa, excepto aquí, y ahora deben evitarse las observaciones. El análisis del significado de las reacciones de la contraversión tiene que permanecer en un nivel de su significado contextual inmediato. Es importante evitar la exploración del pasado personal del personal y cualquier "pelada" emocional del personal como "modelo" para que los pacientes sean imitados por los pacientes. La extracción emocional del personal es una técnica desastrosa que agrava la regresión de los pacientes y del grupo con la del personal y, por lo general, tiene consecuencias muy negativas para todos los involucrados. Una firme autodisciplina del personal que actúa en papel y firme, el control autoimpuesto de la expresión de las necesidades sexuales, agresivas y dependientes por parte del personal es contrapartida al estímulo, de lo contrario, de respuestas naturales y espontáneas a los pacientes, incluido un reflejo directo de los efectos de su comunicación-

346 Tratamiento hospitalario y comportamiento en el personal. Esta actitud del personal corresponde a la neutralidad técnica del psicoterapeuta individual como una línea de base para explorar la transferencia. La exploración abierta de los significados del comportamiento del paciente a través del análisis de todas las interacciones del personal con él también requiere una separación definida por parte de todo el personal de las funciones del comportamiento del paciente en el presente, y ahora de sus asumidas motivas genéticas. De lo contrario, las especulaciones indisciplinadas con respecto a las orineradas asumidas de los comportamientos actuales de los pacientes pueden contribuir a crear una ideología y lenguaje pseudo -analíticos que tienden a confundir la comprensión concreta, dolorosamente adquirida con algunas teorías de desarrollo generalmente aceptadas. Tales especulaciones se burlan de la comprensión de los pacientes. Por lo mismo, aunque el comportamiento del paciente en la unidad o el servicio es público y abierto a la exploración en todas sus facetas, sus comunicaciones al psicoterapeuta individual son privadas y deben ser reemplazadas, excepto cuando el uso del psicoterapeuta de tales comunicaciones Corresponde a un contrato de acordado explícitamente establecido con el paciente al comienzo de la psicoterapia. Por ejemplo, el Psicother-Apist puede decirle al paciente: "Todo lo que estamos discutiendo aquí será absolutamente privado, excepto que, ¿debería considerar que está en peligro de dañarte a sí mismo o para los demás, me sentiría libre de tomar cualquier acción que tenga disponible para comunicar estas preocupaciones a otros miembros del personal y para protegerlo de tales consecuencias de su comportamiento. Si eso se hace necesario, por supuesto, primero lo haría saber". La comunicación entre el psicoterapeuta individual y el resto del personal del hospital en este modelo es, por lo tanto, asimétrica, lo que protege a la privacidad del paciente, de hecho, de hecho, como actuando en despliegas, ya que la influencia del mundo intrapsíquico del paciente en el entorno social de la mediación de la

imagen se convierte en Menos relevante, y a medida que el paciente se prepara para abandonar el entorno hospitalario. En contraste, todas las interas de las acciones del paciente dentro del entorno terapéutico deben estar disponibles para el psicoterapeuta dentro, generalmente mediante la comunicación con el gerente de la unidad, el terapeuta hospitalario o el administrador, y deben integrarse con el enfoque interpretativo del paciente. Material total en las sesiones de la psicoterapia. Aún otro requisito de este modelo es que la autoridad delegada a todo el personal de la unidad y al psicoterapeuta se mantendrá separado, evitando así la posibilidad de que el psicoterapeuta (generalmente el miembro principal del equipo), el psiquiatra administrativo o el manejar el caso controlarán el equipo. La confusión en el proceso de toma de decisiones facilita el control indirectamente de los pacientes con su entorno social a través de su psiquiatra del hospital o su psicoterapeuta y puede convertirse en un canal importante para actuar. Este peligro apunta a la necesidad de clara.

Tratamiento a largo plazo 347 La delimitación de la autoridad delegada a los diversos miembros del personal involucró en el tratamiento del paciente, en el liderazgo de los grupos, y en la administración del servicio. La señorita Z. Un paciente en sus principios de los años veinte tenía lo que consideraba una relación maravillosa con su psicoterapeuta del hospital, con quien discutió sus experiencias de la infancia. Hubo poca relación entre los contenidos de las sesiones y las experiencias, interacciones y comportamiento actuales del paciente en el servicio. Simultáneamente, la señorita Z estaba usando su trabajador social relativamente inexperto como su mensajero personal y ayudante. Ella manipuló con éxito al trabajador social para obtener material para ella desde un colegio local. La enfermera de la señorita Z, el miembro clave del equipo, fue consciente de cómo la señorita Z Manipuló a la gente y la enfrentó con este hecho. Por lo tanto, la enfermera fue el enemigo de la señorita Z, y gran parte de la energía de la señorita Z fue movilizando a varias de las otras enfermeras contra ella. El paciente estaba sucediendo en la división del personal y estaba expresando sus propias necesidades de forma dividida. Una madre empática, comprensiva (psicoterapeuta), una madre enemiga (enfermera), y una madre esclavista (trabajadora social), lo que les permitió a la señorita Z mantener su equilibrio. Estos eventos tuvieron lugar cuando el Director del Servicio estuvo ausente por un período prolongado de tiempo y las reuniones habituales de personal estaban, por lo tanto, cambiando su enfoque en otros temas administrativos. Cuando regresó el Director del Servicio, un consultor encuestó la situación y se celebró una reunión especial para discutir el tratamiento de la señorita Z. Como resultado, el sujeto en discusión en la psicoterapia cambió de lo que sucedió hace 15 años a lo que estaba sucediendo ahora. La interacción entre la señorita Z y su terapeuta se volvió intensa, enojada, caótica. Los encuentros de la señorita Z con la enfermera se volvieron menos abrasivos, ya que la enfermera, ahora apoyada por las

otras enfermeras, continuó afirmando su autoridad. El trabajador social, una vez que se dio cuenta de que había sido maniobrado en una posición inapropiada, trató de ayudar a que te hubieran de acuerdo a que se asumiera la responsabilidad de sí misma. La señorita Z reaccionó al intentar deshacerse del trabajador social, pero sus esfuerzos fueron infructuosos porque otros miembros del personal dejaban en claro que pensaban que sus tratos con el trabajador social eran problemáticos. Cuando las diversas fuerzas en el trabajo se analizaron y se entendieron en la psicoterapia y sus interacciones con el personal y su relación con la transferencia se convirtió en el enfoque central de las sesiones, las relaciones de objeto parcial de la señorita Z podrían integrarse y sus defensas contra la ambivencia hacia su madre podrían ser resueltas. Lo que es de especial interés es la conciencia de la parte de la enfermera de la señorita Z que era más firme con este paciente que con otros pacientes, y el comentario del trabajo social en la reunión del personal: "Sabes, generalmente soy muy firme con los pacientes y no me dejo manejar de esta manera. Aquí, para que las razones no sean claras para mí, me he metido en este papel". El anal-

348 TRATAMIENTO DEL HOSPITAL YSIS de la activación de la vida intrapsíquica del paciente en el campo interpersonal del servicio y de las reacciones de la contraversión en particular y las roles complementarios en el personal fue de importancia crucial para alcanzar la psicoterapia en curso. Modos, objetivos y técnicas de tratamientos grupales Antes de examinar los métodos del grupo principal que forman parte de este enfoque, las funciones terapéuticas de estos métodos deben ser explicadas. Cada paciente, de acuerdo con este concepto, requiere, sobre todo, un miembro del personal con la responsabilidad final de su tratamiento en el servicio y la responsabilidad final para fines terapéuticos, administrativos y legales durante la duración de la estancia del paciente. Este administrador de casos, terapeuta hospinacional, psiquiatra administrativa o administrador / psicoterista, idealmente, debería ser un médico en entornos hospitalarios, donde la autoridad médica está legalmente necesaria para justificar la hospitalización y el tratamiento psiquiátrico. La delegación de dicha autoridad a los no físicos es posible, pero requiere modificaciones adicionales en la compleja red de delegación de la autoridad en el servicio. Cada paciente también requiere que un psicoterapeuta individual que pueda, bajo ciertos acuerdos, también actúe como gerente de la unidad. Aunque la psicoterapia individual inflable es una parte integral del tratamiento, de hecho, el modo terapéutico definitivo que integra toda la información derivada del entorno del paciente, esto no significa que las intervenciones directas, planificadas y organizadas por parte del hospital El personal fuera de las sesiones psicoterapéuticas no es un aspecto crucial del tratamiento. Además de una autoridad directiva y una psicoterista individual, cada paciente requiere la disponibilidad de varios grupos de tareas conciliados en las funciones específicas de enfermería, actividades terapéuticas y trabajo social. Estos grupos de tareas permiten que el paciente vuelva a crear, dentro de la configuración del hospital, las actividades vinculadas a la vida en el

hogar, que se ocupan de la red social y se involucraron productivamente en los esfuerzos de estudio, trabajo, recreativas y creativas. Los grupos de tareas generalmente son pequeños, pero pueden implicar una gran cantidad de pacientes, idealmente sin activar los procesos de gran grupo (ver Kernberg, 1980, cap. 11). Los grupos de tareas deben estar altamente estructurados y orientados a la tarea para minimizar el desarrollo de los grupos de supuestos básicos y de los procesos de gran grupo, y deben requerir solo uno o muy pocos miembros del personal. Cada paciente también requiere algún arreglo por medio de los cuales los líderes de estos grupos de tareas pueden comunicarse entre sí, con el gerente del paciente, y con su psicoterapeuta con respecto a sus observaciones y las interacciones de los pacientes con ellos. Estas son las funciones de las reuniones del equipo, tanto intra como interdisciplinarias.

Tratamiento a largo plazo 349 Otro tipo de reunión altamente deseable es uno que canaliza las interacciones informales del personal y el paciente individual, la protuberancia de un solo paciente en la unidad y en las * tiendas, en una discusión de los problemas de aprendizaje / vida en el servicio, lo que idealmente debe incluir - Discusión de la placa de tareas concretas que involucran a los pacientes y el personal. Estas son reuniones de pacientes / personal que tienen una alta proporción de personal a paciente y, para ser apropiadamente productivos, llame a una delegación cuidadosa por parte del personal para evitar que todos los miembros se comprometan con todos los pacientes simultáneamente. En otros modelos de la comunidad terapéutica, esta tarea a menudo es absorbida por la reunión comunitaria; De hecho, puede convertirse en un aspecto esencial de la reunión comunitaria, una solución que rechazé para aclarar la agenda de la reunión de la comunidad para otros fines. En entornos psiquiátricos más tradicionales, que no utilizan modelos de la comunidad terapéutica, las rondas diarias generalmente exploran las funciones que he delineado en reuniones de equipo y reuniones de vida / aprendizaje. El modelo propuesto también incluye la psicoterapia grupal para la mayoría de los pacientes y, por lo tanto, plantea el complejo problema sobre la relación entre la psicoterapia individual y grupal (a la que regresaré poco a la que regresaré). Aunque todos o la mayoría de los pacientes requieren cierta exploración de sus relaciones con su familia, la terapia familiar es un modo que, debido a que el interés que ha evocado, tiende a aplicarse excesivamente en algunos entornos. Estoy aquí distinguiendo entre el sofisticado trabajo social necesario en la mayoría o en todos los casos y el tratamiento psicoterapéutico de toda la familia. Algunos casos requieren terapia familiar, pero cuando el paciente está simultáneamente en la psicoterapia grupal y la psicoterapia individual, existe el peligro de superposición, lo que debilita o diluye el impacto de cada uno y promueve la división y actuando. El modelo propuesto incluye una reunión comunitaria

que asiste a todo el personal y los pacientes, una reunión realizada con la frecuencia suficiente para capturar cambios significativos en los climas sociales y emocionales de la unidad, pero no más a menudo que eso. Es importante limitar la frecuencia de las reuniones comunitarias para evitar los recursos de la propiedad de congelación en demasiadas reuniones grandes, lo que puede absorber una cantidad de tiempo, engía y atención excesiva con una reducción correspondiente en la productividad del personal. Las dos tareas principales de la reunión de la Comunidad son explorar procesos sociales que afectan a la comunidad total de pacientes / personal y para explorar el proceso de la reunión de la comunidad, es decir, los procesos de grupos grandes activados en ellos. La exploración del sistema social debe incluir una aclaración de conflictos interpersonales reales que requieren medidas por el liderazgo administrativo del servicio; Sin embargo, la informalidad y la espontaneidad de las comunicaciones deben mantenerse (en contraste con el procesamiento burocrático, con el procesamiento de la información y una agenda establecida) para permitir el desarrollo y la exploración de procesos de gran grupo. La reunión de la comunidad, entonces, debería explorar problemas que afectan al

350 comunidad de tratamiento hospitalario y canalizarlos para la toma de decisiones apropiada. Pero al mismo tiempo, la activación de las relaciones de objetos primitivos característicos del grupo grande debe tolerarse lo suficiente como para diagnosticar los procesos de grupo regresivos en todo el servicio, particularmente como se expresa en turnos en la moral, en el surgimiento de temas primitivos específicos, y en la distribución de la Sistema social por cuestiones específicas derivadas de pacientes individuales, procesos grupales en el servicio, y el hospital o administración de la unidad. Dicha reunión de la Comunidad requiere un liderazgo altamente calificado y debe ser seguido por una reunión de personal solo para analizar lo que se llevó a cabo en la reunión y para definir y organizar las tareas administrativas derivadas de ella. Una organización de pacientes paralelos a la del grupo de personal administrativo del servicio, con un vínculo administrativo que permite la negociación entre los pacientes como grupo, personal y el liderazgo administrativo del servicio, completa la lista de estructuras grupales incluidas en el modelo propuesto. Enseñe ahora los objetivos y la técnica de cada uno de estos grupos. Grupos de tareas por definición, el enfoque está en las tareas y no en pacientes individuales. Las tareas deben ser significativas y relacionadas con la vida del paciente fuera del hospital; Una clase de cocina, por ejemplo, puede ser más relevante que el tejido tradicional de las cestas. La organización de las áreas, dentro de las actividades de Thera-Peutic, con respecto al trabajo, el estudio, las artes creativas, la recreación y la rehabilitación vocacional (que en realidad es una condensación de estudio y trabajo) debe permitir que las actividades se vinculen más estrechamente con los intereses que los pacientes regresen después de abandonar el hospital.. Los grupos de tareas permiten la provisión de oportunidades para el liderazgo, para la seguimiento, para la colaboración dentro de un grupo, y para probar las funciones del Ego, así como la movilización de los recursos del ego. Las actividades también

facilitan la expresión sublimada de esfuerzos agresivos, dependientes y sexuales. El estudio psicoanalítico del funcionamiento de los pacientes en tales grupos de tareas dependerá de la sofisticación de las observaciones del personal mientras realizó estos grupos. Por ejemplo, una personalidad narcisista, floreciente cuando es triunfante en una actividad competitiva o su disfrute de algo que lo viene de manera absuriente, en contraste con su negativa categórica a participar en cualquier operación que requiera una "El humillante" proceso de aprendizaje, debe ser material muy importante para la exploración, la confrontación táctil y el examen más detalladamente en el curso de su psicoterapia individual. Los grupos de tareas también pueden incluir el trabajo en el ámbito social y político del servicio, como el gobierno de los pacientes, los comités que evalúan las normas y las regulaciones y las propuestas de la administración de la unidad, la organización de las actividades de fin de semana y la ayuda mutua de los pacientes.

Tratamiento a largo plazo 351 grupos. Los enlaces administrativos proporcionados entre los grupos de pacientes especiales y la administración de la unidad pueden dar sentido e impacto a los gestos vacíos de "democracia". El peligro principal en los grupos de tareas es que, paradójicamente, debido a una orientación psicoanalítica a la explotación del significado de todo comportamiento y el funcionamiento del ego en ellos, pueden convertirse en grupos de psicoterapia ad hoc, con la exploración de sentimientos y Conflictos invadiendo el tiempo asignado para su consideración de tareas objetivas. Reuniones de equipo Idealmente, en un servicio que tiene aproximadamente 20 a 30 pacientes, dos equipos de personal paralelas pueden discutir de 10 a 15 pacientes cada uno, con todas las reuniones de líderes del grupo de tareas con una frecuencia suficiente para discutir brevemente a todos los pacientes en su equipo a lo largo de un período de tiempo determinado, por ejemplo, una semana. El administrador de casos o el terapeuta del hospital debe asistir a esta reunión. Su tarea es usar la información para configurar y monitorear el programa terapéutico de cada paciente y, además, para discutir esto con el paciente y proporcionar información completa al psicoterapeuta individual del paciente sobre lo que ha hecho. Con la delegación inteligente de la autoridad dentro de cada decisión, debe ser posible, por ejemplo, un pequeño grupo de enfermeras para comunicar la información del servicio de enfermería al equipo respectivo para que no todos los miembros de la enfermería deben asistir a cada reunión del equipo. Esta es una reunión crucial, en la que se pueden detectar los patrones de las interacciones de los pacientes en el servicio, su comprensión integrada y hipótesis dinámicas formuladas en términos útiles para la orientación del personal y para el psicoterapeuta individual. Estas reuniones también permiten la toma de decisiones con respecto a cómo se deben construir la retroalimentación de las reacciones del personal a los pacientes individuales, en particular la comunicación a los pacientes con la percepción del personal

en las reuniones de vida / aprendizaje. Reuniones de vida / aprendizaje Estas reuniones, que consisten en personal de reunión de equipo y todos los pacientes que se desempeñan en la discusión, se centran a su vez en el desarrollo de cada paciente durante todo el servicio. Idealmente, el liderazgo de estas reuniones debe coincidir con el liderazgo de la reunión del equipo, generalmente llevada a cabo por un miembro principal del personal. Estas reuniones se centran en la discusión objetiva de las observaciones de la interacción del paciente en el servicio aquí, y ahora del servicio. La participación de un grupo de pacientes entero en esta discusión requiere una vez más que se mantenga la privacidad estricta con respecto a la experiencia subjetiva del paciente en contraste con su comportamiento; También permite a los pacientes como grupo participar en la discusión con respecto a cada uno de ellos. De nuevo, es im-

portant that these meetings be protected from becoming one more edition of group psychotherapy; Deben ser grupos de tareas, sin el examen de sus procesos de grupo interno. Estos grupos tienen un gran potencial de apoyo y reeductivo, que debe ser completamente explotado; De la misma manera, lo hacen extremadamente deseable que la psicopoterapia grupal realizada dentro del modelo propuesto mantiene un modo expresivo en lugar de un modo de apoyo. Los grupos descritos hasta ahora deben ser altamente estructurados, un punto que se ha hecho para subrayar sus tareas específicas y su clara diferencia entre sí. Los procesos regresivos tienden a disminuir o continuar bajo tierra en tales grupos, lo que permite destacar la exploración de los recursos del ego y examinar el funcionamiento de los pacientes en su mejor momento, pero oscurece la activación de las relaciones de objetos primitivos en el campo interpersonal. Los siguientes modos de grupo, por el contrario, están orientados a activar procesos de grupo regresivos y relaciones de objetos primitivos en el campo social. La psicoterapia grupal por las razones mencionadas anteriormente, y especialmente porque los elementos de apoyo están tan presentes en las reuniones de vida / aprendizaje y equipo, existe una ventaja en mantener la psicoterapia del grupo como lo posible. Psicoanalítico. La posibilidad de explorar las operaciones defensivas primitivas y las relaciones de objetos en la psicoterapia grupal realizada a lo largo del modelo BION (1961) o el modelo Ezriel (I950) / Sutherland (1952) (es decir, con un enfoque en las transferencias grupales que prevalecen sobre el examen de Los niveles más diferenciados de transferencias individuales del triamizado, el tipo familiar) pueden reforzar y complementar la psicopoterapia psicoanalítica individual de los tipos graves de patología de caracteres realizados en un entorno hospitalario. Los pacientes con organización de personalidad limítrofe que requieren la hospitalización

generalmente presenta el funcionamiento regresivo del ego regresivo. Por lo general, ex presionan aspectos cruciales de su psicopatología por medios no verbales, de modo que la comunicación verbal en las sesiones de psicoterapia individuales permite la expresión de solo una parte limitada de su campo transferencial total de las relaciones de objetos primitivos. Un desarrollo típico en el tratamiento hospitalario de los pacientes con límites que se encuentran en psicoterapia individual, al mismo tiempo, es una tendencia a la superficialidad en el contenido de las horas de psicoterapia o una desviación de ese contenido hacia el pasado del paciente, mientras que las principales disposiciones de transferencia se dividen y se extienden en El entorno social. El desarrollo de un entorno social estructurado como parte del modelo propuesto facilita el diagnóstico de dicho potencial de transferencia y permite el control de su actuación, al menos en sus manifestaciones más dramáticas. Es esencial controlar

Tratamiento a largo plazo 353 La expresión de las manifestaciones extremas de su patología para evitar ciclos viciosos derivados de la gratificación directa de las necesidades primitivas, la expresión auto-gratificante del control omnipotente y la identificación proyectiva dentro del entorno social. Pero este control también limita la observación de estas manifestaciones extremas de la psicopatología del paciente. La psicoterapia del grupo psicoanalítico es una salida controlada para la expresión de la psicopatología primitiva en un entorno social que permite su interpretación inmediata. Además, si el psicoterista individual recibe comentarios completos del psicoterapeuta del grupo con respecto al desarrollo del paciente en el grupo, de modo que la división de transferencias entre la terapia individual y grupal puede ser monitoreada e intermeada, la psicoterapia grupal puede intensificar al individuo. Experiencia psicoterapéutica. En contraste, cuando la psicoterapia grupal se vuelve de naturaleza de apoyo, se vuelve más difícil mantener un enfoque interpretativo en las sesiones individuales. El grupo puede fomentar las resistencias de los pacientes individuales, y se desarrolla una tendencia para dicha psicoterapia grupal de apoyo para duplicar otros procesos de grupo en el servicio. La comunidad que cumple con la reunión comunitaria, como grupo grande, permite la aplicación de técnicas de gran grupo, que examinan, al analizar los contenidos primitivos que surgen en ella, el origen de los conflictos que influyen en el sistema social del servicio. Simultáneamente, dado que la autoridad administrativa total, la autoridad administrativa del servicio participa en esta reunión, la reunión de la Comunidad permite la negociación de conflictos reales dentro del servicio. Además, todas las personuras de Dramatis involucradas en los conflictos en el servicio están presentes. Todo esto hace que sea tentador extender la agenda para esta reunión. Pero esto resulta en un desbordamiento de la comunicación y, por lo tanto, una pérdida de enfoque en la tarea, una difusión de prioridades y un desperdicio de los recursos invertidos en ella. El

requisito principal para la utilización exitosa de la reunión de la Comunidad es establecer sus prioridades claramente, una historia práctica que el liderazgo de la comunidad terapéutica tiene que lidiar con respecto a cada reunión. En el modelo que estoy proponiendo, la tarea de la reunión comunitaria de diagnóstico de la cantidad de ascenso de la atmósfera social y cultural total del servicio en cualquier momento en particular tiene prioridad. Esto incluye el diagnóstico de distorsiones y conflictos introducidos en el servicio por la administración del hospital, los conflictos dentro del personal, el límite del personal / paciente en el propio servicio, o las distorsiones muy graves en la vida social del servicio evocado por la psicopatología de los pacientes individuales.. A Diagrama de la nariz, una gruesa de tierra en forma de un conjunto dominante y ampliamente compartido de

354 experiencias de tratamiento hospitalario, fantasías y emociones que requieren el uso de procesos de grupos grandes en la reunión de la comunidad. Esto significa una agenda abierta, una participación gratuita de todos los pacientes y el personal en expresar lo que está en su mente en el momento de la reunión, y la invitación a que todos puedan resumir algo que pueda ser útil para aclarar los problemas que afectan a todos los presentes. Esta invitación a la comunicación no estructurada en el establecimiento de grupos grandes se acomoda, no solo los conflictos enumerados antes, sino también su expresión en los niveles primitivos de la formación de fantasía, que a veces pueden alcanzar proporciones cuasi psicóticas. El líder de la reunión de la comunidad, así como los otros participantes, también se invita a explorar libremente su entendimiento de lo que está sucediendo actualmente, y la reunión se lleva a cabo con un enfoque que cambia de aclaración de su propio proceso a contenidos específicos. Una tolerancia de la expresión plena de fantasías primitivas regresivas sin seguridad o aclaración prematura puede tener un impacto psicoperapéutico importante en la discusión de la psicopatología individual en la psicoterapia individual y las sesiones de psicoterapia grupales y pueden ilustrarse por implicación. Fantasías que organizan los conflictos del paciente individual con respecto al entorno social del servicio. En el modelo propuesto de reuniones comunitarias, el enfoque inicial en el proceso de gran grupo se coincide con una segunda prioridad, a saber, la tarea de resolver los problemas aquí y ahora que afectan la interacción del paciente / personal, con el propósito de abrir los canales de comunicación y toma de decisiones. Resolución de tales conflictos. Estoy sugiriendo que las decisiones no se hacen en la reunión de la comunidad. Sin embargo, se identifican los canales y estructuras de comunicación y toma de decisiones, lo que hace posible continuar con tales decisiones, o decisiones y realidades pasadas se aclaran después de la plena ventilación de las fantasías que los rodean. El análisis de las

consecuencias de las decisiones hechas por vía no visto en el pasado refleja el compromiso del personal para reexaminar tales decisiones dentro de las estructuras administrativas apropiadas. Además de los procesos emocionales que afectan a todo el personal y los pacientes, el funcionamiento real del sistema social, la relación entre las estructuras sociales previstas y reales, y el uso y el uso indebido de la autoridad y el poder en las transacciones en la reunión de la Comunidad. La principal ventaja de este tipo de agenda es que los efectos potencialmente antihiterouticos de los procesos de gran grupo que afectan a toda la comunidad pueden ser explorados, diagnosticados y resueltos. Además, el examen abierto de los problemas administrativos, ya que afectan el funcionamiento y los sentimientos de todos son una excelente herramienta educativa, que combina la enseñanza de la dinámica del inconsciente con el análisis del impacto de la administración y las estructuras sociales en las vidas de los individuos. También he encontrado que esta es una de las herramientas más útiles de la capacitación de

Tratamiento a largo plazo 355 residentes psiquiátricos, personal de enfermería y profesionales de la salud mental en general. Otra ventaja es la posibilidad de integrar el impacto de todos los diversos procesos grupales y sistemas de tareas en el servicio, diagnontaling por medio de la moral general del servicio: la calidad de los cuales surge inmediatamente en una situación de gran grupo, la adecuación funcional de los acuerdos administrativos. La desglose en la moral como diagnosticada en el proceso de gran grupo se puede rastrear, ya que he sugerido en otros lugares (1980, chaps. 11-13), a fallas en la estructura administrativa, en el liderazgo, o en la tarea. Rastreo La fuente de la desglose puede resaltar los conflictos de control de límites que afectan al sistema total o cualquiera de sus subsistemas. Aunque el proceso de gran grupo, como se realizó técnicamente, se realiza aquí, evita la discusión de la dinámica o el tratamiento de cualquier paciente individual, genera temas particularmente relevantes para los pacientes cuya psicopatología constituye una principal fuente de conflicto en el servicio. En resumen, la explotación de los procesos de gran grupo en la reunión de la Comunidad tiene un gran valor terapéutico, educativo y administrativo y puede provocar tiempo en todas estas áreas. En otra parte (1980, cap. 11) He explicado el descubrimiento de agendas ocultas de la institución en dichas reuniones de la comunidad y el destacamiento de los temas importantes de los conflictos psicológicos primitivos. Las principales desventajas de este modelo propuesto incluyen, en primer lugar, el peligro, mencionado anteriormente, de apiñarse la agenda; Esto exige que el líder esté intensamente alerta y autodisciplinado. Tanto el liderazgo como el personal deben abstenerse de los intentos de resolver problemas de pacientes individuales, gestión de la sala y toma de decisiones generales en la reunión de la comunidad, la pérdida de límites administrativos se vuelva borrosa. Además, el peligro existe que una combinación de interpretación de temas emocionales y aclaración de los procesos

administrativos puede ser utilizada por el personal para "interpretar" las razones de un paciente para solicitar ciertos cambios. Por lo tanto, la herramienta de comprensión psicodinámica se importaría, ya que se usaría para manipular las relaciones de poder entre los pacientes y el personal. Sin embargo, de la misma manera, la disponibilidad de canales de comunicación alternativos claramente definidos que permiten la toma de decisiones accionadas sobre la base de las discusiones en la reunión de la Comunidad tienden a prevenir la actuación incontrolada de los niveles primitivos de agresión por pasividad implacable y Silencio que se extiende a lo largo de muchas reuniones. En contraste, cuando los procesos de gran grupo se analizan en la reunión de la comunidad sin relacionarlos con los procesos reales de toma de decisiones, es fácil para la reunión retroceder al abrumador caos y la destructividad, tanto que las funciones activas y constructivas en Los pacientes con volvíos y el personal pueden continuar en otra parte del servicio mientras

356 Tratamiento del hospital Toda la agresión (tanto de pacientes como de personal) se disocia y se extiende en esta reunión en particular y se congela a todo el personal en una posición de impotencia que afecta a todos. El modelo propuesto para examinar los procesos de grupos grandes en la reunión de la Comunidad requiere acuerdos administrativos claros que afectan al personal y los límites del paciente / personal, mi próximo punto. Requisitos administrativos Una estructura administrativa funcional en la unidad o servicio o en el hospital de envoltura dentro del cual se evoluciona este modelo comunitario terapéutico es un requisito indispensable. Esto implica, en primer lugar, que el Director de la Unidad o Servicio debe tener un control total de autoridad y límite sobre todas las transacciones entre el entorno externo y la unidad y, naturalmente, a través de los límites de los sistemas de tareas dentro del servicio. En segundo lugar, la autoridad del director debe ser estable, conocida públicamente, y delegada de manera que, a su vez, se conoce, estable, inequívocante y conocido públicamente. En tercer lugar, el modelo propuesto implica un delegación de autoridad de un paralelo, pero no sobrealparo de la autoridad al terapeuta del hospital o el manejo del caso, el "médico administrativo", que tiene la responsabilidad psiquiátrica médica y general final de cada paciente y, en virtud de esta autoridad, se convierte en el Líder del equipo interdisciplinario inmediato involucrado en el tratamiento de cada paciente. La decisión del psiquiatra administrativo, por ejemplo, que un paciente es suicida y debe estar en una rutina de "observación cercana", solo puede ser interrogada por su superior administrativo. De manera paralela, toda la autoridad para la organización de recursos dentro de cada disciplina debe ser delegada al Director de esa disciplina, de modo que la forma en que el servicio de enfermería, por ejemplo, organiza sus funciones en el servicio, incluido el desarrollo de grupos de tareas que involucren a los pacientes y el personal, está totalmente dentro del reino. De la toma de decisiones de la autoridad de

.

la enfermera principal o su delegado. Nuevamente, en una moda paralela y aún no de la moda, el Director del Servicio delega cierta autoridad a la reunión de la Comunidad, en lo que respecta a la participación en la toma de decisiones sobre temas que afectan la vida social de los pacientes en el servicio, en particular los límites del personal y los pacientes como grupos. Por ejemplo, la medida en que las reglas y regulaciones que rigen la vida diaria del servicio pueden ser alteradas por una combinación de los comités de pacientes y los comités de personal deben ser claramente definidos y explicados, primero por el Director del Servicio y más tarde por el Líder de la Comunidad de la Reunión. Naturalmente, si el propio director del propio servicio realizó la reunión comunitaria, simplificaría este proceso. Si lo hace, sin embargo, podría estar tentado a invertir la reunión de la comunidad.

Tratamiento a largo plazo 357 con tanta autoridad que interferiría con la autoridad consistida en el terapeuta hospitalario y los jefes de disciplinas. El modelo propuesto permite una distribución alternativa de la autoridad, en la que la reunión comunitaria tiene autoridad solo para la exploración total de los procesos administrativos y los conflictos en el servicio. Toda la autoridad de fabricación de decisiones con respecto a los pacientes, ya sea como individuos o en grupos, se delega a los terapeutas hospitalarios, los líderes de la disciplina y los comités especiales de personal y pacientes. Esta variación en el modelo evita los conflictos con respecto a la autoridad de toma de decisiones de la reunión de la comunidad y la de todas las demás estructuras grupales derivadas en el servicio, pero la influencia de la reunión de la comunidad como un organismo efectivo de toma de decisiones se debilita, y sus prioridades naturalmente cambiarán en el Dirección del estudio de sus propios procesos de gran grupo. O puede ser, un tipo de ensamblaje de opciones públicas, que se le caracterice por pasividad crónica y un sentido de futilidad. Por lo tanto, creo que es preferible que la autoridad significativa se delegue a la reunión de la comunidad, aunque ciertamente no sea la autoridad total, ya que esto resultaría en una difusión de roles y sería una mala aplicación de una estructura política democrática. Una forma práctica de facilitar las negociaciones entre los pacientes como un grupo y el personal, ya que un grupo dentro del modelo propuesto es organizar un gobierno de pacientes y un comité de personal correspondiente, que obtiene su autoridad, ya sea de la inversión originalmente en la reunión comunitaria o directamente del grupo ejecutivo del servicio. Los "consultores" del personal "los consultores" a las estructuras gubernamentales de los pacientes pueden ayudar a los pacientes a tratar de manera más efectiva las estructuras administrativas del servicio, pero deben estar alertas a la ambigüedad potencial de la naturaleza de la autoridad delegada. Un problema importante con este modelo

propuesto, y probablemente con todos los modelos de "gestión participativa", es la tendencia de los procesos de toma de decisiones en grupos para expandirse en proporción al grado de libertad y apertura con la que trabajan grupos. El resultado es una sobrecarga gradual de la agenda de todos los grupos de toma de decisiones. Se pierde el sentido de las prioridades, y lo que sigue es la administración por las crisis. Esto se puede evitar mediante un liderazgo claramente definido de cada estructura del grupo y mediante una definición clara de límites de tiempo dentro de los cuales se deben tomar ciertas decisiones. Si un grupo no puede recuperar su mente dentro del plazo, el líder del grupo tomará esa decisión, y si la incertidumbre en el Líder obliga al proceso de toma de decisiones en la jerarquía administrativa, la decisión será realizada por el propio Director de Servicio. La obvía de la autoconsiedad de grupos generalmente se puede controlar al revertir la centralización de la toma de decisiones cuando el grupo posterga. Ayuda a tener en cuenta que el propósito final de la comunidad terapéutica es tratar a los pacientes y no llevar a cabo un ejercicio en el gobierno.

358 Ernment de tratamiento hospitalario. La restricción final en el tratamiento de pacientes es la limitación en los recursos del personal, en particular el momento de los miembros más expertos del personal, y estos recursos deben estar protegidos. En circunstancias óptimas, la hospitalización a largo plazo puede considerarse completada cuando la perspectiva o la introspección y la preocupación del paciente para sí mismo se restablecen lo suficiente para fortalecer las motivaciones realistas para el tratamiento, cuando la motivación para el tratamiento en sí misma se vuelve a flujar en la voluntad del paciente y se demuestra capacidad para asume un grado creciente de responsabilidad por sí mismo, cuando una relación psicoterica se ha consolidado en la medida en que la probabilidad de su continuación sobre una base ambulatoria parezca un supuesto razonable, y cuando el paciente ha recuperado las capacidades para llevar a cabo un ordi- Vida social de Nary fuera del entorno hospitalario. La disminución significativa o la resolución de las ganancias secundarias de enfermedades es una indicación adicional importante de que se han logrado los objetivos de hospitalización a largo plazo.

Referencias Abraham, K. (1919). Una forma particular de resistencia neurótica contra el método psico-analítico. En papeles seleccionados sobre psicoanálisis. Nueva York: Brun-Ner / Mazel, 1979, pp. 303-311. Abraham, K. (1920). Manifestaciones del complejo de castración femenina. En papeles seleccionados sobre psicoanálisis. Nueva York: Brunner / Mazel, 1979, pp. 338-369. Adler, G., y Buie, D. H. (1979). El enfoque psicoterapéutico de la alonecura en el paciente límite. En los avances en la psicoterapia del paciente fronterizo, ed. J. LEBOIT Y A. CAPPONI. Nueva York: Jason Aronson, pp. 433-448. Alexander, F., et al. (1946). Terapia psicoanalítica. Nueva York: Ronald Press. Asociación Americana de Psiquiatría (1952). Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos de menores: DSM-L WASHINGTON, D.C. ASOCIACIÓN Psiquiátrica Americana (1968). Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos de menores: DSM-I1. Washington, D.C. American Psychiatric Association (1980). Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos de menores: DSM-III. Washington, D.C. American Psychiatric Association (1981). Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos de menores: DSM-III Case Book. Washington, D.C. Arnold, M. B. (1970). Función cerebral en la emoción: un análisis fenomenológico. En correlaciones fisiológicas de la emoción, ed. P. BLACK. Nueva York: Prensa académica, pp. 261-285. ASCH, S. S. S. (1976). Variedades de reacción terapéutica negativa y problemas de la técnica. /. Asociación Psicoanalítica Americana, 24: 383-407. Balint, M. (1968). La falla básica: aspectos terapéuticos de la regresión. Londres: Tavi- Stock Publicaciones. Bauer, S., Hunt, H., Gould, M., y Goldstein, E. (1980). Organización de la personalidad, diagnóstico estructural y la entrevista estructural. Psiquiatría, 43: 224-233. Beauvoir, S. DE (1972). La llegada de la edad. Nueva York: Putnam. 359

360 Referencias Belknap, I. (1956). Problemas humanos de un hospital mental estatal. Nueva York: McGraw-Hill. Bellak, L., Hurvich, M. y Gediman, H. (1973). Ego funciona en esquizofrénicos, neuróticos y normales. Nueva York: Wiley-intercience. Berezin, M. (1977). Psicología normal del proceso de envejecimiento revisado. II: El destino del narcisismo en la vejez: informes de casos clínicos. /. Psiquiatría geriátrica, 1: 9-26. Berezin, M., y Fern, D. (1967). Persistencia de problemas emocionales tempranos en una mujer de setenta años. /. Psiquiatría geriátrica, 1: 45-60. Bergeret, J. (1970). Les Etats Limites. Revue Franc.Aise de Psychanalyse, 34: 605-633. Bergmann, K. (1978). Trastornos de la neurosis y la personalidad en la vejez. En estudios en psiquiatría geriátrica, ed. A. D. Isaacs y F. POST. Nueva York: Wiley, pp. 41- 75- Bibring, E. (1954). Psicoanálisis y las psicoterapias dinámicas. /. Asociación Psicoanalítica Americana, 2: 745-770. Bick, E. (1968). La experiencia de la piel en las primeras relaciones de objetos. Internacional J. Psico-análisis, 49: 484-486. BION, W. R. (1952). Dynamics de grupo: una recepción. Internacional J. Psico-análisis, 33: 235-247- BION, W. R. (1961). Experiencias en grupos. Nueva York: libros básicos. BION, W. R. (1965). Transformaciones. Nueva York: libros básicos. BION, W. R. (1967). Segundo pensamiento: Papeles seleccionados sobre psicoanálisis. Nueva York: libros básicos. BION, W. R. (1970). Atención e interpretación. LONDRES: Heinemann. Blacker, K., y Tupin, J. (1977). Hysteria and hysterical structure: Developmen-
tal and social theories. En personalidad histérica, ed. M. Horowitz. Nueva York: Jason Aronson, pp. 95-142. Blinder, M. (1966). La personalidad histérica. Psiquiatría, 29: 227-235. Bloch, S., ed. (1979). Una introducción a las psicoterapias. Nueva York: Oxford University Press, PP. 196-220. Blum, H. (1980). El valor de la reconstrucción en el psicoanálisis adulto. Internacional J. Psico-análisis, 61: 39-54. Bromley, D. (1978). Se acerca al estudio de los cambios de personalidad en la vida adulta y la vejez. En estudios

en psiquiatría geriátrica, ed. A. D. Isaacs y F. POST. Nueva York: Wiley, PP. 17-40. Carr, A., Goldstein, E., Hunt, H., y Kernberg, O. (1979). Pruebas psicológicas y pacientes límite. /. Evaluación de la personalidad, 43: 582-590. Caudill, W. (1958). El hospital psiquiátrico como una pequeña sociedad. Cambridge: Harvard University Press. Chassegue-Smirgel, J. (1978). Reflexiones sobre las conexiones entre la perversión y el sadismo. Internacional J. Psico-análisis, 59: 27-35. Chodoff, P., y Lyons, H. (1958). La histeria, la personalidad histérica y la conversión "hysporical". Americano]. Psiquiatría, 114: 734-740.

Referencias 361 Davanloo, H., Ed. (1980). Psicoterapia dinámica a corto plazo. Nueva York: Jason Aronson. Deutsch, F. (1949). Psicoanálisis aplicado. Nueva York: Grune & Stratton. Dewald, P. (1971). Psicoterapia: un enfoque dinámico. Nueva York: libros básicos. EASSER, B. (1966). Resistencia de la transferencia en la neurosis de carácter histérico: consideraciones técnicas. En los desarrollos en psicoanálisis en la Universidad de Columbia, Ed. G. Goldman y D. Shapiro. Nueva York: Hafner, pp. 69-80. EASSER, B., Y MENOS, S. (1965). Personalidad histérica: una reevaluación. Psico-analítico trimestral, 34: 390-405. Edelson, M. (1970). Socioterapia y psicoterapia. Chicago: Universidad de Chicago Press. Eissler, K. (1950). El Instituto Chicago de Psicoanálisis y el sexto período del desarrollo de la técnica psicoanalítica. /. Psicología general, 42: 103-157. Eissler, K. (1953). Los efectos de la estructura del ego en tecnología psicoanalítica. /. Asociación Americana Psicoanalítica, 1: 104-143. Emde, R., Kligman, D. H., Reich, J. H. y Wade, T. D. (1978). Experión emocional en la infancia. I: Estudios iniciales de señalización social y un modelo emergente. En el desarrollo del efecto, ed. M. Lewis y L. Rosenblum. NUEVA YORK: PLENUM PRENSA, PP. 125-148. Ezriel, H. (1950). Un enfoque psicoanalítico para el tratamiento de pacientes en grupos. /. Ciencia mental, 96: 774-779. (Fairbairn, W. (1954). Una teoría de las relaciones de objetos de la personalidad. Nueva York: Libros básicos. Feeder, P. (1952). Psicología del ego y las psicosis. Nueva York: Libros básicos. Fenichel, O. (1941). Problemas de la técnica psicoanalítica. Albany: Psicoanalítico Quarterly, Inc. Fenichel, O. (19453). Neurótico actuando hacia fuera. Revisión psicoanalítica, 39: 197-206. Fenichel, O. (I945B). La teoría psicoanalítica de la neurosis. Nueva York: Norton. Ferenczi, S. (1919). Sobre la técnica del psicoanálisis. En mayores contribuciones a la teoría y la técnica del psicoanálisis. Nueva York: Libros básicos, 1952. Frances, A. (1980). La sección de trastornos de la personalidad DSM-III: un comentario. Americano]. Psiquiatría, 137: 1050-1054. Frances, A. y Cooper, A. (1980). El DSM-III

Controversia: Perspectivas psicoanalíticas. Boletín de la Asociación de Medicina Psicoanalítica, 19: 37-43. Frances, A. y Cooper, A. (1981). Psiquiatría descriptiva y dinámica: una perspectiva en DSM -iii. American J. Psychiatry, 138: 1198-1202. Freud, A. (1936). El ego y los mecanismos de defensa. Los escritos de Anna Freud, 2. Nueva York: Universidades internacionales Press, 1966. Freud, A. (1968). Actuando fuera Internacional J. Psico-análisis, 49: 165-170. Freud, E., y Meng, H., Eds. (1963). Psicoanálisis y fe. Nueva York: libros básicos. Freud, S. (1914). En el narcisismo. Edición estándar, 14: 69-102. LONDRES: HOGARTH Press, 1957.

362 Referencias Freud, S. (1916). Algunos tipos de personajes se reunieron en el trabajo psicoanalítico. Edición de Stan-Dard, 14: 309-333. Londres: Hogarth Press, 1957. Freud, S. (1923). El ego y la identificación. Edición estándar, 19: 3-66. LONDRES: HOGARTH Press, 1961. Freud, S. (19303). La civilización y sus descontentos. Edición estándar, 21: 59-145. Londres: Hogarth Press, 1930. Freud, S. (1930!)). Das Unbehagen en Der Kultur. GesamMelte Werke, 14: 421-506. Londres: lmago, 1948. Fromm-Reichmann, F. (1950). Principios de psicoterapia intensiva. Chicago: Universidad de la prensa de Chicago. FROMM-REICHMANN, F. (1959). Psicoanálisis y psicoterapia: papeles seleccionados. Chicago: Universidad de Chicago Press. FROSCH, J. (1964). El carácter psicótico: consideraciones psiquiátricas clínicas. Psy- Chiatric trimestral, 38: 91-96. FROSCH, J. (1970). Consideraciones psicoanalíticas del carácter psicótico. /. Asociación Americana Psicoanalítica, 18: 24-50. FROSCH, J. (1971). Técnica con respecto a algunos defectos de ego específicos en el tratamiento de los pacientes con límites. Psiquiatría trimestral, 45: 216-220. Purer, M. (1977). Organización de la personalidad durante la recuperación de un niño pequeño severamente disgustado. En los trastornos de la personalidad límite, ed. P. Hartocollis. New
York: International Universities Press, pp. 457-473. Galeenson, E., y Roiphe, H. (1977). Algunas revisiones sugeridas en relación con el desarrollo femenino temprano. En psicología femenina, ed. H. P. BLUM. NUEVA YORK: INTERNACIONALES PRENSA, PP. 29-57. Gedo, J. (1964). Conceptos para una clasificación de las psicoterapias. Internacional J. Psico-análisis, 45: 530-539. Gelerd, E. R. (1958). Fronteras estados en la infancia y la adolescencia. Estudio psico-analítico del niño, 13: 279-285. New York: International Universities
Press. Gianturco, D., y Busse, E. (1978). Problemas psiquiátricos encontrados durante un estudio a largo plazo de los voluntarios de envejecimiento normal. En estudios en

psiquiatría geriátrica, ed. A. D. Isaacs y F. POST. Nueva York: Wiley, PP. 1-16. Gill, M. (1951). Ego Psicología y psicoterapia. Psicoanalítico trimestral, 20: 62-71. Gill, M. (1954). Psicoanálisis y psicoterapia exploratoria. /. Asociación Americana Psy-Choanalytic, 2: 771-797. Gill, M. (1980). El análisis de la transferencia: una crítica de los problemas de Fenichel de la técnica psicoanalítica. Psicoterapia internacional psicoanalítica J. 8: 45-55. Gill, M. (1982). Análisis de la transferencia, vol. yo. NUEVA YORK: Universidad Internacional Press. Gill, M., Newman, R., y Redlich, F. (1954). La entrevista inicial en la práctica psiquiátrica. New York: International Universities Press. Giovacchini, P. (1975). Psicoanálisis de los trastornos del carácter. Nueva York: Jason Aronson.

Referencias 363 Giovacchini, P. (1978). El tratamiento psicoanalítico del paciente alienado. En nuevas perspectivas sobre la psicoterapia del Borderline Adult, Ed. J. F. Masterson. Nueva York: Brunner / Mazel, PP. 3-19. Giovacchini, P. (1979). Los muchos lados de la indefensión: el paciente límite. En los avances en la psicoterapia del paciente fronterizo, ed. J. LEBLEIT Y A. CAP- PONI. Nueva York: Jason Aronson, pp. 227-267. Glover, E. (1955). La técnica del psicoanálisis. Nueva York: Universidades internacionales Press. Goffman, E. (1961). Asilos. Nueva York: Ancla, Doubleday. '> Goldberg, A., ed. (1978). La psicología del yo: un libro de casos. New York: International Universities Press. Goldstein, M., y Jones, J. (1977). Precursores adolescentes y familiares de las condiciones de la línea fronteriza y esquizofrénicas. En los trastornos de la personalidad límite, ed. P. hartocollis. New York: International Universities Press, pp. 213-229. Verde, A. (1977). El concepto límite. En los trastornos de la personalidad límite, ed. P. Hartocollis. New York: International Universities Press, pp. 15-44. Greenacre, P. (1950). Problemas generales de actuar. Psicoanalítico trimestral, 19: 455-467- Greenacre, P. (1963). Problemas de actuar en la relación de transferencia. /. American Academy Child Psychiatry, 2: 144-175. Greenacre, P. (1968). El proceso psicoanalítico, transferencia y actuación. Internacional} '. Psico-análisis, 49: 211-218. Greenson, R. (1954). La lucha contra la identificación. /. Asociación Americana de Psicoana, 2: 200-217. Greenson, R. (1958). En las defensas de la pantalla, el hambre de la pantalla y la identidad de la pantalla. /. Asociación Americana Psicoanalítica, 6: 242-262. Greenson, R. (1965). La alianza trabajadora y la neurosis de transferencia. Psico-analítico trimestral, 34: 155-181. Greenson, R. (1970). La única relación de terapeuta paciente en los pacientes límite. Presentado en la reunión anual de la Asociación Psiquiátrica Americana. No publicados. Grinberg, L. (1968). En actuar y su papel en el proceso psicoanalítico. In-Ternacional J. Psico-análisis, 49: 171-178.

. . . .

Grinberg, L. (1979). Contrariedad proyectiva y contratransferencia. En la contrarresta, ed. L. Epstein y A. Feiner. Nueva York: Jason Aronson, pp. 169-192. GRANKER, R. (1975). Neurosis, psicosis y los estados fronterizos. En el libro de texto integral de psiquiatría, II, ED. H. I. Kaplan, A. M. Freedman, y B. J. Sa- Dock. Baltimore: Williams & Wilkins, pp. 845-850. Pinker, R., et al. (1961). Trabajo social psiquiátrico. Nueva York: libros básicos. Pinker, R., Werble, B., y Drye, R., Eds. (1968). El síndrome límite. Nueva York: libros básicos. Gross, H. (1974). Depresión y personalidades sadomasquistas. En los trastornos de la personalidad, ed. J. R. León. Baltimore: Williams & Wilkins, pp. 178-192.

364 Referencias Grunberger, B. (1979). Narcisismo: ensayos psicoanalíticos. New York: International
Universities Press. Gunderson,}. (1977). Características de las líneas fronterizas. En los pedidos de personalidad limítrofe, ed. P. Hartocollis. New York: International Universities Press, pp.
173-192. Gunderson, J. (1982). Estudios empíricos del diagnóstico límite. En psiquiatría 1982: la Revisión Anual de la Asociación Americana de Psiquiátrica. Washington, D.C .: Prensa psiquiátrica americana, págs. 415-436. Gunderson, J., y Kolb, J. (1978). Características discriminatorias de los pacientes límite. American J. Psychiatry, 135: 792-796. Gunderson, J., Kolb, J. y Austin, V. (1981). La entrevista de diagnóstico para los bor- derribos (DIB). American J. Psychiatry, 138: 896-903. Gunderson, J., y Singer, M. (1975). Definición de pacientes con límites: una vista excesiva. American J. Psychiatry, 133: 1-10. Guntrip, H. (1968). Fenómenos esquizoides, relaciones de objetos y el yo. New York:
International Universities Press. Hartmann, H. (1950). Comentarios sobre la teoría psicoanalítica del ego. En es- dice en la psicología del ego. Nueva York: Universidades Internacionales Press, 1964, pp. 113-141. Hartmann, H. (1955). Notas sobre la teoría de la sublimación. En ensayos sobre la psicología del ego. Nueva York: Universidades Internacionales Press, 1964, pp. 227-240. Hartmann, H. (1964). Ensayos en la psicología del ego. Nueva York: Universidades Internacionales Press. Hartmann, H., Kris, E., y Lowenstein, R. (1946). Comentarios sobre la formación de la estructura psíquica. Estudio psicoanalítico del niño, 2: 11-38. New York: In-
ternational Universities Press. Hartocollis, P. (1977). Afecta en los trastornos límite. En los trastornos de la personalidad límite, ed. P. Hartocollis. New York: International Universities Press, pp.

. .

495-507. Heimann, P. (19553). Una combinación de mecanismos de defensa en los estados paranoicos. En nuevas direcciones en psicoanálisis, ed. M. Klein, P. Heimann, y R. Money- Kyrle. Londres: Publicaciones de Tavistock, pp. 240-265. Heimann, P. (I955B). Una contribución a la reevaluación del complejo de edipus: los primeros estados. En nuevas direcciones en psicoanálisis, ed. M. Klein, P. Heimann, y R. Money-Kyrle. Nueva York: Libros básicos, PP. 23- 38. Heimann, P. (1956). Dinámica de las interpretaciones de transferencia. Internacional J. Psico-análisis, 37: 303-310. Heimann, P. (1960). Contratransferenciales. Británica J. Psicología médica, 33: 9-15. Herz, M. (1971). Día contra hospitalización hospitalaria: un estudio controlado. Americana puede]. Psiquiatría, 127: 1371-1382. Herz, M. (1980). Hospitalización parcial, breve hospitalización y después de tareas. En el libro de texto completo de la psiquiatría, HI, ED. H. I. Kaplan, A. M. Freedman, y B. J. Sadock. Baltimore: Williams & Wilkins, pp. 2368-2381.

Referencias 365 Herz, M, Endicott, J. y Spitzer, R. (1975). Breve hospitalización de pacientes con familias: resultados iniciales. American J. Psychiatry, 132: 413-418. Hill, L. (1955). Intervención psicoterapéutica en la esquizofrenia. Chicago: Universidad de Chicago Press. Hoch, P., y Polatin, P. (1949). Formas pseudoneuróticas de esquizofrenia. Psychi-Tesh trimly, 23: 248-276. Hoffman, M. (1978). Hacia una teoría de la excitación y el desarrollo empático. En el desarrollo del efecto, ed. M. Lewis y L. Rosenblum. NUEVA YORK: PLENUM PRENSA, PP. 227-256. Hollon, T. (1962). Una justificación para la psicoterapia de apoyo de los pacientes deprimidos. American J. Psychiatry, 16: 655-664. Holzman, P., y Ekstein, R. (1959). Repetición: funciones del pensamiento transitorial regañista. Psicoanalítico trimestral, 28: 228-235. Izard, C. (1978). Sobre la ontogénesis de las emociones y las relaciones de cognición emocional en la infancia. En el desarrollo del efecto, ed. M. Lewis y L. Rosen-Blum. Nueva York: PRENSA DE PLENUM, PP. 389-413. Izard, E., y Buechler, S. (1979). Expresiones de emociones y integración de personalidad en la infancia. En emociones en personalidad y psicopatología, ed. C. Izard. NUEVA YORK: PRENSA DE PLENUM, PP. 447-472. Jacobson, E. (1954). Contribución a la metapsicología de las identificaciones psicóticas. /. Asociación Psicoanalítica Americana, 2: 239-262. Jacobson, E. (1961). Los estados de ánimo de los adolescentes y la remodelación de las estructuras psíquicas en la adolescencia. Estudio psicoanalítico del niño, 16: 164-183. New York: Inter-
national Universities Press. Jacobson, E. (1964). El yo y el mundo del objeto. Nueva York: Universidades internacionales Press. Jacobson, E. (1971). La depresión. New York: International Universities Press. Johnson, A. (1949). Sanciones por la lagunas de los adolescentes de los adolescentes. En los reflectores de delincuencia, ed. K. R. Eissler. New York: International Universities Press,
pp. 225-245. Jones, M. (1953). La comunidad terapéutica: un nuevo método de

. . .

tratamiento en psiquiatura. Nueva York: libros básicos. Jones, M. (1956). El concepto de la comunidad terapéutica. American J. Psychia- Pruebe, 112: 647-650. KANZER, M. (1968). Alteración del ego y actuando. Internacional J. Psico-análisis, 49: 431-435- Kernberg, O. (1975). Condiciones fronterizas y narcisismo patológico. Nueva York: Jason Aronson. Kernberg, O. (1976). Teoría de las relaciones de objeto y psicoanálisis clínico. Nueva York: Jason Aronson. Kernberg, O. (1977). Psicología normal del proceso de envejecimiento revisado-II. /. Psiquiatría geriátrica, 10: 27-45. Kernberg, O. (1980). Mundo interno y realidad externa. Nueva York: Jason Aronson.

366 Referencias Kernberg, O., Burstein, E., Coyne, L., Appelbaum, A., Horwitz, L. y Voth, H. (1972). Psicoterapia y psicoanálisis: Informe Final del Proyecto de Investigación de Psicoterapia Fundación de Menninger. Boletín de la Clínica Menninger, 36: 1-275. Kernberg, O., Goldstein, E., Carr, A., Hunt, H., Bauer, S., y Blumenthal, R. (1981). Diagnóstico de la organización de la personalidad límite. /. Enfermedad nerviosa y mental, 169: 225-231. Kernberg, P. (1982). Condiciones fronterizas: aspectos infantiles y adolescentes. En el niño límite: enfoques a la etiología, diagnóstico y tratamiento, ed. K. S. S. Robson. Nueva York: McGraw-Hill, pp. 101-119. Khan, M. (1974). La privacidad del yo: papeles en la teoría psicoanalítica y la tecnología. New York: International Universities Press. Kleeman, J. (1977). Opiniones de Freud sobre la sexualidad femenina temprana a la luz de la observación directa del niño. En psicología femenina, ed. H. P. BLUM. NUEVA YORK: UNIVERSIDADES INTERNACIONALES PRENSA, PP. 3-27. Klein, D. (1975). Psicofarmacología y el paciente límite. En estados fronterizos en psiquiatría, ed. J. E. Mack. Nueva York: Grune & Stratton, pp. 75-92. Klein, D. (1977). Tratamiento psicofarmacológico y delineación de trastornos límite. En los trastornos de la personalidad límite, ed. P. Hartocollis. NUEVA YORK: INTERNACIONES DE UNIVERSIDADES PRENSA, PP. 365-383. Klein, M. (1940). Logro y su relación con los estados maníacos-depresivos. En las contriniones al psicoanálisis, 1921-1945. LONDRES: HOGARTH Press, 1948, pp. 311-338. Klein, M. (1945). El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas. En contribuciones al psicoanálisis, 1921-1945. LONDRES: HOGARTH Press, 1948, pp. 311-338. Klein, M. (1946). Notas sobre algunos mecanismos esquizoides. En los desarrollos en psicoanálisis, ed. J. Riviere. Londres: Hogarth Press, 1952, pp. 292-320. Klein, M. (1957). Envidia y gratitud. Nueva York: libros básicos. Klein, M. (1963). Nuestro mundo adulto. Nueva York: libros básicos. Caballero, R. (1952). Una evaluación de técnicas psicoterapéuticas. En psicología

psicoanítica y psicología, ed. R. P. Knight y C. R. Friedman. NUEVA YORK: UNIVERSIDADES INTERNACIONALES PRENSA, 1954, pp. 65-76 Knight, R. (19533). Estados fronterizos. En psiquiatría psicoanalítica y psicología, ed. R. P. Knight y C. R. Friedman. NUEVA YORK: INTERNACIONALES DE UNIVERSIDADES Press, 1954, pp. 97-109. Caballero, R. (I953B). Gestión y psicoterapia del paciente esquizo-etríneo límite. En psiquiatría psicoanalítica y psicología, ed. R. P. Knight y C. R. Friedman. NUEVA YORK: UNIVERSIDADES INTERNACIONALES Press, 1945, pp. 110-122. Kohut, H. (1971). El análisis del yo. New York: International Universities
Press. Kohut, H. (1972). Pensamientos sobre el narcisismo y la rabia narcisista. Estudio psicoanalítico del niño, 27: 360-400. Nueva York / Chicago: Cuadrangular libros.

Referencias 367 Kohut, H. (1977). La restauración del yo. New York: International Universities
Press. Kraepelin, E. (1904). Conferencias en psiquiatría clínica. Nueva York: Madera. Krohn, A. (1978). HISTERIA: La tize la neurosis. Nueva York: Universidades Internacionales Press. Kroll,]., SIFERS, L., MARTIN, K., LARI, S., PYLE, R., Y ZANOLER, J. (1981). Trastorno de la personalidad de la línea fronteriza: Construir la validez del concepto. Archivos de psiquiatría general, 38: 1021 -1026. Langs, R. (1973). La técnica de la psicoterapia psicoanalítica, vol. yo. Nueva York: Jason Aronson, pp. 538-598. Laplanche, J., y Pontalis, J.-B. (1973). El lenguaje del psicoanálisis. Nueva York: Norton. Laughlin, H. (1967). Las neurosis. Nueva York: Appleton-Century-Crofts. Lazare, A. (1971). El carácter histérico en la teoría psicoanalítica. Archivos de psiquiatría general, 25: 131-137. Levine, M. (1942). Psicoterapia en la práctica médica. Nueva York: Macmillan. Limentani, A. (1966). Una reevaluación de actuar en relación con el trabajo. Internacional J. Psico-análisis, 47: 274-282. Poco, M. I. (1951). Contrarransferencia y la respuesta del paciente a ella. Internacional J. Psico-análisis, 32: 32-40. Poco, M. I. (1957). "R": la respuesta total del analista a las necesidades de su paciente. Inter-Nacional J. Psico-análisis, 38: 240-254. Poco, M. I. (1958). En la transferencia delirante (psicosis de la transferencia). Interna- cional). Psico-análisis, 39: 134-138. Poco, M. I. (1960). En la unidad básica. Internacional J. Psico-análisis, 41: 377-384, 637. Poco, M. I. (1966). Transferencia en estados fronterizos. Internacional]. Psycho-Analysis, 47: 476-485. Poco, M. I. (1981). Transferencia de neurosis y psicosis de transferencia. Nueva York: Ja- Sonon Aronson. Loewald, H. (1960). Sobre la acción terapéutica del psicoanálisis. Internacional J. Psico-análisis, 41: 16-33. Lorenz, K. (1963). Sobre la agresión. Nueva York: Bantam Libros. LUBORSKY, L., et al. (1958). Variables de tratamiento. El proyecto de investigación de psicoterapia de la Fundación

Menninger, 2D. Boletín de la Clínica Menninger, 22: 126-147. McDougall, J. (1979). Comunicación primitiva en el uso de la contratransferencia. En la contrarresta, ed. L. Epstein y A. Feiner. Nueva York: Jason Aron-Sun, PP. 267-304. Mackinnon, R., y Michels, R. (1971). La entrevista psiquiátrica en la práctica clínica. Filadelfia: Saunders. Macleod, J., y Middelman, F. (1962). MIÉRCOLES DE LA TARDE DE LA TARDE: un programa de atención suplicante. Archivos de psiquiatría general, 6: 56-65.

368 Referencias Mahler, M. (1971). Un estudio del proceso de individuación separatibn y su posibilidad de su aplicación a los fenómenos límite en la situación psicoanalítica. Estudio psicolítico del niño, 26: 403-424. Nueva York / Chicago: Cuadrangular libros. Mahler, M. (1972). Surfase de acercamiento del proceso de separación-individualización. Psicoanalítico trimestral, 41: 487-506. Mahler, M. (1979). Papeles seleccionados de Margaret S. Mahler. Nueva York: Jason Aronson. Mahler, M., y Puser, M. (1968). Sobre la simbiosis humana y las vicisitudes de la independimiento. New York: International Universities Press. Mahler, M., y Kaplan, L. (1977). Aspectos de desarrollo en la evaluación de las personalidades narcisísticas y las llamadas personalidades límite. En los pedidos de personalidad limítrofe, ed. P. Hartocollis. NUEVA YORK: UNIVERSIDADES INTERNACIONALES Press, pp. 71-85. Mahler, M., Pine, F. y Bergman, A. (1975). El nacimiento psicológico del bebé humano. Nueva York: libros básicos. Main, T. (1946). El hospital como institución terapéutica. Boletín de la Clínica Menninger, 10: 66-70. Main, T. (1957). La dolencia. Británica J. Psicología médica, 30: 129-145. Masterson, J. F. (1967). El dilema psiquiátrico de la adolescencia. BOSTON: Poco, marrón. Masterson, J. F. (1972). Tratamiento del límite adolescente: un enfoque de desarrollo. Nueva York: Wiley-intercience. Masterson, J. F. (1976). Psicoterapia del límite de adulto: un enfoque de desarrollo. Nueva York: Brunner / Mazel. Masterson, J. F. (1978). El Borderline Adult: Transferencia actuando y trabajando. En nuevas perspectivas sobre la psicoterapia del Borderline Adult, Ed. J. F. Masterson. Nueva York: Brunner / Mazel, pp. 121-147. Masterson, J. F. (1980). De la orinalmente adolescente al adulto que funcione. Nueva York: Brunner / Mazel. Meltzer, D. (1973). Estados de la mente sexuales. Perthshire, Escocia: Clunie. Menninger, K. (1952). Un manual para el estudio de caso psiquiátrico. Nueva York: Grune & Stratton. Menninger, W. (1936). Terapia hospitalaria psiquiátrica diseñada para satisfacer las necesidades inconsciales. En psiquiatra para un mundo con

problemas, vol. yo. Kansas City, Mo.: Hallmark, 1967, pp. 375-385. Menninger, W. (1943). Fundamentos de la psiquiatría. Topeka: Capper. Meyer, A. (1957). Psicobiología: una ciencia del hombre. Springfield, 111.: Charles C Thomas. Miller, I. (1969). Interpretación como una técnica de apoyo en psicoterapia. BULTETET DE LA CLÍNICA DE MENINGINGER, 33: 154-164. MILLON, T. (1981). Trastornos de la personalidad: DSM-I1I: Axis II. Nueva York: Wiley. MODELL, A. (1976). "El entorno de tenencia" y la acción terapéutica de Psy-Choanálisis. /. Asociación Psicoanalítica Americana, 24: 285-307.

Referencias 369 Dinero, J., y EHRHARDT, A. (1972). Hombre 6 * Mujer, niño 6 * niña. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Dinero-Kyrle, R. (1956). Contransferencia normal árida árida algunas de sus desviaciones. Internacional /. Psico-análisis, 37: 360-366. Moore, B. (1968). Contribución al simposio en actuar. Internacional J. Psy-cho-cho-análisis, 49: 182-184. Moore, B., y Multa, B. (1968). Un glosario de términos y conceptos psicoanalíticos. Nueva York: Asociación Americana Psicoanalítica. Novey, S. (1959). La técnica de la terapia de apoyo en psiquiatría y psicocálisis. Psiquiatría, 22: 179-187. Olinek, S. (1964). La reacción terapéutica negativa. Internacional J. Psychocalizamsis, 45: 540-548. Orwell, G. (1949). 1984. Nueva York: Harcourt. Panel (1957). Actuando y su relación con los trastornos impulsos, M. kanzer, reorganización. /. Asociación Americana Psicoanalítica, 5: 136-145. Panel (1970). Acción, actuando y el acto sintomático, N. Atkins, reportero. /. Asociación Psicoanalítica Americana, 18: 631-643. Panel (1977). Variedades de distorsiones de edición previsa en patholisties de carácter severo, W. S. Robbins, reportero. /. Asociación Psicoanalítica Americana, 25: 201- 218. Pasamanick, B., Scarpitti, F. y Dinitz, S. (1967). Esquefrenia en la comunidad: un estudio experimental en la prevención de la hospitalización. Nueva York: Appleton-Century-Crofts. Paz, C. (1976). Estructuras y estados fronterizos en ninos, adolescentes y adultos. Bue-NOS AIRES: Gratica Santo Domingo. Perry, J., y Klerman, G. (1980). Características clínicas del trastorno de personalidad límite. American J. Psychiatry, 137: 165-173. Plutchik, R. (1980). Emociones: una síntesis psicoevolutiva. Nueva York: Harper & Row. Papa, H., Jones, J., Hitos, J., Cohen, B., y Gunderson, J. (1983). La validez del trastorno de personalidad límite DSM-III. Archivos de psiquiatría general, 40: 23-30. Powdermaker, F. (1948). Las técnicas de la entrevista inicial y los métodos de enseñarlos. American J. Psychiatry, 104: 642-646. Rabkin, L. (1965). La agresividad pasiva y el aprendizaje. Niño excepcional, 32: 1-3. Ritero, H.

(1957). El significado y los usos de la contratansferencia. Psicoanalítico trimestral, 26: 303-357. Ritero, H. (1968). Transferencia y contratransferencia. New York: International
Universities Press. Rangell, L. (1968). Un punto de vista de actuar. Internacional J. Psico-análisis, 49: 195-201. RAPAPORT, D. (1960). La estructura de la teoría psicoanalítica. Problemas psicológicos, monografía 6. Nueva York: Universidades internacionales Press.

370 Referencias RAPAPORT, D. (1967). Papeles recolectados de David Rapaport, Ed. M. M. Gill. Nueva York: libros básicos. RAPAPORT, D., Y GILL, M. M. (1959). Los puntos de vista y suposiciones de la metapsicología. Internacional J. Psico-análisis, 40: 153-162. Reich, A. (1951). En la contratransferencia. Contribuciones psicoanalíticas. NUEVA YORK: UNIVERSIDADES INTERNACIONALES Press, 1973, pp. 136-154. Reich, W. (1933). Análisis de caracteres. Nueva York: Farrar, Straus, & Giroux, 1972. Reinser, N. (1957). Psicosis de la transferencia. /. Hospital Hillside, 6: 131-149. Rexford, E., ed. (1978). Un enfoque de desarrollo para los problemas de actuación, rediseñada edición. New York: International Universities Press. Rey, J. (1979). Fenómenos esquizoides en el límite. En los avances en psicotery-apy del paciente fronterizo, ed. J. LEBOIT Y A. CAPPONI. Nueva York: Jason Aronson, pp. 449-484. Arroz, A. K. (1965). Learning for Leadership. LONDRES: Publicaciones de Tavistock. Rinsley, D. (1977). Una vista de objetos-relaciones de la personalidad límite. En los trastornos de la personalidad de la línea fronteriza, ed. P. Hartocollis. Nueva York: Universidad Internacional Press, PP. 47-70. Rinsley, D. (1980). Tratamiento del adolescente severamente perturbado. Nueva York: Jason Aronson. Riviere, J. (1936). Una contribución al análisis de la reacción terapéutica negativa. Internacional J. Psico-análisis, 17: 304-320. Robins, L. (1966). Niños desviados crecidos. Baltimore: Williams & Wilkins. Rogers, C. (1951). Terapia centrada en el cliente. Boston: Houghton Mifflin. Romm, M. (1957). Episodios psicóticos transitorios durante el psicoanálisis. /. Ameri- CAN Asociación Psicoanalítica, 5: 325-341. Rosenfeld, H. (1963). Notas sobre la psicopatología y el tratamiento psicoanalítico de la esquizofrenia. En la psicoterapia de la esquizofrenia y los estados maníacos-depresivos (Informe de investigación psiquiátrica No. 17), ed. H. Azima y B. C. Glueck, Jr. Washington, D.C.: Asociación Americana de Psiquiatría, PP. 61-72. Rosenfeld, H. (1964). Sobre la psicopatología del narcisismo: un enfoque clínico. Internacional J.

Psico-análisis, 45: 332-337. Rosenfeld, H. (1966). La necesidad de pacientes para actuar durante el análisis. Foro Psicoana-Lítico, 1: 19-29. Rosenfeld, H. (1971). Un enfoque clínico para la teoría psicoanalítica de los instintos de vida y muerte: una investigación sobre los aspectos agresivos del narcisismo. Internacional]. Psico-análisis, 52: 169-178. Rosenfeld, H. (1975). Reacción terapéutica negativa. En tácticas y técnicas en terapia psicoanalítica, vol. II, Contrarransferencia, Ed. P. L. Giovacchini. Nueva York: Jason Aronson, pp. 217-228. Rosenfeld, H. (1978). Notas sobre la psicopatología y el tratamiento psicoanalítico de algunos pacientes límite. Internacional J. Psico-análisis, 59: 215-221. Rosenfeld, H. (19793). Dificultades en el tratamiento psicoanalítico de los pacientes límite. En los avances en la psicoterapia del paciente fronterizo, ed. J. LEBOIT Y A. CAPPONI. Nueva York: Jason Aronson, pp. 187-206.

Referencias 371 Rosenfeldx H. (I979B). Psicosis de transferencia en el paciente límite. En avances en psicoterapia del paciente límite, ed. J. LEBOIT Y A. CAPPONI. Nueva York: Jason Aronson, pp. 485-510. Schilder, P. (1938). La psicoterapia. Nueva York: Norton, 1951. Schlesinger, H. (1969). Diagnóstico y prescripción para la psicoterapia. Boletín de la Clínica Menninger, 33: 269-278. Schneider, K. (1950). Terapia psicoanalítica con el límite adulto: algunos principios relacionados con la técnica. En nuevas perspectivas sobre la psicoterapia del abordelline adulto, ed. J. Masterson. Nueva York: Brunner / Mazel, PP. 41-65. Searles, H. (1965). Papeles recogidos en la esquizofrenia y sujetos relacionados. New York:
International Universities Press. Searles, H. (1977). Procesos de identidad dual y múltiple en funciones límite del ego. En los trastornos de la personalidad límite, ed. P. Hartocollis. NUEVA YORK: INTERNACIONALES DE UNIVERSIDADES PRENSA, PP. 441-455. Searles, H. (1978). Terapia psicoanalítica con el límite adulto: algunos principios relacionados con la técnica. En nuevas perspectivas sobre la psicoterapia del adulto de la línea fronteriza, ed. J. Masterson. Nueva York: Brunner / Mazel, PP. 41-65. Searles, H. (1979). La contrarresta con el paciente límite. En avances en psicoterapia del paciente límite, ed. J. LEBOIT Y A. CAPPONI. Nueva York: Jason Aronson, pp. 309-346. Segal, H. (1964). Introducción al trabajo de Melanie Klein. Nueva York: libros básicos. Segal, H. (1967). Técnica de Melanie Klein. En técnicas psicoanalíticas: un libro para el psicoanalista practicante, ed. B. Wolman. NUEVA YORK / LONDRES: LIBROS BÁSICOS, PP. 168-190. Segal, H. (1979). Klein. Glasgow: Collins. Selzer, M. (1981). La entrevista del consultor. No publicados. Shapiro, D. (1965). Estilos neuróticos. Nueva York: libros básicos. Shapiro, E., Zinner, J., Shapiro, R., y Berkovitz, D. (1975). La influencia de la experiencia familiar en el desarrollo de la personalidad límite. Psico-análisis de la revisión internacional, 2: 399-412. Sharpe, E. (1931). Ansiedad: brote y resolución. En

papeles recopilados sobre psicoanálisis, ed. M. BRIERLY. Nueva York: Brunner / Mazel, 1978, pp. 67-80. Simmel, E. (1929). Tratamiento psicoanalítico en un sanatorio. Internacional J. Psico-análisis, 10: 70-89. Pequeño, T., pequeño, J., Alig, V., y Moore, D. (1970). Trastorno personal-agresivo: una búsqueda de un síndrome. American J. Psychiatry, 126: 973-983. Spitz, R. (1965). El primer año de vida. New York: International Universities Press. Spitz, R. (1972). Puentes: sobre anticipación, duración y significado. /. Asociación Psicoanalítica Americana, 20: 721-735. Spitzer, R., y Williams,). (1980). Clasificación del trastorno mental y DSM-III. En el libro de texto integral de la psiquiatría, III, ED. H. I. Kaplan, A. M. Freedman, y B. J. Sadock. Baltimore: Williams & Wilkins, pp. 1035-1072. Stafford-Clark, D. (1970). Psicoterapia de apoyo. En las tendencias modernas en psicología.

372 Referencias Medicina lógica, vol. 2, ed. D. J. Precio. Nueva York: Appleton-Century-Crofts, pp. 277-295. Stanton, A., y Schwartz, M. (1954). El hospital psiquiátrico. Nueva York: libros básicos. Stern, A. (1938). Investigación psicoanalítica y terapia en el grupo fronterizo de neurosis. Psicoanalítico trimestral, 7: 467-489. Stoller, R. (1977). Feminidad primaria. En psicología femenina, ed. H. P. BLUM. New York: International Universities Press, pp. 59-78. Piedra, L. (1954). El alcance amplio de las indicaciones para el psicoanálisis. /. Ameri- CAN Asociación Psicoanalítica, 2: 567-594. Piedra, M. (1980). Los síndromes límite. Nueva York: McGraw-Hill. Piedra, M. (1981). Síndromes límite: una consideración de subtipos y una visión general, instrucciones para la investigación. En las clínicas psiquiátricas de América del Norte, Vol. 4. Filadelfia: Saunders, pp. 3-24. Strachey, J. (1934). La naturaleza de la acción terapéutica para el psicoanálisis. IN-Ternacional]. Psico-análisis, 15: 127-159. Sullivan, H. (19533). Concepciones de la psiquiatría moderna. Nueva York: Norton. Sullivan, H. (1953. La teoría interpersonal de la psiquiatría. Nueva York: Norton. Sullivan, H. (1954). La entrevista psiquiátrica. Nueva York: Norton. Sullivan, H. (1956). Estudios clínicos en psiquiatría. Nueva York: Norton. Sullivan, H, (1962). La esquizofrenia como proceso humano. Nueva York: Norton. Sutherland, J. (1952). Notas sobre la terapia de grupo psicoanalítico. I: Terapia y entrenamiento. Psiquiatría, 15: 111-117. Tarachow, S. (1963). Una introducción a la psicoterapia. Nueva York: Universidades internacionales Press. Ticho, E. (1972). Terminación del psicoanálisis: Metas de tratamiento, Vida. Goles. Psy- Choanalytic Quarterly, 41: 315-333. Tinbergen, N. (1951). Un intento de síntesis. En el estudio del instinto. Nueva York: Oxford University Press, pp. 101-127. Torre, L. (1956). Contrarransferencia. /. Asociación Psicoanalítica Americana, 4: 224-255. Tramer, M. (1931). Personalidades psicopáticas. Schweizer Medizinische Wochen- Schrift, 217: 271-322. Valenstein, A. F. (1973). En el apego a los sentimientos dolorosos y la reacción

terapéutica negativa. Estudio psicoanalítico del niño, 28: 365-392. New Haven: Yale University Press. Volkan, V. D. (1976). Relaciones con objetos internalizados primitivos. NUEVA YORK: INTERNACIONALES PRENSA. Volkan, V. D. (1979). La "burbuja de vidrio" del paciente narcisista. En los avances en la psicoterapia del paciente fronterizo, ed. J. LEBOIT Y A. CAPPONI. Nueva York: Jason Aronson, pp. 405-431. Wallerstein, R. (1965). Los objetivos del psicoanálisis: una encuesta de puntos de vista analíticos. /. Asociación Psicoanalítica Americana, 3: 748-770.

Referencias 373 Wallerstein, R. (1966). El estado actual de la psicoterapia: teoría, práctica, investigación. En psicoterapia y psicoanálisis: teoría, práctica, investigación. NUEVA YORK: UNIVERSIDADES INTERNACIONALES PRENSA, 1975, PP. 135-186. Wallerstein, R. (1967). Reconstrucción y dominio en la psicosis de la transferencia. /. Asociación Psicoanalítica Americana, 15: 551-583. Wallerstein, R. (1969). Introducción al panel: psicoanálisis y psicoterapia. Internacional]. Psico-análisis, 50: 117-126. Wallerstein, R., y Robbins, L. (1956). El Proyecto de Investigación de Psicoterapia de la Fundación Menninger (Parte IV: Conceptos). Boletín de la Clínica Menninger, 20: 239-262. Whitehorn, J. (1944). Guía de entrevistas y estudio de personalidad clínica. AR-CUBIENCIA NEUROLOGÍA Y PSIQUIATRÍA, 52: 197-216. Whiteley, J., y Gordon, J. (1979). Enfoques de grupo en psiquiatría. Londres: Routledge & Kegan Pablo. Whitman, R., TroSman, H., y Koenig, R. (1954). Evaluación clínica de la personalidad pasiva-agresiva. Archivos Neurología y Psiquiatría, 72: 540-549. Will, O. (1967). Esquizofrenia: El problema de origen. En los orígenes de esquizofrenia, ed. J. Romano. Ámsterdam / Nueva York: Fundación Excerpta MEDICA, PP. 214-227. Wilson, E. O. (1975). Sociobiología: la nueva síntesis. Cambridge: PRENSA DE UNIVERIDAD DE HARVARD. Winnicott, D. (1949). Odio en la contra-transferencia. En papeles recogidos. Nueva York: Libros básicos, 1958, pp. 194-203. Winnicott, D. (1958). Papeles recolectados: a través de pediatría al psicoanálisis. Nueva York: libros básicos. Winnicott, D. (19603). Distorsión del ego en términos de ser verdadero y fase. En los procesos maduracionales y el entorno facilitador. Nueva York: Universidades Internacionales Press, 1965, pp. 140-152. Winnicott, D. (I960B). La teoría de la relación padre-infantil. En los procesos maduracionales y el entorno facilitador. NUEVA YORK: UNIVERSIDADES INTERNACIONALES Press, 1965, pp. 37-55. Winnicott, D. (1963). El desarrollo de la capacidad de preocupación. En los procesos maduracionales y el entorno facilitador.

. . . . .

Nueva York: Universidades Internacionales Press, 1965, pp. 73-82. Winnicott, D. (1965). Los procesos madurativos y el entorno facilitador. New York: International Universities Press. Zetzel, E. R. (1956). El concepto de transferencia. En la capacidad de crecimiento emocional. NUEVA YORK: UNIVERSIDADES INTERNACIONALES PRENSA, 1970, PP. 168-181. Zetzel, E. R. (1968). El llamado buen histérico. En la capacidad de crecimiento emocional. NUEVA YORK: UNIVERSIDADES INTERNACIONALES Press, 1970, pp. 229-245. Zetzel, E. R. (1971). Un enfoque de desarrollo para el paciente límite. Ameri- CAN J. Psiquiatría, 127: 867-871.

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

Índice Abraham, K., 80, 214 actuando: en terapia expresiva, 105, 115 -17, 120, 138-46; en terapia de apoyo, 159-60, 203-09; en la personalidad narcisista, 214-15; del narcisismo maligno, 308-09 Adler, G., 100 adolescentes: diagnóstico diferencial en, 52-67, 136-37; tratamiento de 131-38; actuando fuera de, 138-40; Nivel de suministro en, 277 afecta a: e interpretación de la resistencia, 218-24 Passim; y relaciones de objetos internalizados, 235; Como sistemas motivacionales, 235-36; y unidades, 236-38 agresión: en auto psicología, 186, 187-88; y narcisismo maligno, 194-95, 257; y la teoría del desarrollo, 232-38; y tratamiento de tratamiento, 242-48; Tolerancia del terapeuta para, 249-50, 269; Papel de los pacientes suicidas, 263; y contrarresta, 269; y supege patología, 281-82, 285-86 Alexander, F., 147, 148 Personalidad antisocial: en adolescentes, 62-67; e indicaciones de tratamiento, 170, 171, 257, 259, 278-79, 296, 301; En la personalidad narcisista, 196, 276, 278-82. Ver también SuperOgo - Arnold patológico, M., 235 "como" Personalidad, 196, 199 Asch, S., 241 Bauer, S., 7, 5in Beauvoir, S. DE, 68 modificación del comportamiento: y terapia de apoyo, 159 Belknap, I., 321 Bellak, L., 7 Berezin, M., 72 Bergeret, J., 99 Bergmann, K., 69, 74 Bibring, E., 148, 149 Bick, E., 233 bion, W., 98, 99-100, 103, 121, 309, 318-19, 337, 338, 352 Blacker, K., 80 Blinder, M., 80 Bloch, S., 150 Blum, H., 223 Blumenthal, R., 7 Trastorno de la personalidad límite: diagnóstico de, 27-28, 39-43; INDSM-III, 90-91,97; Enfoques de tratamiento a, 97-99; Transformencias de, 112-30 Passim; y Rap-Proachmentmentsubphase, 233, 251; TORTUMENTOS DESTRUCTOS EN, 241 -53; Poicida suicida de, 254-55; y contrarresta, 267-68; y la patio de suministro, 287; y narcisismo maligno, 299; Tratamiento hospitalario para, 343-58- Ver también Organización de personalidad límite Organización de la personalidad: definida, 5-6, 190; Descrito, 10- 24. Véase también el trastorno de la personalidad límite Bromley, D., 69 Carr, A., 7, 5N Caudill, W., 320-21, 322 Carácter: y auto, Patología de 230 caracteres:

Diagnóstico de, 33-37; en adolescentes, 56-58; Clasificación de, 93; tratamiento de 210-26; Resistencia en, 218-22. Ver también trastornos de la personalidad 375

376 Índice Chasseguet-Smirgel, J., 299 Chodoff, P., 80 Clarificación: Definida, 8; en entrevista estructural, 28, 29; y diagnóstico diferencial, 30; En terapia expresiva, 103 ejemplos clínicos: diagnóstico diferencial en adolescentes, 53-61; Tratamiento de ancianos, 70-71, 72-75; transformación de la transferencia, 108-10, 124-28; Oscilación de la transferencia, 128-30; Tratamiento de adolescentes, 140-45; Terapia de apoyo, 157-58; TRATAMIENTO DE LA PERSONALIDAD narcisista, 212-17; contratransferenciales, 215-17; Personalidad antisocial, 279-80; deshonestidad en la transferencia, 282-83, 294-95; Patología de Superego, 284-85; narcisismo maligno, 293-94, 304-06, 309-10; Tratamiento del hospital, 347-48 Cody, J., 153 conflicto, inconsciente: en la personalidad límite, 21-24, 113, 130, 140; En la personalidad narcisista, 192-93, 218-23. $ EE A ^ Tan de la teoría de la teoría de conflictos: y relaciones de objetos internalizados, 210-11, 224-25, 238 Confrontación: definido, 8-9; En la terapia de apoyo, 162, 163 "que contienen" Función de Analista: 99-100, 103, 121, 164 Contrarransferencia: y Identificación proyectiva, 114-15; actuando fuera de, 145-46; e interpretación de la resistencia, 223; y tratamiento estancamiento, 245; concepts de, 264-65, 267-68; Dimensiones temporales de, 265-66; y la regresión del paciente, 266-67; complementario, 267; y regresión de transferencia, 268-70; y defensa contra la dependencia, 271-74 Creatividad: Terapeuta, 268-70, 271, 272-73 Intervención de crisis: y terapia de apoyo, 169-70 Davenloo, H., 170 días Hospital, 327 defensas: como diagnóstico Criterio, 5-6, 7-8, 15-18, 20, 28-43 Passim; Interpretación y funcionamiento del ego, 15, 16, 30, 46, 104-06, 153 ~ 54/164; en la personalidad narcisística, 197-201, 218-19; y relaciones de objetos internalizados, 210-11. Ver también denegación; Devaluación; El yo grandioso, patológico; Identificación proyectiva; La represión; Denegación de la resistencia: como defensa, 17; de distinción entre el yo y el objeto, 180, 181; de la responsabilidad moral, 283-87 Dependencia: y narcisismo

patológico, 179, 180, 198, 203, 206-07, 303, 311; Defensa contra, 270-74 Depresión: Evaluación / 254-55; TENDENCIAS SUICIDALES Y, 254, 258, 259 Deutsch, F., 7 DEVALUACIÓN: Como defensa, 17-18; en los adolescentes limítrofes, 136-37; En el narcisismo maligno, 304 teoría del desarrollo: Kleinian, 181-82; Kohutian, 183-85; Jacobson, 231-32; Mahler's, 232; Relaciones con objetos de psicología del ego, 235-38 Dewald, P., 150 Diagnóstico: descriptivo y estructural, 3-4; Criterios para, 5-6, 12-22; de la personalidad neu-rotica, 36-39; de la personalidad límite, 39-43; de Personalidad Psicótica, 43-46; de Syn-drome de cerebro orgánico, 47-48; de adolescentes, 52-67; de personalidad histérica e infantil, 80-81; de SupereOgo Pathol-gy, 275-76; de la gran cantidad de grandiosos, 296. Véase también Entrevista de la entrevista estructural entrevista de diagnóstico. Ver la disociación de la entrevista estructural. Ver división de unidades: y afecta, 235-38. Ver también la agresión; Libido, teoría de DSM-I, 82, 87, 94 DSM-II, 79, 82, 87, 90, 94, 170 DSM-III, 24, 97, 256; Enfoque "ateorético" de, 77, 82, 86; goles de, 78-79; Limitaciones de, 82, 85, 86-87, 90, 91, 92, 93-94 DSM-III Case Book, 89 Easser, B., 79 Edelson, M., 333-34, 339 Ego: Y Sí mismo, 227-34 Límites del ego, 318. Véase también la diferenciación de sí mismo / objeto Ego Psicología: Enfoque del tratamiento hospitalario, 317-18 Ego-Psycholgy Object Relations TEORY: Y Diagnóstico Estructural, 4-6; de personalidad narcisista, 189-96; y desarrollo de uno mismo y ego, 229-30, 233-34, 238; de unidades y afecta, 234-38 debilidad del ego: como criterio de diagnóstico, 6, 98, 149; e interpretación de las defensas, 15-16; Manifestaciones de, 19; Detección de, 118; Disminución de, 318 Eissler, K., 102, 148

ÍNDICE 377 EMDE, R., 235 Empatía: Y Neutralidad Técnica, 103; Papel de auto psicología, 183-87 Envidia: y narcisismo patológico, 179-80, 181, 303 Erickson, E., 229 psicoterapia expresiva: y terapia de apoyo, 98, 100-01, 148, 151; y psicoanálisis, 100, 103, 120-21, 123, 151; Técnica de, 101-04, 108-11, 112-30; interpretación de la transferencia en, 104, 108-11, 113, 163; Aspectos cognitivos de, 119, 121; para adolescentes, 131-46; Enfoque del equipo y, 134, 138; Indicaciones para, 167-68; Contraindicaciones para, 167-68, 171 Ezriel, H., 352 Fairbairn, W., 93, 97, 231, 233, 237, 319 Falso Self, 136, 250 Terapia familiar: para adolescentes, 63, 66, 134-35; y tratamiento hospitalario a largo plazo, 342, 349 FEEDEN, P., 315, 317, 318, 320 Fenichel, O., 82, 117, 139, 210-11, 217-18, 223-24 Ferenczi, S., 222 Frances, A., 82, 90, 93 Asociación gratuita: e interpretación de la resistencia, 218-22 Passim Freud, A., 139 Freud, S., 179, 189, 192, 227-34 Passim, 237, 288 Fromm-Reichmann, F., 61, 148, 315 FROSCH, J., 18, 103 Purer, M., 99 Galeenson, £., 23 Gedo, J., 149 Gelerd, E., 52 Gianturco, D., 69 Gill, M., 6, 101, 148, 149, 220 Giovacchini, P., 91, 99, 100 Glover, E., 222 Goffman, £., 321 Goldberg, A., 186 Goldstein, E., 7 Goldstein, M., 134 Grandiose Self, patológico: Y Normal Self, 186; promulgado en la transferencia, 197-99, 201-03; Naturaleza defensiva de, 197, 217, 301; y SupeGe Patology, 299-301. Ver también Narcissismo maligno grandiosidad, maligno, 295-96. Ver también Narcissismo maligno Green, A., 98, 99 Greenacre, P., 139 Greenson, R., 120 Grinberg, L., 139, 267 GRANKER, R., 3, 89, 91, 100, 149 Gross, H., 82 Tratamiento grupal: en Hospitales, 349, 352-56 Grunberger, B., 204 culpa. Ver SupeRego Gunderson, J., 3, 89, 90-91, 97 Guntrip, H., 93 Hartmann, H., 4, 228-29, 234, 317, 318 Hartocollis, P., 99 Heimann, P., 113, 114, 115, 223 Herz, M., 323-24 Hill, L., 316 Historia, Pasado del paciente: Fiabilidad de, 42 Hoch, P., 88 Hoffman, M., 235 "Holding" Función de Analista, 99, 103, 121, 154, 162, 164, 206; En el tratamiento, los estancados, 250-52 Hollon, T., 149 Holzman, P., 115

tratamiento hospitalario: indicaciones para pacientes con límites, 172-76; Indicaciones para pacientes suicidas, 258-61, 263; Psy-choanalytic contributaciones a la teoría de 315-20; y procesos grupales, 319-20; Enfoque sociológico a 320-23, 338-39; alternativas a, 323-25; Tendencias recientes en, 327-29. Vea también el modelo de la comunidad terapéutica del tratamiento del hospital, el tratamiento hospitalario, a largo plazo: en comparación con el corto plazo, 172-76 Passim, 325-26, 339-40; y modelo de la comunidad terapéutica, 343-44; El personal funciona en, 344-46; Tratamiento individual en, 346, 348; Delegación de la Autoridad en, 346-48, 356-58; reuniones de equipo en, 348-56; terapia familiar en, 349; Tratamiento de grupo en, 352-56; Objetivos de, 358. Véase también el modelo de la comunidad terapéutica de la caza del tratamiento hospitalario, H., 7 idealización: primitivo en entrevista estructural, 16; En el narcisismo patológico, 180, 202-03, 207, 209; Tipos de 185 Identificación: y tratando a los ancianos, 70-72; complementario, 217, 267; Con el agresor, 293, 300-01 Identidad: integrado, como criterio de diagnóstico, 5, 6, 14. Véase también la difusión de identidad de difusión de identidad: como criterio de diagnóstico, 12-15; sondeo por en vista estructural, 33-41 Passim; Fuente de acercamiento de, 233 Insight: en la personalidad límite, 122

Internalized object relations. Ver Relaciones con objetos - Interpretación internalizada: definida, 9; en intervenciones estructurales, 28-30; Ejemplos clínicos de, 59, 125-27, 128-30, 141-42, 156-58, 213-17, 225, 294, 303, 304-06; en la terapia expresora, 102-13, 117-19; Efecto integrativo de, 119, 121-22, 137; en terapia de apoyo, 150-51; Estrategias para, 210-26 - de la transferencia: en terapia expresiva, 101-02, 105-07, 112-30, 135; en la terapia de apoyo, 154-55, 161, 163; con personalidad narcisista, 182, 204-05; En auto psicología, 186-87 introspección, capacidad para, 28, 38 Izard, E., 235 Jacobson, E., 137, 189-90, 228-33 Passim, 238, 276-78, 280, 300 Johnson, A., 297 Jones, M., 322, 330-31, 338 Kanzer, M., 139 Kernberg, P., 53 Khan, M., 98 Kleeman, J., 23 Klein, D., 91 Klein, M., 73, 114, 179, 231, 233, 319 Teoría Kleiniana: Errores en, 116, 181-82 Knight, R., 98, 100, 101, 148, 315, 317, 318, 320 Kohut, H., 181, 233, 234, 237; Teoría del narcisismo, 182-89 Kraepelin, £., 82 Krohn, A., 80 Kroll, J., 89 Langs, R., 150 Laplanche, J., 228 Laughlin, H., 11, 80, 82, 83, 84 Lazare, A., 80 Levine, M., 147, 148 Libido, Teoría de, 232-38 Limentani, A., 139 Little, M., 98, 99, 100, 115, 121, 264 Loveald, H., 122, 273 Lorenz, K., 237 LUBORSKY, L., 149 MCDOUGALL, J., 271 MACKINNON, R., 7, 80 MacLeod, J., 149 Mahler, M., 97, 99, 189-90, 231, 232, 233, 238, 251 Main, T., 315, 318-19, 320, 322, 330-31, 338 Narcisismo maligno, 195, 276; descrito, 257, 290-97; Patología de Superego de, 279-82, 297; Psicodinámica de, 296-301; Tratamiento de, 302-09 Manipulación, 159 Marceau, M., 196 Masoquismo: niveles de 292-93. Ver también Reacción terapéutica negativa Masterson, J., 52, 91, 97, 98-99, 100, 108 Medicamentos: Uso de, 159, 160 Meltzer, D., 299 Menninger, K., 6 Menninger, W., 315, 317 Investigación de la psicoterapia de Menninger Projectección: y tratamiento de la persona límite, 98-101, 107; y la terapia expresiva contra apoyar, 148-49, 153 Meyer, A., 315 Michels, R., 49, 152, 324 Miller, I., 150 MILLON, T., 85-86,

91-92 Modell, A., 100, 205-06, 251 Money, J., 23 Money-Kyrle, R., 114 Moore, B., 139, 229 Narcisismo: Teorías de, 179-96; Tipos de 192-93 - Patológico: Tratamiento de 197-209; Tratamiento estancamiento en, 242; y resistencia a la dependencia, 270-74; Patología de Superego en, 275-76, 278-89; y narcisismo maligno, 296-97; Tratamiento hospitalario de 343-58. Ver también narcisismo maligno; Trastorno narcisista de la personalidad Trastorno de la personalidad narcisista: diagnosis de, 40, 290; comportamiento antisocial en, 42-43; en adolescentes, 61-67; en tne e ^ 'derly, 72-73; Relaciones de objetos internalizados de, 190-91, 193-94; descrito, 192-96; y narcisismo maligno, 194-95; Gestión de transferencias de, 197-98, 202-03, 212-17; Tratamiento de, 210-26 Passim. Ver también narcisismo maligno; Narcisismo - Organización patológica de la personalidad narcisista. Consulte el trastorno de la personalidad narcisista. RAGE narcisista, 184, 195, 198, 291 Reacción terapéutica negativa: y narcisismo patotógico, 180-81; Fuentes de, 241-42; y tendencias suicidas, 256; y contraversa, 269 organización de personalidad neurótica, 5; Diagnosis de, 36-39; relaciones de objetos en, 191; Patología de Superego en, 288-89 Novey, S., 149 Relaciones con objetos: en la personalidad límite, 14-15; e interacción con los pacientes, 38-39, 50, 316-17, 344

Índice 379 - internalizado: definido, 5; transformación de, 104, 106-07, 110-11; interpretado en la transferencia, 106-07; Desarrollo de, 189-92, 231-32; e inclición inconsciente, 210-11, 219-20, 224-25; y affects, 235, 237-38; y conduce, 237-38; y supege patología, 281 -82, 286-89, 301; y narcisismo maligno, 299, 301, 3 "Olineick, S., 241 Omnipotence: como defensa, 17-18 Síndrome del cerebro orgánico: diagnóstico de, 32-48 Passim Orwell, G., 298, 300 personalidad paranoica: diagnóstico de, 16-17 rasgos paranoicos, 28; diagnóstico de, 46; en ancianos, 74-75 regresión paranoica. Ver regresión - micropsicótico paranoico en la transferencia Urge de paranoides a traicionar, 280, 300 Pasamanick, B., 323 Paz, C., 52 Perry, J., 89 Trastornos de la personalidad: Definido, 77; ausente en DSM-III, 79, 82, 86-87; Histerosico y Histriónico, 80-81; Histriónico e Infanálisis, 81; Histriónico y Frontera, 81-82; Masoquista depresivo, 82-84, 86; Evitente, 85, 86, 87; dependiente y pasivo agresivo, 87-88; esquizotipal, 88-89; esquizoide, 89, 93. Véase también el trastorno de la personalidad de la línea fronteriza; Organización de personalidad de trastorno de personalidad narcisista y estructura psíquica, 4-6 Pessar, L., 7 Plutchik, R., 236 Papa, H., 91 Powdermaker, F., 6 Pronóstico: y enfoque estructural, 4, 25-26; para ancianos, 75-76; para la personalidad límite, 107-08; para la personalidad antisocial, 170; Para la personalidad narcisista, 200 continuidad proyectiva, 267 identificación proyectiva: como defensa, 16-17; en la transferencia, 113-15, 123; en adolescentes de línea fronteriza, 133; y regresión de transferencia, 269 psicoanálisis: y tratamiento de ancianos, 69-70; y terapia expresiva, 100, 103, 104, 151; Técnica de definida, 101; y terapia de apoyo, 151, 163; Indicaciones para, 165-67; y tratamiento de la patología narcisista, 186 psicoterapia psicoanalítica. Ver psicoterapia expresiva Psicopatología: y patología social, 319-20 psicoterapia. Ver psicotery-apy expresivo; Organización de personalidad psicoterapia de apoyo, 190; Diagnóstico de, 5-6, 12, 14, 15, 20, 43-46; y tendencias suicidas, 258 Rabkin, L., 87

racker, H., 50, 114, 217, 262, 267, 269 Rangell, L., 139 RAPAPORT, D., 4, 192, 227, 317 Reality Testing: como Criterio de diagnóstico, 5-6, 7, 15, 18-20, 28-36 Passim, 45-46, 61 Reconstrucción, genético: en el tratamiento de la personalidad de borrar, 101, 104, 105; en el tratamiento de la personalidad narcisista, 182, 222, 223; en el tratamiento de regresiones severas, 306 regresión: y contratransferencia, 266-67, 268-70; resistencia a, 270-74; En grupos, 319, 336-38, 352 - Micropsicótico paranoico en Transferencia, 199-200, 207-08, 271, 290-91; dinámica de, 299-300; Tratamiento de / 302-311. Vea también Narcissismo maligno Reich, A., 264, 265 Reich, W., 210, 220, 221 Reider, N., 115 represión: como defensa, 5-6, 36-39; y tratamiento estancados, 201 resistencia: y resistencia a la transferencia, 199-201, 204, 211, 217-19, 223-26 Rexford, E., 139 llave, J-, 93/97 Rice, A. K., 320 Rinsley, D., 91, 97, 99 Riviere, J., 179 Robins, L., 93 Rogers, C, 7 Romm, M, 115 Rosenfeld, H., 91, 97, 114, 139, 198, 209, 214, 241, 273, 298; Teoría del narcisismo, 179-82 sadismo: como defensa, 200-01. Vea también SQUILDER DE NARCISSIO MALAÑO, P., 147, 148 SCIZOFRENIA: Diagnóstico de, 44-46; en adolescentes, 58-60; En DSM-HI, 88-90. Ver también Organización de personalidad psicótica Schlesinger, H., 150 Schneider, K., 82, 83 Searles, H., 91, 99, 100, 315, 316

380 Índice Secundario Ganancia, 153, 169, 171, 174, 175, 200, 248-49, 255 Segal, H., 114 Self: Conceptos de, 189, 192, 227-34; Normal y patológico, 190-92; y ego, 227-34; y autorrefresentación, 228-30. Véase también grandioso mismo, Diferenciación patológica / objeto de sí mismo, 12; Desarrollo de, 181, 231-32 Psicología, 182-89 Selzer, M., 28 Sexualidad: y narcisismo patológico, 180, 204, 208; y narcisismo maligno, 299 Shapiro, E., 80, 134 Sharpe, E., 116 Simmel, E., 317 Pequeño, T., 87 Spitz, R., 238 Spitzer, R., 77-78, 79, 85, 88 dividiendo: como defensa, 16, 112-13; interpretación de, 247; y denegación de la responsabilidad, 283-84 Stafford-Clark, D., 150 Stanton, A., 315, 319-20, 322 Stoller, R., 23 Piedra, M., 7, 28, 52, 91, 108 Strachey, J., 115, 227-28 Diagnóstico estructural: Ventajas de, 3-4, 25-26. Ver también Entrevista estructural Entrevista estructural: para el diagnóstico, 6-8, 27-30; Fase inicial, 31-36; Fase media, 36-48; Fase de terminación, 45, 48-49; Aspectos prácticos de, 49-50; Transferencia y contratransferencia en, 50; Aspectos de investigación de, 51 N Organización estructural: descrita, 5-6; Transformaciones de, 104, 106-07, suicidio UO-N, tendencias a: en adolescentes, 58-59, 60, 64; Gestión clínica de, 108-11, 258-63, 294-95; Diagnóstico de, 254-58; Como triunfo sobre el analista, 291-94; Dinámica de, 300 Sullivan, H., 6, 315, 320 SUPEROGO: Como criterio de diagnóstico y pronóstico, 19-21, 274; Desarrollo, 276-77 - Patológico, 242-43, 275-76, 278-89; y la deshonestidad en la transferencia, 282-83; y denegación de la responsabilidad, 283-87; y la grandiosa patológica, 299-301 psicoterapia de apoyo: y terapia expresiva, 98, 100-01, 148, 151; y la intervención de crisis, 123-24; historia de, 147-51; Definido, 150; y psicoanálisis, 151, 163; goles de, 151-53; Conceptos erróneos sobre, 153-55; Técnica de, 155-64; Iniciaciones para, 168-71. Véase también el tratamiento hospitalario, Sutherland a largo plazo, J., 352 síntomas: como evidencia presuntiva de la personalidad límite, 10-12; análisis, 28-30 Tarachow, S., 149 Neutralidad técnica: con pacientes con límites,

101-02, 103-04, 105, 121-23; en la terapia de apoyo, 101, 151, 156; con adolescentes, 133; y contrarresta, 266; y narcisismo maligno, 302 alianza terapéutica, 120-21 Modelo comunitario terapéutico de tratamiento hospitalario: descrito, 322-23, 331-34; inconvenientes a, 331-36, 339-42; y procesos grupales reorganizados, 336-38; Modificación de, 343-44. Vea también el tratamiento hospitalario, Ticho a largo plazo, E., 102, 151, 246 TINBERGEN, N., 237 Tower, L., 265 Tramer, M., 82 Transferencia: Definida, 9, 266; en terapia expresiva, 104, 108-11, 113-30 Passim, 163; en la terapia de apoyo, 150-51, 154, 161-64; En auto psicología, 182, 185-87; En la personalidad narcisista, 197-98, 202-03; Tratamiento estanca en, 221, 222; y contratransferencia, 270-74; deshonestidad en, 282-83, 285-86, 294-95, 300, 302-03, 310-11; y el narcisismo maligno, 308, 310; Parasitic, 309 Transference, Negativo: Interpretación de, 105-06, 186, 187-88; En la Therpy de apoyo, 154-55. 161, 163 neurosis de transferencia, 112, 187, 211 psicosis de transferencia, 115 resistencia a la transferencia: y defensas, 210-11; y neurosis de transferencia, 211; en personalidad narcisista, 212-17; y resistencia a los caracteres, 218. Véase también la interdelización de transmutación de resistencia, 183, 184 Tratamiento: elección de, 25-26, 165-71, 173-75 / * 75> 3 <> 2-04> 306-09; Objetivos y objetivos de vida, 102, 246, 249; Cambio de modalidad de, 171-73. Ver también psicoterapia expresiva; Tratamiento hospitalario; Psy- choanalysis; Psicoterapia de apoyo Valenstein, A., 241 Volkan, V., 98, 99, 100, 205-06 Walierstein, R., 115, 148, 150 Whitehorn, J., 6 Velquedad, J., 331 Whitman, R., 331

Índice, O., 315 Wilson, E., 237 Winnicott, D., 98, 99-100, 103, 119, 121, 136, 154, 162, 231, 233, 250, 251, 266, 268 TRABAJANDO 116, 202 Organización Mundial de la Salud, 7811 Zetzel, E., 79, 100, 101, 120, 166 381